# פרוטוקולים לאישור

## חוברת בקרה — כל הפרוטוקולים, ההחלטות והתרופות

**טיוטה לבדיקה.** טרם אושר ע"י הייעוץ המשפטי וניהול סיכונים. לא לשימוש בפועל.

| | |
|---|---|
| פרוטוקולי תרופות (מערכות) | 13 |
| פריטי תרופות | 469 |
| שמות מסחריים | 2088 |
| מתאים / בתנאים / הכנה לרופא/ה / דגל אדום / רופא בלבד | 153 / 219 / 72 / 22 / 3 |
| מעקב צמוד | 49 |
| פרוטוקולים נוספים | אישורים (17) · פניות דיגיטליות (13) · חיסונים (13) |
| הופק | 10.11.2026 · מתוך הכלי שפורסם (asseoy.github.io/medical_aids/protocols-rofan.html) |

ד"ר יונתן אסיאו · asseo_y@mac.org.il

# תוכן העניינים


| # | פרק | פריטים | עמוד פתיחה | רשימה לסימון | פירוט מלא |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | עקרונות כלליים | | **3** | | |
| | רשימה מרוכזת: רופא/ה בלבד | **3** | **5** | | |
| 1 | **לב וכלי דם** | **74** | **11** | **15** | **19** |
| 2 | **סוכרת ואנדוקרינולוגיה** | **51** | **110** | **113** | **116** |
| 3 | **נשימה ואלרגיה** | **30** | **167** | **168** | **171** |
| 4 | **נוירולוגיה** | **47** | **201** | **203** | **206** |
| 5 | **פסיכיאטריה** | **59** | **253** | **255** | **258** |
| 6 | **עיכול וכבד** | **20** | **316** | **317** | **319** |
| 7 | **כליות ודרכי שתן** | **25** | **339** | **340** | **342** |
| 8 | **בריאות האישה** | **21** | **367** | **368** | **370** |
| 9 | **שלד, מפרקים וכאב** | **21** | **389** | **391** | **393** |
| 10 | **דם ויטמינים** | **8** | **418** | **419** | **421** |
| 11 | **עיניים ועור** | **16** | **429** | **430** | **432** |
| 12 | **חיסון, זיהומים ומומחים** | **15** | **447** | **449** | **451** |
| 13 | **תרופות שאינן כרוניות** | **82** | **469** | **471** | **476** |
| 14 | **אישורים** | **17** | **541** | **543** | **545** |
| 15 | **פניות דיגיטליות** | **13** | **553** | **554** | **555** |
| 16 | **חיסונים** | **13** | **560** | **560** | **562** |
| 17 | **סיכום רפואי** | **19** | **569** | **569** | **571** |


בכל פרק: א. כללים · ב. תוצאות (באישורים ובפניות) · ג. בדיקות משותפות · ד. החלטות · ה. רשימה לסימון · ו. פירוט מלא של כל פריט עם משבצת אישור.

# 0. עקרונות כלליים

## מה הכלי עושה

סטודנט/ית לרפואה המסייע/ת לרופא/ה (רפואן) מחדש/ת מרשמים כרוניים, מפיק/ה אישורים ועונה לפניות מקוונות לפי רשימת בדיקות קבועה לכל פריט. אין שיחה עם המטופל/ת בחידוש מרשם; הבדיקה מתבססת על הרשומה, הבדיקות והרכישות. הרפואן לא משנה מינון ולא מחליף תרופה.

## שלושה מסלולים בחידוש מרשם

| מצב | תוצאה | פעולה |
|---|---|---|
| כל הבדיקות תקינות | חידוש ל-3 חודשים (קלוזפין: חודש) | — |
| חסרה מדידה, בדיקה או ביקורת שנתית | חידוש לחודש אחד | זימון למרפאה להשלמה |
| ערך חריג (מעל סף ההחזרה) | חידוש לחודש אחד | הודעה לרופא/ה |
| התווית נגד או ערך חמור | לא מחדשים | הודעה לרופא/ה |
| התראת אינטראקציה, אי-התאמה בכמות, ביחידות או בתדירות, או בקשה מוקדמת בתרופה ממכרת | לא מחדשים עדיין | ממתין לתשובת הרופא/ה |

אין התווית נגד ← תמיד מחדשים לפחות לחודש אחד, כדי לא להפסיק טיפול. ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה פעם בשנה (אין ביקור: חידוש לחודש, זימון והודעה לרופא/ה); עד 3 חידושים רצופים ואז ביקור רופא, ובחידוש השלישי הודעה למטופל/ת שמומלצת ביקורת שנתית; רכישות 80% מהימים ומעלה ב-6 החודשים האחרונים.

## סימונים

לפי הנחיה ביצוע לפי הנחיית הרופא/ה · לפי הנחיה, בתנאים רק טיפול כרוני במינון קבוע (ותנאים נוספים לפי התרופה) · הכנה לאישור רופא/ה הרפואן בודק ומכין, הרופא/ה מאשר/ת (אופיואידים, בנזודיאזפינים, תרופות שאינן כרוניות) · דגל אדום הרפואן מכין, והרופא/ה בודק/ת שוב לפני האישור (סיכון גבוה יותר) · רופא/ה בלבד חידוש ע"י רופא/ה בלבד — הכלי מציג הודעה ולא רשימת בדיקות · מעקב צמוד (⚗) תרופה עם מעקב תכוף (מעבדה, אק"ג, עיניים או צילום — לפי התרופה); בכלי מופיע פס אדום בראש הכרטיס עם המעקב הנדרש.

## תרופות עם כמה התוויות

חוסמי בטא, מעכבי ACE ו-ARB בודדים, MRA, אנטרסטו, פוסיד, פורקסיגה, ג'רדיאנס, אוזמפיק/וגובי ומונג'רו: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות (טווח בטיחות ל"ד במקום יעד; בלי HbA1c). יעד הטיפול נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת.

## תפקוד כליות לא תקין

כשפריט תפקוד הכליות לא תקין, הרפואן רושם ערכי eGFR קודמים וסימון אם יש אבחנה של אי-ספיקת כליות כרונית, והם עוברים בהודעה לרופא/ה.

## טקסט התיעוד

שורת כותרת עם הפריט והפרוטוקול · "הוקלד ע"י סטודנט/ית לרפואה המסייע/ת לרופא/ה [שם], בהוראת ד"ר [שם הרופא/ה]" · "הושלמה בדיקת התיק הרפואי לפי הפרוטוקול לפני חידוש המרשם. נבדקו ונמצאו תקינים: ..." עם שמות הבדיקות, בלי ערכים (או לפני הכנת המרשם, הפקת האישור, המענה לפנייה או הפקת המרשם לחיסון), או רק מה שלא תקין או חסר · התוצאה · מה הועבר למטופל/ת · מה הועבר לרופא/ה.

שני סימונים נפרדים מעל טקסט התיעוד ובשורת "סימון" בתוכו: חריגה מהפרוטוקול — התווית נגד, ממצא שעובר לרופא/ה, התראת אינטראקציה או אי-התאמה בכמות; הרופא/ה מחליט/ה. דגל אדום — תרופה בסיכון גבוה יותר, בדיקה כפולה תמיד. תרופה יכולה לשאת את שניהם. ביומן התיעוד (Excel) — שתי עמודות נפרדות באותם צבעים.

התוצאה נבחרת אוטומטית לפי הסימונים (התווית נגד ← לא מחדשים; אינטראקציה או אי-התאמה ← ממתין; חסר או חריג ← חודש אחד; הכל תקין ← 3 חודשים). הסטודנט/ית יכול/ה לשנות ידנית. כל בדיקה מסומנת בנפרד.

מרשם חד-פעמי (לא כרוני: התקן, פרוגסטרון, זריקת סטרואיד, תרופות שאינן כרוניות ועוד) — כותרת "הוצאת מרשם", והתוצאה "המרשם הונפק לפי הפרוטוקול"; חסר או חריג ← "לא הונפק, הועבר לרופא/ה". אישור שהופק כשהכול תקין — הטקסט מסתיים בשורת בדיקת

התיק, בלי שורת תוצאה ובלי "הועבר למטופל/ת". שם הרופא/ה המנחה נרשם בשדה בראש הכלי; ריק ← "בהוראת ד"ר _____".

## הנחיות כלליות לעבודה (ספר החפיפה, החלטות 3.11.2026)

### הליך העבודה

- הרופא/ה עובר/ת על כל הבקשות, מאשר/ת כל אחת ומנחה את הרפואן לבצע. הרפואן מבצע לפי הפרוטוקול ומשמש ככלי הביצועי של הרופא/ה בהקלדה. אין שיקול דעת עצמאי של הסטודנט/ית.
- העבודה מתבצעת במקביל לעבודת הרופא/ה, באופן סינכרוני. חריגה מהפרוטוקול או דגל אדום בזמן הביצוע — מוצגים לרופא/ה למעבר נוסף; רק הרופא/ה עונה עליהם.
- באותו יום הרופא/ה עובר/ת על צילומי מסך של ביצוע הבקשות ומאשר/ת אותם. צילומי המסך נשלחים לתיבת הדואר הארגונית של הרופא/ה בלבד.
- הבדיקות מתבססות על התיעוד ברשומה ועל הכתוב בפנייה בלבד. כל ספק — לרופא/ה.
- בהודעה או בשיחה עם המטופל/ת הרפואן מציג/ה את עצמו/ה כמי שמעביר/ה את ההודעה מהרופא/ה.

### סדר עבודה

- משימות מזכירה קודם, לסיים באותו יום. פניות דיגיטליות תוך 8 ימים: אישורים, תרופות, ואז השאר.
- בתחילת המשמרת: לסרוק את כל הפניות ולטפל קודם בדחופות; אחר כך לפי סדר ההגעה.
- לפני סגירת משימת מזכירה: לרשום את מספר תעודת הזהות.

### פתיחת התיק

- הערות שקופצות בפתיחת התיק (למשל "יש למדוד לחץ דם"): לשלב בתשובה למטופל/ת.
- עניינים פתוחים מהבקשה הקודמת (למשל בדיקות שהומלצו ולא בוצעו): לעדכן את הרופא/ה, כדי שאפשר יהיה להזכיר למטופל/ת בתשובה.

### תוצאות בדיקות

- תוצאות בדיקה שקופצות בפתיחת התיק: לא ללחוץ "אשר" — לחיצה עליו רושמת שהרופא/ה עבר/ה על התוצאות. ללחוץ רק "הפסק וסגור", להשוות לבדיקות קודמות ולדווח לרופא/ה.
- הרפואן לא מפרש תוצאות. אפשר להעביר למטופל/ת מסר מהרופא/ה, ולציין שמי שמעביר/ה הוא/היא סטודנט/ית לרפואה.

### מרשמים

- לבדוק כמות (OP = אריזות), יחידות (mg/mcg) ותדירות.
- התראת אינטראקציה, מרשם בכתב יד, אישור תרופה או הסרה מהקבועות: לרופא/ה.
- המטופל/ת לא ביקש/ה את כל התרופות הקבועות: לברר למה. נוסח: "שלום, מצורפים המרשמים לתרופות הקבועות לבקשתך. שמנו לב כי לא ביקשת מרשם לתרופה ____ שרשומה כתרופה קבועה. האם נעשה שינוי בתרופותיך?"
- אספקה ל-3 חודשים לנסיעה לחו"ל: יש צורך גם במכתב לבית המרקחת (אישורים ← מכתב).
- תרופה שלא נמצאת בכלי: לחפש ב-UpToDate התוויות נגד ובדיקות מעקב, להשוות לתוצאות המטופל/ת ולהעביר סיכום קצר לרופא/ה. הרופא/ה מחליט/ה.

### בדיקות והפניות

- רק שגרה, מעקב קיים או המלצה כתובה. תסמין או בקשה חדשה: לרופא/ה. מוקד או מיון: מיד.

### לדווח לרופא/ה

- אשפוז, פטירה במשפחה, אבחנה חדשה, או מטופל/ת שפונה שוב ושוב.

## מקורות

ערכים שאין להם הנחיה בפרויקט מסומנים "החלטה מקומית (הצעה)" ומחכים לאישור. שמות מסחריים: מאגר התרופות של משרד הבריאות (קובץ 7.10.2026).

# רשימה מרוכזת: תרופות שמחודשות ע"י רופא/ה בלבד (3)

בתרופות אלה הכלי לא מציג רשימת בדיקות: מוצגת הודעה, והבקשה עוברת לרופא/ה. אחרי סקירת הפריטים החסומים (7.11.2026) נשארו כאן רק רואקוטן (רופא/ת עור), אנטיביוטיקה לתסמין חדש ותרופות נגד שפעת. כל פריט מופיע גם בפרק המערכת שלו (המספר בעמודה הראשונה).

| # | מערכת | תרופה / קבוצה | שמות מסחריים | ההודעה בכלי | אושר |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2 | עיניים ועור | **איזוטרטינואין (רואקוטן)** Isotretinoin | קיורטן \| איזוביר \| רואקוטן | הרפואן לא מפיק מרשם לרואקוטן (איזוטרטינואין) — גם לא להכנה לאישור הרופא/ה. רק רופא/ת עור רושם/ת אותו, במסגרת תוכנית מניעת היריון ומעקב מעבדה. מפנים את המטופל/ת לרופא/ת העור המטפל/ת. | ☐ |
| 13.49 | תרופות שאינן כרוניות | **אנטיביוטיקה לתסמין חדש** Antibiotics for a new symptom | אמוקסיצילין מדו \| אמוקסי קאר פורטה \| מוקסיפן חדש כמוסות \| מוקסיפן פורטה \| מוקסיוויט \| מוקסיוויט פורטה \| ויטאמוקס פורטה \| אמוקסיקלב טבע \| אוגמנטין \| מאקליבן \| פן-רפא וי-ק \| צפואבניר ... (+26) | בקשה לאנטיביוטיקה בגלל תסמין (גרון, אוזן, סינוסים, שיעול, שתן, עור): צריך הערכה של רופא/ה. הרפואן לא מכין מרשם. להעביר לרופא/ה את הפנייה: התסמינים, מתי התחילו, חום, ותרביות קודמות. אנטיביוטיקה מונעת לפי מכתב (שיניים, טיול) — בפריט נפרד. | ☐ |
| 13.51 | תרופות שאינן כרוניות | **תרופות נגד שפעת (טמיפלו, קסופלוזה, רלנזה)** Oseltamivir | טמיפלו \| קסופלוזה 40 מ"ג \| רלנזה | טיפול או מניעה של שפעת: החלטה של רופא/ה לפי זמן מהופעת התסמינים וגורמי סיכון. להעביר לרופא/ה באותו יום. | ☐ |

## רשימה מרוכזת: דגל אדום — בדיקה כפולה מול הרופא/ה (22)

תרופות בסיכון גבוה יותר (סקירה 7.11.2026): הרפואן מכין לפי רשימת הבדיקות, והרופא/ה בודק/ת שוב לפני האישור — גם כשהכול תקין. חריגה מהפרוטוקול מסומנת בנפרד, ותרופה יכולה לשאת את שני הסימונים.

| # | מערכת | תרופה / קבוצה | נימוק | בדיקות ייעודיות | אושר |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 | לב וכלי דם | **תרופות לב במעקב מומחה** | טפמידיס ומבקמטן נקבעים ע"י קרדיולוג/ית מומחה/ית. הרפואן מכין עם המכתב העדכני, והרופא/ה בודק/ת שוב לפני האישור. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. | הנחיה עדכנית של הקרדיולוג/ית · בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | ☐ |
| 1.68 | לב וכלי דם | **הפרינים במשקל מולקולרי נמוך** | נוגד קרישה בזריקה: מינון לפי משקל ותפקוד כליות, ומשך לפי ההתוויה. הרפואן מרכז את המדדים ואת סיבת הטיפול, והרופא/ה מאשר/ת. | משקל עדכני · תפקוד כליות · ספירת דם · סיבת הטיפול ומשכו המתוכנן | ☐ |
| 2.42 | סוכרת ואנדוקרינולוגיה | **הורמון גדילה** | הורמון גדילה נקבע ומנוטר ע"י אנדוקרינולוג/ית (לרוב ילדים). הרפואן מכין עם ההנחיה העדכנית, והרופא/ה מאשר/ת. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. | הנחיה עדכנית של האנדוקרינולוג/ית · בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | ☐ |
| 2.44 | סוכרת ואנדוקרינולוגיה | **פנטרמין** | פנטרמין (רזין) הוא ממריץ במרשם מיוחד, לטווח קצר. הרפואן מכין עם משקל, לחץ דם ומשך הטיפול עד כה, והרופא/ה מאשר/ת. | משקל עדכני · לחץ דם ודופק · משך הטיפול עד כה | ☐ |
| 2.45 | סוכרת ואנדוקרינולוגיה | **אנלוגים לסומטוסטטין ופגויזומנט** | אנלוגים לסומטוסטטין ופגויזומנט נקבעים ע"י אנדוקרינולוג/ית או אונקולוג/ית. הרפואן מכין עם המכתב העדכני, והרופא/ה מאשר/ת. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. | הנחיה עדכנית של המומחה/ית המטפל/ת · בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | ☐ |
| 3.27 | נשימה ואלרגיה | **תרופות ליל"ד ריאתי ולפיברוזיס ריאתי** | תרופות ליל"ד ריאתי ולפיברוזיס ריאתי נקבעות במרכז מומחה. בוסנטן (טרקליר) טרטוגני ומחייב תפקודי כבד חודשיים. הרפואן מכין, והרופא/ה מאשר/ת. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. | הנחיה עדכנית של מרכז המומחה · תפקודי כבד (בבוסנטן ובאמבריסנטן) · אין היריון (בבוסנטן, אמבריסנטן, מאסיטנטן) · בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | ☐ |

| # | מערכת | תרופה / קבוצה | נימוק | בדיקות ייעודיות | אושר |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.42 | נוירולוגיה | **תרופות לטרשת נפוצה** | תרופות לטרשת נפוצה שמחייבות בדיקות דם (לימפוציטים, ספירה, תפקודי כבד) — נקבעות ע"י מרכז MS. הרפואן מכין עם הבדיקות, והרופא/ה מאשר/ת. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. | הנחיה עדכנית של מרכז ה-MS · ספירת דם ולימפוציטים · תפקודי כבד · בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | ☐ |
| 6.15 | עיכול וכבד | **מטוקלופרמיד** | מטוקלופרמיד (פרמין) מעל 12 שבועות: סיכון לדיסקינזיה מאוחרת, בעיקר במבוגרים. הרפואן בודק גיל והתוויות נגד, והרופא/ה מאשר/ת. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. | גיל 18 ומעלה · אין התוויות נגד · בפנייה וברשומה: לא מתוארות תנועות לא רצוניות · משך הטיפול ידוע · עד 12 שבועות | ☐ |
| 7.13 | כליות ודרכי שתן | **מעודדי ייצור דם (אריתרופויאטין)** | מעודדי ייצור דם (ארנספ, בינוקריט): המינון לפי ההמוגלובין, והמוגלובין גבוה מדי מעלה סיכון לפקקת ולשבץ. הרפואן מכין, והרופא/ה מאשר/ת. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. | מעקב מסודר — הנפרולוג/ית או ההמטולוג/ית · המוגלובין עדכני · בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | ☐ |
| 7.15 | כליות ודרכי שתן | **קושרי אשלגן** | קושרי אשלגן (לוקלמה, ולטסה): המינון לפי רמת אשלגן עדכנית. הרפואן מצרף את האשלגן האחרון, והרופא/ה מאשר/ת. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. | מעקב מסודר — הנפרולוג/ית · אשלגן עדכני · בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | ☐ |
| 10.5 | דם וויטמינים | **תרופות המטולוגיות במעקב מומחה** | תרופות המטולוגיות של מומחה (דפרסירוקס, אלטרומבופג, אנגרליד, רוקסוליטיניב ועוד). חלקן מחייבות ספירת דם. הרפואן מכין, והרופא/ה מאשר/ת. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. | הנחיה עדכנית של ההמטולוג/ית · ספירת דם עדכנית · בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | ☐ |
| 10.7 | דם וויטמינים | **ברזל בעירוי לווריד (פרינג'קט, מונופר, ונופר)** | ברזל בעירוי: הרפואן מכין את ההפניה, והרופא/ה מאשר/ת לפני השליחה (דגל אדום). לחסר ברזל שלא הגיב לברזל בבליעה או כשאי אפשר לתת אותו. ההחלטה, המינון ומספר המנות — של הרופא/ה. הרפואן מכין: בדיקות, אישור ותור. | ערכי מעבדה · חסר ברזל מתועד · כישלון או אי-סבילות לברזל בבליעה, או החלטה מתועדת · אין תגובה בעבר לברזל בעירוי · לא בשליש הראשון להיריון · אישור מימון ותור | ☐ |
| 11.3 | עיניים ועור | **אציטרטין** | אציטרטין (ניאוטיגסון) בכמוסות: טרטוגני, ואסור היריון עד 3 שנים אחרי ההפסקה. הרפואן מכין עם בדיקת היריון, כבד ושומנים, והרופא/ה מאשר/ת. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. | הנחיה עדכנית של רופא/ת העור · אין היריון, ויש אמצעי מניעה · תפקודי כבד · שומנים בדם · טריגליצרידים מתחת ל-800 · בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | ☐ |
| 12.5 | חיסון, זיהומים ומומחים | **תרופות נגד HIV** | תרופות HIV ו-PrEP: HIV מנוהל במרכז האיידס; PrEP — בדיקת HIV כל 3 חודשים ותפקוד כליות, ורק רופא/ה מורשה רושם/ת. הרפואן מכין במקרו הייעודי, והרופא/ה מאשר/ת. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. | הנחיה עדכנית של מרכז האיידס או מרפאת ה-PrEP · PrEP: שימוש במקרו הייעודי · PrEP: הרופא/ה מורשה לרשום · PrEP: בדיקת HIV ותפקוד כליות · פינוי קריאטינין מספיק (טנופוביר) · בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | ☐ |
| 12.6 | חיסון, זיהומים ומומחים | **מעכבי קלצינאורין** | טקרולימוס וציקלוספורין: רמה בדם ותפקוד כליות מנוטרים ע"י מרכז ההשתלה או המומחה/ית. הרפואן מכין, והרופא/ה מאשר/ת. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. | הנחיה עדכנית של מרכז ההשתלה או המומחה/ית · רמת התרופה בדם · תפקוד כליות · בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | ☐ |
| 12.9 | חיסון, זיהומים ומומחים | **תרופות אונקולוגיות ובמעקב אונקולוגי** | תרופות אונקולוגיות בבליעה: רעילות גבוהה, ומחזורי הטיפול נקבעים באונקולוגיה. הרפואן מכין עם המכתב העדכני וספירת דם, והרופא/ה מאשר/ת. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. | הנחיה עדכנית של האונקולוג/ית · ספירת דם עדכנית · בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | ☐ |

| # | מערכת | תרופה / קבוצה | נימוק | בדיקות ייעודיות | אושר |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10 | חיסון, זיהומים ומומחים | **מדכאי חיסון להשתלה (mTOR)** | סירולימוס (רפמיון) ואברולימוס (סרטיקן, אפיניטור): רמה בדם ותפקוד כליות. הרפואן מכין, והרופא/ה מאשר/ת. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. | הנחיה עדכנית של מרכז ההשתלה או המומחה/ית · רמת התרופה בדם · תפקוד כליות · בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | ☐ |
| 13.52 | תרופות שאינן כרוניות | **גלולה ליום שאחרי (פוסטינור, אלה)** | גלולה ליום שאחרי: דחוף, באותו יום. הרפואן מכין ומציג לרופא/ה מיד. | בתוך חלון הזמן · טופל באותו יום · אין רגישות לתרופה | ☐ |
| 13.56 | תרופות שאינן כרוניות | **קורס סטרואידים בבליעה (פרדניזון, מדרול)** | קורס סטרואידים בבליעה (פרדניזון, מדרול) אינו רגיל: הרפואן מכין, והרופא/ה בודק/ת שוב לפני האישור. | סיבה ומינון מתועדים · סוכרת ידועה · לא קורסים חוזרים | ☐ |
| 13.73 | תרופות שאינן כרוניות | **פקסלוביד (קורונה)** | פקסלוביד: אינטראקציות רבות וחובה להתחיל תוך 5 ימים מהתסמינים. הרפואן מכין עם תפקוד כליות, והרופא/ה מאשר/ת. | בדיקת קורונה חיובית · עד 5 ימים מתחילת התסמינים · תפקוד כליות | ☐ |
| 13.76 | תרופות שאינן כרוניות | **מיזופרוסטול ומיפפריסטון (ציטוטק, מיפג'ין)** | מיזופרוסטול (ציטוטק): אסור בהיריון, אלא לסיום היריון או לפעולה גינקולוגית. הרפואן מכין, והרופא/ה מאשר/ת. | התוויה מתועדת · היריון נבדק | ☐ |
| 13.77 | תרופות שאינן כרוניות | **תרופות בהזרקה לטיפול מיידי במרפאה (כאב, בחילה, אלרגיה)** | תרופות בהזרקה לטיפול מיידי במרפאה (קטורולק, פרמין, פנרגן, דקסמתזון, אדרנלין, קונקיון). הרפואן מכין, והרופא/ה מאשר/ת לפני ההזרקה. | הוראה וסיבה · אין רגישות לתרופה | ☐ |

## רשימה מרוכזת: הרפואן מכין, הרופא/ה מאשר/ת (72)

בתרופות אלה יש רשימת בדיקות, אבל הרפואן לא מנפיק: מכין סיכום, והאישור הסופי בידי הרופא/ה.

| # | מערכת | תרופה / קבוצה | מה נבדק | אושר |
|---|---|---|---|---|
| 4.45 | נוירולוגיה | **מידזולם לחלל הפה להפסקת פרכוס (בוקולאם)** | תרופת הצלה בפרכוס ממושך, לפי תוכנית של הנוירולוג/ית. בנזודיאזפין — הרפואן מכין, הרופא/ה מאשר/ת. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. | ☐ |
| 5.32 | פסיכיאטריה | **בנזודיאזפינים ותרופות שינה** | ההחלטה בידי הרופא/ה. הרפואן אוסף את הנתונים, מסמן אותם ומעביר סיכום. | ☐ |
| 5.37 | פסיכיאטריה | **קסנומלין-טרוספיום (קובנפי)** | נוגד פסיכוזה חדש, נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. אצירת שתן ועליית אנזימי כבד; לא במחלת כבד. הרפואן מכין, הרופא/ה מאשר/ת. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. | ☐ |
| 7.23 | כליות ודרכי שתן | **אלפרוסטדיל בזריקה לפין (קברג'קט)** | זריקה לפין לאין-אונות, אחרי הדרכה של אורולוג/ית. הרפואן מכין, הרופא/ה מאשר/ת. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. | ☐ |
| 8.17 | בריאות האישה | **בחילות בהיריון (דיקלקטין, לדוקסיה, בונג'סטה)** | קו ראשון לבחילות והקאות בהיריון. בטוח בהיריון. סימני הקאות היריון קשות (התייבשות, ירידה במשקל) — לרופא/ה באותו יום. | ☐ |
| 8.20 | בריאות האישה | **תרופות לטיפולי פוריות (גונל-אף, מנופור, צטרוטייד, אוביטרל)** | תרופות הזרקה לטיפולי פוריות, לפי פרוטוקול של יחידת הפוריות (IVF) למחזור הנוכחי. הרפואן מכין לפי הפרוטוקול, הרופא/ה מאשר/ת. | ☐ |
| 9.6 | שלד, מפרקים וכאב | **אופיואידים** | אופיואיד: הרפואן בודק אבחנת כאב, התאמה לתרופה ומרווח זמן, ומכין סיכום. האישור הסופי בידי הרופא/ה. | ☐ |
| 12.8 | חיסון, זיהומים ומומחים | **תרופות ביולוגיות** | תרופות ביולוגיות בזריקה בקהילה (דופיקסנט, קסולייר, חומירה, סטלרה, קוזנטיקס ועוד): הרפואן מכין — אישור, מכתב, מרווח ובטיחות — והרופא/ה מאשר/ת. עירוי בבית חולים — לרופא/ה. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. | ☐ |
| 13.1 | תרופות שאינן כרוניות | **טרבינפין (טבליות)** | קורס בלבד: עד 12 שבועות בציפורני רגליים, 6 שבועות בציפורני ידיים. ALT לפני הטיפול ואחרי חודש. האישור בידי הרופא/ה. | ☐ |
| 13.2 | תרופות שאינן כרוניות | **נוגדי דלקת חזקים (במרשם)** | לא תרופה כרונית: האישור בידי הרופא/ה. לפני ההצגה הרפואן בודק כיב קיבה בעבר ותפקוד כליות. | ☐ |
| 13.3 | תרופות שאינן כרוניות | **תרופה שאינה ברשימה הקבועה** | כל תרופה שאינה ברשימה הקבועה (כולל המלצת יועץ/ת, מכתב שחרור, המרת מרשם או מעבר לגנרי) מוצגת לרופא/ה לפני שמתחילים. הרפואן מכין סיכום: איפה תועד, תאריך, שם הרופא/ה ותפקידו/ה, האבחנה וההמלצה. | ☐ |

| # | מערכת | תרופה / קבוצה | מה נבדק | אושר |
|---|---|---|---|---|
| 13.4 | תרופות שאינן כרוניות | **טיפות עיניים עם סטרואיד** | טיפול ממושך ללא השגחה מעלה לחץ תוך-עיני. רק כשרופא/ת עיניים קבע/ה טיפול לתקופה ארוכה; אחרת — המלצה חדשה מרופא/ת העיניים. | ☐ |
| 13.5 | תרופות שאינן כרוניות | **משחות וקרמים עם סטרואיד** | שימוש ממושך עלול לגרום לדילול ופגיעה בעור. לא לשימוש כרוני. כשמרשם מאושר — הוראה קבועה למטופל/ת. | ☐ |
| 13.6 | תרופות שאינן כרוניות | **תרסיס מכווץ כלי דם לאף** | לגודש באף בצינון. שימוש מעבר ל-5–7 ימים גורם לגודש חוזר (ריניטיס מתרופות). | ☐ |
| 13.7 | תרופות שאינן כרוניות | **תרסיס סטרואידי לאף (עונתי)** | לנזלת אלרגית עונתית. ההשפעה מלאה אחרי כמה ימים. כשנלקח באופן קבוע כל השנה — זה טיפול כרוני (לשונית נשימה). | ☐ |
| 13.8 | תרופות שאינן כרוניות | **אזלסטין — תרסיס אנטיהיסטמיני לאף** | אנטיהיסטמין מקומי לנזלת אלרגית. עלול לגרום לטעם מר ולישנוניות קלה. | ☐ |
| 13.9 | תרופות שאינן כרוניות | **אנטיהיסטמין מרדים (דור ראשון)** | מרדים ואנטיכולינרגי. להימנע בגיל 65 ומעלה (נפילות, בלבול). לא עם אלכוהול או תרופות מרדימות. | ☐ |
| 13.10 | תרופות שאינן כרוניות | **תכשירים לשיעול (דקסטרומתורפן, גואיפנזין)** | לשיעול בצינון. דקסטרומתורפן: סיכון לתסמונת סרוטונין עם SSRI, SNRI, טרמדול ו-MAOI. | ☐ |
| 13.11 | תרופות שאינן כרוניות | **תכשירי צינון ושפעת משולבים (פסאודואפדרין, פנילאפרין)** | כולם מכילים מכווץ כלי דם (פסאודואפדרין), שמעלה לחץ דם ודופק. הרכיבים הנוספים משתנים: אקמול צינון, דקסמול ופראמול — עם פרצטמול; אדויל קולד ונורופן צינון — עם איבופרופן; קלרינז — עם לורטדין; היסטפד ונוסידקס — עם אנטיהיסטמין מרדים; סינופד וקלסינוס — פסאודואפדרין בלבד. הרכיבים של כל תכשיר מופיעים ליד שמו. | ☐ |
| 13.12 | תרופות שאינן כרוניות | **תכשירים לכאב גרון (לכסניות ותרסיסים)** | לכאב גרון בצינון. פלורביפרופן (סטרפן) הוא נוגד דלקת: לא באסתמה רגישה לנוגדי דלקת. | ☐ |
| 13.13 | תרופות שאינן כרוניות | **פרצטמול — קורס קצר** | לכאב ולחום. עד 4 גרם ביום (בגיל מבוגר, במשקל נמוך או בצריכת אלכוהול: עד 3 גרם). לבדוק כפילות עם תכשירי צינון. | ☐ |
| 13.14 | תרופות שאינן כרוניות | **איבופרופן / נפרוקסן / אספירין — קורס קצר** | נוגדי דלקת במינון רגיל. סיכון לקיבה, לכליות ולדימום. נוגדי דלקת חזקים במרשם (ארקוקסיה ודומיה) — בפריט נפרד. | ☐ |
| 13.15 | תרופות שאינן כרוניות | **דיפירון (אופטלגין) — קורס קצר** | משכך כאב וחום. סיכון נדיר לירידה חמורה בכדוריות הלבנות (אגרנולוציטוזיס) ולירידת ל"ד. | ☐ |
| 13.16 | תרופות שאינן כרוניות | **ג'ל נוגד דלקת (וולטרן ודומיו)** | למריחה על כאב שרירים או מפרק. ספיגה מועטה; לא על עור פגוע. | ☐ |
| 13.17 | תרופות שאינן כרוניות | **נוגדי חומצה ואלגינטים (גביסקון, מאלוקס)** | לצרבת ולקלקול קיבה מזדמנים. מפריעים לספיגת תרופות אחרות (לבותירוקסין, ברזל, אנטיביוטיקה): להפריד בשעתיים. | ☐ |
| 13.18 | תרופות שאינן כרוניות | **מעכבי חומצה — קורס קצר (אומפרזול ודומיו, פמוטידין)** | קורס קצר לצרבת. טיפול קבוע ומתמשך — בלשונית מערכת העיכול. בגיל 55 ומעלה עם תסמין חדש, או עם סימן אזהרה — לרופא/ה. | ☐ |
| 13.19 | תרופות שאינן כרוניות | **לופרמיד (אימודיום)** | לשלשול חד בלי סימני אזהרה. לא בשלשול דמי, בחום או אחרי אנטיביוטיקה (חשד לזיהום חיידקי או קלוסטרידיום). | ☐ |
| 13.20 | תרופות שאינן כרוניות | **ביסמות סובסליצילט (קלבטן, ביטני)** | מכיל סליצילט: כמו אספירין לעניין רגישות ונוגדי קרישה. צואה ולשון שחורות — צפוי ולא מסוכן. | ☐ |
| 13.21 | תרופות שאינן כרוניות | **משלשלים אוסמוטיים (לקטולוז, PEG)** | לעצירות חדשה או מזדמנת. טיפול קבוע — בלשונית מערכת העיכול (משלשלים). עצירות חדשה מגיל 50 — לרופא/ה. | ☐ |
| 13.22 | תרופות שאינן כרוניות | **משלשלים ממריצים ופתילות (ביסקודיל, סנה, גליצרין)** | לעצירות מזדמנת בלבד. שימוש ממושך בממריצים גורם לתלות ולהפרעות מלחים. | ☐ |
| 13.23 | תרופות שאינן כרוניות | **סימתיקון (גזים)** | לגזים ולנפיחות. בטוח, כמעט אינו נספג. | ☐ |
| 13.24 | תרופות שאינן כרוניות | **נוגדי עוויתות למעי רגיש ידוע (קולוטאל, קולפרמין)** | נוגד עוויתות לכאבי בטן במעי רגיש. רק כשיש אבחנה של מעי רגיש; כאב בטן חדש — לרופא/ה. | ☐ |
| 13.25 | תרופות שאינן כרוניות | **תכשירים לטחורים (פרוקטו-גליבנול, רקטוצורין)** | לטחורים ידועים. דימום מהרקטום שלא הוערך, בעיקר מגיל 50, או כאב חזק — לרופא/ה. | ☐ |
| 13.26 | תרופות שאינן כרוניות | **קרם נגד פטרת (קלוטרימזול, מיקונזול, טרבינפין)** | לפטרת בעור (רגל אתלט, מפשעה, גוף). פטרת בציפורניים או בקרקפת, או נגעים נרחבים — לרופא/ה. דקטרין ג'ל לפה — לא כאן (אינטראקציה עם וורפרין). | ☐ |
| 13.27 | תרופות שאינן כרוניות | **שמפו נגד פטרת (קטוזול, אגיספור)** | לקשקשים סבוריאיים ולפטרת עור (פיטיריאזיס). פטרת בקרקפת עם נשירה — לרופא/ה. | ☐ |

| # | מערכת | תרופה / קבוצה | מה נבדק | אושר |
|---|---|---|---|---|
| 13.28 | תרופות שאינן כרוניות | **לכה נגד פטרת ציפורניים (לוסריל, פונגינייל)** | לפטרת ציפורניים קלה (עד חצי ציפורן, בלי שורש הציפורן). טיפול ארוך: 6 חודשים בידיים, 9–12 ברגליים. טבליות טרבינפין — בפריט נפרד. | ☐ |
| 13.29 | תרופות שאינן כרוניות | **משחה אנטיביוטית (פוסידין, בקטרובן)** | לזיהום שטחי קטן בעור (אימפטיגו מקומי). זיהום נרחב, חום או אודם מתפשט — לרופא/ה (ייתכן צורך באנטיביוטיקה בבליעה). שימוש ממושך מעודד עמידות. | ☐ |
| 13.30 | תרופות שאינן כרוניות | **קרם אציקלוביר (זובירקס) — פצעי קור** | לפצעי קור (הרפס בשפתיים) חוזרים. יעיל בעיקר כשמתחילים בתחושת העקצוץ. | ☐ |
| 13.31 | תרופות שאינן כרוניות | **אציקלוביר / ולציקלוביר בטבליות — התקף של הרפס ידוע** | רק להתקף חוזר של הרפס שאובחן בעבר (שפתיים או איברי מין). התקף ראשון, שלבקת חוגרת, עין או דיכוי חיסוני — לרופא/ה. טיפול מונע קבוע — בלשונית חיסון וזיהומים. | ☐ |
| 13.32 | תרופות שאינן כרוניות | **טיפול בגרדת (לייקליר)** | פרמתרין לגרדת. מטפלים בכל בני הבית באותו יום, וחוזרים אחרי שבוע. הגרד יכול להימשך 2–4 שבועות אחרי טיפול מוצלח. | ☐ |
| 13.33 | תרופות שאינן כרוניות | **משחות לכוויות ופצעים (סילברול, בפנטן פלוס)** | לכוויה שטחית קטנה או לפצע קטן. סלברול מכיל סולפה: לא ברגישות לסולפה ולא בהיריון מתקדם. | ☐ |
| 13.34 | תרופות שאינן כרוניות | **חיטוי עור ופה (כלורהקסידין, פולידין)** | לחיטוי פצע קטן או לשטיפת פה. יוד: לא במחלת בלוטת התריס, בהיריון או על שטח נרחב. | ☐ |
| 13.35 | תרופות שאינן כרוניות | **תכשירים לגרד מקומי (קלמין, פניסטיל ג'ל, צינק)** | לגרד מקומי (עקיצות, פריחה קלה). גרד בכל הגוף בלי פריחה, או עם צהבת — לרופא/ה. | ☐ |
| 13.36 | תרופות שאינן כרוניות | **טיפול מקומי באקנה (בנזק, אפידו, דואק)** | לאקנה קלה עד בינונית. אדפלן (אפידו, אדאפרין) — אסור בהיריון. אקנה קשה עם צלקות — רופא/ת עור. | ☐ |
| 13.37 | תרופות שאינן כרוניות | **טיפול ביבלות (סלאטק)** | חומצה סליצילית ליבלות בידיים וברגליים. לא בפנים, באיברי המין או בחולי סוכרת או מחלת כלי דם היקפית. | ☐ |
| 13.38 | תרופות שאינן כרוניות | **הרדמה מקומית לפני פעולה (אמלה, LMX4, עזרקאין)** | לפני דקירה, לייזר או פעולה קטנה, לפי הנחיית המטפל/ת. כמות גדולה על שטח נרחב — סיכון למתהמוגלובינמיה. | ☐ |
| 13.39 | תרופות שאינן כרוניות | **דמעות מלאכותיות** | ליובש בעיניים. בטוחות. שימוש יותר מ-4–6 פעמים ביום — תכשיר ללא חומר משמר. | ☐ |
| 13.40 | תרופות שאינן כרוניות | **טיפות עיניים נגד אלרגיה (אופטילסט, אולופטדין)** | לדלקת לחמית אלרגית: גרד, דמעות ואודם בשתי העיניים. אודם בעין אחת, כאב או הפרשה — לרופא/ה. | ☐ |
| 13.41 | תרופות שאינן כרוניות | **הכנה לקולונוסקופיה (מרוקן, מוביפרפ, פיקו סלקס)** | לפי ההפניה והתור לקולונוסקופיה. פיקו סלקס — לא באי-ספיקת כליות או לב. סוכרת עם אינסולין — הנחיה לגבי האינסולין מהרופא/ה. | ☐ |
| 13.42 | תרופות שאינן כרוניות | **פרה-מדיקציה לפני בדיקה עם חומר ניגוד (רגישות ידועה)** | רק לפי הפרוטוקול הכתוב של מכון הדימות, למטופל/ת עם רגישות ידועה לחומר ניגוד (בדרך כלל פרדניזון ואנטיהיסטמין לפני הבדיקה). | ☐ |
| 13.43 | תרופות שאינן כרוניות | **אנטיביוטיקה מונעת לפני טיפול שיניים** | רק לפי מכתב קרדיולוג/ית (מסתם תותב, אנדוקרדיטיס בעבר, מומי לב מסוימים). מנה אחת לפני הטיפול. | ☐ |
| 13.44 | תרופות שאינן כרוניות | **תחליפי ניקוטין (מדבקות, מסטיק, לכסניות, תרסיס)** | לגמילה מעישון, כ-8–12 שבועות. מדבקה + תכשיר קצר-טווח יחד יעילים יותר. ורניקלין — בלשונית בריאות הנפש. | ☐ |
| 13.45 | תרופות שאינן כרוניות | **מניעת מלריה לטיול (מלרון, דוקסיציקלין)** | רק לפי מכתב של מרפאת מטיילים: יעד, תאריכים, תכשיר ומשך. דוקסיציקלין — רגישות לשמש ולא בהיריון. | ☐ |
| 13.46 | תרופות שאינן כרוניות | **מניעת מחלת גבהים (אורמוקס)** | אצטזולמיד לטרקים בגובה רב. סולפונאמיד: לא ברגישות לסולפה, באבנים בכליות או באי-ספיקת כליות. | ☐ |
| 13.47 | תרופות שאינן כרוניות | **אנטיביוטיקה "למקרה הצורך" לשלשול מטיילים** | רק לפי מכתב של מרפאת מטיילים, ליעדים שבהם מומלץ. מנה או קורס קצר כשמופיע שלשול קשה בטיול. | ☐ |
| 13.48 | תרופות שאינן כרוניות | **מחלת תנועה (טרבמין)** | לבחילה בנסיעה. מרדים; להימנע בגיל 65 ומעלה, בגלאוקומה ובהגדלת ערמונית. | ☐ |
| 13.58 | תרופות שאינן כרוניות | **מדללי ליחה (אצטילציסטאין, קרבוציסטאין, ברומהקסין)** | לשיעול עם ליחה סמיכה. קרבוציסטאין וברומהקסין — לא בכיב קיבה פעיל. | ☐ |
| 13.59 | תרופות שאינן כרוניות | **תכשירי צמחים לשיעול ולסינוסים (ברונכיקליר, קלובה, סינוקליר)** | תכשירי צמחים. קלובה (פלרגוניום) — לא במחלת כבד ולא עם נוגדי קרישה. | ☐ |

| # | מערכת | תרופה / קבוצה | מה נבדק | אושר |
|---|---|---|---|---|
| 13.60 | תרופות שאינן כרוניות | **תכשירים לאפטות ולכאב בפה (אורקורט, טיג'ל)** | לאפטה קטנה או לכאב מקומי בפה. פצע בפה מעל 3 שבועות — לרופא/ה (חשד לגידול). טיג'ל מכיל סליצילט. | ☐ |
| 13.61 | תרופות שאינן כרוניות | **טיפות עיניים נגד אודם (טטריזולין)** | מכווצות כלי דם בעין: לשימוש קצר בלבד (עד 3 ימים), אחרת אודם חוזר. לא בגלאוקומה עם זווית סגורה. | ☐ |
| 13.62 | תרופות שאינן כרוניות | **עזרי שינה ללא מרשם (דוקסילמין, ולריאן)** | לקשיי שינה זמניים. דוקסילמין — אנטיהיסטמין מרדים: לא בגיל 65 ומעלה, בגלאוקומה, בהגדלת ערמונית או עם תרופות מרדימות. נדודי שינה מתמשכים — הערכה (דיכאון, חרדה, דום נשימה בשינה). | ☐ |
| 13.63 | תרופות שאינן כרוניות | **תרופות נגד תולעים (ורמוקס, אסקזול)** | לתולעי סיכה (אוקסיאורים). מטפלים בכל בני הבית, וחוזרים אחרי שבועיים. לא בהיריון. | ☐ |
| 13.64 | תרופות שאינן כרוניות | **קרם קפסאיצין (זוסטריקס)** | לכאב נוירופתי מקומי ולכאב מפרקים. צריבה בהתחלה — צפויה. לא על עור פצוע או ליד העיניים. | ☐ |
| 13.65 | תרופות שאינן כרוניות | **משחות מחממות וצמחים לכאב שרירים (טראומפלנט, בנגיי, טייגר באלם)** | לחבלות קלות ולנקעים. לא על עור פצוע, ולא יותר מ-10 ימים. | ☐ |
| 13.66 | תרופות שאינן כרוניות | **תוספים לשחיקת סחוס (גלוקוזאמין, דיאצרין)** | תועלת מוגבלת. גלוקוזאמין — זהירות עם וורפרין. דיאצרין — שלשולים; לא בגיל 65 ומעלה ולא במחלת כבד. | ☐ |
| 13.67 | תרופות שאינן כרוניות | **הזעת יתר (אנהידרול פורטה)** | אלומיניום כלוריד להזעת יתר מקומית. הזעה כללית, בלילה או עם ירידה במשקל — לרופא/ה. | ☐ |
| 13.68 | תרופות שאינן כרוניות | **טיפול בנשירת שיער (מינוקסידיל, פרופסיה)** | לנשירה תורשתית. נשירה פתאומית, במוקדים או עם סימנים נוספים — לרופא/ה. אסור בהיריון. | ☐ |
| 13.69 | תרופות שאינן כרוניות | **תכשירי צמחים לגיל המעבר ולתסמונת קדם-וסתית** | צימיציפוגה (מנופרט, צימידונה) — דיווחים על פגיעה כבדית. אגנוס קסטוס (פרפמין) — לא עם טיפול הורמונלי. | ☐ |
| 13.70 | תרופות שאינן כרוניות | **תכשירי צמחים לערמונית ולדרכי השתן (פרמיקסון, קנפרון)** | לתסמיני ערמונית ידועים או לתמיכה בדרכי השתן. דם בשתן, צריבה עם חום או תסמינים חדשים — לרופא/ה. | ☐ |
| 13.71 | תרופות שאינן כרוניות | **גינקו בילובה (צרבונין, טבוקן)** | תועלת לא מוכחת בזיכרון. מגביר דימום: לא עם נוגדי קרישה, מעכבי טסיות או לפני ניתוח. | ☐ |
| 13.72 | תרופות שאינן כרוניות | **תכשירים לאי-ספיקה ורידית (ונורוטון)** | לנפיחות וכבדות ברגליים באי-ספיקה ורידית. נפיחות ברגל אחת, כאב או אודם — לרופא/ה (חשד לקריש דם). | ☐ |
| 13.82 | תרופות שאינן כרוניות | **תכשירי טרפנים לאבנים בדרכי השתן ובדרכי המרה (רווהטינקס, רווהכול)** | תכשירי צמחים (טרפנים) כתוספת בטיפול באבנים. לא מחליפים בירור של כאב, חום או דם בשתן. | ☐ |

# 1. לב וכלי דם

74 תרופות · לפי הנחיה: 26 · לפי הנחיה, בתנאים: 46 · הכנה לאישור רופא/ה: 2 · גרסה 2 · חלוקה לפי מערכות · 2.11.2026

מקורות: הנחיות יל"ד ישראל, ההסתדרות הרפואית, מהד' 2, יוני 2026; הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020; ACOG 2023 (סיכום AFP). שאר התחומים: החלטה מקומית; עלון לצרכן לפונקס (עודכן 12/2020). שאר התרופות: החלטה מקומית

## 1.א כללים

- חידוש רגיל: 3 חודשים
- ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה פעם בשנה
- עד 3 חידושים רצופים, ואז ביקור רופא
- אין התווית נגד ← תמיד מחדשים לפחות לחודש אחד
- חסרה מדידה, בדיקה או ביקורת שנתית: חידוש לחודש אחד + זימון למרפאה
- חריגה מספי ההחזרה: חידוש לחודש אחד + הודעה לרופא/ה
- התווית נגד או ערך חמור: לא מחדשים, הודעה לרופא/ה (הסף של כל תרופה מופיע ברשימה שלה)
- רפואן לא משנה מינון ולא מחליף תרופה. "מעקב צמוד" = תרופה עם מעקב תכוף (מעבדה, אק"ג, עיניים או צילום) — לבדוק כל ערך בקפידה
- ערכים חמורים בתרופות ליל"ד — לא מחדשים, הודעה לרופא/ה: (1) אשלגן 5.5 ומעלה בכל תרופה שבודקים בה אשלגן; באלדקטון (ספירונולקטון) כבר מ-5.0. (2) eGFR מתחת ל-30 במעכבי ACE, בחוסמי קולטן לאנגיוטנסין (ARB) ובאלדקטון, אינספרה או קרנדיה (MRA). (3) דופק מתחת ל-50 בתרופות שמאטות דופק: חוסמי בטא, ורפמיל, דילטיאזם, דיגוקסין, אמיודרון.
- תיאזיד לבד (הידרוכלורותיאזיד, אינדפמיד) עם eGFR מתחת ל-30: זה לא ערך חמור — חידוש לחודש אחד + הודעה לרופא/ה.
- תרופות עם כמה התוויות (ACEi/ARB בודדים, MRA, אנטרסטו, פוסיד, חוסמי בטא): בלי יעד ל"ד; טווח בטיחות סיסטולי 90 עד מתחת ל-160/100; מתחת ל-90 או תסמין ← לרופא/ה
- נוגדי קרישה ונוגדי טסיות לא נעצרים ע"י רפואן מלבד ערך חמור; דימום ← הודעה דחופה
- דגל אדום: הרפואן מכין לפי רשימת הבדיקות, והרופא/ה בודק/ת שוב לפני האישור — גם כשהכול תקין

## 1.ג בדיקות משותפות

| שלב | נושא | מה בודקים | קריטריון | אם לא מתקיים | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| לפני כל חידוש | מדידת ל"ד מתועדת | יש מדידה מתועדת (מרפאה או ממוצע ביתי) | מטופל חדש או אחרי שינוי טיפול ב-12 החודשים האחרונים: ב-6 החודשים האחרונים. אחרים: ב-12 החודשים האחרונים. ביתית: 2 בבוקר + 2 בערב, 4-7 ימים, לפי ממוצע | אין מדידה בזמן ← חידוש לחודש אחד + בקשת מדידה | החלטה יל"ד-9; פרק 1 עמ' 11; פרק 10 עמ' 86-87 |
| לפני כל חידוש | ל"ד ביעד | הממוצע האחרון בין הרצפה ליעד | ביעד: ≥130/80 וגם ≤120/70 | סיסטולי ≥131 או דיאסטולי ≥81 ← לרופא. סיסטולי <120 או דיאסטולי <70 ← לרופא | החלטות יל"ד-2-3 |
| לפני כל חידוש | גיל 80+ | מדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים | ביעד: סיסטולי 130-150 ודיאסטולי ≥70 (במקום היעד הכללי). נפילות וסחרחורת נבדקות בביקורת אצל הרופא/ה, לא בחידוש | מחוץ לטווח ← לרופא | פרק 6 עמ' 52; פרק 11 עמ' 92-96 |
| לפני כל חידוש | רכישות | כיסוי ימים ב-6 החודשים האחרונים | ≥80% מהימים | פחות ← לרופא/אחות לשיחת היענות | החלטה יל"ד-8 |
| לפני כל חידוש | בדיקות שנתיות | בוצעו ב-12 החודשים האחרונים | תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן | באיחור ← חידוש לחודש אחד + הפניה לבדיקות | החלטה יל"ד-11; פרק 10 עמ' 87 |
| לפני כל חידוש | בדיקות אחרי שינוי | אם היה שינוי: האם בוצעו | קריאטינין, K ו-Na תוך 4 שבועות מהשינוי | לא בוצעו או חריגים ← לרופא | החלטה יל"ד-1 |
| לפני כל חידוש | ספי מעבדה | התוצאות האחרונות | K: ≥5.0 תחת ספירונולקטון, אחרת מחוץ לטווח. Na: מחוץ לטווח. קריאטינין: עלייה >30% מהקודמת או eGFR <30 | חריגה ← לרופא | החלטות יל"ד-4-6 |
| לפני כל חידוש | ביקורת שנתית | ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה | ב-12 החודשים האחרונים | אין ביקור ← חידוש לחודש אחד + זימון לביקורת במרפאה | החלטה יל"ד-14 |

| שלב | נושא | מה בודקים | קריטריון | אם לא מתקיים | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| לפני כל חידוש | רצף חידושים | כמה חידושים רצופים מאז ביקור רופא | חידוש ל-3 חודשים; עד 4 רצופים | 3 חידושים כבר בוצעו ← ביקור רופא | החלטה יל"ד-10 |
| החזרה מיידית לרופא | ל"ד גבוה מאוד | המדידה האחרונה | ≥180/110: מעקב רופא תוך שבועיים לכל היותר. ≥220/120 במדידה חוזרת: לרופא עכשיו | חידוש לחודש אחד + העברה לרופא/ה (≥220/120: לרופא עכשיו) | פרק 8 עמ' 64; כלי האחיות |
| החזרה מיידית לרופא | תסמינים חריפים | תלונה בפנייה | כאב חזה, קוצר נשימה, כאב ראש פתאומי וחמור, חולשה, קושי בדיבור, הפרעת ראייה, בלבול | דחוף - לרופא עכשיו | פרק 19 עמ' 183 |
| החזרה מיידית לרופא | היריון | היריון, ייתכן היריון או תכנון היריון | ACEi, ARB וספירונולקטון אסורים בהיריון | לרופא | פרק 8 עמ' 72-73; פרק 26 |
| החזרה מיידית לרופא | נפילה או עילפון | מופיע בפנייה או ברשומה: סחרחורת בעמידה, נפילה, עילפון | חשד לתת-ל"ד תנוחתי | לרופא | פרק 1 עמ' 11; פרק 11 |
| החזרה מיידית לרופא | תרופה חדשה שמעלה ל"ד | תרופה חדשה ברשימה | NSAIDs כרוני, סטרואידים, גלולות עם אסטרוגן, נוגדי גודש, ממריצים, ציקלוספורין/טקרולימוס, ונלפקסין, ליקוריץ | לרופא | פרק 9 עמ' 83 |
| החזרה מיידית לרופא | דופק לא סדיר | במדידה | - | לרופא | פרק 10 עמ' 88 |
| לפני כל חידוש | בדיקת מעקב | לפי התרופה | שומנים: LDL; לבותירוקסין: TSH; אלופורינול/פבוקסוסטט: חומצה אורית — מ-12 החודשים האחרונים | אין ← חידוש לחודש + זימון לבדיקה | הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52; החלטה כללי-1 |
| לפני כל חידוש | ערך המעקב | לעומת הבדיקה הקודמת או היעד | LDL לא עלה ב-30% ומעלה; TSH בטווח המעבדה; חומצה אורית מתחת ל-6 | לא ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה | החלטות כללי-4-2 |
| לפני כל חידוש | רמה או ספירה מתועדת | לפי התרופה | ליתיום: 6 חודשים; דיגוקסין: 12 חודשים; קלוזפין: 4 שבועות | אין ← חידוש לחודש + זימון לבדיקה | החלטות מעקב-1, 3, 5 |
| לפני כל חידוש | רמה בטווח | הבדיקה האחרונה | ליתיום 0.6-1.0; דיגוקסין עד 1.2; קלוזפין WBC ≥3,500 ונויטרופילים ≥2,000 | מחוץ לטווח ← חידוש לחודש + הודעה; ערך חמור ← לא מחדשים | החלטות מעקב-2, 4, 5 |
| לפני כל חידוש | תרופות חדשות | רשימת התרופות | ליתיום: NSAIDs, ACEi, ARB, משתנים. דיגוקסין: אמיודרון, ורפמיל, דילטיאזם, קלריתרומיצין | יש ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה | החלטות מעקב-2, 4 |
| החזרה מיידית לרופא | חשד לרעילות | מופיע בפנייה או ברשומה | ליתיום: רעד, הקאות, שלשול, בלבול. דיגוקסין: בחילות, הפרעות ראייה, בלבול | דחוף - לרופא עכשיו | החלטות מעקב-2, 4 |

## 1.ד החלטות

| # | נושא | מה ההנחיה אומרת | ההחלטה לפרוטוקול | סוג | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| יל"ד-1 | בדיקות אחרי שינוי טיפול | קריאטינין ואלקטרוליטים 2-3 שבועות (פרק 8) או 4-2 שבועות (פרקים 10, 13); נתרן 7-14 ימים אחרי תיאזיד | קריאטינין, K ו-Na תוך 4 שבועות מכל התחלה או שינוי מינון. לא בוצעו או חריגים ← לרופא | הכרעה | פרק 8 עמ' 66; פרק 10 עמ' 86; פרק 13 עמ' 142 |
| יל"ד-2 | יעד ל"ד | טבלה 4: "130/80"; פרק 6 ושאר הפרקים: "<130/80" | ביעד = ממוצע ≥130/80. סיסטולי ≥131 או דיאסטולי ≥81 ← לרופא | הכרעה | פרק 1 עמ' 13; פרק 6 עמ' 52 |
| יל"ד-3 | רצפת ל"ד | פרק 6: לא מתחת ל-120/70; פרק 11 (גיל 65-79): 120/60 | סיסטולי <120 או דיאסטולי <70 ← לרופא (לשקול הפחתת טיפול) | הכרעה | פרק 6 עמ' 52; פרק 11 עמ' 92 |

| # | נושא | מה ההנחיה אומרת | ההחלטה לפרוטוקול | סוג | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| יל"ד-4 | אשלגן | "היפרקלמיה עיקשת או חמורה" ← הפסקה; ערך מספרי רק ל-MRA (<4.5 זהירות, >5.0 להימנע) | ספירונולקטון (אלדקטון): K ≥5.0 ← לרופא. כל שאר התרופות: K מחוץ לטווח המעבדה ← לרופא | החלטה מקומית | פרק 8 עמ' 63, 71 |
| יל"ד-5 | נתרן | תיאזידים ומעכבי RAAS: נתרן ואשלגן בתחילת טיפול ולפחות פעם בשנה; היפונתרמיה — לשקול הפסקת התיאזיד | Na מחוץ לטווח המעבדה ← לרופא | החלטה מקומית | פרק 8 עמ' 71; SPS |
| יל"ד-6 | קריאטינין | עלייה >30% מערך הבסיס ← הפסקה; עד 30% צפוי. "בסיס" לא מוגדר במטופל יציב | עלייה >30% לעומת התוצאה הקודמת, או eGFR <30 ← לרופא. חל על ACEi, ARB ותיאזידים | הנחיה + החלטה מקומית (הגדרת הבסיס) | פרק 8 עמ' 66, 71; פרק 13 עמ' 142 |
| יל"ד-7 | דופק תחת חוסם בטא | "ברדיקרדיה עקשנית" ← הפסקה; אין ערך מספרי | דופק במנוחה <55 ← לרופא | החלטה מקומית | פרק 8 עמ' 72 |
| יל"ד-8 | רכישות סדירות | ניטור רכישות מוזכר כדרך לבחון היענות; אין סף | רכישות שמכסות ≤80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← לרופא/אחות לשיחת היענות | החלטה מקומית | פרק 8 עמ' 67; פרק 9 עמ' 82 |
| יל"ד-9 | עדכניות מדידת ל"ד | למדוד בכל ביקור; אין מרווח מוגדר | מטופל חדש או אחרי שינוי טיפול ב-12 החודשים האחרונים: מדידה ב-6 החודשים האחרונים. כל השאר: ב-12 החודשים האחרונים. אין מדידה בזמן ← חידוש לחודש אחד + בקשת מדידה | החלטה מקומית | פרק 10 עמ' 86-87 |
| יל"ד-10 | משך חידוש ורצף | ביקור רופא 1-2 בשנה במטופל יציב (2-4 בשנה הראשונה) | חידוש ל-3 חודשים; עד 3 חידושים רצופים ואז ביקור רופא | החלטה מקומית | פרק 10 עמ' 86-87 |
| יל"ד-11 | מדידה או בדיקות שנתיות באיחור | נושא תפעולי — הנחיות קליניות לא עוסקות בו; מבוסס על נוהל הרפואן | חידוש חד-פעמי לחודש אחד + הפניה להשלמה. החידוש הבא רק עם התוצאות | החלטה מקומית | פרק 10 עמ' 87 |
| יל"ד-12 | תרופות קו מתקדם או התוויה לא שגרתית | ההנחיה מגדירה אותן כקו רביעי ואילך, נישה או התוויה אחרת; לא מתייחסת לחידוש | הרפואן מחדש בתנאי: טיפול כרוני קבוע, ובכפוף לכל ספי ההחזרה | החלטה מקומית | פרק 8 עמ' 63-75 |
| יל"ד-13 | שיחה עם המטופל/ת | נושא תפעולי — הנחיות קליניות לא עוסקות בו; מבוסס על נוהל הרפואן | החידוש הוא פעולה אדמיניסטרטיבית ללא שיחה עם המטופל/ת. הרפואן לא שואל על תלונות. תלונות שמחייבות החלפה או הפסקה נבדקות בביקורת השנתית אצל הרופא/ה. אם תלונה כזו מופיעה בפנייה או ברשומה, מעבירים לרופא/ה. | החלטה מקומית | - |
| יל"ד-14 | ביקורת שנתית במרפאה | ביקור רופא 1-2 בשנה במטופל יציב (2-4 בשנה הראשונה) | כל חידוש מחייב ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אין ביקור ← חידוש לחודש אחד וזימון לביקורת במרפאה. חל על כל התרופות. | החלטה מקומית | פרק 10 עמ' 86-87 |
| יל"ד-15 | מתי לא מחדשים | נושא תפעולי — הנחיות קליניות לא עוסקות בו; מבוסס על נוהל הרפואן | אין התווית נגד ← תמיד מחדשים לפחות לחודש אחד. חסר (מדידה, בדיקות, ביקורת שנתית) ← חידוש לחודש + זימון למרפאה. חריגה מספי ההחזרה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | החלטה מקומית | - |

| # | נושא | מה ההנחיה אומרת | ההחלטה לפרוטוקול | סוג | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| יל"ד-16 | ערכים חמורים | ACEi/ARB: K ≥6.0 ← הפסקה; ירידת eGFR ≥25% ← בירור (NICE NG203). MRA: K >5.5 ← הפחתה, ≥6.0 ← הפסקה (ESC HF 2021). חוסמי בטא: ברדיקרדיה <50 עם תסמינים ← הפחתה (ESC HF 2021). הספים בפרוטוקול מחמירים מעט | ערך חמור נחשב התווית נגד: K ≥5.5 (באלדקטון K ≥5.0); eGFR <30 ב-ACEi, ARB ו-MRA; דופק במנוחה <50 בתרופות מאטות דופק (חוסמי בטא, ורפמיל, דילטיאזם, דיגוקסין, אמיודרון). לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. תיאזיד בלבד עם eGFR <30: חידוש לחודש + הודעה (עודכן 8.11.2026). | החלטה מקומית | NICE NG203; ESC HF 2021 |
| יל"ד-17 | תרופות עם כמה התוויות | ההנחיות מטפלות בכל התוויה בנפרד: באי ספיקת לב, CKD וסוכרת מעלים למינון מטרה בלי קשר ליעד ל"ד; יעד ל"ד חל רק על יל"ד | חוסמי בטא (ביסופרולול, מטופרולול, קרבדילול, פרופרנולול), מעכבי ACE ו-ARB בודדים (לא בשילוב קבוע), ספירונולקטון, אפלרנון, פינרנון, אנטרסטו ופוסיד: בלי יעד ל"ד ובלי סעיף גיל 80; במקום זה טווח בטיחות: סיסטולי 90 ומעלה (עודכן מ-100 ב-8.11.2026) ומתחת ל-160/100. דופק, אשלגן וכליות כמו קודם | החלטה מקומית (2.11.2026) | ESC HF 2021; KDIGO 2024; ADA 2026 |
| כללי-1 | בדיקות מעקב | שומנים: פרופיל 12-4 שבועות אחרי התחלה, אחר כך כל 12-6 חודשים (ההנחיה הישראלית 2020; ESC/EAS 2019). TSH בלבותירוקסין: שנתי כשמאוזן (NICE NG145). חומצה אורית בטיפול מוריד: יעד <6, בדיקה תקופתית (ACR 2020) | LDL, TSH וחומצה אורית מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש + זימון | החלטה מקומית (הצעה) | הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52; ESC/EAS 2019; NICE NG145; ACR 2020 |
| כללי-5 | נוגדי טסיות | אספירין 100-75 מ"ג למניעה שניונית; משך DAPT לפי הקרדיולוג; שילוב עם נוגד קרישה מעלה דימום ומוגבל לתקופה מוגדרת | אספירין 100-75 מ"ג בלבד. נוגד קרישה במקביל ← הודעה. דימום ← התווית נגד. קלופידוגרל רק כטיפול כרוני לטווח ארוך | החלטה מקומית (הצעה) | ESC CCS 2024; ESC ACS 2023 |
| כללי-7 | אלופורינול ופבוקסוסטט | יעד חומצה אורית <6 mg/dL; התחלה במינון נמוך והתאמה לכליות; פריחה ← הפסקה מיידית (סיכון SJS/DRESS) | חומצה אורית ≥6 ← הודעה. אלופורינול: eGFR <30 ← הודעה (מינון). פריחה ← התווית נגד, דחוף | החלטה מקומית (הצעה) | ACR 2020; תווית FDA |
| כללי-11 | מעכבי PCSK9 (רפאטה, פראלואנט) | בסל באינדיקציות מצומצמות; רוב המטופלים דרך שב"ן או ביטוח. סבילות טובה, תגובה מקומית | בתנאים: אישור מימון בתוקף וטיפול כרוני; מעקב LDL כמו בסטטין. אין אישור ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה | החלטה מקומית (הצעה) | הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 (פרק מעכבי PCSK9) |
| כללי-12 | תרופות כרוניות נוספות (2) | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי). SSRI/SNRI: היפונתרמיה בקשישים | בזאפיברט, גבפנטין, פרגבלין, SSRI/SNRI (נתרן בגיל 65+), מעכבי ארומטאז, טמוקסיפן, רלוקסיפן, טרבינפין ואיטרקונזול (קורס): לפי הרשימה של כל תרופה | החלטה מקומית (הצעה) | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| כללי-16 | ברזל, B12, חומצה פולית | ברזל: אחרי תיקון האנמיה ממשיכים כ-3 חודשים לחידוש המאגרים, ואז ספירה תקופתית (BSG 2021). B12 בטיפול שימורי: אין בדיקת רמה שגרתית אלא בתסמינים (NICE NG239, 2024) — הרמה השנתית בפרוטוקול מחמירה | ברזל: ספירת דם ופריטין מ-6 חודשים; טיפול מעל 6 חודשים בלי התוויה ← הודעה. B12: רמה שנתית | החלטה מקומית (הצעה) | BSG 2021; NICE NG239 |
| כללי-17 | קרדיולוגיה | טיקגרלור/פרסוגרל: DAPT כ-12 חודשים אחרי ACS (ESC 2023). פלקאיניד/פרופפנון: אסורים במחלה לבבית מבנית (ESC AF 2024). דרונדרון: תפקודי כבד בחודשים הראשונים (תווית) | טיקגרלור ופרסוגרל: לפי משך שנקבע; נוגד קרישה במקביל ← דחוף. פלקאיניד, פרופפנון, דרונדרון: אק"ג שנתי ושלילת מחלה מבנית. אנטרסטו: בפרוטוקול יל"ד | החלטה מקומית (הצעה) | ESC ACS 2023; ESC AF 2024; תווית |

| # | נושא | מה ההנחיה אומרת | ההחלטה לפרוטוקול | סוג | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| כללי-20 | השלמות מהמאגר (2.11.2026) | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) | טרזוסין, פינסטריד, אינקליסירן, ורדנאפיל, טיפות לגלאוקומה (ביקורת עיניים שנתית; טימולול: דופק ואסתמה), NSAID ממושך (כליות, אשלגן, ל"ד, דימום, הגנת קיבה), אנטיהיסטמינים, ציננריזין, דומפרידון, מבברין, סידן, מידודרין, פנטוקסיפילין, דיפירידמול, ולציקלוביר מונע, חומצה זולדרונית | החלטה מקומית (הצעה) | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| כללי-21 | תרופות מומחה נוספות | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי). הטיפול נקבע ומנוטר ע"י המומחה | מטוקלופרמיד ממושך, ממריצים/מודפיניל, טרשת נפוצה, אונקולוגיה, יל"ד ריאתי/IPF, סירולימוס, הורמון גדילה, המטולוגיה, CF, טפמידיס/מבקמטן: הודעה בלבד, חידוש ע"י רופא/ה. תרופות ביולוגיות בזריקה בקהילה: הרפואן מכין (אישור, מכתב מומחה, מרווח, בטיחות) והרופא/ה מאשר/ת (5.11.2026) | החלטה מקומית | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| כללי-22 | השלמות 2 מהמאגר (2.11.2026) | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) | ויטמין D, בטאהיסטין, חומצה במפדואית, אומגה 3/איקוזפנט, ציפרופיברט, וריסיגואט, ניטרוגליצרין תת-לשוני, פזולינטנט/אלינזנטנט (ALT), דואביב, אינטראוסה, סיאנה, אורליסטט, פרוקלופריד, משלשלים, טטרציקלינים ממושכים, מניעת זיהומי שתן, משככי כאב ממושכים, ביקרבונט. עודכן ב-7.11.2026: אין עוד "רופא/ה בלבד" בקבוצה זו — ראו החלטת הסקירה | החלטה מקומית (הצעה) | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| מעקב-3 | דיגוקסין: תדירות | רמה לא נדרשת באופן שגרתי — רק בחשד לרעילות, שינוי בתפקוד הכליות או תרופה מתקשרת; כליות ואשלגן לפחות שנתית. הרמה השנתית בפרוטוקול מחמירה | רמה מ-12 החודשים האחרונים; אשלגן וקריאטינין מ-6 החודשים האחרונים | החלטה מקומית (הצעה) | SPS |
| מעקב-4 | דיגוקסין: ערכים | באי ספיקת לב רמה מכוונת 0.5-0.9 ng/mL; מעל 2.0 — רעילות; היפוקלמיה מגבירה רעילות | רמה עד 1.2 ng/mL ← תקין. מעל ← הודעה; ≥2.0 ← ערך חמור. K <3.0 או דופק <50 ← ערך חמור | החלטה מקומית (הצעה) | ESC HF 2021; SPS |
| מעקב-9 | אמיודרון | TSH ותפקודי כבד כל 6 חודשים; צילום חזה ותפקודי ריאה בתחילת טיפול; בדיקת עיניים בתסמינים; אק"ג | TSH ו-ALT מ-6 החודשים האחרונים; אק"ג, צילום חזה ובדיקת עיניים שנתיים; דופק | החלטה מקומית (הצעה) | SPS; תווית FDA |
| מעקב-10 | וורפרין (קומדין) | INR כל 4-12 שבועות כשיציב; INR >5 בלי דימום ← השהיה/הפחתה; דימום ← טיפול דחוף | INR מ-6 השבועות האחרונים ובטווח היעד; INR ≥5 או דימום ← הודעה דחופה. לא נעצר ע"י רפואן | החלטה מקומית (הצעה) | ACCP 2012; BSH |
| מעקב-11 | NOACs | קריאטינין וספירת דם שנתית; גיל ≥75 או שבריריות — כל 6 חודשים; CrCl ≤60 — כל (CrCl/10) חודשים. אפיקסבן/ריברוקסבן אסורים ב-CrCl <15, דביגטרן ב-<30 | קריאטינין וספירת דם מ-12 חודשים (גיל 75+ או eGFR 60> :6 חודשים). eGFR <50 ← הודעה (מינון). אפיקסבן/ריברוקסבן eGFR <15, דביגטרן eGFR <30 ← ערך חמור. ירידה ב-Hb או דימום ← הודעה | החלטה מקומית (הצעה) | EHRA 2021 |
| סקירה-1 | סקירת פריטים חסומים (7.11.2026) | נושא תפעולי — הנחיות קליניות לא עוסקות בו; מבוסס על נוהל הרפואן | אף תרופה לא חסומה כברירת מחדל. 59 הפריטים שהיו "רופא/ה בלבד" נסקרו אחד-אחד: חלקם פתוחים עם רשימת בדיקות, חלקם בדגל אדום (בדיקה כפולה מול הרופא/ה). נשארים אצל הרופא/ה: רואקוטן, אנטיביוטיקה לתסמין חדש (מלבד מוקסיפן/רפאפן אחרי משטח גרון חיובי) ותרופות נגד שפעת. התראת האינטראקציות של המערכת היא שכבת ההגנה הבסיסית. | החלטה מקומית (7.11.2026) | - |

## 1.ה רשימת התרופות (לסימון)

| # | שם | גנרי | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | אנלפריל | Enalapril | מעכב ACE | לפי הנחיה | ☐ | |
| 1.2 | רמיפריל | Ramipril | מעכב ACE | לפי הנחיה | ☐ | |
| 1.3 | סילזפריל | Cilazapril | מעכב ACE | לפי הנחיה | ☐ | |
| 1.4 | קפטופריל | Captopril | מעכב ACE | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.5 | לוסרטן | Losartan | ARB | לפי הנחיה | ☐ | |
| 1.6 | קנדסרטן | Candesartan | ARB | לפי הנחיה | ☐ | |
| 1.7 | ולסרטן | Valsartan | ARB | לפי הנחיה | ☐ | |
| 1.8 | הידרוכלורותיאזיד | Hydrochlorothiazide | משתן תיאזידי | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.9 | אינדפמיד | Indapamide | משתן דמוי-תיאזיד | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.10 | אמלודיפין | Amlodipine | חוסם תעלות סידן DHP | לפי הנחיה | ☐ | |
| 1.11 | לבאמלודיפין | Levamlodipine | חוסם תעלות סידן DHP | לפי הנחיה | ☐ | |
| 1.12 | לרקנידיפין | Lercanidipine | חוסם תעלות סידן DHP | לפי הנחיה | ☐ | |
| 1.13 | ניפדיפין | Nifedipine | חוסם תעלות סידן DHP | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.14 | ביסופרולול | Bisoprolol | חוסם בטא | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.15 | מטופרולול | Metoprolol | חוסם בטא | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.16 | אטנולול | Atenolol | חוסם בטא | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.17 | קרבדילול | Carvedilol | חוסם בטא + אלפא | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.18 | פרופרנולול | Propranolol | חוסם בטא | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.19 | לבטלול | Labetalol | חוסם בטא + אלפא | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.20 | ורפמיל | Verapamil | חוסם תעלות סידן non-DHP | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.21 | דילטיאזם | Diltiazem | חוסם תעלות סידן non-DHP | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.22 | ספירונולקטון | Spironolactone | חוסם קולטן מינרלוקורטיקואידי | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.23 | אפלרנון | Eplerenone | חוסם קולטן מינרלוקורטיקואידי | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.24 | פינרנון | Finerenone | MRA לא-סטרואידלי | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.25 | פורוסמיד | Furosemide | משתן לולאה | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.26 | דוקסזוסין | Doxazosin | חוסם אלפא | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.27 | קלונידין | Clonidine | אגוניסט אלפא מרכזי | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |

| # | שם | גנרי | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.28 | מתילדופה | Methyldopa | אגוניסט אלפא מרכזי | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.29 | מינוקסידיל | Minoxidil | מרחיב כלי דם ישיר | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.30 | הידרלזין | Hydralazine | מרחיב כלי דם ישיר | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.31 | אמילוריד + הידרוכלורותיאזיד | Amiloride + HCTZ | משתן שומר אשלגן + תיאזיד | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.32 | סקוביטריל/ולסרטן | Sacubitril/Valsartan | ARNI | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.33 | רמיפריל + הידרוכלורותיאזיד | Ramipril + HCTZ | משולב: ACEi + תיאזיד | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.34 | סילזפריל + הידרוכלורותיאזיד | Cilazapril + HCTZ | משולב: ACEi + תיאזיד | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.35 | לוסרטן + הידרוכלורותיאזיד | Losartan + HCTZ | משולב: ARB + תיאזיד | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.36 | קנדסרטן + הידרוכלורותיאזיד | Candesartan + HCTZ | משולב: ARB + תיאזיד | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.37 | ולסרטן + הידרוכלורותיאזיד | Valsartan + HCTZ | משולב: ARB + תיאזיד | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.38 | אנלפריל + לרקנידיפין | Enalapril + Lercanidipine | משולב: ACEi + CCB | לפי הנחיה | ☐ | |
| 1.39 | ולסרטן + אמלודיפין | Valsartan + Amlodipine | משולב: ARB + CCB | לפי הנחיה | ☐ | |
| 1.40 | אטורבסטטין | Atorvastatin | שומנים · סטטין | לפי הנחיה | ☐ | |
| 1.41 | רוזובסטטין | Rosuvastatin | שומנים · סטטין | לפי הנחיה | ☐ | |
| 1.42 | סימבסטטין | Simvastatin | שומנים · סטטין | לפי הנחיה | ☐ | |
| 1.43 | פרבסטטין | Pravastatin | שומנים · סטטין | לפי הנחיה | ☐ | |
| 1.44 | אזטימיב | Ezetimibe | שומנים · מעכב ספיגת כולסטרול | לפי הנחיה | ☐ | |
| 1.45 | אטורבסטטין + אזטימיב | Atorvastatin + Ezetimibe | שומנים · סטטין + אזטימיב | לפי הנחיה | ☐ | |
| 1.46 | רוזובסטטין + אזטימיב | Rosuvastatin + Ezetimibe | שומנים · סטטין + אזטימיב | לפי הנחיה | ☐ | |
| 1.47 | אבולוקומאב | Evolocumab | שומנים · מעכב PCSK9 (זריקה) | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.48 | אלירוקומאב | Alirocumab | שומנים · מעכב PCSK9 (זריקה) | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.49 | אספירין במינון נמוך | Aspirin (low dose) | נוגדי טסיות · נוגד טסיות | לפי הנחיה | ☐ | |
| 1.50 | קלופידוגרל | Clopidogrel | נוגדי טסיות · נוגד טסיות | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.51 | בזאפיברט | Bezafibrate | שומנים · פיברט | לפי הנחיה | ☐ | |
| 1.52 | טיקגרלור | Ticagrelor | נוגד טסיות (P2Y12) | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.53 | פרסוגרל | Prasugrel | נוגד טסיות (P2Y12) | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.54 | איזוסורביד מונוניטרט | Isosorbide mononitrate | ניטרט | לפי הנחיה | ☐ | |

| # | שם | גנרי | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 | פלקאיניד | Flecainide | נוגד הפרעות קצב (IC) | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.56 | פרופפנון | Propafenone | נוגד הפרעות קצב (IC) | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.57 | דרונדרון | Dronedarone | נוגד הפרעות קצב | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.58 | אינקליסירן | Inclisiran | שומנים · siRNA נגד PCSK9 (זריקה כל 6 חודשים) | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.59 | מידודרין | Midodrine | יל"ד אורתוסטטי | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.60 | פנטוקסיפילין | Pentoxifylline | צליעה לסירוגין | לפי הנחיה | ☐ | |
| 1.61 | דיפירידמול | Dipyridamole | נוגד טסיות | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.62 | תרופות לב במעקב מומחה | Cardiology specialist drugs | קרדיולוגיה - מומחה | דגל אדום | ☐ | |
| 1.63 | חומצה במפדואית | Bempedoic acid | שומנים · מעכב ACL | לפי הנחיה | ☐ | |
| 1.64 | אומגה 3 / איקוזפנט אתיל | Omega-3 / icosapent ethyl | שומנים · אומגה 3 מרשמית | לפי הנחיה | ☐ | |
| 1.65 | ציפרופיברט | Ciprofibrate | שומנים · פיברט | לפי הנחיה | ☐ | |
| 1.66 | וריסיגואט | Vericiguat | אי-ספיקת לב · מעורר sGC | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 1.67 | ניטרוגליצרין (תת-לשוני) | Nitroglycerin (sublingual) | ניטרט לפי הצורך | לפי הנחיה | ☐ | |
| 1.68 | הפרינים במשקל מולקולרי נמוך | Low-molecular-weight heparins | נוגד קרישה בזריקה | דגל אדום | ☐ | |
| 1.69 | דיגוקסין | Digoxin | גליקוזיד לבבי | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |
| 1.70 | אמיודרון | Amiodarone | נוגד הפרעות קצב | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |
| 1.71 | וורפרין | Warfarin | נוגד קרישה (אנטגוניסט ויטמין K) | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |
| 1.72 | אפיקסבן | Apixaban | נוגד קרישה ישיר (NOAC) | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |
| 1.73 | ריברוקסבן | Rivaroxaban | נוגד קרישה ישיר (NOAC) | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |
| 1.74 | דביגטרן | Dabigatran | נוגד קרישה ישיר (NOAC) | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |

## 1.1 ו פירוט מלא

### 1.1 **אנלפריל** · Enalapril לפי הנחיה

מעכב ACE

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | אנלדקס · Enaladex \| אנלפרי · Enalapri |
| נימוק / הערה | תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: יל"ד, אי-ספיקת לב, מחלת כליות כרונית, אחרי אוטם. קו ראשון; ספי מעבדה ברורים בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מדידת ל"ד מתועדת | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | ל"ד בטווח בטיחות | ל"ד אחרון: סיסטולי 90 ומעלה ומתחת ל-160/100, בלי סחרחורת או עילפון מתועדים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן. | זימון |
| 6 | בדיקות אחרי שינוי<br>שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם? | אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן, נתרן תוך 4 שבועות מהשינוי. | שאלה |
| 7 | אשלגן (K) תקין | בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים | |
| 8 | נתרן (Na) תקין | בבדיקה האחרונה נתרן (Na) תקין. חריג: Na מתחת ל-132 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 9 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים | |
| 10 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 11 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 12 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 13 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 14 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 15 | אי ספיקת לב: בדיקות כל 3–6 חודשים | באי ספיקת לב: אשלגן וקריאטינין מ-6 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | קריאטינין, K, Na תוך 4 שבועות מכל שינוי; שנתי: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, אלבומין/קריאטינין בשתן |
| ספי החזרה לרופא/ה | K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם; Na מתחת ל-132 |
| ערך חמור | K ≥5.5; eGFR <30 |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; ערך חמור: K ≥5.5; eGFR <30 |

| | |
|---|---|
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | שיעול יבש ← הפסקה ומעבר ל-ARB |
| **מקור** | פרק 8 עמ' 61, 71-72; מעקב: SPS Medicines Monitoring · SPS Medicines Monitoring (NHS) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.2 רמיפריל · Ramipril לפי הנחיה

מעכב ACE

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (4) | טריטייס · Tritace \| רמיטנס 10 · Ramitens 10 \| רמיפריל אינובמד · Ramipril Inovamed \| רמיפריל טבע 5 · Ramipril Teva 5 |
| נימוק / הערה | תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: יל"ד, אי-ספיקת לב, מחלת כליות כרונית, אחרי אוטם. קו ראשון; ספי מעבדה ברורים בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מדידת ל"ד מתועדת | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | ל"ד בטווח בטיחות | ל"ד אחרון: סיסטולי 90 ומעלה ומתחת ל-160/100, בלי סחרחורת או עילפון מתועדים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן. | זימון |
| 6 | בדיקות אחרי שינוי<br>שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם? | אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן, נתרן תוך 4 שבועות מהשינוי. | שאלה |
| 7 | אשלגן (K) תקין | בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים | |
| 8 | נתרן (Na) תקין | בבדיקה האחרונה נתרן (Na) תקין. חריג: Na מתחת ל-132 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 9 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים | |
| 10 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 11 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 12 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 13 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 14 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 15 | אי ספיקת לב: בדיקות כל 3–6 חודשים | באי ספיקת לב: אשלגן וקריאטינין מ-6 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | קריאטינין, K, Na תוך 4 שבועות מכל שינוי; שנתי: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, אלבומין/קריאטינין בשתן |
| ספי החזרה לרופא/ה | K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם; Na מתחת ל-132 |
| ערך חמור | K ≥5.5; eGFR <30 |

| | |
|---|---|
| **מצבים שמוציאים מהפרוטוקול** | היריון או תכנון היריון; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; ערך חמור: K ≥5.5; eGFR <30 |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | שיעול יבש ← הפסקה ומעבר ל-ARB |
| **מקור** | פרק 8 עמ' 72; מעקב: SPS Medicines Monitoring · SPS Medicines Monitoring (NHS) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 1.3 **סילזפריל** · Cilazapril לפי הנחיה

מעכב ACE

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (1)** | סילריל · Cilaril |
| **נימוק / הערה** | תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: יל"ד, אי-ספיקת לב, מחלת כליות כרונית, אחרי אוטם. קו ראשון; ספי מעבדה ברורים בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מדידת ל"ד מתועדת | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | ל"ד בטווח בטיחות | ל"ד אחרון: סיסטולי 90 ומעלה ומתחת ל-160/100, בלי סחרחורת או עילפון מתועדים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן. | זימון |
| 6 | בדיקות אחרי שינוי<br>שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם? | אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן, נתרן תוך 4 שבועות מהשינוי. | שאלה |
| 7 | אשלגן (K) תקין | בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים | |
| 8 | נתרן (Na) תקין | בבדיקה האחרונה נתרן (Na) תקין. חריג: Na מתחת ל-132 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 9 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים | |
| 10 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 11 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 12 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 13 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 14 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 15 | אי ספיקת לב: בדיקות כל 3–6 חודשים | באי ספיקת לב: אשלגן וקריאטינין מ-6 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | קריאטינין, K, Na תוך 4 שבועות מכל שינוי; שנתי: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, אלבומין/קריאטינין בשתן |
| **ספי החזרה לרופא/ה** | K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם; Na מתחת ל-132 |
| **ערך חמור** | K ≥5.5; eGFR <30 |
| **מצבים שמוציאים מהפרוטוקול** | היריון או תכנון היריון; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; ערך חמור: K ≥5.5; eGFR <30 |

| | |
|---|---|
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | שיעול יבש ← הפסקה ומעבר ל-ARB |
| **מקור** | פרק 8 עמ' 72; מעקב: SPS Medicines Monitoring · SPS Medicines Monitoring (NHS) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.4 קפטופריל · Captopril

לפי הנחיה, בתנאים

מעכב ACE

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | אסריל · Aceril 12.5, 25 \| Aceril 50 · אסריל 50 (לאימות מול מאגר משרד הבריאות) |
| נימוק / הערה | תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: יל"ד, אי-ספיקת לב, מחלת כליות כרונית, אחרי אוטם. 2-3 מנות ביום; לוודא שזה טיפול קבוע ולא לפי צורך בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מדידת ל"ד מתועדת | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | ל"ד בטווח בטיחות | ל"ד אחרון: סיסטולי 90 ומעלה ומתחת ל-160/100, בלי סחרחורת או עילפון מתועדים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן. | זימון |
| 6 | בדיקות אחרי שינוי<br>שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם? | אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן, נתרן תוך 4 שבועות מהשינוי. | שאלה |
| 7 | אשלגן (K) תקין | בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים | |
| 8 | נתרן (Na) תקין | בבדיקה האחרונה נתרן (Na) תקין. חריג: Na מתחת ל-132 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 9 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים | |
| 10 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 11 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 12 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 13 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 14 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 15 | אי ספיקת לב: בדיקות כל 3–6 חודשים | באי ספיקת לב: אשלגן וקריאטינין מ-6 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | קריאטינין, K, Na תוך 4 שבועות מכל שינוי; שנתי: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, אלבומין/קריאטינין בשתן |
| ספי החזרה לרופא/ה | K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם; Na מתחת ל-132 |
| ערך חמור | K ≥5.5; eGFR <30 |

| | |
|---|---|
| **מצבים שמוציאים מהפרוטוקול** | היריון או תכנון היריון; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; ערך חמור: K ≥5.5; eGFR <30 |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | שיעול יבש ← הפסקה ומעבר ל-ARB |
| **מקור** | פרק 8 עמ' 72; מעקב: SPS Medicines Monitoring · SPS Medicines Monitoring (NHS) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.5 לוסרטן · Losartan לפי הנחיה

ARB

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (4) | אוקסאאר · Ocsaar 50 \| לוסרטה · Losarta \| לוסרדקס · Losardex \| לוטן · Lotan |
| נימוק / הערה | תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: יל"ד, אי-ספיקת לב, מחלת כליות כרונית, אחרי אוטם. קו ראשון; ספי מעבדה ברורים בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מדידת ל"ד מתועדת | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | ל"ד בטווח בטיחות | ל"ד אחרון: סיסטולי 90 ומעלה ומתחת ל-160/100, בלי סחרחורת או עילפון מתועדים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן. | זימון |
| 6 | בדיקות אחרי שינוי<br>שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם? | אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן, נתרן תוך 4 שבועות מהשינוי. | שאלה |
| 7 | אשלגן (K) תקין | בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים | |
| 8 | נתרן (Na) תקין | בבדיקה האחרונה נתרן (Na) תקין. חריג: Na מתחת ל-132 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 9 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים | |
| 10 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 11 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 12 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 13 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 14 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 15 | אי ספיקת לב: בדיקות כל 3–6 חודשים | באי ספיקת לב: אשלגן וקריאטינין מ-6 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | קריאטינין, K, Na תוך 4 שבועות מכל שינוי; שנתי: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, אלבומין/קריאטינין בשתן |
| ספי החזרה לרופא/ה | K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם; Na מתחת ל-132 |
| ערך חמור | K ≥5.5; eGFR <30 |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; ערך חמור: K ≥5.5; eGFR <30 |

| מקור | |
|---|---|
| פרק 8 עמ' 71-72; מעקב: SPS Medicines Monitoring | SPS Medicines Monitoring (NHS) · |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 1.6 קנדסרטן · Candesartan לפי הנחיה

ARB

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | אטקנד · Atacand \| קנדור · Candor |
| נימוק / הערה | תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: יל"ד, אי-ספיקת לב, מחלת כליות כרונית, אחרי אוטם. קו ראשון; ספי מעבדה ברורים בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מדידת ל"ד מתועדת | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | ל"ד בטווח בטיחות | ל"ד אחרון: סיסטולי 90 ומעלה ומתחת ל-160/100, בלי סחרחורת או עילפון מתועדים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן. | זימון |
| 6 | בדיקות אחרי שינוי<br>שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם? | אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן, נתרן תוך 4 שבועות מהשינוי. | שאלה |
| 7 | אשלגן (K) תקין | בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים | |
| 8 | נתרן (Na) תקין | בבדיקה האחרונה נתרן (Na) תקין. חריג: Na מתחת ל-132 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 9 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים | |
| 10 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 11 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 12 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 13 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 14 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 15 | אי ספיקת לב: בדיקות כל 3–6 חודשים | באי ספיקת לב: אשלגן וקריאטינין מ-6 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | קריאטינין, K, Na תוך 4 שבועות מכל שינוי; שנתי: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, אלבומין/קריאטינין בשתן |
| ספי החזרה לרופא/ה | K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם; Na מתחת ל-132 |
| ערך חמור | K ≥5.5; eGFR <30 |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; ערך חמור: K ≥5.5; eGFR <30 |

| מקור | |
|---|---|
| פרק 8 עמ' 72; מעקב: SPS Medicines Monitoring | SPS Medicines Monitoring (NHS) · |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.7 ולסרטן · Valsartan לפי הנחיה

ARB

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (4) | דיובן · Diovan \| וקטור · Vector \| ואלסרטן דקסל · Valsartan Dexcel \| ואלסרטן מדו · Valsartan-Medo |
| נימוק / הערה | תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: יל"ד, אי-ספיקת לב, מחלת כליות כרונית, אחרי אוטם. קו ראשון; ספי מעבדה ברורים בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מדידת ל"ד מתועדת | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | ל"ד בטווח בטיחות | ל"ד אחרון: סיסטולי 90 ומעלה ומתחת ל-160/100, בלי סחרחורת או עילפון מתועדים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן. | זימון |
| 6 | בדיקות אחרי שינוי<br>שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם? | אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן, נתרן תוך 4 שבועות מהשינוי. | שאלה |
| 7 | אשלגן (K) תקין | בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים | |
| 8 | נתרן (Na) תקין | בבדיקה האחרונה נתרן (Na) תקין. חריג: Na מתחת ל-132 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 9 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים | |
| 10 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 11 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 12 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 13 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 14 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 15 | אי ספיקת לב: בדיקות כל 3–6 חודשים | באי ספיקת לב: אשלגן וקריאטינין מ-6 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | קריאטינין, K, Na תוך 4 שבועות מכל שינוי; שנתי: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, אלבומין/קריאטינין בשתן |
| ספי החזרה לרופא/ה | K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם; Na מתחת ל-132 |
| ערך חמור | K ≥5.5; eGFR <30 |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; ערך חמור: K ≥5.5; eGFR <30 |

| מקור | |
|---|---|
| פרק 8 עמ' 72; מעקב: SPS Medicines Monitoring | SPS Medicines Monitoring (NHS) · |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 1.8 הידרוכלורותיאזיד · Hydrochlorothiazide לפי הנחיה, בתנאים

משתן תיאזידי

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | דיזותיאזיד · Disothiazide 25 |
| נימוק / הערה | רק אחרי בדיקת Na ראשונה תקינה ובדיקות שנתיות בזמן |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מדידת ל"ד מתועדת | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | ל"ד ביעד | ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | גיל 80+<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה? | בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן, סידן, חומצה אורית. | זימון |
| 7 | בדיקות אחרי שינוי<br>שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם? | אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן, נתרן תוך 4 שבועות מהשינוי. | שאלה |
| 8 | אשלגן (K) תקין | בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים | |
| 9 | נתרן (Na) תקין | בבדיקה האחרונה נתרן (Na) תקין. חריג: Na מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 10 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם או eGFR <30 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 11 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 12 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 13 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 14 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 15 | אין התווית נגד | גאוט פעיל ללא אלופורינול/פבוקסוסטט; eGFR <30; סידן גבוה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | Na, K, קריאטינין תוך 4 שבועות מהתחלה (בייחוד נשים מעל 65); שנתי: Na, K, Ca, חומצה אורית, קריאטינין |
| ספי החזרה לרופא/ה | Na מחוץ לטווח המעבדה; K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם; eGFR <30 |
| ערך חמור | K ≥5.5 |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | גאוט פעיל ללא אלופורינול/פבוקסוסטט; eGFR <30; סידן גבוה; ערך חמור: K ≥5.5 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | התקף גאוט ← הפסקה אם אין טיפול באלופורינול/פבוקסוסטט; חולשה או בלבול (חשד להיפונתרמיה) ← בדיקת Na; היפונתרמיה ← הפסקה; סידן גבוה בבדיקה ← בירור ומעבר לפורוסמיד |

| מקור | |
|---|---|
| פרק 8 עמ' 62, 66, 71-73; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) | |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 1.9 **אינדפמיד** · Indapamide לפי הנחיה, בתנאים

משתן דמוי-תיאזיד

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (1)** | פמיד · Pamid 2.5 |
| **נימוק / הערה** | כמו תיאזיד; המשתן המועדף בהנחיה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מדידת ל"ד מתועדת | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | ל"ד ביעד | ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | גיל 80+<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה? | בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן, סידן, חומצה אורית. | זימון |
| 7 | בדיקות אחרי שינוי<br>שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם? | אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן, נתרן תוך 4 שבועות מהשינוי. | שאלה |
| 8 | אשלגן (K) תקין | בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים | |
| 9 | נתרן (Na) תקין | בבדיקה האחרונה נתרן (Na) תקין. חריג: Na מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 10 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם או eGFR <30 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 11 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 OP = 2 אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 12 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 13 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 14 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 15 | אין התווית נגד | גאוט פעיל ללא אלופורינול/פבוקסוסטט; eGFR <30; סידן גבוה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | Na, K, קריאטינין תוך 4 שבועות מהתחלה (בייחוד נשים מעל 65); שנתי: Na, K, Ca, חומצה אורית, קריאטינין |
| **ספי החזרה לרופא/ה** | Na מחוץ לטווח המעבדה; K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם; eGFR <30 |
| **ערך חמור** | K ≥5.5 |
| **מצבים שמוציאים מהפרוטוקול** | גאוט פעיל ללא אלופורינול/פבוקסוסטט; eGFR <30; סידן גבוה; ערך חמור: K ≥5.5 |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | התקף גאוט ← הפסקה אם אין טיפול באלופורינול/פבוקסוסטט; חולשה או בלבול (חשד להיפונתרמיה) ← בדיקת Na; היפונתרמיה ← הפסקה; סידן גבוה בבדיקה ← בירור ומעבר לפורוסמיד |

| | |
|---|---|
| מקור | פרק 8 עמ' 62, 73; פרק 9 עמ' 84; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.10 אמלודיפין · Amlodipine לפי הנחיה

חוסם תעלות סידן DHP

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (4) | נורווסק · Norvasc \| אמלו · Amlow \| אמלודי · Amlody \| אמלודיפין טבע · Amlodipine Teva |
| נימוק / הערה | ללא דרישת מעבדה; תופעות לוואי קלות לזיהוי |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מדידת ל"ד מתועדת | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | ל"ד ביעד | ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | גיל 80+<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה? | בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן. | זימון |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | אין התווית נגד | מינון שנקבע בגלל היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין בדיקה ייעודית; הבדיקות השנתיות הכלליות |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | מינון שנקבע בגלל היריון |
| תלונות בפנייה או ברשומה | בצקת ברגליים ← הפחתת מינון או מעבר ללרקנידיפין; עיבוי חניכיים ← הפסקה |
| מקור | פרק 8 עמ' 61, 71, 73; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.11 **לבאמלודיפין** · Levamlodipine לפי הנחיה

חוסם תעלות סידן DHP

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (1)** | קונג'ופרי · Conjupri 2.5, 5 |
| **נימוק / הערה** | ללא דרישת מעבדה; פחות בצקת |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **מדידת ל"ד מתועדת** | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | **ל"ד ביעד** | ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | **גיל 80+**<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה? | בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 4 | **רכישות** | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 5 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | **בדיקות שנתיות** | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן. | זימון |
| 7 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | **אין התווית נגד** | מינון שנקבע בגלל היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | אין בדיקה ייעודית; הבדיקות השנתיות הכלליות |
| **מצבים שמוציאים מהפרוטוקול** | מינון שנקבע בגלל היריון |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | בצקת ברגליים ← הפחתת מינון או מעבר ללרקנידיפין; עיבוי חניכיים ← הפסקה |
| **מקור** | פרק 8 עמ' 61, 73; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.12 **לרקנידיפין** · Lercanidipine לפי הנחיה

חוסם תעלות סידן DHP

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (3)** | וזודיפ · Vasodip 10 \| לרקפרס · Lercapress 10, 20 \| וזודיפ 20 · Vasodip 20 (לאימות מול מאגר משרד הבריאות) |
| **נימוק / הערה** | ללא דרישת מעבדה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **מדידת ל"ד מתועדת** | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | **ל"ד ביעד** | ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | **גיל 80+**<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה? | בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 4 | **רכישות** | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 5 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | **בדיקות שנתיות** | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן. | זימון |
| 7 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | **אין התווית נגד** | מינון שנקבע בגלל היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | אין בדיקה ייעודית; הבדיקות השנתיות הכלליות |
| **מצבים שמוציאים מהפרוטוקול** | מינון שנקבע בגלל היריון |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | בצקת ברגליים ← הפחתת מינון; עיבוי חניכיים ← הפסקה |
| **מקור** | פרק 8 עמ' 71, 73 |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.13 **ניפדיפין** · Nifedipine

לפי הנחיה, בתנאים

חוסם תעלות סידן DHP

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (2)** | ניפדילונג · Nifedilong 30, 60 \| טנסיפין · Tensipine MR (לא רשום; יבוא תקנה 29) |
| **נימוק / הערה** | רק אם לא נרשם בהקשר של היריון |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **מדידת ל"ד מתועדת** | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | **ל"ד ביעד** | ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | **גיל 80+**<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה? | בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 4 | **רכישות** | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 5 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | **בדיקות שנתיות** | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן. | זימון |
| 7 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | **אין התווית נגד** | מינון שנקבע בגלל היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | אין בדיקה ייעודית; הבדיקות השנתיות הכלליות |
| **מצבים שמוציאים מהפרוטוקול** | מינון שנקבע בגלל היריון |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | בצקת ברגליים ← הפחתת מינון או מעבר ללרקנידיפין; עיבוי חניכיים ← הפסקה |
| **מקור** | פרק 8 עמ' 73; פרק 26 עמ' 251; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.14 ביסופרולול · Bisoprolol

לפי הנחיה, בתנאים

חוסם בטא

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (4) | קונקור · Concor | קרדילוק · Cardiloc | ביסופרולול אינובמד · Bisoprolol Inovamed | ביסופרולול ד.ק.ל. · Bisoprolol D.K.L. |
| נימוק / הערה | תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: יל"ד, אי-ספיקת לב, פרפור, מחלת לב איסכמית. רק עם התוויה מתועדת ודופק מתועד |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מדידת ל"ד מתועדת | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | ל"ד בטווח בטיחות | ל"ד אחרון: סיסטולי 90 ומעלה ומתחת ל-160/100, בלי סחרחורת או עילפון מתועדים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | דופק במנוחה תקין | במדידה האחרונה דופק במנוחה תקין. חריג: מתחת ל-55 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן. | זימון |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | אין התווית נגד | אסתמה; אין התוויה מתועדת (מחלת לב איסכמית, אי ספיקת לב, פרפור). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | דופק במנוחה בכל חידוש; אין בדיקת מעבדה ייעודית |
| ספי החזרה לרופא/ה | דופק במנוחה <55 |
| ערך חמור | דופק במנוחה <50 |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | אסתמה; אין התוויה מתועדת (מחלת לב איסכמית, אי ספיקת לב, פרפור); לא להפסיק בפתאומיות; ערך חמור: דופק במנוחה <50 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | דופק איטי מתמשך או עייפות שפוגעת בתפקוד ← התאמת מינון או הפסקה; החמרה באסתמה ← הפסקה |
| מקור | פרק 8 עמ' 62-63, 70-74; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 1.15 **מטופרולול** · Metoprolol לפי הנחיה, בתנאים

חוסם בטא

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | ניאובלוק · Neobloc \| לופרסור דיויטבס · Lopresor Divitabs (לאימות מול מאגר משרד הבריאות) |
| נימוק / הערה | תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: יל"ד, אי-ספיקת לב, פרפור, מחלת לב איסכמית. רק עם התוויה מתועדת ודופק מתועד |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מדידת ל"ד מתועדת | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | ל"ד בטווח בטיחות | ל"ד אחרון: סיסטולי 90 ומעלה ומתחת ל-160/100, בלי סחרחורת או עילפון מתועדים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | דופק במנוחה תקין | במדידה האחרונה דופק במנוחה תקין. חריג: מתחת ל-55 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן. | זימון |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | אין התווית נגד | אסתמה; אין התוויה מתועדת (מחלת לב איסכמית, אי ספיקת לב, פרפור). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | דופק במנוחה בכל חידוש; אין בדיקת מעבדה ייעודית |
| ספי החזרה לרופא/ה | דופק במנוחה <55 |
| ערך חמור | דופק במנוחה <50 |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | אסתמה; אין התוויה מתועדת (מחלת לב איסכמית, אי ספיקת לב, פרפור); לא להפסיק בפתאומיות; ערך חמור: דופק במנוחה <50 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | דופק איטי מתמשך או עייפות שפוגעת בתפקוד ← התאמת מינון או הפסקה; החמרה באסתמה ← הפסקה |
| מקור | פרק 8 עמ' 74; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 1.16 **אטנולול** · Atenolol לפי הנחיה, בתנאים

חוסם בטא

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | נורמלול · Normalol \| נורמיטן · Normiten |
| נימוק / הערה | רק עם התוויה מתועדת ודופק מתועד; פינוי כלייתי |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מדידת ל"ד מתועדת | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | ל"ד ביעד | ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | גיל 80+<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה? | בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 4 | דופק במנוחה תקין | במדידה האחרונה דופק במנוחה תקין. חריג: מתחת ל-55 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן. | זימון |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התארת אינטראקציה | כל התארת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 12 | אין התווית נגד | אסתמה; אין התוויה מתועדת (מחלת לב איסכמית, אי ספיקת לב, פרפור). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | דופק במנוחה בכל חידוש; אין בדיקת מעבדה ייעודית |
| ספי החזרה לרופא/ה | דופק במנוחה <55 |
| ערך חמור | דופק במנוחה <50 |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | אסתמה; אין התוויה מתועדת (מחלת לב איסכמית, אי ספיקת לב, פרפור); לא להפסיק בפתאומיות; ערך חמור: דופק במנוחה <50 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | דופק איטי מתמשך או עייפות שפוגעת בתפקוד ← התאמת מינון או הפסקה; החמרה באסתמה ← הפסקה |
| מקור | פרק 8 עמ' 74; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 1.17 **קרבדילול** · Carvedilol לפי הנחיה, בתנאים

חוסם בטא + אלפא

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (2)** | קרבדקסון · Carvedexxon \| קרוודילול טבע · Carvedilol Teva |
| **נימוק / הערה** | תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: יל"ד, אי-ספיקת לב, מחלת לב איסכמית. בדרך כלל באי ספיקת לב; רק אם הרופא קבע טיפול יציב |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מדידת ל"ד מתועדת | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | ל"ד בטווח בטיחות | ל"ד אחרון: סיסטולי 90 ומעלה ומתחת ל-160/100, בלי סחרחורת או עילפון מתועדים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | דופק במנוחה תקין | במדידה האחרונה דופק במנוחה תקין. חריג: מתחת ל-55 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן. | זימון |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | אין התווית נגד | אסתמה; אין התוויה מתועדת (מחלת לב איסכמית, אי ספיקת לב, פרפור). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | דופק במנוחה בכל חידוש; אין בדיקת מעבדה ייעודית |
| **ספי החזרה לרופא/ה** | דופק במנוחה <55 |
| **ערך חמור** | דופק במנוחה <50 |
| **מצבים שמוציאים מהפרוטוקול** | אסתמה; אין התוויה מתועדת (מחלת לב איסכמית, אי ספיקת לב, פרפור); לא להפסיק בפתאומיות; ערך חמור: דופק במנוחה <50 |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | דופק איטי מתמשך או עייפות שפוגעת בתפקוד ← התאמת מינון או הפסקה; החמרה באסתמה ← הפסקה |
| **מקור** | פרק 8 עמ' 74; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

☐ אושר ☐ לתיקון הערות: _____

## 1.18 פרופרנולול · Propranolol

לפי הנחיה, בתנאים

חוסם בטא

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | פרולול · Prolol 10, 40 \| בטא-פרוגרן · Beta-Programe (לא רשום; יבוא תקנה 29) \| סיריפרלול 5 מ"ג/ 5 מ"ל תמיסה לבליעה · Syripralol |
| נימוק / הערה | תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: יל"ד, רעד, מניעת מיגרנה, דליות ושט. רק טיפול כרוני קבוע. רקע: לא סלקטיבי; לרוב בהתוויות שאינן יל"ד |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מדידת ל"ד מתועדת | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | ל"ד בטווח בטיחות | ל"ד אחרון: סיסטולי 90 ומעלה ומתחת ל-160/100, בלי סחרחורת או עילפון מתועדים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | דופק במנוחה תקין | במדידה האחרונה דופק במנוחה תקין. חריג: מתחת ל-55 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן. | זימון |
| 7 | טיפול כרוני | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע. | |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 12 | אין התווית נגד | אסתמה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | דופק במנוחה בכל חידוש; אין בדיקת מעבדה ייעודית |
| ספי החזרה לרופא/ה | דופק במנוחה <55 |
| ערך חמור | דופק במנוחה <50 |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | אסתמה; לא להפסיק בפתאומיות; ערך חמור: דופק במנוחה <50 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | דופק איטי מתמשך או עייפות שפוגעת בתפקוד ← התאמת מינון או הפסקה; החמרה באסתמה ← הפסקה |
| מקור | פרק 8 עמ' 74; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.19 **לבטלול** · Labetalol · לפי הנחיה, בתנאים

חוסם בטא + אלפא

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (1)** | טרנדייט · Trandate 100, 200 |
| **נימוק / הערה** | רק טיפול כרוני קבוע. רקע: שימוש עיקרי בהיריון |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מדידת ל"ד מתועדת | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | ל"ד ביעד | ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | גיל 80+<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה? | בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 4 | דופק במנוחה תקין | במדידה האחרונה דופק במנוחה תקין. חריג: מתחת ל-55 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן. | זימון |
| 8 | טיפול כרוני | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע. | |
| 9 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 10 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 11 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 12 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 13 | אין התווית נגד | אסתמה; היריון ← לרופא (לפי כללי ההחזרה). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | דופק במנוחה בכל חידוש; אין בדיקת מעבדה ייעודית |
| **ספי החזרה לרופא/ה** | דופק במנוחה <55 |
| **ערך חמור** | דופק במנוחה <50 |
| **מצבים שמוציאים מהפרוטוקול** | אסתמה; היריון ← לרופא (לפי כללי ההחזרה); לא להפסיק בפתאומיות; ערך חמור: דופק במנוחה <50 |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | דופק איטי מתמשך או עייפות שפוגעת בתפקוד ← התאמת מינון או הפסקה; החמרה באסתמה ← הפסקה |
| **מקור** | פרק 8 עמ' 74; פרק 26 עמ' 251; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.20 ורפמיל · Verapamil לפי הנחיה, בתנאים

חוסם תעלות סידן non-DHP

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | קורדמיל · Cordamil 40, 80 \| ורפרס · Verapress 240 SR |
| נימוק / הערה | רק טיפול כרוני קבוע. רקע: אינטראקציות רבות; בדרך כלל בהתוויה לבבית |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מדידת ל"ד מתועדת | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | ל"ד ביעד | ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | גיל 80+<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה? | בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 4 | דופק במנוחה תקין | במדידה האחרונה דופק במנוחה תקין. חריג: מתחת ל-55 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן. | זימון |
| 8 | טיפול כרוני | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע. | |
| 9 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 10 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 11 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 12 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | דופק במנוחה בכל חידוש |
| ספי החזרה לרופא/ה | דופק במנוחה <55 |
| ערך חמור | דופק במנוחה <50 |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | ערך חמור: דופק במנוחה <50 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | דופק איטי ← לרופא |
| מקור | פרק 8 עמ' 62, 65, 75; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.21 **דילטיאזם** · Diltiazem לפי הנחיה, בתנאים

חוסם תעלות סידן non-DHP

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (2)** | דילאטם · Dilatam 120 SR \| אדיזם · Adizem CD |
| **נימוק / הערה** | רק טיפול כרוני קבוע. רקע: אינטראקציות רבות; בדרך כלל בהתוויה לבבית |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מדידת ל"ד מתועדת | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | ל"ד ביעד | ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | גיל 80+<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה? | בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 4 | דופק במנוחה תקין | במדידה האחרונה דופק במנוחה תקין. חריג: מתחת ל-55 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן. | זימון |
| 8 | טיפול כרוני | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע. | |
| 9 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 10 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 11 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 12 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | דופק במנוחה בכל חידוש |
| **ספי החזרה לרופא/ה** | דופק במנוחה <55 |
| **ערך חמור** | דופק במנוחה <50 |
| **מצבים שמוציאים מהפרוטוקול** | ערך חמור: דופק במנוחה <50 |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | דופק איטי ← לרופא |
| **מקור** | פרק 8 עמ' 62, 75; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.22 ספירונולקטון · Spironolactone לפי הנחיה, בתנאים

חוסם קולטן מינרלוקורטיקואידי

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | אלדקטון · Aldactone 25 \| אלדקטון 100 · Aldactone 100 (לאימות מול מאגר משרד הבריאות) \| ספירונולקטון טבע · Spironolactone Teva |
| נימוק / הערה | תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: יל"ד, אי-ספיקת לב, בצקות, היפרקלמיה נמוכה/אלדוסטרון. רק טיפול כרוני קבוע. רקע: קו רביעי ביל"ד עמיד; סיכון היפרקלמיה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מדידת ל"ד מתועדת | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | ל"ד בטווח בטיחות | ל"ד אחרון: סיסטולי 90 ומעלה ומתחת ל-160/100, בלי סחרחורת או עילפון מתועדים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן. | זימון |
| 6 | בדיקות אחרי שינוי<br>שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם? | אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן תוך 4 שבועות מהשינוי. | שאלה |
| 7 | אשלגן (K) תקין | בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חמור: K ≥5.0 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 8 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם או eGFR ≤45 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים | |
| 9 | טיפול כרוני | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע. | |
| 10 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 11 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 12 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 13 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 14 | אין התווית נגד | היריון; דרוספירנון במקביל. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | K וקריאטינין (תדירות בטיפול כרוני: לא מופיע בהנחיות) |
| ספי החזרה לרופא/ה | קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם; eGFR ≤45 |
| ערך חמור | K ≥5.0; eGFR <30 |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון; דרוספירנון במקביל; ערך חמור: K ≥5.0; eGFR <30 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | הגדלת שד כואבת, הפרעה בזקפה ← מעבר לאפלרנון |
| מקור | SPS Medicines Monitoring (NHS) · SPS Medicines Monitoring: פרק 8 עמ' 63, 73; פרק 9 עמ' 83; מעקב |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.23 אפלרנון · Eplerenone לפי הנחיה, בתנאים

חוסם קולטן מינרלוקורטיקואידי

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | אינספרה · Inspra 25, 50 |
| נימוק / הערה | תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: אי-ספיקת לב, יל"ד. רק טיפול כרוני קבוע. רקע: קו רביעי ביל"ד עמיד; סיכון היפרקלמיה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מדידת ל"ד מתועדת | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | ל"ד בטווח בטיחות | ל"ד אחרון: סיסטולי 90 ומעלה ומתחת ל-160/100, בלי סחרחורת או עילפון מתועדים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן. | זימון |
| 6 | בדיקות אחרי שינוי<br>שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם? | אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן תוך 4 שבועות מהשינוי. | שאלה |
| 7 | אשלגן (K) תקין | בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים | |
| 8 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם או eGFR ≤45 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים | |
| 9 | טיפול כרוני | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע. | |
| 10 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 11 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 12 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 13 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 14 | אין התווית נגד | היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | K וקריאטינין (תדירות בטיפול כרוני: לא מופיע בהנחיות) |
| ספי החזרה לרופא/ה | K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם; eGFR ≤45 |
| ערך חמור | K ≥5.5; eGFR <30 |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון; ערך חמור: K ≥5.5; eGFR <30 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | תסמיני היפרקלמיה (חולשה, דפיקות לב) ← לרופא |
| מקור | פרק 8 עמ' 63, 73; פרק 9 עמ' 83; מעקב: SPS Medicines Monitoring · SPS Medicines Monitoring (NHS) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.24 פינרנון · Finerenone לפי הנחיה, בתנאים

MRA לא-סטרואידלי

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | קרנדיאה · Kerendia 10, 20 |
| נימוק / הערה | תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: מחלת כליות סוכרתית, אי-ספיקת לב. רק טיפול כרוני קבוע. רקע: אין התוויה ליל"ד; ניתן ב-CKD עם סוכרת |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מדידת ל"ד מתועדת | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | ל"ד בטווח בטיחות | ל"ד אחרון: סיסטולי 90 ומעלה ומתחת ל-160/100, בלי סחרחורת או עילפון מתועדים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן. | זימון |
| 6 | בדיקות אחרי שינוי<br>שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם? | אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן תוך 4 שבועות מהשינוי. | שאלה |
| 7 | אשלגן (K) תקין | בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים | |
| 8 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התוויות נגד |
| 9 | טיפול כרוני | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע. | |
| 10 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 11 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 12 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 13 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 14 | אין התווית נגד | לחדש רק כהמשך טיפול קיים (התוויה: CKD עם סוכרת). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התוויות נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | K וקריאטינין (תדירות בטיפול כרוני: לא מופיע בהנחיות) |
| ספי החזרה לרופא/ה | K מחוץ לטווח המעבדה |
| ערך חמור | K ≥5.5; eGFR <30 |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | לחדש רק כהמשך טיפול קיים (התוויה: CKD עם סוכרת); ערך חמור: K ≥5.5; eGFR <30 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | תסמיני היפרקלמיה ← לרופא |
| מקור | פרק 8 עמ' 68; פרק 13 עמ' 143; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.25 פורוסמיד · Furosemide

לפי הנחיה, בתנאים

משתן לולאה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | פוזיד · Fusid \| פורוסמיד אינובמד · Furosemide Inovamed |
| נימוק / הערה | תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: בצקות, אי-ספיקת לב, מחלת כליות, יל"ד. רק טיפול כרוני קבוע. רקע: התוויות מורכבות (eGFR <30, אי ספיקת לב) בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מדידת ל"ד מתועדת | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | ל"ד בטווח בטיחות | ל"ד אחרון: סיסטולי 90 ומעלה ומתחת ל-160/100, בלי סחרחורת או עילפון מתועדים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן. | זימון |
| 6 | בדיקות אחרי שינוי<br>שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם? | אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות אשלגן, נתרן תוך 4 שבועות מהשינוי. | שאלה |
| 7 | אשלגן (K) תקין | בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה או K מתחת ל-3 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים | |
| 8 | נתרן (Na) תקין | בבדיקה האחרונה נתרן (Na) תקין. חריג: Na מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 9 | טיפול כרוני | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע. | |
| 10 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 11 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 12 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 13 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 14 | אלקטרוליטים וקריאטינין | מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | תפקודי כליה ואלקטרוליטים (תדירות: לא מופיע בהנחיות) |
| ספי החזרה לרופא/ה | Na או K מחוץ לטווח המעבדה; K מתחת ל-3 |
| ערך חמור | K ≥5.5 |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | לא להפסיק בפתאומיות (אצירת נוזלים); ערך חמור: K ≥5.5 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | ירידה במשקל, סחרחורת, התייבשות ← לרופא |
| מקור | SPS Medicines Monitoring (NHS) · SPS Medicines Monitoring: פרק 8 עמ' 67, 73; מעקב |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.26 דוקסזוסין · Doxazosin לפי הנחיה, בתנאים

חוסם אלפא

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | קדקס · Cadex 1, 2, 4 |
| נימוק / הערה | רק טיפול כרוני קבוע. רקע: סיכון סחרחורת בעמידה ונפילות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מדידת ל"ד מתועדת | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | ל"ד ביעד | ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | גיל 80+<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה? | בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן. | זימון |
| 7 | טיפול כרוני | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע. | |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 12 | אין התווית נגד | שברירויות או נפילות. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ל"ד בעמידה בקשישים |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | שברירויות או נפילות |
| תלונות בפנייה או ברשומה | סחרחורת בעמידה, נפילה ← לרופא |
| מקור | פרק 8 עמ' 63, 75; פרק 11 עמ' 92; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.27 קלונידין · Clonidine לפי הנחיה, בתנאים

אגוניסט אלפא מרכזי

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | נורמופרסאן · Normopresan \| קלוניריט · Clonnirit |
| נימוק / הערה | רק טיפול כרוני קבוע. רקע: קו מתקדם; סיכון בהפסקה פתאומית |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מדידת ל"ד מתועדת | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | ל"ד ביעד | ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | גיל 80+<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה? | בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן. | זימון |
| 7 | טיפול כרוני | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע. | |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | לא מופיע בהנחיות |
| ספי החזרה לרופא/ה | לא מופיע בהנחיות |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | לא להפסיק בפתאומיות |
| תלונות בפנייה או ברשומה | הפסקה או החמצת מנות ← דחוף - סיכון להתקף היפרטנסיבי |
| מקור | פרק 8 עמ' 63, 67, 75; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.28 **מתילדופה** · Methyldopa לפי הנחיה, בתנאים

אגוניסט אלפא מרכזי

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (1)** | אלדומין · Aldomin (לא רשום; יבוא תקנה 29) |
| **נימוק / הערה** | רק טיפול כרוני קבוע. רקע: בעיקר בהיריון בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **מדידת ל"ד מתועדת** | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | **ל"ד ביעד** | ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | **גיל 80+**<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה? | בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 4 | **רכישות** | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 5 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | **בדיקות שנתיות** | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן. | זימון |
| 7 | **טיפול כרוני** | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע. | |
| 8 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 12 | **אין התווית נגד** | היריון ← לרופא (לפי כללי ההחזרה). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 13 | **ספירת דם** | ספירת דם מהשנה האחרונה (אנמיה המוליטית). אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | לא מופיע בהנחיות |
| **ספי החזרה לרופא/ה** | לא מופיע בהנחיות |
| **מצבים שמוציאים מהפרוטוקול** | היריון ← לרופא (לפי כללי ההחזרה) |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | הפרעה בתפקודי כבד ← לרופא |
| **מקור** | פרק 8 עמ' 75; פרק 26; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.29 מינוקסידיל · Minoxidil

לפי הנחיה, בתנאים

מרחיב כלי דם ישיר

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | מינוקסידיל · Minoxidil (פומי) (לא רשום; יבוא תקנה 29) |
| נימוק / הערה | רק טיפול כרוני קבוע. רקע: קו אחרון |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מדידת ל"ד מתועדת | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | ל"ד ביעד | ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | גיל 80+<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה? | בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן. | זימון |
| 7 | טיפול כרוני | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע. | |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 12 | אין התווית נגד | אין במקביל חוסם בטא ומשתן לולאה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | לא מופיע בהנחיות |
| ספי החזרה לרופא/ה | לא מופיע בהנחיות |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | אין במקביל חוסם בטא ומשתן לולאה |
| תלונות בפנייה או ברשומה | דופק מהיר, בצקות, שיעור יתר ← לרופא |
| מקור | פרק 8 עמ' 75; פרק 9 עמ' 84; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.30 **הידרלזין** · Hydralazine לפי הנחיה, בתנאים

מרחיב כלי דם ישיר

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | הידרלזין · Hydralazine (לא רשום; יבוא תקנה 29) |
| נימוק / הערה | רק טיפול כרוני קבוע. רקע: קו אחרון |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מדידת ל"ד מתועדת | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | ל"ד ביעד | ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | גיל 80+<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה? | בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן. | זימון |
| 7 | טיפול כרוני | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע. | |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | לא מופיע בהנחיות |
| ספי החזרה לרופא/ה | לא מופיע בהנחיות |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | - |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאבי מפרקים, פריחה (תסמינים דמויי לופוס) ← לרופא |
| מקור | פרק 8 עמ' 75; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.31 אמילוריד + הידרוכלורותיאזיד · Amiloride + HCTZ לפי הנחיה, בתנאים

משתן שומר אשלגן + תיאזיד

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | קלוריל · Kaluril |
| נימוק / הערה | רק טיפול כרוני קבוע. רקע: סיכון היפרקלמיה בשילוב עם ACEi/ARB בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מדידת ל"ד מתועדת | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | ל"ד ביעד | ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | גיל 80+<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה? | בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן, סידן, חומצה אורית. | זימון |
| 7 | בדיקות אחרי שינוי<br>שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם? | אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן, נתרן תוך 4 שבועות מהשינוי. | שאלה |
| 8 | אשלגן (K) תקין | בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים | |
| 9 | נתרן (Na) תקין | בבדיקה האחרונה נתרן (Na) תקין. חריג: Na מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 10 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים | |
| 11 | טיפול כרוני | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע. | |
| 12 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 13 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 14 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 15 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 16 | אין התווית נגד | גאוט פעיל ללא אלופורינול/פבוקסוסטט; eGFR <30. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 17 | אלקטרוליטים בסוכרת או בפגיעה כלייתית | בסוכרת או קריאטינין מעל 1.5: אלקטרוליטים וקריאטינין מ-3 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | Na, K, קריאטינין תוך 4 שבועות מהתחלה (בייחוד נשים מעל 65); שנתי: Na, K, Ca, חומצה אורית, קריאטינין |

| | |
|---|---|
| ספי החזרה לרופא/ה | Na מחוץ לטווח המעבדה; K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם |
| ערך חמור | K ≥5.5; eGFR <30 |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | גאוט פעיל ללא אלופורינול/פבוקסוסטט; eGFR <30; ערך חמור: K ≥5.5; eGFR <30 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | התקף גאוט ← הפסקה אם אין טיפול באלופורינול/פבוקסוסטט; חולשה או בלבול (חשד להיפונתרמיה) ← בדיקת Na; היפונתרמיה ← הפסקה; סידן גבוה בבדיקה ← בירור ומעבר לפורוסמיד |
| מקור | פרק 8 עמ' 76; פרק 9 עמ' 83-84; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.32 סקוביטריל/ולסרטן · Sacubitril/Valsartan

לפי הנחיה, בתנאים

ARNI

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | אנטרסטו · Entresto \| סקטור · Sector |
| נימוק / הערה | תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: אי-ספיקת לב. רק טיפול כרוני קבוע. רקע: התוויה: אי ספיקת לב, לא יל"ד בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מדידת ל"ד מתועדת | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | ל"ד בטווח בטיחות | ל"ד אחרון: סיסטולי 90 ומעלה ומתחת ל-160/100, בלי סחרחורת או עילפון מתועדים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן. | זימון |
| 6 | בדיקות אחרי שינוי<br>שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם? | אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן, נתרן תוך 4 שבועות מהשינוי. | שאלה |
| 7 | אשלגן (K) תקין | בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים | |
| 8 | נתרן (Na) תקין | בבדיקה האחרונה נתרן (Na) תקין. חריג: Na מתחת ל-132 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 9 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים | |
| 10 | טיפול כרוני | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע. | |
| 11 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 12 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 13 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 14 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 15 | אין התווית נגד | לחדש רק כהמשך טיפול קיים (התוויה: אי ספיקת לב); היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 16 | אי ספיקת לב: בדיקות כל 3–6 חודשים | באי ספיקת לב: אשלגן וקריאטינין מ-6 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | קריאטינין, K, Na תוך 4 שבועות מכל שינוי; שנתי: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, אלבומין/קריאטינין בשתן |
| ספי החזרה לרופא/ה | K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם; Na מתחת ל-132 |
| ערך חמור | K ≥5.5; eGFR <30 |

| | |
|---|---|
| **מצבים שמוציאים מהפרוטוקול** | לחדש רק כהמשך טיפול קיים (התוויה: אי ספיקת לב); היריון; ערך חמור: K ≥5.5; eGFR <30 |
| **מקור** | פרק 8 עמ' 69; מעקב: SPS Medicines Monitoring · SPS Medicines Monitoring (NHS) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.33 רמיפריל + הידרוכלורותיאזיד · Ramipril + HCTZ לפי הנחיה, בתנאים

משולב: ACEi + תיאזיד

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | טריטייס קומפ · Tritace Comp \| רמיפריל פלוס · Ramipril Plus (לאימות מול מאגר משרד הבריאות) |
| נימוק / הערה | כל רכיב לפי התנאים שלו בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מדידת ל"ד מתועדת | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | ל"ד ביעד | ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | גיל 80+<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה? | בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן. | זימון |
| 7 | בדיקות אחרי שינוי<br>שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם? | אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן, נתרן תוך 4 שבועות מהשינוי. | שאלה |
| 8 | אשלגן (K) תקין | בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה או K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים | |
| 9 | נתרן (Na) תקין | בבדיקה האחרונה נתרן (Na) תקין. חריג: Na מחוץ לטווח המעבדה או Na מתחת ל-132 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 10 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים | |
| 11 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 12 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 13 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 14 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 15 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; גאוט פעיל ללא אלופורינול/פבוקסוסטט; eGFR <30; סידן גבוה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 16 | אי ספיקת לב: בדיקות כל 3–6 חודשים | באי ספיקת לב: אשלגן וקריאטינין מ-6 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | קריאטינין, K, Na תוך 4 שבועות מכל שינוי; שנתי: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, אלבומין/קריאטינין בשתן |

| | |
|---|---|
| **ספי החזרה לרופא/ה** | K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם; Na מחוץ לטווח המעבדה; K מחוץ לטווח המעבדה; Na מתחת ל-132 |
| **ערך חמור** | K ≥5.5; eGFR <30 |
| **מצבים שמוציאים מהפרוטוקול** | היריון או תכנון היריון; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; גאוט פעיל ללא אלופורינול/פבוקסוסטט; eGFR <30; סידן גבוה; ערך חמור: K ≥5.5; eGFR <30 |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | שיעול יבש ← הפסקה ומעבר ל-ARB; התקף גאוט ← הפסקה אם אין טיפול באלופורינול/פבוקסוסטט; חולשה או בלבול (חשד להיפונתרמיה) ← בדיקת Na; היפונתרמיה ← הפסקה; סידן גבוה בבדיקה ← בירור ומעבר לפורוסמיד |
| **מקור** | פרק 8 עמ' 76; מעקב: SPS Medicines Monitoring · SPS Medicines Monitoring (NHS) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.34 סילזפריל + הידרוכלורותיאזיד · Cilazapril + HCTZ לפי הנחיה, בתנאים

משולב: ACEi + תיאזיד

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | סילריל פלוס · Cilaril Plus |
| נימוק / הערה | כל רכיב לפי התנאים שלו בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מדידת ל"ד מתועדת | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | ל"ד ביעד | ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | גיל 80+<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה? | בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן. | זימון |
| 7 | בדיקות אחרי שינוי<br>שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם? | אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן, נתרן תוך 4 שבועות מהשינוי. | שאלה |
| 8 | אשלגן (K) תקין | בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה או K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים | |
| 9 | נתרן (Na) תקין | בבדיקה האחרונה נתרן (Na) תקין. חריג: Na מחוץ לטווח המעבדה או Na מתחת ל-132 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 10 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים | |
| 11 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 12 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 13 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 14 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 15 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; גאוט פעיל ללא אלופורינול/פבוקסוסטט; eGFR <30; סידן גבוה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 16 | אי ספיקת לב: בדיקות כל 3–6 חודשים | באי ספיקת לב: אשלגן וקריאטינין מ-6 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | קריאטינין, K, Na תוך 4 שבועות מכל שינוי; שנתי: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, אלבומין/קריאטינין בשתן |

| | |
|---|---|
| **ספי החזרה לרופא/ה** | K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם; Na מחוץ לטווח המעבדה; K מחוץ לטווח המעבדה; Na מתחת ל-132 |
| **ערך חמור** | K ≥5.5; eGFR <30 |
| **מצבים שמוציאים מהפרוטוקול** | היריון או תכנון היריון; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; גאוט פעיל ללא אלופורינול/פבוקסוסטט; eGFR <30; סידן גבוה; ערך חמור: K ≥5.5; eGFR <30 |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | שיעול יבש ← הפסקה ומעבר ל-ARB; התקף גאוט ← הפסקה אם אין טיפול באלופורינול/פבוקסוסטט; חולשה או בלבול (חשד להיפונתרמיה) ← בדיקת Na; היפונתרמיה ← הפסקה; סידן גבוה בבדיקה ← בירור ומעבר לפורוסמיד |
| **מקור** | פרק 8 עמ' 76; מעקב: SPS Medicines Monitoring · SPS Medicines Monitoring (NHS) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.35 לוסרטן + הידרוכלורותיאזיד · Losartan + HCTZ לפי הנחיה, בתנאים

משולב: ARB + תיאזיד

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (4) | אוקסאאר פלוס · Ocsaar Plus | לוטן פלוס · Lotan Plus | לוסרטה פלוס · Losarta Plus | לוסרדקס פלוס · Losardex Plus |
| נימוק / הערה | כל רכיב לפי התנאים שלו בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מדידת ל"ד מתועדת | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | ל"ד ביעד | ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | גיל 80+<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה? | בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן. | זימון |
| 7 | בדיקות אחרי שינוי<br>שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם? | אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן, נתרן תוך 4 שבועות מהשינוי. | שאלה |
| 8 | אשלגן (K) תקין | בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה או K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים | |
| 9 | נתרן (Na) תקין | בבדיקה האחרונה נתרן (Na) תקין. חריג: Na מחוץ לטווח המעבדה או Na מתחת ל-132 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 10 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים | |
| 11 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 OP = 2 אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 12 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 13 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 14 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 15 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; גאוט פעיל ללא אלופורינול/פבוקסוסטט; eGFR <30; סידן גבוה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 16 | אי ספיקת לב: בדיקות כל 3–6 חודשים | באי ספיקת לב: אשלגן וקריאטינין מ-6 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | קריאטינין, K, Na תוך 4 שבועות מכל שינוי; שנתי: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, אלבומין/קריאטינין בשתן |

| | |
|---|---|
| **ספי החזרה לרופא/ה** | K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם; Na מחוץ לטווח המעבדה; K מחוץ לטווח המעבדה; Na מתחת ל-132 |
| **ערך חמור** | K ≥5.5; eGFR <30 |
| **מצבים שמוציאים מהפרוטוקול** | היריון או תכנון היריון; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; גאוט פעיל ללא אלופורינול/פבוקסוסטט; eGFR <30; סידן גבוה; ערך חמור: K ≥5.5; eGFR <30 |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | התקף גאוט ← הפסקה אם אין טיפול באלופורינול/פבוקסוסטט; חולשה או בלבול (חשד להיפונתרמיה) ← בדיקת Na; היפונתרמיה ← הפסקה; סידן גבוה בבדיקה ← בירור ומעבר לפורוסמיד |
| **מקור** | פרק 8 עמ' 76; מעקב: SPS Medicines Monitoring · SPS Medicines Monitoring (NHS) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.36 קנדסרטן + הידרוכלורותיאזיד · Candesartan + HCTZ לפי הנחיה, בתנאים

משולב: ARB + תיאזיד

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | אטקנד פלוס · Atacand Plus \| קנדור פלוס · Candor Plus |
| נימוק / הערה | כל רכיב לפי התנאים שלו בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מדידת ל"ד מתועדת | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | ל"ד ביעד | ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | גיל 80+<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה? | בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן. | זימון |
| 7 | בדיקות אחרי שינוי<br>שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם? | אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן, נתרן תוך 4 שבועות מהשינוי. | שאלה |
| 8 | אשלגן (K) תקין | בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה או K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים | |
| 9 | נתרן (Na) תקין | בבדיקה האחרונה נתרן (Na) תקין. חריג: Na מחוץ לטווח המעבדה או Na מתחת ל-132 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 10 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים | |
| 11 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 12 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 13 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 14 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 15 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; גאוט פעיל ללא אלופורינול/פבוקסוסטט; eGFR <30; סידן גבוה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 16 | אי ספיקת לב: בדיקות כל 3–6 חודשים | באי ספיקת לב: אשלגן וקריאטינין מ-6 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | קריאטינין, K, Na תוך 4 שבועות מכל שינוי; שנתי: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, אלבומין/קריאטינין בשתן |

| | |
|---|---|
| **ספי החזרה לרופא/ה** | K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם; Na מחוץ לטווח המעבדה; K מחוץ לטווח המעבדה; Na מתחת ל-132 |
| **ערך חמור** | K ≥5.5; eGFR <30 |
| **מצבים שמוציאים מהפרוטוקול** | היריון או תכנון היריון; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; גאוט פעיל ללא אלופורינול/פבוקסוסטט; eGFR <30; סידן גבוה; ערך חמור: K ≥5.5; eGFR <30 |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | התקף גאוט ← הפסקה אם אין טיפול באלופורינול/פבוקסוסטט; חולשה או בלבול (חשד להיפונתרמיה) ← בדיקת Na; היפונתרמיה ← הפסקה; סידן גבוה בבדיקה ← בירור ומעבר לפורוסמיד |
| **מקור** | פרק 8 עמ' 76; מעקב: SPS Medicines Monitoring · SPS Medicines Monitoring (NHS) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.37 ולסרטן + הידרוכלורותיאזיד · Valsartan + HCTZ

לפי הנחיה, בתנאים

משולב: ARB + תיאזיד

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | קו-דיובאן · Co-Diovan \| וקטור פלוס · Vector Plus |
| נימוק / הערה | כל רכיב לפי התנאים שלו בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מדידת ל"ד מתועדת | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | ל"ד ביעד | ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | גיל 80+<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה? | בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן. | זימון |
| 7 | בדיקות אחרי שינוי<br>שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם? | אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן, נתרן תוך 4 שבועות מהשינוי. | שאלה |
| 8 | אשלגן (K) תקין | בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה או K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים | |
| 9 | נתרן (Na) תקין | בבדיקה האחרונה נתרן (Na) תקין. חריג: Na מחוץ לטווח המעבדה או Na מתחת ל-132 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 10 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים | |
| 11 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 12 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 13 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 14 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 15 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; גאוט פעיל ללא אלופורינול/פבוקסוסטט; eGFR <30; סידן גבוה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 16 | אי ספיקת לב: בדיקות כל 3–6 חודשים | באי ספיקת לב: אשלגן וקריאטינין מ-6 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | קריאטינין, K, Na תוך 4 שבועות מכל שינוי; שנתי: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, אלבומין/קריאטינין בשתן |

| | |
|---|---|
| **ספי החזרה לרופא/ה** | K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם; Na מחוץ לטווח המעבדה; K מחוץ לטווח המעבדה; Na מתחת ל-132 |
| **ערך חמור** | K ≥5.5; eGFR <30 |
| **מצבים שמוציאים מהפרוטוקול** | היריון או תכנון היריון; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; גאוט פעיל ללא אלופורינול/פבוקסוסטט; eGFR <30; סידן גבוה; ערך חמור: K ≥5.5; eGFR <30 |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | התקף גאוט ← הפסקה אם אין טיפול באלופורינול/פבוקסוסטט; חולשה או בלבול (חשד להיפונתרמיה) ← בדיקת Na; היפונתרמיה ← הפסקה; סידן גבוה בבדיקה ← בירור ומעבר לפורוסמיד |
| **מקור** | פרק 8 עמ' 76; מעקב: SPS Medicines Monitoring · SPS Medicines Monitoring (NHS) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.38 אנלפריל + לרקנידיפין · Enalapril + Lercanidipine לפי הנחיה

משולב: ACEi + CCB

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | וזודיפ קומבו · Vasodip Combo \| לרקאנפריל טבע · Lercanapril Teva |
| נימוק / הערה | שילוב מועדף; ניטור כמו ACEi בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מדידת ל"ד מתועדת | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | ל"ד ביעד | ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | גיל 80+<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה? | בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן. | זימון |
| 7 | בדיקות אחרי שינוי<br>שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם? | אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן, נתרן תוך 4 שבועות מהשינוי. | שאלה |
| 8 | אשלגן (K) תקין | בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים | |
| 9 | נתרן (Na) תקין | בבדיקה האחרונה נתרן (Na) תקין. חריג: Na מתחת ל-132 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 10 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים | |
| 11 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 12 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 13 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 14 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 15 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; מינון שנקבע בגלל היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 16 | אי ספיקת לב: בדיקות כל 3–6 חודשים | באי ספיקת לב: אשלגן וקריאטינין מ-6 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | קריאטינין, K, Na תוך 4 שבועות מכל שינוי; שנתי: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, אלבומין/קריאטינין בשתן |
| ספי החזרה לרופא/ה | K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם; Na מתחת ל-132 |

| | |
|---|---|
| **ערך חמור** | K ≥5.5; eGFR <30 |
| **מצבים שמוציאים מהפרוטוקול** | היריון או תכנון היריון; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; מינון שנקבע בגלל היריון; ערך חמור: K ≥5.5; eGFR <30 |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | שיעול יבש ← הפסקה ומעבר ל-ARB; בצקת ברגליים ← הפחתת מינון; עיבוי חניכיים ← הפסקה |
| **מקור** | פרק 8 עמ' 65, 76; מעקב: SPS Medicines Monitoring · SPS Medicines Monitoring (NHS) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.39 ולסרטן + אמלודיפין · Valsartan + Amlodipine לפי הנחיה

משולב: ARB + CCB

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (4) | אקספורג' · Exforge \| דופלקס · Duplex \| אמלוואל · Amloval \| אמלודיפין/ולסרטן דקסל · Amlodipine/Valsartan Dexcel |
| נימוק / הערה | שילוב מועדף; ניטור כמו ARB בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מדידת ל"ד מתועדת | נדרשת מדידת ל"ד מתועדת (במרפאה או ממוצע מדידות ביתיות) מ-6 החודשים האחרונים במטופל/ת חדש/ה או אחרי שינוי טיפול, ומ-12 החודשים האחרונים בשאר. | זימון |
| 2 | ל"ד ביעד | ממוצע ל"ד האחרון צריך להיות עד 130/80 ולא מתחת ל-120/70 (בגיל 80 ומעלה חל הטווח של סעיף גיל 80+). ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | גיל 80+<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 80 ומעלה? | בגיל 80 ומעלה, במקום היעד הכללי: במדידת ל"ד מתועדת מ-12 החודשים האחרונים סיסטולי 130-150 ודיאסטולי 70 ומעלה. ערך מחוץ לטווח ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, גלוקוז/HbA1c, שומנים, אלבומין/קריאטינין בשתן. | זימון |
| 7 | בדיקות אחרי שינוי<br>שאלה: היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון) מאז החידוש הקודם? | אם היה שינוי בטיפול (התחלה או שינוי מינון), בוצעו בדיקות קריאטינין, אשלגן, נתרן תוך 4 שבועות מהשינוי. | שאלה |
| 8 | אשלגן (K) תקין | בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: K ≥5.5 ← לא מחדשים | |
| 9 | נתרן (Na) תקין | בבדיקה האחרונה נתרן (Na) תקין. חריג: Na מתחת ל-132 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 10 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים | |
| 11 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 12 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 13 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 14 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 15 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; מינון שנקבע בגלל היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 16 | אי ספיקת לב: בדיקות כל 3–6 חודשים | באי ספיקת לב: אשלגן וקריאטינין מ-6 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | קריאטינין, K, Na תוך 4 שבועות מכל שינוי; שנתי: תפקודי כליה, אלקטרוליטים, אלבומין/קריאטינין בשתן |
| ספי החזרה לרופא/ה | K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם; Na מתחת ל-132 |

| | |
|---|---|
| ערך חמור | K ≥5.5; eGFR <30 |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון; היצרות דו-צדדית של עורקי הכליה; מינון שנקבע בגלל היריון; ערך חמור: K ≥5.5; eGFR <30 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | בצקת ברגליים ← הפחתת מינון או מעבר ללרקנידיפין; עיבוי חניכיים ← הפסקה |
| מקור | פרק 8 עמ' 65, 76; מעקב: SPS Medicines Monitoring · SPS Medicines Monitoring (NHS) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.40 אטורבסטטין · Atorvastatin לפי הנחיה

שומנים · סטטין

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (4) | ליפיטור · Lipitor \| ליטורבה · Litorva \| טורבה · Torva \| אטורבה-דקס · Atorva-Dex |
| נימוק / הערה | מעקב LDL; ללא בדיקות כבד ושריר שגרתיות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | LDL מתועד | פרופיל שומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | LDL יציב | LDL לא עלה ב-30% או יותר לעומת הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | תפקודי כבד (ALT) תקין | בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חמור: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 6 | CPK (אם נבדק) תקין | בבדיקה האחרונה CPK (אם נבדק) תקין. חמור: CPK מעל פי 5 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון; מחלת כבד פעילה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | פרופיל שומנים כל 6-12 חודשים; ALT ו-CPK רק לפי תסמינים |
| ערך חמור | CPK מעל פי 5 מהגבול העליון; ALT מעל פי 3 מהגבול העליון |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון; מחלת כבד פעילה |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאבי שרירים או חולשה ← לרופא + CPK; שתן כהה עם חולשת שרירים ← דחוף |
| מקור | הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 50-53; מעקב: SPS Medicines Monitoring (NHS) · SPS Medicines Monitoring |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.41 רוזובסטטין · Rosuvastatin לפי הנחיה

שומנים · סטטין

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (7) | קרסטור · Crestor | סטטור · Stator | רוזובסטטין מדו · Rosuvastatin Medo | רוזובסטטין אינובמד · Rosuvastatin Inovamed | רוזובסטטין סנדוז · Rosuvastatin Sandoz | רוזובסטטין טבע · Rosuvastatin Teva | רוסובסטטין ויטאמד · Rosuvastatin Vitamed |
| נימוק / הערה | מעקב LDL |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | LDL מתועד | פרופיל שומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | LDL יציב | LDL לא עלה ב-30% או יותר לעומת הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | תפקודי כבד (ALT) תקין | בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חמור: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התוויות נגד |
| 6 | CPK (אם נבדק) תקין | בבדיקה האחרונה CPK (אם נבדק) תקין. חמור: CPK מעל פי 5 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התוויות נגד |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון; מחלת כבד פעילה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התוויות נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | פרופיל שומנים כל 6-12 חודשים; ALT ו-CPK רק לפי תסמינים |
| ערך חמור | CPK מעל פי 5 מהגבול העליון; ALT מעל פי 3 מהגבול העליון |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון; מחלת כבד פעילה |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאבי שרירים או חולשה ← לרופא + CPK; שתן כהה עם חולשת שרירים ← דחוף |
| מקור | הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 50-53; מעקב: SPS Medicines Monitoring (NHS) · SPS Medicines Monitoring |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.42 **סימבסטטין** · Simvastatin לפי הנחיה

שומנים · סטטין

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (3)** | סימבקור · Simvacor \| סימבקסון · Simvaxon \| סימבסטאטין טבע · Simvastatin Teva |
| **נימוק / הערה** | מעקב LDL |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | LDL מתועד | פרופיל שומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | LDL יציב | LDL לא עלה ב-30% או יותר לעומת הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | תפקודי כבד (ALT) תקין | בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חמור: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התוויית נגד |
| 6 | CPK (אם נבדק) תקין | בבדיקה האחרונה CPK (אם נבדק) תקין. חמור: CPK מעל פי 5 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התוויית נגד |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | אין התוויית נגד | היריון או תכנון היריון; מחלת כבד פעילה. התוויית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התוויית נגד |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | פרופיל שומנים כל 6-12 חודשים; ALT ו-CPK רק לפי תסמינים |
| **ערך חמור** | CPK מעל פי 5 מהגבול העליון; ALT מעל פי 3 מהגבול העליון |
| **מצבים שמוציאים מהפרוטוקול** | היריון או תכנון היריון; מחלת כבד פעילה |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | כאבי שרירים או חולשה ← לרופא + CPK; שתן כהה עם חולשת שרירים ← דחוף |
| **מקור** | הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 50-53; מעקב: SPS Medicines Monitoring (NHS) · SPS Medicines Monitoring |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.43 פרבסטטין · Pravastatin לפי הנחיה

שומנים · סטטין

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | פרבליפ · Pravalip \| פרבה טבע · Prava Teva \| פרבסטאטין טבע · Pravastatin Teva |
| נימוק / הערה | מעקב LDL |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | LDL מתועד | פרופיל שומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | LDL יציב | LDL לא עלה ב-30% או יותר לעומת הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | תפקודי כבד (ALT) תקין | בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חמור: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 6 | CPK (אם נבדק) תקין | בבדיקה האחרונה CPK (אם נבדק) תקין. חמור: CPK מעל פי 5 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון; מחלת כבד פעילה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | פרופיל שומנים כל 6-12 חודשים; ALT ו-CPK רק לפי תסמינים |
| ערך חמור | CPK מעל פי 5 מהגבול העליון; ALT מעל פי 3 מהגבול העליון |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון; מחלת כבד פעילה |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאבי שרירים או חולשה ← לרופא + CPK; שתן כהה עם חולשת שרירים ← דחוף |
| מקור | הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 50-53; מעקב: SPS Medicines Monitoring (NHS) · SPS Medicines Monitoring |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.44 **אזטימיב** · Ezetimibe לפי הנחיה

שומנים · מעכב ספיגת כולסטרול

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (5)** | אזטרול · Ezetrol \| אזקור · Ezecor \| אזטימיב סנדוז · Ezetimibe Sandoz \| אזטימיב תרו · Ezetimibe Taro \| אזטימיב טבע · Ezetimibe Teva |
| **נימוק / הערה** | מעקב LDL |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | LDL מתועד | פרופיל שומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | LDL יציב | LDL לא עלה ב-30% או יותר לעומת הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | פרופיל שומנים כל 6-12 חודשים |
| **מצבים שמוציאים מהפרוטוקול** | היריון או תכנון היריון |
| **מקור** | הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.45 אטורבסטטין + אזטימיב · Atorvastatin + Ezetimibe לפי הנחיה

שומנים · סטטין + אזטימיב

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (4) | אטוזט · Atozet \| אזאטור אס.קיי. · Ezator S.K \| אזהאטורבה · Ezeatorva \| טורז · Torez |
| נימוק / הערה | מעקב LDL |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | LDL מתועד | פרופיל שומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | LDL יציב | LDL לא עלה ב-30% או יותר לעומת הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | תפקודי כבד (ALT) תקין | בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חמור: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התוויית נגד |
| 6 | CPK (אם נבדק) תקין | בבדיקה האחרונה CPK (אם נבדק) תקין. חמור: CPK מעל פי 5 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התוויית נגד |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | אין התוויית נגד | היריון או תכנון היריון; מחלת כבד פעילה. התוויית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התוויית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | פרופיל שומנים כל 6-12 חודשים; ALT ו-CPK רק לפי תסמינים; פרופיל שומנים כל 6-12 חודשים |
| ערך חמור | CPK מעל פי 5 מהגבול העליון; ALT מעל פי 3 מהגבול העליון |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון; מחלת כבד פעילה |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאבי שרירים או חולשה ← לרופא + CPK; שתן כהה עם חולשת שרירים ← דחוף |
| מקור | הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 50-53; הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52; מעקב: SPS Medicines · SPS Medicines Monitoring (NHS) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.46 רוזובסטטין + אזטימיב · Rosuvastatin + Ezetimibe לפי הנחיה

שומנים · סטטין + אזטימיב

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | רוזט טבע · Rozet Teva \| רוסטמיב אס.קיי. · Rosetemib S.K. |
| נימוק / הערה | מעקב LDL |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | LDL מתועד | פרופיל שומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | LDL יציב | LDL לא עלה ב-30% או יותר לעומת הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | תפקודי כבד (ALT) תקין | בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חמור: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התוויות נגד |
| 6 | CPK (אם נבדק) תקין | בבדיקה האחרונה CPK (אם נבדק) תקין. חמור: CPK מעל פי 5 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התוויות נגד |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | אין התוויות נגד | היריון או תכנון היריון; מחלת כבד פעילה. התוויות נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התוויות נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | פרופיל שומנים כל 6-12 חודשים; ALT ו-CPK רק לפי תסמינים; פרופיל שומנים כל 6-12 חודשים |
| ערך חמור | CPK מעל פי 5 מהגבול העליון; ALT מעל פי 3 מהגבול העליון |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון; מחלת כבד פעילה |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאבי שרירים או חולשה ← לרופא + CPK; שתן כהה עם חולשת שרירים ← דחוף |
| מקור | הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 50-53; הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52; מעקב: SPS Medicines · SPS Medicines Monitoring (NHS) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.47 **אבולוקומאב** · Evolocumab לפי הנחיה, בתנאים

שומנים · מעכב PCSK9 (זריקה)

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (1)** | רפאטה · Repatha |
| **נימוק / הערה** | רק אישור סל או שב"ן בתוקף, וטיפול כרוני קבוע. נקבע ע"י רופא/ה; מחודש רק עם אישור מימון בתוקף. מעקב LDL |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | LDL מתועד | פרופיל שומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | LDL יציב | LDL לא עלה ב-30% או יותר לעומת הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | אישור מימון בתוקף | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשיש אישור סל או שב"ן בתוקף, וטיפול כרוני קבוע. אין ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 10 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | פרופיל שומנים כל 6-12 חודשים |
| **מצבים שמוציאים מהפרוטוקול** | היריון או תכנון היריון |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | תגובה מקומית קשה באזור ההזרקה ← לרופא; תסמיני שפעת מתמשכים ← לרופא |
| **מקור** | הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 (פרק מעכבי PCSK9); עמ' 52; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.48 **אלירוקומאב** · Alirocumab לפי הנחיה, בתנאים

שומנים · מעכב PCSK9 (זריקה)

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (1)** | פראלואנט · Praluent |
| **נימוק / הערה** | רק אישור סל או שב"ן בתוקף, וטיפול כרוני קבוע. נקבע ע"י רופא/ה; מחודש רק עם אישור מימון בתוקף. מעקב LDL |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | LDL מתועד | פרופיל שומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | LDL יציב | LDL לא עלה ב-30% או יותר לעומת הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | אישור מימון בתוקף | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשיש אישור סל או שב"ן בתוקף, וטיפול כרוני קבוע. אין ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 10 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | פרופיל שומנים כל 6-12 חודשים |
| **מצבים שמוציאים מהפרוטוקול** | היריון או תכנון היריון |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | תגובה מקומית קשה באזור ההזרקה ← לרופא; תסמיני שפעת מתמשכים ← לרופא |
| **מקור** | הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 (פרק מעכבי PCSK9); עמ' 52; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.49 **אספירין במינון נמוך** · Aspirin (low dose) לפי הנחיה

נוגדי טסיות · נוגד טסיות

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (6)** | אספירין קרדיו · Aspirin Cardio | קרטיה · Cartia | מיקרופירין · Micropirin | גודמד · Godamed | מדיפירין · Medipirin | טבעפירין · Tevapirin |
| **נימוק / הערה** | רק 75-100 מ"ג ליום; ללא נוגד קרישה במקביל |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: ספירת דם. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 4 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 5 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 6 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 7 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 8 | אין התווית נגד | דימום פעיל או דימום משמעותי מאז הביקור האחרון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | ספירת דם שנתית |
| **מצבים שמוציאים מהפרוטוקול** | דימום פעיל או דימום משמעותי מאז הביקור האחרון |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | צואה שחורה או דם בצואה ← דחוף; חבורות או דימומים חריגים ← לרופא |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.50 **קלופידוגרל** · Clopidogrel לפי הנחיה, בתנאים

נוגדי טסיות · נוגד טסיות

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (4) | פלויקס · Plavix \| קלוד · Clood \| קלופידקסל · Clopidexcel \| קלופידוגרל טבע · Clopidogrel Teva |
| נימוק / הערה | רק טיפול כרוני קבוע. רק טיפול כרוני שנקבע לטווח ארוך; טיפול קצוב אחרי צנתור ← רופא |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: ספירת דם. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 4 | טיפול כרוני | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | אין התווית נגד | דימום פעיל או דימום משמעותי מאז הביקור האחרון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ספירת דם שנתית |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | דימום פעיל או דימום משמעותי מאז הביקור האחרון |
| תלונות בפנייה או ברשומה | צואה שחורה או דם בצואה ← דחוף; חבורות או דימומים חריגים ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.51 בזאפיברט · Bezafibrate לפי הנחיה

שומנים · פיברט

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | נורליפ · Norlip \| בזאפיבראט מדומי · Bezafibrate Medomie |
| נימוק / הערה | מעקב כליות וכבד |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | בדיקות מתועדות | קריאטינין/eGFR, ALT ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <60 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <15 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: eGFR <15 ← לא מחדשים | |
| 3 | תפקודי כבד (ALT) תקין | בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | קריאטינין ו-ALT שנתי |
| ספי החזרה לרופא/ה | eGFR <60 (לבדיקת מינון); ALT מעל פי 3 מהגבול העליון |
| ערך חמור | eGFR <15 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאבי שרירים או חולשה ← לרופא + CPK |
| מקור | הנחיות הטיפול בדיסליפידמיה (ישראל, 2020) — שיוך לפי קבוצת התרופות (פיברטים), אושר 9.11.2026 |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.52 **טיקגרלור** · Ticagrelor לפי הנחיה, בתנאים

נוגד טסיות (P2Y12)

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (8)** | בריליינטה · Brilinta | טיקאטה · Ticata | טיקבניר · Ticavenir | טיקגרלור טבע · Ticagrelor Teva | תרו · Ticagrelor Taro | טיקגרלור אס.קיי. · Ticagrelor S.K | טיקגרלור אינובמד · Ticagrelor Inovamed | טיקגרלור פרופארם · Ticagrelor Propharm |
| **נימוק / הערה** | משך הטיפול נקבע ע"י הקרדיולוג/ית (לרוב 12 חודשים אחרי אירוע). אספירין עד 100 מ"ג |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | בתוך משך הטיפול שנקבע | תאריך סיום הטיפול מתועד במכתב הקרדיולוג/ית ועוד לא הגיע. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | אין דימום מתועד | ברשומה או בפנייה אין צואה שחורה, דם בצואה או דימום משמעותי. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | אין נוגד קרישה במקביל | ברשימת התרופות אין נוגד קרישה (קומדין, אליקוויס, קסרלטו, פרדקסה). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 4 | אספירין עד 100 מ"ג | אם יש אספירין: מינון 75-100 מ"ג. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י קרדיולוג/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | דימום ← דחוף; קוצר נשימה חדש ← לרופא |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-(DailyMed) FDA · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.53 פרסוגרל · Prasugrel

לפי הנחיה, בתנאים

נוגד טסיות (P2Y12)

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | פרסוגרל טבע · Prasugrel Teva \| פרסוגרל-תרימה · Prasugrel-Trima |
| נימוק / הערה | אסור אחרי שבץ; גיל 75+ או משקל מתחת ל-60 ק"ג - מינון מופחת |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | בתוך משך הטיפול שנקבע | תאריך סיום הטיפול מתועד במכתב הקרדיולוג/ית ועוד לא הגיע. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | אין דימום מתועד | ברשומה או בפנייה אין צואה שחורה, דם בצואה או דימום משמעותי. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | אין נוגד קרישה במקביל | ברשימת התרופות אין נוגד קרישה (קומדין, אליקוויס, קסרלטו, פרדקסה). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י קרדיולוג/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | אין התווית נגד | שבץ או אירוע מוחי חולף בעבר. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | שבץ או אירוע מוחי חולף בעבר |
| תלונות בפנייה או ברשומה | דימום ← דחוף |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.54 איזוסורביד מונוניטרט · Isosorbide mononitrate לפי הנחיה

ניטרט

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | מונוקורד · Monocord |
| נימוק / הערה | אסור עם מעכבי PDE5 (ויאגרה, סיאליס) |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין החמרה בתעוקה | ברשומה או בפנייה אין כאב בחזה חדש או מחמיר. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 2 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 5 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 6 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 7 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 8 | אין התווית נגד | מעכב PDE5 (סילדנאפיל, טדלפיל). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | מעכב PDE5 (סילדנאפיל, טדלפיל) |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב בחזה במנוחה ← דחוף - מיון; סחרחורת או עילפון ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.55 פלקאיניד · Flecainide

לפי הנחיה, בתנאים

נוגד הפרעות קצב (IC)

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | טמבוקור · Tambocor \| פלקאיניד אמ.בי.איי · Flecainide MBI |
| נימוק / הערה | אסור במחלת לב מבנית או איסכמית. אק"ג שנתי |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אק"ג וקריאטינין מתועדים | אק"ג וקריאטינין/eGFR מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | אק"ג ללא שינוי | QRS לא התרחב ואין הפרעת הולכה חדשה לפי פענוח האק"ג. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <35 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י קרדיולוג/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 OP = 2 אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | אין התווית נגד | מחלת לב איסכמית או אוטם בעבר; אי-ספיקת לב או ירידה בתפקוד החדר השמאלי. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אק"ג שנתי; קריאטינין שנתי |
| ספי החזרה לרופא/ה | eGFR <35 (לבדיקת מינון) |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | מחלת לב איסכמית או אוטם בעבר; אי-ספיקת לב או ירידה בתפקוד החדר השמאלי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | עילפון או דפיקות לב ← דחוף; כאב בחזה או קוצר נשימה ← דחוף |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.56 פרופפנון · Propafenone

לפי הנחיה, בתנאים

נוגד הפרעות קצב (IC)

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | ריתמונורם · Rytmonorm \| פרופקס · Profex |
| נימוק / הערה | אסור במחלת לב מבנית או איסכמית. אק"ג שנתי |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אק"ג וקריאטינין מתועדים | אק"ג וקריאטינין/eGFR מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | אק"ג ללא שינוי | QRS לא התרחב ואין הפרעת הולכה חדשה לפי פענוח האק"ג. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <35 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י קרדיולוג/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | אין התווית נגד | מחלת לב איסכמית או אוטם בעבר; אי-ספיקת לב או ירידה בתפקוד החדר השמאלי. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אק"ג שנתי; קריאטינין שנתי |
| ספי החזרה לרופא/ה | eGFR <35 (לבדיקת מינון) |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | מחלת לב איסכמית או אוטם בעבר; אי-ספיקת לב או ירידה בתפקוד החדר השמאלי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | עילפון או דפיקות לב ← דחוף; כאב בחזה או קוצר נשימה ← דחוף |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.57 דרונדרון · Dronedarone

לפי הנחיה, בתנאים

נוגד הפרעות קצב

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | מולטאק · Multaq \| דרונקור · Droncor |
| נימוק / הערה | אסור באי-ספיקת לב מתקדמת ובפרפור פרוזדורים קבוע. אינטראקציות (דביגטרן, דיגוקסין) בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | בדיקות מתועדות | ALT וקריאטינין/eGFR מ-6 החודשים האחרונים; אק"ג מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה ב-30% ומעלה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים | |
| 3 | תפקודי כבד (ALT) תקין | בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י קרדיולוג/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | אין התווית נגד | אי-ספיקת לב מתקדמת; פרפור פרוזדורים קבוע. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 12 | אק"ג | אק"ג מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 13 | תפקודי כבד ואלקטרוליטים | תפקודי כבד, אשלגן, מגנזיום וקריאטינין מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ALT וקריאטינין כל 6 חודשים; אק"ג שנתי |
| ספי החזרה לרופא/ה | ALT מעל פי 3 מהגבול העליון; קריאטינין עלה ב-30% ומעלה |
| ערך חמור | eGFR <30 |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | אי-ספיקת לב מתקדמת; פרפור פרוזדורים קבוע |
| תלונות בפנייה או ברשומה | קוצר נשימה או בצקות ← דחוף; צהבת או שתן כהה ← דחוף |
| מקור | מעקב: SPS Medicines Monitoring · SPS Medicines Monitoring (NHS) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.58 **אינקליסירן** · Inclisiran לפי הנחיה, בתנאים

שומנים · siRNA נגד PCSK9 (זריקה כל 6 חודשים)

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (1)** | לקוויו · Leqvio |
| **נימוק / הערה** | רק אישור סל או שב"ן בתוקף, וטיפול כרוני קבוע. זריקה במרפאה פעם ב-6 חודשים (אחרי מנת העמסה). מעקב LDL |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | LDL מתועד | פרופיל שומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | LDL יציב | LDL לא עלה ב-30% או יותר לעומת הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | אישור מימון בתוקף | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשיש אישור סל או שב"ן בתוקף, וטיפול כרוני קבוע. אין ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 10 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | פרופיל שומנים כל 6-12 חודשים |
| **מצבים שמוציאים מהפרוטוקול** | היריון או תכנון היריון |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | תגובה מקומית קשה באזור ההזרקה ← לרופא; תסמיני שפעת מתמשכים ← לרופא |
| **מקור** | הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 (פרק מעכבי PCSK9); עמ' 52; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.59 מידודרין · Midodrine לפי הנחיה, בתנאים

יל"ד אורתוסטטי

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | מידודרין מורנינגסייד · Midodrine Morningside |
| נימוק / הערה | יל"ד בשכיבה; לא ליטול לפני שינה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | ל"ד מתועד | מדידת ל"ד מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | ל"ד בשכיבה מתחת ל-160/90 | ל"ד אחרון (בשכיבה או בישיבה) מתחת ל-160/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אין אצירת שתן | ברשומה או בפנייה אין אצירת שתן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ה מומחה/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ל"ד בשכיבה ובעמידה |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב ראש חזק או דפיקות לב בשכיבה ← לרופא; קושי במתן שתן ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.60 פנטוקסיפילין · Pentoxifylline לפי הנחיה

צליעה לסירוגין

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | אוקסופורין · Oxopurin |
| נימוק / הערה | תועלת מוגבלת; זהירות עם נוגדי קרישה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין דימום מתועד | ברשומה או בפנייה אין צואה שחורה, דם בצואה או דימום משמעותי. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 2 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 5 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 6 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 7 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה |
| תלונות בפנייה או ברשומה | דימום ← דחוף |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 1.61 **דיפירידמול** · Dipyridamole לפי הנחיה, בתנאים

נוגד טסיות

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (1)** | קורוסן · Corosan |
| **נימוק / הערה** | לרוב עם אספירין אחרי שבץ |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **אין דימום מתועד** | ברשומה או בפנייה אין צואה שחורה, דם בצואה או דימום משמעותי. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 2 | **אין נוגד קרישה במקביל** | ברשימת התרופות אין נוגד קרישה (קומדין, אליקוויס, קסרלטו, פרדקסה). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | **רכישות** | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | **טיפול כרוני במינון קבוע** | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | אין מעקב מעבדה |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | דימום ← דחוף; כאב בחזה ← דחוף |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.62 תרופות לב במעקב מומחה · Cardiology specialist drugs דגל אדום

קרדיולוגיה - מומחה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (6) | טפמידקס · Tafamidex \| טאפיס · Tafis \| וינדמקס · Vyndamax \| וינדאקל · Vyndaqel \| אטרובי · Attruby \| קמזיוס · Camzyos |
| נימוק / הערה | טפמידיס ומבקמטן נקבעים ע"י קרדיולוג/ית מומחה/ית. הרפואן מכין עם המכתב העדכני, והרופא/ה בודק/ת שוב לפני האישור. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני במינון קבוע שנקבע ע"י מומחה/ית. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | הנחיה עדכנית של הקרדיולוג/ית | מכתב או סיכום של הקרדיולוג/ית מ-12 החודשים האחרונים, עם אותה תרופה ומינון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.63 חומצה במפדואית · Bempedoic acid לפי הנחיה

שומנים · מעכב ACL

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | נקסלטול · Nexletol \| נקסליזט · Nexlizet (עם אזטימיב) |
| נימוק / הערה | מעקב LDL; חומצה אורית עלולה לעלות (שיגדון) |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | LDL מתועד | פרופיל שומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | LDL יציב | LDL לא עלה ב-30% או יותר לעומת הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | פרופיל שומנים כל 6-12 חודשים |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון |
| מקור | הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA · עלון FDA (DailyMed) · (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.64 אומגה 3 / איקוזפנט אתיל · Omega-3 / icosapent ethyl לפי הנחיה

שומנים · אומגה 3 מרשמית

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | וסקפה · Vazkepa \| אומקור · Omacor \| ליפופלוס · Lipoplus |
| נימוק / הערה | מעקב שומנים; איקוזפנט: פרפור ודימום (זהירות עם נוגדי קרישה) |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | LDL מתועד | פרופיל שומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | LDL יציב | LDL לא עלה ב-30% או יותר לעומת הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | פרופיל שומנים כל 6-12 חודשים |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון |
| מקור | הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.65 ציפרופיברט · Ciprofibrate לפי הנחיה

שומנים · פיברט

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | ליפנור · Lipanor |
| נימוק / הערה | מעקב כליות וכבד |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | בדיקות מתועדות | קריאטינין/eGFR, ALT ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <60 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים | |
| 3 | תפקודי כבד (ALT) תקין | בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | קריאטינין ו-ALT שנתי |
| ספי החזרה לרופא/ה | eGFR <60 (לבדיקת מינון); ALT מעל פי 3 מהגבול העליון |
| ערך חמור | eGFR <30 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאבי שרירים או חולשה ← לרופא + CPK |
| מקור | הנחיות הטיפול בדיסליפידמיה (ישראל, 2020) — שיוך לפי קבוצת התרופות (פיברטים), אושר 9.11.2026 |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.66 וריסיגואט · Vericiguat

לפי הנחיה, בתנאים

אי-ספיקת לב · מעורר sGC

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | וורקובו · Verquvo |
| נימוק / הערה | אסור עם ניטרטים ומעכבי PDE5; ל"ד נמוך |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | ל"ד מתועד | מדידת ל"ד מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | סיסטולי 100 ומעלה | ל"ד סיסטולי אחרון 100 ומעלה, בלי סחרחורת או עילפון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י קרדיולוג/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 10 | אין התווית נגד | ניטרטים; מעכב PDE5 (סילדנאפיל, טדלפיל); ריוציגואט; היריון או תכנון היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ל"ד והמוגלובין |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | ניטרטים; מעכב PDE5 (סילדנאפיל, טדלפיל); ריוציגואט; היריון או תכנון היריון |
| תלונות בפנייה או ברשומה | סחרחורת או עילפון ← לרופא; קוצר נשימה מחמיר ← דחוף |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.67 ניטרוגליצרין (תת-לשוני) · Nitroglycerin (sublingual) לפי הנחיה

ניטרט לפי הצורך

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | ניטרולינגואל ספריי · Nitrolingual Spray |
| נימוק / הערה | שימוש תכוף או מחמיר = תעוקה לא יציבה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | שימוש לא תכוף | פחות ממכל אחד בחודשיים לפי הרכישות, ואין החמרה בשימוש. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 4 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 5 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 6 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 7 | אין התווית נגד | מעכב PDE5 (סילדנאפיל, טדלפיל, ורדנאפיל); וריסיגואט או ריוציגואט. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | מעכב PDE5 (סילדנאפיל, טדלפיל, ורדנאפיל); וריסיגואט או ריוציגואט |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב בחזה שלא חולף אחרי 3 מנות (15 דקות) ← דחוף - 101; כאב בחזה במנוחה או בתדירות עולה ← דחוף |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.68 הפרינים במשקל מולקולרי נמוך · Low-molecular-weight heparins דגל אדום

נוגד קרישה בזריקה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (8) | קלקסן · Clexane | קרוסיה · Crusia | קרוסיה פורטה · Crusia Forte | אנוקספרין קמהדע · Enoxaparin Kamada | אנוקספרין קמהדע פורטה · Enoxaparin Kamada Forte | אנוקספרין לדרקסן · Enoxaparin Ledraxen | פרגמין · Fragmin | אריקסטרה · Arixtra |
| נימוק / הערה | נוגד קרישה בזריקה: מינון לפי משקל ותפקוד כליות, ומשך לפי ההתוויה. הרפואן מרכז את המדדים ואת סיבת הטיפול, והרופא/ה מאשר/ת. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול שנקבע במסמך רפואי, באותו מינון. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | משקל עדכני | משקל מתועד מ-3 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 5 | תפקוד כליות | קראטינין ו-eGFR מ-3 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 6 | ספירת דם | ספירת דם עם טסיות מ-3 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 7 | סיבת הטיפול ומשכו המתוכנן | במסמכים הרפואיים מתועדות ההתוויה (למשל אחרי ניתוח, פקקת, היריון) ומשך הטיפול שנקבע, והמשך לא עבר. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | משקל, קראטינין ו-eGFR, ספירת דם — מ-3 החודשים האחרונים |
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.69 דיגוקסין · Digoxin

מעקב צמוד | לפי הנחיה, בתנאים

גליקוזיד לבבי

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | דיגוקסין קרן פארמה · Digoxin Kern Pharma \| לאנוקסין · Lanoxin (תמיסה) |
| נימוק / הערה | רמה, אשלגן ותפקוד כליות. לא נעצר ע"י רפואן, מלבד ערך חמור. הרפואן לא משנה מינון בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רמת דיגוקסין מתועדת | בדיקה מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | רמת התרופה בדם בטווח | בבדיקה האחרונה רמת התרופה בדם בטווח. חריג: רמה מעל 1.2 ng/mL ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: רמה 2.0 ng/mL ומעלה ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: רמה 2.0 ng/mL ומעלה ← לא מחדשים | |
| 3 | אשלגן (K) תקין | בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K <3.0 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: K <3.0 ← לא מחדשים | |
| 4 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 5 | דופק במנוחה תקין | במדידה האחרונה דופק במנוחה תקין. חריג: מתחת ל-55 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים | |
| 6 | בדיקות כל 6 חודשים | מ-6 החודשים האחרונים: אשלגן, קריאטינין/eGFR. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 7 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 8 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 9 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 10 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 11 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 12 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 13 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 14 | סידן ומגנזיום | סידן ומגנזיום מהשנה האחרונה. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | רמת דיגוקסין שנתית; אשלגן וקריאטינין כל 6 חודשים |
| ספי החזרה לרופא/ה | רמה מעל 1.2 ng/mL; K מחוץ לטווח המעבדה; קריאטינין עלה >30% לעומת הקודם; דופק במנוחה <55 |
| ערך חמור | רמה 2.0 ng/mL ומעלה; K <3.0; דופק במנוחה <50 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | בחילות, הקאות, הפרעות ראייה (צבעים) או בלבול (חשד לרעילות) ← דחוף - לרופא עכשיו; דפיקות לב או סחרחורת ← לרופא |
| מקור | מעקב: SPS Medicines Monitoring (NHS) · SPS Medicines Monitoring |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.70 **אמיודרון** · Amiodarone

מעקב צמוד | לפי הנחיה, בתנאים

נוגד הפרעות קצב

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | פרוקור · Procor \| אמיאוקרד · Amiocard |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י קרדיולוג/ית. מעקב תריס, כבד, ריאות ועיניים. הרפואן לא משנה מינון בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | TSH ו-ALT מתועדים | מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | TSH בטווח | TSH בטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | תפקודי כבד (ALT) תקין | בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 2 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 4 | דופק במנוחה תקין | במדידה האחרונה דופק במנוחה תקין. חריג: מתחת ל-55 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים | |
| 5 | אק"ג, צילום חזה ובדיקת עיניים | מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 6 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 8 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י קרדיולוג/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 9 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 10 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 11 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 12 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 13 | אשלגן, מגנזיום ותפקודי כליות | מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 14 | בדיקת עיניים | בדיקת עיניים בשנה האחרונה (ומיידית בכל תסמין ראייה). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | TSH ו-ALT כל 6 חודשים; אק"ג, צילום חזה ובדיקת עיניים שנתיים |
| ספי החזרה לרופא/ה | ALT מעל פי 2 מהגבול העליון; דופק במנוחה <55 |
| ערך חמור | דופק במנוחה <50 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | שיעול או קוצר נשימה חדשים ← דחוף; ירידה בראייה ← לרופא; רגישות לשמש או גוון כחלחל בעור ← לרופא |
| מקור | מעקב: SPS Medicines Monitoring · SPS Medicines Monitoring (NHS) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.71 וורפרין · Warfarin

לפי הנחיה, בתנאים | מעקב צמוד

נוגד קרישה (אנטגוניסט ויטמין K)

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | קומדין · Coumadin |
| נימוק / הערה | INR מנוהל ע"י מרפאת נוגדי קרישה או הרופא/ה. לא נעצר ע"י רפואן; הרפואן לא משנה מינון |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | INR מתועד | INR מ-6 השבועות האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | INR בטווח היעד | INR בטווח היעד שתועד (בדרך כלל 2-3; מסתם מכני 2.5-3.5); INR 5 ומעלה ← הודעה דחופה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אין דימום מתועד | ברשומה או בפנייה אין דימום (צואה שחורה, דם בשתן או בצואה, דימום ממושך) מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 4 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני; המינון נקבע ע"י מרפאת נוגדי קרישה או הרופא/ה. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | INR לפחות כל 6 שבועות (לפי מרפאת נוגדי קרישה) |
| תלונות בפנייה או ברשומה | דימום, צואה שחורה או דם בשתן ← דחוף; חבורות מרובות ← לרופא |
| מקור | מעקב: SPS Medicines Monitoring · SPS Medicines Monitoring (NHS) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.72 אפיקסבן · Apixaban

לפי הנחיה, בתנאים | מעקב צמוד

נוגד קרישה ישיר (NOAC)

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (10) | אליקוויס · Eliquis \| אפיקס · Apix \| אפיקסבן דקסל · Apixaban Dexcel \| אפיקסבן אינובמד · Apixaban Inovamed \| אפיקסבן פרופארם · Apixaban Propharm \| אפיקסבן אס.קיי. · Apixaban S.K. \| אפיקסבן סנדוז · Apixaban Sandoz \| אפיקסבן תרו · Apixaban Taro \| אפיקסבן טבע · Apixaban Teva \| אפיקסבן-אבניר · Apixaban-Avenir |
| נימוק / הערה | מעקב כליות וספירת דם. הרפואן לא משנה מינון בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | קריאטינין וספירת דם מתועדים | מ-12 החודשים האחרונים; בגיל 75+ או eGFR <60 — מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | המוגלובין (Hb) תקין | בבדיקה האחרונה המוגלובין (Hb) תקין. חריג: Hb ירד ב-2 g/dL ומעלה לעומת הקודם או Hb מתחת ל-10 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <50 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <15 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: eGFR <15 ← לא מחדשים | |
| 4 | אין דימום מתועד | ברשומה או בפנייה אין דימום (צואה שחורה, דם בשתן או בצואה, דימום ממושך) מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 12 | תפקודי כבד | תפקודי כבד מהשנה האחרונה. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 13 | תדירות בדיקת כליות | בגיל 75 ומעלה או חולשה: קריאטינין מ-4 החודשים האחרונים; בפינוי קריאטינין מתחת ל-60: כל (פינוי ÷ 10) חודשים, לפי Cockcroft-Gault. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | קריאטינין/eGFR וספירת דם שנתית (גיל 75+ או eGFR <60: כל 6 חודשים) |
| ספי החזרה לרופא/ה | eGFR <50 (לבדיקת מינון); Hb ירד ב-2 g/dL ומעלה לעומת הקודם או Hb מתחת ל-10 |
| ערך חמור | eGFR <15 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | דימום, צואה שחורה או דם בשתן ← דחוף; חבורות מרובות ← לרופא |
| מקור | מעקב: SPS Medicines Monitoring (NHS) · SPS Medicines Monitoring |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.73 ריברוקסבן · Rivaroxaban

לפי הנחיה, בתנאים | מעקב צמוד

נוגד קרישה ישיר (NOAC)

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (10) | קסרלטו · Xarelto · ריבר טבע · Rivar Teva · ריברוקסבאן תרימה · Rivaroxaban Trima · ריברוקסבן דקסל · Rivaroxaban Dexcel · ריברוקסבן מדו · Rivaroxaban Medo · ריברוקסבאן אן אייץ' · Rivaroxaban NH · ריברוקסבאן פרופארם · Rivaroxaban Propharm · ריברוקסבאן אס.קיי. · Rivaroxaban S.K. · ריברוקסבן סנדוז · Rivaroxaban Sandoz · ריברוקסבן תרו · Rivaroxaban Taro |
| נימוק / הערה | מעקב כליות וספירת דם. 15/20 מ"ג נלקחים עם ארוחה. הרפואן לא משנה מינון בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | קריאטינין וספירת דם מתועדים | מ-12 החודשים האחרונים; בגיל 75+ או eGFR <60 — מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | המוגלובין (Hb) תקין | בבדיקה האחרונה המוגלובין (Hb) תקין. חריג: Hb ירד ב-2 g/dL ומעלה לעומת הקודם או Hb מתחת ל-10 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <50 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <15 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: eGFR <15 ← לא מחדשים | |
| 4 | אין דימום מתועד | ברשומה או בפנייה אין דימום (צואה שחורה, דם בשתן או בצואה, דימום ממושך) מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 12 | תפקודי כבד | תפקודי כבד מהשנה האחרונה. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 13 | תדירות בדיקת כליות | בגיל 75 ומעלה או חולשה: קריאטינין מ-4 החודשים האחרונים; בפינוי קריאטינין מתחת ל-60: כל (פינוי ÷ 10) חודשים, לפי Cockcroft-Gault. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | קריאטינין/eGFR וספירת דם שנתית (גיל 75+ או eGFR <60: כל 6 חודשים) |
| ספי החזרה לרופא/ה | eGFR <50 (לבדיקת מינון); Hb ירד ב-2 g/dL ומעלה לעומת הקודם או Hb מתחת ל-10 |
| ערך חמור | eGFR <15 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | דימום, צואה שחורה או דם בשתן ← דחוף; חבורות מרובות ← לרופא |
| מקור | מעקב: SPS Medicines Monitoring · SPS Medicines Monitoring (NHS) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 1.74 **דביגטרן** · Dabigatran

מעקב צמוד · לפי הנחיה, בתנאים

נוגד קרישה ישיר (NOAC)

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (3)** | פרדקסה · Pradaxa \| דביגטרן אס.קיי · Dabigatran S.K. \| דביגאטרן טבע · Dabigatran Teva |
| **נימוק / הערה** | הכי תלוי בכליות מבין ה-NOACs. הרפואן לא משנה מינון בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | קריאטינין וספירת דם מתועדים | מ-12 החודשים האחרונים; בגיל 75+ או eGFR <60 — מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | המוגלובין (Hb) תקין | בבדיקה האחרונה המוגלובין (Hb) תקין. חריג: Hb ירד ב-2 g/dL ומעלה לעומת הקודם או Hb מתחת ל-10 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <50 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים | |
| 4 | אין דימום מתועד | ברשומה או בפנייה אין דימום (צואה שחורה, דם בשתן או בצואה, דימום ממושך) מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 12 | תפקודי כבד | תפקודי כבד מהשנה האחרונה. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 13 | תדירות בדיקת כליות | בגיל 75 ומעלה או חולשה: קריאטינין מ-4 החודשים האחרונים; בפינוי קריאטינין מתחת ל-60: כל (פינוי ÷ 10) חודשים, לפי Cockcroft-Gault. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | קריאטינין/eGFR וספירת דם שנתית (גיל 75+ או eGFR <60: כל 6 חודשים) |
| **ספי החזרה לרופא/ה** | eGFR <50 (לבדיקת מינון); Hb ירד ב-2 g/dL ומעלה לעומת הקודם או Hb מתחת ל-10 |
| **ערך חמור** | eGFR <30 |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | דימום, צואה שחורה או דם בשתן ← דחוף; חבורות מרובות ← לרופא |
| **מקור** | מעקב: SPS Medicines Monitoring · SPS Medicines Monitoring (NHS) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

# 2. סוכרת ואנדוקרינולוגיה

51 תרופות · לפי הנחיה: 20 · לפי הנחיה, בתנאים: 28 · הכנה לאישור רופא/ה: 3 · גרסה 2 · חלוקה לפי מערכות · 2.11.2026

מקורות: ADA Standards of Care 2026 (פרקים 6, 9); קווי הכוונה לטיפול בסוכרת סוג 2 (עדכון 13.01.2021); הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020; ACOG 2023 (סיכום AFP). שאר התחומים: החלטה מקומית; עלון לצרכן לפונקס (עודכן 12/2020). שאר התרופות: החלטה מקומית

## 2.א כללים

- חידוש רגיל: 3 חודשים
- ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה פעם בשנה
- עד 3 חידושים רצופים, ואז ביקור רופא
- אין התווית נגד ← תמיד מחדשים לפחות לחודש אחד
- חסרה מדידה, בדיקה או ביקורת שנתית: חידוש לחודש אחד + זימון למרפאה
- חריגה מספי ההחזרה: חידוש לחודש אחד + הודעה לרופא/ה
- התווית נגד או ערך חמור: לא מחדשים, הודעה לרופא/ה (הסף של כל תרופה מופיע ברשימה שלה)
- רפואן לא משנה מינון ולא מחליף תרופה. "מעקב צמוד" = תרופה עם מעקב תכוף (מעבדה, אק"ג, עיניים או צילום) — לבדוק כל ערך בקפידה
- ערך חמור בסוכרת: מטפורמין eGFR <30; גליבנקלמיד וגלימפיריד eGFR >60; סולפונילאוריאה אחרת eGFR <15; פיוגליטזון ALT מעל פי 2.5. מטפורמין עם eGFR 30–45 ומינון מעל 1,000 מ"ג ליום ← הודעה
- אינסולין בטיפול קבוע וכל הבדיקות תקינות: 3 חודשים. כל חריגה ← חודש באותו מינון + הודעה; אינסולין לא נעצר ע"י רפואן
- פורקסיגה, ג'רדיאנס, אוזמפיק/וגובי ומונג'רו (כמה התוויות): בלי HbA1c; יעד הטיפול נבדק ע"י הרופא/ה
- לבותירוקסין, הידרוקורטיזון וסטרואידים לא נעצרים ע"י רפואן: כל חריגה ← חודש + הודעה
- דגל אדום: הרפואן מכין לפי רשימת הבדיקות, והרופא/ה בודק/ת שוב לפני האישור — גם כשהכול תקין

## 2.ג בדיקות משותפות

| שלב | נושא | מה בודקים | קריטריון | אם לא מתקיים | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| לפני כל חידוש | HbA1c מתועד | בדיקה מ-6 החודשים האחרונים | לפחות פעמיים בשנה | אין ← חידוש לחודש אחד + זימון לבדיקה | ADA פרק 6 עמ' 132-133; החלטה סוכרת-1 |
| לפני כל חידוש | HbA1c יציב | הערך האחרון לעומת הבדיקה הקודמת | לא עלה ב-0.5% או יותר. בתרופה שגורמת להיפוגליקמיה (אינסולין, סולפונילאוריאה, רפגליניד): לא מתחת ל-6.5% | עלייה, ערך נמוך או אין בדיקה קודמת ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה; ≥10% ← הודעה דחופה באותו יום | החלטות סוכרת-2-4 |
| לפני כל חידוש | היפוגליקמיה | רשומה מאז הביקור האחרון (רק בתרופות שגורמות להיפוגליקמיה) | אין סוכר מתחת ל-70, פנייה למיון או טיפול בגלוקגון | יש ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה | ADA פרק 6 עמ' 144-145; החלטה סוכרת-5 |
| לפני כל חידוש | רכישות | כיסוי ימים ב-6 החודשים האחרונים | 80% מהימים ומעלה | פחות ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה | החלטה מקומית (כמו ביל"ד) |
| לפני כל חידוש | ביקורת שנתית | ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה | ב-12 החודשים האחרונים | אין ביקור ← חידוש לחודש + זימון לביקורת במרפאה | החלטה מקומית (כמו ביל"ד) |
| לפני כל חידוש | בדיקות שנתיות | ב-12 החודשים האחרונים | קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים; מטפורמין: B12 כל שנתיים; פיוגליטזון: ALT | חסר ← חידוש לחודש + זימון לבדיקות | קווי הכוונה עמ' 17, 23; ADA פרק 9 עמ' 203; החלטה סוכרת-12 |
| לפני כל חידוש | תפקוד כליות | eGFR האחרון | ספים לפי התרופה (ראו בכל תרופה) | חריגה ← חידוש לחודש + הודעה; ערך חמור ← לא מחדשים | החלטות סוכרת-6-9 |
| לפני כל חידוש | רצף חידושים | כמה חידושים רצופים מאז ביקור רופא | פחות מ-3 | 3 חידושים כבר בוצעו ← ביקור רופא | החלטה מקומית (כמו ביל"ד) |
| החזרה מיידית לרופא | סוכר גבוה מאוד | הבדיקה האחרונה | HbA1c ≥10% או סוכר ≥300 מ"ג/ד"ל | חידוש לחודש + הודעה דחופה באותו יום | ADA פרק 9 עמ' 198, 203 |

| שלב | נושא | מה בודקים | קריטריון | אם לא מתקיים | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| החזרה מיידית לרופא | היפוגליקמיה חמורה | מופיע בפנייה או ברשומה | איבוד הכרה, עזרת אדם אחר, פנייה למיון | חידוש לחודש + הודעה דחופה | ADA פרק 6 עמ' 145 |
| החזרה מיידית לרופא | היריון | היריון או תכנון היריון | תרופות פומיות ו-GLP-1: לא מחדשים. אינסולין: חידוש לחודש | הודעה דחופה לרופא/ה | ADA פרק 9 עמ' 211-212 |
| החזרה מיידית לרופא | חשד ל-DKA או לדלקת לבלב | מופיע בפנייה או ברשומה | SGLT2: הקאות, כאבי בטן, חולשה. GLP-1/DPP-4: כאב בטן עליון חזק | דחוף - לרופא עכשיו | ADA פרק 9 עמ' 193-195 |
| לפני כל חידוש | בדיקת מעקב | לפי התרופה | שומנים: LDL; לבותירוקסין: TSH; אלופורינול/פבוקסוסטט: חומצה אורית — מ-12 החודשים האחרונים | אין ← חידוש לחודש + זימון לבדיקה | הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52; החלטה כללי-1 |

## 2.ד החלטות

| # | נושא | מה ההנחיה אומרת | ההחלטה לפרוטוקול | סוג | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| סוכרת-1 | תדירות HbA1c | ADA: לפחות פעמיים בשנה; כל 3 חודשים כשלא ביעד או אחרי שינוי | נדרש HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש + זימון לבדיקה | הנחיה | ADA 6.2, עמ' 132-133 |
| סוכרת-2 | HbA1c לעומת הבדיקה הקודמת | ADA: יעד אישי; <7% לרוב המבוגרים, עד 8% במצב בריאותי מורכב; קווי הכוונה: <7% | אין סף קבוע: משווים לבדיקה הקודמת. עלייה של 0.5% או יותר, או אין בדיקה קודמת ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. בכל מקרה מחדשים לפחות לחודש | החלטה מקומית | ADA 6.3a-6.5, עמ' 135, 138; קווי הכוונה עמ' 12 |
| סוכרת-3 | HbA1c גבוה מאוד | ADA: לשקול אינסולין ב-HbA1c >10% או סוכר ≥300 | HbA1c ≥10% ← חידוש לחודש + הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום | החלטה מקומית | ADA 9.20, עמ' 198 |
| סוכרת-4 | סף תחתון בתרופות שגורמות להיפוגליקמיה | ADA: להפחית אינסולין, סולפונילאוריאה ומגליטיניד בסיכון גבוה להיפוגליקמיה | באינסולין, סולפונילאוריאה ורפגליניד: HbA1c <6.5% ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה (בכל גיל) | החלטה מקומית | ADA 6.6, טבלה 6.5, עמ' 135, 140 |
| סוכרת-5 | היפוגליקמיה מתועדת | ADA: אירוע דרגה 2 או 3 מחייב הערכה מחדש של הטיפול | תיעוד היפוגליקמיה מאז הביקור האחרון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה | הנחיה | ADA 6.19, עמ' 145 |
| סוכרת-6 | מטפורמין ותפקוד כליות | ADA וקווי הכוונה: הפחתת מינון ב-eGFR <45; התווית נגד ב-eGFR <30 | eGFR <45 ← חידוש לחודש + הודעה (בדיקת מינון). eGFR <30 ← ערך חמור, לא מחדשים | הנחיה | ADA עמ' 193, 205; קווי הכוונה עמ' 42 |
| סוכרת-7 | SGLT2 ותפקוד כליות | קווי הכוונה 2021: להפסיק אמפגליפלוזין 2026 .ADA 45.<: להמשיך עד דיאליזה; להתחיל אם eGFR >20 | eGFR <45 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה, שמכריע בין המקורות. לא ערך חמור | הכרעה | ADA עמ' 193, 197, 205; קווי הכוונה עמ' 44-45 |
| סוכרת-8 | DPP-4 ותפקוד כליות | סיטגליפטין, וילדגליפטין: הפחתת מינון ב-eGFR <50; לינגליפטין: ללא התאמה | eGFR <50 ← חידוש לחודש + הודעה (בדיקת מינון). לינגליפטין: אין סף | הנחיה | ADA עמ' 195; קווי הכוונה עמ' 51 |
| סוכרת-9 | סולפונילאוריאה ותפקוד כליות | קווי הכוונה: גליבנקלמיד להפסיק ב-eGFR <60; גלימפיריד בזהירות <60; לא ב-ESRF | גליבנקלמיד וגלימפיריד: eGFR <60 ← ערך חמור (גלימפיריד עודכן 8.11.2026). גליקלזיד: <15 ← ערך חמור | הנחיה | ADA עמ' 195; קווי הכוונה עמ' 54 |
| סוכרת-10 | שילובים לא מומלצים | ADA: לא לשלב DPP-4 עם GLP-1 או טירזפטייד; להגביל סולפונילאוריאה ומגליטיניד עם אינסולין | שילוב כזה ברשימת התרופות ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה | הנחיה | ADA 9.18, עמ' 192, 197, 201 |
| סוכרת-11 | פיוגליטזון | ADA וקווי הכוונה: אסור באי-ספיקת לב ובסרטן שלפוחית; קווי הכוונה: אסור ב-ALT מעל פי 2.5 | אי-ספיקת לב או סרטן שלפוחית ← התווית נגד. ALT מעל פי 2.5 ← ערך חמור | הנחיה | ADA עמ' 195; קווי הכוונה עמ' 56 |
| סוכרת-12 | B12 במטפורמין | ADA: בדיקה תקופתית; קווי הכוונה: אחרי כשנה, ואחת לשנה-שנתיים | B12 מ-24 החודשים האחרונים, כחלק מהבדיקות השנתיות | החלטה מקומית | ADA עמ' 203; קווי הכוונה עמ' 23 |

| # | נושא | מה ההנחיה אומרת | ההחלטה לפרוטוקול | סוג | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| סוכרת-13 | אינסולין | ADA: הפסקת אינסולין מסוכנת; הרפואן אינו מתאים מינון | טיפול קבוע (אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים) וכל הבדיקות תקינות ← חידוש ל-3 חודשים. כל חריגה, כולל היריון, היפוגליקמיה או ירידה בתפקוד הכליות ← חידוש לחודש באותו מינון + הודעה לרופא/ה. אינסולין לא נעצר ע"י רפואן | החלטה מקומית | ADA פרק 6 עמ' 144-147; פרק 9 עמ' 200-201 |
| סוכרת-14 | מונג'רו ו-וויגובי | וויגובי רשום בישראל להשמנה; מונג'רו לסוכרת ולהשמנה | שניהם בפרוטוקול באותם תנאים (וויגובי תחת סמגלוטייד בהזרקה). Saxenda אינו בפרוטוקול | החלטה מקומית | מאגר התרופות 7.10.2026 |
| סוכרת-15 | מקור ישראלי | קווי ההכוונה 2021 ישנים מ-ADA 2026 ואינם כוללים טירזפטייד וסמגלוטייד פומי | בסתירה: ADA 2026 קובע, והסתירה מסומנת "הכרעה" לאישור | הכרעה | - |
| סוכרת-16 | תרופות עם כמה התוויות | SGLT2i (דפגליפלוזין, אמפגליפלוזין) ב-CKD ובאי ספיקת לב: התחלה עד eGFR ≥20 והמשך עד דיאליזה; GLP-1/טירזפטייד בהתוויה למשקל או ללב — לא תלוי HbA1c | דפגליפלוזין ואמפגליפלוזין: בלי HbA1c; eGFR מתחת ל-25 ← הודעה (במקום 45). סמגלוטייד וטירזפטייד: בלי HbA1c; מדידת משקל שנתית | החלטה מקומית (2.11.2026) | ADA 2026; KDIGO 2024 |
| כללי-1 | בדיקות מעקב | שומנים: פרופיל 12-4 שבועות אחרי התחלה, אחר כך כל 12-6 חודשים (ההנחיה הישראלית 2020; ESC/EAS 2019). TSH בלבותירוקסין: שנתי כשמאוזן (NICE NG145). חומצה אורית בטיפול מוריד: יעד <6, בדיקה תקופתית (ACR 2020) | LDL, TSH וחומצה אורית מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש + זימון | החלטה מקומית (הצעה) | הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52; ESC/EAS 2019; NICE NG145; ACR 2020 |
| כללי-4 | לבותירוקסין | TSH שנתי כשמאוזן (NICE NG145); היריון ← העלאת מינון מיידית ובדיקת TSH (ATA 2017) | TSH מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה. היריון ← הודעה דחופה. לא נעצר ע"י רפואן | החלטה מקומית (הצעה) | NICE NG145; ATA 2017 |
| כללי-8 | ערמונית | חוסמי אלפא ו-5ARI: אין מעקב מעבדה שגרתי; 5ARI מוריד PSA בכ-50% (להכפיל לפרשנות) | חוסמי אלפא ו-5ARI: ללא מעקב מעבדה; רק רכישות וביקורת שנתית | החלטה מקומית (הצעה) | EAU 2024; AUA |
| כללי-9 | ביספוספונטים | להפסיק אחרי 5 שנים טיפול פומי בסיכון שאינו גבוה; עד 10 שנים בסיכון גבוה. אסור ב-eGFR ≤35 | 5 שנות טיפול ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. eGFR <35 ← ערך חמור | הנחיה | ACOG 2023 (סיכום AFP) עמ' 101-102 |
| כללי-14 | הורמונים לנשים | NAMS 2022: אסטרוגן מערכתי עם רחם ← פרוגסטוגן; דימום לא סדיר ← בירור; התוויות נגד: סרטן שד, פקקת, אוטם/שבץ, מחלת כבד | אסטרוגן בלי פרוגסטוגן כשיש רחם ← הודעה; דימום ← הודעה דחופה; ממוגרפיה לפי התוכנית; ל"ד שנתי. אמצעי מניעה משולב: ל"ד מתחת ל-140/90, עישון בגיל 35+, מיגרנה עם הילה ופקקת = התווית נגד | הנחיה + החלטה מקומית | NAMS 2022; נייר העמדה הישראלי לטיפול הורמונלי (בפרויקט) |
| כללי-18 | גסטרו ואנדוקרינולוגיה | מסאלזין: תפקוד כליות לפני, אחרי 3 חודשים ואז שנתי (BSG 2019). הידרוקורטיזון: הנחיות יום מחלה (Endocrine Society 2016). דסמופרסין: נתרן (תווית). סינקלצט/אלפקלצידול: סידן (תווית) | מסאלזין: קריאטינין שנתי. הידרוקורטיזון: לא נעצר, הנחיות מחלה. אלפקלצידול וסינקלצט: סידן. דסמופרסין: נתרן | החלטה מקומית (הצעה) | BSG 2019; Endocrine Society 2016; תווית |
| כללי-21 | תרופות מומחה נוספות | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי). הטיפול נקבע ומנוטר ע"י המומחה | מטוקלופרמיד ממושך, ממריצים/מודפיניל, טרשת נפוצה, אונקולוגיה, יל"ד ריאתי/IPF, סירולימוס, הורמון גדילה, המטולוגיה, CF, טפמידיס/מבקמטן: הודעה בלבד, חידוש ע"י רופא/ה. תרופות ביולוגיות בזריקה בקהילה: הרפואן מכין (אישור, מכתב מומחה, מרווח, בטיחות) והרופא/ה מאשר/ת (5.11.2026) | החלטה מקומית | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |

| # | נושא | מה ההנחיה אומרת | ההחלטה לפרוטוקול | סוג | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| כללי-22 | השלמות 2 מהמאגר (2.11.2026) | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) | ויטמין D, בטאהיסטין, חומצה במפדואית, אומגה 3/איקוזפנט, ציפרופיברט, וריסיגואט, ניטרוגליצרין תת-לשוני, פזולינטנט/אלינזנטנט (ALT), דואביב, אינטראזוסה, סיאנה, אורליסטט, פרוקלופריד, משלשלים, טטרציקלינים ממושכים, מניעת זיהומי שתן, משככי כאב ממושכים, ביקרבונט. עודכן ב-7.11.2026: אין עוד "רופא/ה בלבד" בקבוצה זו — ראו החלטת הסקירה | החלטה מקומית (הצעה) | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| מעקב-12 | תרופות למעקב צמוד נוספות | DMARDs: ספירת דם, ALT וקריאטינין כל 3 חודשים בטיפול יציב (BSR 2017); שאר התרופות לפי התווית | מתימזול/PTU, לפלונומיד, אזתיופרין, סולפסלזין, מיקופנולט, מעכבי JAK, הידרוקסיאוריאה, הידרוקסיכלורוקווין, נוגדי פסיכוזה, טסטוסטרון, סטרואידים כרוניים, ניטרופורנטואין, קולכיצין, דנוסומאב, טריפרטייד: בדיקות לפי התרופה; חריגה ← חודש + הודעה; ערך חמור ← לא מחדשים | החלטה מקומית (הצעה) | BSR 2017; עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| מעקב-13 | נוגדי פסיכוזה נוספים | מעקב מטבולי (משקל, גלוקוז/HbA1c, שומנים) בתחילה, אחרי 12 שבועות ואז שנתי; אק"ג לפי התווית (QT) | הלופרידול, פליפרידון, קריפרזין, זיפרזידון, פרפנזין: מעקב מטבולי כמו בשאר; אק"ג בגיל 50+ בהלופרידול וזיפרזידון | החלטה מקומית (הצעה) | NICE CG178; ADA/APA 2004 |
| סקירה-1 | סקירת פריטים חסומים (7.11.2026) | נושא תפעולי — הנחיות קליניות לא עוסקות בו; מבוסס על נוהל הרפואן | אף תרופה לא חסומה כברירת מחדל. 59 הפריטים שהיו "רופא/ה בלבד" נסקרו אחד-אחד: חלקם פתוחים עם רשימת בדיקות, חלקם בדגל אדום (בדיקה כפולה מול הרופא/ה). נשארים אצל הרופא/ה: רואקוטן, אנטיביוטיקה לתסמין חדש (מלבד מוקסיפן/רפאפן אחרי משטח גרון חיובי) ותרופות נגד שפעת. התראת האינטראקציות של המערכת היא שכבת ההגנה הבסיסית. | החלטה מקומית (7.11.2026) | - |

## 2.ה רשימת התרופות (לסימון)

| # | שם | גנרי | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | מטפורמין | Metformin | ביגואניד | לפי הנחיה | ☐ | |
| 2.2 | אמפגליפלוזין | Empagliflozin | מעכב SGLT2 | לפי הנחיה | ☐ | |
| 2.3 | דפגליפלוזין | Dapagliflozin | מעכב SGLT2 | לפי הנחיה | ☐ | |
| 2.4 | ארטוגליפלוזין | Ertugliflozin | מעכב SGLT2 | לפי הנחיה | ☐ | |
| 2.5 | סיטגליפטין | Sitagliptin | מעכב DPP-4 | לפי הנחיה | ☐ | |
| 2.6 | וילדגליפטין | Vildagliptin | מעכב DPP-4 | לפי הנחיה | ☐ | |
| 2.7 | לינגליפטין | Linagliptin | מעכב DPP-4 | לפי הנחיה | ☐ | |
| 2.8 | סיטגליפטין + מטפורמין | Sitagliptin + Metformin | מעכב DPP-4 + ביגואניד | לפי הנחיה | ☐ | |
| 2.9 | וילדגליפטין + מטפורמין | Vildagliptin + Metformin | מעכב DPP-4 + ביגואניד | לפי הנחיה | ☐ | |
| 2.10 | לינגליפטין + מטפורמין | Linagliptin + Metformin | מעכב DPP-4 + ביגואניד | לפי הנחיה | ☐ | |
| 2.11 | אמפגליפלוזין + מטפורמין | Empagliflozin + Metformin | מעכב SGLT2 + ביגואניד | לפי הנחיה | ☐ | |
| 2.12 | דפגליפלוזין + מטפורמין | Dapagliflozin + Metformin | מעכב SGLT2 + ביגואניד | לפי הנחיה | ☐ | |

| # | שם | גנרי | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.13 | אמפגליפלוזין + לינגליפטין | Empagliflozin + Linagliptin | מעכב SGLT2 + מעכב DPP-4 | לפי הנחיה | ☐ | |
| 2.14 | פיוגליטזון + מטפורמין | Pioglitazone + Metformin | תיאזולידינדיון + ביגואניד | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 2.15 | סמגלוטייד בהזרקה | Semaglutide | אגוניסט GLP-1 | לפי הנחיה | ☐ | |
| 2.16 | סמגלוטייד פומי | Semaglutide (oral) | אגוניסט GLP-1 | לפי הנחיה | ☐ | |
| 2.17 | דולגלוטייד | Dulaglutide | אגוניסט GLP-1 | לפי הנחיה | ☐ | |
| 2.18 | טירזפטייד | Tirzepatide | אגוניסט כפול GIP/GLP-1 | לפי הנחיה | ☐ | |
| 2.19 | גלימפיריד | Glimepiride | סולפונילאוריאה | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 2.20 | גליבנקלמיד | Glibenclamide | סולפונילאוריאה | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 2.21 | רפגליניד | Repaglinide | מגליטיניד | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 2.22 | פיוגליטזון | Pioglitazone | תיאזולידינדיון | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 2.23 | אקרבוז | Acarbose | מעכב אלפא-גלוקוזידאז | לפי הנחיה | ☐ | |
| 2.24 | אינסולין גלרגין | Insulin glargine | אינסולין בזאלי | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 2.25 | אינסולין דגלודק | Insulin degludec | אינסולין בזאלי | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 2.26 | אינסולין דטמיר | Insulin detemir | אינסולין בזאלי | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 2.27 | אינסולין איקודק | Insulin icodec | אינסולין בזאלי שבועי | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 2.28 | אינסולין NPH | Insulin NPH (human) | אינסולין בינוני (NPH) | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 2.29 | אינסולין אספרט | Insulin aspart | אינסולין מהיר | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 2.30 | אינסולין ליספרו | Insulin lispro | אינסולין מהיר | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 2.31 | אינסולין גלוליזין | Insulin glulisine | אינסולין מהיר | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 2.32 | אינסולין רגיל | Insulin regular (human) | אינסולין קצר | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 2.33 | אינסולין מעורב | Insulin premixed | אינסולין מעורב | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 2.34 | דגלודק + ליראגלוטייד | Insulin degludec + Liraglutide | אינסולין + GLP-1 | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 2.35 | גלרגין + ליקסיסנטייד | Insulin glargine + Lixisenatide | אינסולין + GLP-1 | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 2.36 | לבותירוקסין | Levothyroxine | בלוטת התריס · הורמון בלוטת התריס | לפי הנחיה | ☐ | |
| 2.37 | הידרוקורטיזון (תחליפי) | Hydrocortisone (replacement) | אי-ספיקת אדרנל | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |

| # | שם | גנרי | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.38 | אלפקלצידול | Alfacalcidol | ויטמין D פעיל | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 2.39 | סינקלצט | Cinacalcet | קלצימימטי | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 2.40 | קברגולין | Cabergoline | אגוניסט לדופמין | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 2.41 | דסמופרסין | Desmopressin | אנלוג ADH | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 2.42 | הורמון גדילה | Growth hormone | אנדוקרינולוגיה | דגל אדום | ☐ | |
| 2.43 | אורליסטט | Orlistat | השמנה | לפי הנחיה | ☐ | |
| 2.44 | פנטרמין | Phentermine | השמנה · ממריץ | דגל אדום | ☐ | |
| 2.45 | אנלוגים לסומטוסטטין ופגויזומנט | Somatostatin analogues / pegvisomant | אנדוקרינולוגיה | דגל אדום | ☐ | |
| 2.46 | גלוקגון — ערכת חירום להיפוגליקמיה (גלוקגן היפוקיט) | Glucagon (rescue kit) | סוכרת · ערכת חירום | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 2.47 | מתימזול | Methimazole | נוגד פעילות יתר של התריס | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |
| 2.48 | פרופילתיאוראציל (PTU) | Propylthiouracil | נוגד פעילות יתר של התריס | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |
| 2.49 | טסטוסטרון | Testosterone | הורמון גברי | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |
| 2.50 | פרדניזון (טיפול כרוני) | Prednisone (chronic) | סטרואיד | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |
| 2.51 | מתילפרדניזולון (טיפול כרוני) | Methylprednisolone (chronic) | סטרואיד | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |

## 1.2 פירוט מלא

### 2.1 **מטפורמין** · Metformin לפי הנחיה

ביגואניד

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (5) | גלוקומין · Glucomin | גלוקופג' XR · Glucophage XR | מטפורמין טבע · Metformin Teva | אינובמד · Metformin Inovamed | מטפורמין גלניקום · Metformin Galenicum |
| נימוק / הערה | קו ראשון; ספי כליה ברורים |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | HbA1c מתועד | נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | HbA1c יציב | משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים, B12 (ב-24 החודשים האחרונים). חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 6 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <45 (לבדיקת מינון: מעל 1,000 מ"ג ליום עם eGFR 30–45) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 OP = 2 אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי; B12 כל שנתיים |
| ספי החזרה לרופא/ה | eGFR <45 (לבדיקת מינון: מעל 1,000 מ"ג ליום עם eGFR 30–45) |
| ערך חמור | eGFR <30 |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון |
| תלונות בפנייה או ברשומה | שלשולים או אי-נוחות בטן מתמשכים ← לרופא לשקול תכשיר XR או הפחתה; הקאות, שלשול חריף או התייבשות ← הפסקה זמנית, לרופא |
| מקור | ADA פרק 9 עמ' 197, 205; קווי הכוונה עמ' 42; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.2 אמפגליפלוזין · Empagliflozin לפי הנחיה

מעכב SGLT2

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | ג'ארדיאנס · Jardiance \| אמפזין אס.קיי. · Empazin S.K. |
| נימוק / הערה | תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: סוכרת, אי-ספיקת לב, מחלת כליות כרונית. תועלת לב-כליה; ספי כליה ברורים |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 4 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <25 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון; סוכרת סוג 1. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי |
| ספי החזרה לרופא/ה | eGFR <25 |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון; סוכרת סוג 1 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | זיהומים חוזרים בדרכי השתן או זיהום פטרייתי באברי המין ← לרופא לשקול החלפה; כאב, אודם או נפיחות באזור איברי המין (חשד לפורנייה) ← דחוף; הקאות, כאבי בטן או חולשה ניכרת (חשד ל-DKA) ← דחוף |
| מקור | ADA פרק 9 עמ' 193, 199, 214; קווי הכוונה עמ' 44-45; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.3 דפגליפלוזין · Dapagliflozin לפי הנחיה

מעכב SGLT2

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (6) | פורסיגה · Forxiga \| דפגליפלוזין סנדוז · Dapagliflozin Sandoz \| דאפאגליפלוזין תרו · Dapagliflozin Taro \| דאפאגליפלוזין טבע · Dapagliflozin Teva \| דאפאמד · Dapamed \| דיפו · Dippo |
| נימוק / הערה | תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: סוכרת, אי-ספיקת לב, מחלת כליות כרונית. תועלת לב-כליה; ספי כליה ברורים |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 4 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <25 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון; סוכרת סוג 1. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי |
| ספי החזרה לרופא/ה | eGFR <25 |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון; סוכרת סוג 1 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | זיהומים חוזרים בדרכי השתן או זיהום פטרייתי באברי המין ← לרופא לשקול החלפה; כאב, אודם או נפיחות באזור איברי המין (חשד לפורנייה) ← דחוף; הקאות, כאבי בטן או חולשה ניכרת (חשד ל-DKA) ← דחוף |
| מקור | ADA פרק 9 עמ' 193, 199, 214; קווי הכוונה עמ' 44-45; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.4 ארטוגליפלוזין · Ertugliflozin לפי הנחיה

מעכב SGLT2

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | סטגלטרו · Steglatro |
| נימוק / הערה | ספי כליה ברורים |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | HbA1c מתועד | נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | HbA1c יציב | משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 6 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <45 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון; סוכרת סוג 1. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי |
| ספי החזרה לרופא/ה | eGFR <45 |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון; סוכרת סוג 1 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | זיהומים חוזרים בדרכי השתן או זיהום פטרייתי באברי המין ← לרופא לשקול החלפה; כאב, אודם או נפיחות באזור איברי המין (חשד לפורנייה) ← דחוף; הקאות, כאבי בטן או חולשה ניכרת (חשד ל-DKA) ← דחוף |
| מקור | ADA פרק 9 עמ' 193, 199, 214; קווי הכוונה עמ' 44-45; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.5 סיטגליפטין · Sitagliptin לפי הנחיה

מעכב DPP-4

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (8) | ג'נוביה · Januvia · סיטגליפטין אס.קיי. · Sitagliptin S.K. · סיטגליפטין סנדוז · Sitagliptin Sandoz · סיטגליפטין תרו · Sitagliptin Taro · סיטאגליפטין טבע · Sitagliptin Teva · סיטגליפטין ויטאמד · Sitagliptin Vitamed · סיטאר · Sitar · סיטין · Sitin |
| נימוק / הערה | ללא היפוגליקמיה; מינון לפי כליות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | HbA1c מתועד | נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | HbA1c יציב | משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 6 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <50 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי |
| ספי החזרה לרופא/ה | eGFR <50 (לבדיקת מינון) |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב בטן עליון חזק (חשד לדלקת לבלב) ← הפסקה, דחוף; שלפוחיות בעור (חשד לפמפיגואיד) ← הפסקה, לרופא; כאבי פרקים קשים ← לרופא לשקול הפסקה |
| מקור | ADA פרק 9 עמ' 195; קווי הכוונה עמ' 51; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.6 **וילדגליפטין** · Vildagliptin לפי הנחיה

מעכב DPP-4

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | גאלבוס · Galvus \| וילדאגליפטין אס.קיי. · Vildagliptin S.K. |
| נימוק / הערה | ללא היפוגליקמיה; מינון לפי כליות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | HbA1c מתועד | נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | HbA1c יציב | משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 6 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <50 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי |
| ספי החזרה לרופא/ה | eGFR <50 (לבדיקת מינון) |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב בטן עליון חזק (חשד לדלקת לבלב) ← הפסקה, דחוף; שלפוחיות בעור (חשד לפמפיגואיד) ← הפסקה, לרופא; כאבי פרקים קשים ← לרופא לשקול הפסקה |
| מקור | ADA פרק 9 עמ' 195; קווי הכוונה עמ' 51 |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.7 לינגליפטין · Linagliptin לפי הנחיה

מעכב DPP-4

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (5) | טרג'נטה · Trajenta \| לינגליפטין אינובמד · Linagliptin Inovamed \| לינגליפטין אס.קיי. · Linagliptin S.K \| לינגליפטין תרו · Linagliptin Taro \| לינגליפטין טבע · Linagliptin Teva |
| נימוק / הערה | ללא היפוגליקמיה; ללא התאמה לכליות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | HbA1c מתועד | נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | HbA1c יציב | משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 10 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב בטן עליון חזק (חשד לדלקת לבלב) ← הפסקה, דחוף; שלפוחיות בעור (חשד לפמפיגואיד) ← הפסקה, לרופא; כאבי פרקים קשים ← לרופא לשקול הפסקה |
| מקור | ADA פרק 9 עמ' 195; קווי הכוונה עמ' 51; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.8 סיטגליפטין + מטפורמין · Sitagliptin + Metformin לפי הנחיה

מעכב DPP-4 + ביגואניד

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (11) | ג'נואט · Januet | ג'נואט XR · Januet XR | סימטרין · Simetrin | סיטאפורמין טבע · Sitaformin Teva | סיטפורמין ויטאמד · Sitaformin Vitamed | סיטגליפטין קומבו סנדוז · Sitagliptin Combo Sandoz | סיטאגמט אס.קיי. · Sitagmet S.K | סיטמט-אבניר · Sitamet-Avenir | סיטאמין · Sitamin | סיטאר פלוס · Sitar Plus | סיטפורמין תרו · Sitformin Taro |
| נימוק / הערה | שילוב קבוע; ספי כליה של שני הרכיבים |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | HbA1c מתועד | נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | HbA1c יציב | משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים, B12 (ב-24 החודשים האחרונים). חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 6 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <50 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי; HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי; B12 כל שנתיים |
| ספי החזרה לרופא/ה | eGFR <50 (לבדיקת מינון) |
| ערך חמור | eGFR <30 |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב בטן עליון חזק (חשד לדלקת לבלב) ← הפסקה, דחוף; שלפוחיות בעור (חשד לפמפיגואיד) ← הפסקה, לרופא; כאבי פרקים קשים ← לרופא לשקול הפסקה; שלשולים או אי-נוחות בטן מתמשכים ← לרופא לשקול תכשיר XR או הפחתה; הקאות, שלשול חריף או התייבשות ← הפסקה זמנית, לרופא |
| מקור | ADA פרק 9 עמ' 195; קווי הכוונה עמ' 51; ADA פרק 9 עמ' 197, 205; קווי הכוונה עמ' 42; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.9 **וילדגליפטין + מטפורמין** · Vildagliptin + Metformin לפי הנחיה

מעכב DPP-4 + ביגואניד

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (5) | יוקריאס · Eucreas | מטילדה · Metilda | ויפורמין · Viformin | וילדאמד אס.קיי. · Vildamed S.K. | ויולט · Violet |
| נימוק / הערה | שילוב קבוע; ספי כליה של שני הרכיבים |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | HbA1c מתועד | נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | HbA1c יציב | משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים, B12 (ב-24 החודשים האחרונים). חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 6 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <50 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי; HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי; B12 כל שנתיים |
| ספי החזרה לרופא/ה | eGFR <50 (לבדיקת מינון) |
| ערך חמור | eGFR <30 |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב בטן עליון חזק (חשד לדלקת לבלב) ← הפסקה, דחוף; שלפוחיות בעור (חשד לפמפיגואיד) ← הפסקה, לרופא; כאבי פרקים קשים ← לרופא לשקול הפסקה; שלשולים או אי-נוחות בטן מתמשכים ← לרופא לשקול תכשיר XR או הפחתה; הקאות, שלשול חריף או התייבשות ← הפסקה זמנית, לרופא |
| מקור | ADA פרק 9 עמ' 195; קווי הכוונה עמ' 51; ADA פרק 9 עמ' 197, 205; קווי הכוונה עמ' 42 |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.10 **לינגליפטין + מטפורמין** · Linagliptin + Metformin לפי הנחיה

מעכב DPP-4 + ביגואניד

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (1)** | טרג'נטה דואו · Trajenta Duo |
| **נימוק / הערה** | שילוב קבוע; ספי הכליה של מטפורמין |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | HbA1c מתועד | נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | HbA1c יציב | משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים, B12 (ב-24 החודשים האחרונים). חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 6 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <45 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 OP = 2 אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי; HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי; B12 כל שנתיים |
| **ספי החזרה לרופא/ה** | eGFR <45 |
| **ערך חמור** | eGFR <30 |
| **מצבים שמוציאים מהפרוטוקול** | היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | כאב בטן עליון חזק (חשד לדלקת לבלב) ← הפסקה, דחוף; שלפוחיות בעור (חשד לפמפיגואיד) ← הפסקה, לרופא; כאבי פרקים קשים ← לרופא לשקול הפסקה; שלשולים או אי-נוחות בטן מתמשכים ← לרופא לשקול תכשיר XR או הפחתה; הקאות, שלשול חריף או התייבשות ← הפסקה זמנית, לרופא |
| **מקור** | ADA פרק 9 עמ' 195; קווי הכוונה עמ' 51; ADA פרק 9 עמ' 197, 205; קווי הכוונה עמ' 42; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.11 אמפגליפלוזין + מטפורמין · Empagliflozin + Metformin לפי הנחיה

מעכב SGLT2 + ביגואניד

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | ג'ארדיאנס דואו · Jardiance Duo |
| נימוק / הערה | שילוב קבוע; ספי כליה של שני הרכיבים |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | HbA1c מתועד | נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | HbA1c יציב | משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים, B12 (ב-24 החודשים האחרונים). חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 6 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <45 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 OP = 2 אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון; סוכרת סוג 1. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי; HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי; B12 כל שנתיים |
| ספי החזרה לרופא/ה | eGFR <45 |
| ערך חמור | eGFR <30 |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון; סוכרת סוג 1 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | זיהומים חוזרים בדרכי השתן או זיהום פטרייתי באברי המין ← לרופא לשקול החלפה; כאב, אודם או נפיחות באזור איברי המין (חשד לפורנייה) ← דחוף; הקאות, כאבי בטן או חולשה ניכרת (חשד ל-DKA) ← דחוף; שלשולים או אי-נוחות בטן מתמשכים ← לרופא לשקול תכשיר XR או הפחתה; הקאות, שלשול חריף או התייבשות ← הפסקה זמנית, לרופא |
| מקור | ADA פרק 9 עמ' 193, 199, 214; קווי הכוונה עמ' 44-45; ADA פרק 9 עמ' 197, 205; קווי הכוונה עמ' 42; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.12 דפגליפלוזין + מטפורמין · Dapagliflozin + Metformin לפי הנחיה

מעכב SGLT2 + ביגואניד

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | קסיגדו XR · Xigduo XR |
| נימוק / הערה | שילוב קבוע; ספי כליה של שני הרכיבים |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | HbA1c מתועד | נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | HbA1c יציב | משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים, B12 (ב-24 החודשים האחרונים). חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 6 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <45 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 OP = 2 אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון; סוכרת סוג 1. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי; HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי; B12 כל שנתיים |
| ספי החזרה לרופא/ה | eGFR <45 |
| ערך חמור | eGFR <30 |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון; סוכרת סוג 1 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | זיהומים חוזרים בדרכי השתן או זיהום פטרייתי באברי המין ← לרופא לשקול החלפה; כאב, אודם או נפיחות באזור איברי המין (חשד לפורנייה) ← דחוף; הקאות, כאבי בטן או חולשה ניכרת (חשד ל-DKA) ← דחוף; שלשולים או אי-נוחות בטן מתמשכים ← לרופא לשקול תכשיר XR או הפחתה; הקאות, שלשול חריף או התייבשות ← הפסקה זמנית, לרופא |
| מקור | ADA פרק 9 עמ' 193, 199, 214; קווי הכוונה עמ' 44-45; ADA פרק 9 עמ' 197, 205; קווי הכוונה עמ' 42; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.13 אמפגליפלוזין + לינגליפטין · Empagliflozin + Linagliptin לפי הנחיה

מעכב SGLT2 + מעכב DPP-4

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | גליקסמבי · Glyxambi |
| נימוק / הערה | שילוב קבוע |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | HbA1c מתועד | נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | HbA1c יציב | משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 6 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <45 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון; סוכרת סוג 1; דלקת לבלב בעבר. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי |
| ספי החזרה לרופא/ה | eGFR <45 |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון; סוכרת סוג 1; דלקת לבלב בעבר |
| תלונות בפנייה או ברשומה | זיהומים חוזרים בדרכי השתן או זיהום פטרייתי באברי המין ← לרופא לשקול החלפה; כאב, אודם או נפיחות באזור איברי המין (חשד לפורנייה) ← דחוף; הקאות, כאבי בטן או חולשה ניכרת (חשד ל-DKA) ← דחוף; כאב בטן עליון חזק (חשד לדלקת לבלב) ← הפסקה, דחוף; שלפוחיות בעור (חשד לפמפיגואיד) ← הפסקה, לרופא; כאבי פרקים קשים ← לרופא לשקול הפסקה |
| מקור | ADA פרק 9 עמ' 193, 199, 214; קווי הכוונה עמ' 44-45; ADA פרק 9 עמ' 195; קווי הכוונה עמ' 51; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.14 פיוגליטזון + מטפורמין · Pioglitazone + Metformin לפי הנחיה, בתנאים

תיאזולידינדיון + ביגואניד

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | קומפטקט · Competact |
| נימוק / הערה | רק טיפול כרוני קבוע. סיכון אי-ספיקת לב ובצקות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | HbA1c מתועד | נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | HbA1c יציב | משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים, B12 (ב-24 החודשים האחרונים), תפקודי כבד (ALT). חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 6 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <45 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים | |
| 7 | תפקודי כבד (ALT) תקין | בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חמור: ALT מעל פי 2.5 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התוויות נגד |
| 8 | טיפול כרוני | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע. | |
| 9 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 10 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 11 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 12 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 13 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון; אי-ספיקת לב; סרטן שלפוחית השתן (פעיל או בעבר). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התוויות נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR, שומנים ו-ALT שנתי; HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי; B12 כל שנתיים |
| ספי החזרה לרופא/ה | eGFR <45 |
| ערך חמור | ALT מעל פי 2.5 מהגבול העליון; eGFR <30 |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון; אי-ספיקת לב; סרטן שלפוחית השתן (פעיל או בעבר) |
| תלונות בפנייה או ברשומה | בצקות ברגליים או קוצר נשימה ← לרופא (חשד לאי-ספיקת לב); עלייה מהירה במשקל ← לרופא; דם בשתן ← לרופא; שלשולים או אי-נוחות בטן מתמשכים ← לרופא לשקול תכשיר XR או הפחתה; הקאות, שלשול חריף או התייבשות ← הפסקה זמנית, לרופא |
| מקור | ADA פרק 9 עמ' 195; קווי הכוונה עמ' 56; ADA פרק 9 עמ' 197, 205; קווי הכוונה עמ' 42; מעקב: SPS Medicines Monitoring (NHS) · SPS Medicines Monitoring |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.15 סמגלוטייד בהזרקה · Semaglutide לפי הנחיה

אגוניסט GLP-1

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | אוזמפיק · Ozempic \| וויגובי · Wegovy (התוויה להשמנה) |
| נימוק / הערה | תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: סוכרת (אוזמפיק), השמנה (וגובי), מניעה קרדיווסקולרית. הזרקה שבועית; ללא היפוגליקמיה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | משקל מתועד | מדידת משקל מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 5 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <15 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 10 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר; סרטן מדולרי של בלוטת התריס או MEN2 (אישי או במשפחה). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי |
| ספי החזרה לרופא/ה | eGFR <15 |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר; סרטן מדולרי של בלוטת התריס או MEN2 (אישי או במשפחה) |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב בטן עליון חזק (חשד לדלקת לבלב) ← הפסקה, דחוף; הקאות או שלשולים מתמשכים ← לרופא; כאב בבטן הימנית העליונה (חשד לאבנים בכיס המרה) ← לרופא |
| מקור | ADA פרק 9 עמ' 194-195, 199; קווי הכוונה עמ' 49; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.16 **סמגלוטייד פומי** · Semaglutide (oral) לפי הנחיה

אגוניסט GLP-1

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | ריבלסוס · Rybelsus |
| נימוק / הערה | ללא היפוגליקמיה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | HbA1c מתועד | נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | HbA1c יציב | משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 6 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <15 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר; סרטן מדולרי של בלוטת התריס או MEN2 (אישי או במשפחה). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי |
| ספי החזרה לרופא/ה | eGFR <15 |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר; סרטן מדולרי של בלוטת התריס או MEN2 (אישי או במשפחה) |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב בטן עליון חזק (חשד לדלקת לבלב) ← הפסקה, דחוף; הקאות או שלשולים מתמשכים ← לרופא; כאב בבטן הימנית העליונה (חשד לאבנים בכיס המרה) ← לרופא |
| מקור | ADA פרק 9 עמ' 194-195, 199; קווי הכוונה עמ' 49; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.17 דולגלוטייד · Dulaglutide לפי הנחיה

אגוניסט GLP-1

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | טרוליסיטי · Trulicity |
| נימוק / הערה | הזרקה שבועית; ללא היפוגליקמיה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | HbA1c מתועד | נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | HbA1c יציב | משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 6 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <15 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר; סרטן מדולרי של בלוטת התריס או MEN2 (אישי או במשפחה). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי |
| ספי החזרה לרופא/ה | eGFR <15 |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר; סרטן מדולרי של בלוטת התריס או MEN2 (אישי או במשפחה) |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב בטן עליון חזק (חשד לדלקת לבלב) ← הפסקה, דחוף; הקאות או שלשולים מתמשכים ← לרופא; כאב בבטן הימנית העליונה (חשד לאבנים בכיס המרה) ← לרופא |
| מקור | ADA פרק 9 עמ' 194-195, 199; קווי הכוונה עמ' 49; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.18 טירזפטייד · Tirzepatide לפי הנחיה

אגוניסט כפול GIP/GLP-1

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | מאונג'רו · Mounjaro |
| נימוק / הערה | תרופה עם כמה התוויות: נבדקים רק תנאים משותפים לכל ההתוויות. יעד הטיפול (ל"ד, HbA1c, משקל) נבדק ע"י הרופא/ה בביקורת. התוויות: סוכרת, השמנה. הזרקה שבועית; ללא היפוגליקמיה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | משקל מתועד | מדידת משקל מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר; סרטן מדולרי של בלוטת התריס או MEN2 (אישי או במשפחה). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון; דלקת לבלב בעבר; סרטן מדולרי של בלוטת התריס או MEN2 (אישי או במשפחה) |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב בטן עליון חזק (חשד לדלקת לבלב) ← הפסקה, דחוף; הקאות או שלשולים מתמשכים ← לרופא; כאב בבטן הימנית העליונה (חשד לאבנים בכיס המרה) ← לרופא |
| מקור | ADA פרק 9 עמ' 194-195, 211-212 (אינו בקווי ההכוונה 2021); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.19 גלימפיריד · Glimepiride לפי הנחיה, בתנאים

סולפונילאוריאה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | אמריל · Amaryl \| גלימפירייד טבע · Glimepiride Teva |
| נימוק / הערה | רק טיפול כרוני קבוע. סיכון להיפוגליקמיה: נדרש HbA1c בטווח וללא היפוגליקמיה מתועדת; eGFR <60 = ערך חמור, כמו גליבנקלמיד (8.11.2026) |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | HbA1c מתועד | נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | HbA1c יציב | משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר, או ערך מתחת ל-6.5% (תרופה שגורמת להיפוגליקמיה) ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אין היפוגליקמיה מתועדת | ברשומה מאז הביקור האחרון אין תיעוד של סוכר מתחת ל-70 מ"ג/ד"ל, פנייה למיון או טיפול בגלוקגון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 7 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חמור: eGFR <60 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התוויות נגד |
| 8 | טיפול כרוני | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע. | |
| 9 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 10 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 11 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 12 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 13 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התוויות נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי |
| ערך חמור | eGFR <60 |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון |
| תלונות בפנייה או ברשומה | אירועי היפוגליקמיה ← לרופא להפחתה או החלפה; עלייה ניכרת במשקל ← לרופא |
| מקור | ADA פרק 6 עמ' 141, 145-144; פרק 9 עמ' 195; קווי הכוונה עמ' 54; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.20 גליבנקלמיד · Glibenclamide

לפי הנחיה, בתנאים

סולפונילאוריאה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | גלובן · Gluben \| גליבטיק · Glibetic (לאימות מול מאגר משרד הבריאות) |
| נימוק / הערה | רק טיפול כרוני קבוע. סיכון להיפוגליקמיה: נדרש HbA1c בטווח וללא היפוגליקמיה מתועדת; הסיכון הגבוה בקבוצה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | HbA1c מתועד | נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | HbA1c יציב | משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר, או ערך מתחת ל-6.5% (תרופה שגורמת להיפוגליקמיה) ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אין היפוגליקמיה מתועדת | ברשומה מאז הביקור האחרון אין תיעוד של סוכר מתחת ל-70 מ"ג/ד"ל, פנייה למיון או טיפול בגלוקגון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 7 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חמור: eGFR <60 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התוויות נגד |
| 8 | טיפול כרוני | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע. | |
| 9 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 10 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 11 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 12 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 13 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התוויות נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי |
| ערך חמור | eGFR <60 |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון |
| תלונות בפנייה או ברשומה | אירועי היפוגליקמיה ← לרופא להפחתה או החלפה; עלייה ניכרת במשקל ← לרופא |
| מקור | ADA פרק 6 עמ' 141, 144-145; פרק 9 עמ' 195; קווי הכוונה עמ' 54; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.21 רפגליניד · Repaglinide לפי הנחיה, בתנאים

מגליטיניד

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | נובונורם · NovoNorm \| רפאגליניד טבע · Repaglinide Teva \| ריפאליד · Ripalid |
| נימוק / הערה | רק טיפול כרוני קבוע. סיכון להיפוגליקמיה: נדרש HbA1c בטווח וללא היפוגליקמיה מתועדת |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | HbA1c מתועד | נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | HbA1c יציב | משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר, או ערך מתחת ל-6.5% (תרופה שגורמת להיפוגליקמיה) ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אין היפוגליקמיה מתועדת | ברשומה מאז הביקור האחרון אין תיעוד של סוכר מתחת ל-70 מ"ג/ד"ל, פנייה למיון או טיפול בגלוקגון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 7 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <30 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 8 | טיפול כרוני | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע. | |
| 9 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 10 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 11 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 12 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 13 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי |
| ספי החזרה לרופא/ה | eGFR <30 |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון |
| תלונות בפנייה או ברשומה | אירועי היפוגליקמיה ← לרופא להפחתה או החלפה |
| מקור | ADA פרק 6 עמ' 145-144; קווי הכוונה עמ' 54; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.22 פיוגליטזון · Pioglitazone לפי הנחיה, בתנאים

תיאזולידינדיון

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | אקטוס · Actos \| פיוגליטזון טבע · Pioglitazone Teva \| פיוגליטזון אינובמד · Pioglitazone Inovamed |
| נימוק / הערה | רק טיפול כרוני קבוע. סיכון אי-ספיקת לב, בצקות ושברים |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | HbA1c מתועד | נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | HbA1c יציב | משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים, תפקודי כבד (ALT). חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 6 | תפקודי כבד (ALT) תקין | בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חמור: ALT מעל פי 2.5 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התוויית נגד |
| 7 | טיפול כרוני | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע. | |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 12 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון; אי-ספיקת לב; סרטן שלפוחית השתן (פעיל או בעבר). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התוויית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR, שומנים ו-ALT שנתי |
| ערך חמור | ALT מעל פי 2.5 מהגבול העליון |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון; אי-ספיקת לב; סרטן שלפוחית השתן (פעיל או בעבר) |
| תלונות בפנייה או ברשומה | בצקות ברגליים או קוצר נשימה ← לרופא (חשד לאי-ספיקת לב); עלייה מהירה במשקל ← לרופא; דם בשתן ← לרופא |
| מקור | ADA פרק 9 עמ' 195; קווי הכוונה עמ' 56; מעקב: SPS · SPS Medicines Monitoring (NHS) Medicines Monitoring |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.23 **אקרבוז** · Acarbose · לפי הנחיה

מעכב אלפא-גלוקוזידאז

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (2)** | אקרוז · Acrose \| פרנדאזה · Prandase (לאימות מול מאגר משרד הבריאות) |
| **נימוק / הערה** | ללא היפוגליקמיה בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | HbA1c מתועד | נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | HbA1c יציב | משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 10 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 11 | תפקודי כבד בשנה הראשונה | בשנה הראשונה לטיפול: ALT מ-3 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי |
| **מצבים שמוציאים מהפרוטוקול** | היריון או תכנון היריון |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | גזים או שלשולים שמגבילים את הטיפול ← לרופא לשקול החלפה |
| **מקור** | ADA פרק 6 עמ' 147; קווי הכוונה עמ' 55; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.24 **אינסולין גלרגין** · Insulin glargine לפי הנחיה, בתנאים

אינסולין בזאלי

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (4)** | לנטוס · Lantus | בסגלר · Basaglar | טוג'או · Toujeo | סמגלי · Semglee |
| **נימוק / הערה** | רק טיפול כרוני קבוע במינון קבוע. טיפול קבוע וכל הבדיקות תקינות ← חידוש ל-3 חודשים. כל חריגה ← חידוש לחודש באותו מינון והודעה לרופא/ה; לא נעצר ע"י רפואן. הרפואן לא משנה מינון. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | HbA1c מתועד | נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | HbA1c יציב | משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר, או ערך מתחת ל-6.5% (תרופה שגורמת להיפוגליקמיה) ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אין היפוגליקמיה מתועדת | ברשומה מאז הביקור האחרון אין תיעוד של סוכר מתחת ל-70 מ"ג/ד"ל, פנייה למיון או טיפול בגלוקגון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 7 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 8 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה (לא מפסיקים אינסולין). | |
| 9 | טיפול כרוני במינון קבוע | אינסולין מחודש ע"י רפואן רק כטיפול כרוני באותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. שינוי מינון או בקשה לשינוי ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 10 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 11 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 12 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 13 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי |
| **ספי החזרה לרופא/ה** | eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון) |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | אירועי היפוגליקמיה ← לרופא להתאמת מינון; גושים באזורי ההזרקה ← לאחות להדרכה |
| **מקור** | ADA פרק 6 עמ' 141, 144-147; פרק 9 עמ' 196, 200-201, 208; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.25 אינסולין דגלודק · Insulin degludec לפי הנחיה, בתנאים

אינסולין בזאלי

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | טרגלודק · Tregludec \| טרסיבה · Tresiba (לאימות מול מאגר משרד הבריאות) |
| נימוק / הערה | רק טיפול כרוני קבוע במינון קבוע. טיפול קבוע וכל הבדיקות תקינות ← חידוש ל-3 חודשים. כל חריגה ← חידוש לחודש באותו מינון והודעה לרופא/ה; לא נעצר ע"י רפואן. הרפואן לא משנה מינון. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | HbA1c מתועד | נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | HbA1c יציב | משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר, או ערך מתחת ל-6.5% (תרופה שגורמת להיפוגליקמיה) ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אין היפוגליקמיה מתועדת | ברשומה מאז הביקור האחרון אין תיעוד של סוכר מתחת ל-70 מ"ג/ד"ל, פנייה למיון או טיפול בגלוקגון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 7 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 8 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה (לא מפסיקים אינסולין). | |
| 9 | טיפול כרוני במינון קבוע | אינסולין מחודש ע"י רפואן רק כטיפול כרוני באותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. שינוי מינון או בקשה לשינוי ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 10 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 OP = 2 אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 11 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 12 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 13 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי |
| ספי החזרה לרופא/ה | eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון) |
| תלונות בפנייה או ברשומה | אירועי היפוגליקמיה ← לרופא להתאמת מינון; גושים באזורי ההזרקה ← לאחות להדרכה |
| מקור | ADA פרק 6 עמ' 141, 144-147; פרק 9 עמ' 196, 200-201, 208; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.26 אינסולין דטמיר · Insulin detemir

לפי הנחיה, בתנאים

אינסולין בזאלי

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | לבמיר · Levemir |
| נימוק / הערה | רק טיפול כרוני קבוע במינון קבוע. טיפול קבוע וכל הבדיקות תקינות ← חידוש ל-3 חודשים. כל חריגה ← חידוש לחודש באותו מינון והודעה לרופא/ה; לא נעצר ע"י רפואן. הרפואן לא משנה מינון. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | HbA1c מתועד | נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | HbA1c יציב | משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר, או ערך מתחת ל-6.5% (תרופה שגורמת להיפוגליקמיה) ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אין היפוגליקמיה מתועדת | ברשומה מאז הביקור האחרון אין תיעוד של סוכר מתחת ל-70 מ"ג/ד"ל, פנייה למיון או טיפול בגלוקגון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 7 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 8 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה (לא מפסיקים אינסולין). | |
| 9 | טיפול כרוני במינון קבוע | אינסולין מחודש ע"י רפואן רק כטיפול כרוני באותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. שינוי מינון או בקשה לשינוי ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 10 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 11 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 12 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 13 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי |
| ספי החזרה לרופא/ה | eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון) |
| תלונות בפנייה או ברשומה | אירועי היפוגליקמיה ← לרופא להתאמת מינון; גושים באזורי ההזרקה ← לאחות להדרכה |
| מקור | ADA פרק 6 עמ' 141, 144-147; פרק 9 עמ' 196, 200-201, 208; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.27 אינסולין איקודק · Insulin icodec

לפי הנחיה, בתנאים

אינסולין בזאלי שבועי

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | אוויקלי · Awiqli |
| נימוק / הערה | רק טיפול כרוני קבוע במינון קבוע. טיפול קבוע וכל הבדיקות תקינות ← חידוש ל-3 חודשים. כל חריגה ← חידוש לחודש באותו מינון והודעה לרופא/ה; לא נעצר ע"י רפואן. הרפואן לא משנה מינון. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | HbA1c מתועד | נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | HbA1c יציב | משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר, או ערך מתחת ל-6.5% (תרופה שגורמת להיפוגליקמיה) ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אין היפוגליקמיה מתועדת | ברשומה מאז הביקור האחרון אין תיעוד של סוכר מתחת ל-70 מ"ג/ד"ל, פנייה למיון או טיפול בגלוקגון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 7 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 8 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה (לא מפסיקים אינסולין). | |
| 9 | טיפול כרוני במינון קבוע | אינסולין מחודש ע"י רפואן רק כטיפול כרוני באותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. שינוי מינון או בקשה לשינוי ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 10 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 11 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 12 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 13 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי |
| ספי החזרה לרופא/ה | eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון) |
| תלונות בפנייה או ברשומה | אירועי היפוגליקמיה ← לרופא להתאמת מינון; גושים באזורי ההזרקה ← לאחות להדרכה |
| מקור | ADA פרק 6 עמ' 141, 147-144; פרק 9 עמ' 196, 201-200, 208 |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.28 **אינסולין NPH** · Insulin NPH (human) לפי הנחיה, בתנאים

אינסולין בינוני (NPH)

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (1)** | אינסולטרד · Insulatard |
| **נימוק / הערה** | רק טיפול כרוני קבוע במינון קבוע. טיפול קבוע וכל הבדיקות תקינות ← חידוש ל-3 חודשים. כל חריגה ← חידוש לחודש באותו מינון והודעה לרופא/ה; לא נעצר ע"י רפואן. הרפואן לא משנה מינון. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | HbA1c מתועד | נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | HbA1c יציב | משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר, או ערך מתחת ל-6.5% (תרופה שגורמת להיפוגליקמיה) ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אין היפוגליקמיה מתועדת | ברשומה מאז הביקור האחרון אין תיעוד של סוכר מתחת ל-70 מ"ג/ד"ל, פנייה למיון או טיפול בגלוקגון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 7 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 8 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה (לא מפסיקים אינסולין). | |
| 9 | טיפול כרוני במינון קבוע | אינסולין מחודש ע"י רפואן רק כטיפול כרוני באותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. שינוי מינון או בקשה לשינוי ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 10 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 11 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 12 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 13 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי |
| **ספי החזרה לרופא/ה** | eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון) |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | אירועי היפוגליקמיה ← לרופא להתאמת מינון; גושים באזורי ההזרקה ← לאחות להדרכה |
| **מקור** | ADA פרק 6 עמ' 141, 144-147; פרק 9 עמ' 196, 200-201, 208; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.29 אינסולין אספרט · Insulin aspart

לפי הנחיה, בתנאים

אינסולין מהיר

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | נובורפיד · NovoRapid \| פיאספ · Fiasp |
| נימוק / הערה | רק טיפול כרוני קבוע במינון קבוע. טיפול קבוע וכל הבדיקות תקינות ← חידוש ל-3 חודשים. כל חריגה ← חידוש לחודש באותו מינון והודעה לרופא/ה; לא נעצר ע"י רפואן. הרפואן לא משנה מינון. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | HbA1c מתועד | נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | HbA1c יציב | משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר, או ערך מתחת ל-6.5% (תרופה שגורמת להיפוגליקמיה) ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אין היפוגליקמיה מתועדת | ברשומה מאז הביקור האחרון אין תיעוד של סוכר מתחת ל-70 מ"ג/ד"ל, פנייה למיון או טיפול בגלוקגון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 7 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 8 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה (לא מפסיקים אינסולין). | |
| 9 | טיפול כרוני במינון קבוע | אינסולין מחודש ע"י רפואן רק כטיפול כרוני באותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. שינוי מינון או בקשה לשינוי ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 10 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 11 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 12 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 13 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי |
| ספי החזרה לרופא/ה | eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון) |
| תלונות בפנייה או ברשומה | אירועי היפוגליקמיה ← לרופא להתאמת מינון; גושים באזורי ההזרקה ← לאחות להדרכה |
| מקור | ADA פרק 6 עמ' 141, 144-147; פרק 9 עמ' 196, 200-201, 208; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.30 **אינסולין ליספרו** · Insulin lispro · לפי הנחיה, בתנאים

אינסולין מהיר

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | הומלוג · Humalog \| ליומג'ב · Lyumjev |
| נימוק / הערה | רק טיפול כרוני קבוע במינון קבוע. טיפול קבוע וכל הבדיקות תקינות ← חידוש ל-3 חודשים. כל חריגה ← חידוש לחודש באותו מינון והודעה לרופא/ה; לא נעצר ע"י רפואן. הרפואן לא משנה מינון. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | HbA1c מתועד | נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | HbA1c יציב | משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר, או ערך מתחת ל-6.5% (תרופה שגורמת להיפוגליקמיה) ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אין היפוגליקמיה מתועדת | ברשומה מאז הביקור האחרון אין תיעוד של סוכר מתחת ל-70 מ"ג/ד"ל, פנייה למיון או טיפול בגלוקגון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 7 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 8 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה (לא מפסיקים אינסולין). | |
| 9 | טיפול כרוני במינון קבוע | אינסולין מחודש ע"י רפואן רק כטיפול כרוני באותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. שינוי מינון או בקשה לשינוי ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 10 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 11 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 12 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 13 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי |
| ספי החזרה לרופא/ה | eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון) |
| תלונות בפנייה או ברשומה | אירועי היפוגליקמיה ← לרופא להתאמת מינון; גושים באזורי ההזרקה ← לאחות להדרכה |
| מקור | ADA פרק 6 עמ' 141, 144-147; פרק 9 עמ' 196, 200-201, 208; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.31 **אינסולין גלוליזין** · Insulin glulisine · לפי הנחיה, בתנאים

אינסולין מהיר

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (1)** | אפידרה · Apidra |
| **נימוק / הערה** | רק טיפול כרוני קבוע במינון קבוע. טיפול קבוע וכל הבדיקות תקינות ← חידוש ל-3 חודשים. כל חריגה ← חידוש לחודש באותו מינון והודעה לרופא/ה; לא נעצר ע"י רפואן. הרפואן לא משנה מינון. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | HbA1c מתועד | נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | HbA1c יציב | משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר, או ערך מתחת ל-6.5% (תרופה שגורמת להיפוגליקמיה) ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אין היפוגליקמיה מתועדת | ברשומה מאז הביקור האחרון אין תיעוד של סוכר מתחת ל-70 מ"ג/ד"ל, פנייה למיון או טיפול בגלוקגון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 7 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 8 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה (לא מפסיקים אינסולין). | |
| 9 | טיפול כרוני במינון קבוע | אינסולין מחודש ע"י רפואן רק כטיפול כרוני באותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. שינוי מינון או בקשה לשינוי ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 10 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 11 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 12 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 13 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי |
| **ספי החזרה לרופא/ה** | eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון) |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | אירועי היפוגליקמיה ← לרופא להתאמת מינון; גושים באזורי ההזרקה ← לאחות להדרכה |
| **מקור** | ADA פרק 6 עמ' 141, 144-147; פרק 9 עמ' 196, 200-201, 208; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.32 **אינסולין רגיל** · Insulin regular (human) לפי הנחיה, בתנאים

אינסולין קצר

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (1)** | אקטרפיד · Actrapid |
| **נימוק / הערה** | רק טיפול כרוני קבוע במינון קבוע. טיפול קבוע וכל הבדיקות תקינות ← חידוש ל-3 חודשים. כל חריגה ← חידוש לחודש באותו מינון והודעה לרופא/ה; לא נעצר ע"י רפואן. הרפואן לא משנה מינון. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | HbA1c מתועד | נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | HbA1c יציב | משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר, או ערך מתחת ל-6.5% (תרופה שגורמת להיפוגליקמיה) ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אין היפוגליקמיה מתועדת | ברשומה מאז הביקור האחרון אין תיעוד של סוכר מתחת ל-70 מ"ג/ד"ל, פנייה למיון או טיפול בגלוקגון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 7 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 8 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה (לא מפסיקים אינסולין). | |
| 9 | טיפול כרוני במינון קבוע | אינסולין מחודש ע"י רפואן רק כטיפול כרוני באותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. שינוי מינון או בקשה לשינוי ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 10 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 11 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 12 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 13 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי |
| **ספי החזרה לרופא/ה** | eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון) |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | אירועי היפוגליקמיה ← לרופא להתאמת מינון; גושים באזורי ההזרקה ← לאחות להדרכה |
| **מקור** | ADA פרק 6 עמ' 141, 144-147; פרק 9 עמ' 196, 200-201, 208; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.33 **אינסולין מעורב** · Insulin premixed (לפי הנחיה, בתנאים)

אינסולין מעורב

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (4)** | נובומיקס 30 · NovoMix 30 \| הומלוג מיקס 25 · Humalog Mix 25 \| הומלוג מיקס 50 · Humalog Mix 50 \| מיקסטרד 30 · Mixtard 30 |
| **נימוק / הערה** | רק טיפול כרוני קבוע במינון קבוע. טיפול קבוע וכל הבדיקות תקינות ← חידוש ל-3 חודשים. כל חריגה ← חידוש לחודש באותו מינון והודעה לרופא/ה; לא נעצר ע"י רפואן. הרפואן לא משנה מינון. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | HbA1c מתועד | נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | HbA1c יציב | משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר, או ערך מתחת ל-6.5% (תרופה שגורמת להיפוגליקמיה) ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אין היפוגליקמיה מתועדת | ברשומה מאז הביקור האחרון אין תיעוד של סוכר מתחת ל-70 מ"ג/ד"ל, פנייה למיון או טיפול בגלוקגון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 7 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 8 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה (לא מפסיקים אינסולין). | |
| 9 | טיפול כרוני במינון קבוע | אינסולין מחודש ע"י רפואן רק כטיפול כרוני באותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. שינוי מינון או בקשה לשינוי ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 10 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 11 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 12 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 13 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי |
| **ספי החזרה לרופא/ה** | eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון) |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | אירועי היפוגליקמיה ← לרופא להתאמת מינון; גושים באזורי ההזרקה ← לאחות להדרכה |
| **מקור** | ADA פרק 6 עמ' 141, 147-144; פרק 9 עמ' 196, 201-200, 208; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.34 דגלודק + ליראגלוטייד · Insulin degludec + Liraglutide לפי הנחיה, בתנאים

אינסולין + GLP-1

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | זולטופיי · Xultophy |
| נימוק / הערה | רק טיפול כרוני קבוע במינון קבוע. טיפול קבוע וכל הבדיקות תקינות ← חידוש ל-3 חודשים. כל חריגה ← חידוש לחודש באותו מינון והודעה לרופא/ה; לא נעצר ע"י רפואן. הרפואן לא משנה מינון. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | HbA1c מתועד | נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | HbA1c יציב | משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר, או ערך מתחת ל-6.5% (תרופה שגורמת להיפוגליקמיה) ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אין היפוגליקמיה מתועדת | ברשומה מאז הביקור האחרון אין תיעוד של סוכר מתחת ל-70 מ"ג/ד"ל, פנייה למיון או טיפול בגלוקגון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 7 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 8 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה (לא מפסיקים אינסולין). | |
| 9 | טיפול כרוני במינון קבוע | אינסולין מחודש ע"י רפואן רק כטיפול כרוני באותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. שינוי מינון או בקשה לשינוי ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 10 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 11 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 12 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 13 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי |
| ספי החזרה לרופא/ה | eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון) |
| תלונות בפנייה או ברשומה | אירועי היפוגליקמיה ← לרופא להתאמת מינון; גושים באזורי ההזרקה ← לאחות להדרכה |
| מקור | ADA פרק 6 עמ' 141, 144-147; פרק 9 עמ' 196, 200-201, 208; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.35 גלרגין + ליקסיסנטייד · Insulin glargine + Lixisenatide

לפי הנחיה, בתנאים

אינסולין + GLP-1

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | סוליקווה · Suliqua |
| נימוק / הערה | רק טיפול כרוני קבוע במינון קבוע. טיפול קבוע וכל הבדיקות תקינות ← חידוש ל-3 חודשים. כל חריגה ← חידוש לחודש באותו מינון והודעה לרופא/ה; לא נעצר ע"י רפואן. הרפואן לא משנה מינון. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | HbA1c מתועד | נדרשת בדיקת HbA1c מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | HbA1c יציב | משווים את HbA1c האחרון לבדיקה הקודמת: עלייה של 0.5% או יותר, או ערך מתחת ל-6.5% (תרופה שגורמת להיפוגליקמיה) ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. HbA1c 10% ומעלה ← הודעה דחופה לרופא/ה באותו יום. אין בדיקה קודמת להשוואה ← הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אין היפוגליקמיה מתועדת | ברשומה מאז הביקור האחרון אין תיעוד של סוכר מתחת ל-70 מ"ג/ד"ל, פנייה למיון או טיפול בגלוקגון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה בבית המרקחת לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים (היענות לטיפול). פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, אלבומין/קריאטינין בשתן, שומנים. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 7 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 8 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה (לא מפסיקים אינסולין). | |
| 9 | טיפול כרוני במינון קבוע | אינסולין מחודש ע"י רפואן רק כטיפול כרוני באותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. שינוי מינון או בקשה לשינוי ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 10 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 11 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 12 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 13 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | HbA1c כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, ACR ושומנים שנתי |
| ספי החזרה לרופא/ה | eGFR <30 (צורך בהפחתת מינון) |
| תלונות בפנייה או ברשומה | אירועי היפוגליקמיה ← לרופא להתאמת מינון; גושים באזורי ההזרקה ← לאחות להדרכה |
| מקור | ADA פרק 6 עמ' 141, 144-147; פרק 9 עמ' 196, 200-201, 208; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.36 **לבותירוקסין** · Levothyroxine לפי הנחיה

בלוטת התריס · הורמון בלוטת התריס

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (4)** | אלטרוקסין · Eltroxin \| יוטירוקס · Euthyrox \| סינתרואיד · Synthroid \| אל-טירוקסין סרב · L-Thyroxine Serb (טיפות) |
| **נימוק / הערה** | מעקב TSH שנתי; היריון ← הודעה דחופה, לא מפסיקים |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **TSH מתועד** | בדיקה מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | **TSH בטווח** | בטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | **אין היריון** | אין היריון או תכנון היריון. יש ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה (לא מפסיקים את הטיפול). | |
| 4 | **רכישות** | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | TSH שנתי |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | דפיקות לב, ירידה במשקל או רעד ← לרופא |
| **מקור** | מעקב: SPS Medicines Monitoring · SPS Medicines Monitoring (NHS) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.37 **הידרוקורטיזון (תחליפי)** · Hydrocortisone (replacement) לפי הנחיה, בתנאים

אי-ספיקת אדרנל

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (3)** | הידרוקורטיזון · Hydrocortisone \| אלקינדי · Alkindi \| אפמודי · Efmody |
| **נימוק / הערה** | אסור להפסיק. מינון כפול בזמן מחלה; הקאות ← זריקה ומיון |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **הנחיות מחלה מתועדות** | יש תיעוד של הסבר על הכפלת מינון בזמן מחלה ותעודת מטופל. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | **רכישות** | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | **טיפול כרוני במינון קבוע** | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י אנדוקרינולוג/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | הקאות, שלשולים או חולשה קשה ← דחוף - מיון; חום ← לרופא - הכפלת מינון |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · FDA (DailyMed) עלון |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.38 **אלפקלצידול** · Alfacalcidol לפי הנחיה, בתנאים

ויטמין D פעיל

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (1)** | אלפא די · Alpha D3 |
| **נימוק / הערה** | סידן גבוה; נקבע ע"י נפרולוג/ית או אנדוקרינולוג/ית בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **סידן וקריאטינין מתועדים** | סידן וקריאטינין מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | **סידן לא גבוה** | סידן בטווח המעבדה או נמוך ממנו (סידן גבוה = לא מחדשים). לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 3 | **רכישות** | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | **טיפול כרוני במינון קבוע** | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ה מומחה/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 10 | **סידן ופוספט** | סידן ופוספט מ-3 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | סידן וקריאטינין כל 6 חודשים |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | צמא, בחילות או בלבול ← דחוף - סידן |
| **מקור** | מעקב: SPS Medicines Monitoring · SPS Medicines Monitoring (NHS) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.39 **סינקלצט** · Cinacalcet לפי הנחיה, בתנאים

קלצימימטי

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (2)** | סינאקלסט תרו · Cinacalcet Taro \| סינאקלצט תרימה · Cinacalcet Trima |
| **נימוק / הערה** | סידן נמוך; נקבע ע"י נפרולוג/ית או אנדוקרינולוג/ית |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **סידן מתועד** | סידן מ-3 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | **סידן לא נמוך** | סידן בטווח המעבדה (סידן נמוך = לא מחדשים). לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 3 | **רכישות** | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | **טיפול כרוני במינון קבוע** | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ה מומחה/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | סידן כל 3 חודשים |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | עוויתות או נימול ← דחוף |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · FDA (DailyMed) עלון |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.40 קברגולין · Cabergoline לפי הנחיה, בתנאים

אגוניסט לדופמין

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | דוסטינקס · Dostinex \| קבותרים · Cabotrim |
| נימוק / הערה | פרולקטין; במינון גבוה (מעל 2 מ"ג בשבוע) - אקו לב |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | פרולקטין מתועד | פרולקטין מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | אקו לב מתועד<br>שאלה: מינון מעל 2 מ"ג בשבוע? | אקו לב מ-24 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 3 | אין התנהגות כפייתית מתועדת | ברשומה או בפנייה אין הימורים, קניות כפייתיות או שינוי בהתנהגות המינית. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י אנדוקרינולוג/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | פרולקטין שנתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | קוצר נשימה או בצקות ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.41 דסמופרסין · Desmopressin לפי הנחיה, בתנאים

אנלוג ADH

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (5) | מינירין · Minirin | מינירין מלט · Minirin Melt | דסמופרסין טבע · Desmopressin Teva | דסמופרסין אס.קיי · Desmopressin S.K. | דסמופרסין סנדוז · Desmopressin Sandoz |
| נימוק / הערה | נתרן נמוך, בעיקר בגיל 65+ בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | נתרן מתועד | נתרן מ-6 החודשים האחרונים (גיל 65+: מ-3 החודשים האחרונים). אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | נתרן (Na) תקין | בבדיקה האחרונה נתרן (Na) תקין. חריג: Na מתחת ל-135 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: Na מתחת ל-130 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: Na מתחת ל-130 ← לא מחדשים | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 10 | פינוי קריאטינין 50 ומעלה | פינוי קריאטינין (או eGFR) מהשנה האחרונה 50 ומעלה. לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | נתרן כל 6 חודשים (גיל 65+: כל 3 חודשים) |
| ספי החזרה לרופא/ה | Na מתחת ל-135 |
| ערך חמור | Na מתחת ל-130 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב ראש, בחילה או בלבול ← דחוף - נתרן |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.42 **הורמון גדילה** · Growth hormone דגל אדום

אנדוקרינולוגיה

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (3)** | גנוטרופין · Genotropin \| נורדיטרופין · Norditropin \| אנג'נלה · Ngenla |
| **נימוק / הערה** | הורמון גדילה נקבע ומנוטר ע"י אנדוקרינולוג/ית (לרוב ילדים). הרפואן מכין עם ההנחיה העדכנית, והרופא/ה מאשר/ת. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **רכישות** | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | **טיפול כרוני במינון קבוע** | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני במינון קבוע שנקבע ע"י מומחה/ית. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | **הנחיה עדכנית של האנדוקרינולוג/ית** | מכתב או סיכום של האנדוקרינולוג/ית מ-12 החודשים האחרונים, עם אותה תרופה ומינון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | **בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו** | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **מקור** | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.43 **אורליסטט** · Orlistat · לפי הנחיה

השמנה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | קסניקל · Xenical |
| נימוק / הערה | תועלת צנועה; תופעות במערכת העיכול |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | משקל מתועד | מדידת משקל מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | ירידה במשקל | ירידה של 5% לפחות מתחילת הטיפול (אחרי 3 חודשים). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | אין התווית נגד | תת-ספיגה כרונית; כולסטזיס. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | משקל כל 6-3 חודשים |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | תת-ספיגה כרונית; כולסטזיס |
| תלונות בפנייה או ברשומה | שלשולים שומניים קשים ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.44 פנטרמין · Phentermine דגל אדום

השמנה · ממריץ

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | רזין · Razin |
| נימוק / הערה | פנטרמין (רזין) הוא ממריץ במרשם מיוחד, לטווח קצר. הרפואן מכין עם משקל, לחץ דם ומשך הטיפול עד כה, והרופא/ה מאשר/ת. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | משקל עדכני | משקל מתועד מהחודש האחרון. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | לחץ דם ודופק | מדידת לחץ דם ודופק מהחודש האחרון. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 3 | משך הטיפול עד כה | תאריך תחילת הטיפול ומספר החודשים מאז מתועדים בסיכום לרופא/ה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | משקל, לחץ דם ודופק מהחודש האחרון |
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.45 אנלוגים לסומטוסטטין ופגויזומנט · Somatostatin analogues / pegvisomant דגל אדום

אנדוקרינולוגיה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (9) | אוקטראוסטט · Octreostat \| אוקטריאוטייד בנדליס · Octreotide Bendalis \| אולתוטון · Olatuton \| סנדוסטטין · Sandostatin \| סנדוסטטין לאר · Sandostatin Lar \| לנראותיד תרו · Lanreotide Taro \| סומטולין אוטוג'ל · Somatuline Autogel \| סומאברט · Somavert \| סיגניפור לאר · Signifor Lar |
| נימוק / הערה | אנלוגים לסומטוסטטין ופגויזומנט נקבעים ע"י אנדוקרינולוג/ית או אונקולוג/ית. הרפואן מכין עם המכתב העדכני, והרופא/ה מאשר/ת. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני במינון קבוע שנקבע ע"י מומחה/ית. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | הנחיה עדכנית של המומחה/ית המטפל/ת | מכתב או סיכום של המומחה/ית המטפל/ת מ-12 החודשים האחרונים, עם אותה תרופה ומינון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 2.46 גלוקגון — ערכת חירום להיפוגליקמיה (גלוקגן היפוקיט) · Glucagon (rescue kit) לפי הנחיה, בתנאים

סוכרת · ערכת חירום

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | גלוקגן היפוקיט · GlucaGen HypoKit |
| נימוק / הערה | ערכת חירום להיפוגליקמיה קשה. מחדשים למטופל/ת באינסולין או בסולפונילאוריאה, כשהערכה הקודמת נוצלה או שפג תוקפה. שימוש בערכה = היפוגליקמיה קשה: הרופא/ה צריך/ה לדעת. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 2 | טיפול באינסולין או בסולפונילאוריאה | ברשימת התרופות יש אינסולין או סולפונילאוריאה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | הערכה הקודמת נוצלה או שפג תוקפה | בפנייה: הערכה נוצלה, פג תוקפה, או שזו ערכה ראשונה שהרופא/ה המליץ/ה עליה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | אם הערכה נוצלה: האירוע דווח לרופא/ה | אם הערכה נוצלה — הרופא/ה יודע/ת על אירוע ההיפוגליקמיה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| תלונות בפנייה או ברשומה | היפוגליקמיה קשה, אובדן הכרה או פרכוס ← דחוף — מד"א 101 |
| מקור | פער מול הרג'יסטרי, החלטה מקומית (8.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.47 **מתימזול** · Methimazole

מעקב צמוד | לפי הנחיה, בתנאים

נוגד פעילות יתר של התריס

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | מרקפטיזול · Mercaptizol |
| נימוק / הערה | TSH ו-T4 חופשי; חום או כאב גרון ← ספירת דם דחופה (אגרנולוציטוזיס) |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | TSH ו-T4 חופשי מתועדים | מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | TSH בטווח | TSH בטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | תפקודי כבד (ALT) תקין | בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 4 | אין חום או זיהום מתועד | ברשומה או בפנייה אין חום, כאב גרון, פצעים בפה או זיהום. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 5 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 6 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 8 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ה מומחה/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 9 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 10 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 11 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 12 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | TSH ו-T4 חופשי כל 6 חודשים; ALT |
| ספי החזרה לרופא/ה | ALT מעל פי 3 מהגבול העליון |
| תלונות בפנייה או ברשומה | חום, כאב גרון או פצעים בפה ← דחוף - ספירת דם היום; פריחה או גרד ← לרופא; צהבת או שתן כהה ← דחוף |
| מקור | מעקב: SPS Medicines Monitoring · SPS Medicines Monitoring (NHS) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.48 פרופילתיאוראציל (PTU) · Propylthiouracil

מעקב צמוד | לפי הנחיה, בתנאים

נוגד פעילות יתר של התריס

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | פרופיל תיוציל · Propyl-Thiocil |
| נימוק / הערה | TSH ו-T4 חופשי; סיכון לפגיעה כבדית; חום ← ספירת דם דחופה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | TSH, T4 חופשי ו-ALT מתועדים | מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | TSH בטווח | TSH בטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | תפקודי כבד (ALT) תקין | בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 2 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← לא מחדשים | |
| 4 | אין חום או זיהום מתועד | ברשומה או בפנייה אין חום, כאב גרון, פצעים בפה או זיהום. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 5 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 6 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 8 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ה מומחה/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 9 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 10 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 11 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 12 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | TSH, T4 חופשי ו-ALT כל 6 חודשים |
| ספי החזרה לרופא/ה | ALT מעל פי 2 מהגבול העליון |
| ערך חמור | ALT מעל פי 3 מהגבול העליון |
| תלונות בפנייה או ברשומה | חום, כאב גרון או פצעים בפה ← דחוף - ספירת דם היום; צהבת, שתן כהה או כאבי בטן ← דחוף |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.49 טסטוסטרון · Testosterone לפי הנחיה, בתנאים מעקב צמוד

הורמון גברי

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (5) | אנדרוג'ל · Androgel \| נבידו · Nebido \| טסטווירון דפו · Testoviron Depot \| טסטומקס · Testomax \| טסטוסטרון טבע · Testosterone Teva |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י רופא/ה או אנדוקרינולוג/ית. המטוקריט ו-PSA |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | בדיקות מתועדות | המטוקריט, PSA ורמת טסטוסטרון מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | המטוקריט (Hct) תקין | בבדיקה האחרונה המטוקריט (Hct) תקין. חריג: Hct מעל 50% ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: Hct מעל 54% ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: Hct מעל 54% ← לא מחדשים | |
| 3 | PSA תקין | PSA מתחת ל-4 ולא עלה ב-1.4 ומעלה לעומת הקודם. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | אין התווית נגד | סרטן ערמונית או שד. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | המטוקריט, PSA ורמת טסטוסטרון שנתי |
| ספי החזרה לרופא/ה | Hct מעל 50% |
| ערך חמור | Hct מעל 54% |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | סרטן ערמונית או שד |
| תלונות בפנייה או ברשומה | קשיי השתנה חדשים ← לרופא; כאב ונפיחות ברגל ← דחוף |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.50 פרדניזון (טיפול כרוני) · Prednisone (chronic)

לפי הנחיה, בתנאים | מעקב צמוד

סטרואיד

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | פרדניזון רקח · Prednisone Rekah |
| נימוק / הערה | לא נעצר בפתאומיות (סיכון לאי-ספיקת אדרנל). מעקב סוכר, ל"ד ועצם בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מעקב מתועד | גלוקוז/HbA1c ומדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים; צפיפות עצם מ-24 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | הגנה על העצם מתועדת | סידן וויטמין D (או ביספוספונט) ברשימת התרופות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | תוכנית מינון מתועדת | מינון ומשך מתועדים ע"י הרופא/ה; לא מפסיקים בפתאומיות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני שנקבע ע"י רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | בדיקת עיניים | בדיקת עיניים ב-12 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 12 | HbA1c, אשלגן וטריגליצרידים | HbA1c מ-3 החודשים האחרונים; אשלגן וטריגליצרידים מהשנה האחרונה. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | גלוקוז/HbA1c ול"ד שנתי; צפיפות עצם כל שנתיים |
| תלונות בפנייה או ברשומה | חום או זיהום ← לרופא; כאב בטן עליון או צואה שחורה ← דחוף |
| מקור | מעקב: SPS Medicines Monitoring (NHS) · SPS Medicines Monitoring |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 2.51 מתילפרדניזולון (טיפול כרוני) · Methylprednisolone (chronic) לפי הנחיה, בתנאים מעקב צמוד

סטרואיד

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | מדרול · Medrol |
| נימוק / הערה | לא נעצר בפתאומיות (סיכון לאי-ספיקת אדרנל). מעקב סוכר, ל"ד ועצם בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מעקב מתועד | גלוקוז/HbA1c ומדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים; צפיפות עצם מ-24 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | הגנה על העצם מתועדת | סידן וויטמין D (או ביספוספונט) ברשימת התרופות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | תוכנית מינון מתועדת | מינון ומשך מתועדים ע"י הרופא/ה; לא מפסיקים בפתאומיות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני שנקבע ע"י רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | בדיקת עיניים | בדיקת עיניים ב-12 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 12 | HbA1c, אשלגן וטריגליצרידים | HbA1c מ-3 החודשים האחרונים; אשלגן וטריגליצרידים מהשנה האחרונה. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | גלוקוז/HbA1c ול"ד שנתי; צפיפות עצם כל שנתיים |
| תלונות בפנייה או ברשומה | חום או זיהום ← לרופא; כאב בטן עליון או צואה שחורה ← דחוף |
| מקור | מעקב: SPS Medicines Monitoring (NHS) · SPS Medicines Monitoring |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

# 3. נשימה ואלרגיה

30 תרופות · לפי הנחיה: 17 · לפי הנחיה, בתנאים: 12 · הכנה לאישור רופא/ה: 1 · גרסה 2 · חלוקה לפי מערכות · 2.11.2026

מקורות: GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט). שאר הערכים: החלטה מקומית; הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020; ACOG 2023 (סיכום AFP). שאר התחומים: החלטה מקומית

## 3.א כללים

- חידוש רגיל: 3 חודשים
- ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה פעם בשנה
- עד 3 חידושים רצופים, ואז ביקור רופא
- אין התווית נגד ← תמיד מחדשים לפחות לחודש אחד
- חסרה מדידה, בדיקה או ביקורת שנתית: חידוש לחודש אחד + זימון למרפאה
- חריגה מספי ההחזרה: חידוש לחודש אחד + הודעה לרופא/ה
- התווית נגד או ערך חמור: לא מחדשים, הודעה לרופא/ה (הסף של כל תרופה מופיע ברשימה שלה)
- רפואן לא משנה מינון ולא מחליף תרופה. "מעקב צמוד" = תרופה עם מעקב תכוף (מעבדה, אק"ג, עיניים או צילום) — לבדוק כל ערך בקפידה
- 3 משאפי הרגעה ומעלה בשנה או התקף ב-12 החודשים האחרונים: חודש + הודעה
- LABA או LAMA-LABA בלי סטרואיד אצל מטופל/ת עם אסתמה: חודש + הודעה דחופה
- משאף הרגעה לפי הצורך: לא בודקים כיסוי רכישות, אלא כמות משאפים בשנה
- דגל אדום: הרפואן מכין לפי רשימת הבדיקות, והרופא/ה בודק/ת שוב לפני האישור — גם כשהכול תקין

## 3.ג בדיקות משותפות

| שלב | נושא | מה בודקים | קריטריון | אם לא מתקיים | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| לפני כל חידוש | משאפי הרגעה | כמה משאפי SABA נרכשו ב-12 החודשים האחרונים | פחות מ-3 | 3 ומעלה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה | GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט) עמ' 13 |
| לפני כל חידוש | התקפים | קורס סטרואידים, מיון או אשפוז ב-12 החודשים האחרונים | אין | יש ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה | GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט) עמ' 37 |
| לפני כל חידוש | טיפול מונע | באסתמה: יש ICS ברשימה | LABA או LAMA-LABA בלי ICS רק ב-COPD | אסתמה בלי ICS ← חידוש לחודש + הודעה (דחופה אם LABA) | GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט) עמ' 26-27 |
| לפני כל חידוש | רכישות | כיסוי ימים ב-6 החודשים האחרונים (משאף מונע) | 80% מהימים ומעלה | פחות ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה | כמו ביל"ד |
| לפני כל חידוש | ביקורת שנתית | ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה | ב-12 החודשים האחרונים | אין ← חידוש לחודש + זימון לביקורת | כמו ביל"ד |
| החזרה מיידית לרופא | קוצר נשימה | מופיע בפנייה או ברשומה | קוצר נשימה במנוחה או קושי לדבר | דחוף - מיון | GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט) |
| לפני כל חידוש | רצף חידושים | כמה חידושים רצופים מאז ביקור רופא | פחות מ-3 | 3 ← ביקור רופא | כמו ביל"ד |

## 3.ד החלטות

| # | נושא | מה ההנחיה אומרת | ההחלטה לפרוטוקול | סוג | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| נשימה-1 | שימוש יתר ב-SABA | 3 משאפים ומעלה בשנה = גורם סיכון להתקפים; משאף בחודש ומעלה = סיכון למוות | 3 ומעלה ב-12 חודשים ← חידוש לחודש + הודעה | הנחיה | GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט) עמ' 13 |

| # | נושא | מה ההנחיה אומרת | ההחלטה לפרוטוקול | סוג | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| נשימה-2 | התקף בשנה האחרונה | יותר מקורס סטרואידים אחד בשנה ← הפניה למומחה | כל קורס סטרואידים, מיון או אשפוז ← חידוש לחודש + הודעה | החלטה מקומית (הצעה) | GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט) עמ' 37 |
| נשימה-3 | LABA בלי ICS | באסתמה תמיד טיפול שמכיל ICS; LABA לבד אסור | LABA או LAMA-LABA בלי ICS ובלי אבחנת COPD ← חידוש לחודש + הודעה דחופה | הנחיה | GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט) עמ' 26 |
| נשימה-4 | SABA בלבד | לא מומלץ באסתמה; עדיף ICS-פורמוטרול לפי הצורך | SABA בלי ICS ובלי COPD ← חידוש לחודש + הודעה | הנחיה | GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט) עמ' 26 |
| נשימה-5 | מונטלוקאסט | פחות יעיל מ-ICS; סיכון לתופעות נפשיות | תופעות נפשיות ← חידוש לחודש + הודעה דחופה | הנחיה | GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט) עמ' 27 |
| נשימה-6 | תאופילין | GINA לא ממליצה | רמה שנתית; מעל 15 ← הודעה; מעל 20 ← לא מחדשים | החלטה מקומית (הצעה) | GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט) עמ' 27 |
| נשימה-7 | אזיתרומיצין ממושך | לפני התחלה: אק"ג (QTc), תפקודי כבד ושלילת NTM בכיח; מעקב תקופתי | רק בהמלצת רופא/ת ריאות; אק"ג ו-ALT שנתי; QTc מוארך ← הודעה דחופה | החלטה מקומית (הצעה) | BTS 2020 (מקרולידים ממושכים); ERS 2017 |
| כללי-20 | השלמות מהמאגר (2.11.2026) | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) | טרזוסין, פינסטריד, אינקליסירן, ורדנאפיל, טיפות לגלאוקומה (ביקורת עיניים שנתית; טימולול: דופק ואסתמה), NSAID ממושך (כליות, אשלגן, ל"ד, דימום, הגנת קיבה), אנטיהיסטמינים, ציננריזין, דומפרידון, מבברין, סידן, מידודרין, פנטוקסיפילין, דיפירידמול, ולציקלוביר מונע, חומצה זולדרונית | החלטה מקומית (הצעה) | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| כללי-21 | תרופות מומחה נוספות | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי). הטיפול נקבע ומנוטר ע"י המומחה | מטוקלופרמיד ממושך, ממריצים/מודפיניל, טרשת נפוצה, אונקולוגיה, יל"ד ריאתי/IPF, סירולימוס, הורמון גדילה, המטולוגיה, CF, טפמידיס/מבקמטן: הודעה בלבד, חידוש ע"י רופא/ה. תרופות ביולוגיות בזריקה בקהילה: הרפואן מכין (אישור, מכתב מומחה, מרווח, בטיחות) והרופא/ה מאשר/ת (5.11.2026) | החלטה מקומית | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| סקירה-1 | סקירת פריטים חסומים (7.11.2026) | נושא תפעולי — הנחיות קליניות לא עוסקות בו; מבוסס על נוהל הרפואן | אף תרופה לא חסומה כברירת מחדל. 59 הפריטים שהיו "רופא/ה בלבד" נסקרו אחד-אחד: חלקם פתוחים עם רשימת בדיקות, חלקם בדגל אדום (בדיקה כפולה מול הרופא/ה). נשארים אצל הרופא/ה: רואקוטן, אנטיביוטיקה לתסמין חדש (מלבד מוקסיפן/רפאפן אחרי משטח גרון חיובי) ותרופות נגד שפעת. התראת האינטראקציות של המערכת היא שכבת ההגנה הבסיסית. | החלטה מקומית (7.11.2026) | - |

## 3.ה רשימת התרופות (לסימון)

| # | שם | גנרי | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | פלוטיקזון (משאף) | Fluticasone (inhaled) | ICS · סטרואיד בשאיפה | לפי הנחיה | ☐ | |
| 3.2 | בקלומטזון (משאף) | Beclometasone (inhaled) | ICS · סטרואיד בשאיפה | לפי הנחיה | ☐ | |

| # | שם | גנרי | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | בודזוניד (אינהלציה) | Budesonide (nebulised) | ICS · סטרואיד בשאיפה | לפי הנחיה | ☐ | |
| 3.4 | בודזוניד + פורמוטרול | Budesonide + formoterol | ICS-LABA | לפי הנחיה | ☐ | |
| 3.5 | בקלומטזון + פורמוטרול | Beclometasone + formoterol | ICS-LABA | לפי הנחיה | ☐ | |
| 3.6 | פלוטיקזון + סלמטרול | Fluticasone + salmeterol | ICS-LABA | לפי הנחיה | ☐ | |
| 3.7 | פלוטיקזון + פורמוטרול | Fluticasone + formoterol | ICS-LABA | לפי הנחיה | ☐ | |
| 3.8 | פלוטיקזון פוראט + וילנטרול | Fluticasone furoate + vilanterol | ICS-LABA | לפי הנחיה | ☐ | |
| 3.9 | סלמטרול | Salmeterol | LABA בלבד | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 3.10 | פורמוטרול | Formoterol | LABA בלבד | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 3.11 | טיוטרופיום | Tiotropium | LAMA | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 3.12 | אומקלידיניום | Umeclidinium | LAMA | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 3.13 | גליקופירוניום (משאף) | Glycopyrronium (inhaled) | LAMA | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 3.14 | אומקלידיניום + וילנטרול | Umeclidinium + vilanterol | LAMA-LABA | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 3.15 | אינדקטרול + גליקופירוניום | Indacaterol + glycopyrronium | LAMA-LABA | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 3.16 | טיוטרופיום + אולודטרול | Tiotropium + olodaterol | LAMA-LABA | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 3.17 | פלוטיקזון + אומקלידיניום + וילנטרול | Fluticasone + umeclidinium + vilanterol | טיפול משולש (ICS-LAMA-LABA) | לפי הנחיה | ☐ | |
| 3.18 | בקלומטזון + פורמוטרול + גליקופירוניום | Beclometasone + formoterol + glycopyrronium | טיפול משולש (ICS-LAMA-LABA) | לפי הנחיה | ☐ | |
| 3.19 | בודזוניד + גליקופירוניום + פורמוטרול | Budesonide + glycopyrronium + formoterol | טיפול משולש (ICS-LAMA-LABA) | לפי הנחיה | ☐ | |
| 3.20 | סלבוטמול | Salbutamol | SABA · משאף הרגעה | לפי הנחיה | ☐ | |
| 3.21 | טרבוטלין | Terbutaline | SABA · משאף הרגעה | לפי הנחיה | ☐ | |
| 3.22 | איפרטרופיום | Ipratropium | SAMA · משאף הרגעה | לפי הנחיה | ☐ | |
| 3.23 | מונטלוקאסט | Montelukast | אנטגוניסט ללויקוטריאנים | לפי הנחיה | ☐ | |
| 3.24 | תאופילין | Theophylline | מתילקסנטין | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 3.25 | אזיתרומיצין (טיפול ממושך) | Azithromycin (long-term) | מקרוליד למניעת התלקחויות | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 3.26 | אנטיהיסטמינים (דור שני) | Antihistamines (2nd generation) | אלרגיה | לפי הנחיה | ☐ | |
| 3.27 | תרופות ליל"ד ריאתי ולפיברוזיס ריאתי | Pulmonary hypertension / IPF drugs | ריאות - מומחה | דגל אדום | ☐ | |

| # | שם | גנרי | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.28 | תרופות לסיסטיק פיברוזיס | Cystic fibrosis modulators | CF | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 3.29 | מזרק אדרנלין (אפיפן, ג'קסט) | Epinephrine auto-injector | אלרגיה · אנפילקסיס | לפי הנחיה | ☐ | |
| 3.30 | חיסון לאלרגיה (אקריזקס) | Allergen immunotherapy | אלרגיה · מומחה | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |

## 1.3 פירוט מלא

### 3.1 **פלוטיקזון (משאף)** · Fluticasone (inhaled) לפי הנחיה

ICS · סטרואיד בשאיפה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | פליקסוטייד דיסקוס · Flixotide Diskus \| פליקסוטייד משאף · Flixotide Inhaler |
| נימוק / הערה | טיפול מונע; שימוש יתר במשאף הרגעה או התקף ← הודעה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | פחות מ-3 משאפי הרגעה בשנה | ברכישות: פחות מ-3 משאפי הרגעה (ונטולין, סלבוטרים, בריקלין) ב-12 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | אין התקף ב-12 החודשים האחרונים | ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה) |
| מקור | GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 3.2 בקלומטזון (משאף) · Beclometasone (inhaled) לפי הנחיה

ICS · סטרואיד בשאיפה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | קיואר · Qvar |
| נימוק / הערה | טיפול מונע; שימוש יתר במשאף הרגעה או התקף ← הודעה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | פחות מ-3 משאפי הרגעה בשנה | ברכישות: פחות מ-3 משאפי הרגעה (ונטולין, סלבוטרים, בריקלין) ב-12 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | אין התקף ב-12 החודשים האחרונים | ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה) |
| מקור | GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 3.3 בודזוניד (אינהלציה) · Budesonide (nebulised) לפי הנחיה

ICS · סטרואיד בשאיפה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | בודיקורט רספולס · Budicort Respules \| בודזונייד סטרינבז טבע · Budesonide Sterinebs Teva |
| נימוק / הערה | טיפול מונע, בעיקר בילדים |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | פחות מ-3 משאפי הרגעה בשנה | ברכישות: פחות מ-3 משאפי הרגעה (ונטולין, סלבוטרים, בריקלין) ב-12 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | אין התקף ב-12 החודשים האחרונים | ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה) |
| מקור | GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 3.4 בודזוניד + פורמוטרול · Budesonide + formoterol לפי הנחיה

ICS-LABA

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | סימביקורט טורבוהלר · Symbicort Turbuhaler | דואורספ ספירומקס · Duoresp Spiromax | בודמול אס.קיי. · Budemol S.K. |
| נימוק / הערה | טיפול מונע ומרגיע (MART); שימוש תכוף מאוד ← הודעה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין התקף ב-12 החודשים האחרונים | ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 5 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 6 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 7 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה) |
| מקור | GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 3.5 בקלומטזון + פורמוטרול · Beclometasone + formoterol (לפי הנחיה)

ICS-LABA

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | פוסטר · Foster |
| נימוק / הערה | טיפול מונע ומרגיע (MART) |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין התקף ב-12 החודשים האחרונים | ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 POP = 2 אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 5 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 6 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 7 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה) |
| מקור | GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 3.6 פלוטיקזון + סלמטרול · Fluticasone + salmeterol לפי הנחיה

ICS-LABA

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | סרטייד דיסקוס · Seretide Diskus \| פלוסלמר אס.קיי. · Flusalmer S.K. |
| נימוק / הערה | טיפול מונע |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | פחות מ-3 משאפי הרגעה בשנה | ברכישות: פחות מ-3 משאפי הרגעה (ונטולין, סלבוטרים, בריקלין) ב-12 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | אין התקף ב-12 החודשים האחרונים | ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה) |
| מקור | GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 3.7 **פלוטיקזון + פורמוטרול** · Fluticasone + formoterol לפי הנחיה

ICS-LABA

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (1)** | פלוטיפורם · Flutiform |
| **נימוק / הערה** | טיפול מונע |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **פחות מ-3 משאפי הרגעה בשנה** | ברכישות: פחות מ-3 משאפי הרגעה (ונטולין, סלבוטרים, בריקלין) ב-12 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | **אין התקף ב-12 החודשים האחרונים** | ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | **רכישות** | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה) |
| **מקור** | GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 3.8 פלוטיקזון פוראט + וילנטרול · Fluticasone furoate + vilanterol (לפי הנחיה)

ICS-LABA

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | רלוואר אליפטה · Relvar Ellipta |
| נימוק / הערה | טיפול מונע |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | פחות מ-3 משאפי הרגעה בשנה | ברכישות: פחות מ-3 משאפי הרגעה (ונטולין, סלבוטרים, בריקלין) ב-12 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | אין התקף ב-12 החודשים האחרונים | ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה) |
| מקור | GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 3.9 סלמטרול · Salmeterol

לפי הנחיה, בתנאים

LABA בלבד

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | סרוונט דיסקוס · Serevent Diskus \| סרוונט משאף · Serevent Inhaler |
| נימוק / הערה | LABA בלי סטרואיד אסור באסתמה (סיכון למוות מאסתמה) |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין אסתמה מתועדת בלי משאף עם סטרואיד | אין אבחנת אסתמה ברשומה (למשל COPD בלבד), או שיש משאף עם סטרואיד (ICS) ברשימת התרופות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 2 | פחות מ-3 משאפי הרגעה בשנה | ברכישות: פחות מ-3 משאפי הרגעה (ונטולין, סלבוטרים, בריקלין) ב-12 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אין התקף ב-12 החודשים האחרונים | ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה) |
| מקור | GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 3.10 פורמוטרול · Formoterol לפי הנחיה, בתנאים

LABA בלבד

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | אוקסיס טורבוהלר · Oxis Turbuhaler \| פוראדיל · Foradil |
| נימוק / הערה | LABA בלי סטרואיד אסור באסתמה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין אסתמה מתועדת בלי משאף עם סטרואיד | אין אבחנת אסתמה ברשומה (למשל COPD בלבד), או שיש משאף עם סטרואיד (ICS) ברשימת התרופות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 2 | פחות מ-3 משאפי הרגעה בשנה | ברכישות: פחות מ-3 משאפי הרגעה (ונטולין, סלבוטרים, בריקלין) ב-12 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אין התקף ב-12 החודשים האחרונים | ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה) |
| מקור | GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 3.11 **טיוטרופיום** · Tiotropium לפי הנחיה, בתנאים

LAMA

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | ספיריבה · Spiriva \| ספיריבה רספימט · Spiriva Respimat |
| נימוק / הערה | COPD; באסתמה רק בתוספת ל-ICS-LABA |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין אסתמה מתועדת בלי משאף עם סטרואיד | אין אבחנת אסתמה ברשומה (למשל COPD בלבד), או שיש משאף עם סטרואיד (ICS) ברשימת התרופות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 2 | אין התקף ב-12 החודשים האחרונים | ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה); קושי במתן שתן ← לרופא; כאב עיניים או ראייה מטושטשת ← דחוף |
| מקור | GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 3.12 **אומקלידיניום** · Umeclidinium (לפי הנחיה, בתנאים)

LAMA

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | אינקרוז אליפטה · Incruse Ellipta |
| נימוק / הערה | COPD |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין אסתמה מתועדת בלי משאף עם סטרואיד | אין אבחנת אסתמה ברשומה (למשל COPD בלבד), או שיש משאף עם סטרואיד (ICS) ברשימת התרופות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 2 | אין התקף ב-12 החודשים האחרונים | ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה) |
| מקור | GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 3.13 גליקופירוניום (משאף) · Glycopyrronium (inhaled) לפי הנחיה, בתנאים

LAMA

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | ריברילה · Rybrila (לאימות מול מאגר משרד הבריאות) |
| נימוק / הערה | COPD |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין אסתמה מתועדת בלי משאף עם סטרואיד | אין אבחנת אסתמה ברשומה (למשל COPD בלבד), או שיש משאף עם סטרואיד (ICS) ברשימת התרופות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 2 | אין התקף ב-12 החודשים האחרונים | ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה) |
| מקור | GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 3.14 אומקלידיניום + וילנטרול · Umeclidinium + vilanterol לפי הנחיה, בתנאים

LAMA-LABA

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | אנורו אליפטה · Anoro Ellipta |
| נימוק / הערה | COPD בלבד; אסור באסתמה בלי ICS |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין אסתמה מתועדת בלי משאף עם סטרואיד | אין אבחנת אסתמה ברשומה (למשל COPD בלבד), או שיש משאף עם סטרואיד (ICS) ברשימת התרופות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 2 | אין התקף ב-12 החודשים האחרונים | ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה) |
| מקור | GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 3.15 **אינדקטרול + גליקופירוניום** · Indacaterol + glycopyrronium · לפי הנחיה, בתנאים
LAMA-LABA

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | אולטיברו בריזהלר · Ultibro Breezhaler |
| נימוק / הערה | COPD בלבד |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין אסתמה מתועדת בלי משאף עם סטרואיד | אין אבחנת אסתמה ברשומה (למשל COPD בלבד), או שיש משאף עם סטרואיד (ICS) ברשימת התרופות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 2 | אין התקף ב-12 החודשים האחרונים | ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה) |
| מקור | GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 3.16 טיוטרופיום + אולודטרול · Tiotropium + olodaterol

לפי הנחיה, בתנאים

LAMA-LABA

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | ספיולטו רספימט · Spiolto Respimat |
| נימוק / הערה | COPD בלבד |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין אסתמה מתועדת בלי משאף עם סטרואיד | אין אבחנת אסתמה ברשומה (למשל COPD בלבד), או שיש משאף עם סטרואיד (ICS) ברשימת התרופות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 2 | אין התקף ב-12 החודשים האחרונים | ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה) |
| מקור | GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 3.17 פלוטיקזון + אומקלידיניום + וילנטרול · Fluticasone + umeclidinium + vilanterol לפי הנחיה

טיפול משולש (ICS-LAMA-LABA)

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | טרלג'י אליפטה · Trelegy Ellipta |
| נימוק / הערה | COPD או אסתמה קשה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין התקף ב-12 החודשים האחרונים | ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 5 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 6 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 7 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה) |
| מקור | GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 3.18 בקלומטזון + פורמוטרול + גליקופירוניום · Beclometasone + formoterol + glycopyrronium לפי הנחיה

טיפול משולש (ICS-LAMA-LABA)

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | טרימבו · Trimbow |
| נימוק / הערה | COPD או אסתמה קשה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין התקף ב-12 החודשים האחרונים | ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 5 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 6 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 7 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה) |
| מקור | GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 3.19 בודזוניד + גליקופירוניום + פורמוטרול · Budesonide + glycopyrronium + formoterol לפי הנחיה

טיפול משולש (ICS-LAMA-LABA)

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | טריקסאו אירוספיר · Trixeo Aerosphere |
| נימוק / הערה | COPD |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין התקף ב-12 החודשים האחרונים | ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 5 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 6 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 7 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה) |
| מקור | GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 3.20 **סלבוטמול** · Salbutamol לפי הנחיה

SABA · משאף הרגעה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (5) | ונטולין משאף · Ventolin Inhaler \| ונטולין דיסקוס · Ventolin Diskus \| סלבוטרים · Salbutrim \| ונטולין תמיסה לאינהלציה · Ventolin Respirator Solution \| סלבוטק · Salbutec |
| נימוק / הערה | לפי הצורך. SABA בלבד באסתמה לא מומלץ; 3 משאפים ומעלה בשנה = לא מאוזן |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | משאף מונע עם סטרואיד ברשימה, או אבחנת COPD | ברשימת התרופות יש משאף עם סטרואיד (ICS), או שהאבחנה היא COPD. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | פחות מ-3 משאפי הרגעה בשנה | ברכישות: פחות מ-3 משאפי הרגעה (ונטולין, סלבוטרים, בריקלין) ב-12 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אין התקף ב-12 החודשים האחרונים | ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה; ספירת משאפים שנרכשו |
| תלונות בפנייה או ברשומה | קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה) |
| מקור | GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 3.21 **טרבוטלין** · Terbutaline לפי הנחיה

SABA · משאף הרגעה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | בריקלין טורבוהלר · Bricalin Turbuhaler \| טרבולין תמיסה לשאיפה · Terbulin Respiratory Solution \| טרבולין סירופ · Terbulin Syrup |
| נימוק / הערה | לפי הצורך. SABA בלבד באסתמה לא מומלץ |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | משאף מונע עם סטרואיד ברשימה, או אבחנת COPD | ברשימת התרופות יש משאף עם סטרואיד (ICS), או שהאבחנה היא COPD. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | פחות מ-3 משאפי הרגעה בשנה | ברכישות: פחות מ-3 משאפי הרגעה (ונטולין, סלבוטרים, בריקלין) ב-12 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אין התקף ב-12 החודשים האחרונים | ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה; ספירת משאפים שנרכשו |
| תלונות בפנייה או ברשומה | קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה) |
| מקור | GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 3.22 **איפרטרופיום** · Ipratropium לפי הנחיה

SAMA · משאף הרגעה

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (3)** | ארוונט · Aerovent \| איפרטרים · Ipratrim \| איירווייז תמיסה לאינהלציה · Airways Respiratory Solution |
| **נימוק / הערה** | COPD; לא יחד עם LAMA (טיוטרופיום ודומיו) |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין LAMA במקביל | ברשימת התרופות אין טיוטרופיום, אומקלידיניום או גליקופירוניום. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | אין התקף ב-12 החודשים האחרונים | ב-12 החודשים האחרונים אין קורס סטרואידים בבליעה, ביקור מיון או אשפוז בגלל קוצר נשימה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 5 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 6 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 7 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | קוצר נשימה בזמן מנוחה או קושי לדבר ← דחוף - מיון; שימוש במשאף הרגעה יותר מפעמיים בשבוע ← לרופא; פטרת בפה או צרידות ← לרופא (שטיפת פה אחרי שאיפה) |
| **מקור** | GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 3.23 **מונטלוקאסט** · Montelukast לפי הנחיה

אנטגוניסט ללויקוטריאנים

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (3)** | סינגולייר · Singulair \| מונטאייר · Montair \| מונטלוקאסט-תרימה · Montelukast-Trima |
| **נימוק / הערה** | פחות יעיל מ-ICS; סיכון לתופעות נפשיות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **אין תופעות נפשיות מתועדות** | ברשומה או בפנייה אין שינויי התנהגות, סיוטים, דיכאון או מחשבות אובדניות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 2 | **רכישות** | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 5 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 6 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 7 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | שינויי התנהגות, דיכאון או מחשבות אובדניות ← דחוף - הפסקה; סיוטים או הפרעות שינה ← לרופא |
| **מקור** | GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 3.24 **תאופילין** · Theophylline לפי הנחיה, בתנאים

מתילקסנטין

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (1)** | תאוטרים · Theotrim |
| **נימוק / הערה** | GINA לא ממליצה (תופעות לוואי). טווח טיפולי צר, אינטראקציות רבות בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רמת תאופילין מתועדת | רמה מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | רמת התרופה בדם בטווח | בבדיקה האחרונה רמת התרופה בדם בטווח. חריג: רמה מעל 15 מ"ג/ל ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: רמה מעל 20 מ"ג/ל ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: רמה מעל 20 מ"ג/ל ← לא מחדשים | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 10 | רמת תאופילין | רמה מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | רמה בדם שנתית ובכל שינוי |
| **ספי החזרה לרופא/ה** | רמה מעל 15 מ"ג/ל |
| **ערך חמור** | רמה מעל 20 מ"ג/ל |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | בחילות, הקאות או דפיקות לב ← דחוף - רמה בדם; פרכוס ← דחוף - מיון |
| **מקור** | GINA 2026 Summary Guide (בפרויקט) עמ' 27; מעקב: SPS · SPS Medicines Monitoring (NHS) Medicines Monitoring |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 3.25 אזיתרומיצין (טיפול ממושך) · Azithromycin (long-term) לפי הנחיה, בתנאים

מקרוליד למניעת התלקחויות

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (5) | אזניל · Azenil \| זטו · Zeto \| אזיתרו טבע · Azithro Teva \| אזיתרומיצין אינובמד · Azithromycin Inovamed \| אזיתרובניר · Azithrovenir |
| נימוק / הערה | רק בהמלצת רופא/ת ריאות. QT מוארך, שמיעה, ALT |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אק"ג ו-ALT מתועדים | אק"ג ו-ALT מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | QTc תקין באק"ג | QTc באק"ג האחרון מתחת ל-450 (גברים) או 470 (נשים). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | תפקודי כבד (ALT) תקין | בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 4 | אין ירידה בשמיעה מתועדת | ברשומה או בפנייה אין ירידה בשמיעה או טנטון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ת ריאות, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אק"ג ו-ALT שנתי; שמיעה לפי תסמינים |
| ספי החזרה לרופא/ה | ALT מעל פי 3 מהגבול העליון |
| תלונות בפנייה או ברשומה | דפיקות לב או עילפון ← דחוף; ירידה בשמיעה ← לרופא; שלשולים ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 3.26 אנטיהיסטמינים (דור שני) · Antihistamines (2nd generation) לפי הנחיה

אלרגיה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (19) | היסטזין · Histazine | זילרג'י · Zyllergy | אן-אלרגיה · N-Alergya | אלרג'י-קאר · Allergy-Care | לורטדים · Loratadim | לורסטין · Lorastine | לורתרים · Loratrim | אריוס · Aerius | דס-לורטדים · Des-Loratadim | טלפסט · Telfast | פקסי · Fexy | פקסופנאדין-תרימה · Fexofenadine-Trima | בילקסטן · Bilaxten | ליסטומד · Listomed | בילסטין-תרימה · Bilastine-Trima | רופפין · Rupafin | אלרג'י X · Allergyx | דסלורטדין - תרימה סירופ 0.5 מ"ג/מ"ל · Desloratadine - Trima Syrup | דסלורטדין - תרימה טבליות · Desloratadine - Trima |
| נימוק / הערה | בטוחים; מינון מופחת של צטיריזין באי-ספיקת כליות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2OP = 2 אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 4 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 5 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 6 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה |
| תלונות בפנייה או ברשומה | קושי בנשימה או נפיחות בפנים ← דחוף - מיון |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 3.27 תרופות ליל"ד ריאתי ולפיברוזיס ריאתי · Pulmonary hypertension / IPF drugs דגל אדום

ריאות - מומחה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (32) | בוסנטן תרו · Bosentan Taro \| בוסנטן טבע · Bosentan Teva \| טרקליר · Tracleer \| אמבריסנטן אס.קיי. · Ambrisentan S.K. \| אמבריסנטן טבע · Ambrisentan Teva \| סנטאבניר · Sentavenir \| וולובריס · Volibris \| מאציטנטן טבע · Macitentan Teva \| אופסומיט · Opsumit \| אדמפאס · Adempas \| אפטרבי · Uptravi \| רימודולין · Remodulin \| טרפרוסטיניל אס.קיי. · Treprostinil S.K \| טרפרוסטיניל אס.קיי. · Treprostinil S.K \| טייבסו · Tyvaso \| אילומדין · Ilomedin \| אילופרוסט אמ.בי.איי · Iloprost Mbi \| ונטויס · Ventavis \| אסברייט · Esbriet \| פירפנידון אינובמד · Pirfenidone Inovamed \| פירפנידון סנדוז · Pirfenidone Sandoz \| פירפנידון טבע · Pirfenidone Teva \| פירון · Piron \| נינפב טבע · Ninfev Teva \| נינטדניב אס.קיי. · Nintedanib S.K. \| נינטדניב סנדוז · Nintedanib Sandoz \| נינטומד · Nintomed \| אופב · Ofev \| ורדאניב טבע · Vardanib Teva \| וארגטף · Vargatef \| רווטיו · Revatio \| וינרוור · Winrevair |
| נימוק / הערה | תרופות ליל"ד ריאתי ולפיברוזיס ריאתי נקבעות במרכז מומחה. בוסנטן (טרקליר) טרטוגני ומחייב תפקודי כבד חודשיים. הרפואן מכין, והרופא/ה מאשר/ת. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני במינון קבוע שנקבע ע"י מומחה/ית. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | הנחיה עדכנית של מרכז המומחה | מכתב או סיכום של מרכז המומחה מ-12 החודשים האחרונים, עם אותה תרופה ומינון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | תפקודי כבד (בבוסנטן ובאמבריסנטן) | ALT ו-AST מהחודש האחרון בבוסנטן; לפי ההנחיה בשאר התרופות. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 6 | אין היריון (בבוסנטן, אמבריסנטן, מאסיטנטן) | באישה בגיל הפוריות: אמצעי מניעה מתועד ואין היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | בוסנטן: ALT ו-AST חודשיים |
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 3.28 תרופות לסיסטיק פיברוזיס · Cystic fibrosis modulators לפי הנחיה, בתנאים

CF

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (9) | אליפטרק · Alyftrek | קלייידקו · Kalydeco | אורקמבי · Orkambi | סימדקו · Symdeko | טריקפטה · Trikafta | טובי פודהלר 28 מ"ג · Tobi Podhaler (טוברמיצין בשאיפה) | טובי תמיסה לשאיפה · Tobi Solution For Inhalation (טוברמיצין בשאיפה) | פולמוזיים · Pulmozyme (בשאיפה) | קאיסטון · Cayston (אזטראונם בשאיפה) |
| נימוק / הערה | מווסתי CFTR נקבעים ע"י מרכז CF. חידוש כשיש מעקב מסודר ותפקודי כבד בטווח. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני במינון קבוע שנקבע ע"י מומחה/ית. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | מעקב מסודר — מרכז ה-CF | יש ביקור (מרכז ה-CF) בתקופה שנקבעה במעקב, ואין פער במעקב. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | תפקודי כבד | ALT ו-AST מ-6 החודשים האחרונים (שנה ראשונה: כל 3 חודשים). אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 10 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ALT ו-AST כל 3–6 חודשים |
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 3.29 מזרק אדרנלין (אפיפן, ג'קסט) · Epinephrine auto-injector לפי הנחיה

אלרגיה · אנפילקסיס

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | אפיפן · Epipen \| ג'קסט 0.3 מ"ג · Jext 0.3 MG \| ג'קסט 0.15 מ"ג · Jext 0.15 MG |
| נימוק / הערה | למטופל/ת עם אלרגיה שגרמה לאנפילקסיס או בסיכון לה. חידוש כשהמזרק פג תוקף או שומש. 2 מזרקים. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אלרגיה מתועדת | אבחנה ברשומה של אלרגיה עם סיכון לאנפילקסיס (מזון, עקיצות, תרופה), או מכתב אלרגולוג/ית. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | המזרק לא שומש | החידוש בגלל פג תוקף, ולא כי המזרק שומש בתגובה אלרגית. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | מינון מבוגר מתאים | משקל 30 ק"ג ומעלה ל-0.3 מ"ג (פחות — 0.15 מ"ג, ברופא/ה). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה |
| תלונות בפנייה או ברשומה | המזרק שומש ← לרופא/ה: תגובה אלרגית, צריך הערכה; תגובה אלרגית חדשה ← לרופא/ה |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון (FDA (DailyMed |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 3.30 חיסון לאלרגיה (אקריזקס) · Allergen immunotherapy לפי הנחיה, בתנאים

אלרגיה · מומחה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | אקריזקס · Acarizax |
| נימוק / הערה | אקריזקס: המנה הראשונה ניתנת בהשגחת אלרגולוג/ית. בחידוש — אסתמה מאוזנת ואין תגובה קשה. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול שהתחיל אצל אלרגולוג/ית, אותו מינון. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | מעקב מסודר — האלרגולוג/ית | יש ביקור (האלרגולוג/ית) בתקופה שנקבעה במעקב, ואין פער במעקב. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ברשומה: אין סימנים לאסתמה לא מאוזנת | לא מתועדים בחודשים האחרונים התקף אסתמה, קורס סטרואידים או פנייה למיון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ברשומה ובפנייה: לא מתוארת תגובה קשה | לא מתוארים נפיחות בגרון, קשיי בליעה או נשימה, או פריחה כללית מאז תחילת הטיפול. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | יש שיפור אחרי שנה | אחרי השנה הראשונה יש שיפור מתועד; גיל עד 65. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 12 | אין מחלה אוטואימונית פעילה או דיכוי חיסוני | אין ברשומה מחלה אוטואימונית פעילה, חסר חיסוני, טיפול מדכא חיסון או ממאירות פעילה. לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 13 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: העלון לרופא (משרד הבריאות) · עלון לרופא (משרד הבריאות) — Acarizax |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

# 4. נוירולוגיה

47 תרופות · לפי הנחיה, בתנאים: 39 · לפי הנחיה: 6 · הכנה לאישור רופא/ה: 2 · גרסה 2 · חלוקה לפי מערכות · 2.11.2026

מקורות: אין הנחיה בפרויקט לתחומים אלה: כל הערכים הם החלטה מקומית (הצעה); הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020; ACOG 2023 (סיכום AFP). שאר התחומים: החלטה מקומית; עלון לצרכן לפונקס (עודכן 12/2020). שאר התרופות: החלטה מקומית

## 4.א כללים

- חידוש רגיל: 3 חודשים
- ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה פעם בשנה
- עד 3 חידושים רצופים, ואז ביקור רופא
- אין התווית נגד ← תמיד מחדשים לפחות לחודש אחד
- חסרה מדידה, בדיקה או ביקורת שנתית: חידוש לחודש אחד + זימון למרפאה
- חריגה מספי ההחזרה: חידוש לחודש אחד + הודעה לרופא/ה
- התווית נגד או ערך חמור: לא מחדשים, הודעה לרופא/ה (הסף של כל תרופה מופיע ברשימה שלה)
- רפואן לא משנה מינון ולא מחליף תרופה. "מעקב צמוד" = תרופה עם מעקב תכוף (מעבדה, אק"ג, עיניים או צילום) — לבדוק כל ערך בקפידה
- נוגדי פרכוסים, תרופות לפרקינסון, בקלופן וגואנפצין לא נעצרים ע"י רפואן: כל חריגה ← חודש + הודעה
- פריחה בלמוטריגין, התנהגות כפייתית או החמרה במיאסתניה ← הודעה דחופה
- טריפטנים לפי הצורך: 10 ימי טיפול ומעלה בחודש ← הודעה
- דגל אדום: הרפואן מכין לפי רשימת הבדיקות, והרופא/ה בודק/ת שוב לפני האישור — גם כשהכול תקין

## 4.ג בדיקות משותפות

| שלב | נושא | מה בודקים | קריטריון | אם לא מתקיים | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| לפני כל חידוש | יציבות | פרכוס חדש, נפילות או החמרה נפשית מאז הביקור האחרון | אין | יש ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה | החלטה נוירו-1 |
| לפני כל חידוש | בדיקת מעקב | לפי התרופה | קריאטינין (לבטירצטם, פרמיפקסול, אמנטדין, ממנטין, בקלופן); נתרן (אוקסקרבזפין); רמה (פניטואין); דופק (דונפזיל, ריבסטיגמין) | אין ← חידוש לחודש + זימון לבדיקה | החלטה נוירו-2 |
| לפני כל חידוש | רכישות | כיסוי ימים ב-6 החודשים האחרונים | 80% מהימים ומעלה | פחות ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה | כמו בי"ל |
| לפני כל חידוש | ביקורת שנתית | ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה | ב-12 החודשים האחרונים | אין ← חידוש לחודש + זימון לביקורת | כמו בי"ל |
| החזרה מיידית לרופא | פריחה | מופיע בפנייה או ברשומה (נוגדי פרכוסים) | פריחה, חום או פצעים בפה | דחוף - לרופא עכשיו | החלטה נוירו-3 |
| לפני כל חידוש | רצף חידושים | כמה חידושים רצופים מאז ביקור רופא | פחות מ-3 | 3 ← ביקור רופא | כמו בי"ל |

## 4.ד החלטות

| # | נושא | מה ההנחיה אומרת | ההחלטה לפרוטוקול | סוג | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| נוירו-1 | תרופות שלא נעצרות | נוגדי פרכוסים: הפסקה רק בהנחיית מומחה (NICE NG217); פרקינסון ובקלופן: אין להפסיק בפתאומיות (NICE NG71; תווית FDA) | נוגדי פרכוסים, פרקינסון, בקלופן, גואנפצין: רפואן לא עוצר; חריגה ← חידוש לחודש + הודעה | החלטה מקומית (הצעה) | NICE NG217; NICE NG71; תווית |
| נוירו-2 | בדיקות מעקב | אוקסקרבזפין: נתרן (עלון); פניטואין: טווח 10-20 mg/L (עלון); תרופות שמופרשות בכליות: מינון לפי תפקוד כלייתי | קריאטינין שנתי בתרופות שמינון לפי כליות; נתרן באוקסקרבזפין (מתחת ל-133 ← הודעה, מתחת ל-125 ← לא מחדשים); רמת פניטואין 10-20 (מעל 25 ← לא מחדשים); דופק במעכבי כולינאסטרז (מתחת ל-55 ← הודעה, מתחת ל-50 ← לא מחדשים) | החלטה מקומית (הצעה) | עלונים |

| # | נושא | מה ההנחיה אומרת | ההחלטה לפרוטוקול | סוג | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| נוירו-3 | סימנים דחופים | אזהרת אובדנות לכל נוגדי הפרכוס (FDA 2008); פריחה בלמוטריגין — אזהרה מודגשת; הפרעות דחפים באגוניסטים לדופמין (תווית) | מחשבות אובדניות, פריחה בלמוטריגין, התנהגות כפייתית באגוניסטים לדופמין, החמרה במיאסתניה ← הודעה דחופה | החלטה מקומית (הצעה) | תוויות FDA |
| נוירו-4 | טופירמט | טרטוגני (אזהרת EMA 2023) | אישה בגיל הפוריות: אמצעי מניעה מתועד; אחרת ← הודעה. היריון ← לא מחדשים | החלטה מקומית (הצעה) | - |
| נוירו-7 | השלמות (2.11.2026) | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) | פרימידון, פנוברביטל (רמה 40-15), אסליקרבזפין (נתרן), פרמפנל, צנובמט, אנטי-כולינרגיים (גיל 65+: קוגניציה), מיאנסרין, מפרוטילין, דוקספין | החלטה מקומית (הצעה) | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| נוירו-8 | השלמות 2 (2.11.2026) | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) | בוספירון, אנטגוניסטי אורקסין, גפנטים, נרטריפטן, מילנציפרן, רבוקסטין, אופיקפון, סלג'ילין, רילוזול (ALT). עודכן ב-7.11.2026: אפומורפין/טטרבנזין, אפילפסיה מומחה ונרקולפסיה — לפי הנחיה עדכנית של המומחה/ית | החלטה מקומית (הצעה) | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| כללי-12 | תרופות כרוניות נוספות (2) | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי). SSRI/SNRI: היפונתרמיה בקשישים | בזאפיברט, גבפנטין, פרגבלין, SSRI/SNRI (נתרן בגיל 65+), מעכבי ארומטאז, טמוקסיפן, רלוקסיפן, טרבינפין ואיטרקונזול (קורס): לפי הרשימה של כל תרופה | החלטה מקומית (הצעה) | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| כללי-14 | הורמונים לנשים | NAMS 2022: אסטרוגן מערכתי עם רחם ← פרוגסטוגן; דימום לא סדיר ← בירור; התוויות נגד: סרטן שד, פקקת, אוטם/שבץ, מחלת כבד | אסטרוגן בלי פרוגסטוגן כשיש רחם ← הודעה; דימום ← הודעה דחופה; ממוגרפיה לפי התוכנית; ל"ד שנתי. אמצעי מניעה משולב: ל"ד מתחת ל-140/90, עישון בגיל 35+, מיגרנה עם הילה ופקקת = התווית נגד | הנחיה + החלטה מקומית | NAMS 2022; נייר העמדה הישראלי לטיפול הורמונלי (בפרויקט) |
| כללי-20 | השלמות מהמאגר (2.11.2026) | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) | טרזוסין, פינסטריד, אינקליסירן, ורדנאפיל, טיפות לגלאוקומה (ביקורת עיניים שנתית; טימולול: דופק ואסתמה), NSAID ממושך (כליות, אשלגן, ל"ד, דימום, הגנת קיבה), אנטיהיסטמינים, ציננריזין, דומפרידון, מבברין, סידן, מידודרין, פנטוקסיפילין, דיפירידמול, ולציקלוביר מונע, חומצה זולדרונית | החלטה מקומית (הצעה) | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| כללי-21 | תרופות מומחה נוספות | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי). הטיפול נקבע ומנוטר ע"י המומחה | מטוקלופרמיד ממושך, ממריצים/מודפיניל, טרשת נפוצה, אונקולוגיה, יל"ד ריאתי/IPF, סירולימוס, הורמון גדילה, המטולוגיה, CF, טפמידיס/מבקמטן: הודעה בלבד, חידוש ע"י רופא/ה. תרופות ביולוגיות בזריקה בקהילה: הרפואן מכין (אישור, מכתב מומחה, מרווח, בטיחות) והרופא/ה מאשר/ת (5.11.2026) | החלטה מקומית | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| כללי-22 | השלמות 2 מהמאגר (2.11.2026) | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) | ויטמין D, בטאהיסטין, חומצה במפדואית, אומגה 3/איקוזפנט, ציפרופיברט, וריסיגואט, ניטרוגליצרין תת-לשוני, פזולינטנט/אלינזנטנט (ALT), דואביב, אינטראורוסה, סיאנה, אורליסטט, פרוקלופריד, משלשלים, טטרציקלינים ממושכים, מניעת זיהומי שתן, משככי כאב ממושכים, ביקרבונט. עודכן ב-7.11.2026: אין עוד "רופא/ה בלבד" בקבוצה זו — ראו החלטת הסקירה | החלטה מקומית (הצעה) | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| מעקב-7 | קרבמזפין וולפרואט | רמה שגרתית לא נדרשת — רק בחשד לרעילות או אי-היענות (הרמה השנתית בפרוטוקול מחמירה). ולפרואט באישה בגיל הפוריות: תוכנית מניעת היריון עם אמצעי מניעה יעיל (MHRA/EMA) | רמה, נתרן (קרבמזפין), ALT וספירת דם מ-12 החודשים האחרונים. ולפרואט באישה בגיל הפוריות: אמצעי מניעה מתועד. היריון ← הודעה דחופה, לא מפסיקים | החלטה מקומית (הצעה) | NICE NG217; MHRA 2023 |

| # | נושא | מה ההנחיה אומרת | ההחלטה לפרוטוקול | סוג | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| סקירה-1 | סקירת פריטים חסומים (7.11.2026) | נושא תפעולי — הנחיות קליניות לא עוסקות בו; מבוסס על נוהל הרפואן | אף תרופה לא חסומה כברירת מחדל. 59 הפריטים שהיו "רופא/ה בלבד" נסקרו אחד-אחד: חלקם פתוחים עם רשימת בדיקות, חלקם בדגל אדום (בדיקה כפולה מול הרופא/ה). נשארים אצל הרופא/ה: רואקוטן, אנטיביוטיקה לתסמין חדש (מלבד מוקסיפן/רפאפן אחרי משטח גרון חיובי) ותרופות נגד שפעת. התראת האינטראקציות של המערכת היא שכבת ההגנה הבסיסית. | החלטה מקומית (7.11.2026) | - |

## 4.ה רשימת התרופות (לסימון)

| # | שם | גנרי | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | לבטירצטם | Levetiracetam | נוגד פרכוסים | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 4.2 | בריברצטם | Brivaracetam | נוגד פרכוסים | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 4.3 | למוטריגין | Lamotrigine | נוגד פרכוסים / מייצב מצב רוח | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 4.4 | טופירמט | Topiramate | נוגד פרכוסים / מניעת מיגרנה | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 4.5 | אוקסקרבזפין | Oxcarbazepine | נוגד פרכוסים | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 4.6 | לקוסמיד | Lacosamide | נוגד פרכוסים | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 4.7 | פניטואין | Phenytoin | נוגד פרכוסים | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 4.8 | לבודופה / קרבידופה | Levodopa / carbidopa | פרקינסון | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 4.9 | פרמיפקסול | Pramipexole | פרקינסון / רגליים חסרות מנוחה | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 4.10 | רופינירול | Ropinirole | פרקינסון / רגליים חסרות מנוחה | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 4.11 | רסג'ילין | Rasagiline | פרקינסון · מעכב MAO-B | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 4.12 | ספינמיד | Safinamide | פרקינסון · מעכב MAO-B | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 4.13 | אמנטדין | Amantadine | פרקינסון | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 4.14 | דונפזיל | Donepezil | דמנציה · מעכב כולינאסטרז | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 4.15 | ריבסטיגמין | Rivastigmine | דמנציה · מעכב כולינאסטרז | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 4.16 | ממנטין | Memantine | דמנציה · אנטגוניסט NMDA | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 4.17 | סומטריפטן | Sumatriptan | מיגרנה · טריפטן (לפי הצורך) | לפי הנחיה | ☐ | |
| 4.18 | ריזטריפטן | Rizatriptan | מיגרנה · טריפטן (לפי הצורך) | לפי הנחיה | ☐ | |
| 4.19 | אלטריפטן | Eletriptan | מיגרנה · טריפטן (לפי הצורך) | לפי הנחיה | ☐ | |

| # | שם | גנרי | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20 | זולמיטריפטן | Zolmitriptan | מיגרנה · טריפטן (לפי הצורך) | לפי הנחיה | ☐ | |
| 4.21 | בקלופן | Baclofen | מרפה שרירים (ספסטיות) | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 4.22 | פירידוסטיגמין | Pyridostigmine | מיאסתניה גרביס | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 4.23 | פרימידון | Primidone | רעד / נוגד פרכוסים | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 4.24 | פנוברביטל | Phenobarbital | נוגד פרכוסים | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 4.25 | אסליקרבזפין | Eslicarbazepine | נוגד פרכוסים | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 4.26 | פרמפנל | Perampanel | נוגד פרכוסים | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 4.27 | צנובמט | Cenobamate | נוגד פרכוסים | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 4.28 | טריהקסיפנידיל | Trihexyphenidyl | אנטי-כולינרגי (פרקינסון / תופעות חוץ-פירמידליות) | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 4.29 | ביפרידן | Biperiden | אנטי-כולינרגי (פרקינסון / תופעות חוץ-פירמידליות) | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 4.30 | פרוציקלידין | Procyclidine | אנטי-כולינרגי (פרקינסון / תופעות חוץ-פירמידליות) | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 4.31 | גפנטים (מיגרנה) | Gepants (migraine) | מיגרנה · אנטגוניסט CGRP | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 4.32 | נרטריפטן | Naratriptan | מיגרנה · טריפטן (לפי הצורך) | לפי הנחיה | ☐ | |
| 4.33 | אופיקפון | Opicapone | פרקינסון · מעכב COMT | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 4.34 | סלג'ילין | Selegiline | פרקינסון · מעכב MAO-B | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 4.35 | רילוזול | Riluzole | ALS | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 4.36 | תרופות להפרעות תנועה במעקב מומחה | Specialist movement-disorder drugs | נוירולוגיה - מומחה | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 4.37 | תרופות לאפילפסיה במעקב מומחה | Specialist epilepsy drugs | נוירולוגיה - מומחה | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 4.38 | תרופות לנרקולפסיה | Narcolepsy drugs | הפרעות שינה | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 4.39 | גבפנטין | Gabapentin | כאב נוירופתי / נוגד פרכוסים | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 4.40 | פרגבלין | Pregabalin | כאב נוירופתי / נוגד פרכוסים | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 4.41 | ציננריזין | Cinnarizine | סחרחורת · אנטיהיסטמין | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 4.42 | תרופות לטרשת נפוצה | Multiple sclerosis drugs | טרשת נפוצה | דגל אדום | ☐ | |
| 4.43 | גלטירמר לטרשת נפוצה (קופקסון) | Glatiramer (MS) | טרשת נפוצה | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |

| # | שם | גנרי | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.44 | בטאהיסטין | Betahistine | סחרחורת (מנייר) | לפי הנחיה | ☐ | |
| 4.45 | מידזולם לחלל הפה להפסקת פרכוס (בוקולאם) | Midazolam buccal (seizure rescue) | נוירולוגיה · תרופת הצלה | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 4.46 | קרבמזפין | Carbamazepine | נוגד פרכוסים | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |
| 4.47 | ולפרואט | Valproate | נוגד פרכוסים / מייצב מצב רוח | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |

## 1.4 פירוט מלא

### 4.1 **לבטירצטם** · Levetiracetam לפי הנחיה, בתנאים

נוגד פרכוסים

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (5) | קפרה · Keppra | לוותרים · Levetrim | לובון · Levebon | לבטיראצטם דקסל · Levetiracetam Dexcel | לבטיראצטם אלטן · Levetiracetam Altan |
| נימוק / הערה | לא נעצר בפתאומיות. מינון לפי כליות; תופעות התנהגותיות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין פרכוס מאז הביקור האחרון | ברשומה או בפנייה אין פרכוס חדש מאז הביקור האחרון אצל הנוירולוג/ית או הרופא/ה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | קריאטינין מתועד | קריאטינין/eGFR מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 3 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <50 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 4 | אין שינוי התנהגותי מתועד | ברשומה או בפנייה אין עצבנות קשה, תוקפנות, דיכאון או מחשבות אובדניות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | קריאטינין שנתי |
| ספי החזרה לרופא/ה | eGFR <50 (לבדיקת מינון) |
| תלונות בפנייה או ברשומה | פרכוס ← לרופא; פרכוס ממושך - מיון; פריחה, חום או פצעים בפה ← דחוף; ישנוניות או חוסר יציבות ← לרופא; עצבנות קשה או דיכאון ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · FDA (DailyMed) עלון |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 4.2 **בריברצטם** · Brivaracetam · לפי הנחיה, בתנאים

נוגד פרכוסים

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | בריביאקט · Briviact |
| נימוק / הערה | לא נעצר בפתאומיות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין פרכוס מאז הביקור האחרון | ברשומה או בפנייה אין פרכוס חדש מאז הביקור האחרון אצל הנוירולוג/ית או הרופא/ה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | אין החמרה מתועדת | ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | פרכוס ← לרופא; פרכוס ממושך - מיון; פריחה, חום או פצעים בפה ← דחוף; ישנוניות או חוסר יציבות ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 4.3 למוטריגין · Lamotrigine לפי הנחיה, בתנאים

נוגד פרכוסים / מייצב מצב רוח

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | למיקטל · Lamictal \| למודקס · Lamodex \| למוג'ין · Lamogine |
| נימוק / הערה | פריחה ← הפסקה מיידית (SJS). ולפרואט מכפיל את הרמה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין פרכוס מאז הביקור האחרון | ברשומה או בפנייה אין פרכוס חדש מאז הביקור האחרון אצל הנוירולוג/ית או הרופא/ה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | אין פריחה מתועדת | ברשומה או בפנייה אין פריחה, חום או פצעים בפה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | פריחה, חום או פצעים בפה ← דחוף - הפסקה; פרכוס ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 4.4 טופירמט · Topiramate לפי הנחיה, בתנאים

נוגד פרכוסים / מניעת מיגרנה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | טופמקס · Topamax \| טופיתרים · Topitrim |
| נימוק / הערה | טרטוגני: נשים בגיל הפוריות רק עם אמצעי מניעה. אבנים בכליות, ירידה במשקל |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין פרכוס מאז הביקור האחרון | ברשומה או בפנייה אין פרכוס חדש מאז הביקור האחרון אצל הנוירולוג/ית או הרופא/ה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | אמצעי מניעה יעיל מתועד<br>שאלה: אישה בגיל הפוריות? | אמצעי מניעה יעיל מתועד, או החלטה מתועדת של הרופא/ה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 3 | אין החמרה מתועדת | ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 OP = 2 אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ביקרבונט וקריאטינין לפי תסמינים |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון |
| תלונות בפנייה או ברשומה | פרכוס ← לרופא; פרכוס ממושך - מיון; פריחה, חום או פצעים בפה ← דחוף; ישנוניות או חוסר יציבות ← לרופא; כאב עיניים או ירידה בראייה ← דחוף; כאב גב חד או דם בשתן ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 4.5 אוקסקרבזפין · Oxcarbazepine לפי הנחיה, בתנאים

נוגד פרכוסים

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | טרילפטין · Trileptin |
| נימוק / הערה | נתרן נמוך שכיח, בעיקר בגיל מבוגר או עם משתנים |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין פרכוס מאז הביקור האחרון | ברשומה או בפנייה אין פרכוס חדש מאז הביקור האחרון אצל הנוירולוג/ית או הרופא/ה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | נתרן מתועד | נתרן מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 3 | נתרן (Na) תקין | בבדיקה האחרונה נתרן (Na) תקין. חריג: Na מתחת ל-133 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: Na מתחת ל-125 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: Na מתחת ל-125 ← לא מחדשים | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | נתרן שנתי (כל 6 חודשים בגיל 65+ או עם משתן) |
| ספי החזרה לרופא/ה | Na מתחת ל-133 |
| ערך חמור | Na מתחת ל-125 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | פרכוס ← לרופא; פרכוס ממושך - מיון; פריחה, חום או פצעים בפה ← דחוף; ישנוניות או חוסר יציבות ← לרופא; בלבול, כאב ראש או בחילה (נתרן נמוך) ← דחוף |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 4.6 לקוסמיד · Lacosamide

לפי הנחיה, בתנאים

נוגד פרכוסים

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | וימפט · Vimpat \| לאקומייד · Lacomide \| לקוסמיד טבע · Lacosamide Teva |
| נימוק / הערה | מאריך PR; זהירות במחלת הולכה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין פרכוס מאז הביקור האחרון | ברשומה או בפנייה אין פרכוס חדש מאז הביקור האחרון אצל הנוירולוג/ית או הרופא/ה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | אק"ג מתועד<br>שאלה: יש מחלת לב, הפרעת הולכה או טיפול נוסף שמאט הולכה? | אק"ג מ-12 החודשים האחרונים ללא חסם הולכה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אק"ג לפי מחלת לב |
| תלונות בפנייה או ברשומה | פרכוס ← לרופא; פרכוס ממושך - מיון; פריחה, חום או פצעים בפה ← דחוף; ישנוניות או חוסר יציבות ← לרופא; עילפון או דופק איטי ← דחוף |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 4.7 פניטואין · Phenytoin

לפי הנחיה, בתנאים

נוגד פרכוסים

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | אפנוטין · Epanutin \| דילנטין · Dilantin |
| נימוק / הערה | טווח טיפולי צר; אינטראקציות רבות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין פרכוס מאז הביקור האחרון | ברשומה או בפנייה אין פרכוס חדש מאז הביקור האחרון אצל הנוירולוג/ית או הרופא/ה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | רמת פניטואין מתועדת | רמה ואלבומין מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 3 | רמת התרופה בדם בטווח | בבדיקה האחרונה רמת התרופה בדם בטווח. חריג: רמה מחוץ לטווח 10-20 מק"ג/מ"ל ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: רמה מעל 25 מק"ג/מ"ל ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>**חמור: רמה מעל 25 מק"ג/מ"ל ← לא מחדשים** | |
| 4 | תפקודי כבד (ALT) תקין | בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | רמה בדם ואלבומין שנתי; ALT |
| ספי החזרה לרופא/ה | רמה מחוץ לטווח 10-20 מק"ג/מ"ל; ALT מעל פי 3 מהגבול העליון |
| ערך חמור | רמה מעל 25 מק"ג/מ"ל |
| תלונות בפנייה או ברשומה | פרכוס ← לרופא; פרכוס ממושך - מיון; פריחה, חום או פצעים בפה ← דחוף; ישנוניות או חוסר יציבות ← לרופא; ראייה כפולה, חוסר יציבות או דיבור לא ברור ← דחוף - רמה בדם |
| מקור | מעקב: SPS Medicines Monitoring (NHS) · SPS Medicines Monitoring |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 4.8 **לבודופה / קרבידופה** · Levodopa / carbidopa לפי הנחיה, בתנאים

פרקינסון

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (4)** | דופיקר · Dopicar \| סינמט סי.אר · Sinemet CR \| קרבידופה/לוודופה מדו · Carbidopa/Levodopa Medo \| סטאלבו · Stalevo (עם אנטקפון) |
| **נימוק / הערה** | לא נעצר בפתאומיות. משאבות (דואודופה, לסיגון) - רק ע"י היחידה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **אין נפילות או הזיות מתועדות** | ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | **רכישות** | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | **טיפול כרוני במינון קבוע** | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | נפילות או הזיות ← לרופא; נוקשות עם חום ← דחוף |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 4.9 פרמיפקסול · Pramipexole

לפי הנחיה, בתנאים

פרקינסון / רגליים חסרות מנוחה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | סיפרול Sifrol ER · ER |
| נימוק / הערה | התנהגות כפייתית, ישנוניות פתאומית. מינון לפי כליות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין נפילות או הזיות מתועדות | ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | אין התנהגות כפייתית מתועדת | ברשומה או בפנייה אין הימורים, קניות כפייתיות או שינוי בהתנהגות המינית. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | קריאטינין מתועד | קריאטינין/eGFR מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 4 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <50 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | קריאטינין שנתי |
| ספי החזרה לרופא/ה | eGFR <50 (לבדיקת מינון) |
| תלונות בפנייה או ברשומה | הימורים או קניות כפייתיות ← דחוף; הירדמות פתאומית ← לרופא - נהיגה |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 4.10 **רופינירול** · Ropinirole לפי הנחיה, בתנאים

פרקינסון / רגליים חסרות מנוחה

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (1)** | רקוויפ מודוטאב · Requip Modutab |
| **נימוק / הערה** | התנהגות כפייתית, ישנוניות פתאומית |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **אין נפילות או הזיות מתועדות** | ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | **אין התנהגות כפייתית מתועדת** | ברשומה או בפנייה אין הימורים, קניות כפייתיות או שינוי בהתנהגות המינית. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | **רכישות** | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | **טיפול כרוני במינון קבוע** | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | הימורים או קניות כפייתיות ← דחוף; הירדמות פתאומית ← לרופא - נהיגה |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 4.11 רסג'ילין · Rasagiline

לפי הנחיה, בתנאים

פרקינסון · מעכב MAO-B

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (5) | אזילקט · Azilect | רסג'ילין-תרימה · Rasagiline-Trima | ראסאג'ילין אינובמד · Rasagiline Inovamed | רסג'ילין סנדוז · Rasagiline Sandoz | רז-אג'ילין · Raz-Agiline |
| נימוק / הערה | אינטראקציות מסוכנות (תסמונת סרוטונין) |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין נפילות או הזיות מתועדות | ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | אי-שקט, חום ורעד (תסמונת סרוטונין) ← דחוף - מיון |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 4.12 ספינמיד · Safinamide

לפי הנחיה, בתנאים

פרקינסון · מעכב MAO-B

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | קסדגו · Xadago |
| נימוק / הערה | אינטראקציות כמו רסג'ילין |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין נפילות או הזיות מתועדות | ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| מקור | מעקב: עלון ה-(FDA (DailyMed · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 4.13 **אמנטדין** · Amantadine לפי הנחיה, בתנאים

פרקינסון

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (1)** | אמנדין · Amandin |
| **נימוק / הערה** | מינון לפי כליות; בלבול והזיות בגיל מבוגר |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין נפילות או הזיות מתועדות | ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | קריאטינין מתועד | קריאטינין/eGFR מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 3 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <60 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <15 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: eGFR <15 ← לא מחדשים | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | קריאטינין שנתי |
| **ספי החזרה לרופא/ה** | eGFR <60 (לבדיקת מינון) |
| **ערך חמור** | eGFR <15 |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | בלבול או הזיות ← לרופא; בצקות ← לרופא |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 4.14 דונפזיל · Donepezil לפי הנחיה, בתנאים

דמנציה · מעכב כולינאסטרז

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | אסנטה · Asenta \| ממוריט · Memorit \| דונפזיל טבע · Donepezil Teva |
| נימוק / הערה | האטת דופק ועילפון בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | דופק מתועד | מדידת דופק מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | דופק במנוחה תקין | במדידה האחרונה דופק במנוחה תקין. חריג: מתחת ל-55 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים | |
| 3 | אין עילפון או נפילות מתועדים | ברשומה או בפנייה אין עילפון, סחרחורת או נפילות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י גריאטר/ית, נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 OP = 2 אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | דופק | דופק מתועד ב-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | דופק ומשקל בביקורת |
| ספי החזרה לרופא/ה | דופק מתחת ל-55 |
| ערך חמור | דופק מתחת ל-50 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | עילפון או סחרחורת ← דחוף; ירידה בתיאבון ובמשקל ← לרופא; הקאות או שלשולים ← לרופא |
| מקור | מעקב: SPS Medicines Monitoring · SPS Medicines Monitoring (NHS) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 4.15 ריבסטיגמין · Rivastigmine לפי הנחיה, בתנאים

דמנציה · מעכב כולינאסטרז

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | אקסלון מדבקה · Exelon Patch | ריבסטיגמין דקסל · Rivastigmine Dexcel | ריבסטיגמין מדבקה דקסל · Rivastigmine Patch Dexcel |
| נימוק / הערה | האטת דופק ועילפון בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | דופק מתועד | מדידת דופק מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | דופק במנוחה תקין | במדידה האחרונה דופק במנוחה תקין. חריג: מתחת ל-55 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים | |
| 3 | אין עילפון או נפילות מתועדים | ברשומה או בפנייה אין עילפון, סחרחורת או נפילות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י גריאטר/ית, נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | דופק | דופק מתועד ב-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | דופק ומשקל בביקורת |
| ספי החזרה לרופא/ה | דופק מתחת ל-55 |
| ערך חמור | דופק מתחת ל-50 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | עילפון או סחרחורת ← דחוף; ירידה בתיאבון ובמשקל ← לרופא; הקאות או שלשולים ← לרופא |
| מקור | מעקב: SPS Medicines Monitoring · SPS Medicines Monitoring (NHS) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 4.16 **ממנטין** · Memantine לפי הנחיה, בתנאים

דמנציה · אנטגוניסט NMDA

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (5)** | אביקסה · Ebixa \| ממוקס · Memox \| נמדטין · Nemdatine \| וי-מנטין · V-Mantine \| ממנטין גרינדקס · Memantine Grindeks |
| **נימוק / הערה** | מינון לפי כליות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | קריאטינין מתועד | קריאטינין/eGFR מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <30 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י גריאטר/ית, נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | קריאטינין שנתי |
| **ספי החזרה לרופא/ה** | eGFR <30 (לבדיקת מינון) |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | בלבול או אי-שקט חדשים ← לרופא |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 4.17 סומטריפטן · Sumatriptan לפי הנחיה

מיגרנה · טריפטן (לפי הצורך)

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | אימיטרקס · Imitrex \| סומטרידקס · Sumatridex |
| נימוק / הערה | אסור במחלת לב, שבץ או ל"ד לא מאוזן. שימוש 10 ימים ומעלה בחודש = כאב ראש משימוש יתר |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | פחות מ-10 ימי טיפול בחודש | לפי הרכישות: פחות מ-10 מנות בחודש בממוצע ב-3 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | מדידת ל"ד מתועדת | מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 3 | ל"ד מתחת ל-140/90 | מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | אין התווית נגד | מחלת לב איסכמית; שבץ או אירוע מוחי חולף; מחלת כלי דם היקפית. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | מחלת לב איסכמית; שבץ או אירוע מוחי חולף; מחלת כלי דם היקפית |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב או לחץ בחזה ← דחוף - מיון; כאב ראש שונה מהרגיל או חולשה בצד אחד ← דחוף - מיון |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 4.18 ריזטריפטן · Rizatriptan לפי הנחיה

מיגרנה · טריפטן (לפי הצורך)

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | ריזלט · Rizalt \| ריזלט אר.פי.די · Rizalt RPD \| ריזטריפטן אינובמד · Rizatriptan Inovamed |
| נימוק / הערה | אסור במחלת לב, שבץ או ל"ד לא מאוזן. שימוש 10 ימים ומעלה בחודש = כאב ראש משימוש יתר |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | פחות מ-10 ימי טיפול בחודש | לפי הרכישות: פחות מ-10 מנות בחודש בממוצע ב-3 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | מדידת ל"ד מתועדת | מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 3 | ל"ד מתחת ל-140/90 | מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | אין התווית נגד | מחלת לב איסכמית; שבץ או אירוע מוחי חולף; מחלת כלי דם היקפית. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | מחלת לב איסכמית; שבץ או אירוע מוחי חולף; מחלת כלי דם היקפית |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב או לחץ בחזה ← דחוף - מיון; כאב ראש שונה מהרגיל או חולשה בצד אחד ← דחוף - מיון |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 4.19 **אלטריפטן** · Eletriptan לפי הנחיה

מיגרנה · טריפטן (לפי הצורך)

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | רילרט · Relert \| אלטריפטן-תרימה · Eletriptan-Trima \| אלטריפטאן אינובמד · Eletriptan Inovamed |
| נימוק / הערה | אסור במחלת לב, שבץ או ל"ד לא מאוזן. שימוש 10 ימים ומעלה בחודש = כאב ראש משימוש יתר |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **פחות מ-10 ימי טיפול בחודש** | לפי הרכישות: פחות מ-10 מנות בחודש בממוצע ב-3 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | **מדידת ל"ד מתועדת** | מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 3 | **ל"ד מתחת ל-140/90** | מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | **אין התווית נגד** | מחלת לב איסכמית; שבץ או אירוע מוחי חולף; מחלת כלי דם היקפית. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | מחלת לב איסכמית; שבץ או אירוע מוחי חולף; מחלת כלי דם היקפית |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב או לחץ בחזה ← דחוף - מיון; כאב ראש שונה מהרגיל או חולשה בצד אחד ← דחוף - מיון |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 4.20 זולמיטריפטן · Zolmitriptan לפי הנחיה

מיגרנה · טריפטן (לפי הצורך)

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | זומיג · Zomig |
| נימוק / הערה | אסור במחלת לב, שבץ או ל"ד לא מאוזן. שימוש 10 ימים ומעלה בחודש = כאב ראש משימוש יתר |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | פחות מ-10 ימי טיפול בחודש | לפי הרכישות: פחות מ-10 מנות בחודש בממוצע ב-3 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | מדידת ל"ד מתועדת | מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 3 | ל"ד מתחת ל-140/90 | מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | אין התווית נגד | מחלת לב איסכמית; שבץ או אירוע מוחי חולף; מחלת כלי דם היקפית. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | מחלת לב איסכמית; שבץ או אירוע מוחי חולף; מחלת כלי דם היקפית |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב או לחץ בחזה ← דחוף - מיון; כאב ראש שונה מהרגיל או חולשה בצד אחד ← דחוף - מיון |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 4.21 **בקלופן** · Baclofen לפי הנחיה, בתנאים

מרפה שרירים (ספסטיות)

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (2)** | בקלוסל · Baclosal \| בקלופן סינטטיקה · Baclofen Sintetica |
| **נימוק / הערה** | לא נעצר בפתאומיות (פרכוסים, הזיות). מצטבר באי-ספיקת כליות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | קריאטינין מתועד | קריאטינין/eGFR מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <60 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים | |
| 3 | אין נפילות או הזיות מתועדות | ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | קריאטינין שנתי |
| **ספי החזרה לרופא/ה** | eGFR <60 (לבדיקת מינון) |
| **ערך חמור** | eGFR <30 |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | ישנוניות קשה או בלבול ← דחוף; חולשה ונפילות ← לרופא |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 4.22 פירידוסטיגמין · Pyridostigmine לפי הנחיה, בתנאים

מיאסתניה גרביס

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | מסטינון · Mestinon \| פירידוסטיגמין · Pyridostigmine |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י נוירולוג/ית. החמרה במיאסתניה = מצב דחוף |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין החמרה מתועדת | ברשומה או בפנייה אין קושי בבליעה, בדיבור או בנשימה, או חולשה מחמירה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 2 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | קושי בבליעה או בנשימה ← דחוף - מיון; שלשולים, הזעה או התכווציות ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 4.23 פרימידון · Primidone

לפי הנחיה, בתנאים

רעד / נוגד פרכוסים

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | פריזולין · Prysoline |
| נימוק / הערה | ישנוניות ונפילות; לא נעצר בפתאומיות בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין נפילות או הזיות מתועדות | ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | ספירת דם וכימיה | ספירת דם וכימיה מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | ישנוניות או חוסר יציבות ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 4.24 פנוברביטל · Phenobarbital לפי הנחיה, בתנאים

נוגד פרכוסים

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | פנוברביטון רקח · Phenobarbitone Rekah |
| נימוק / הערה | רמה בדם; ישנוניות ונפילות; אינטראקציות רבות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין פרכוס מאז הביקור האחרון | ברשומה או בפנייה אין פרכוס חדש מאז הביקור האחרון אצל הנוירולוג/ית או הרופא/ה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | רמה מתועדת | רמת פנוברביטל מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 3 | רמת התרופה בדם בטווח | בבדיקה האחרונה רמת התרופה בדם בטווח. חריג: רמה מחוץ לטווח 15-40 מק"ג/מ"ל ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 4 | אין נפילות או הזיות מתועדות | ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | רמה בדם שנתית |
| ספי החזרה לרופא/ה | רמה מחוץ לטווח 15-40 מק"ג/מ"ל |
| תלונות בפנייה או ברשומה | פרכוס ← לרופא; פרכוס ממושך - מיון; פריחה, חום או פצעים בפה ← דחוף; ישנוניות או חוסר יציבות ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 4.25 אסליקרבזפין · Eslicarbazepine

לפי הנחיה, בתנאים

נוגד פרכוסים

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | זביניקס · Zebinix |
| נימוק / הערה | נתרן נמוך כמו באוקסקרבזפין |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין פרכוס מאז הביקור האחרון | ברשומה או בפנייה אין פרכוס חדש מאז הביקור האחרון אצל הנוירולוג/ית או הרופא/ה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | נתרן מתועד | נתרן מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 3 | נתרן (Na) תקין | בבדיקה האחרונה נתרן (Na) תקין. חריג: Na מתחת ל-133 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: Na מתחת ל-125 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: Na מתחת ל-125 ← לא מחדשים | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | נתרן שנתי |
| ספי החזרה לרופא/ה | Na מתחת ל-133 |
| ערך חמור | Na מתחת ל-125 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | פרכוס ← לרופא; פרכוס ממושך - מיון; פריחה, חום או פצעים בפה ← דחוף; ישנוניות או חוסר יציבות ← לרופא; בלבול או בחילה (נתרן נמוך) ← דחוף |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 4.26 **פרמפנל** · Perampanel לפי הנחיה, בתנאים

נוגד פרכוסים

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (1)** | פייקומפה · Fycompa |
| **נימוק / הערה** | תוקפנות ושינויי התנהגות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין פרכוס מאז הביקור האחרון | ברשומה או בפנייה אין פרכוס חדש מאז הביקור האחרון אצל הנוירולוג/ית או הרופא/ה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | אין שינוי התנהגותי מתועד | ברשומה או בפנייה אין תוקפנות, עצבנות קשה או מחשבות אובדניות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | פרכוס ← לרופא; פרכוס ממושך - מיון; פריחה, חום או פצעים בפה ← דחוף; ישנוניות או חוסר יציבות ← לרופא; תוקפנות או מחשבות אובדניות ← דחוף |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 4.27 צנובמט · Cenobamate

לפי הנחיה, בתנאים

נוגד פרכוסים

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | אקסקופרי · Xcopri |
| נימוק / הערה | מקצר QT; פריחה (DRESS) בתחילת טיפול |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין פרכוס מאז הביקור האחרון | ברשומה או בפנייה אין פרכוס חדש מאז הביקור האחרון אצל הנוירולוג/ית או הרופא/ה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | אין פריחה מתועדת | ברשומה או בפנייה אין פריחה או חום. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | פרכוס ← לרופא; פרכוס ממושך - מיון; פריחה, חום או פצעים בפה ← דחוף; ישנוניות או חוסר יציבות ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 4.28 **טריהקסיפנידיל** · Trihexyphenidyl לפי הנחיה, בתנאים

אנטי-כולינרגי (פרקינסון / תופעות חוץ-פירמידליות)

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (2)** | פרטאן · Partane \| רודנל · Rodenal |
| **נימוק / הערה** | בלבול, עצירות ואצירת שתן בגיל מבוגר |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **אין ירידה קוגניטיבית מתועדת**<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה? | אין בלבול או ירידה בזיכרון מתועדים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 2 | **אין אצירת שתן** | ברשומה או בפנייה אין אצירת שתן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | **רכישות** | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | **טיפול כרוני במינון קבוע** | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2OP = 2 אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | אין מעקב מעבדה |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | בלבול או הזיות ← לרופא; קושי במתן שתן ← לרופא; כאב עיניים ← דחוף |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · FDA (DailyMed) עלון |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 4.29 ביפרידן · Biperiden לפי הנחיה, בתנאים

אנטי-כולינרגי (פרקינסון / תופעות חוץ-פירמידליות)

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | דקינט · Dekinet |
| נימוק / הערה | בלבול, עצירות ואצירת שתן בגיל מבוגר בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין ירידה קוגניטיבית מתועדת<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה? | אין בלבול או ירידה בזיכרון מתועדים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 2 | אין אצירת שתן | ברשומה או בפנייה אין אצירת שתן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 10 | אין התווית נגד אנטי-כולינרגית | אין ברשומה גלאוקומה של זווית סגורה לא מטופלת, הגדלת ערמונית, או היצרות / חסימה במערכת העיכול. לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה |
| תלונות בפנייה או ברשומה | בלבול או הזיות ← לרופא; קושי במתן שתן ← לרופא; כאב עיניים ← דחוף |
| מקור | מעקב: העלון לרופא (משרד הבריאות) · עלון לרופא (משרד הבריאות) — Dekinet |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 4.30 פרוציקלידין · Procyclidine לפי הנחיה, בתנאים

אנטי-כולינרגי (פרקינסון / תופעות חוץ-פירמידליות)

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | קמדרין · Kemadrin |
| נימוק / הערה | בלבול, עצירות ואצירת שתן בגיל מבוגר בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין ירידה קוגניטיבית מתועדת<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה? | אין בלבול או ירידה בזיכרון מתועדים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 2 | אין אצירת שתן | ברשומה או בפנייה אין אצירת שתן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 10 | אין התווית נגד אנטי-כולינרגית | אין ברשומה גלאוקומה של זווית סגורה או חסימה במערכת העיכול. לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה |
| תלונות בפנייה או ברשומה | בלבול או הזיות ← לרופא; קושי במתן שתן ← לרופא; כאב עיניים ← דחוף |
| מקור | מעקב: העלון לרופא (משרד הבריאות) · עלון לרופא (משרד הבריאות) — Kemadrin (רישום בוטל) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 4.31 גפנטים (מיגרנה) · Gepants (migraine) לפי הנחיה, בתנאים

מיגרנה · אנטגוניסט CGRP

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | קיוליפטה · Qulipta (מניעה) \| נורטק או.די.טי · Nurtec ODT (התקף או מניעה) \| אוברלוי · Ubrelvy (התקף) |
| נימוק / הערה | נקבע לרוב ע"י נוירולוג/ית; אינטראקציות עם מעכבי CYP3A4 |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | הוערכה תועלת | ירידה בימי מיגרנה מתועדת ב-12 החודשים האחרונים (מניעה). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב ראש שונה מהרגיל או חולשה בצד אחד ← דחוף - מיון |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 4.32 נרטריפטן · Naratriptan לפי הנחיה

מיגרנה · טריפטן (לפי הצורך)

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | נרמיג · Naramig |
| נימוק / הערה | אסור במחלת לב או שבץ. 10 ימים ומעלה בחודש = כאב ראש משימוש יתר |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | פחות מ-10 ימי טיפול בחודש | לפי הרכישות: פחות מ-10 מנות בחודש בממוצע ב-3 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | מדידת ל"ד מתועדת | מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 3 | ל"ד מתחת ל-140/90 | מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | אין התוויות נגד | מחלת לב איסכמית; שבץ או אירוע מוחי חולף; מחלת כלי דם היקפית. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | מחלת לב איסכמית; שבץ או אירוע מוחי חולף; מחלת כלי דם היקפית |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב או לחץ בחזה ← דחוף - מיון |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 4.33 **אופיקפון** · Opicapone · לפי הנחיה, בתנאים

פרקינסון · מעכב COMT

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (1)** | אונג'נטיס · Ongentys |
| **נימוק / הערה** | תוספת ללבודופה; דיסקינזיה והזיות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **אין נפילות או הזיות מתועדות** | ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | **רכישות** | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | **טיפול כרוני במינון קבוע** | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | אין מעקב מעבדה |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; הזיות ← לרופא |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 4.34 סלג'ילין · Selegiline לפי הנחיה, בתנאים

פרקינסון · מעכב MAO-B

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | סלג'ין · Selgin |
| נימוק / הערה | אינטראקציות מסוכנות (תסמונת סרוטונין) |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין נפילות או הזיות מתועדות | ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה |
| תלונות בפנייה או ברשומה | אי-שקט, חום ורעד ← דחוף - מיון |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 4.35 **רילוזול** · Riluzole (לפי הנחיה, בתנאים)

ALS

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | רילוטק · Rilutek |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י נוירולוג/ית. ALT וספירת דם |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | ALT וספירת דם מתועדים | ALT וספירת דם מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | תפקודי כבד (ALT) תקין | בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: ALT מעל פי 5 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: ALT מעל פי 5 מהגבול העליון ← לא מחדשים | |
| 3 | אין חום מתועד | ברשומה או בפנייה אין חום או זיהום. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ALT כל 3 חודשים בשנה הראשונה, אחר כך כל 6 חודשים; ספירת דם |
| ספי החזרה לרופא/ה | ALT מעל פי 3 מהגבול העליון |
| ערך חמור | ALT מעל פי 5 מהגבול העליון |
| תלונות בפנייה או ברשומה | חום ← דחוף - ספירת דם; שיעול או קוצר נשימה ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 4.36 תרופות להפרעות תנועה במעקב מומחה · Specialist movement-disorder drugs

לפי הנחיה, בתנאים

נוירולוגיה - מומחה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (4) | אפו-גו · Apo-Go \| אפו-גו פן · Apo Go Pen \| קסנזין · Xenazine \| אוסטדו · Austedo |
| נימוק / הערה | אפומורפין, טטרבנזין ודומיהן נקבעים ע"י נוירולוג/ית מומחה/ית. חידוש לפי ההנחיה העדכנית. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני במינון קבוע שנקבע ע"י מומחה/ית. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | הנחיה עדכנית של הנוירולוג/ית | מכתב או סיכום של הנוירולוג/ית מ-12 החודשים האחרונים, עם אותה תרופה ומינון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 4.37 תרופות לאפילפסיה במעקב מומחה · Specialist epilepsy drugs

לפי הנחיה, בתנאים

נוירולוגיה - מומחה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (6) | אינובלון טבליות · Inovelon | רופינאמיד - תרימה · Trima – Rufinamide | אוספולוט · Ospolot | פינטפלה · Fintepla | אפידיולקס · Epidiolex | סטיבקס · Sativex |
| נימוק / הערה | תרופות אפילפסיה של מרכז מומחה (רופינאמיד, סולטיאם, קנבידיול, פנפלורמין). חידוש לפי ההנחיה העדכנית. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני במינון קבוע שנקבע ע"י מומחה/ית. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | הנחיה עדכנית של הנוירולוג/ית | מכתב או סיכום של הנוירולוג/ית מ-12 החודשים האחרונים, עם אותה תרופה ומינון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 4.38 תרופות לנרקולפסיה · Narcolepsy drugs לפי הנחיה, בתנאים

הפרעות שינה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | וואקיקס · Wakix \| סנוסי · Sunosi |
| נימוק / הערה | פיטוליסנט וסולריאמפטול נקבעים ע"י מרפאת שינה. חידוש לפי ההנחיה העדכנית. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני במינון קבוע שנקבע ע"י מומחה/ית. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | הנחיה עדכנית של מרפאת השינה | מכתב או סיכום של מרפאת השינה מ-12 החודשים האחרונים, עם אותה תרופה ומינון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 4.39 **גבפנטין** · Gabapentin לפי הנחיה, בתנאים

כאב נוירופתי / נוגד פרכוסים

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (2)** | נאורונטין · Neurontin \| גאבאפנטין טבע · Gabapentin Teva |
| **נימוק / הערה** | מינון לפי כליות; סיכון לשימוש לרעה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **קריאטינין מתועד** | קריאטינין/eGFR מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | **תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין** | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <60 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | **אין סימני שימוש לרעה** | אין בקשות מוקדמות או רכישות מעל 110% מהכמות שנרשמה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | **רכישות** | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | **טיפול כרוני במינון קבוע** | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | קריאטינין שנתי |
| **ספי החזרה לרופא/ה** | eGFR <60 (לבדיקת מינון) |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | ישנוניות או סחרחורת קשה ← לרופא; בצקות ← לרופא |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 4.40 פרגבלין · Pregabalin

לפי הנחיה, בתנאים

כאב נוירופתי / נוגד פרכוסים

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (5) | ליריקה · Lyrica \| בליסק · Blisk \| פרגבלין דקסל · Pregabalin Dexcel \| פרגבלין אינובמד · Pregabalin Inovamed \| פרגבלין טבע · Pregabalin Teva |
| נימוק / הערה | מינון לפי כליות; סיכון לשימוש לרעה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | קריאטינין מתועד | קריאטינין/eGFR מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <60 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אין סימני שימוש לרעה | אין בקשות מוקדמות או רכישות מעל 110% מהכמות שנרשמה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | קריאטינין שנתי |
| ספי החזרה לרופא/ה | eGFR <60 (לבדיקת מינון) |
| תלונות בפנייה או ברשומה | ישנוניות או סחרחורת קשה ← לרופא; בצקות ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 4.41 **ציננריזין** · Cinnarizine `לפי הנחיה, בתנאים`

סחרחורת · אנטיהיסטמין

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (1)** | סטונרון · Stunarone |
| **נימוק / הערה** | לא מומלץ לטיפול ממושך; בגיל מבוגר - נפילות ותופעות פרקינסוניות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **התוויה מתועדת לטיפול ממושך** | החלטה מתועדת של הרופא/ה על טיפול ממושך. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | **אין נפילות או הזיות מתועדות** | ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | **רכישות** | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | **טיפול כרוני במינון קבוע** | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | אין מעקב מעבדה |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | רעד או נוקשות חדשים ← לרופא; נפילות ← לרופא |
| **מקור** | מעקב: העלון לרופא (משרד הבריאות) · עלון לרופא (משרד הבריאות) — Stunarone (רישום בוטל) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 4.42 תרופות לטרשת נפוצה · Multiple sclerosis drugs דגל אדום

טרשת נפוצה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (29) | דיפומר אס.קיי.120 מ"ג · Difumar S.K. \| דימתיל פומרט דקסל · Dimethyl Fumarate Dexcel \| דימתיל פומרט מדומי · Dimethyl Fumarate Medomie \| דימתיל פומרט תרו · Dimethyl Fumarate Taro \| דימתיל פומרט טבע · Dimethyl Fumarate Teva \| וומריטי · Vumerity \| פינגולימוד - תרימה · Fingolimod - Trima \| פינגולימוד טבע · Fingolimod Teva \| פינולים · Finolim \| גילניה · Gilenya \| זפוסיה · Zeposia \| מייזנט · Mayzent \| אובג'יו · Aubagio \| טריפלונומיד מדומי · Teriflunomide Medomie \| טריפלונומיד תרו · Teriflunomide Taro \| טריפלונומיד טבע · Teriflunomide Teva \| ליטק · Litak \| מייבנקלאד · Mavenclad \| אוונקס תמיסה להזרקה · Avonex Solution For Injection \| בטאפרון · Betaferon \| פלגרידי · Plegridy \| רביף · Rebif \| אוקרוואס · Ocrevus \| קיסימפטה · Kesimpta \| טיירוקו · Tyruko \| טייסברי תוך ורידי · Tysabri I.V \| פמפירה · Fampyra (פמפרידין) \| פמפרידין אס.קיי. · Fampridine S.K. \| פמפרידין טבע · Fampridine Teva |
| נימוק / הערה | תרופות לטרשת נפוצה שמחייבות בדיקות דם (לימפוציטים, ספירה, תפקודי כבד) — נקבעות ע"י מרכז MS. הרפואן מכין עם הבדיקות, והרופא/ה מאשר/ת. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני במינון קבוע שנקבע ע"י מומחה/ית. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | הנחיה עדכנית של מרכז ה-MS | מכתב או סיכום של מרכז ה-MS מ-12 החודשים האחרונים, עם אותה תרופה ומינון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ספירת דם ולימפוציטים | ספירת דם מלאה מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 6 | תפקודי כבד | ALT ו-AST מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ספירת דם, לימפוציטים ותפקודי כבד — כל 6 חודשים או לפי ההנחיה |
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 4.43 גלטירמר לטרשת נפוצה (קופקסון) · Glatiramer (MS) לפי הנחיה, בתנאים

טרשת נפוצה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | קופקסון · Copaxone |
| נימוק / הערה | קופקסון (גלטירמר) לטרשת נפוצה, נקבע ע"י מרכז MS ואינו מחייב בדיקות דם שגרתיות. חידוש לפי ההנחיה העדכנית. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני במינון קבוע שנקבע ע"י מומחה/ית. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | הנחיה עדכנית של מרכז ה-MS | מכתב או סיכום של מרכז ה-MS מ-12 החודשים האחרונים, עם אותה תרופה ומינון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 4.44 בטאהיסטין · Betahistine לפי הנחיה

סחרחורת (מנייר)

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | בטיסטין · Betistine \| אגיסרק · Agiserc \| בטאהיסטין טבע · Betahistine Teva |
| נימוק / הערה | בטוח; זהירות באסתמה ובכיב פעיל בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 OP = אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 4 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 5 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 6 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 7 | אין פאוכרומוציטומה | אין ברשומה פאוכרומוציטומה. לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה |
| תלונות בפנייה או ברשומה | סחרחורת עם חולשה, הפרעת דיבור או ראייה ← דחוף - מיון; ירידה חדשה בשמיעה ← לרופא |
| מקור | מעקב: העלון לרופא (משרד הבריאות) · עלון לרופא (משרד הבריאות) — Agiserc 16 |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 4.45 מידזולם לחלל הפה להפסקת פרכוס (בוקולאם) · Midazolam buccal (seizure rescue)

הכנה לאישור רופא/ה

נוירולוגיה · תרופת הצלה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | בוקולאם · Buccolam |
| נימוק / הערה | תרופת הצלה בפרכוס ממושך, לפי תוכנית של הנוירולוג/ית. בנזודיאזפין — הרפואן מכין, הרופא/ה מאשר/ת. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 2 | הנחיה עדכנית של הנוירולוג/ית | מכתב או סיכום של הנוירולוג/ית מ-12 החודשים האחרונים, עם אותה תרופה ומינון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | מספר השימושים מאז המרשם הקודם מתועד | בפנייה או ברשומה: כמה פעמים נעשה שימוש ומתי. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| תלונות בפנייה או ברשומה | פרכוס שלא נעצר 5 דקות אחרי המנה, או קושי בנשימה ← דחוף — מד"א 101 |
| מקור | פער מול הרג'יסטרי, החלטה מקומית (8.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 4.46 קרבמזפין · Carbamazepine

מעקב צמוד | לפי הנחיה, בתנאים

נוגד פרכוסים

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | טגרטול · Tegretol \| טריל · Teril \| טימוניל · Timonil |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י נוירולוג/ית או פסיכיאטר/ית. לא נעצר ע"י רפואן, מלבד ערך חמור. הרפואן לא משנה מינון בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רמה ובדיקות מתועדות | רמת קרבמזפין, נתרן, ספירת דם ו-ALT מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | רמת התרופה בדם בטווח | בבדיקה האחרונה רמת התרופה בדם בטווח. חריג: רמה מחוץ לטווח 4-12 mg/L ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה | בבדיקה האחרונה ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה. חריג: WBC מתחת ל-3,500 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: WBC מתחת ל-3,000 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: WBC מתחת ל-3,000 ← לא מחדשים | |
| 4 | נתרן (Na) תקין | בבדיקה האחרונה נתרן (Na) תקין. חריג: Na מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: Na <125 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: Na <125 ← לא מחדשים | |
| 5 | תפקודי כבד (ALT) תקין | בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 6 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 7 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 8 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 9 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או פסיכיאטר/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 10 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 11 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 12 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 13 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 14 | תפקודי כליות וויטמין D | קריאטינין וויטמין D מהשנה האחרונה. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | רמה, נתרן, ספירת דם ו-ALT שנתי |
| ספי החזרה לרופא/ה | רמה מחוץ לטווח 4-12 mg/L; Na מחוץ לטווח המעבדה; WBC מתחת ל-3,500; ALT מעל פי 3 מהגבול העליון |
| ערך חמור | Na <125; WBC מתחת ל-3,000 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | פריחה, שלפוחיות או פצעים בפה ← הפסקה, דחוף; חום או כאב גרון ← דחוף - ספירת דם; סחרחורת, ראייה כפולה או חוסר יציבות ← לרופא |
| מקור | מעקב: SPS Medicines Monitoring · SPS Medicines Monitoring (NHS) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 4.47 ולפרואט · Valproate

לפי הנחיה, בתנאים | מעקב צמוד

נוגד פרכוסים / מייצב מצב רוח

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | דפלפט · Depalept \| דפלפט כרונו · Depalept Chrono |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י נוירולוג/ית או פסיכיאטר/ית. מסוכן בהיריון: באישה בגיל הפוריות — דגל אדום (בדיקה כפולה מול הרופא/ה) ואמצעי מניעה מתועד. הרפואן לא משנה מינון בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רמה ובדיקות מתועדות | רמת ולפרואט, ALT וספירת דם מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | רמת התרופה בדם בטווח | בבדיקה האחרונה רמת התרופה בדם בטווח. חריג: רמה מחוץ לטווח 50-100 mg/L ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה | בבדיקה האחרונה ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה. חריג: WBC או טסיות מתחת לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-50,000 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-50,000 ← לא מחדשים | |
| 4 | תפקודי כבד (ALT) תקין | בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 5 | אמצעי מניעה מתועד<br>שאלה: המטופלת אישה בגיל הפוריות? (כן = דגל אדום) | אישה בגיל הפוריות: אמצעי מניעה יעיל מתועד ברשומה. אין ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | שאלה |
| 6 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 7 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 8 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 9 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י נוירולוג/ית או פסיכיאטר/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 10 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 11 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 12 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 13 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 14 | משקל | משקל מתועד בשנה האחרונה. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | רמה, ALT וספירת דם (טסיות) שנתי |
| ספי החזרה לרופא/ה | רמה מחוץ לטווח 50-100 mg/L; ALT מעל פי 3 מהגבול העליון; WBC או טסיות מתחת לטווח המעבדה |
| ערך חמור | WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-50,000 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאבי בטן חזקים או הקאות (חשד לדלקת לבלב) ← דחוף; צהבת או חולשה ניכרת ← דחוף; חבורות או דימומים ← לרופא |
| מקור | מעקב: SPS Medicines Monitoring · SPS Medicines Monitoring (NHS) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

# 5. פסיכיאטריה

59 תרופות · לפי הנחיה: 23 · לפי הנחיה, בתנאים: 34 · הכנה לאישור רופא/ה: 2 · גרסה 2 · חלוקה לפי מערכות · 2.11.2026

מקורות: אין הנחיה בפרויקט לתחומים אלה: כל הערכים הם החלטה מקומית (הצעה); הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020; ACOG 2023 (סיכום AFP). שאר התחומים: החלטה מקומית; עלון לצרכן לפונקס (עודכן 12/2020). שאר התרופות: החלטה מקומית

## 5.א כללים

- חידוש רגיל: 3 חודשים
- ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה פעם בשנה
- עד 3 חידושים רצופים, ואז ביקור רופא
- אין התווית נגד ← תמיד מחדשים לפחות לחודש אחד
- חסרה מדידה, בדיקה או ביקורת שנתית: חידוש לחודש אחד + זימון למרפאה
- חריגה מספי ההחזרה: חידוש לחודש אחד + הודעה לרופא/ה
- התווית נגד או ערך חמור: לא מחדשים, הודעה לרופא/ה (הסף של כל תרופה מופיע ברשימה שלה)
- רפואן לא משנה מינון ולא מחליף תרופה. "מעקב צמוד" = תרופה עם מעקב תכוף (מעבדה, אק"ג, עיניים או צילום) — לבדוק כל ערך בקפידה
- מחשבות אובדניות או החמרה נפשית ← הודעה דחופה
- קלוזפין: חידוש לחודש אחד בלבד, לפי ספירת דם
- מתילפנידאט: חידוש בתנאים. בנזודיאזפינים ותרופות שינה Z: הכנה לאישור הרופא/ה
- נוגדי פסיכוזה: מעקב מטבולי שנתי; לא נעצרים ע"י רפואן מלבד ערך חמור

## 5.ג בדיקות משותפות

| שלב | נושא | מה בודקים | קריטריון | אם לא מתקיים | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| לפני כל חידוש | רכישות | כיסוי ימים ב-6 החודשים האחרונים | 80% מהימים ומעלה | פחות ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה | כמו ביל"ד |
| לפני כל חידוש | ביקורת שנתית | ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה | ב-12 החודשים האחרונים | אין ← חידוש לחודש + זימון לביקורת | כמו ביל"ד |
| לפני כל חידוש | רצף חידושים | כמה חידושים רצופים מאז ביקור רופא | פחות מ-3 | 3 ← ביקור רופא | כמו ביל"ד |
| לפני כל חידוש | רמה או ספירה מתועדת | לפי התרופה | ליתיום: 6 חודשים; דיגוקסין: 12 חודשים; קלוזפין: 4 שבועות | אין ← חידוש לחודש + זימון לבדיקה | החלטות מעקב-1, 3, 5 |
| לפני כל חידוש | רמה בטווח | הבדיקה האחרונה | ליתיום 0.6-1.0; דיגוקסין עד 1.2; קלוזפין WBC ≥3,500 ונויטרופילים ≥2,000 | מחוץ לטווח ← חידוש לחודש + הודעה; ערך חמור ← לא מחדשים | החלטות מעקב-2, 4, 5 |
| לפני כל חידוש | תרופות חדשות | רשימת התרופות | ליתיום: NSAIDs, ACEi, ARB, משתנים. דיגוקסין: אמיודרון, ורפמיל, דילטיאזם, קלריתרומיצין | יש ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה | החלטות מעקב-2, 4 |
| החזרה מיידית לרופא | חשד לרעילות | מופיע בפנייה או ברשומה | ליתיום: רעד, הקאות, שלשול, בלבול. דיגוקסין: בחילות, הפרעות ראייה, בלבול | דחוף - לרופא עכשיו | החלטות מעקב-2, 4 |
| החזרה מיידית לרופא | חום בקלוזפין | מופיע בפנייה או ברשומה | חום, כאב גרון, זיהום | דחוף - ספירת דם היום | עלון לצרכן לפונקס (עודכן 12/2020) |

## 5.ד החלטות

| # | נושא | מה ההנחיה אומרת | ההחלטה לפרוטוקול | סוג | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| נוירו-1 | תרופות שלא נעצרות | נוגדי פרכוסים: הפסקה רק בהנחיית מומחה (NICE NG217); פרקינסון ובקלופן: אין להפסיק בפתאומיות (NICE NG71; תווית FDA) | נוגדי פרכוסים, פרקינסון, בקלופן, גואנפצין: רפואן לא עוצר; חריגה ← חידוש לחודש + הודעה | החלטה מקומית (הצעה) | NICE NG217; NICE NG71; תווית |
| נוירו-7 | השלמות (2.11.2026) | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) | פרימידון, פנוברביטל (רמה 40-15), אסליקרבזפין (נתרן), פרמפנל, צנובמט, אנטי-כולינרגיים (גיל 65+: קוגניציה), מיאנסרין, מפרוטילין, דוקספין | החלטה מקומית (הצעה) | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| נוירו-8 | השלמות 2 (2.11.2026) | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) | בוספירון, אנטגוניסטי אורקסין, גפנטים, נרטריפטן, מילנציפרן, רבוקסטין, אופיקפון, סלג'ילין, רילוזול (ALT). עודכן ב-7.11.2026: אפומורפין/טטרבנזין, אפילפסיה מומחה ונרקולפסיה — לפי הנחיה עדכנית של המומחה/ית | החלטה מקומית (הצעה) | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| כללי-13 | חידוש ע"י רופא/ה בלבד | רואקוטן: מרשם ע"י רופא/ת עור בלבד, אנטיביוטיקה לתסמין חדש ותרופות נגד שפעת: הכלי מציג הודעה ולא רשימת בדיקות | רואקוטן (רופא/ת עור בלבד), אנטיביוטיקה לתסמין חדש ותרופות נגד שפעת: הכלי מציג הודעה ולא רשימת בדיקות | החלטה מקומית | משרד הבריאות; EMA |
| כללי-21 | תרופות מומחה נוספות | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי). הטיפול נקבע ומנוטר ע"י המומחה | מטוקלופרמיד ממושך, ממריצים/מודפיניל, טרשת נפוצה, אונקולוגיה, יל"ד ריאתי/IPF, סירולימוס, הורמון גדילה, המטולוגיה, CF, טפמידיס/מבקמטן: הודעה בלבד, חידוש ע"י רופא/ה. תרופות ביולוגיות בזריקה בקהילה: הרפואן מכין (אישור, מכתב מומחה, מרווח, בטיחות) והרופא/ה מאשר/ת (5.11.2026) | החלטה מקומית | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| מעקב-1 | ליתיום: תדירות | רמה כל 3 חודשים בשנה הראשונה ואז כל 6 חודשים; eGFR, TSH וסידן כל 6 חודשים | רמה, קריאטינין/eGFR, נתרן, TSH וסידן מ-6 החודשים האחרונים | החלטה מקומית (הצעה) | NICE CG185 |
| מעקב-2 | ליתיום: ערכים | רמה מכוונת 0.6-0.8 (עד 1.0) mmol/L; מעל 1.5 — רעילות; ירידה בתפקוד הכליות ← הערכה מחדש | רמה 0.6-1.0 ← תקין. מחוץ לטווח, Na חריג או eGFR <60 ← חידוש לחודש + הודעה. רמה ≥1.5 ← ערך חמור. תרופה חדשה שמעלה רמה ← הודעה | החלטה מקומית (הצעה) | NICE CG185 |
| מעקב-5 | קלוזפין (לפונקס) | ספירת דם כל שבוע ב-18 השבועות הראשונים, אחר כך לפחות פעם בחודש; ניפוק רק עם ספירה תקינה | רפואן מחדש רק בשלב החודשי, לחודש אחד, עם ספירה מ-4 השבועות האחרונים. WBC 3,000-3,500 או נויטרופילים 1,500-2,000 ← הודעה. מתחת ← ערך חמור, דחוף | הנחיה + החלטה מקומית (ספי הספירה: הצעה) | עלון לצרכן לפונקס (עודכן 12/2020) |
| מעקב-13 | נוגדי פסיכוזה נוספים | מעקב מטבולי (משקל, גלוקוז/HbA1c, שומנים) בתחילה, אחרי 12 שבועות ואז שנתי; אק"ג לפי התווית (QT) | הלופרידול, פליפרידון, קריפרזין, זיפרזידון, פרפנזין: מעקב מטבולי כמו בשאר; אק"ג בגיל 50+ בהלופרידול וזיפרזידון | החלטה מקומית (הצעה) | NICE CG178; ADA/APA 2004 |
| מעקב-14 | נוגדי פסיכוזה ותיקים | מעקב מטבולי (משקל, גלוקוז/HbA1c, שומנים) בתחילה, אחרי 12 שבועות ואז שנתי | אמיסולפריד, סולפיריד, פלופנזין, זוקלופנתיקסול, קלוטיאפין, לבומפרומזין: מעקב מטבולי כמו בשאר | החלטה מקומית (הצעה) | NICE CG178; ADA/APA 2004 |
| מעקב-15 | נוגדי פסיכוזה נוספים (2) | מעקב מטבולי כמו בשאר; סרטינדול: אק"ג לפני, בהגעה למינון יציב, אחרי 3 חודשים ואז כל 3 חודשים (עלון) | ברקספיפרזול, אסנפין, אילופרידון, סרטינדול (אק"ג כל 3 חודשים), תיורידזין | החלטה מקומית (הצעה) | NICE CG178; עלון סרטינדול |

| # | נושא | מה ההנחיה אומרת | ההחלטה לפרוטוקול | סוג | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| סקירה-1 | סקירת פריטים חסומים (7.11.2026) | נושא תפעולי — הנחיות קליניות לא עוסקות בו; מבוסס על נוהל הרפואן | אף תרופה לא חסומה כברירת מחדל. 59 הפריטים שהיו "רופא/ה בלבד" נסקרו אחד-אחד: חלקם פתוחים עם רשימת בדיקות, חלקם בדגל אדום (בדיקה כפולה מול הרופא/ה). נשארים אצל הרופא/ה: רואקוטן, אנטיביוטיקה לתסמין חדש (מלבד מוקסיפן/רפאפן אחרי משטח גרון חיובי) ותרופות נגד שפעת. התראת האינטראקציות של המערכת היא שכבת ההגנה הבסיסית. | החלטה מקומית (7.11.2026) | - |

## 5.ה רשימת התרופות (לסימון)

| # | שם | גנרי | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | מירטזפין | Mirtazapine | נוגד דיכאון | לפי הנחיה | ☐ | |
| 5.2 | טרזודון | Trazodone | נוגד דיכאון / שינה | לפי הנחיה | ☐ | |
| 5.3 | בופרופיון | Bupropion | נוגד דיכאון / גמילה מעישון | לפי הנחיה | ☐ | |
| 5.4 | וורטיוקסטין | Vortioxetine | נוגד דיכאון | לפי הנחיה | ☐ | |
| 5.5 | פלובוקסמין | Fluvoxamine | SSRI | לפי הנחיה | ☐ | |
| 5.6 | אמיטריפטילין | Amitriptyline | נוגד דיכאון טריציקלי | לפי הנחיה | ☐ | |
| 5.7 | נורטריפטילין | Nortriptyline | נוגד דיכאון טריציקלי | לפי הנחיה | ☐ | |
| 5.8 | קלומיפרמין | Clomipramine | נוגד דיכאון טריציקלי | לפי הנחיה | ☐ | |
| 5.9 | אטומוקסטין | Atomoxetine | ADHD · לא ממריץ | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 5.10 | גואנפצין | Guanfacine | ADHD · לא ממריץ | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 5.11 | ורניקלין | Varenicline | גמילה מעישון (קורס) | לפי הנחיה | ☐ | |
| 5.12 | מלטונין | Melatonin | שינה | לפי הנחיה | ☐ | |
| 5.13 | מיאנסרין | Mianserin | נוגד דיכאון | לפי הנחיה | ☐ | |
| 5.14 | מפרוטילין | Maprotiline | נוגד דיכאון טטרציקלי | לפי הנחיה | ☐ | |
| 5.15 | דוקספין | Doxepin | נוגד דיכאון טריציקלי / שינה | לפי הנחיה | ☐ | |
| 5.16 | בוספירון | Buspirone | נוגד חרדה | לפי הנחיה | ☐ | |
| 5.17 | דרידורקסנט | Daridorexant | שינה · אנטגוניסט אורקסין | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 5.18 | למבורקסנט | Lemborexant | שינה · אנטגוניסט אורקסין | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 5.19 | מילנציפרן | Milnacipran | SNRI | לפי הנחיה | ☐ | |
| 5.20 | רבוקסטין | Reboxetine | נוגד דיכאון (NRI) | לפי הנחיה | ☐ | |
| 5.21 | אסציטלופרם | Escitalopram | SSRI | לפי הנחיה | ☐ | |
| 5.22 | ציטלופרם | Citalopram | SSRI | לפי הנחיה | ☐ | |
| 5.23 | סרטרלין | Sertraline | SSRI | לפי הנחיה | ☐ | |
| 5.24 | פלואוקסטין | Fluoxetine | SSRI | לפי הנחיה | ☐ | |
| 5.25 | פרוקסטין | Paroxetine | SSRI | לפי הנחיה | ☐ | |
| 5.26 | ונלפקסין | Venlafaxine | SNRI | לפי הנחיה | ☐ | |
| 5.27 | דולוקסטין | Duloxetine | SNRI | לפי הנחיה | ☐ | |
| 5.28 | מתילפנידאט (מבוגרים) | Methylphenidate (adults) | ADHD · ממריץ (סם מסוכן) | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |

| # | שם | גנרי | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.29 | מתילפנידאט (ילדים ובני נוער) | Methylphenidate (children) | ADHD · ממריץ (סם מסוכן) | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 5.30 | ליסדקסאמפטמין (מבוגרים) | Lisdexamfetamine (adults) | ADHD · ממריץ (סם מסוכן) | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 5.31 | ליסדקסאמפטמין (ילדים ובני נוער) | Lisdexamfetamine (children) | ADHD · ממריץ (סם מסוכן) | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 5.32 | בנזודיאזפינים ותרופות שינה | Benzodiazepines / Z-drugs | מרגיעים ותרופות שינה | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 5.33 | מלחי אמפטמין (מבוגרים) | Amphetamine salts (adults) | ADHD · ממריץ (סם מסוכן) | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 5.34 | מלחי אמפטמין (ילדים ובני נוער) | Amphetamine salts (children) | ADHD · ממריץ (סם מסוכן) | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 5.35 | מודפיניל / ארמודפיניל | Modafinil / armodafinil | תרופות ערנות | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 5.36 | נלמפן (סלינקרו) | Nalmefene | התמכרות לאלכוהול · מומחה | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 5.37 | קסנומלין-טרוספיום (קובנפי) | Xanomeline-trospium | נוגד פסיכוזה · מוסקריני | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 5.38 | ליתיום | Lithium carbonate | מייצב מצב רוח | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |
| 5.39 | קלוזפין | Clozapine | נוגד פסיכוזה (מעקב ספירת דם חובה) | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |
| 5.40 | אולנזפין | Olanzapine | נוגד פסיכוזה | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |
| 5.41 | קוטיאפין | Quetiapine | נוגד פסיכוזה | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |
| 5.42 | ריספרידון | Risperidone | נוגד פסיכוזה | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |
| 5.43 | אריפיפרזול | Aripiprazole | נוגד פסיכוזה | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |
| 5.44 | הלופרידול | Haloperidol | נוגד פסיכוזה | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |
| 5.45 | פליפרידון | Paliperidone | נוגד פסיכוזה | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |
| 5.46 | קריפרזין | Cariprazine | נוגד פסיכוזה | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |
| 5.47 | זיפרזידון | Ziprasidone | נוגד פסיכוזה | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |
| 5.48 | פרפנזין | Perphenazine | נוגד פסיכוזה | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |

| # | שם | גנרי | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.49 | אמיסולפריד | Amisulpride | נוגד פסיכוזה | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |
| 5.50 | סולפיריד | Sulpiride | נוגד פסיכוזה | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |
| 5.51 | פלופנזין | Fluphenazine | נוגד פסיכוזה | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |
| 5.52 | זוקלופנתיקסול | Zuclopenthixol | נוגד פסיכוזה | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |
| 5.53 | קלוטיאפין | Clotiapine | נוגד פסיכוזה | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |
| 5.54 | לבומפרומזין | Levomepromazine | נוגד פסיכוזה | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |
| 5.55 | ברקספיפרזול | Brexpiprazole | נוגד פסיכוזה | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |
| 5.56 | אסנפין | Asenapine | נוגד פסיכוזה | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |
| 5.57 | אילופרידון | Iloperidone | נוגד פסיכוזה | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |
| 5.58 | סרטינדול | Sertindole | נוגד פסיכוזה | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |
| 5.59 | תיורידזין | Thioridazine | נוגד פסיכוזה | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |

## 1.5 פירוט מלא

### 5.1 מירטזפין · Mirtazapine לפי הנחיה

נוגד דיכאון

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | מירו · Miro | מירטא טבע · Mirta Teva |
| נימוק / הערה | ישנוניות, עלייה במשקל; נתרן בגיל 65+ |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | נתרן תקין (גיל 65+)<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה? | נתרן מ-12 החודשים האחרונים ובטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 2 | אין החמרה מתועדת | ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | נתרן שנתי בגיל 65+ |
| תלונות בפנייה או ברשומה | מחשבות אובדניות ← דחוף; החמרה במצב הרוח או אי-שקט קשה ← לרופא; חום או כאב גרון ← לרופא - ספירת דם |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · FDA (DailyMed) עלון |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 5.2 **טרזודון** · Trazodone לפי הנחיה

נוגד דיכאון / שינה

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (2)** | טריטיקו · Trittico \| טרזודיל · Trazodil |
| **נימוק / הערה** | סחרחורת ונפילות בגיל מבוגר |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **נתרן תקין (גיל 65+)**<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה? | נתרן מ-12 החודשים האחרונים ובטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 2 | **אין החמרה מתועדת** | ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | **אין נפילות או הזיות מתועדות** | ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | **רכישות** | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | נתרן שנתי בגיל 65+ |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | מחשבות אובדניות ← דחוף; החמרה במצב הרוח או אי-שקט קשה ← לרופא; זקפה ממושכת וכואבת ← דחוף - מיון |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.3 בופרופיון · Bupropion לפי הנחיה

נוגד דיכאון / גמילה מעישון

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (4) | וולבוטרין Wellbutrin XR · XR | זיבן · Zyban | בופרופיון · Bupropion Hydrochloride | אובליטי ® · Auvelity (עם דקסטרומתורפן) |
| נימוק / הערה | מוריד סף פרכוס; ל"ד |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין החמרה מתועדת | ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 2 | מדידת ל"ד מתועדת | מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 3 | ל"ד מתחת ל-140/90 | מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 10 | אין התווית נגד | פרכוסים בעבר; אנורקסיה או בולימיה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ל"ד שנתי |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | פרכוסים בעבר; אנורקסיה או בולימיה |
| תלונות בפנייה או ברשומה | מחשבות אובדניות ← דחוף; החמרה במצב הרוח או אי-שקט קשה ← לרופא; פרכוס ← דחוף - הפסקה |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 5.4 וורטיוקסטין · Vortioxetine לפי הנחיה

נוגד דיכאון

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | ברינטליקס · Brintellix |
| נימוק / הערה | נתרן בגיל 65+ |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | נתרן תקין (גיל 65+)<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה? | נתרן מ-12 החודשים האחרונים ובטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 2 | אין החמרה מתועדת | ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | נתרן שנתי בגיל 65+ |
| תלונות בפנייה או ברשומה | מחשבות אובדניות ← דחוף; החמרה במצב הרוח או אי-שקט קשה ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 5.5 פלובוקסמין · Fluvoxamine לפי הנחיה

SSRI

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | פבוקסיל · Favoxil |
| נימוק / הערה | אינטראקציות רבות (תאופילין, קלוזפין, טיזנידין) |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | נתרן תקין (גיל 65+)<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה? | נתרן מ-12 החודשים האחרונים ובטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 2 | אין החמרה מתועדת | ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | נתרן שנתי בגיל 65+ |
| תלונות בפנייה או ברשומה | מחשבות אובדניות ← דחוף; החמרה במצב הרוח או אי-שקט קשה ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · FDA (DailyMed) עלון |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.6 אמיטריפטילין · Amitriptyline לפי הנחיה

נוגד דיכאון טריציקלי

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | אמיטריפטילין טבע · Amitriptyline Teva |
| נימוק / הערה | רעיל במנת יתר; QT, נפילות, עצירות ואצירת שתן בגיל מבוגר |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | נתרן תקין (גיל 65+)<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה? | נתרן מ-12 החודשים האחרונים ובטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 2 | אין החמרה מתועדת | ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | אק"ג מתועד<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 50 ומעלה או עם מחלת לב? | אק"ג מ-12 החודשים האחרונים ללא QTc מוארך. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 4 | אין נפילות או הזיות מתועדות | ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אק"ג בגיל 50+ או במחלת לב |
| תלונות בפנייה או ברשומה | מחשבות אובדניות ← דחוף; החמרה במצב הרוח או אי-שקט קשה ← לרופא; דפיקות לב או עילפון ← דחוף; אצירת שתן או עצירות קשה ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-(DailyMed) FDA · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 5.7 נורטריפטילין · Nortriptyline לפי הנחיה

נוגד דיכאון טריציקלי

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | נורטילין · Nortylin |
| נימוק / הערה | רעיל במנת יתר; QT, נפילות, עצירות ואצירת שתן בגיל מבוגר |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | נתרן תקין (גיל 65+)<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה? | נתרן מ-12 החודשים האחרונים ובטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 2 | אין החמרה מתועדת | ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | אק"ג מתועד<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 50 ומעלה או עם מחלת לב? | אק"ג מ-12 החודשים האחרונים ללא QTc מוארך. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 4 | אין נפילות או הזיות מתועדות | ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אק"ג בגיל 50+ או במחלת לב |
| תלונות בפנייה או ברשומה | מחשבות אובדניות ← דחוף; החמרה במצב הרוח או אי-שקט קשה ← לרופא; דפיקות לב או עילפון ← דחוף; אצירת שתן או עצירות קשה ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 5.8 קלומיפרמין · Clomipramine לפי הנחיה

נוגד דיכאון טריציקלי

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | אנאפרניל · Anafranil \| אנאפרניל SR · Anafranil SR |
| נימוק / הערה | רעיל במנת יתר; QT, נפילות, עצירות ואצירת שתן בגיל מבוגר |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | נתרן תקין (גיל 65+)<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה? | נתרן מ-12 החודשים האחרונים ובטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 2 | אין החמרה מתועדת | ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | אק"ג מתועד<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 50 ומעלה או עם מחלת לב? | אק"ג מ-12 החודשים האחרונים ללא QTc מוארך. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 4 | אין נפילות או הזיות מתועדות | ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 OP = 2 אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אק"ג בגיל 50+ או במחלת לב |
| תלונות בפנייה או ברשומה | מחשבות אובדניות ← דחוף; החמרה במצב הרוח או אי-שקט קשה ← לרופא; דפיקות לב או עילפון ← דחוף; אצירת שתן או עצירות קשה ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-(DailyMed) FDA · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.9 **אטומוקסטין** · Atomoxetine לפי הנחיה, בתנאים

ADHD · לא ממריץ

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (2)** | אטומיק · Atomic \| אטומוקסימד · Atomoximed |
| **נימוק / הערה** | ל"ד ודופק; מחשבות אובדניות בצעירים |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **אין החמרה מתועדת** | ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 2 | **מדידת ל"ד מתועדת** | מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 3 | **ל"ד מתחת ל-140/90** | מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | **דופק מתחת ל-100** | דופק במדידה האחרונה מתחת ל-100. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | **רכישות** | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | **טיפול כרוני במינון קבוע** | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 8 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | ל"ד ודופק כל 6 חודשים |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | מחשבות אובדניות ← דחוף; החמרה במצב הרוח או אי-שקט קשה ← לרופא; צהבת או שתן כהה ← דחוף; דפיקות לב ← לרופא |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-(DailyMed) FDA · עלון (DailyMed) FDA |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.10 גואנפצין · Guanfacine

לפי הנחיה, בתנאים

ADHD · לא ממריץ

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | גואנפצין מדומי · Guanfacine Medomie |
| נימוק / הערה | לא נעצר בפתאומיות (עלייה חדה בל"ד). ל"ד נמוך ודופק איטי |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | ל"ד ודופק מתועדים | מדידת ל"ד ודופק מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | דופק במנוחה תקין | במדידה האחרונה דופק במנוחה תקין. חריג: מתחת ל-55 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים | |
| 3 | אין עילפון מתועד | ברשומה או בפנייה אין עילפון או סחרחורת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 OP = 2 אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ל"ד ודופק כל 6 חודשים |
| ספי החזרה לרופא/ה | דופק מתחת ל-55 |
| ערך חמור | דופק מתחת ל-50 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | עילפון או סחרחורת ← דחוף; ישנוניות קשה ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.11 ורניקלין · Varenicline לפי הנחיה

גמילה מעישון (קורס)

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | צ'מפיקס · Champix \| אפו-ורניקלין · Apo-Varenicline |
| נימוק / הערה | קורס 12 שבועות (עד 24 אם נגמל/ה) |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | בתוך משך הקורס | סך הטיפול עד 12 שבועות, או עד 24 שבועות עם החלטה מתועדת של הרופא/ה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | אין החמרה מתועדת | ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 5 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה |
| תלונות בפנייה או ברשומה | מחשבות אובדניות ← דחוף; החמרה במצב הרוח או אי-שקט קשה ← לרופא; בחילות קשות ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.12 מלטונין · Melatonin לפי הנחיה

שינה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | סירקדין · Circadin \| מלטונין אינובמד · Melatonin Inovamed \| סלנייטו · Slenyto (ילדים - ע"י מומחה) |
| נימוק / הערה | סירקדין: גיל 55+; ילדים (סלנייטו) - רק ע"י מומחה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 4 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 5 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 6 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה |
| תלונות בפנייה או ברשומה | ישנוניות ביום ← לרופא |
| מקור | מעקב: העלון לרופא (משרד הבריאות) · עלון לרופא (משרד הבריאות) — Circadin |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.13 מיאנסרין · Mianserin לפי הנחיה

נוגד דיכאון

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | בונסרין · Bonserin |
| נימוק / הערה | אגרנולוציטוזיס נדירה; נתרן בגיל 65+ בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | נתרן תקין (גיל 65+)<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה? | נתרן מ-12 החודשים האחרונים ובטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 2 | אין החמרה מתועדת | ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | אין חום או כאב גרון | ברשומה או בפנייה אין חום, כאב גרון או פצעים בפה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 10 | אין מחלת כבד קשה | אין ברשומה שחמת או מחלת כבד קשה. לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 11 | אין היפומאניה | בפנייה או ברשומה אין סימני היפומאניה או מאניה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | נתרן שנתי בגיל 65+ |
| תלונות בפנייה או ברשומה | מחשבות אובדניות ← דחוף; החמרה במצב הרוח או אי-שקט קשה ← לרופא; חום או כאב גרון ← דחוף - ספירת דם |
| מקור | מעקב: העלון לרופא (משרד הבריאות) · עלון לרופא (משרד הבריאות) — Bonserin |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.14 מפרוטילין · Maprotiline לפי הנחיה

נוגד דיכאון טטרציקלי

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | מלודיל · Melodil |
| נימוק / הערה | מוריד סף פרכוס; QT |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | נתרן תקין (גיל 65+)<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה? | נתרן מ-12 החודשים האחרונים ובטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 2 | אין החמרה מתועדת | ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | אק"ג מתועד<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 50 ומעלה או עם מחלת לב? | אק"ג מ-12 החודשים האחרונים ללא QTc מוארך. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 4 | אין נפילות או הזיות מתועדות | ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אק"ג בגיל 50+ |
| תלונות בפנייה או ברשומה | מחשבות אובדניות ← דחוף; החמרה במצב הרוח או אי-שקט קשה ← לרופא; פרכוס ← דחוף |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.15 דוקספין · Doxepin לפי הנחיה

נוגד דיכאון טריציקלי / שינה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | גילקס · Gilex |
| נימוק / הערה | כמו טריציקליים: QT, נפילות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | נתרן תקין (גיל 65+)<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה? | נתרן מ-12 החודשים האחרונים ובטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 2 | אין החמרה מתועדת | ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | אק"ג מתועד<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 50 ומעלה או עם מחלת לב? | אק"ג מ-12 החודשים האחרונים ללא QTc מוארך. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 4 | אין נפילות או הזיות מתועדות | ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 OP = 2 אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אק"ג בגיל 50+ |
| תלונות בפנייה או ברשומה | מחשבות אובדניות ← דחוף; החמרה במצב הרוח או אי-שקט קשה ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-(DailyMed) FDA · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.16 בוספירון · Buspirone לפי הנחיה

נוגד חרדה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | סורבון · Sorbon |
| נימוק / הערה | ללא תלות; אינטראקציה עם מעכבי MAO |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין החמרה מתועדת | ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 2 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 5 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 6 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 7 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה |
| תלונות בפנייה או ברשומה | מחשבות אובדניות ← דחוף; החמרה במצב הרוח או אי-שקט קשה ← לרופא; סחרחורת ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.17 דרידורקסנט · Daridorexant לפי הנחיה, בתנאים

שינה · אנטגוניסט אורקסין

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | קיוויויק · Quviviq |
| נימוק / הערה | פחות תלות מבנזודיאזפינים; לא עם אלכוהול. אסור בנרקולפסיה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין נפילות או הזיות מתועדות | ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | אין התווית נגד | נרקולפסיה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | נרקולפסיה |
| תלונות בפנייה או ברשומה | ישנוניות ביום או שיתוק שינה ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.18 למבורקסנט · Lemborexant לפי הנחיה, בתנאים

שינה · אנטגוניסט אורקסין

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | דייויגו · Dayvigo |
| נימוק / הערה | פחות תלות מבנזודיאזפינים; לא עם אלכוהול. אסור בנרקולפסיה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין נפילות או הזיות מתועדות | ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | אין התווית נגד | נרקולפסיה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | נרקולפסיה |
| תלונות בפנייה או ברשומה | ישנוניות ביום או שיתוק שינה ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · FDA (DailyMed) עלון |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.19 מילנציפרן · Milnacipran לפי הנחיה

SNRI

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | מילנאבניר · Miln-Avenir |
| נימוק / הערה | ל"ד ודופק; נתרן בגיל 65+ |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | נתרן תקין (גיל 65+)<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה? | נתרן מ-12 החודשים האחרונים ובטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 2 | אין החמרה מתועדת | ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | מדידת ל"ד מתועדת | מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 4 | ל"ד מתחת ל-140/90 | מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ל"ד שנתי; נתרן בגיל 65+ |
| תלונות בפנייה או ברשומה | מחשבות אובדניות ← דחוף; החמרה במצב הרוח או אי-שקט קשה ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.20 רבוקסטין · Reboxetine לפי הנחיה

נוגד דיכאון (NRI)

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | אדרונקס · Edronax |
| נימוק / הערה | ל"ד, דופק ואצירת שתן בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | נתרן תקין (גיל 65+)<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה? | נתרן מ-12 החודשים האחרונים ובטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 2 | אין החמרה מתועדת | ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | מדידת ל"ד מתועדת | מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 4 | ל"ד מתחת ל-140/90 | מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | לא בקשישים | לפי העלון לא מומלץ בקשישים; בגיל 65 ומעלה — החלטת רופא/ה מתועדת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ל"ד שנתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | מחשבות אובדניות ← דחוף; החמרה במצב הרוח או אי-שקט קשה ← לרופא; קושי במתן שתן ← לרופא |
| מקור | מעקב: העלון לרופא (משרד הבריאות) · עלון לרופא (משרד הבריאות) — Edronax |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.21 **אסציטלופרם** · Escitalopram לפי הנחיה

SSRI

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (4)** | ציפרלקס · Cipralex | אסטו · Esto | אסציטאלופרם טבע · Escitalopram Teva | אסציטאלופרם מדו · Escitalopram Medo |
| **נימוק / הערה** | נתרן בגיל 65+; החמרה או מחשבות אובדניות ← דחוף |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **נתרן תקין (גיל 65+)**<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה? | נתרן מ-12 החודשים האחרונים ובטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 2 | **אין החמרה מתועדת** | ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | **רכישות** | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | נתרן שנתי בגיל 65+ |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | מחשבות אובדניות ← דחוף; בלבול או חולשה (נתרן נמוך) ← לרופא; דימומים ← לרופא |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.22 **ציטלופרם** · Citalopram לפי הנחיה

SSRI

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (3)** | ציפראמיל · Cipramil | רסיטל · Recital | ציטאלופרם טבע · Citalopram Teva |
| **נימוק / הערה** | נתרן בגיל 65+; החמרה או מחשבות אובדניות ← דחוף בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **נתרן תקין (גיל 65+)**<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה? | נתרן מ-12 החודשים האחרונים ובטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 2 | **אין החמרה מתועדת** | ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | **רכישות** | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | **אק"ג בסיכון לבבי** | במחלת לב, הפרעת קצב או אלקטרוליטים: אק"ג מהשנה האחרונה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 10 | **QTc אחרון מתחת ל-500** | באק"ג האחרון QTc מתחת ל-500 msec. לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | נתרן שנתי בגיל 65+ |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | מחשבות אובדניות ← דחוף; בלבול או חולשה (נתרן נמוך) ← לרופא; דימומים ← לרופא |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.23 סרטרלין · Sertraline לפי הנחיה

SSRI

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | לוסטרל · Lustral \| סרנדה · Serenada \| סרטרלין טבע · Sertraline Teva |
| נימוק / הערה | נתרן בגיל 65+; החמרה או מחשבות אובדניות ← דחוף |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | נתרן תקין (גיל 65+)<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה? | נתרן מ-12 החודשים האחרונים ובטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 2 | אין החמרה מתועדת | ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | נתרן שנתי בגיל 65+ |
| תלונות בפנייה או ברשומה | מחשבות אובדניות ← דחוף; בלבול או חולשה (נתרן נמוך) ← לרופא; דימומים ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · FDA (DailyMed) עלון |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.24 פלואוקסטין · Fluoxetine לפי הנחיה

SSRI

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | פריזמה · Prizma \| פלוטין · Flutine \| פלואוקסטין ג'י.אל. · Fluoxetine G.L. |
| נימוק / הערה | נתרן בגיל 65+; החמרה או מחשבות אובדניות ← דחוף |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | נתרן תקין (גיל 65+)<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה? | נתרן מ-12 החודשים האחרונים ובטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 2 | אין החמרה מתועדת | ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | נתרן שנתי בגיל 65+ |
| תלונות בפנייה או ברשומה | מחשבות אובדניות ← דחוף; בלבול או חולשה (נתרן נמוך) ← לרופא; דימומים ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · FDA (DailyMed) עלון |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.25 פרוקסטין · Paroxetine לפי הנחיה

SSRI

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | סרוקסט · Seroxat \| פאקסט · Paxxet \| פרוטין · Parotin |
| נימוק / הערה | נתרן בגיל 65+; החמרה או מחשבות אובדניות ← דחוף |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | נתרן תקין (גיל 65+)<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה? | נתרן מ-12 החודשים האחרונים ובטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 2 | אין החמרה מתועדת | ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | נתרן שנתי בגיל 65+ |
| תלונות בפנייה או ברשומה | מחשבות אובדניות ← דחוף; בלבול או חולשה (נתרן נמוך) ← לרופא; דימומים ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · FDA (DailyMed) עלון |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.26 ונלפקסין · Venlafaxine לפי הנחיה

SNRI

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | אפקסור Efexor XR · XR | ויפאקס · Viepax | וונלה · Venla |
| נימוק / הערה | נתרן בגיל 65+; החמרה או מחשבות אובדניות ← דחוף |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | נתרן תקין (גיל 65+)<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה? | נתרן מ-12 החודשים האחרונים ובטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 2 | אין החמרה מתועדת | ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | ל"ד מתחת ל-140/90 | מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | נתרן שנתי בגיל 65+ ; ל"ד |
| תלונות בפנייה או ברשומה | מחשבות אובדניות ← דחוף; בלבול או חולשה (נתרן נמוך) ← לרופא; דימומים ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · FDA (DailyMed) עלון |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.27 דולוקסטין · Duloxetine לפי הנחיה

SNRI

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (4) | דולוקס טבע · Dulox Teva \| דולוקסטין מדו · Duloxetine Medo \| דולוקסטין אס.קיי. · Duloxetine S.K. \| דולוקסטין סנדוז · Duloxetine Sandoz |
| נימוק / הערה | נתרן בגיל 65+; החמרה או מחשבות אובדניות ← דחוף |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | נתרן תקין (גיל 65+)<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 65 ומעלה? | נתרן מ-12 החודשים האחרונים ובטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 2 | אין החמרה מתועדת | ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | נתרן שנתי בגיל 65+ |
| תלונות בפנייה או ברשומה | מחשבות אובדניות ← דחוף; בלבול או חולשה (נתרן נמוך) ← לרופא; דימומים ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.28 מתילפנידאט (מבוגרים) · Methylphenidate (adults) לפי הנחיה, בתנאים

ADHD · ממריץ (סם מסוכן)

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (11) | ריטלין · Ritalin | ריטלין LA · Ritalin LA | קונסרטה · Concerta | רפנידאט · Rephenidate | פנידין · Phenidin | תרופן · Tarophen | מטדקס XR · Metadex XR | מתילפנידאט טבע · Methylphenidate Teva | מתילפנידאט סנדוז · Methylphenidate Sandoz | ריאבניר LA · Riavenir LA | קוויליואנט XR · Quillivant XR |
| נימוק / הערה | סם מסוכן: מחודש ע"י רפואן רק כשרשום בתרופות הקבועות, עם אבחנה מצורפת למרשם. אפשר ל-3 חודשים (מרשמים עתידיים). בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רשומה בתרופות הקבועות | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהתרופה רשומה בתרופות הקבועות ונרשמה בעבר ע"י רופא/ה. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | אבחנה מתועדת ומצורפת למרשם | אבחנת ADHD (או נרקולפסיה) ברשימת האבחנות, ומצורפת למרשם ("ADD במעקב שלי"). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | עברו כ-3 חודשים מהמרשם הקודם | תרופה עם פוטנציאל התמכרות: בקשה לפני שעברו כ-3 חודשים, או רכישות מעבר לכמות שנרשמה ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 10 | לחץ דם ודופק | לחץ דם ודופק מתועדים בשנה האחרונה. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ילדים: משקל, גובה, דופק ול"ד כל 6 חודשים |
| תלונות בפנייה או ברשומה | ירידה בתיאבון ובמשקל ← לרופא; דפיקות לב, כאב בחזה או עילפון ← דחוף; מחשבות אובדניות או שינוי חד במצב הרוח ← דחוף |
| מקור | החלטה מקומית (3.11.2026); NICE NG87 (מעקב בילדים); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.29 מתילפנידאט (ילדים ובני נוער) · Methylphenidate (children) לפי הנחיה, בתנאים

ADHD · ממריץ (סם מסוכן)

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (11) | ריטלין · Ritalin | ריטלין LA · Ritalin LA | קונסרטה · Concerta | רפנידאט · Rephenidate | פנידין · Phenidin | תרופן · Tarophen | מטדקס XR · Metadex XR | מתילפנידאט טבע · Methylphenidate Teva | מתילפנידאט סנדוז · Methylphenidate Sandoz | ריאבניר LA · Riavenir LA | קוויליואנט XR · Quillivant XR |
| נימוק / הערה | סם מסוכן: מחודש ע"י רפואן רק כשרשום בתרופות הקבועות, עם אבחנה מצורפת למרשם. אפשר ל-3 חודשים (מרשמים עתידיים). בילדים גם משקל, גובה, דופק ול"ד כל 6 חודשים. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רשומה בתרופות הקבועות | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהתרופה רשומה בתרופות הקבועות ונרשמה בעבר ע"י רופא/ה. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | אבחנה מתועדת ומצורפת למרשם | אבחנת ADHD (או נרקולפסיה) ברשימת האבחנות, ומצורפת למרשם ("ADD במעקב שלי"). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | משקל וגובה מתועדים | משקל וגובה מ-6 החודשים האחרונים (עקומת גדילה). אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 4 | דופק ול"ד מתועדים | דופק ול"ד מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 5 | אין ירידה במשקל או האטה בגדילה | המשקל לא ירד והגדילה לא הואטה לעומת המדידה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | עברו כ-3 חודשים מהמרשם הקודם | תרופה עם פוטנציאל התמכרות: בקשה לפני שעברו כ-3 חודשים, או רכישות מעבר לכמות שנרשמה ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 8 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 9 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 10 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 11 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 12 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ילדים: משקל, גובה, דופק ול"ד כל 6 חודשים |
| תלונות בפנייה או ברשומה | ירידה בתיאבון ובמשקל ← לרופא; דפיקות לב, כאב בחזה או עילפון ← דחוף; מחשבות אובדניות או שינוי חד במצב הרוח ← דחוף |
| מקור | החלטה מקומית (3.11.2026); NICE NG87 (מעקב בילדים); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.30 **ליסדקסאמפטמין (מבוגרים)** · Lisdexamfetamine (adults) לפי הנחיה, בתנאים

ADHD · ממריץ (סם מסוכן)

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (5)** | ויואנס · Vyvanse | ליסדקס טבע · Lisdex Teva | ליסדקסא אס.קיי. · Lisdexa S.K. | ליסין · Lissin | תרומין · Taromine |
| **נימוק / הערה** | סם מסוכן: מחודש ע"י רפואן רק כשרשום בתרופות הקבועות, עם אבחנה מצורפת למרשם. אפשר ל-3 חודשים (מרשמים עתידיים). בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רשומה בתרופות הקבועות | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהתרופה רשומה בתרופות הקבועות ונרשמה בעבר ע"י רופא/ה. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | אבחנה מתועדת ומצורפת למרשם | אבחנת ADHD (או נרקולפסיה) ברשימת האבחנות, ומצורפת למרשם ("ADD במעקב שלי"). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | מרשם ראשון ע"י המומחה המתאים | אטנט, אדרל או ויואנס: המרשם הראשון ניתן ע"י נוירולוג/ית או פסיכיאטר/ית. מעבר מריטלין לאטנט — רק בהמלצת מומחה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | עברו כ-3 חודשים מהמרשם הקודם | תרופה עם פוטנציאל התמכרות: בקשה לפני שעברו כ-3 חודשים, או רכישות מעבר לכמות שנרשמה ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | לחץ דם ודופק | לחץ דם ודופק מתועדים בשנה האחרונה. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | ילדים: משקל, גובה, דופק ול"ד כל 6 חודשים |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | ירידה בתיאבון ובמשקל ← לרופא; דפיקות לב, כאב בחזה או עילפון ← דחוף; מחשבות אובדניות או שינוי חד במצב הרוח ← דחוף |
| **מקור** | החלטה מקומית (3.11.2026); NICE NG87 (מעקב בילדים); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.31 ליסדקסאמפטמין (ילדים ובני נוער) · Lisdexamfetamine (children) לפי הנחיה, בתנאים

ADHD · ממריץ (סם מסוכן)

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (5) | ויואנס · Vyvanse · ליסדקס טבע · Lisdex Teva · ליסדקסא אס.קיי. · Lisdexa S.K. · ליסין · Lissin · תרומין · Taromine |
| נימוק / הערה | סם מסוכן: מחודש ע"י רפואן רק כשרשום בתרופות הקבועות, עם אבחנה מצורפת למרשם. אפשר ל-3 חודשים (מרשמים עתידיים). בילדים גם משקל, גובה, דופק ול"ד כל 6 חודשים. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רשומה בתרופות הקבועות | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהתרופה רשומה בתרופות הקבועות ונרשמה בעבר ע"י רופא/ה. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | אבחנה מתועדת ומצורפת למרשם | אבחנת ADHD (או נרקולפסיה) ברשימת האבחנות, ומצורפת למרשם ("ADD במעקב שלי"). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | מרשם ראשון ע"י המומחה המתאים | אטנט, אדרל או ויואנס: המרשם הראשון ניתן ע"י נוירולוג/ית או פסיכיאטר/ית. מעבר מריטלין לאטנט — רק בהמלצת מומחה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | משקל וגובה מתועדים | משקל וגובה מ-6 החודשים האחרונים (עקומת גדילה). אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 5 | דופק ול"ד מתועדים | דופק ול"ד מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 6 | אין ירידה במשקל או האטה בגדילה | המשקל לא ירד והגדילה לא הואטה לעומת המדידה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | עברו כ-3 חודשים מהמרשם הקודם | תרופה עם פוטנציאל התמכרות: בקשה לפני שעברו כ-3 חודשים, או רכישות מעבר לכמות שנרשמה ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 9 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 10 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 OP = 2 אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 11 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 12 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 13 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ילדים: משקל, גובה, דופק ול"ד כל 6 חודשים |
| תלונות בפנייה או ברשומה | ירידה בתיאבון ובמשקל ← לרופא; דפיקות לב, כאב בחזה או עילפון ← דחוף; מחשבות אובדניות או שינוי חד במצב הרוח ← דחוף |
| מקור | החלטה מקומית (3.11.2026); NICE NG87 (מעקב בילדים); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.32 בנזודיאזפינים ותרופות שינה · Benzodiazepines / Z-drugs

הכנה לאישור רופא/ה

מרגיעים ותרופות שינה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (24) | קלונקס · Clonex · קלומד · Clomed · לוריוון · Lorivan · אסיול · Assival · קסנאגיס · Xanagis · אלפרליד · Alpralid · קסנאקס XR · Xanax XR · בונדורמין · Bondormin · סטילנוקס · Stilnox · אמביאן Ambien · CR · זודורם · Zodorm · ריווטריל · Rivotril · קלונזפאם אמ.בי.איי · Clonazepam MBI · אימובן · Imovane · נוקטורנו · Nocturno · נוקטורנו פורטה · Nocturno Forte · זופיקלון גרינדקס · Zopiclone Grindeks · אסיול חדש · Assival New · אסיול טבע · Assival Teva · דיאזפם גרינדקס · Diazepam Grindeks · לורזפאם מדו · Lorazepam Medo · ואבן · Vaben · ברוטיזולאם טבע · Brotizolam Teva · פריזיום · Frisium (קלובזם) |
| נימוק / הערה | ההחלטה בידי הרופא/ה. הרפואן אוסף את הנתונים, מסמן אותם ומעביר סיכום. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | משך הנטילה ורציפות תועדו | כמה זמן נוטל/ת ואם ברצף — לפי הרכישות והרשומה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | השימוש לא נעשה תכוף יותר | לפי הרכישות: אין עלייה בתדירות לאחרונה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | תיעוד שיחה על שינה או חרדה | ברשומה יש שיחה על הרגלי שינה, ניסיון טיפול אחר או הפניה למעבדת שינה (ומתי). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | עברו כ-3 חודשים מהמרשם הקודם | תרופה עם פוטנציאל התמכרות: בקשה לפני שעברו כ-3 חודשים, או רכישות מעבר לכמות שנרשמה ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| תלונות בפנייה או ברשומה | נפילות או בלבול (בגיל מבוגר) ← לרופא; בקשה מוקדמת או אובדן מרשם ← לרופא |
| מקור | ספר חפיפה עוזרי רופא; החלטה מקומית (3.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.33 **מלחי אמפטמין (מבוגרים)** · Amphetamine salts (adults) לפי הנחיה, בתנאים

ADHD · ממריץ (סם מסוכן)

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (4)** | אטנט · Attent \| אטנט Attent XR · XR \| אמפקסון 10 מ"ג · Amfexon \| דקסטמין 10 מ"ג · Dextamine |
| **נימוק / הערה** | סם מסוכן: מחודש ע"י רפואן רק כשרשום בתרופות הקבועות, עם אבחנה מצורפת למרשם. אפשר ל-3 חודשים (מרשמים עתידיים). בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **רשומה בתרופות הקבועות** | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהתרופה רשומה בתרופות הקבועות ונרשמה בעבר ע"י רופא/ה. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | **אבחנה מתועדת ומצורפת למרשם** | אבחנת ADHD (או נרקולפסיה) ברשימת האבחנות, ומצורפת למרשם ("ADD במעקב שלי"). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | **מרשם ראשון ע"י המומחה המתאים** | אטנט, אדרל או ויואנס: המרשם הראשון ניתן ע"י נוירולוג/ית או פסיכיאטר/ית. מעבר מריטלין לאטנט — רק בהמלצת מומחה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | **עברו כ-3 חודשים מהמרשם הקודם** | תרופה עם פוטנציאל התמכרות: בקשה לפני שעברו כ-3 חודשים, או רכישות מעבר לכמות שנרשמה ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 5 | **רכישות** | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | **לחץ דם ודופק** | לחץ דם ודופק מתועדים בשנה האחרונה. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | ילדים: משקל, גובה, דופק ול"ד כל 6 חודשים |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | ירידה בתיאבון ובמשקל ← לרופא; דפיקות לב, כאב בחזה או עילפון ← דחוף; מחשבות אובדניות או שינוי חד במצב הרוח ← דחוף |
| **מקור** | החלטה מקומית (3.11.2026); NICE NG87 (מעקב בילדים); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.34 מלחי אמפטמין (ילדים ובני נוער) · Amphetamine salts (children) לפי הנחיה, בתנאים

ADHD · ממריץ (סם מסוכן)

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (4) | אטנט · Attent \| אטנט XR · Attent XR \| אמפקסון 10 מ"ג · Amfexon \| דקסטמין 10 מ"ג · Dextamine |
| נימוק / הערה | סם מסוכן: מחודש ע"י רפואן רק כשרשום בתרופות הקבועות, עם אבחנה מצורפת למרשם. אפשר ל-3 חודשים (מרשמים עתידיים). בילדים גם משקל, גובה, דופק ול"ד כל 6 חודשים. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רשומה בתרופות הקבועות | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהתרופה רשומה בתרופות הקבועות ונרשמה בעבר ע"י רופא/ה. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | אבחנה מתועדת ומצורפת למרשם | אבחנת ADHD (או נרקולפסיה) ברשימת האבחנות, ומצורפת למרשם ("ADD במעקב שלי"). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | מרשם ראשון ע"י המומחה המתאים | אטנט, אדרל או ויואנס: המרשם הראשון ניתן ע"י נוירולוג/ית או פסיכיאטר/ית. מעבר מריטלין לאטנט — רק בהמלצת מומחה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | משקל וגובה מתועדים | משקל וגובה מ-6 החודשים האחרונים (עקומת גדילה). אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 5 | דופק ול"ד מתועדים | דופק ול"ד מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 6 | אין ירידה במשקל או האטה בגדילה | המשקל לא ירד והגדילה לא הואטה לעומת המדידה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | עברו כ-3 חודשים מהמרשם הקודם | תרופה עם פוטנציאל התמכרות: בקשה לפני שעברו כ-3 חודשים, או רכישות מעבר לכמות שנרשמה ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 9 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 10 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 11 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 12 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 13 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ילדים: משקל, גובה, דופק ול"ד כל 6 חודשים |
| תלונות בפנייה או ברשומה | ירידה בתיאבון ובמשקל ← לרופא; דפיקות לב, כאב בחזה או עילפון ← דחוף; מחשבות אובדניות או שינוי חד במצב הרוח ← דחוף |
| מקור | החלטה מקומית (3.11.2026); NICE NG87 (מעקב בילדים); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.35 מודפיניל / ארמודפיניל · Modafinil / armodafinil לפי הנחיה, בתנאים

תרופות ערנות

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | פרוויג'יל · Provigil \| מודפיניל מדוכמי · Modafinil Medochemie \| נוביג'יל · Nuvigil (ארמודפיניל) |
| נימוק / הערה | מודפיניל וארמודפיניל לערנות (נרקולפסיה), נקבעים ע"י מרפאת שינה. מחלישים את הגלולה למניעת היריון — לבדוק. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני במינון קבוע שנקבע ע"י מומחה/ית. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | הנחיה עדכנית של מרפאת השינה | מכתב או סיכום של מרפאת השינה מ-12 החודשים האחרונים, עם אותה תרופה ומינון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | אין גלולה הורמונלית למניעת היריון | באישה בגיל הפוריות: אין גלולה, מדבקה או טבעת הורמונלית בתרופות, או שיש אמצעי מניעה נוסף מתועד. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 10 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 5.36 נלמפן (סלינקרו) · Nalmefene לפי הנחיה, בתנאים

התמכרות לאלכוהול · מומחה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | סלינקרו 18 מ"ג · Selincro 18 MG |
| נימוק / הערה | נלמפן (סלינקרו) להפחתת שתיית אלכוהול, במסגרת טיפול ומעקב. אסור עם אופיואידים. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול שהתחיל במסגרת טיפול ומעקב, אותו מינון. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | אין אופיואידים | אין אופיואיד בתרופות הקבועות או ברכישות האחרונות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | eGFR 30 ומעלה | eGFR מ-12 החודשים האחרונים 30 ומעלה. לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 10 | אין מחלת כבד קשה | אין ברשומה שחמת או מחלת כבד קשה. לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 11 | מעקב התגובה לטיפול | מעקב תקופתי מתועד (למשל חודשי); מעל שנה — החלטת רופא/ה להמשיך. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: העלון לרופא (משרד הבריאות) · עלון לרופא (משרד הבריאות) — Selincro |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.37 קסנומלין-טרוספיום (קובנפי) · Xanomeline-trospium

הכנה לאישור רופא/ה

נוגד פסיכוזה · מוסקריני

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | קובנפי · Cobenfy (לא בסל) |
| נימוק / הערה | נוגד פסיכוזה חדש, נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. אצירת שתן ועליית אנזימי כבד; לא במחלת כבד. הרפואן מכין, הרופא/ה מאשר/ת. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | הנחיה עדכנית של הפסיכיאטר/ית | מכתב או סיכום של הפסיכיאטר/ית מ-12 החודשים האחרונים, עם אותה תרופה ומינון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | תפקודי כבד | ALT, AST ובילירובין מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 6 | אין אצירת שתן | ברשומה או בפנייה אין קושי במתן שתן או אצירת שתן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | תפקודי כבד |
| תלונות בפנייה או ברשומה | קושי במתן שתן ← לרופא; צהבת או שתן כהה ← דחוף |
| מקור | פער מול הרג'יסטרי, החלטה מקומית (8.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.38 **ליתיום** · Lithium carbonate

לפי הנחיה, בתנאים | מעקב צמוד

מייצב מצב רוח

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (2)** | ליקרביום · Licarbium | פריאדל · Priadel (לאימות מול מאגר משרד הבריאות) |
| **נימוק / הערה** | נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. לא נעצר ע"י רפואן, מלבד רמה רעילה. הרפואן לא משנה מינון בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רמת ליתיום מתועדת | בדיקה מ-6 החודשים האחרונים, 12 שעות אחרי המנה. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | רמת התרופה בדם בטווח | בבדיקה האחרונה רמת התרופה בדם בטווח. חריג: רמה מחוץ לטווח 0.6-1.0 mmol/L ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: רמה 1.5 mmol/L ומעלה ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: רמה 1.5 mmol/L ומעלה ← לא מחדשים | |
| 3 | נתרן (Na) תקין | בבדיקה האחרונה נתרן (Na) תקין. חריג: Na מחוץ לטווח המעבדה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 4 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <60 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 5 | בדיקות כל 6 חודשים | מ-6 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, נתרן, TSH, סידן. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 6 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 7 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 8 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 9 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 10 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 11 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 12 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 13 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 14 | תדירות בדיקות בקבוצת סיכון | בגיל 65 ומעלה, רמה 0.8 ומעלה, או פגיעה בכליות או בבלוטת התריס: רמה, כליות ונתרן מ-3 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 15 | משקל | משקל מתועד בשנה האחרונה. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | רמת ליתיום כל 6 חודשים; קריאטינין/eGFR, נתרן, TSH וסידן כל 6 חודשים |
| **ספי החזרה לרופא/ה** | רמה מחוץ לטווח 0.6-1.0 mmol/L; Na מחוץ לטווח המעבדה; eGFR <60 |
| **ערך חמור** | רמה 1.5 mmol/L ומעלה |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | רעד חדש או מוגבר, בחילות, שלשולים, בלבול או חוסר יציבות (חשד לרעילות) ← דחוף - לרופא עכשיו; שתייה ומתן שתן מרובים ← לרופא; הקאות או שלשול עם התייבשות ← דחוף - בדיקת רמה |
| **מקור** | מעקב: SPS Medicines Monitoring (NHS) · SPS Medicines Monitoring |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 5.39 קלוזפין · Clozapine

לפי הנחיה, בתנאים | מעקב צמוד

נוגד פסיכוזה (מעקב ספירת דם חובה)

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | לפונקס · Leponex \| לוזפין · Lozapine |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. ניפוק חודשי בלבד, רק עם ספירת דם תקינה מהחודש האחרון. חידוש מלא = חודש אחד בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | ספירת דם מהחודש האחרון | WBC ונויטרופילים מ-4 השבועות האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה | בבדיקה האחרונה ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה. חריג: WBC 3,000-3,500 או נויטרופילים 1,500-2,000 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: WBC מתחת ל-3,000 או נויטרופילים מתחת ל-1,500 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. **חמור: WBC מתחת ל-3,000 או נויטרופילים מתחת ל-1,500 ← לא מחדשים** | |
| 3 | שלב חודשי (מעל 18 שבועות טיפול) | הטיפול נמשך יותר מ-18 שבועות (בשלב הראשון: ניפוק שבועי ע"י הצוות המטפל). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | אין חום או זיהום מתועד | ברשומה או בפנייה אין חום, כאב גרון או זיהום. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 12 | משקל, סוכר ושומנים | משקל, סוכר או HbA1c ושומנים מהשנה האחרונה. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 13 | תדירות ספירה | חודשים 1–6: שבועית; 7–12: כל שבועיים; משנה שנייה: חודשית. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ספירת דם (WBC, נויטרופילים) כל שבוע ב-18 השבועות הראשונים, ואחר כך לפחות פעם בחודש |
| ספי החזרה לרופא/ה | WBC 3,000-3,500 או נויטרופילים 1,500-2,000 |
| ערך חמור | WBC מתחת ל-3,000 או נויטרופילים מתחת ל-1,500 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | חום, כאב גרון או זיהום ← דחוף - ספירת דם היום; כאב בחזה, קוצר נשימה או דופק מהיר (חשד לדלקת שריר הלב) ← דחוף; עצירות קשה או כאבי בטן ← לרופא, דחוף; פרכוס ← דחוף |
| מקור | עלון לצרכן לפונקס (עודכן 12/2020); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.40 אולנזפין · Olanzapine

לפי הנחיה, בתנאים | מעקב צמוד

נוגד פסיכוזה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (5) | זיפרקסה · Zyprexa \| זיפרקסה ולוטב · Zyprexa Velotab \| זאפה · Zappa \| אולנזפין טבע · Olanzapine Teva \| אולנזפין ODT טבע · Olanzapine ODT Teva (טבליה מסיסה) |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מעקב מטבולי מתועד | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | ללא החמרה מטבולית | אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; ישנוניות קשה ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.41 קווטיאפין · Quetiapine

לפי הנחיה, בתנאים | מעקב צמוד

נוגד פסיכוזה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (5) | סרוקואל · Seroquel \| סרוקואל XR · Seroquel XR \| קווטיאפין טבע · Quetiapine Teva \| קווטיאפין סנדוז · Quetiapine Sandoz \| קווטיאפין אינובמד SR · Quetiapine Inovamed SR |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מעקב מטבולי מתועד | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | ללא החמרה מטבולית | אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; ישנוניות קשה ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.42 ריספרידון · Risperidone

מעקב צמוד | לפי הנחיה, בתנאים

נוגד פסיכוזה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | ריספרדל · Risperdal \| ריספרידקס · Risperidex \| ריספונד · Rispond |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מעקב מטבולי מתועד | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | ללא החמרה מטבולית | אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; ישנוניות קשה ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-(DailyMed) FDA · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.43 אריפיפרזול · Aripiprazole

לפי הנחיה, בתנאים | מעקב צמוד

נוגד פסיכוזה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (5) | אריפיפרזול מדו · Aripiprazole Medo \| אריפיפרזול סנדוז · Aripiprazole Sandoz \| אריפלי · Ariply \| אביליפיי מיינטנה 300 מ"ג · Abilify Maintena 300 MG (זריקת מאגר) \| אביליפיי מיינטנה 400 מ"ג · Abilify Maintena 400 MG (זריקת מאגר) |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מעקב מטבולי מתועד | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | ללא החמרה מטבולית | אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; ישנוניות קשה ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.44 הלופרידול · Haloperidol

לפי הנחיה, בתנאים | מעקב צמוד

נוגד פסיכוזה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | הלדול · Haldol \| הלופר · Haloper \| הלדול דקאנואס · Haldol Decanoas (זריקת מאגר) |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי. מאריך QT; תופעות חוץ-פירמידליות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מעקב מטבולי מתועד | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | ללא החמרה מטבולית | אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אק"ג מתועד<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 50 ומעלה או עם מחלת לב? | אק"ג מ-12 החודשים האחרונים ללא QTc מוארך. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 4 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי; אק"ג בגיל 50+ או במחלת לב |
| תלונות בפנייה או ברשומה | נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; דפיקות לב או עילפון ← דחוף |
| מקור | מעקב: עלון ה-(DailyMed) FDA · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.45 פליפרידון · Paliperidone

לפי הנחיה, בתנאים | מעקב צמוד

נוגד פסיכוזה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (4) | אינווגה · Invega | פליפרידון טבע · Paliperidone Teva | קספליון · Xeplion (זריקת מאגר) | טרוויקטה · Trevicta (זריקת מאגר) |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי. מינון לפי כליות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מעקב מטבולי מתועד | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | ללא החמרה מטבולית | אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 OP = 2 אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי; קריאטינין שנתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; דפיקות לב או עילפון ← דחוף |
| מקור | מעקב: עלון ה-(DailyMed) FDA · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.46 קריפרזין · Cariprazine

לפי הנחיה, בתנאים | מעקב צמוד

נוגד פסיכוזה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | ריאגילה · Reagila |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מעקב מטבולי מתועד | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | ללא החמרה מטבולית | אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; דפיקות לב או עילפון ← דחוף |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.47 זיפרזידון · Ziprasidone

לפי הנחיה, בתנאים | מעקב צמוד

נוגד פסיכוזה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | גאודון · Geodon |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי. מאריך QT בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מעקב מטבולי מתועד | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | ללא החמרה מטבולית | אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אק"ג מתועד<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 50 ומעלה או עם מחלת לב? | אק"ג מ-12 החודשים האחרונים ללא QTc מוארך. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 4 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 12 | QTc אחרון מתחת ל-500 | באק"ג האחרון QTc מתחת ל-500 msec. לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי; אק"ג |
| תלונות בפנייה או ברשומה | נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; דפיקות לב או עילפון ← דחוף |
| מקור | מעקב: עלון ה-(DailyMed) FDA · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.48 פרפנזין · Perphenazine

לפי הנחיה, בתנאים | מעקב צמוד

נוגד פסיכוזה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | פרפנאן · Perphenan |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי. תופעות חוץ-פירמידליות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מעקב מטבולי מתועד | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | ללא החמרה מטבולית | אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; דפיקות לב או עילפון ← דחוף |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.49 אמיסולפריד · Amisulpride

לפי הנחיה, בתנאים | מעקב צמוד

נוגד פסיכוזה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | פרייד · Pride \| אמיסולפריד מדו · Amisulpride Medo |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי. מינון לפי כליות; פרולקטין; QT בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מעקב מטבולי מתועד | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | ללא החמרה מטבולית | אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אק"ג מתועד<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 50 ומעלה או עם מחלת לב? | אק"ג מ-12 החודשים האחרונים ללא QTc מוארך. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 4 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 12 | מינון מותאם לתפקוד הכליות | קריאטינין מ-12 החודשים האחרונים; בפינוי קריאטינין 30–60 המינון עד חצי מהרגיל, ב-10–30 עד שליש. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 13 | אין גידול תלוי פרולקטין | אין ברשומה פרולקטינומה או סרטן שד. לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 14 | אין חום או כאב גרון לא מוסברים | בפנייה או ברשומה אין חום, כאב גרון או זיהום לא מוסבר. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי; קריאטינין שנתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; דפיקות לב או עילפון ← דחוף |
| מקור | מעקב: העלון לרופא (משרד הבריאות) · עלון לרופא (משרד הבריאות) — Pride |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.50 סולפיריד · Sulpiride

לפי הנחיה, בתנאים | מעקב צמוד

נוגד פסיכוזה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | מודאל · Modal \| מודאל פורטה · Modal Forte |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי. פרולקטין בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מעקב מטבולי מתועד | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | ללא החמרה מטבולית | אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | מינון מותאם לתפקוד הכליות | קריאטינין מ-12 החודשים האחרונים; בפינוי קריאטינין 30–60 המינון עד חצי מהרגיל, ב-10–30 עד שליש. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 12 | אין גידול תלוי פרולקטין | אין ברשומה פרולקטינומה או סרטן שד. לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 13 | אין חום או כאב גרון לא מוסברים | בפנייה או ברשומה אין חום, כאב גרון או זיהום לא מוסבר. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 14 | לחץ דם בשנה האחרונה | לחץ דם מתועד בשנה האחרונה; ביתר לחץ דם — מאוזן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; דפיקות לב או עילפון ← דחוף |
| מקור | מעקב: העלון לרופא (משרד הבריאות) · עלון לרופא (משרד הבריאות) — Modal |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.51 פלופנזין · Fluphenazine

לפי הנחיה, בתנאים | מעקב צמוד

נוגד פסיכוזה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | פלודקאט · Fludecate (זריקת מאגר) |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי. תופעות חוץ-פירמידליות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מעקב מטבולי מתועד | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | ללא החמרה מטבולית | אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; דפיקות לב או עילפון ← דחוף |
| מקור | מעקב: עלון ה-(DailyMed) FDA · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.52 זוקלופנתיקסול · Zuclopenthixol

לפי הנחיה, בתנאים | מעקב צמוד

נוגד פסיכוזה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | קלופיקסול · Clopixol \| קלופיקסול דפו · Clopixol Depot (זריקת מאגר) |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי. תופעות חוץ-פירמידליות בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מעקב מטבולי מתועד | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | ללא החמרה מטבולית | אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | אין גורם סיכון ל-QT | אין ברשומה אשלגן או מגנזיום נמוכים, דופק מתחת ל-50, אוטם טרי או אי ספיקת לב. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; דפיקות לב או עילפון ← דחוף |
| מקור | מעקב: העלון לרופא (משרד הבריאות) · עלון לרופא (משרד הבריאות) — Clopixol |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.53 קלוטיאפין · Clotiapine

מעקב צמוד | לפי הנחיה, בתנאים

נוגד פסיכוזה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | אנטומין · Entumin |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי. ישנוניות בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מעקב מטבולי מתועד | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | ללא החמרה מטבולית | אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | אין אפילפסיה או סיכון לפרכוס | אין ברשומה אפילפסיה או פגיעה מוחית. לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 12 | אין גלאוקומה של זווית סגורה | אין ברשומה גלאוקומה של זווית סגורה. לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 13 | לחץ דם (גיל 65 ומעלה) | בגיל 65 ומעלה: לחץ דם מתועד ב-6 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 14 | אין חום או כאב גרון לא מוסברים | בפנייה או ברשומה אין חום, כאב גרון או זיהום לא מוסבר. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; דפיקות לב או עילפון ← דחוף |
| מקור | מעקב: העלון לרופא (משרד הבריאות) · עלון לרופא (משרד הבריאות) — Entumin |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.54 לבומפרומזין · Levomepromazine

לפי הנחיה, בתנאים · מעקב צמוד

נוגד פסיכוזה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | רונקסין · Ronexine |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי. ישנוניות ויל"ד אורתוסטטי בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מעקב מטבולי מתועד | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | ללא החמרה מטבולית | אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אין נפילות או הזיות מתועדות | ברשומה או בפנייה אין נפילות, בלבול או הזיות חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 12 | אין מחלת לב קשה | אין ברשומה מחלת לב איסכמית קשה או אי ספיקת לב (לפי העלון מ-2014). לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 13 | אין חום או כאב גרון לא מוסברים | בפנייה או ברשומה אין חום, כאב גרון או זיהום לא מוסבר. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; דפיקות לב או עילפון ← דחוף |
| מקור | מעקב: העלון לרופא (משרד הבריאות) · עלון לרופא (משרד הבריאות) — Nozinan 2014 (רישום בוטל, זמני) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.55 ברקספיפרזול · Brexpiprazole

לפי הנחיה, בתנאים | מעקב צמוד

נוגד פסיכוזה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | ריקסלטי · Rexulti |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מעקב מטבולי מתועד | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | ללא החמרה מטבולית | אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; דפיקות לב או עילפון ← דחוף |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.56 אסנפין · Asenapine

לפי הנחיה, בתנאים · מעקב צמוד

נוגד פסיכוזה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | סאפריס · Saphris (תת-לשוני) |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מעקב מטבולי מתועד | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | ללא החמרה מטבולית | אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; דפיקות לב או עילפון ← דחוף |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.57 אילופרידון · Iloperidone

לפי הנחיה, בתנאים | מעקב צמוד

נוגד פסיכוזה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | פנאפט · Fanapt |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי. מאריך QT |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מעקב מטבולי מתועד | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | ללא החמרה מטבולית | אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אק"ג מתועד<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 50 ומעלה או עם מחלת לב? | אק"ג מ-12 החודשים האחרונים ללא QTc מוארך. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 4 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי; אק"ג |
| תלונות בפנייה או ברשומה | נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; דפיקות לב או עילפון ← דחוף |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.58 סרטינדול · Sertindole

מעקב צמוד · לפי הנחיה, בתנאים

נוגד פסיכוזה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | סרדולקט · Serdolect |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי. מאריך QT: אק"ג חובה בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מעקב מטבולי מתועד | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | ללא החמרה מטבולית | אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אק"ג מ-3 החודשים האחרונים | אק"ג מ-3 החודשים האחרונים עם QTc מתחת ל-450 (גברים) או 470 (נשים). אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 4 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 12 | אין מחלת לב משמעותית | אין ברשומה מחלת לב משמעותית, אי ספיקת לב, היפרטרופיה של הלב, הפרעת קצב, או דופק מתחת ל-50. לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 13 | אשלגן ומגנזיום | אשלגן ומגנזיום בטווח, מ-3 החודשים האחרונים (ובכל הקאות, שלשולים או משתנים מורידי אשלגן). אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 14 | אין מחלת כבד קשה | אין ברשומה שחמת או מחלת כבד קשה. לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי; אק"ג כל 3 חודשים |
| תלונות בפנייה או ברשומה | נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; דפיקות לב או עילפון ← דחוף |
| מקור | מעקב: העלון לרופא (משרד הבריאות) · עלון לרופא (משרד הבריאות) — Serdolect |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 5.59 תיורידזין · Thioridazine

לפי הנחיה, בתנאים | מעקב צמוד

נוגד פסיכוזה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | רידזין · Ridazin |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י פסיכיאטר/ית. מעקב מטבולי שנתי. מאריך QT מאוד בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מעקב מטבולי מתועד | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | ללא החמרה מטבולית | אין סוכרת חדשה, HbA1c ≥6.5% או עלייה של 7% ומעלה במשקל מאז הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אק"ג מתועד<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 50 ומעלה או עם מחלת לב? | אק"ג מ-12 החודשים האחרונים ללא QTc מוארך. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 4 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י פסיכיאטר/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 12 | QTc אחרון מתחת ל-500 | באק"ג האחרון QTc מתחת ל-500 msec. לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | משקל, גלוקוז/HbA1c ושומנים שנתי; אק"ג |
| תלונות בפנייה או ברשומה | נוקשות שרירים עם חום או בלבול ← דחוף - חדר מיון; תנועות לא רצוניות חדשות ← לרופא; דפיקות לב או עילפון ← דחוף |
| מקור | מעקב: עלון ה-(DailyMed) FDA · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

# 6. עיכול וכבד

20 תרופות · לפי הנחיה: 12 · לפי הנחיה, בתנאים: 7 · הכנה לאישור רופא/ה: 1 · גרסה 2 · חלוקה לפי מערכות · 2.11.2026

מקורות: הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020; ACOG 2023 (סיכום AFP). שאר התחומים: החלטה מקומית

## 6.א כללים

- חידוש רגיל: 3 חודשים
- ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה פעם בשנה
- עד 3 חידושים רצופים, ואז ביקור רופא
- אין התווית נגד ← תמיד מחדשים לפחות לחודש אחד
- חסרה מדידה, בדיקה או ביקורת שנתית: חידוש לחודש אחד + זימון למרפאה
- חריגה מספי ההחזרה: חידוש לחודש אחד + הודעה לרופא/ה
- התווית נגד או ערך חמור: לא מחדשים, הודעה לרופא/ה (הסף של כל תרופה מופיע ברשימה שלה)
- רפואן לא משנה מינון ולא מחליף תרופה. "מעקב צמוד" = תרופה עם מעקב תכוף (מעבדה, אק"ג, עיניים או צילום) — לבדוק כל ערך בקפידה
- מעכבי משאבת פרוטונים: נדרשת התוויה מתועדת לטיפול ממושך
- דם בצואה, ירידה במשקל או שינוי חדש ביציאות ← הודעה לרופא/ה
- דגל אדום: הרפואן מכין לפי רשימת הבדיקות, והרופא/ה בודק/ת שוב לפני האישור — גם כשהכול תקין

## 6.ג בדיקות משותפות

| שלב | נושא | מה בודקים | קריטריון | אם לא מתקיים | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| לפני כל חידוש | בדיקת מעקב | לפי התרופה | שומנים: LDL; לבותירוקסין: TSH; אלופורינול/פבוקסוסטט: חומצה אורית — מ-12 החודשים האחרונים | אין ← חידוש לחודש + זימון לבדיקה | הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52; החלטה כללי-1 |
| לפני כל חידוש | ערך המעקב | לעומת הבדיקה הקודמת או היעד | LDL לא עלה ב-30% ומעלה; TSH בטווח המעבדה; חומצה אורית מתחת ל-6 | לא ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה | החלטות כללי-2–4 |
| לפני כל חידוש | רכישות | כיסוי ימים ב-6 החודשים האחרונים | 80% מהימים ומעלה | פחות ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה | כמו ביל"ד |
| לפני כל חידוש | ביקורת שנתית | ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה | ב-12 החודשים האחרונים | אין ← חידוש לחודש + זימון לביקורת | כמו ביל"ד |
| לפני כל חידוש | רצף חידושים | כמה חידושים רצופים מאז ביקור רופא | פחות מ-3 | 3 ← ביקור רופא | כמו ביל"ד |

## 6.ד החלטות

| # | נושא | מה ההנחיה אומרת | ההחלטה לפרוטוקול | סוג | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| כללי-1 | בדיקות מעקב | שומנים: פרופיל 4-12 שבועות אחרי התחלה, אחר כך כל 6-12 חודשים (ההנחיה הישראלית 2020; ESC/EAS 2019). TSH בלבותירוקסין: שנתי כשמאוזן (NICE NG145). חומצה אורית בטיפול מוריד: יעד <6, בדיקה תקופתית (ACR 2020) | LDL, TSH וחומצה אורית מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש + זימון | החלטה מקומית (הצעה) | הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52; ESC/EAS 2019; NICE NG145; ACR 2020 |
| כללי-7 | אלופורינול ופבוקסוסטט | יעד חומצה אורית <6 mg/dL; התחלה במינון נמוך והתאמה לכליות; פריחה ← הפסקה מיידית (סיכון SJS/DRESS) | חומצה אורית ≥6 ← הודעה. אלופורינול: eGFR <30 ← הודעה (מינון). פריחה ← התווית נגד, דחוף | החלטה מקומית (הצעה) | ACR 2020; תווית FDA |

| # | נושא | מה ההנחיה אומרת | ההחלטה לפרוטוקול | סוג | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| כללי-12 | תרופות כרוניות נוספות (2) | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי). SSRI/SNRI: היפונתרמיה בקשישים | בזאפיברט, גבפנטין, פרגבלין, SSRI/SNRI (נתרן בגיל 65+), מעכבי ארומטאז, טמוקסיפן, רלוקסיפן, טרבינפין ואיטרקונזול (קורס): לפי הרשימה של כל תרופה | החלטה מקומית (הצעה) | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| כללי-16 | ברזל, B12, חומצה פולית | ברזל: אחרי תיקון האנמיה ממשיכים כ-3 חודשים לחידוש המאגרים, ואז ספירה תקופתית (BSG 2021). B12 בטיפול שימורי: אין בדיקת רמה שגרתית אלא בתסמינים (NICE NG239, 2024) — הרמה השנתית בפרוטוקול מחמירה | ברזל: ספירת דם ופריטין מ-6 חודשים; טיפול מעל 6 חודשים בלי התוויה ← הודעה. B12: רמה שנתית | החלטה מקומית (הצעה) | BSG 2021; NICE NG239 |
| כללי-18 | גסטרו ואנדוקרינולוגיה | מסאלזין: תפקוד כליות לפני, אחרי 3 חודשים ואז שנתי (BSG 2019). הידרוקורטיזון: הנחיות יום מחלה (Endocrine Society 2016). דסמופרסין: נתרן (תווית). סינקלצט/אלפקלצידול: סידן (תווית) | מסאלזין: קריאטינין שנתי. הידרוקורטיזון: לא נעצר, הנחיות מחלה. אלפקלצידול וסינקלצט: סידן. דסמופרסין: נתרן | החלטה מקומית (הצעה) | BSG 2019; Endocrine Society 2016; תווית |
| כללי-19 | תרופות מומחה | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי). הטיפול נקבע ומנוטר ע"י המומחה | אריתרופויאטין, קושרי זרחן ואשלגן, HIV, הפטיטיס B, ציקלוספורין/טקרולימוס, אפרמילסט ואציטרטין: הודעה בלבד, חידוש ע"י רופא/ה | החלטה מקומית | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| כללי-20 | השלמות מהמאגר (2.11.2026) | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) | טרזוסין, פינסטריד, אינקליסירן, ורדנאפיל, טיפות לגלאוקומה (ביקורת עיניים שנתית; טימולול: דופק ואסתמה), NSAID ממושך (כליות, אשלגן, ל"ד, דימום, הגנת קיבה), אנטיהיסטמינים, ציננריזין, דומפרידון, מבברין, סידן, מידודרין, פנטוקסיפילין, דיפירידמול, ולציקלוביר מונע, חומצה זולדרונית | החלטה מקומית (הצעה) | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| כללי-21 | תרופות מומחה נוספות | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי). הטיפול נקבע ומנוטר ע"י המומחה | מטוקלופרמיד ממושך, ממריצים/מודפיניל, טרשת נפוצה, אונקולוגיה, יל"ד ריאתי/IPF, סירולימוס, הורמון גדילה, המטולוגיה, CF, טפמידיס/מבקמטן: הודעה בלבד, חידוש ע"י רופא/ה. תרופות ביולוגיות בזריקה בקהילה: הרפואן מכין (אישור, מכתב מומחה, מרווח, בטיחות) והרופא/ה מאשר/ת (5.11.2026) | החלטה מקומית | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| כללי-22 | השלמות 2 מהמאגר (2.11.2026) | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) | ויטמין D, בטאהיסטין, חומצה במפדואית, אומגה 3/איקוזפנט, ציפרופיברט, וריסיגואט, ניטרוגליצרין תת-לשוני, פזולינטנט/אלינזנטנט (ALT), דואביב, אינטראروסה, סיאנה, אורליסטט, פרוקלופריד, משלשלים, טטרציקלינים ממושכים, מניעת זיהומי שתן, משככי כאב ממושכים, ביקרבונט. עודכן ב-7.11.2026: אין עוד "רופא/ה בלבד" בקבוצה זו — ראו החלטת הסקירה | החלטה מקומית (הצעה) | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| סקירה-1 | סקירת פריטים חסומים (7.11.2026) | נושא תפעולי — הנחיות קליניות לא עוסקות בו; מבוסס על נוהל הרפואן | אף תרופה לא חסומה כברירת מחדל. 59 הפריטים שהיו "רופא/ה בלבד" נסקרו אחד-אחד: חלקם פתוחים עם רשימת בדיקות, חלקם בדגל אדום (בדיקה כפולה מול הרופא/ה). נשארים אצל הרופא/ה: רואקוטן, אנטיביוטיקה לתסמין חדש (מלבד מוקסיפן/רפאפן אחרי משטח גרון חיובי) ותרופות נגד שפעת. התראת האינטראקציות של המערכת היא שכבת ההגנה הבסיסית. | החלטה מקומית (7.11.2026) | - |

## 6.ה רשימת התרופות (לסימון)

| # | שם | גנרי | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | אומפרזול | Omeprazole | קיבה · מעכב משאבת פרוטונים | לפי הנחיה | ☐ | |
| 6.2 | אזומפרזול | Esomeprazole | קיבה · מעכב משאבת פרוטונים | לפי הנחיה | ☐ | |
| 6.3 | לנסופרזול | Lansoprazole | קיבה · מעכב משאבת פרוטונים | לפי הנחיה | ☐ | |
| 6.4 | פנטופרזול | Pantoprazole | קיבה · מעכב משאבת פרוטונים | לפי הנחיה | ☐ | |
| 6.5 | דקסלנסופרזול | Dexlansoprazole | קיבה · מעכב משאבת פרוטונים | לפי הנחיה | ☐ | |
| 6.6 | מסאלזין (בבליעה) | Mesalazine (oral) | IBD · 5-ASA | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 6.7 | בודזוניד (בבליעה) | Budesonide (oral) | סטרואיד בפעילות מקומית | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 6.8 | חומצה אורסודאוקסיכולית | Ursodeoxycholic acid | מחלות כבד כולסטטיות / אבני מרה | לפי הנחיה | ☐ | |
| 6.9 | לקטולוז | Lactulose | משלשל / אנצפלופתיה כבדית | לפי הנחיה | ☐ | |
| 6.10 | פמוטידין | Famotidine | חוסם H2 | לפי הנחיה | ☐ | |
| 6.11 | פנקראטין | Pancreatin | אנזימי לבלב | לפי הנחיה | ☐ | |
| 6.12 | ריפקסימין | Rifaximin | אנטיביוטיקה במעי | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 6.13 | תרופות נגד הפטיטיס B | Hepatitis B antivirals | אנטי-ויראלי | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 6.14 | דומפרידון | Domperidone | פרוקינטי | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 6.15 | מטוקלופרמיד | Metoclopramide | פרוקינטי | דגל אדום | ☐ | |
| 6.16 | מבברין | Mebeverine | נוגד עוויתות (IBS) | לפי הנחיה | ☐ | |
| 6.17 | פרוקלופריד | Prucalopride | עצירות כרונית | לפי הנחיה | ☐ | |
| 6.18 | משלשלים | Laxatives | עצירות | לפי הנחיה | ☐ | |
| 6.19 | תרופות נגד הפטיטיס C ו-D | Hepatitis C / D antivirals | אנטי-ויראלי | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 6.20 | תרופות מומחה נוספות | Other specialist drugs | מומחה | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |

## 1.6 פירוט מלא

### 6.1 **אומפרזול** · Omeprazole לפי הנחיה

קיבה · מעכב משאבת פרוטונים

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (4) | לוסק · Losec \| אומפרדקס · Omepradex \| אומפרה · Omepra \| פרומזול 2 מ"ג/מ"ל · Promezole (תרחיף) |
| נימוק / הערה | התוויה מתועדת לטיפול ממושך |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | התוויה מתועדת לטיפול ממושך | ברשומה מתועדת התוויה לטיפול ממושך (רפלוקס קשה, ושט בארט, היצרות, או הגנה עם NSAID/נוגדי טסיות/סטרואידים). אין ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה לשקול הפחתה או הפסקה. | |
| 2 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 5 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 6 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 7 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | שלשולים מתמשכים ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 6.2 **אזומפרזול** · Esomeprazole לפי הנחיה

קיבה · מעכב משאבת פרוטונים

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (3)** | נקסיום · Nexium \| אסופרים · Esoprim \| אסומפראזול אינובמד · Esomeprazole Inovamed |
| **נימוק / הערה** | התוויה מתועדת לטיפול ממושך |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **התוויה מתועדת לטיפול ממושך** | ברשומה מתועדת התוויה לטיפול ממושך (רפלוקס קשה, ושט בארט, היצרות, או הגנה עם NSAID/נוגדי טסיות/סטרואידים). אין ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה לשקול הפחתה או הפסקה. | |
| 2 | **רכישות** | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 5 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 6 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 7 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | שלשולים מתמשכים ← לרופא |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 6.3 לנסופרזול · Lansoprazole לפי הנחיה

קיבה · מעכב משאבת פרוטונים

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | לנטון · Lanton \| לנסו טבע · Lanso Teva |
| נימוק / הערה | התוויה מתועדת לטיפול ממושך |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | התוויה מתועדת לטיפול ממושך | ברשומה מתועדת התוויה לטיפול ממושך (רפלוקס קשה, ושט בארט, היצרות, או הגנה עם NSAID/נוגדי טסיות/סטרואידים). אין ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה לשקול הפחתה או הפסקה. | |
| 2 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 5 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 6 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 7 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | שלשולים מתמשכים ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 6.4 **פנטופרזול** · Pantoprazole לפי הנחיה

קיבה · מעכב משאבת פרוטונים

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (2)** | קונטרולוק · Controloc \| פנטופרזול קלצקס · Pantoprazole Kalceks |
| **נימוק / הערה** | התוויה מתועדת לטיפול ממושך |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **התוויה מתועדת לטיפול ממושך** | ברשומה מתועדת התוויה לטיפול ממושך (רפלוקס קשה, ושט בארט, היצרות, או הגנה עם NSAID/נוגדי טסיות/סטרואידים). אין ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה לשקול הפחתה או הפסקה. | |
| 2 | **רכישות** | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 5 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 6 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 7 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | שלשולים מתמשכים ← לרופא |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 6.5 דקסלנסופרזול · Dexlansoprazole

לפי הנחיה

קיבה · מעכב משאבת פרוטונים

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | דקסילנט · Dexilant |
| נימוק / הערה | התוויה מתועדת לטיפול ממושך |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | התוויה מתועדת לטיפול ממושך | ברשומה מתועדת התוויה לטיפול ממושך (רפלוקס קשה, ושט בארט, היצרות, או הגנה עם NSAID/נוגדי טסיות/סטרואידים). אין ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה לשקול הפחתה או הפסקה. | |
| 2 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 5 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 6 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 7 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | שלשולים מתמשכים ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 6.6 מסאלזין (בבליעה) · Mesalazine (oral) לפי הנחיה, בתנאים

IBD · 5-ASA

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (4) | אסאקול · Asacol | מזוונט · Mezavant | פנטסה · Pentasa | רפאסאל · Rafassal |
| נימוק / הערה | נפריטיס נדירה: קריאטינין שנתי בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | קריאטינין מתועד | קריאטינין/eGFR מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה ב-30% ומעלה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י גסטרואנטרולוג/ית או רופא/ה, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 10 | תפקודי כליות | קריאטינין ו-eGFR מהשנה האחרונה. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | קריאטינין שנתי; ספירת דם שנתית |
| ספי החזרה לרופא/ה | קריאטינין עלה ב-30% ומעלה |
| ערך חמור | eGFR <30 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | דם בצואה או שלשולים מחמירים ← לרופא; חום וכאב בטן ← דחוף |
| מקור | מעקב: SPS Medicines Monitoring (NHS) · SPS Medicines Monitoring |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 6.7 **בודזוניד (בבליעה)** · Budesonide (oral) לפי הנחיה, בתנאים

סטרואיד בפעילות מקומית

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (3)** | בודסון · Budeson \| קורטימנט · Cortiment \| ג'ורבזה · Jorveza (EoE) |
| **נימוק / הערה** | קורס לפי הגסטרואנטרולוג/ית; טיפול ממושך ← עצם וסוכר |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | בתוך משך הטיפול שנקבע | בתוך משך הטיפול שנקבע ע"י הגסטרואנטרולוג/ית. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י גסטרואנטרולוג/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | חום או זיהום ← לרופא |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 6.8 **חומצה אורסודאוקסיכולית** · Ursodeoxycholic acid לפי הנחיה

מחלות כבד כולסטטיות / אבני מרה

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (2)** | אורסופאלק · Ursofalk \| אורסוליט · Ursolit |
| **נימוק / הערה** | תפקודי כבד |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **תפקודי כבד מתועדים** | ALT ופוספטזה בסיסית מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | **תפקודי כבד (ALT) תקין** | בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 2 מהגבול העליון או עלייה לעומת הקודם ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | **רכישות** | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | תפקודי כבד שנתי |
| **ספי החזרה לרופא/ה** | ALT מעל פי 2 מהגבול העליון או עלייה לעומת הקודם |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | צהבת או גרד ← לרופא |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · FDA (DailyMed) עלון |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 6.9 **לקטולוז** · Lactulose לפי הנחיה

משלשל / אנצפלופתיה כבדית

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (3)** | לקטורז · Lacturaz \| לבולק · Laevolac \| אבילק · Avilac |
| **נימוק / הערה** | באנצפלופתיה כבדית לא מפסיקים |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **רכישות** | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 4 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 5 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 6 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | אין מעקב מעבדה |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | בלבול או ישנוניות (מחלת כבד) ← דחוף; שלשולים מרובים ← לרופא |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-(DailyMed) FDA · עלון (DailyMed) FDA |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 6.10 **פמוטידין** · Famotidine לפי הנחיה

חוסם H2

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (3)** | פאמו · Famo \| גאסטרו · Gastro \| פמוטידין טבע · Famotidine Teva |
| **נימוק / הערה** | מינון לפי כליות; התוויה לטיפול ממושך |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **התוויה מתועדת לטיפול ממושך** | התוויה מתועדת לטיפול ממושך. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | **רכישות** | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 5 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 6 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 7 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | צואה שחורה או הקאה דמית ← דחוף; קושי בבליעה או ירידה במשקל ← לרופא |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 6.11 פנקראטין · Pancreatin לפי הנחיה

אנזימי לבלב

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | קראון · Creon |
| נימוק / הערה | אי-ספיקת לבלב מתועדת |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אי-ספיקת לבלב מתועדת | אבחנה מתועדת של אי-ספיקת לבלב או CF. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 5 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 6 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 7 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 6.12 ריפקסימין · Rifaximin לפי הנחיה, בתנאים

אנטיביוטיקה במעי

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | לורמיקס · Lormyx (לאימות מול מאגר משרד הבריאות) |
| נימוק / הערה | למניעת אנצפלופתיה כבדית - ע"י הכבד; IBS - קורס |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | התוויה מתועדת | מניעת אנצפלופתיה כבדית שנקבעה ע"י היחידה, או קורס שנקבע ע"י רופא/ה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ה מומחה/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה |
| תלונות בפנייה או ברשומה | בלבול (מחלת כבד) ← דחוף |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 6.13 תרופות נגד הפטיטיס B · Hepatitis B antivirals

לפי הנחיה, בתנאים

אנטי-ויראלי

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (10) | ויראד · Viread \| טנופוביר טבע · Tenofovir Teva \| ומלידי · Vemlidy \| אנטקאביר טבע · Entecavir Teva \| אנטאבניר · Enteavenir \| אנטקאביר סנדוז · Entecavir Sandoz \| אנטקאביר אס.קיי. · Entecavir S.K. \| אנטקאביר אינובמד · Entecavir Inovamed \| אנטקאביר-תרימה · Entecavir-Trima \| זפיקס · Zeffix |
| נימוק / הערה | טיפול בהפטיטיס B נקבע ומנוטר ע"י מרפאת הכבד. אסור להפסיק: הפסקה עלולה לגרום להתלקחות. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני במינון קבוע שנקבע ע"י מומחה/ית. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | מעקב מסודר — מרפאת הכבד | יש ביקור (מרפאת הכבד) בתקופה שנקבעה במעקב, ואין פער במעקב. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | תפקודי כליות (טנופוביר) | בטנופוביר: קריאטינין ו-eGFR מהשנה האחרונה. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 10 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 6.14 דומפרידון · Domperidone

לפי הנחיה, בתנאים

פרוקינטי

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | מוטיליום · Motilium |
| נימוק / הערה | מאריך QT. מומלץ לטווח קצר בלבד; טיפול ממושך רק בהחלטת רופא/ה בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | התוויה מתועדת לטיפול ממושך | החלטה מתועדת של הרופא/ה על טיפול ממושך (למשל גסטרופרזיס). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | אין מחלת לב או הפרעת אלקטרוליטים | אין ברשומה אי ספיקת לב, הארכת QT, הפרעת קצב או הפרעה משמעותית באלקטרוליטים. לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 10 | משך קצר ומינון עד 30 מ"ג ליום | הטיפול עד שבוע בדרך כלל, 10 מ"ג עד 3 פעמים ביום (עד 30 מ"ג ליום). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 11 | אין פגיעה כבדית בינונית או קשה | אין ברשומה מחלת כבד בינונית או קשה. לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אק"ג בגיל 60+ או במחלת לב |
| תלונות בפנייה או ברשומה | דפיקות לב או עילפון ← דחוף |
| מקור | מעקב: העלון לרופא (משרד הבריאות) ו2014 EMA · עלון לרופא (משרד הבריאות) — EMA · Motilium — 2014 — דומפרידון |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 6.15 **מטוקלופרמיד** · Metoclopramide דגל אדום

פרוקינטי

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (1)** | פראמין · Pramin |
| **נימוק / הערה** | מטוקלופרמיד (פרמין) מעל 12 שבועות: סיכון לדיסקינזיה מאוחרת, בעיקר במבוגרים. הרפואן בודק גיל והתוויות נגד, והרופא/ה מאשר/ת. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **גיל 18 ומעלה** | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה (בילדים ובני נוער — קו שני בלבד). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | **אין התוויות נגד** | אין פרקינסון, אפילפסיה, פאוכרומוציטומה, חסימת מעיים או דימום במערכת העיכול. לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 3 | **בפנייה וברשומה: לא מתוארות תנועות לא רצוניות** | בפנייה וברשומה לא מתוארות תנועות לא רצוניות בפנים, בלשון או בגפיים, או רעד חדש. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 4 | **משך הטיפול ידוע** | תאריך תחילת הטיפול ומשכו מתועדים בסיכום לרופא/ה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 10 | **עד 12 שבועות** | הטיפול הרצוף עד 12 שבועות (אזהרת קופסה שחורה). לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| **מקור** | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 6.16 **מבברין** · Mebeverine לפי הנחיה

נוגד עוויתות (IBS)

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (1)** | קולוטאל · Colotal |
| **נימוק / הערה** | בטוח |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **רכישות** | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 4 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 5 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 6 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | אין מעקב מעבדה |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | דם בצואה, ירידה במשקל או שינוי חדש ביציאות מגיל 50 ← לרופא |
| **מקור** | נייר העמדה של ההסתדרות הרפואית על IBS (Ne194, 2022) — שיוך לפי קבוצה (נוגדי עוויתות), אושר 9.11.2026 |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 6.17 פרוקלופריד · Prucalopride לפי הנחיה

עצירות כרונית

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | רזולור · Resolor |
| נימוק / הערה | אם אין שיפור אחרי 4 שבועות ← הערכה מחדש |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין החמרה מתועדת | ברשומה או בפנייה אין מחשבות אובדניות או החמרה במצב הנפשי מאז הביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 2 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 5 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 6 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 7 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה |
| תלונות בפנייה או ברשומה | מחשבות אובדניות ← דחוף; החמרה במצב הרוח או אי-שקט קשה ← לרופא; דם בצואה או ירידה במשקל ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 6.18 **משלשלים** · Laxatives לפי הנחיה

עצירות

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (8)** | נורמלקס · Normalax \| פגלקס · Peglax \| רגולקס · Regulax \| אגיולקס · Agiolax \| אגיוקור · Agiocur \| לקסעדין · Laxadin \| קונטלקס · Contalax \| אאוקרבון · Eucarbon |
| **נימוק / הערה** | בטוחים; שינוי חדש ביציאות מגיל 50 ← בירור |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **רכישות** | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 4 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 5 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 6 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | אין מעקב מעבדה |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | דם בצואה, ירידה במשקל או שינוי חדש ביציאות ← לרופא; כאב בטן חזק או הקאות ← דחוף |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 6.19 תרופות נגד הפטיטיס C ו-D · Hepatitis C / D antivirals

לפי הנחיה, בתנאים

אנטי-ויראלי

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (4) | אפקלוזה · Epclusa \| ווסווי · Vosevi \| מבירט · Maviret \| הפקלודקס · Hepcludex |
| נימוק / הערה | טיפול בהפטיטיס C הוא קורס קבוע (לרוב 8–12 שבועות), ובהפטיטיס D לפי מרפאת הכבד. חידוש עד תאריך הסיום שנקבע. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | הנחיה עדכנית של מרפאת הכבד | מכתב או סיכום של מרפאת הכבד מ-12 החודשים האחרונים, עם אותה תרופה ומינון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | בתוך משך הקורס | תאריך הסיום שקבעה מרפאת הכבד לא עבר. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 5 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 6 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 7 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 8 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 6.20 תרופות מומחה נוספות · Other specialist drugs לפי הנחיה, בתנאים

מומחה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (5) | אוקליבה · Ocaliva \| ליבדלזי · Livdelzi \| ואנראפיה · Vanrafia \| פבהלטה · Fabhalta \| רקטוסוניד · Rectosonide (בודסוניד רקטלי, גסטרו) |
| נימוק / הערה | אוקליבה ולבדלזי ל-PBC: נקבעות ע"י הפטולוג/ית. חידוש כשיש מעקב מסודר והנחיה עדכנית. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני במינון קבוע שנקבע ע"י מומחה/ית. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | מעקב מסודר — ההפטולוג/ית | יש ביקור (ההפטולוג/ית) בתקופה שנקבעה במעקב, ואין פער במעקב. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | הנחיה עדכנית של ההפטולוג/ית | מכתב או סיכום של ההפטולוג/ית מ-12 החודשים האחרונים, עם אותה תרופה ומינון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 10 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

# 7. כליות ודרכי שתן

25 תרופות · לפי הנחיה: 16 · הכנה לאישור רופא/ה: 3 · לפי הנחיה, בתנאים: 6 · גרסה 2 · חלוקה לפי מערכות · 2.11.2026

מקורות: הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020; ACOG 2023 (סיכום AFP). שאר התחומים: החלטה מקומית; עלון לצרכן לפונקס (עודכן 12/2020). שאר התרופות: החלטה מקומית

## 7.א כללים

- חידוש רגיל: 3 חודשים
- ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה פעם בשנה
- עד 3 חידושים רצופים, ואז ביקור רופא
- אין התווית נגד ← תמיד מחדשים לפחות לחודש אחד
- חסרה מדידה, בדיקה או ביקורת שנתית: חידוש לחודש אחד + זימון למרפאה
- חריגה מספי ההחזרה: חידוש לחודש אחד + הודעה לרופא/ה
- התווית נגד או ערך חמור: לא מחדשים, הודעה לרופא/ה (הסף של כל תרופה מופיע ברשימה שלה)
- רפואן לא משנה מינון ולא מחליף תרופה. "מעקב צמוד" = תרופה עם מעקב תכוף (מעבדה, אק"ג, עיניים או צילום) — לבדוק כל ערך בקפידה
- מעכבי PDE5: ניטרטים = התווית נגד
- אנטי-כולינרגיים לשלפוחית: גיל 75+ ← אישור רופא/ה; אצירת שתן ← דחוף
- תרופות לאי-ספיקת כליות מתקדמת: מעקב נפרולוגי מסודר. ESA וקושרי אשלגן — דגל אדום (המוגלובין / אשלגן עדכניים)
- דגל אדום: הרפואן מכין לפי רשימת הבדיקות, והרופא/ה בודק/ת שוב לפני האישור — גם כשהכול תקין

## 7.ג בדיקות משותפות

| שלב | נושא | מה בודקים | קריטריון | אם לא מתקיים | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| לפני כל חידוש | רכישות | כיסוי ימים ב-6 החודשים האחרונים | 80% מהימים ומעלה | פחות ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה | כמו ביל"ד |
| לפני כל חידוש | ביקורת שנתית | ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה | ב-12 החודשים האחרונים | אין ← חידוש לחודש + זימון לביקורת | כמו ביל"ד |
| לפני כל חידוש | רצף חידושים | כמה חידושים רצופים מאז ביקור רופא | פחות מ-3 | 3 ← ביקור רופא | כמו ביל"ד |

## 7.ד החלטות

| # | נושא | מה ההנחיה אומרת | ההחלטה לפרוטוקול | סוג | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| כללי-15 | שלפוחית רגיזה ו-PDE5 | אנטי-כולינרגיים חזקים — להימנע בקשישים (Beers 2023). מירבגרון: אסור ב- ל"ד ≥180/110, זהירות מעל 160/100 (עלון). PDE5 + ניטרטים — התווית נגד (תווית) | אנטי-כולינרגיים: גיל 75+ ← אישור רופא/ה; אצירת שתן ← דחוף. מירבגרון: ל"ד מתחת ל-160/100. PDE5: ניטרטים = התווית נגד | החלטה מקומית (הצעה) | Beers 2023; עלונים |
| כללי-19 | תרופות מומחה | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי). הטיפול נקבע ומנוטר ע"י המומחה | אריתרופויאטין, קושרי זרחן ואשלגן, HIV, הפטיטיס B, ציקלוספורין/טקרולימוס, אפרמילסט ואציטרטין: הודעה בלבד, חידוש ע"י רופא/ה | החלטה מקומית | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| כללי-20 | השלמות מהמאגר (2.11.2026) | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) | טרזוסין, פינסטריד, אינקליסירן, ורדנאפיל, טיפות לגלאוקומה (ביקורת עיניים שנתית; טימולול: דופק ואסתמה), NSAID ממושך (כליות, אשלגן, ל"ד, דימום, הגנת קיבה), אנטיהיסטמינים, ציננריזין, דומפרידון, מבברין, סידן, מידודרין, פנטוקסיפילין, דיפירידמול, ולציקלוביר מונע, חומצה זולדרונית | החלטה מקומית (הצעה) | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |

| # | נושא | מה ההנחיה אומרת | ההחלטה לפרוטוקול | סוג | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| כללי-21 | תרופות מומחה נוספות | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי). הטיפול נקבע ומנוטר ע"י המומחה | מטוקלופרמיד ממושך, ממריצים/מודפיניל, טרשת נפוצה, אונקולוגיה, יל"ד ריאתי/IPF, סירולימוס, הורמון גדילה, המטולוגיה, CF, טפמידיס/מבקמטן: הודעה בלבד, חידוש ע"י רופא/ה. תרופות ביולוגיות בזריקה בקהילה: הרפואן מכין (אישור, מכתב מומחה, מרווח, בטיחות) והרופא/ה מאשר/ת (5.11.2026) | החלטה מקומית | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| כללי-22 | השלמות 2 מהמאגר (2.11.2026) | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) | ויטמין D, בטאהיסטין, חומצה במפדואית, אומגה 3/איקוזפנט, ציפרופיברט, וריסיגואט, ניטרוגליצרין תת-לשוני, פזולינטנט/אלינזנטנט (ALT), דואביב, אינטראروסה, סיאנה, אורליסטט, פרוקלופריד, משלשלים, טטרציקלינים ממושכים, מניעת זיהומי שתן, משככי כאב ממושכים, ביקרבונט. עודכן ב-7.11.2026: אין עוד "רופא/ה בלבד" בקבוצה זו — ראו החלטת הסקירה | החלטה מקומית (הצעה) | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| מעקב-3 | דיגוקסין: תדירות | רמה לא נדרשת באופן שגרתי — רק בחשד לרעילות, שינוי בתפקוד הכליות או תרופה מתקשרת; כליות ואשלגן לפחות שנתית. הרמה השנתית בפרוטוקול מחמירה | רמה מ-12 החודשים האחרונים; אשלגן וקריאטינין מ-6 החודשים האחרונים | החלטה מקומית (הצעה) | SPS |
| מעקב-12 | תרופות למעקב צמוד נוספות | DMARDs: ספירת דם, ALT וקריאטינין כל 3 חודשים בטיפול יציב (BSR 2017); שאר התרופות לפי התווית | מתימזול/PTU, לפלונומיד, אזתיופרין, סולפסלזין, מיקופנולט, מעכבי JAK, הידרוקסיאוריאה, הידרוקסיכלורוקווין, נוגדי פסיכוזה, טסטוסטרון, סטרואידים כרוניים, ניטרופורנטואין, קולכיצין, דנוסומאב, טריפרטייד: בדיקות לפי התרופה; חריגה ← חודש + הודעה; ערך חמור ← לא מחדשים | החלטה מקומית (הצעה) | BSR 2017; עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| סקירה-1 | סקירת פריטים חסומים (7.11.2026) | נושא תפעולי — הנחיות קליניות לא עוסקות בו; מבוסס על נוהל הרפואן | אף תרופה לא חסומה כברירת מחדל. 59 הפריטים שהיו "רופא/ה בלבד" נסקרו אחד-אחד: חלקם פתוחים עם רשימת בדיקות, חלקם בדגל אדום (בדיקה כפולה מול הרופא/ה). נשארים אצל הרופא/ה: רואקוטן, אנטיביוטיקה לתסמין חדש (מלבד מוקסיפן/רפאפן אחרי משטח גרון חיובי) ותרופות נגד שפעת. התראת האינטראקציות של המערכת היא שכבת ההגנה הבסיסית. | החלטה מקומית (7.11.2026) | - |

## 7.ה רשימת התרופות (לסימון)

| # | שם | גנרי | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | טמסולוסין | Tamsulosin | ערמונית · חוסם אלפא | לפי הנחיה | ☐ | |
| 7.2 | אלפוזוסין | Alfuzosin | ערמונית · חוסם אלפא | לפי הנחיה | ☐ | |
| 7.3 | דוטסטריד | Dutasteride | ערמונית · מעכב 5-אלפא רדוקטאז | לפי הנחיה | ☐ | |
| 7.4 | דוטסטריד + טמסולוסין | Dutasteride + Tamsulosin | ערמונית · מעכב 5-אלפא רדוקטאז + חוסם אלפא | לפי הנחיה | ☐ | |
| 7.5 | סוליפנצין | Solifenacin | שלפוחית רגיזה · אנטי-כולינרגי | לפי הנחיה | ☐ | |
| 7.6 | טולטרודין | Tolterodine | שלפוחית רגיזה · אנטי-כולינרגי | לפי הנחיה | ☐ | |
| 7.7 | פזוטרודין | Fesoterodine | שלפוחית רגיזה · אנטי-כולינרגי | לפי הנחיה | ☐ | |
| 7.8 | טרוספיום | Trospium | שלפוחית רגיזה · אנטי-כולינרגי | לפי הנחיה | ☐ | |
| 7.9 | אוקסיבוטינין | Oxybutynin | שלפוחית רגיזה · אנטי-כולינרגי | לפי הנחיה | ☐ | |

| # | שם | גנרי | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.10 | מירבגרון | Mirabegron | שלפוחית רגיזה · אגוניסט בטא-3 | לפי הנחיה | ☐ | |
| 7.11 | סילדנאפיל | Sildenafil | מעכב PDE5 | לפי הנחיה | ☐ | |
| 7.12 | טדלפיל | Tadalafil | מעכב PDE5 | לפי הנחיה | ☐ | |
| 7.13 | מעודדי ייצור דם (אריתרופויאטין) | Erythropoiesis-stimulating agents | ESA | דגל אדום | ☐ | |
| 7.14 | קושרי זרחן | Phosphate binders | אי-ספיקת כליות | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 7.15 | קושרי אשלגן | Potassium binders | היפרקלמיה | דגל אדום | ☐ | |
| 7.16 | טרזוסין | Terazosin | ערמונית · חוסם אלפא | לפי הנחיה | ☐ | |
| 7.17 | פינסטריד | Finasteride | ערמונית · מעכב 5-אלפא רדוקטאז | לפי הנחיה | ☐ | |
| 7.18 | ורדנאפיל | Vardenafil | מעכב PDE5 | לפי הנחיה | ☐ | |
| 7.19 | מניעת זיהומי שתן | UTI prophylaxis | מניעה ממושכת | לפי הנחיה | ☐ | |
| 7.20 | סודיום ביקרבונט (טבליות) | Sodium bicarbonate (tablets) | חמצת במחלת כליות | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 7.21 | תרופות למחלת עצם בכליות | CKD bone-mineral drugs | נפרולוגיה | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 7.22 | אשלגן ציטרט ומשנני שתן (יורוציט-קיי, אוראליט-U) | Urinary alkalinisers | אבנים בכליות · מומחה | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 7.23 | אלפרוסטדיל בזריקה לפין (קברג'קט) | Alprostadil (intracavernosal) | אורולוגיה · אין-אונות | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 7.24 | בתנכול (מיוכולין) | Bethanechol | אורולוגיה · אצירת שתן | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 7.25 | ניטרופורנטואין (מניעה) | Nitrofurantoin (prophylaxis) | אנטיביוטיקה למניעת זיהומי שתן | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |

## 7.ו פירוט מלא

### 7.1 **טמסולוסין** · Tamsulosin לפי הנחיה

ערמונית · חוסם אלפא

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (4)** | פרומניקס · Promnix \| טמסולין · Tamsulin \| טמסו פי.אר. טבע · Tamsu P.R. Teva \| טמסולוסין אינובמד · Tamsulosin Inovamed |
| **נימוק / הערה** | ללא מעקב מעבדה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **רכישות** | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 4 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 5 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 6 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | סחרחורת בעמידה או נפילות ← לרופא |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · FDA (DailyMed) עלון |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 7.2 אלפוזוסין · Alfuzosin לפי הנחיה

ערמונית · חוסם אלפא

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | קסטרל · Xatral \| אלפו-קל Alfu-Kal XL \| XL · אלפוזוסין ER טבע · Alfuzosin ER Teva |
| נימוק / הערה | ללא מעקב מעבדה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 4 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 5 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 6 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | סחרחורת בעמידה או נפילות ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 7.3 דוטסטריד · Dutasteride לפי הנחיה

ערמונית · מעכב 5-אלפא רדוקטאז

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (4) | אבודרט · Avodart \| ערמוניה · Armonia \| דוטסטריד תרו · Dutasteride Taro \| דוטאסטריד טבע · Dutasteride Teva |
| נימוק / הערה | ללא מעקב מעבדה בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 4 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 5 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 6 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 7 | אין התווית נגד | מטופלת (אישה). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 8 | PSA במעקב | PSA אחרי 6 חודשי טיפול (בסיס חדש) ומהשנה האחרונה; כל עלייה מהשפל על הטיפול ← לרופא/ה (הערך על הטיפול הוא כחצי). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה שגרתי (PSA יורד בכמחצית) |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | מטופלת (אישה) |
| מקור | מעקב: SPS Medicines Monitoring · SPS Medicines Monitoring (NHS) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 7.4 **דוטסטריד + טמסולוסין** · Dutasteride + Tamsulosin לפי הנחיה

ערמונית · מעכב 5-אלפא רדוקטאז + חוסם אלפא

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (6)** | דואודרט · Duodart \| ערמוניה פלוס · Armonia Plus \| דופרוסט · Duprost \| דוטלוסין טבע · Dutalosin Teva \| דוטרסין אס.קיי · Dutarsin S.K. \| דוטאסטמד · Dutastamed |
| **נימוק / הערה** | ללא מעקב מעבדה בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 4 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 5 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 6 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 7 | אין התווית נגד | מטופלת (אישה). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 8 | PSA במעקב | PSA אחרי 6 חודשי טיפול (בסיס חדש) ומהשנה האחרונה; כל עלייה מהשפל על הטיפול ← לרופא/ה (הערך על הטיפול הוא כחצי). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | אין מעקב מעבדה שגרתי (PSA יורד בכמחצית); אין מעקב מעבדה שגרתי |
| **מצבים שמוציאים מהפרוטוקול** | מטופלת (אישה) |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | סחרחורת בעמידה או נפילות ← לרופא |
| **מקור** | מעקב: SPS Medicines Monitoring · SPS Medicines Monitoring (NHS) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 7.5 סוליפנצין · Solifenacin לפי הנחיה

שלפוחית רגיזה · אנטי-כולינרגי

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | סוליפנאסין מדו · Solifenacin Medo \| סוליפנאסין תרימה · Solifenacin Trima \| טאמסולופן · Tamsulofen (עם טמסולוסין) |
| נימוק / הערה | תופעות קוגניטיביות בגיל מבוגר |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **אין ירידה קוגניטיבית מתועדת**<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 75 ומעלה? | אין ירידה קוגניטיבית או בלבול מתועדים, והרופא/ה אישר/ה המשך טיפול בשנה האחרונה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 2 | **אין אצירת שתן מתועדת** | ברשומה או בפנייה אין קושי במתן שתן או אצירת שתן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | **רכישות** | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | **אין התווית נגד** | גלאוקומה עם זווית צרה; אצירת שתן. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | גלאוקומה עם זווית צרה; אצירת שתן |
| תלונות בפנייה או ברשומה | קושי במתן שתן ← דחוף; בלבול או ירידה בזיכרון ← לרופא; כאב עיניים ← דחוף; עצירות קשה ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 7.6 טולטרודין · Tolterodine לפי הנחיה

שלפוחית רגיזה · אנטי-כולינרגי

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | דטרוסיטול Detrusitol SR · SR \| טולטרודין אי.אר. מדומי · Tolterodine E.R. Medomie |
| נימוק / הערה | תופעות קוגניטיביות בגיל מבוגר |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין ירידה קוגניטיבית מתועדת<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 75 ומעלה? | אין ירידה קוגניטיבית או בלבול מתועדים, והרופא/ה אישר/ה המשך טיפול בשנה האחרונה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 2 | אין אצירת שתן מתועדת | ברשומה או בפנייה אין קושי במתן שתן או אצירת שתן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | אין התווית נגד | גלאוקומה עם זווית צרה; אצירת שתן. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | גלאוקומה עם זווית צרה; אצירת שתן |
| תלונות בפנייה או ברשומה | קושי במתן שתן ← דחוף; בלבול או ירידה בזיכרון ← לרופא; כאב עיניים ← דחוף; עצירות קשה ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 7.7 **פזוטרודין** · Fesoterodine לפי הנחיה

שלפוחית רגיזה · אנטי-כולינרגי

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (4)** | טוביאז · Toviaz \| פסוטרמד · Fesotermed \| תרופז · Tarofes \| טרודו · Trudo |
| **נימוק / הערה** | תופעות קוגניטיביות בגיל מבוגר |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **אין ירידה קוגניטיבית מתועדת**<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 75 ומעלה? | אין ירידה קוגניטיבית או בלבול מתועדים, והרופא/ה אישר/ה המשך טיפול בשנה האחרונה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 2 | **אין אצירת שתן מתועדת** | ברשומה או בפנייה אין קושי במתן שתן או אצירת שתן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | **רכישות** | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | **אין התווית נגד** | גלאוקומה עם זווית צרה; אצירת שתן. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | אין מעקב מעבדה |
| **מצבים שמוציאים מהפרוטוקול** | גלאוקומה עם זווית צרה; אצירת שתן |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | קושי במתן שתן ← דחוף; בלבול או ירידה בזיכרון ← לרופא; כאב עיניים ← דחוף; עצירות קשה ← לרופא |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 7.8 **טרוספיום** · Trospium לפי הנחיה

שלפוחית רגיזה · אנטי-כולינרגי

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (4)** | ספזמקס · Spasmex \| ספסמו-ליט · Spasmo-Lyt \| טרוסמוליט · Trosmolyt \| טרוספס · Trospas |
| **נימוק / הערה** | תופעות קוגניטיביות בגיל מבוגר (פחות חודר למוח) |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **אין ירידה קוגניטיבית מתועדת**<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 75 ומעלה? | אין ירידה קוגניטיבית או בלבול מתועדים, והרופא/ה אישר/ה המשך טיפול בשנה האחרונה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 2 | **אין אצירת שתן מתועדת** | ברשומה או בפנייה אין קושי במתן שתן או אצירת שתן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | **רכישות** | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | **אין התווית נגד** | גלאוקומה עם זווית צרה; אצירת שתן. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | אין מעקב מעבדה |
| **מצבים שמוציאים מהפרוטוקול** | גלאוקומה עם זווית צרה; אצירת שתן |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | קושי במתן שתן ← דחוף; בלבול או ירידה בזיכרון ← לרופא; כאב עיניים ← דחוף; עצירות קשה ← לרופא |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 7.9 **אוקסיבוטינין** · Oxybutynin לפי הנחיה

שלפוחית רגיזה · אנטי-כולינרגי

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (2)** | נוביטרופן · Novitropan \| וסוקס · Vesoxx (לשלפוחית) |
| **נימוק / הערה** | תופעות קוגניטיביות בגיל מבוגר — הכי פחות מתאים בגיל מבוגר |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **אין ירידה קוגניטיבית מתועדת**<br>שאלה: המטופל/ת בגיל 75 ומעלה? | אין ירידה קוגניטיבית או בלבול מתועדים, והרופא/ה אישר/ה המשך טיפול בשנה האחרונה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 2 | **אין אצירת שתן מתועדת** | ברשומה או בפנייה אין קושי במתן שתן או אצירת שתן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | **רכישות** | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | **אין התווית נגד** | גלאוקומה עם זווית צרה; אצירת שתן. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | אין מעקב מעבדה |
| **מצבים שמוציאים מהפרוטוקול** | גלאוקומה עם זווית צרה; אצירת שתן |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | קושי במתן שתן ← דחוף; בלבול או ירידה בזיכרון ← לרופא; כאב עיניים ← דחוף; עצירות קשה ← לרופא |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 7.10 **מירבגרון** · Mirabegron לפי הנחיה

שלפוחית רגיזה · אגוניסט בטא-3

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (3)** | בטמיגה · Betmiga \| מיראבגרון אס.קיי. · Mirabegron S.K. \| מירבגרון סנדוז · Mirabegron Sandoz |
| **נימוק / הערה** | אסור בל"ד לא מאוזן (180/110 ומעלה) |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **מדידת ל"ד מתועדת** | מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | **ל"ד מתחת ל-160/100** | מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-160/100. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | **רכישות** | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | ל"ד שנתי |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | כאב ראש או דפיקות לב ← לרופא; קושי במתן שתן ← לרופא |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 7.11 **סילדנאפיל** · Sildenafil לפי הנחיה

מעכב PDE5

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (6)** | ויאגרה · Viagra \| סילדזן · Sildazen \| סילדנאפיל טבע · Sildenafil Teva \| סליידר · Slider \| תרים · Tarim \| ויה-אבניר · Via-Avenir |
| **נימוק / הערה** | אסור עם ניטרטים. רווטיו (יל"ד ריאתי) - רק ע"י היחידה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **אין כאב חזה מתועד** | ברשומה או בפנייה אין כאב בחזה במאמץ. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 2 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 4 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 5 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 6 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 7 | **אין התווית נגד** | ניטרטים (איזוסורביד, ניטרוגליצרין); ריוציגואט (אדמפס). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | אין מעקב מעבדה |
| **מצבים שמוציאים מהפרוטוקול** | ניטרטים (איזוסורביד, ניטרוגליצרין); ריוציגואט (אדמפס) |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | כאב בחזה ← דחוף - מיון, לא לקחת ניטרט; זקפה מעל 4 שעות ← דחוף; ירידה פתאומית בראייה או בשמיעה ← דחוף |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 7.12 **טדלפיל** · Tadalafil לפי הנחיה

מעכב PDE5

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (5)** | סיאליס · Cialis \| טאדאייר · Tadair \| טאדאלאמד · Tadalamed \| טדאליס טבע · Tadalis Teva \| טאדם · Tadam |
| **נימוק / הערה** | אסור עם ניטרטים. רווטיו (יל"ד ריאתי) - רק ע"י היחידה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין כאב חזה מתועד | ברשומה או בפנייה אין כאב בחזה במאמץ. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 4 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 5 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 6 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 7 | אין התווית נגד | ניטרטים (איזוסורביד, ניטרוגליצרין); ריוציגואט (אדמפס). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | אין מעקב מעבדה |
| **מצבים שמוציאים מהפרוטוקול** | ניטרטים (איזוסורביד, ניטרוגליצרין); ריוציגואט (אדמפס) |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | כאב בחזה ← דחוף - מיון, לא לקחת ניטרט; זקפה מעל 4 שעות ← דחוף; ירידה פתאומית בראייה או בשמיעה ← דחוף |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 7.13 מעודדי ייצור דם (אריתרופויאטין) · Erythropoiesis-stimulating agents · דגל אדום

ESA

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | אראנספ · Aranesp \| אפרקס · Eprex \| בינוקריט · Binocrit |
| נימוק / הערה | מעודדי ייצור דם (ארנספ, בינוקריט): המינון לפי ההמוגלובין, והמוגלובין גבוה מדי מעלה סיכון לפקקת ולשבץ. הרפואן מכין, והרופא/ה מאשר/ת. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני במינון קבוע שנקבע ע"י מומחה/ית. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | מעקב מסודר — הנפרולוג/ית או ההמטולוג/ית | יש ביקור (הנפרולוג/ית או ההמטולוג/ית) בתקופה שנקבעה במעקב, ואין פער במעקב. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | המוגלובין עדכני | המוגלובין מהחודש האחרון. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 10 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | המוגלובין מהחודש האחרון |
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 7.14 קושרי זרחן · Phosphate binders

לפי הנחיה, בתנאים

אי-ספיקת כליות

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (4) | רנוולה · Renvela \| סבלמר תרו · Sevelamer Taro \| פוסרנול · Fosrenol \| וולפורו · Velphoro |
| נימוק / הערה | קושרי זרחן באי-ספיקת כליות מתקדמת. זרחן, סידן ו-PTH מנוטרים ביחידת הדיאליזה או בנפרולוגיה. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני במינון קבוע שנקבע ע"י מומחה/ית. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | מעקב מסודר — הנפרולוג/ית | יש ביקור (הנפרולוג/ית) בתקופה שנקבעה במעקב, ואין פער במעקב. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 7.15 קושרי אשלגן · Potassium binders דגל אדום

היפרקלמיה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | לוקלמה · Lokelma \| ולטסה · Veltassa \| קיאקסאלאט · Kayexalate |
| נימוק / הערה | קושרי אשלגן (לוקלמה, ולטסה): המינון לפי רמת אשלגן עדכנית. הרפואן מצרף את האשלגן האחרון, והרופא/ה מאשר/ת. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני במינון קבוע שנקבע ע"י מומחה/ית. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | מעקב מסודר — הנפרולוג/ית | יש ביקור (הנפרולוג/ית) בתקופה שנקבעה במעקב, ואין פער במעקב. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | אשלגן עדכני | אשלגן מהחודש האחרון. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 10 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אשלגן מהחודש האחרון |
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 7.16 טרזוסין · Terazosin לפי הנחיה

ערמונית · חוסם אלפא

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | היטרין · Hytrin \| טרזוסין טבע · Terazosin Teva |
| נימוק / הערה | ללא מעקב מעבדה; סחרחורת בעמידה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 4 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 5 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 6 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| תלונות בפנייה או ברשומה | סחרחורת בעמידה או נפילות ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 7.17 פינסטריד · Finasteride לפי הנחיה

ערמונית · מעכב 5-אלפא רדוקטאז

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | פינסטרייד טבע · Finasteride Teva (1 מ"ג - נשירת שיער) |
| נימוק / הערה | ללא מעקב מעבדה. 1 מ"ג = נשירת שיער; PSA יורד בחצי בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 OP = אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 4 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 5 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 6 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 7 | אין התווית נגד | מטופלת (אישה). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 8 | PSA במעקב | PSA אחרי 6 חודשי טיפול (בסיס חדש) ומהשנה האחרונה; כל עלייה מהשפל על הטיפול ← לרופא/ה (הערך על הטיפול הוא כחצי). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה שגרתי (PSA יורד בכמחצית) |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | מטופלת (אישה) |
| מקור | מעקב: SPS Medicines Monitoring · SPS Medicines Monitoring (NHS) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 7.18 ורדנאפיל · Vardenafil לפי הנחיה

מעכב PDE5

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | בי-און · B-On \| וארדנאפיל אינובמד 10 מ"ג · Vardenafil Inovamed |
| נימוק / הערה | אסור עם ניטרטים |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין כאב חזה מתועד | ברשומה או בפנייה אין כאב בחזה במאמץ. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 4 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 5 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 6 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 7 | אין התווית נגד | ניטרטים (איזוסורביד, ניטרוגליצרין); ריוציגואט (אדמפס). התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | ניטרטים (איזוסורביד, ניטרוגליצרין); ריוציגואט (אדמפס) |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב בחזה ← דחוף - מיון, לא לקחת ניטרט; זקפה מעל 4 שעות ← דחוף |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 7.19 **מניעת זיהומי שתן** · UTI prophylaxis לפי הנחיה

מניעה ממושכת

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (3)** | מתנאמין היפורט אמ.בי.איי · Hiprex (Methenamine Hippurate MBI) \| מטרקס אס.קיי · Metherex S.K \| דיספטיל · Diseptyl (טרימתופרים-סולפה) |
| **נימוק / הערה** | מניעה שנקבעה ע"י רופא/ה; הערכה מחדש כל 6-12 חודשים בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מניעה שהוערכה בשנה האחרונה | החלטת רופא/ה על מניעה ב-12 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | קריאטינין מתועד | קריאטינין/eGFR ואשלגן מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 3 | אשלגן (K) תקין | בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מעל 5.0 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 4 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <30 (לבדיקה) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | ספירת דם (טריפרים) | בטריפרים (TMP-SMX): ספירת דם מהשנה האחרונה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | קריאטינין שנתי; טרימתופרים-סולפה: אשלגן |
| **ספי החזרה לרופא/ה** | eGFR <30 (לבדיקה); K מעל 5.0 |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | פריחה ← דחוף - הפסקה; חום וכאב מותני ← דחוף |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-(DailyMed) FDA · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 7.20 סודיום ביקרבונט (טבליות) · Sodium bicarbonate (tablets) לפי הנחיה, בתנאים

חמצת במחלת כליות

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | סודיום ביקרבונט רקח · Sodium Bicarbonate Rekah |
| נימוק / הערה | נקבע לפי ביקרבונט בדם; בצקות ול"ד |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | ביקרבונט מתועד | ביקרבונט וקריאטינין מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | ביקרבונט בטווח | ביקרבונט בדם 22-29. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ה מומחה/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ביקרבונט וקריאטינין כל 6 חודשים |
| תלונות בפנייה או ברשומה | בצקות או קוצר נשימה ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 7.21 תרופות למחלת עצם בכליות · CKD bone-mineral drugs

לפי הנחיה, בתנאים

נפרולוגיה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (5) | פאריקלציטול אינובמד · Paricalcitol Inovamed \| פרקל · Parkal \| רקסטול · Rextol \| זמפלר · Zemplar \| פארסביב · Parsabiv |
| נימוק / הערה | פריקלציטול (זמפלר) וסינקלצט (מימפרה) באי-ספיקת כליות, מנוטרים בנפרולוגיה (סידן, זרחן, PTH). בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני במינון קבוע שנקבע ע"י מומחה/ית. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | מעקב מסודר — הנפרולוג/ית | יש ביקור (הנפרולוג/ית) בתקופה שנקבעה במעקב, ואין פער במעקב. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 7.22 אשלגן ציטרט ומשנני שתן (יורוציט-קיי, אוראליט-U) · Urinary alkalinisers לפי הנחיה, בתנאים

אבנים בכליות · מומחה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | יורוציט-קיי 10 mEq · Urocit-K 10 mEq \| אוראליט-U · Uralyt-U |
| נימוק / הערה | אשלגן ציטרט (אוראליט-U, יורוציט-קיי) למניעת אבנים, נקבע ע"י נפרולוג/ית או אורולוג/ית. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני במינון קבוע שנקבע ע"י מומחה/ית. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | הנחיה עדכנית של הנפרולוג/ית או האורולוג/ית | מכתב או סיכום של הנפרולוג/ית או האורולוג/ית מ-12 החודשים האחרונים, עם אותה תרופה ומינון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | אלקטרוליטים, קריאטינין וספירה | מ-4 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 10 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 7.23 אלפרוסטדיל בזריקה לפין (קברג'קט) · Alprostadil (intracavernosal) הכנה לאישור רופא/ה

אורולוגיה · אין-אונות

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | קאברג'קט · Caverject (לא בסל) |
| נימוק / הערה | זריקה לפין לאין-אונות, אחרי הדרכה של אורולוג/ית. הרפואן מכין, הרופא/ה מאשר/ת. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 2 | הנחיה עדכנית של האורולוג/ית | מכתב או סיכום של האורולוג/ית מ-12 החודשים האחרונים, עם אותה תרופה ומינון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אין זקפה ממושכת מדווחת | ברשומה או בפנייה אין זקפה שנמשכה מעל 4 שעות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| תלונות בפנייה או ברשומה | זקפה מעל 4 שעות ← דחוף — מיון |
| מקור | פער מול הרג'יסטרי, החלטה מקומית (8.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 7.24 בתנכול (מיוכולין) · Bethanechol לפי הנחיה, בתנאים

אורולוגיה · אצירת שתן

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | מיוכולין גלנווד · Myocholine-Glenwood (לא בסל) |
| נימוק / הערה | כולינרגי לאצירת שתן. התוויות נגד: אסתמה, דופק איטי, כיב פעיל, חסימה במערכת השתן או העיכול. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני במינון קבוע שנקבע ע"י מומחה/ית. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | אין התווית נגד | ברשומה אין אסתמה, דופק איטי, כיב פעיל, או חסימה במערכת השתן או העיכול. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| תלונות בפנייה או ברשומה | קוצר נשימה או צפצופים ← לרופא; סחרחורת או עילפון ← לרופא |
| מקור | פער מול הרג'יסטרי, החלטה מקומית (8.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 7.25 ניטרופורנטואין (מניעה) · Nitrofurantoin (prophylaxis) לפי הנחיה, בתנאים מעקב צמוד

אנטיביוטיקה למניעת זיהומי שתן

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | ניטרופורנטואין רז · Nitrofurantoin Raz \| מאקרוביד · Macrobid |
| נימוק / הערה | מניעה ממושכת בלבד, שנקבעה ע"י רופא/ה. סיכון לפגיעה ריאתית וכבדית |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | בדיקות מתועדות | קריאטינין/eGFR ו-ALT מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חמור: eGFR <45 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התוויות נגד |
| 3 | תפקודי כבד (ALT) תקין | בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 2 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 4 | אין תסמיני ריאות מתועדים | ברשומה או בפנייה אין שיעול או קוצר נשימה חדשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 5 | פחות מ-6 חודשי מניעה רצופים | המניעה נמשכת פחות מ-6 חודשים מאז ההערכה האחרונה של הרופא/ה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 8 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשמניעה ממושכת שנקבעה ע"י רופא/ה. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 9 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 10 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 11 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 12 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | קריאטינין ו-ALT כל 6 חודשים |
| ספי החזרה לרופא/ה | ALT מעל פי 2 מהגבול העליון |
| ערך חמור | eGFR <45 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | שיעול או קוצר נשימה ← דחוף; נימול בידיים או ברגליים ← לרופא; צהבת ← דחוף |
| מקור | מעקב: SPS Medicines Monitoring · SPS Medicines Monitoring (NHS) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

# 8. בריאות האישה

21 תרופות · לפי הנחיה, בתנאים: 11 · לפי הנחיה: 8 · הכנה לאישור רופא/ה: 2 · גרסה 2 · חלוקה לפי מערכות · 2.11.2026

מקורות: הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020; ACOG 2023 (סיכום AFP). שאר התחומים: החלטה מקומית

## 8.א כללים

- חידוש רגיל: 3 חודשים
- ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה פעם בשנה
- עד 3 חידושים רצופים, ואז ביקור רופא
- אין התווית נגד ← תמיד מחדשים לפחות לחודש אחד
- חסרה מדידה, בדיקה או ביקורת שנתית: חידוש לחודש אחד + זימון למרפאה
- חריגה מספי ההחזרה: חידוש לחודש אחד + הודעה לרופא/ה
- התווית נגד או ערך חמור: לא מחדשים, הודעה לרופא/ה (הסף של כל תרופה מופיע ברשימה שלה)
- רפואן לא משנה מינון ולא מחליף תרופה. "מעקב צמוד" = תרופה עם מעקב תכוף (מעבדה, אק"ג, עיניים או צילום) — לבדוק כל ערך בקפידה
- דימום וגינלי לא סדיר ← הודעה דחופה
- אסטרוגן מערכתי כשיש רחם: חייב פרוגסטוגן
- אמצעי מניעה משולב: עישון בגיל 35+, מיגרנה עם הילה או פקקת בעבר = התווית נגד

## 8.ג בדיקות משותפות

| שלב | נושא | מה בודקים | קריטריון | אם לא מתקיים | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| לפני כל חידוש | רכישות | כיסוי ימים ב-6 החודשים האחרונים | 80% מהימים ומעלה | פחות ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה | כמו ביל"ד |
| לפני כל חידוש | ביקורת שנתית | ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה | ב-12 החודשים האחרונים | אין ← חידוש לחודש + זימון לביקורת | כמו ביל"ד |
| לפני כל חידוש | רצף חידושים | כמה חידושים רצופים מאז ביקור רופא | פחות מ-3 | 3 ← ביקור רופא | כמו ביל"ד |

## 8.ד החלטות

| # | נושא | מה ההנחיה אומרת | ההחלטה לפרוטוקול | סוג | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| כללי-14 | הורמונים לנשים | NAMS 2022: אסטרוגן מערכתי עם רחם ← פרוגסטוגן; דימום לא סדיר ← בירור; התוויות נגד: סרטן שד, פקקת, אוטם/שבץ, מחלת כבד | אסטרוגן בלי פרוגסטוגן כשיש רחם ← הודעה דחופה; ממוגרפיה לפי התוכנית; ל"ד שנתי. אמצעי מניעה משולב: ל"ד מתחת ל-140/90, עישון בגיל 35+, מיגרנה עם הילה ופקקת = התווית נגד | הנחיה + החלטה מקומית | NAMS 2022; נייר העמדה הישראלי לטיפול הורמונלי (בפרויקט) |
| כללי-20 | השלמות מהמאגר (2.11.2026) | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) | טרזוסין, פינסטריד, אינקליסירן, ורדנאפיל, טיפות לגלאוקומה (ביקורת עיניים שנתית; טימולול: דופק ואסתמה), NSAID ממושך (כליות, אשלגן, ל"ד, דימום, הגנת קיבה), אנטיהיסטמינים, ציננריזין, דומפרידון, מבברין, סידן, מידודרין, פנטוקסיפילין, דיפירידמול, ולציקלוביר מונע, חומצה זולדרונית | החלטה מקומית (הצעה) | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| כללי-22 | השלמות 2 מהמאגר (2.11.2026) | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) | ויטמין D, בטאהיסטין, חומצה במפדואית, אומגה 3/איקוזפנט, ציפרופיברט, וריסיגואט, ניטרוגליצרין תת-לשוני, פוזולינטנט/אלינזנטנט (ALT), דואביב, אינטראורוסה, סיאנה, אורליסטט, פרוקלופריד, משלשלים, טטרציקלינים ממושכים, מניעת זיהומי שתן, משככי כאב ממושכים, ביקרבונט. עודכן ב-7.11.2026: אין עוד "רופא/ה בלבד" בקבוצה זו — ראו החלטת הסקירה | החלטה מקומית (הצעה) | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |

| # | נושא | מה ההנחיה אומרת | ההחלטה לפרוטוקול | סוג | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| סקירה-1 | סקירת פריטים חסומים (7.11.2026) | נושא תפעולי — הנחיות קליניות לא עוסקות בו; מבוסס על נוהל הרפואן | אף תרופה לא חסומה כברירת מחדל. 59 הפריטים שהיו "רופא/ה בלבד" נסקרו אחד-אחד: חלקם פתוחים עם רשימת בדיקות, חלקם בדגל אדום (בדיקה כפולה מול הרופא/ה). נשארים אצל הרופא/ה: רואקוטן, אנטיביוטיקה לתסמין חדש (מלבד מוקסיפן/רפאפן אחרי משטח גרון חיובי) ותרופות נגד שפעת. התראת האינטראקציות של המערכת היא שכבת ההגנה הבסיסית. | החלטה מקומית (7.11.2026) | - |

## 8.ה רשימת התרופות (לסימון)

| # | שם | גנרי | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | אסטרדיול (מערכתי) | Estradiol (systemic) | טיפול הורמונלי במנופאוזה · אסטרוגן | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 8.2 | אסטרדיול + דידרוגסטרון | Estradiol + dydrogesterone | טיפול הורמונלי במנופאוזה · משולב | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 8.3 | אסטרדיול + נורתיסטרון | Estradiol + norethisterone | טיפול הורמונלי במנופאוזה · משולב | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 8.4 | אסטרדיול + דרוספירנון | Estradiol + drospirenone | טיפול הורמונלי במנופאוזה · משולב | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 8.5 | אסטרדיול + נורגסטרל | Estradiol + norgestrel | טיפול הורמונלי במנופאוזה · משולב | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 8.6 | פרוגסטרון ופרוגסטינים (בבליעה) | Progesterone / progestogens (oral) | פרוגסטוגן | לפי הנחיה | ☐ | |
| 8.7 | אסטרוגן נרתיקי (אסטרדיול, אסטריול) | Estradiol (vaginal) | אסטרוגן מקומי | לפי הנחיה | ☐ | |
| 8.8 | אמצעי מניעה הורמונלי משולב | Combined hormonal contraception | גלולה, טבעת או מדבקה משולבת | לפי הנחיה | ☐ | |
| 8.9 | גלולה פרוגסטטיבית | Progestogen-only pill | אמצעי מניעה | לפי הנחיה | ☐ | |
| 8.10 | דיאנוגסט | Dienogest | אנדומטריוזיס | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 8.11 | פזולינטנט | Fezolinetant | גלי חום · אנטגוניסט NK3 | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 8.12 | אלינזנטנט | Elinzanetant | גלי חום · אנטגוניסט NK3 | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 8.13 | אסטרוגנים מצומדים + בזדוקסיפן | Conjugated estrogens + bazedoxifene | טיפול הורמונלי במנופאוזה (TSEC) | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 8.14 | פרסטרון (נרתיקי) | Prasterone (vaginal) | DHEA מקומי | לפי הנחיה | ☐ | |
| 8.15 | מדרוקסיפרוגסטרון (זריקת מאגר) | Medroxyprogesterone (depot injection) | אמצעי מניעה בזריקה | לפי הנחיה | ☐ | |
| 8.16 | אנטגוניסטים ל-GnRH (אוריליסה, יסלטי) | GnRH antagonists (endometriosis, fibroids) | גינקולוגיה · מומחה | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 8.17 | בחילות בהיריון (דיקלקטין, לדוקסיה, בונג'סטה) | Doxylamine + pyridoxine (nausea of pregnancy) | היריון · בחילות | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 8.18 | התקן תוך-רחמי הורמונלי (מירנה, קיילינה) | Intrauterine devices (hormonal) | בריאות האישה · התקן | לפי הנחיה | ☐ | |

| # | שם | גנרי | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.19 | פרוגסטרון נרתיקי לפוריות ולהיריון (אנדומטרין, קרינון) | Progesterone (fertility, pregnancy) | פוריות · מומחה | לפי הנחיה | ☐ | |
| 8.20 | תרופות לטיפולי פוריות (גונל-אף, מנופור, צטרוטייד, אוביטרל) | Fertility drugs (IVF) | פוריות · מומחה | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 8.21 | טיבולון (ליויאל) | Tibolone | טיפול הורמונלי במנופאוזה · טיבולון | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |

## 1.8 פירוט מלא

### 8.1 **אסטרדיול (מערכתי)** · Estradiol (systemic) לפי הנחיה, בתנאים

טיפול הורמונלי במנופאוזה · אסטרוגן

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | אסטרופם · Estrofem \| אסטרוג'ל · Oestrogel \| אוורל · Evorel (מדבקה) |
| נימוק / הערה | רחם קיים ← חייב פרוגסטוגן. דימום לא סדיר ← בירור |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | פרוגסטוגן ברשימה<br>שאלה: יש רחם (לא עברה כריתת רחם)? | ברשימת התרופות יש פרוגסטרון (אוטרוגסטן, דופסטון) או התקן מירנה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 2 | אין דימום וגינלי לא סדיר | ברשומה או בפנייה אין דימום וגינלי לא סדיר (או דימום אחרי גיל המעבר). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | ממוגרפיה לפי התוכנית | גיל 74-50: ממוגרפיה מ-24 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 4 | מדידת ל"ד מתועדת | מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 5 | ל"ד מתחת ל-140/90 | מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 8 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 9 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 10 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 11 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 12 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 13 | אין התווית נגד | סרטן שד או סרטן רגיש לאסטרוגן; פקקת ורידים או תסחיף ריאתי; אוטם לב או שבץ; מחלת כבד פעילה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ממוגרפיה לפי התוכנית; ל"ד שנתי |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | סרטן שד או סרטן רגיש לאסטרוגן; פקקת ורידים או תסחיף ריאתי; אוטם לב או שבץ; מחלת כבד פעילה |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב ונפיחות ברגל או קוצר נשימה ← דחוף; גוש בשד ← לרופא; דימום וגינלי ← לרופא; כאב ראש חדש וחזק ← דחוף |
| מקור | NAMS 2022; נייר העמדה הישראלי לטיפול הורמונלי (בפרויקט); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 8.2 אסטרדיול + דידרוגסטרון · Estradiol + dydrogesterone לפי הנחיה, בתנאים

טיפול הורמונלי במנופאוזה · משולב

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | פמוסטון · Femoston \| פמוסטון קונטי · Femoston Conti |
| נימוק / הערה | אסטרוגן + פרוגסטוגן. דימום לא סדיר ← בירור |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין דימום וגינלי לא סדיר | ברשומה או בפנייה אין דימום וגינלי לא סדיר (או דימום אחרי גיל המעבר). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ממוגרפיה לפי התוכנית | גיל 50-74: ממוגרפיה מ-24 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 3 | מדידת ל"ד מתועדת | מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 4 | ל"ד מתחת ל-140/90 | מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 12 | אין התווית נגד | סרטן שד או סרטן רגיש לאסטרוגן; פקקת ורידים או תסחיף ריאתי; אוטם לב או שבץ; מחלת כבד פעילה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ממוגרפיה לפי התוכנית; ל"ד שנתי |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | סרטן שד או סרטן רגיש לאסטרוגן; פקקת ורידים או תסחיף ריאתי; אוטם לב או שבץ; מחלת כבד פעילה |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב ונפיחות ברגל או קוצר נשימה ← דחוף; גוש בשד ← לרופא; דימום וגינלי ← לרופא; כאב ראש חדש וחזק ← דחוף |
| מקור | NAMS 2022; נייר העמדה הישראלי לטיפול הורמונלי (בפרויקט) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 8.3 אסטרדיול + נורתיסטרון · Estradiol + norethisterone לפי הנחיה, בתנאים

טיפול הורמונלי במנופאוזה · משולב

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (4) | אקטיבל · Activelle \| נובופם · Novofem \| אביאנה · Eviana \| אוורל קונטי · Evorel Conti (מדבקה) |
| נימוק / הערה | אסטרוגן + פרוגסטוגן. דימום לא סדיר ← בירור |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין דימום וגינלי לא סדיר | ברשומה או בפנייה אין דימום וגינלי לא סדיר (או דימום אחרי גיל המעבר). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ממוגרפיה לפי התוכנית | גיל 74-50: ממוגרפיה מ-24 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 3 | מדידת ל"ד מתועדת | מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 4 | ל"ד מתחת ל-140/90 | מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 12 | אין התווית נגד | סרטן שד או סרטן רגיש לאסטרוגן; פקקת ורידים או תסחיף ריאתי; אוטם לב או שבץ; מחלת כבד פעילה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ממוגרפיה לפי התוכנית; ל"ד שנתי |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | סרטן שד או סרטן רגיש לאסטרוגן; פקקת ורידים או תסחיף ריאתי; אוטם לב או שבץ; מחלת כבד פעילה |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב ונפיחות ברגל או קוצר נשימה ← דחוף; גוש בשד ← לרופא; דימום וגינלי ← לרופא; כאב ראש חדש וחזק ← דחוף |
| מקור | NAMS 2022; נייר העמדה הישראלי לטיפול הורמונלי (בפרויקט); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 8.4 אסטרדיול + דרוספירנון · Estradiol + drospirenone לפי הנחיה, בתנאים

טיפול הורמונלי במנופאוזה · משולב

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | אנג'ליק · Angeliq |
| נימוק / הערה | אסטרוגן + פרוגסטוגן. דימום לא סדיר ← בירור |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין דימום וגינלי לא סדיר | ברשומה או בפנייה אין דימום וגינלי לא סדיר (או דימום אחרי גיל המעבר). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ממוגרפיה לפי התוכנית | גיל 50-74: ממוגרפיה מ-24 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 3 | מדידת ל"ד מתועדת | מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 4 | ל"ד מתחת ל-140/90 | מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 12 | אין התווית נגד | סרטן שד או סרטן רגיש לאסטרוגן; פקקת ורידים או תסחיף ריאתי; אוטם לב או שבץ; מחלת כבד פעילה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ממוגרפיה לפי התוכנית; ל"ד שנתי |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | סרטן שד או סרטן רגיש לאסטרוגן; פקקת ורידים או תסחיף ריאתי; אוטם לב או שבץ; מחלת כבד פעילה |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב ונפיחות ברגל או קוצר נשימה ← דחוף; גוש בשד ← לרופא; דימום וגינלי ← לרופא; כאב ראש חדש וחזק ← דחוף |
| מקור | NAMS 2022; נייר העמדה הישראלי לטיפול הורמונלי (בפרויקט); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 8.5 אסטרדיול + נורגסטרל · Estradiol + norgestrel לפי הנחיה, בתנאים

טיפול הורמונלי במנופאוזה · משולב

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | פרוגילוטון · Progyluton |
| נימוק / הערה | אסטרוגן + פרוגסטוגן. דימום לא סדיר ← בירור |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין דימום וגינלי לא סדיר | ברשומה או בפנייה אין דימום וגינלי לא סדיר (או דימום אחרי גיל המעבר). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ממוגרפיה לפי התוכנית | גיל 50-74: ממוגרפיה מ-24 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 3 | מדידת ל"ד מתועדת | מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 4 | ל"ד מתחת ל-140/90 | מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 12 | אין התווית נגד | סרטן שד או סרטן רגיש לאסטרוגן; פקקת ורידים או תסחיף ריאתי; אוטם לב או שבץ; מחלת כבד פעילה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ממוגרפיה לפי התוכנית; ל"ד שנתי |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | סרטן שד או סרטן רגיש לאסטרוגן; פקקת ורידים או תסחיף ריאתי; אוטם לב או שבץ; מחלת כבד פעילה |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב ונפיחות ברגל או קוצר נשימה ← דחוף; גוש בשד ← לרופא; דימום וגינלי ← לרופא; כאב ראש חדש וחזק ← דחוף |
| מקור | NAMS 2022; נייר העמדה הישראלי לטיפול הורמונלי (בפרויקט) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 8.6 פרוגסטרון ופרוגסטינים (בבליעה) · Progesterone / progestogens (oral) לפי הנחיה

פרוגסטוגן

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (4) | אוטרוגסטן · Utrogestan \| דופסטון · Duphaston \| פרוברה · Provera \| פרימולוט-נור · Primolut-Nor |
| נימוק / הערה | בדרך כלל כהגנה על הרחם עם אסטרוגן, או בהתוויה גינקולוגית |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | התוויה מתועדת | ניתן יחד עם אסטרוגן, או התוויה גינקולוגית מתועדת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | אין דימום וגינלי לא סדיר | ברשומה או בפנייה אין דימום וגינלי לא סדיר (או דימום אחרי גיל המעבר). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה |
| תלונות בפנייה או ברשומה | דימום וגינלי לא סדיר ← לרופא; כאב ונפיחות ברגל ← דחוף |
| מקור | NAMS 2022; נייר העמדה הישראלי לטיפול הורמונלי (בפרויקט); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 8.7 **אסטרוגן נרתיקי (אסטרדיול, אסטריול)** · Estradiol (vaginal) לפי הנחיה

אסטרוגן מקומי

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (2)** | וגיפם · Vagifem \| אובסטין קרם · Ovestin Cream (אסטריול) |
| **נימוק / הערה** | מינון נמוך; אינו מחייב פרוגסטוגן |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **אין דימום וגינלי לא סדיר** | ברשומה או בפנייה אין דימום וגינלי לא סדיר (או דימום אחרי גיל המעבר). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 2 | **רכישות** | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 5 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 6 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 7 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | אין מעקב מעבדה |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | דימום וגינלי ← לרופא |
| **מקור** | NAMS 2022; נייר העמדה הישראלי לטיפול הורמונלי (בפרויקט); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 8.8 אמצעי מניעה הורמונלי משולב · Combined hormonal contraception לפי הנחיה

גלולה, טבעת או מדבקה משולבת

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (23) | מיקרוגינון · Microgynon \| יסמין · Yasmin \| יסמין פלוס · Yasmin Plus \| יאז · Yaz \| יאז פלוס · Yaz Plus \| ליז · Liz \| מרסילון · Mercilon \| פמינט · Feminet \| הרמונט · Harmonet \| מינולט · Minulet \| מליאן · Meliane \| גינרה · Gynera \| קלייר · Qlair \| זואלי · Zoely \| בלארה · Belara \| מינס · Minesse \| פלורט · Floret \| פליים · Flame \| נקסטלה · Nextela \| נובארינג · Nuvaring (טבעת) \| אוורה · Evra (מדבקה) \| דיאנה · Diane (ציפרוטרון) \| אסטל · Estelle-35 (ציפרוטרון) |
| נימוק / הערה | ל"ד, עישון, מיגרנה עם הילה ופקקת בעבר |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מדידת ל"ד מתועדת | מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | ל"ד מתחת ל-140/90 | מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | לא מעשנת, או מתחת לגיל 35 | אין עישון מתועד בגיל 35 ומעלה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 10 | אין התווית נגד | פקקת ורידים או תסחיף ריאתי בעבר; מיגרנה עם הילה (אורה); עישון בגיל 35 ומעלה; סרטן שד; אוטם לב או שבץ; מחלת כבד פעילה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ל"ד שנתי |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | פקקת ורידים או תסחיף ריאתי בעבר; מיגרנה עם הילה (אורה); עישון בגיל 35 ומעלה; סרטן שד; אוטם לב או שבץ; מחלת כבד פעילה |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב ונפיחות ברגל או קוצר נשימה ← דחוף; כאב ראש חזק חדש או הפרעות ראייה ← דחוף; כאב בחזה ← דחוף - מיון |
| מקור | WHO/CDC MEC (החלטה מקומית); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 8.9 גלולה פרוגסטטיבית · Progestogen-only pill לפי הנחיה

אמצעי מניעה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | סרזט · Cerazette \| דיאמילה · Diamilla \| פומיניק · Fominic |
| נימוק / הערה | מתאימה גם כשאסטרוגן אסור בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 4 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 5 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 6 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 7 | אין התווית נגד | סרטן שד. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 8 | אין התווית נגד | אין ברשומה פקקת ורידים פעילה, מחלת כבד קשה, גידול כבד, סרטן תלוי הורמונים, או דימום נרתיקי לא מבורר. לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 9 | גיל עד 55 | לפי FSRH: עד גיל 55. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | סרטן שד |
| תלונות בפנייה או ברשומה | דימום לא סדיר ממושך ← לרופא |
| מקור | מעקב: העלון לרופא (משרד הבריאות) ו FSRH POP 2022 · עלון לרופא (משרד הבריאות) — Cerazette · FSRH POP 2022 |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 8.10 **דיאנוגסט** · Dienogest לפי הנחיה, בתנאים

אנדומטריוזיס

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (1)** | ויזאבל · Visabelle |
| **נימוק / הערה** | נקבע ע"י גינקולוג/ית בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **אין דימום וגינלי לא סדיר** | ברשומה או בפנייה אין דימום וגינלי לא סדיר (או דימום אחרי גיל המעבר). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 2 | **רכישות** | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | **טיפול כרוני במינון קבוע** | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י גינקולוג/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | **אין מחלת לב וכלי דם או קרישיות** | אין ברשומה אוטם, שבץ, מחלה איסכמית, פקקת ורידים פעילה או סוכרת עם מעורבות כלי דם. לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 10 | **אין סרטן תלוי הורמונים** | אין ברשומה סרטן תלוי הורמוני מין או גידול כבד. לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 11 | **לחץ דם תקין** | לחץ דם אחרון מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | אין מעקב מעבדה |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | דיכאון ← לרופא |
| **מקור** | מעקב: העלון לרופא (משרד הבריאות) · עלון לרופא (משרד הבריאות) — Visabelle |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 8.11 **פזולינטנט** · Fezolinetant לפי הנחיה, בתנאים

גלי חום · אנטגוניסט NK3

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | ואוזה · Veoza |
| נימוק / הערה | לא הורמונלי. סיכון לפגיעה כבדית: ALT לפני ובחודשים הראשונים בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | ALT מתועד | ALT בתוך 3 החודשים האחרונים בשנה הראשונה, אחר כך שנתי. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | תפקודי כבד (ALT) תקין | בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: ALT מעל פי 5 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: ALT מעל פי 5 מהגבול העליון ← לא מחדשים | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 10 | אין ALT מעל פי 3 עם בילירובין מעל פי 2 | בבדיקה האחרונה אין ALT או AST מעל פי 3 יחד עם בילירובין מעל פי 2. לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 11 | בדיקות כבד בחודשים 1, 2, 3, 6 ו-9 | תפקודי כבד בכל אחד מהמועדים שעברו (חודשים 1, 2, 3, 6, 9). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ALT לפני הטיפול, אחרי 1, 2, 3 חודשים ואז לפי תסמינים |
| ספי החזרה לרופא/ה | ALT מעל פי 3 מהגבול העליון |
| ערך חמור | ALT מעל פי 5 מהגבול העליון |
| תלונות בפנייה או ברשומה | צהבת, שתן כהה, גרד או כאב בטן ← דחוף - הפסקה |
| מקור | NAMS 2022; נייר העמדה הישראלי לטיפול הורמונלי (בפרויקט); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 8.12 **אלינזנטנט** · Elinzanetant לפי הנחיה, בתנאים

גלי חום · אנטגוניסט NK3

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | לינקואט · Lynkuet |
| נימוק / הערה | לא הורמונלי. סיכון לפגיעה כבדית: ALT לפני ובחודשים הראשונים |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | ALT מתועד | ALT בתוך 3 החודשים האחרונים בשנה הראשונה, אחר כך שנתי. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | תפקודי כבד (ALT) תקין | בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: ALT מעל פי 5 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: ALT מעל פי 5 מהגבול העליון ← לא מחדשים | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ALT לפני הטיפול, אחרי 1, 2, 3 חודשים ואז לפי תסמינים |
| ספי החזרה לרופא/ה | ALT מעל פי 3 מהגבול העליון |
| ערך חמור | ALT מעל פי 5 מהגבול העליון |
| תלונות בפנייה או ברשומה | צהבת, שתן כהה, גרד או כאב בטן ← דחוף - הפסקה |
| מקור | NAMS 2022; נייר העמדה הישראלי לטיפול הורמונלי (בפרויקט); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 8.13 אסטרוגנים מצומדים + בזדוקסיפן · Conjugated estrogens + bazedoxifene לפי הנחיה, בתנאים

טיפול הורמונלי במנופאוזה (TSEC)

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | דואביב · Duavive |
| נימוק / הערה | לא צריך פרוגסטוגן. דימום לא סדיר ← בירור |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין דימום וגינלי לא סדיר | ברשומה או בפנייה אין דימום וגינלי לא סדיר (או דימום אחרי גיל המעבר). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ממוגרפיה לפי התוכנית | גיל 74-50: ממוגרפיה מ-24 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 3 | מדידת ל"ד מתועדת | מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 4 | ל"ד מתחת ל-140/90 | מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 12 | אין התווית נגד | סרטן שד; פקקת ורידים או תסחיף ריאתי; אוטם לב או שבץ; מחלת כבד פעילה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ממוגרפיה לפי התוכנית; ל"ד שנתי |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | סרטן שד; פקקת ורידים או תסחיף ריאתי; אוטם לב או שבץ; מחלת כבד פעילה |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב ונפיחות ברגל או קוצר נשימה ← דחוף; גוש בשד ← לרופא; דימום וגינלי ← לרופא; כאב ראש חדש וחזק ← דחוף |
| מקור | NAMS 2022; נייר העמדה הישראלי לטיפול הורמונלי (בפרויקט); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 8.14 פרסטרון (נרתיקי) · Prasterone (vaginal) לפי הנחיה

DHEA מקומי

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | אינטראروסה · Intrarosa |
| נימוק / הערה | מקומי; דימום ← בירור |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין דימום וגינלי לא סדיר | ברשומה או בפנייה אין דימום וגינלי לא סדיר (או דימום אחרי גיל המעבר). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 2 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 5 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 6 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 7 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה |
| תלונות בפנייה או ברשומה | דימום וגינלי ← לרופא |
| מקור | NAMS 2022; נייר העמדה הישראלי לטיפול הורמונלי (בפרויקט); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 8.15 מדרוקסיפרוגסטרון (זריקת מאגר) · Medroxyprogesterone (depot injection) לפי הנחיה

אמצעי מניעה בזריקה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | סיאנה · Sayana |
| נימוק / הערה | זריקה כל 13 שבועות. ירידה בצפיפות עצם בשימוש ממושך בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | הזריקה בזמן | הזריקה הקודמת ניתנה לפני 13 שבועות לכל היותר (עד 14 שבועות). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 2 | פחות משנתיים, או החלטה מתועדת | פחות משנתיים של שימוש, או החלטה מתועדת של הרופא/ה להמשך. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | אין התווית נגד | סרטן שד. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 10 | צפיפות עצם בשימוש מעל שנתיים | מעל שנתיים שימוש: צפיפות עצם מתועדת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | סרטן שד |
| תלונות בפנייה או ברשומה | דימום ממושך ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 8.16 אנטגוניסטים ל-GnRH (אוריליסה, יסלטי) · GnRH antagonists (endometriosis, fibroids)

לפי הנחיה, בתנאים

גינקולוגיה · מומחה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (5) | אוריליסה 150 מ"ג · Orilissa 150 MG \| אוריליסה 200 מ"ג · Orilissa 200 MG \| יסלטי 100 מ"ג · Yselty 100 MG \| יסלטי 200 מ"ג · Yselty 200 MG \| ריאקו · Ryeqo |
| נימוק / הערה | אנטגוניסטים ל-GnRH (ריקו, אוריליסה) מוגבלים בזמן בגלל ירידה בצפיפות העצם. חידוש בתוך משך הטיפול שנקבע. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני במינון קבוע שנקבע ע"י מומחה/ית. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | הנחיה עדכנית של הגינקולוג/ית | מכתב או סיכום של הגינקולוג/ית מ-12 החודשים האחרונים, עם אותה תרופה ומינון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | בתוך משך הטיפול | משך הטיפול שקבע/ה הגינקולוג/ית לא עבר. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 10 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 8.17 בחילות בהיריון (דיקלקטין, לדוקסיה, בונג'סטה) · Doxylamine + pyridoxine (nausea of pregnancy)

הכנה לאישור רופא/ה

היריון · בחילות

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | דיקלקטין · Diclectin \| לדוקסיה טבע · Ladoxia Teva \| בונג'סטה · Bonjesta |
| נימוק / הערה | קו ראשון לבחילות והקאות בהיריון. בטוח בהיריון. סימני הקאות היריון קשות (התייבשות, ירידה במשקל) — לרופא/ה באותו יום. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | היריון מתועד | היריון ידוע ומתועד ברשומה (שבוע ההיריון). לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | ערכי מעבדה | בבדיקות האחרונות אין: -. יש ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | אין סימן לסיבה אחרת | אין חום, כאב בטן, כאב ראש חזק, צרבת חזקה, שלשול או דם בהקאה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | אין תרופות מרדימות קבועות | אין בנזודיאזפינים, אופיואידים או תרופות שינה בתרופות הקבועות. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | כמות לחודש | מרשם לחודש, לפי ההוראה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| תלונות בפנייה או ברשומה | לא שומרת נוזלים מעל 24 שעות ← לרופא/ה באותו יום; כאב בטן, חום או דם בהקאה ← דחוף |
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | הוראות לטיפול בבחילות בהיריון:<br>• לקחת לפי ההוראה: בדרך כלל 2 טבליות לפני השינה, ולפי הצורך תוספת בבוקר ובצהריים.<br>• גורם לישנוניות: לא לנהוג אם יש ישנוניות.<br>• לאכול ארוחות קטנות ותכופות ולשתות לאורך היום.<br>• אם אי אפשר לשמור נוזלים יותר מ-24 שעות, יש ירידה במשקל, שתן כהה ומעט, סחרחורת, כאב בטן, חום או דם בהקאה — לפנות לרופא באותו יום. |
| מקור | הנחיה: בחילות והקאות בהיריון (מסמך הפרויקט); עלון לרופא; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 8.18 התקן תוך-רחמי הורמונלי (מירנה, קיילינה) · Intrauterine devices (hormonal)

לפי הנחיה

בריאות האישה · התקן

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | מירנה · Mirena \| קיילינה · Kyleena |
| נימוק / הערה | התקן הורמונלי (מירנה, קיילינה) מוחדר ע"י גינקולוג/ית. מרשם לפי המלצה של גינקולוג/ית. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | המלצה של גינקולוג/ית | סיכום של גינקולוג/ית שממליץ על ההתקן (הכנסה או החלפה), מהשנה האחרונה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 3 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 8.19 פרוגסטרון נרתיקי לפוריות ולהיריון (אנדומטרין, קרינון) · Progesterone (fertility, pregnancy) לפי הנחיה

פוריות · מומחה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (4) | אנדומטרין · Endometrin | קרינון 8 % · Crinone | אוטרוגסטן · Utrogestan (שימוש נרתיקי) | פרולוטקס · Prolutex (זריקה תת-עורית) |
| נימוק / הערה | פרוגסטרון נרתיקי נקבע ע"י רופא/ת פוריות או מעקב היריון. מרשם לפי הנחיה עדכנית של הרופא/ה המטפל/ת. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | הנחיה עדכנית של הרופא/ה המטפל/ת | הנחיה של רופא/ת הפוריות או ההיריון לשלב הטיפול הנוכחי, עם מינון ומשך. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 3 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 8.20 תרופות לטיפולי פוריות (גונל-אף, מנופור, צטרוטייד, אוביטרל) · Fertility drugs (IVF) הכנה לאישור רופא/ה

פוריות · מומחה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (9) | גונאל-אף · Gonal-F | אובליפ · Ovaleap | פרגובריס · Pergoveris | פיורגון · Puregon | מנופור · Menopur | אלונבה · Elonva | צטרוטייד · Cetrotide | אורגלוטרן · Orgalutran | אוביטרל · Ovitrelle |
| נימוק / הערה | תרופות הזרקה לטיפולי פוריות, לפי פרוטוקול של יחידת הפוריות (IVF) למחזור הנוכחי. הרפואן מכין לפי הפרוטוקול, הרופא/ה מאשר/ת. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | פרוטוקול עדכני מיחידת הפוריות | מכתב או פרוטוקול מיחידת הפוריות למחזור הנוכחי, עם התרופות והמינונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | אישור מימון בתוקף | אישור לטיפולי פוריות (סל או ביטוח) בתוקף למחזור הנוכחי. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 4 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב בטן חזק, נפיחות בבטן או קוצר נשימה (גירוי יתר של השחלות) ← דחוף — יחידת הפוריות או מיון נשים |
| מקור | פער מול הרג'יסטרי, החלטה מקומית (8.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 8.21 טיבולון (ליויאל) · Tibolone

לפי הנחיה, בתנאים

טיפול הורמונלי במנופאוזה · טיבולון

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | ליויאל · Livial (לא בסל) |
| נימוק / הערה | טיבולון לתסמיני גיל המעבר: אותן בדיקות כמו בטיפול הורמונלי (ממוגרפיה, ל"ד, דימום). לא נותנים פרוגסטוגן בנוסף. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין דימום וגינלי לא סדיר | ברשומה או בפנייה אין דימום וגינלי לא סדיר (או דימום אחרי גיל המעבר). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 2 | ממוגרפיה לפי התוכנית | גיל 74-50: ממוגרפיה מ-24 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 3 | מדידת ל"ד מתועדת | מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 4 | ל"ד מתחת ל-140/90 | מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 12 | אין התווית נגד | סרטן שד או סרטן רגיש לאסטרוגן; פקקת ורידים או תסחיף ריאתי; אוטם לב או שבץ; מחלת כבד פעילה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | סרטן שד או סרטן רגיש לאסטרוגן; פקקת ורידים או תסחיף ריאתי; אוטם לב או שבץ; מחלת כבד פעילה |
| מקור | NAMS 2022; נייר העמדה הישראלי לטיפול הורמונלי במנופאוזה (Ne174) — שיוך לפי קבוצה, אושר 9.11.2026 |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

# 9. שלד, מפרקים וכאב

21 תרופות · לפי הנחיה: 4 · לפי הנחיה, בתנאים: 16 · הכנה לאישור רופא/ה: 1 · גרסה 2 · חלוקה לפי מערכות · 2.11.2026

מקורות: הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020; ACOG 2023 (סיכום AFP). שאר התחומים: החלטה מקומית; עלון לצרכן לפונקס (עודכן 12/2020). שאר התרופות: החלטה מקומית

## 9.א כללים

- חידוש רגיל: 3 חודשים
- ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה פעם בשנה
- עד 3 חידושים רצופים, ואז ביקור רופא
- אין התווית נגד ← תמיד מחדשים לפחות לחודש אחד
- חסרה מדידה, בדיקה או ביקורת שנתית: חידוש לחודש אחד + זימון למרפאה
- חריגה מספי ההחזרה: חידוש לחודש אחד + הודעה לרופא/ה
- התווית נגד או ערך חמור: לא מחדשים, הודעה לרופא/ה (הסף של כל תרופה מופיע ברשימה שלה)
- רפואן לא משנה מינון ולא מחליף תרופה. "מעקב צמוד" = תרופה עם מעקב תכוף (מעבדה, אק"ג, עיניים או צילום) — לבדוק כל ערך בקפידה
- ביספוספונט: eGFR <35 = ערך חמור; 5 שנות טיפול ← הודעה
- אופיואידים: הכנה לאישור הרופא/ה
- NSAID ממושך: כליות, אשלגן, ל"ד, דימום והגנת קיבה
- מתוטרקסט ו-DMARD: ספירת דם ותפקודי כבד לפי התרופה; חום או זיהום ← דחוף

## 9.ג בדיקות משותפות

| שלב | נושא | מה בודקים | קריטריון | אם לא מתקיים | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| לפני כל חידוש | בדיקת מעקב | לפי התרופה | שומנים: LDL; לבותירוקסין: TSH; אלופורינול/פבוקסוסטט: חומצה אורית — מ-12 החודשים האחרונים | אין ← חידוש לחודש + זימון לבדיקה | הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52; החלטה כללי-1 |
| לפני כל חידוש | ערך המעקב | לעומת הבדיקה הקודמת או היעד | LDL לא עלה ב-30% ומעלה; TSH בטווח המעבדה; חומצה אורית מתחת ל-6 | לא ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה | החלטות כללי-4-2 |
| לפני כל חידוש | רכישות | כיסוי ימים ב-6 החודשים האחרונים | 80% מהימים ומעלה | פחות ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה | כמו ביל"ד |
| לפני כל חידוש | ביקורת שנתית | ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה | ב-12 החודשים האחרונים | אין ← חידוש לחודש + זימון לביקורת | כמו ביל"ד |
| לפני כל חידוש | רצף חידושים | כמה חידושים רצופים מאז ביקור רופא | פחות מ-3 | 3 ← ביקור רופא | כמו ביל"ד |
| החזרה מיידית לרופא | פריחה | מופיע בפנייה או ברשומה (אלופורינול) | פריחה או תגובה עורית | הפסקה, דחוף | החלטה כללי-7 |

## 9.ד החלטות

| # | נושא | מה ההנחיה אומרת | ההחלטה לפרוטוקול | סוג | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| כללי-1 | בדיקות מעקב | שומנים: פרופיל 12-4 שבועות אחרי התחלה, אחר כך כל 12-6 חודשים (ההנחיה הישראלית 2020; ESC/EAS 2019). TSH בלבותירוקסין: שנתי כשמאוזן (NICE NG145). חומצה אורית בטיפול מוריד: יעד <6, בדיקה תקופתית (ACR 2020) | LDL, TSH וחומצה אורית מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש + זימון | החלטה מקומית (הצעה) | הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52; ESC/EAS 2019; NICE NG145; ACR 2020 |

| # | נושא | מה ההנחיה אומרת | ההחלטה לפרוטוקול | סוג | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| כללי-7 | אלופורינול ופבוקסוסטט | יעד חומצה אורית <6 mg/dL; התחלה במינון נמוך והתאמה לכליות; פריחה ← הפסקה מיידית (סיכון SJS/DRESS) | חומצה אורית ≥6 ← הודעה. אלופורינול: eGFR <30 ← הודעה (מינון). פריחה ← התווית נגד, דחוף | החלטה מקומית (הצעה) | ACR 2020; תווית FDA |
| כללי-12 | תרופות כרוניות נוספות (2) | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי). SSRI/SNRI: היפונתרמיה בקשישים | בזאפיברט, גבפנטין, פרגבלין, SSRI/SNRI (נתרן בגיל 65+), מעכבי ארומטאז, טמוקסיפן, רלוקסיפן, טרבינפין ואיטרקונזול (קורס): לפי הרשימה של כל תרופה | החלטה מקומית (הצעה) | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| כללי-13 | חידוש ע"י רופא/ה בלבד | רואקוטן: מרשם ע"י רופא/ת עור בלבד ותוכנית מניעת היריון (משרד הבריאות; EMA) | רואקוטן (רופא/ת עור בלבד), אנטיביוטיקה לתסמין חדש ותרופות נגד שפעת: הכלי מציג הודעה ולא רשימת בדיקות | החלטה מקומית | משרד הבריאות; EMA |
| כללי-16 | ברזל, B12, חומצה פולית | ברזל: אחרי תיקון האנמיה ממשיכים כ-3 חודשים לחידוש המאגרים, ואז ספירה תקופתית (BSG 2021). B12 בטיפול שימורי: אין בדיקת רמה שגרתית אלא בתסמינים (NICE NG239, 2024) — הרמה השנתית בפרוטוקול מחמירה | ברזל: ספירת דם ופריטין מ-6 חודשים; טיפול מעל 6 חודשים בלי התוויה ← הודעה. B12: רמה שנתית | החלטה מקומית (הצעה) | BSG 2021; NICE NG239 |
| כללי-19 | תרופות מומחה | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי). הטיפול נקבע ומנוטר ע"י המומחה | אריתרופויאטין, קושרי זרחן ואשלגן, HIV, הפטיטיס B, ציקלוספורין/טקרולימוס, אפרמילסט ואציטרטין: הודעה בלבד, חידוש ע"י רופא/ה | החלטה מקומית | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| כללי-20 | השלמות מהמאגר (2.11.2026) | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) | טרזוסין, פינסטריד, אינקליסירן, ורדנאפיל, טיפות לגלאוקומה (ביקורת עיניים שנתית; טימולול: דופק ואסתמה), NSAID ממושך (כליות, אשלגן, ל"ד, דימום, הגנת קיבה), אנטיהיסטמינים, ציננריזין, דומפרידון, מבברין, סידן, מידודרין, פנטוקסיפילין, דיפירידמול, ולציקלוביר מונע, חומצה זולדרונית | החלטה מקומית (הצעה) | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| כללי-22 | השלמות 2 מהמאגר (2.11.2026) | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) | ויטמין D, בטאהיסטין, חומצה במפדואית, אומגה 3/איקוזפנט, ציפרופיברט, וריסיגואט, ניטרוגליצרין תת-לשוני, פזולינטנט/אלינזנטנט (ALT), דואביב, אינטראזוסה, סיאנה, אורליסטט, פרוקלופריד, משלשלים, טטרציקלינים ממושכים, מניעת זיהומי שתן, משככי כאב ממושכים, ביקרבונט. עודכן ב-7.11.2026: אין עוד "רופא/ה בלבד" בקבוצה זו — ראו החלטת הסקירה | החלטה מקומית (הצעה) | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| מעקב-8 | מתוטרקסט | ספירת דם, ALT, קריאטינין ואלבומין כל 3 חודשים בטיפול יציב; מינון שבועי פעם אחת; טרימתופרים — אסור בשילוב | ספירת דם, ALT וקריאטינין מ-3 החודשים האחרונים; מינון שבועי מתועד; ללא טרימתופרים. היריון ← התווית נגד | החלטה מקומית (הצעה) | BSR 2017; MHRA |
| מעקב-12 | תרופות למעקב צמוד נוספות | DMARDs: ספירת דם, ALT וקריאטינין כל 3 חודשים בטיפול יציב (BSR 2017); שאר התרופות לפי התווית | מתימזול/PTU, לפלונומיד, אזתיופרין, סולפסלזין, מיקופנולט, מעכבי JAK, הידרוקסיאוריאה, הידרוקסיכלורוקווין, נוגדי פסיכוזה, טסטוסטרון, סטרואידים כרוניים, ניטרופורנטואין, קולכיצין, דנוסומאב, טריפרטייד: בדיקות לפי התרופה; חריגה ← חודש + הודעה; ערך חמור ← לא מחדשים | החלטה מקומית (הצעה) | BSR 2017; עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| סקירה-1 | סקירת פריטים חסומים (7.11.2026) | נושא תפעולי — הנחיות קליניות לא עוסקות בו; מבוסס על נוהל הרפואן | אף תרופה לא חסומה כברירת מחדל. 59 הפריטים שהיו "רופא/ה בלבד" נסקרו אחד-אחד: חלקם פתוחים עם רשימת בדיקות, חלקם בדגל אדום (בדיקה כפולה מול הרופא/ה). נשארים אצל הרופא/ה: רואקוטן, אנטיביוטיקה לתסמין חדש (מלבד מוקסיפן/רפאפן אחרי משטח גרון חיובי) ותרופות נגד שפעת. התראת האינטראקציות של המערכת היא שכבת ההגנה הבסיסית. | החלטה מקומית (7.11.2026) | - |

## 9.ה רשימת התרופות (לסימון)

| # | שם | גנרי | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | אלופורינול | Allopurinol | שיגדון · מעכב קסנטין אוקסידאז | לפי הנחיה | ☐ | |
| 9.2 | פבוקסוסטט | Febuxostat | שיגדון · מעכב קסנטין אוקסידאז | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 9.3 | אלנדרונט | Alendronate | אוסטאופורוזיס · ביספוספונט | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 9.4 | ריזדרונט | Risedronate | אוסטאופורוזיס · ביספוספונט | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 9.5 | רלוקסיפן | Raloxifene | אוסטאופורוזיס · SERM | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 9.6 | אופיואידים | Opioids | משככי כאב אופיואידים | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 9.7 | אפרמילסט | Apremilast | מעכב PDE4 | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 9.8 | חומצה זולדרונית (אוסטאופורוזיס) | Zoledronic acid (osteoporosis) | ביספוספונט לעירוי (פעם בשנה) | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 9.9 | פרצטמול / דיפירון (טיפול ממושך) | Paracetamol / dipyrone (chronic) | משככי כאב | לפי הנחיה | ☐ | |
| 9.10 | תרופות בונות עצם במעקב מומחה | Osteoanabolic (specialist) | אוסטאופורוזיס - מומחה | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 9.11 | זריקות סטרואידים למפרק, לרקמה או לשריר (דפו מדרול, דיפרוספן) | Corticosteroid injections | סטרואידים בהזרקה | לפי הנחיה | ☐ | |
| 9.12 | מתוטרקסט (בבליעה ובזריקה) | Methotrexate (oral) | אנטי-מטבוליט (מינון שבועי) | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |
| 9.13 | לפלונומיד | Leflunomide | DMARD | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |
| 9.14 | סולפסלזין | Sulfasalazine | DMARD / IBD | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |
| 9.15 | טופסיטיניב | Tofacitinib | מעכב JAK | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |
| 9.16 | בריסיטיניב | Baricitinib | מעכב JAK | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |
| 9.17 | אופדסיטיניב | Upadacitinib | מעכב JAK | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |
| 9.18 | הידרוקסיכלורוקווין | Hydroxychloroquine | נוגד מלריה / DMARD | לפי הנחיה ⚗ | ☐ | |
| 9.19 | קולכיצין (טיפול כרוני) | Colchicine (chronic) | נוגד דלקת | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |

| # | שם | גנרי | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.20 | דנוסומאב (אוסטאופורוזיס) | Denosumab (osteoporosis) | נוגדן RANKL (זריקה כל 6 חודשים) | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |
| 9.21 | טריפרטייד | Teriparatide | אנלוג PTH (זריקה יומית) | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |

## 9.ו פירוט מלא

### 9.1 **אלופורינול** · Allopurinol לפי הנחיה

שיגדון · מעכב קסנטין אוקסידאז

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | אלוריל · Alloril \| זילוריק · Zyloric (לאימות מול מאגר משרד הבריאות) |
| נימוק / הערה | יעד חומצה אורית; פריחה ← הפסקה ודחוף |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | חומצה אורית מתועדת | בדיקה מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | חומצה אורית ביעד | מתחת ל-6 מ"ג/ד"ל. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 6 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <30 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | אין התווית נגד | פריחה או תגובה עורית לתרופה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | חומצה אורית וקריאטינין שנתי |
| ספי החזרה לרופא/ה | eGFR <30 (לבדיקת מינון) |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | פריחה או תגובה עורית לתרופה |
| תלונות בפנייה או ברשומה | פריחה בעור ← הפסקה, דחוף; התקפי גאוט חוזרים ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 9.2 פבוקסוסטט · Febuxostat לפי הנחיה, בתנאים

שיגדון · מעכב קסנטין אוקסידאז

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | פבאוריק · Feburic |
| נימוק / הערה | רק טיפול כרוני קבוע. קו שני; אזהרה במחלת לב |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | חומצה אורית מתועדת | בדיקה מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | חומצה אורית ביעד | מתחת ל-6 מ"ג/ד"ל. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 6 | טיפול כרוני | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | אין התווית נגד | פריחה או תגובה עורית לתרופה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | חומצה אורית וקריאטינין שנתי |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | פריחה או תגובה עורית לתרופה |
| תלונות בפנייה או ברשומה | פריחה בעור ← הפסקה, דחוף; התקפי גאוט חוזרים ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 9.3 **אלנדרונט** · Alendronate לפי הנחיה, בתנאים

אוסטאופורוזיס · ביספוספונט

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (4) | פוסאלאן · Fosalan \| מקסיבון · Maxibone \| בינוסטו · Binosto \| פוסאוונס · Fosavance |
| נימוק / הערה | רק טיפול כרוני קבוע. עד 5 שנות טיפול; אחר כך החלטת רופא על הפסקה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | משך טיפול פחות מ-5 שנים | משך הטיפול בביספוספונט פחות מ-5 שנים. 5 שנים ומעלה ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה לשקול הפסקה זמנית. | |
| 2 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, סידן. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 5 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חמור: eGFR <35 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התוויית נגד |
| 6 | טיפול כרוני | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | אין התוויית נגד | סידן נמוך; מחלת ושט פעילה או קושי להישאר זקוף 30 דקות. התוויית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התוויית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | קריאטינין וסידן שנתי |
| ערך חמור | eGFR <35 |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | סידן נמוך; מחלת ושט פעילה או קושי להישאר זקוף 30 דקות |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב בבליעה או צרבת חדשה ← לרופא; כאב בירך או במפשעה ← לרופא; כאב או חשיפת עצם בלסת ← לרופא |
| מקור | ACOG 2023 (סיכום AFP) עמ' 101-102; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 9.4 ריזדרונט · Risedronate לפי הנחיה, בתנאים

אוסטאופורוזיס · ביספוספונט

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | ריבון · Ribone \| ריזדרונייט אס.קיי. · Risedronate S.K. |
| נימוק / הערה | רק טיפול כרוני קבוע. עד 5 שנות טיפול; אחר כך החלטת רופא על הפסקה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | משך טיפול פחות מ-5 שנים | משך הטיפול בביספוספונט פחות מ-5 שנים. 5 שנים ומעלה ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה לשקול הפסקה זמנית. | |
| 2 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | בדיקות שנתיות | בדיקות שנתיות בוצעו ב-12 החודשים האחרונים: קריאטינין/eGFR, סידן. חסר ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקות. | זימון |
| 5 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חמור: eGFR <35 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 6 | טיפול כרוני | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשהיא ניתנת כטיפול כרוני קבוע. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | אין התווית נגד | סידן נמוך; מחלת ושט פעילה או קושי להישאר זקוף 30 דקות. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | קריאטינין וסידן שנתי |
| ערך חמור | eGFR <35 |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | סידן נמוך; מחלת ושט פעילה או קושי להישאר זקוף 30 דקות |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב בבליעה או צרבת חדשה ← לרופא; כאב בירך או במפשעה ← לרופא; כאב או חשיפת עצם בלסת ← לרופא |
| מקור | ACOG 2023 (סיכום AFP) עמ' 101-102; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 9.5 רלוקסיפן · Raloxifene

לפי הנחיה, בתנאים

אוסטאופורוזיס · SERM

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | ראלוקסיפן טבע · Raloxifene Teva |
| נימוק / הערה | אסור באירוע תרומבואמבולי בעבר |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 5 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 6 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 7 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 8 | אין התווית נגד | פקקת ורידים או תסחיף ריאתי בעבר; שבץ או אירוע מוחי חולף בעבר. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | פקקת ורידים או תסחיף ריאתי בעבר; שבץ או אירוע מוחי חולף בעבר |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב ונפיחות ברגל ← דחוף; גלי חום ← לרופא |
| מקור | ACOG 2023 (סיכום AFP) עמ' 102; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 9.6 **אופיואידים** · Opioids הכנה לאישור רופא/ה

משככי כאב אופיואידים

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (45)** | אוקסיקונטין · OxyContin \| מ.י.ר. · M.I.R. \| מ.סי.ר · MCR \| טרמדקס · Tramadex \| טרמל · Tramal \| בוטרנס · Butrans \| סובוטקס · Subutex \| סובוקסון · Suboxone \| בובידל · Buvidal \| מתדון · Methadone \| טרגין · Targin \| פרקוסט · Percocet \| אוקסיקוד · Oxycod \| אוקסין-אבניר · Oxyn-Avenir \| פנטה · Fenta \| פנטאדול · Fentadol \| אורמורפ · Oramorph \| דרופיזול · Dropizol \| רוקסט · Rokacet \| רוקסט פלוס · Rokacet Plus \| קוד-אקמול · Cod-Acamol \| קודיקל · Codical \| רקוד · Rekod \| נורופן פלוס · Nurofen Plus \| טרמדקס או.די · Tramadex OD \| טרמדקס פלאשטב · Tramadex Flashtab \| טרמל רטרד · Tramal Retard \| טרמדול מדוכמי · Tramadol Medochemie \| הידרומורפון קלצקס · Hydromorphone Kalceks \| ברונכולט פורטה · Broncholate Forte (עם קודאין) \| קוד אקמול · Cod Acamol (עם קודאין) \| היסטפד קומפאונד לינקטוס · Histafed Compound Linctus (עם קודאין) \| פרטוסול סירופ · Pertussol Syrup (עם קודאין) \| ספסמלגין · Spasmalgin (עם קודאין) \| טוקאר סירופ · Tocare Syrup (עם קודאין) \| זאלדיאר · Zaldiar \| אבסטרל 100 מק"ג · Abstral \| פנטאמד 100מק"ג · Fentamed \| פנטורה ® 100 מק"ג · Fentora \| פקפנט 100 · Pecfent \| אקטיק 1200 מק"ג · Actiq \| סובלוקייד 100 מ"ג · Sublocade \| בופנסן דואו 2 מ"ג/0.5 מ"ג · Bupensan Duo \| בופרבניר 10 מק"ג/שעה · Buprevenir \| ניקסואיד 1.8 מ"ג · Nyxoid |
| **נימוק / הערה** | אופיואיד: הרפואן בודק אבחנת כאב, התאמה לתרופה ומרווח זמן, ומכין סיכום. האישור הסופי בידי הרופא/ה. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אבחנת כאב מתועדת | אבחנת כאב ברשימת האבחנות הקבועות או בביקור האחרון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | האבחנה מתאימה לתרופה | האבחנה מצדיקה את האופיואיד ואת המינון (למשל כאב סרטני, כאב גב כרוני). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | האבחנה מצורפת למרשם | אבחנת הכאב מצורפת למרשם עצמו. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | עברו כ-3 חודשים מהמרשם הקודם | תרופה עם פוטנציאל התמכרות: בקשה לפני שעברו כ-3 חודשים, או רכישות מעבר לכמות שנרשמה ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | ישנוניות, בלבול או נשימה איטית ← דחוף; עצירות קשה ← לרופא; בקשה מוקדמת או אובדן מרשם ← לרופא |
| **מקור** | החלטה מקומית (3.11.2026); מעקב: SPS Medicines · SPS Medicines Monitoring (NHS) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 9.7 אפרמילסט · Apremilast לפי הנחיה, בתנאים

מעכב PDE4

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | אוטזלה · Otezla \| אפרמיל · Apremil \| אפרמילסט סנדוז · Apremilast Sandoz |
| נימוק / הערה | אפרמילסט (אוטזלה) לפסוריאזיס ולדלקת מפרקים פסוריאטית, נקבע ע"י רופא/ת עור או ראומטולוג/ית. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני במינון קבוע שנקבע ע"י מומחה/ית. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | הנחיה עדכנית של רופא/ת העור או הראומטולוג/ית | מכתב או סיכום של רופא/ת העור או הראומטולוג/ית מ-12 החודשים האחרונים, עם אותה תרופה ומינון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 9.8 חומצה זולדרונית (אוסטאופורוזיס) · Zoledronic acid (osteoporosis) לפי הנחיה, בתנאים

ביספוספונט לעירוי (פעם בשנה)

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | אקלסטה · Aclasta \| חומצה זולדרונית תרו · Zoledronic Acid Taro \| חומצה זולדרונית פרזניוס · Zoledronic Acid Fresenius |
| נימוק / הערה | קריאטינין וסידן לפני כל עירוי; אחרי 3 עירויים - הערכה מחדש |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | קריאטינין וסידן מתועדים | קריאטינין/eGFR וסידן מהחודש שלפני העירוי. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <45 (לבדיקה) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <35 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <35 ← לא מחדשים | |
| 3 | סידן לא נמוך | סידן בטווח המעבדה (סידן נמוך = לא נותנים). לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 4 | פחות מ-3 עירויים | פחות מ-3 עירויים מאז ההחלטה האחרונה של הרופא/ה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ה. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | קריאטינין, סידן וויטמין D לפני כל מנה |
| ספי החזרה לרופא/ה | eGFR <45 (לבדיקה) |
| ערך חמור | eGFR <35 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב או חשיפת עצם בלסת ← לרופא; כאב בירך או במפשעה ← לרופא |
| מקור | ACOG 2023 (סיכום AFP) עמ' 101-102; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 9.9 **פרצטמול / דיפירון (טיפול ממושך)** · Paracetamol / dipyrone (chronic) לפי הנחיה

משככי כאב

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (6)** | אקמול · Acamol | אברול · Abrol | אופטלגין · Optalgin | אופטלגין טבע · Optalgin Teva | דולרגין · Dulergin | וי-דלגין · V-Dalgin |
| **נימוק / הערה** | פרצטמול: עד 3 גרם ביום (2 גרם במחלת כבד או אלכוהול). דיפירון: אגרנולוציטוזיס נדירה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין חום או כאב גרון (דיפירון) | ברשומה או בפנייה אין חום, כאב גרון או פצעים בפה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 2 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 5 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 6 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 7 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | אין מעקב מעבדה שגרתי |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | חום, כאב גרון או פצעים בפה (דיפירון) ← דחוף - ספירת דם; צהבת ← דחוף |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · FDA (DailyMed) עלון |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 9.10 תרופות בונות עצם במעקב מומחה · Osteoanabolic (specialist) לפי הנחיה, בתנאים

אוסטאופורוזיס - מומחה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | איבניטי · Evenity \| אלדינוס · Eladynos |
| נימוק / הערה | תרופות בונות עצם הן קורס מוגבל: איבניטי 12 חודשים, טריפרטייד עד שנתיים. חידוש בתוך משך הקורס. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני במינון קבוע שנקבע ע"י מומחה/ית. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | הנחיה עדכנית של המומחה/ית לאוסטאופורוזיס | מכתב או סיכום של המומחה/ית לאוסטאופורוזיס מ-12 החודשים האחרונים, עם אותה תרופה ומינון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | בתוך משך הקורס | משך הקורס שנקבע לא עבר (איבניטי 12 חודשים, טריפרטייד עד 24 חודשים). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 10 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 9.11 זריקות סטרואידים למפרק, לרקמה או לשריר (דפו מדרול, דיפרוספן) · Corticosteroid injections

לפי הנחיה

סטרואידים בהזרקה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (4) | דפו מדרול 40 מ"ג/מ"ל · Depo Medrol 40 MG/ML \| דפו מדרול עם לידוקאין · Depo Medrol + Lidocaine \| דיפרוספן להזרקה · Diprospan Injection \| סלסטון כרונודוז · Celestone Chronodose |
| נימוק / הערה | זריקת סטרואיד למפרק, לרקמה או לשריר (דפו מדרול, דיפרוספן, קנאלוג): לפי הפניה או המלצה של רופא/ה (למשל אורתופד/ית). בלי הפניה — לרופא/ה. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | הפניה או המלצה של רופא/ה | סיכום או הפניה של רופא/ה (אורתופד/ית, ראומטולוג/ית, רופא/ת משפחה) עם סוג הזריקה והמקום. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 3 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA · עלון FDA (DailyMed) · (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 9.12 מתוטרקסט (בבליעה ובזריקה) · Methotrexate (oral)

לפי הנחיה, בתנאים | מעקב צמוד

אנטי-מטבוליט (מינון שבועי)

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (4) | מתוטרקסאט אבווה · Methotrexat Ebewe | מטוטרקס · Metotrex | מטוג'קט · Metoject (זריקה תת-עורית) | מטוג'קט עט · Metoject Pen (זריקה תת-עורית) |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י ראומטולוג/ית או רופא/ת עור. מינון שבועי בלבד. התווית נגד בהיריון מטוג'קט: אותן בדיקות, זריקה תת-עורית פעם בשבוע. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | בדיקות מ-3 החודשים האחרונים | ספירת דם, ALT וקריאטינין מ-3 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה | בבדיקה האחרונה ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה. חריג: WBC מתחת ל-3,500, נויטרופילים מתחת ל-1,600, טסיות מתחת ל-140,000 או MCV מעל 105 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-100,000 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-100,000 ← לא מחדשים | |
| 3 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה מעל 30% או eGFR מתחת ל-60 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים | |
| 4 | תפקודי כבד (ALT) תקין | בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT או AST מעל 100 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← לא מחדשים | |
| 5 | ערכי מעבדה | בבדיקות האחרונות אין: אלבומין מתחת ל-30. יש ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 6 | מינון שבועי מתועד | המרשם מנוסח כמינון פעם בשבוע, ביום קבוע, עם חומצה פולית. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 7 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 8 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 9 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ה מומחה/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 10 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 11 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 12 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 13 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 14 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 15 | בדיקות בתדירות SPS | ספירה, תפקודי כבד, קריאטינין ואלבומין מ-3 החודשים האחרונים; אלבומין מתחת ל-30 ← לרופא/ה. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ספירת דם, ALT וקריאטינין כל 3 חודשים |
| ספי החזרה לרופא/ה | WBC מתחת ל-3,500, נויטרופילים מתחת ל-1,600, טסיות מתחת ל-140,000 או MCV מעל 105; ALT או AST מעל 100; קריאטינין עלה מעל 30% או eGFR מתחת ל-60; אלבומין מתחת ל-30 |
| ערך חמור | WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-100,000; ALT מעל פי 3 מהגבול העליון; eGFR <30 |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון |

| | |
|---|---|
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | פצעים בפה, חום או כאב גרון ← דחוף - ספירת דם; שיעול או קוצר נשימה חדשים ← דחוף; בחילות ממושכות ← לרופא |
| **מקור** | מעקב: SPS Medicines Monitoring · SPS Medicines Monitoring (NHS) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 9.13 לפלונומיד · Leflunomide

לפי הנחיה, בתנאים | מעקב צמוד

DMARD

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | ערבה · Arava |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י ראומטולוג/ית. התווית נגד בהיריון בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | בדיקות מ-3 החודשים האחרונים | ספירת דם, ALT ומדידת ל"ד מ-3 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה | בבדיקה האחרונה ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה. חריג: WBC מתחת ל-3,500, נויטרופילים מתחת ל-1,600, טסיות מתחת ל-140,000 או MCV מעל 105 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-100,000 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-100,000 ← לא מחדשים | |
| 3 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה מעל 30% או eGFR מתחת ל-60 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 4 | תפקודי כבד (ALT) תקין | בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT או AST מעל 100 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← לא מחדשים | |
| 5 | ערכי מעבדה | בבדיקות האחרונות אין: אלבומין מתחת ל-30. יש ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ל"ד מתחת ל-140/90 | מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | אין חום או זיהום מתועד | ברשומה או בפנייה אין חום, כאב גרון, פצעים בפה או זיהום. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 8 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 9 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 10 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ה מומחה/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 11 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 12 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 13 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 14 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 15 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 16 | בדיקות בתדירות SPS | ספירה, תפקודי כבד, קריאטינין ואלבומין מ-3 החודשים האחרונים; אלבומין מתחת ל-30 ← לרופא/ה. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ספירת דם, ALT ול"ד כל 3 חודשים |
| ספי החזרה לרופא/ה | WBC מתחת ל-3,500, נויטרופילים מתחת ל-1,600, טסיות מתחת ל-140,000 או MCV מעל 105; ALT או AST מעל 100; קריאטינין עלה מעל 30% או eGFR מתחת ל-60; אלבומין מתחת ל-30 |
| ערך חמור | WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-100,000; ALT מעל פי 3 מהגבול העליון |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון |
| תלונות בפנייה או ברשומה | חום או זיהום ← דחוף; שיעול או קוצר נשימה חדשים ← דחוף; שלשולים מתמשכים ← לרופא |

| מקור | |
|---|---|
| מעקב: SPS Medicines Monitoring · SPS Medicines Monitoring (NHS) | |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 9.14 סולפסלזין · Sulfasalazine

לפי הנחיה, בתנאים | מעקב צמוד

DMARD / IBD

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | סלאזופירין · Salazopyrin | סלאזופירין אי.אן. · Salazopyrin EN |
| נימוק / הערה | ספירת דם ו-ALT בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | בדיקות מתועדות | ספירת דם ו-ALT מ-3 החודשים האחרונים (אחרי שנת טיפול: מ-6 החודשים האחרונים). אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה | בבדיקה האחרונה ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה. חריג: WBC מתחת ל-3,500, נויטרופילים מתחת ל-1,600, טסיות מתחת ל-140,000 או MCV מעל 105 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-100,000 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-100,000 ← לא מחדשים | |
| 3 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה מעל 30% או eGFR מתחת ל-60 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 4 | תפקודי כבד (ALT) תקין | בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT או AST מעל 100 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← לא מחדשים | |
| 5 | ערכי מעבדה | בבדיקות האחרונות אין: אלבומין מתחת ל-30. יש ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 6 | אין חום או זיהום מתועד | ברשומה או בפנייה אין חום, כאב גרון, פצעים בפה או זיהום. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 7 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 8 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 9 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ה מומחה/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 10 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 11 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 12 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 13 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 14 | בדיקות בתדירות SPS | ספירה, תפקודי כבד, קריאטינין ואלבומין מ-3 החודשים האחרונים; אלבומין מתחת ל-30 ← לרופא/ה. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ספירת דם ו-ALT כל 3 חודשים בשנה הראשונה, אחר כך כל 6 חודשים |
| ספי החזרה לרופא/ה | WBC מתחת ל-3,500, נויטרופילים מתחת ל-1,600, טסיות מתחת ל-140,000 או MCV מעל 105; ALT או AST מעל 100; קריאטינין עלה מעל 30% או eGFR מתחת ל-60; אלבומין מתחת ל-30 |
| ערך חמור | WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-100,000; ALT מעל פי 3 מהגבול העליון |
| תלונות בפנייה או ברשומה | חום, כאב גרון או פריחה ← דחוף |
| מקור | מעקב: SPS Medicines Monitoring (NHS) · SPS Medicines Monitoring |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 9.15 טופסיטיניב · Tofacitinib

לפי הנחיה, בתנאים | מעקב צמוד

מעכב JAK

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (4) | קסלג'אנז · Xeljanz | קסלג'אנז XR · Xeljanz XR | טופסיניב תרו · Tofacitinib Taro | טופסיניב טבע · Tofacitinib Teva |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י ראומטולוג/ית, גסטרואנטרולוג/ית או רופא/ת עור. סיכון לזיהומים, פקקת ואירועי לב בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | בדיקות מתועדות | ספירת דם ו-ALT מ-3 החודשים האחרונים; שומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה | בבדיקה האחרונה ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה. חריג: WBC מתחת ל-3,500 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: WBC מתחת ל-2,000 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: WBC מתחת ל-2,000 ← לא מחדשים | |
| 3 | המוגלובין (Hb) תקין | בבדיקה האחרונה המוגלובין (Hb) תקין. חריג: Hb מתחת ל-9 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: Hb מתחת ל-8 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: Hb מתחת ל-8 ← לא מחדשים | |
| 4 | תפקודי כבד (ALT) תקין | בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 2 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← לא מחדשים | |
| 5 | אין חום או זיהום מתועד | ברשומה או בפנייה אין חום, כאב גרון, פצעים בפה או זיהום (כולל שלבקת חוגרת). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 6 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 8 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ה מומחה/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 9 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2QP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 10 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 11 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 12 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 13 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון; פקקת ורידים או תסחיף ריאתי בעבר. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 14 | בדיקת שחפת במהלך הטיפול | בדיקת שחפת (TB) לפי הנחיית המומחה, ואין תסמיני שחפת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ספירת דם ו-ALT כל 3 חודשים; שומנים שנתי |
| ספי החזרה לרופא/ה | WBC מתחת ל-3,500; Hb מתחת ל-9; ALT מעל פי 2 מהגבול העליון |
| ערך חמור | WBC מתחת ל-2,000; Hb מתחת ל-8; ALT מעל פי 3 מהגבול העליון |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון; פקקת ורידים או תסחיף ריאתי בעבר |
| תלונות בפנייה או ברשומה | חום או זיהום ← דחוף; כאב ונפיחות ברגל או קוצר נשימה (חשד לפקקת) ← דחוף; פריחה שלפוחיתית (שלבקת) ← לרופא |

| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |
| --- | --- |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 9.16 בריסיטיניב · Baricitinib

מעקב צמוד | לפי הנחיה, בתנאים

מעכב JAK

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | אולומיאנט · Olumiant |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י ראומטולוג/ית, גסטרואנטרולוג/ית או רופא/ת עור. סיכון לזיהומים, פקקת ואירועי לב בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | בדיקות מתועדות | ספירת דם ו-ALT מ-3 החודשים האחרונים; שומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה | בבדיקה האחרונה ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה. חריג: WBC מתחת ל-3,500 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: WBC מתחת ל-2,000 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: WBC מתחת ל-2,000 ← לא מחדשים | |
| 3 | המוגלובין (Hb) תקין | בבדיקה האחרונה המוגלובין (Hb) תקין. חריג: Hb מתחת ל-9 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: Hb מתחת ל-8 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: Hb מתחת ל-8 ← לא מחדשים | |
| 4 | תפקודי כבד (ALT) תקין | בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 2 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← לא מחדשים | |
| 5 | אין חום או זיהום מתועד | ברשומה או בפנייה אין חום, כאב גרון, פצעים בפה או זיהום (כולל שלבקת חוגרת). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 6 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 8 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ה מומחה/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 9 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 10 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 11 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 12 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 13 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון; פקקת ורידים או תסחיף ריאתי בעבר. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 14 | בדיקת שחפת במהלך הטיפול | בדיקת שחפת (TB) לפי הנחיית המומחה, ואין תסמיני שחפת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ספירת דם ו-ALT כל 3 חודשים; שומנים שנתי |
| ספי החזרה לרופא/ה | WBC מתחת ל-3,500; Hb מתחת ל-9; ALT מעל פי 2 מהגבול העליון |
| ערך חמור | WBC מתחת ל-2,000; Hb מתחת ל-8; ALT מעל פי 3 מהגבול העליון |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון; פקקת ורידים או תסחיף ריאתי בעבר |
| תלונות בפנייה או ברשומה | חום או זיהום ← דחוף; כאב ונפיחות ברגל או קוצר נשימה (חשד לפקקת) ← דחוף; פריחה שלפוחיתית (שלבקת) ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 9.17 **אופדסיטיניב** · Upadacitinib

לפי הנחיה, בתנאים | מעקב צמוד

מעכב JAK

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | רינבוק · Rinvoq |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י ראומטולוג/ית, גסטרואנטרולוג/ית או רופא/ת עור. סיכון לזיהומים, פקקת ואירועי לב בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | בדיקות מתועדות | ספירת דם ו-ALT מ-3 החודשים האחרונים; שומנים מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה | בבדיקה האחרונה ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה. חריג: WBC מתחת ל-3,500 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: WBC מתחת ל-2,000 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: WBC מתחת ל-2,000 ← לא מחדשים | |
| 3 | המוגלובין (Hb) תקין | בבדיקה האחרונה המוגלובין (Hb) תקין. חריג: Hb מתחת ל-9 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: Hb מתחת ל-8 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: Hb מתחת ל-8 ← לא מחדשים | |
| 4 | תפקודי כבד (ALT) תקין | בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 2 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← לא מחדשים | |
| 5 | אין חום או זיהום מתועד | ברשומה או בפנייה אין חום, כאב גרון, פצעים בפה או זיהום (כולל שלבקת חוגרת). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 6 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 8 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ה מומחה/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 9 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2OP = 2 אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 10 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 11 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 12 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 13 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון; פקקת ורידים או תסחיף ריאתי בעבר. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 14 | בדיקת שחפת במהלך הטיפול | בדיקת שחפת (TB) לפי הנחיית המומחה, ואין תסמיני שחפת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ספירת דם ו-ALT כל 3 חודשים; שומנים שנתי |
| ספי החזרה לרופא/ה | WBC מתחת ל-3,500; Hb מתחת ל-9; ALT מעל פי 2 מהגבול העליון |
| ערך חמור | WBC מתחת ל-2,000; Hb מתחת ל-8; ALT מעל פי 3 מהגבול העליון |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון; פקקת ורידים או תסחיף ריאתי בעבר |
| תלונות בפנייה או ברשומה | חום או זיהום ← דחוף; כאב ונפיחות ברגל או קוצר נשימה (חשד לפקקת) ← דחוף; פריחה שלפוחיתית (שלבקת) ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 9.18 הידרוקסיכלורוקווין · Hydroxychloroquine

לפי הנחיה | מעקב צמוד

נוגד מלריה / DMARD

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | פלקווניל · Plaquenil |
| נימוק / הערה | בדיקת עיניים שנתית אחרי 5 שנות טיפול (או מההתחלה בסיכון גבוה) |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | בדיקת עיניים מ-12 החודשים האחרונים<br>שאלה: הטיפול נמשך 5 שנים ומעלה, או שיש eGFR <60 או טמוקסיפן? | בדיקת עיניים (OCT ושדה ראייה) מ-12 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 2 | קריאטינין מתועד | קריאטינין/eGFR מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 3 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <60 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 4 | אין שינוי בראייה מתועד | ברשומה או בפנייה אין ירידה או שינוי בראייה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | בדיקת עיניים (OCT ושדה ראייה) שנתית; קריאטינין שנתי |
| ספי החזרה לרופא/ה | eGFR <60 (לבדיקת מינון) |
| תלונות בפנייה או ברשומה | ירידה או שינוי בראייה ← דחוף - רופא/ת עיניים; פריחה ← לרופא |
| מקור | מעקב: SPS Medicines Monitoring · SPS Medicines Monitoring (NHS) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 9.19 קולכיצין (טיפול כרוני) · Colchicine (chronic) לפי הנחיה, בתנאים מעקב צמוד

נוגד דלקת

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | קולכיצין · Colchicine |
| נימוק / הערה | מינון לפי כליות; אינטראקציות מסוכנות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | קריאטינין מתועד | קריאטינין/eGFR מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <60 (לבדיקת מינון) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: eGFR <30 ← לא מחדשים | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 OP = 2 אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | קריאטינין שנתי |
| ספי החזרה לרופא/ה | eGFR <60 (לבדיקת מינון) |
| ערך חמור | eGFR <30 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | שלשולים או הקאות ← לרופא; כאבי שרירים או חולשה ← דחוף |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 9.20 דנוסומאב (אוסטאופורוזיס) · Denosumab (osteoporosis) לפי הנחיה, בתנאים מעקב צמוד

נוגדן RANKL (זריקה כל 6 חודשים)

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (6) | פרוליה · Prolia | ג'ובונטי · Jubbonti | דנומקס · Denomax (ביוסימילר של פרוליה) | דנוסומב טבע · Denosumab Teva (ביוסימילר של פרוליה) | אוופרקסי · Evfraxy (ביוסימילר של פרוליה) | רסיניב · Resyniv (ביוסימילר של פרוליה) |
| נימוק / הערה | אסור לדחות מנה או להפסיק ללא ביספוספונט (עלייה חדה בשברים). סידן לפני כל מנה בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | סידן וקריאטינין מתועדים | מהחודש שלפני המנה. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | סידן בטווח | סידן בטווח המעבדה (סידן נמוך = התווית נגד). לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 3 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: eGFR <30 (סיכון לסידן נמוך) ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 4 | המנה בזמן | המנה הקודמת ניתנה לפני כ-6 חודשים, לא באיחור של יותר מחודש. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני שנקבע ע"י רופא/ה. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 12 | סידן בפגיעה כלייתית קשה | ב-eGFR מתחת ל-30: סידן שבועי בחודש הראשון אחרי הזריקה, ואז חודשי. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | סידן וקריאטינין לפני כל מנה |
| ספי החזרה לרופא/ה | eGFR <30 (סיכון לסידן נמוך) |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב או חשיפת עצם בלסת ← לרופא; כאב בירך או במפשעה ← לרופא; עוויתות או נימול (סידן נמוך) ← דחוף |
| מקור | ACOG 2023 (סיכום AFP) עמ' 101; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 9.21 **טריפרטייד** · Teriparatide לפי הנחיה, בתנאים מעקב צמוד

אנלוג PTH (זריקה יומית)

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (4)** | פורטאו · Forteo \| טרוזה · Terrosa \| טריפראטייד טבע · Teriparatide Teva \| טריפראטייד קמהדע · Teriparatide Kamada |
| **נימוק / הערה** | נקבע ע"י רופא/ה מומחה/ית. עד 24 חודשים בחיים, ואחר כך תרופה אנטי-רזורבטיבית |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **פחות מ-24 חודשי טיפול** | משך הטיפול הכולל בחיים פחות מ-24 חודשים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 2 | **סידן מתועד** | סידן מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 3 | **סידן בטווח** | סידן בטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | **רכישות** | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | **טיפול כרוני במינון קבוע** | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ה מומחה/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 OP = 2 אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | **אין התווית נגד** | סרטן עצם או גרורות בעצם; הקרנות לשלד; מחלת פאג'ט. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | סידן שנתי |
| **מצבים שמוציאים מהפרוטוקול** | סרטן עצם או גרורות בעצם; הקרנות לשלד; מחלת פאג'ט |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | סחרחורת אחרי הזריקה ← לרופא; עוויתות שרירים ← לרופא |
| **מקור** | ACOG 2023 (סיכום AFP) עמ' 102; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

# 10. דם וויטמינים

8 תרופות · לפי הנחיה: 5 · הכנה לאישור רופא/ה: 2 · לפי הנחיה, בתנאים: 1 · גרסה 2 · חלוקה לפי מערכות · 2.11.2026

מקורות: הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020; ACOG 2023 (סיכום AFP). שאר התחומים: החלטה מקומית; עלון לצרכן לפונקס (עודכן 12/2020). שאר התרופות: החלטה מקומית

## 10.א כללים

- חידוש רגיל: 3 חודשים
- ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה פעם בשנה
- עד 3 חידושים רצופים, ואז ביקור רופא
- אין התווית נגד ← תמיד מחדשים לפחות לחודש אחד
- חסרה מדידה, בדיקה או ביקורת שנתית: חידוש לחודש אחד + זימון למרפאה
- חריגה מספי ההחזרה: חידוש לחודש אחד + הודעה לרופא/ה
- התווית נגד או ערך חמור: לא מחדשים, הודעה לרופא/ה (הסף של כל תרופה מופיע ברשימה שלה)
- רפואן לא משנה מינון ולא מחליף תרופה. "מעקב צמוד" = תרופה עם מעקב תכוף (מעבדה, אק"ג, עיניים או צילום) — לבדוק כל ערך בקפידה
- ברזל מעל 6 חודשים בלי התוויה מתועדת ← הודעה
- דגל אדום: הרפואן מכין לפי רשימת הבדיקות, והרופא/ה בודק/ת שוב לפני האישור — גם כשהכול תקין

## 10.ג בדיקות משותפות

| שלב | נושא | מה בודקים | קריטריון | אם לא מתקיים | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| לפני כל חידוש | בדיקת מעקב | לפי התרופה | שומנים: LDL; לבותירוקסין: TSH; אלופורינול/פבוקסוסטט: חומצה אורית — מ-12 החודשים האחרונים | אין ← חידוש לחודש + זימון לבדיקה | הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52; החלטה כללי-1 |
| לפני כל חידוש | ערך המעקב | לעומת הבדיקה הקודמת או היעד | LDL לא עלה ב-30% ומעלה; TSH בטווח המעבדה; חומצה אורית מתחת ל-6 | לא ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה | החלטות כללי-2–4 |
| לפני כל חידוש | רכישות | כיסוי ימים ב-6 החודשים האחרונים | 80% מהימים ומעלה | פחות ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה | כמו בי"ל |
| לפני כל חידוש | ביקורת שנתית | ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה | ב-12 החודשים האחרונים | אין ← חידוש לחודש + זימון לביקורת | כמו בי"ל |
| לפני כל חידוש | רצף חידושים | כמה חידושים רצופים מאז ביקור רופא | פחות מ-3 | 3 ← ביקור רופא | כמו בי"ל |

## 10.ד החלטות

| # | נושא | מה ההנחיה אומרת | ההחלטה לפרוטוקול | סוג | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| כללי-1 | בדיקות מעקב | שומנים: פרופיל 12-4 שבועות אחרי התחלה, אחר כך כל 12-6 חודשים (ההנחיה הישראלית 2020; ESC/EAS 2019). TSH בלבותירוקסין: שנתי כשמאוזן (NICE NG145). חומצה אורית בטיפול מוריד: יעד <6, בדיקה תקופתית (ACR 2020) | LDL, TSH וחומצה אורית מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש + זימון | החלטה מקומית (הצעה) | הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52; ESC/EAS 2019; NICE NG145; ACR 2020 |
| כללי-7 | אלופורינול ופבוקסוסטט | יעד חומצה אורית <6 mg/dL; התחלה במינון נמוך והתאמה לכליות; פריחה ← הפסקה מיידית (סיכון SJS/DRESS) | חומצה אורית ≥6 ← הודעה. אלופורינול: eGFR <30 ← הודעה (מינון). פריחה ← התווית נגד, דחוף | החלטה מקומית (הצעה) | ACR 2020; תווית FDA |

| # | נושא | מה ההנחיה אומרת | ההחלטה לפרוטוקול | סוג | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| כללי-16 | ברזל, B12, חומצה פולית | ברזל: אחרי תיקון האנמיה ממשיכים כ-3 חודשים לחידוש המאגרים, ואז ספירה תקופתית (BSG 2021). B12 בטיפול שימורי: אין בדיקת רמה שגרתית אלא בתסמינים (NICE NG239, 2024) — הרמה השנתית בפרוטוקול מחמירה | ברזל: ספירת דם ופריטין מ-6 חודשים; טיפול מעל 6 חודשים בלי התוויה ← הודעה. B12: רמה שנתית | החלטה מקומית (הצעה) | BSG 2021; NICE NG239 |
| כללי-18 | גסטרו ואנדוקרינולוגיה | מסאלזין: תפקוד כליות לפני, אחרי 3 חודשים ואז שנתי (BSG 2019). הידרוקורטיזון: הנחיות יום מחלה (Endocrine Society 2016). דסמופרסין: נתרן (תווית). סינקלצט/אלפקלצידול: סידן (תווית) | מסאלזין: קריאטינין שנתי. הידרוקורטיזון: לא נעצר, הנחיות מחלה. אלפקלצידול וסינקלצט: סידן. דסמופרסין: נתרן | החלטה מקומית (הצעה) | BSG 2019; Endocrine Society 2016; תווית |
| כללי-20 | השלמות מהמאגר (2.11.2026) | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) | טרזוסין, פינסטריד, אינקליסירן, ורדנאפיל, טיפות לגלאוקומה (ביקורת עיניים שנתית; טימולול: דופק ואסתמה), NSAID ממושך (כליות, אשלגן, ל"ד, דימום, הגנת קיבה), אנטיהיסטמינים, ציננריזין, דומפרידון, מבברין, סידן, מידודרין, פנטוקסיפילין, דיפירידמול, ולציקלוביר מונע, חומצה זולדרונית | החלטה מקומית (הצעה) | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| כללי-22 | השלמות 2 מהמאגר (2.11.2026) | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) | ויטמין D, בטאהיסטין, חומצה במפדואית, אומגה 3/איקוזפנט, ציפרופיברט, וריסיגואט, ניטרוגליצרין תת-לשוני, פזולינטנט/אלינזנטנט (ALT), דואביב, אינטראروסה, סיאנה, אורליסטט, פרוקלופריד, משלשלים, טטרציקלינים ממושכים, מניעת זיהומי שתן, משככי כאב ממושכים, ביקרבונט. עודכן ב-7.11.2026: אין עוד "רופא/ה בלבד" בקבוצה זו — ראו החלטת הסקירה | החלטה מקומית (הצעה) | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| מעקב-1 | ליתיום: תדירות | רמה כל 3 חודשים בשנה הראשונה ואז כל 6 חודשים; eGFR, TSH וסידן כל 6 חודשים | רמה, קריאטינין/eGFR, נתרן, TSH וסידן מ-6 החודשים האחרונים | החלטה מקומית (הצעה) | NICE CG185 |
| מעקב-12 | תרופות למעקב צמוד נוספות | DMARDs: ספירת דם, ALT וקריאטינין כל 3 חודשים בטיפול יציב (BSR 2017); שאר התרופות לפי התווית | מתימזול/PTU, לפלונומיד, אזתיופרין, סולפסלזין, מיקופנולט, מעכבי JAK, הידרוקסיאוריאה, הידרוקסיכלורוקווין, נוגדי פסיכוזה, טסטוסטרון, סטרואידים כרוניים, ניטרופורנטואין, קולכיצין, דנוסומאב, טריפרטייד: בדיקות לפי התרופה; חריגה ← חודש + הודעה; ערך חמור ← לא מחדשים | החלטה מקומית (הצעה) | BSR 2017; עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| סקירה-1 | סקירת פריטים חסומים (7.11.2026) | נושא תפעולי — הנחיות קליניות לא עוסקות בו; מבוסס על נוהל הרפואן | אף תרופה לא חסומה כברירת מחדל. 59 הפריטים שהיו "רופא/ה בלבד" נסקרו אחד-אחד: חלקם פתוחים עם רשימת בדיקות, חלקם בדגל אדום (בדיקה כפולה מול הרופא/ה). נשארים אצל הרופא/ה: רואקוטן, אנטיביוטיקה לתסמין חדש (מלבד מוקסיפן/רפאפן אחרי משטח גרון חיובי) ותרופות נגד שפעת. התראת האינטראקציות של המערכת היא שכבת ההגנה הבסיסית. | החלטה מקומית (7.11.2026) | - |

## 10.ה רשימת התרופות (לסימון)

| # | שם | גנרי | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | ברזל (בבליעה) | Iron (oral) | תוסף ברזל | לפי הנחיה | ☐ | |
| 10.2 | ויטמין B12 | Vitamin B12 | ויטמין | לפי הנחיה | ☐ | |

| # | שם | גנרי | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.3 | חומצה פולית | Folic acid | ויטמין | לפי הנחיה | ☐ | |
| 10.4 | סידן (בבליעה) | Calcium (oral) | תוסף סידן | לפי הנחיה | ☐ | |
| 10.5 | תרופות המטולוגיות במעקב מומחה | Haematology specialist drugs | המטולוגיה | דגל אדום | ☐ | |
| 10.6 | ויטמין D | Vitamin D | ויטמין | לפי הנחיה | ☐ | |
| 10.7 | ברזל בעירוי לווריד (פרינג'קט, מונופר, ונופר) | Intravenous iron | ברזל · עירוי במרפאה | דגל אדום | ☐ | |
| 10.8 | הידרוקסיאוריאה | Hydroxyurea | מעכב מח עצם | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |

## 10.ו פירוט מלא

### 10.1 **ברזל (בבליעה)** · Iron (oral) לפי הנחיה

תוסף ברזל

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (9) | תרדיפרון · Tardyferon | פרו 15 סירופ · Ferro 15 Syrup | פרוקל · Ferrocal | פריפול · Ferrifol (עם חומצה פולית) | פולקס · Folex (עם חומצה פולית) | פוליRון · Foliron (עם חומצה פולית) | איירון קאר · Iron Care | המפר · Hemafer | פריפל - 3 סירופ · Ferripel-3 Syrup |
| נימוק / הערה | חוסר ברזל: טיפול עד 3 חודשים אחרי תיקון ההמוגלובין. טיפול ממושך ← לברר את הסיבה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | ספירת דם ופריטין מתועדים | ספירת דם ופריטין מ-6 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | Hb לא ירד | המוגלובין לא ירד לעומת הבדיקה הקודמת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | משך מתאים | פחות מ-6 חודשי טיפול, או התוויה כרונית מתועדת (למשל דימום וסתי, ניתוח בריאטרי). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ספירת דם ופריטין כל 3-6 חודשים |
| תלונות בפנייה או ברשומה | צואה שחורה או דם בצואה ← דחוף; כאבי בטן או עצירות ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 10.2 ויטמין B12 · Vitamin B12 לפי הנחיה

ויטמין

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (4) | ויטמין בי 12 סטרופ · Vitamine B12 Sterop (זריקה) \| טריבמין · Tribemin (B1+B6+B12) \| טריו בי · Trio B \| שלוש בי · Shalosh B |
| נימוק / הערה | תוספים בבליעה רבים אינם תרופות רשומות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רמת B12 מתועדת | רמת B12 מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | רמה בטווח | רמת B12 בטווח המעבדה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | רמת B12 שנתית |
| תלונות בפנייה או ברשומה | נימול בידיים או ברגליים ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 10.3 **חומצה פולית** · Folic acid לפי הנחיה

ויטמין

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (5)** | חומצה פולית · Folic Acid \| פולי · Foli \| פולקס · Folex (עם ברזל - ראו ברזל) \| פורול טבליות · Forol \| פוריק הריון · Foric Pregnancy |
| **נימוק / הערה** | היריון או תכנון היריון, מתוטרקסט, אנמיה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **התוויה מתועדת** | היריון או תכנון היריון, טיפול במתוטרקסט, או אנמיה מתועדת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | **רכישות** | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 5 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 6 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 7 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | אין מעקב מעבדה |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 10.4 **סידן (בבליעה)** · Calcium (oral) לפי הנחיה

תוסף סידן

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (3)** | קלצימור · Calcimore · קלציום-D-סורס · Calcium-D-Source (עם ויטמין D) · קלציום סורס 500 מ"ג · Calcium Source 500 MG |
| **נימוק / הערה** | לרוב עם טיפול לאוסטאופורוזיס |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 4 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 5 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 6 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 7 | סידן לא גבוה | אם נבדק: סידן לא מעל טווח המעבדה. לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | סידן לפי הצורך |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | עצירות ← לרופא; כאב גב חד או דם בשתן (אבנים) ← לרופא |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 10.5 תרופות המטולוגיות במעקב מומחה · Haematology specialist drugs דגל אדום

המטולוגיה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (19) | דפרסירוקס תרו · Deferasirox Taro | דפראסירוקס טבע · Deferasirox Teva | דפירוקס · Defirox | אקסג'ייד · Exjade | דפריפרון תרו · Deferiprone Taro | פריפרוקס תמיסה · Ferriprox Oral Solution | פריפרוקס טבליות · Ferriprox | אלטופ · Eltop | אלטרובניר · Eltrovenir | רבולייד · Revolade | אופזורו · Optzuro | אנגריד · Anagrid | ג'קאבי · Jakavi | רוקסובניר · Ruxovenir | רוקסול · Ruxxol | טבליס · Tavalisse | אנפלייט · Nplate | בסרמי · Besremi | רבלוזיל · Reblozyl |
| נימוק / הערה | תרופות המטולוגיות של מומחה (דפרסירוקס, אלטרומבופג, אנגרליד, רוקסוליטיניב ועוד). חלקן מחייבות ספירת דם. הרפואן מכין, והרופא/ה מאשר/ת. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני במינון קבוע שנקבע ע"י מומחה/ית. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | הנחיה עדכנית של ההמטולוג/ית | מכתב או סיכום של ההמטולוג/ית מ-12 החודשים האחרונים, עם אותה תרופה ומינון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ספירת דם עדכנית | ספירת דם מלאה מ-3 החודשים האחרונים (או לפי ההנחיה). אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 10 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ספירת דם מ-3 החודשים האחרונים |
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 10.6 ויטמין D · Vitamin D לפי הנחיה

ויטמין

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | ויטה די · Vita D | ריאלדי · Rayaldee (קלציידיול) |
| נימוק / הערה | בטוח במינון רגיל; מינון גבוה ← סידן |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 4 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 5 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 6 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 7 | סידן לא גבוה | אם נבדק: סידן לא מעל טווח המעבדה. לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | רמת ויטמין D לפי הצורך |
| תלונות בפנייה או ברשומה | צמא, בחילות או בלבול ← לרופא - סידן |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 10.7 ברזל בעירוי לווריד (פרינג'קט, מונופר, ונופר) · Intravenous iron · דגל אדום

ברזל · עירוי במרפאה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (4) | פרינג'קט · Ferinject \| מונופר · Monofer \| ונופר · Venofer \| פרובין · Ferrovin |
| נימוק / הערה | ברזל בעירוי: הרפואן מכין את ההפניה, והרופא/ה מאשר/ת לפני השליחה (דגל אדום). לחסר ברזל שלא הגיב לברזל בבליעה או כשאי אפשר לתת אותו. ההחלטה, המינון ומספר המנות — של הרופא/ה. הרפואן מכין: בדיקות, אישור ותור. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | ערכי מעבדה | בבדיקות האחרונות אין: -. יש ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 2 | חסר ברזל מתועד | המוגלובין או פריטין נמוכים, ואבחנה של חסר ברזל ברשומה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | כישלון או אי-סבילות לברזל בבליעה, או החלטה מתועדת | ברשומה: ברזל בבליעה לא עזר או לא נסבל, או החלטה מתועדת של הרופא/ה או המומחה/ית. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | אין תגובה בעבר לברזל בעירוי | ברשומה אין תגובה אלרגית לעירוי ברזל. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | לא בשליש הראשון להיריון | אין היריון בשליש הראשון. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | אישור מימון ותור | אישור תרופה (אם נדרש) בתוקף, ותור במרפאה או ביחידה שנותנת עירויים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| תלונות בפנייה או ברשומה | פריחה, קוצר נשימה או נפיחות בזמן העירוי ← דחוף — לצוות או למוקד |
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | הוראות לפני עירוי ברזל:<br>• להגיע לתור במרפאה או ביחידת האשפוז היום. אפשר לאכול ולשתות כרגיל.<br>• לקחת את התרופות הקבועות כרגיל. כדורי ברזל — להפסיק ביום העירוי ולשבוע אחריו, אלא אם הרופא הנחה אחרת.<br>• אחרי העירוי נשארים להשגחה כחצי שעה.<br>• אם מופיעים בזמן העירוי או אחריו פריחה, קוצר נשימה, נפיחות בפנים או סחרחורת חזקה — להודיע מיד לצוות או לפנות למוקד. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לרופא של התכשירים; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 10.8 הידרוקסיאוריאה · Hydroxyurea

לפי הנחיה, בתנאים | מעקב צמוד

מעכב מח עצם

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | הידרוקסיאוריאה מדאק · Hydroxyurea Medac |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י המטולוג/ית. התווית נגד בהיריון |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | ספירת דם מ-3 החודשים האחרונים | ספירת דם מ-3 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה | בבדיקה האחרונה ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה. חריג: WBC מתחת ל-3,500 או טסיות מתחת ל-150,000 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-100,000 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-100,000 ← לא מחדשים | |
| 3 | המוגלובין (Hb) תקין | בבדיקה האחרונה המוגלובין (Hb) תקין. חריג: Hb מתחת ל-9 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: Hb מתחת ל-8 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: Hb מתחת ל-8 ← לא מחדשים | |
| 4 | אין חום או זיהום מתועד | ברשומה או בפנייה אין חום, כאב גרון, פצעים בפה או זיהום. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 5 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 7 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י המטולוג/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2QP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 12 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ספירת דם כל 1-3 חודשים (לפי ההמטולוג/ית) |
| ספי החזרה לרופא/ה | WBC מתחת ל-3,500 או טסיות מתחת ל-150,000; Hb מתחת ל-9 |
| ערך חמור | WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-100,000; Hb מתחת ל-8 |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון |
| תלונות בפנייה או ברשומה | חום או זיהום ← דחוף; פצעים ברגליים ← לרופא |
| מקור | מעקב: SPS Medicines Monitoring · SPS Medicines Monitoring (NHS) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

# 11. עיניים ועור

16 תרופות · לפי הנחיה: 3 · רופא/ה בלבד: 1 · הכנה לאישור רופא/ה: 1 · לפי הנחיה, בתנאים: 11 · גרסה 2 · חלוקה לפי מערכות · 2.11.2026

מקורות: הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020; ACOG 2023 (סיכום AFP). שאר התחומים: החלטה מקומית

## 11.א כללים

- חידוש רגיל: 3 חודשים
- ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה פעם בשנה
- עד 3 חידושים רצופים, ואז ביקור רופא
- אין התווית נגד ← תמיד מחדשים לפחות לחודש אחד
- חסרה מדידה, בדיקה או ביקורת שנתית: חידוש לחודש אחד + זימון למרפאה
- חריגה מספי ההחזרה: חידוש לחודש אחד + הודעה לרופא/ה
- התווית נגד או ערך חמור: לא מחדשים, הודעה לרופא/ה (הסף של כל תרופה מופיע ברשימה שלה)
- רפואן לא משנה מינון ולא מחליף תרופה. "מעקב צמוד" = תרופה עם מעקב תכוף (מעבדה, אק"ג, עיניים או צילום) — לבדוק כל ערך בקפידה
- טיפות לגלאוקומה: ביקורת שנתית אצל רופא/ת עיניים; טימולול: דופק ואסתמה
- רואקוטן: הרפואן לא מפיק מרשם — רק רופא/ת עור; מפנים לרופא/ת העור המטפל/ת. אציטרטין: דגל אדום (היריון, כבד, שומנים)
- נוגדי פטרת וטטרציקלינים: רק בתוך משך הקורס
- דגל אדום: הרפואן מכין לפי רשימת הבדיקות, והרופא/ה בודק/ת שוב לפני האישור — גם כשהכול תקין

## 11.ג בדיקות משותפות

| שלב | נושא | מה בודקים | קריטריון | אם לא מתקיים | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| לפני כל חידוש | ערך המעקב | לעומת הבדיקה הקודמת או היעד | LDL לא עלה ב-30% ומעלה; TSH בטווח המעבדה; חומצה אורית מתחת ל-6 | לא ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה | החלטות כללי-2-4 |
| לפני כל חידוש | רכישות | כיסוי ימים ב-6 החודשים האחרונים | 80% מהימים ומעלה | פחות ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה | כמו ביל"ד |
| לפני כל חידוש | ביקורת שנתית | ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה | ב-12 החודשים האחרונים | אין ← חידוש לחודש + זימון לביקורת | כמו ביל"ד |
| לפני כל חידוש | רצף חידושים | כמה חידושים רצופים מאז ביקור רופא | פחות מ-3 | 3 ← ביקור רופא | כמו ביל"ד |
| החזרה מיידית לרופא | דימום | מופיע בפנייה או ברשומה (נוגדי טסיות) | צואה שחורה, דם בצואה, דימום משמעותי | דחוף - לרופא עכשיו | החלטה כללי-5 |
| החזרה מיידית לרופא | חולשת שרירים | מופיע בפנייה או ברשומה (סטטין) | חולשה או כאבי שרירים עם שתן כהה | דחוף - לרופא עכשיו | הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 51 |

## 11.ד החלטות

| # | נושא | מה ההנחיה אומרת | ההחלטה לפרוטוקול | סוג | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| כללי-2 | LDL לעומת הבדיקה הקודמת | עלייה לא מוסברת ← לברר היענות וסיבות שניוניות; היעד לפי דרגת הסיכון | עלייה של 30% ומעלה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. היעד האישי בידי הרופא/ה | החלטה מקומית (הצעה) | הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52 |
| כללי-6 | מעכבי משאבת פרוטונים | טיפול ממושך דורש התוויה מתועדת; בלי התוויה — לנסות הפחתה או הפסקה | נדרשת התוויה מתועדת לטיפול ממושך. אין ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה לשקול הפחתה | החלטה מקומית (הצעה) | AGA 2022 |
| כללי-9 | ביספוספונטים | להפסיק אחרי 5 שנים טיפול פומי בסיכון שאינו גבוה; עד 10 שנים בסיכון גבוה. אסור ב-eGFR ≤35 | 5 שנות טיפול ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. eGFR <35 ← ערך חמור | הנחיה | ACOG 2023 (סיכום AFP) עמ' 101-102 |

| # | נושא | מה ההנחיה אומרת | ההחלטה לפרוטוקול | סוג | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| כללי-11 | מעכבי PCSK9 (רפאטה, פראלואנט) | בסל באינדיקציות מצומצמות; רוב המטופלים דרך שב"ן או ביטוח. סבילות טובה, תגובה מקומית | בתנאים: אישור מימון בתוקף וטיפול כרוני; מעקב LDL כמו בסטטין. אין אישור ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה | החלטה מקומית (הצעה) | הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 (פרק מעכבי PCSK9) |
| כללי-12 | תרופות כרוניות נוספות (2) | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי). SSRI/SNRI: היפונתרמיה בקשישים | בזאפיברט, גבפנטין, פרגבלין, SSRI/SNRI (נתרן בגיל 65+), מעכבי ארומטאז, טמוקסיפן, רלוקסיפן, טרבינפין ואיטרקונזול (קורס): לפי הרשימה של כל תרופה | החלטה מקומית (הצעה) | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| כללי-13 | חידוש ע"י רופא/ה בלבד | רואקוטן: מרשם ע"י רופא/ת עור בלבד ותוכנית מניעת היריון (משרד הבריאות; EMA) | רואקוטן (רופא/ת עור בלבד), אנטיביוטיקה לתסמין חדש ותרופות נגד שפעת: הכלי מציג הודעה ולא רשימת בדיקות | החלטה מקומית | משרד הבריאות; EMA |
| כללי-15 | שלפוחית רגיזה ו-PDE5 | אנטי-כולינרגיים חזקים — להימנע בקשישים (Beers 2023). מירבגרון: אסור ב-ל"ד ≥180/110, זהירות מעל 160/100 (עלון). PDE5 + ניטרטים — התווית נגד (תווית) | אנטי-כולינרגיים: גיל 75+ ← אישור רופא/ה; אצירת שתן ← דחוף. מירבגרון: ל"ד מתחת ל-160/100. PDE5: ניטרטים = התווית נגד | החלטה מקומית (הצעה) | Beers 2023; עלונים |
| כללי-19 | תרופות מומחה | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי). הטיפול נקבע ומנוטר ע"י המומחה | אריתרופויאטין, קושרי זרחן ואשלגן, HIV, הפטיטיס B, ציקלוספורין/טקרולימוס, אפרמילסט ואציטרטין: הודעה בלבד, חידוש ע"י רופא/ה | החלטה מקומית | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| כללי-20 | השלמות מהמאגר (2.11.2026) | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) | טרזוסין, פינסטריד, אינקליסירן, ורדנאפיל, טיפות לגלאוקומה (ביקורת עיניים שנתית; טימולול: דופק ואסתמה), NSAID ממושך (כליות, אשלגן, ל"ד, דימום, הגנת קיבה), אנטיהיסטמינים, ציננריזין, דומפרידון, מברין, סידן, מידודרין, פנטוקסיפילין, דיפירידמול, ולציקלוביר מונע, חומצה זולדרונית | החלטה מקומית (הצעה) | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| כללי-21 | תרופות מומחה נוספות | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי). הטיפול נקבע ומנוטר ע"י המומחה | מטוקלופרמיד ממושך, ממריצים/מודפיניל, טרשת נפוצה, אונקולוגיה, יל"ד ריאתי/IPF, סירולימוס, הורמון גדילה, המטולוגיה, CF, טפמידיס/מבקמטן: הודעה בלבד, חידוש ע"י רופא/ה. תרופות ביולוגיות בזריקה בקהילה: הרפואן מכין (אישור, מכתב מומחה, מרווח, בטיחות) והרופא/ה מאשר/ת (5.11.2026) | החלטה מקומית | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| כללי-22 | השלמות 2 מהמאגר (2.11.2026) | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) | ויטמין D, בטאהיסטין, חומצה במפדואית, אומגה 3/איקוזפנט, ציפרופיברט, וריסיגואט, ניטרוגליצרין תת-לשוני, פזולינטנט/אלינזנטנט (ALT), דואביב, אינטראורוסה, סיאנה, אורליסטט, פרוקלופריד, משלשלים, טטרציקלינים ממושכים, מניעת זיהומי שתן, משככי כאב ממושכים, ביקרבונט. עודכן ב-7.11.2026: אין עוד "רופא/ה בלבד" בקבוצה זו — ראו החלטת הסקירה | החלטה מקומית (הצעה) | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| סקירה-1 | סקירת פריטים חסומים (7.11.2026) | נושא תפעולי — הנחיות קליניות לא עוסקות בו; מבוסס על נוהל הרפואן | אף תרופה לא חסומה כברירת מחדל. 59 הפריטים שהיו "רופא/ה בלבד" נסקרו אחד-אחד: חלקם פתוחים עם רשימת בדיקות, חלקם בדגל אדום (בדיקה כפולה מול הרופא/ה). נשארים אצל הרופא/ה: רואקוטן, אנטיביוטיקה לתסמין חדש (מלבד מוקסיפן/רפאפן אחרי משטח גרון חיובי) ותרופות נגד שפעת. התראת האינטראקציות של המערכת היא שכבת ההגנה הבסיסית. | החלטה מקומית (7.11.2026) | - |

## 11.ה רשימת התרופות (לסימון)

| # | שם | גנרי | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | איטרקונזול | Itraconazole | נוגד פטרת (קורס) | לפי הנחיה | ☐ | |
| 11.2 | איזוטרטינואין (רואקוטן) | Isotretinoin | רטינואיד פומי | רופא/ה בלבד | ☐ | |
| 11.3 | אציטרטין | Acitretin | רטינואיד פומי | דגל אדום | ☐ | |
| 11.4 | אנלוג פרוסטגלנדין (טיפות עיניים) | Prostaglandin analogue (eye drops) | גלאוקומה | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 11.5 | טימולול (טיפות עיניים) | Timolol (eye drops) | גלאוקומה · חוסם בטא | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 11.6 | מעכב קרבוניק אנהידרז (טיפות עיניים) | Carbonic anhydrase inhibitor (eye drops) | גלאוקומה | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 11.7 | ברימונידין (טיפות עיניים) | Brimonidine (eye drops) | גלאוקומה · אגוניסט אלפא | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 11.8 | שילוב לגלאוקומה עם טימולול | Glaucoma combination with timolol | גלאוקומה · שילוב | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 11.9 | דוקסיציקלין / מינוציקלין (קורס ממושך) | Doxycycline / minocycline (long course) | טטרציקלין לאקנה או לרוזציאה | לפי הנחיה | ☐ | |
| 11.10 | פילוקרפין (טיפות עיניים) | Pilocarpine (eye drops) | גלאוקומה · כולינרגי | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 11.11 | משחות לאטופיק דרמטיטיס ללא סטרואיד (אלידל, סטקוויס) | Topical calcineurin / PDE4 inhibitors (eczema) | אקזמה · לא סטרואיד | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 11.12 | טיפול מקומי ברוזציאה (סולנטרה, רוזקס) | Ivermectin cream (rosacea) | רוזציאה | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 11.13 | טיפולים מקומיים של רופא/ת עור (אפודיקס, אלדרה, קליסירי) | Dermatology specialist topicals | עור · מומחה | לפי הנחיה | ☐ | |
| 11.14 | זריקות לעין (איליה, לוסנטיס, ואביסמו) | Intravitreal anti-VEGF injections | עיניים · רופא/ת עיניים | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 11.15 | טיפות וטיפולים של רופא/ת עיניים (נבנק, ברומסייט, אוזורדקס, מרחיבי אישונים) | Eye-specialist drops and implants | עיניים · מומחה | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 11.16 | ציקלוספורין טיפות עיניים ליובש (רסטזיס, סיקווה) | Ciclosporin eye drops (dry eye) | עיניים · מומחה | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |

## 11.ו פירוט מלא

### 11.1 **איטרקונזול** · Itraconazole לפי הנחיה

נוגד פטרת (קורס)

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | איטרנול · Itranol |
| נימוק / הערה | קורס לפי הרופא/ה. אסור באי-ספיקת לב; אינטראקציות רבות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | בתוך משך הקורס | בתוך משך הקורס שנקבע ע"י הרופא/ה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ALT (בקורס מעל חודש) | ALT מהחודש האחרון, אם הקורס ארוך מחודש. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 3 | תפקודי כבד (ALT) תקין | בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 2 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | אין התווית נגד | אי-ספיקת לב. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ALT בקורס מעל חודש |
| ספי החזרה לרופא/ה | ALT מעל פי 2 מהגבול העליון |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | אי-ספיקת לב |
| תלונות בפנייה או ברשומה | קוצר נשימה או בצקות ← דחוף; צהבת או שתן כהה ← דחוף |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 11.2 **איזוטרטינואין (רואקוטן)** · Isotretinoin רופא/ה בלבד

רטינואיד פומי

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | קיורטן · Curatane \| איזובניר · Isovenir \| רואקוטן · Roaccutane (לאימות מול מאגר משרד הבריאות) |
| נימוק / הערה | הרפואן לא מפיק מרשם לרואקוטן (איזוטרטינואין) — גם לא להכנה לאישור הרופא/ה. רק רופא/ת עור רושם/ת אותו, במסגרת תוכנית מניעת היריון ומעקב מעבדה. מפנים את המטופל/ת לרופא/ת העור המטפל/ת. |
| הנחיה | **הרפואן לא מפיק מרשם לרואקוטן (איזוטרטינואין) — גם לא להכנה לאישור הרופא/ה. רק רופא/ת עור רושם/ת אותו, במסגרת תוכנית מניעת היריון ומעקב מעבדה. מפנים את המטופל/ת לרופא/ת העור המטפל/ת.** |
| מקור | -; מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 11.3 **אציטרטין** · Acitretin דגל אדום

רטינואיד פומי

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (1)** | ניאוטיגאזון · Neotigason |
| **נימוק / הערה** | אציטרטין (ניאוטיגסון) בכמוסות: טרטוגני, ואסור היריון עד 3 שנים אחרי ההפסקה. הרפואן מכין עם בדיקת היריון, כבד ושומנים, והרופא/ה מאשר/ת. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני במינון קבוע שנקבע ע"י מומחה/ית. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | הנחיה עדכנית של רופא/ת העור | מכתב או סיכום של רופא/ת העור מ-12 החודשים האחרונים, עם אותה תרופה ומינון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | אין היריון, ויש אמצעי מניעה | באישה בגיל הפוריות: בדיקת היריון שלילית מהחודש האחרון ואמצעי מניעה מתועד; אין הנקה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | תפקודי כבד | ALT ו-AST מ-3 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 7 | שומנים בדם | טריגליצרידים וכולסטרול מ-3 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 12 | טריגליצרידים מתחת ל-800 | טריגליצרידים אחרונים מתחת ל-800 מ"ג/ד"ל (סכנת פנקריאטיטיס). לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 13 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | בדיקת היריון חודשית בגיל הפוריות; ALT, AST ושומנים כל 3 חודשים |
| **מקור** | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 11.4 **אנלוג פרוסטגלנדין (טיפות עיניים)** · Prostaglandin analogue (eye drops) לפי הנחיה, בתנאים

גלאוקומה

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (11)** | קסאלטן · Xalatan | גלאוטן · Glautan | לתרו · Lataro | לטנו-אבניר · Latano-Avenir | ויזולטה · Vyzulta | טרבתן · Travatan | טרבופרוסט אס.קיי. · Travoprost S.K. | לומיגן · Lumigan (לאימות מול מאגר משרד הבריאות) | בימטופרוסט טבע · Bimatoprost Teva | בימטופרוסט אס.קיי. · Bimatoprost S.K. | ספלוטן · Saflutan |
| **נימוק / הערה** | ביקורת שנתית אצל רופא/ת עיניים |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **ביקורת אצל רופא/ת עיניים** | ביקור אצל רופא/ת עיניים ב-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | **רכישות** | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | **טיפול כרוני במינון קבוע** | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ת עיניים, אותו טיפול ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | אין מעקב מעבדה; ביקורת עיניים שנתית |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | כאב עין, אודם או ירידה פתאומית בראייה ← דחוף - רופא/ת עיניים / מיון עיניים; קוצר נשימה (טימולול) ← לרופא |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 11.5 טימולול (טיפות עיניים) · Timolol (eye drops) לפי הנחיה, בתנאים

גלאוקומה · חוסם בטא

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | וי-אופטיק · V-Optic |
| נימוק / הערה | נספג: האטת דופק וסימפונות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | ביקורת אצל רופא/ת עיניים | ביקור אצל רופא/ת עיניים ב-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | דופק במנוחה תקין | במדידה האחרונה דופק במנוחה תקין. חריג: מתחת ל-55 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים | |
| 3 | אין אסתמה או COPD | אין אבחנת אסתמה או COPD (טימולול נספג ועלול לגרום להתכווצות סימפונות). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ת עיניים, אותו טיפול ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה; ביקורת עיניים שנתית |
| ספי החזרה לרופא/ה | דופק מתחת ל-55 |
| ערך חמור | דופק מתחת ל-50 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב עין, אודם או ירידה פתאומית בראייה ← דחוף - רופא/ת עיניים / מיון עיניים; קוצר נשימה (טימולול) ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 11.6 מעכב קרבוניק אנהידרז (טיפות עיניים) · Carbonic anhydrase inhibitor (eye drops) לפי הנחיה, בתנאים

גלאוקומה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (4) | דורזופט · Dorzopt \| דורזולאמיד אס.קיי. · Dorzolamide S.K \| ברינזולאמיד אס.קיי. · Brinzolamide S.K. \| אזופט · Azopt (לאימות מול מאגר משרד הבריאות) |
| נימוק / הערה | ביקורת שנתית |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | ביקורת אצל רופא/ת עיניים | ביקור אצל רופא/ת עיניים ב-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ת עיניים, אותו טיפול ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה; ביקורת עיניים שנתית |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב עין, אודם או ירידה פתאומית בראייה ← דחוף - רופא/ת עיניים / מיון עיניים; קוצר נשימה (טימולול) ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 11.7 **ברימונידין (טיפות עיניים)** · Brimonidine (eye drops) לפי הנחיה, בתנאים

גלאוקומה · אגוניסט אלפא

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | אלפאגן פי · Alphagan P | ברימונידין טבע · Brimonidine Teva | סימברינזה · Simbrinza (עם ברינזולאמיד) |
| נימוק / הערה | ביקורת שנתית |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | ביקורת אצל רופא/ת עיניים | ביקור אצל רופא/ת עיניים ב-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ת עיניים, אותו טיפול ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה; ביקורת עיניים שנתית |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב עין, אודם או ירידה פתאומית בראייה ← דחוף - רופא/ת עיניים / מיון עיניים; קוצר נשימה (טימולול) ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 11.8 שילוב לגלאוקומה עם טימולול · Glaucoma combination with timolol

לפי הנחיה, בתנאים

גלאוקומה · שילוב

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (12) | קסלאקום · Xalacom \| לתרו-טים · Lataro-Tim \| דואוטרב · Duotrav \| גאנפורט · Ganfort \| בימטילול טבע · Bimatilol Teva \| בימאטול אס.קיי. · Bimatol S.K. \| קוסופט · Cosopt \| דורזטול-אבניר · Dorzatol-Avenir \| דורזולאמיד טימולול תרו · Dorzolamide Timolol Taro \| אזרגה · Azarga \| ברינזוטול אס.קיי. · Brinzotol S.K \| קומביגן · Combigan |
| נימוק / הערה | מכיל טימולול: דופק וסימפונות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | ביקורת אצל רופא/ת עיניים | ביקור אצל רופא/ת עיניים ב-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | דופק במנוחה תקין | במדידה האחרונה דופק במנוחה תקין. חריג: מתחת ל-55 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: מתחת ל-50 ← לא מחדשים | |
| 3 | אין אסתמה או COPD | אין אבחנת אסתמה או COPD (טימולול נספג ועלול לגרום להתכווצות סימפונות). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 4 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 6 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ת עיניים, אותו טיפול ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה; ביקורת עיניים שנתית |
| ספי החזרה לרופא/ה | דופק מתחת ל-55 |
| ערך חמור | דופק מתחת ל-50 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב עין, אודם או ירידה פתאומית בראייה ← דחוף - רופא/ת עיניים / מיון עיניים; קוצר נשימה (טימולול) ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 11.9 דוקסיציקלין / מינוציקלין (קורס ממושך) · Doxycycline / minocycline (long course) לפי הנחיה

טטרציקלין לאקנה או לרוזציאה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | דוקסילין · Doxylin | דוקסי · Doxy | מינוציקלין · Minocycline |
| נימוק / הערה | קורס עד 3-4 חודשים; לא בהיריון ולא מתחת לגיל 8 בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | בתוך משך הטיפול שנקבע | סך הטיפול עד 4 חודשים, או החלטה מתועדת של הרופא/ה להמשך. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | מינוציקלין מעל 6 חודשים | במינוציקלין מעל 6 חודשים: תפקודי כבד מ-3 החודשים האחרונים, ואין פיגמנטציה או סימני זאבת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב ראש חזק עם הפרעות ראייה ← דחוף; כוויות שמש חזקות ← לרופא |
| מקור | מעקב: SPS Medicines Monitoring · SPS Medicines Monitoring (NHS) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 11.10 **פילוקרפין (טיפות עיניים)** · Pilocarpine (eye drops) לפי הנחיה, בתנאים

גלאוקומה · כולינרגי

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (1)** | פילוקרפין 2% ויטאמד · Pilocarpine 2 % Vitamed |
| **נימוק / הערה** | מצר אישונים: ראייה חשוכה בלילה. ביקורת שנתית אצל רופא/ת עיניים |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | ביקורת אצל רופא/ת עיניים | ביקור אצל רופא/ת עיניים ב-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ת עיניים, אותו טיפול ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | אין מעקב מעבדה; ביקורת עיניים שנתית |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | כאב עין, אודם או ירידה פתאומית בראייה ← דחוף - רופא/ת עיניים / מיון עיניים; קוצר נשימה (טימולול) ← לרופא |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 11.11 משחות לאטופיק דרמטיטיס ללא סטרואיד (אלידל, סטקוויס) · Topical calcineurin / PDE4 inhibitors (eczema)

לפי הנחיה, בתנאים

אקזמה · לא סטרואיד

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | אלידל קרם 1% · Elidel Cream 1 % \| סטקוויס · Staquis \| פרוטופיק 0.03 % · Protopic |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י רופא/ת עור או ילדים. צריבה בהתחלה — צפויה. זיהום בעור (מוגלה, הרפס) ← להפסיק ולפנות לרופא/ה. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין זיהום בעור | בפנייה אין מוגלה, שלפוחיות או פצעים מזוהמים. לא ← לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ת עור, אותו טיפול ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 5 | אין התארת אינטראקציה | כל התארת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 6 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 7 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה |
| תלונות בפנייה או ברשומה | מוגלה, שלפוחיות או הרפס ← לרופא/ה; החמרה למרות טיפול ← לרופא/ת עור |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 11.12 טיפול מקומי ברוזציאה (סולנטרה, רוזקס) · Ivermectin cream (rosacea) לפי הנחיה, בתנאים

רוזציאה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | סולנטרה · Soolantra \| רוזקס · Rozex (מטרונידזול) |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י רופא/ת עור או משפחה. החמרה זמנית בשבועות הראשונים אפשרית. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 2 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ת עור או משפחה, אותו טיפול ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 4 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 5 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 6 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | אין מעקב מעבדה |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב או אודם בעין ← לרופא/ה; החמרה ← לרופא/ה |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 11.13 טיפולים מקומיים של רופא/ת עור (אפודיקס, אלדרה, קליסירי) · Dermatology specialist topicals

לפי הנחיה

עור · מומחה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (12) | אפודיקס קרם 5% · Efudix Cream 5% | אלדרה 5% · Aldara 5 % | אקווימוד קרם 5% · Aquimod Cream 5 % | קליסירי משחה · Klisyri Ointment | אסומד ג'ל · Esomed Gel (הידרוקינון) | לשקוטן משחה · Leshcutan Ointment | טוקטינו 10 מ"ג · Toctino 10 MG | טוקטינו 30 מ"ג · Toctino 30 MG | לדגה · Ledaga | סאנאקטיק · Sunactic | פלותרול · Flutarol | פילסובז ג'ל · Filsuvez Gel |
| נימוק / הערה | אלדרה ואפודיקס לקרטוזיס אקטינית ולגידולי עור שטחיים: קורס מוגבל, לפי המלצת רופא/ת עור. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | הנחיה עדכנית של רופא/ת העור | מכתב או סיכום של רופא/ת העור מ-12 החודשים האחרונים, עם אותה תרופה ומינון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | קורס אחד לפי ההמלצה | המרשם לקורס אחד, באורך שרופא/ת העור קבע/ה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 5 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 11.14 זריקות לעין (איליה, לוסנטיס, ואביסמו) · Intravitreal anti-VEGF injections לפי הנחיה, בתנאים

עיניים · רופא/ת עיניים

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (8) | איליה 2 מ"ג · Eylea 2 MG \| איליה 8 מ"ג · Eylea 8 MG \| אפלי טבע · Afli Teva \| אפליברספט קמהדע 2 מ"ג · Aflibercept Kamada 2 MG \| אפקליר · Afqlir \| לוסנטיס · Lucentis \| רניויזיו · Ranivisio \| ואביסמו · Vabysmo |
| נימוק / הערה | זריקות לעין (איליה, לוסנטיס, ואביסמו) ניתנות במרפאת עיניים. רצף הטיפול חשוב: פער בטיפול עלול לגרום לאובדן ראייה. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני במינון קבוע שנקבע ע"י מומחה/ית. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | מעקב מסודר — מרפאת העיניים | יש ביקור (מרפאת העיניים) בתקופה שנקבעה במעקב, ואין פער במעקב. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ניפוק מסודר בלי פערים | הזריקות נופקו וניתנו לפי המרווח שנקבע, בלי פער בין זריקות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 10 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 11.15 טיפות וטיפולים של רופא/ת עיניים (נבנק, ברומסייט, אוזורדקס, מרחיבי אישונים) · Eye-specialist drops and implants

לפי הנחיה, בתנאים

עיניים · מומחה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (14) | נבנק · Nevanac | ברומסייט · Bromsite | אוזורדקס · Ozurdex | ציקלופנטולט אדול 1% · Cyclopentolate Edol | אטרוספן טיפות עיניים · Atrospan Eye Drops | מידראמיד · Mydramide | פנילאפרין ויז'ן 10% · Phenylephrine Vision | אפרין 10 · Efrin | איופידין 0.5 % · Iopidine | ציסטדרופס 3.8 מ"ג/מ"ל · Cystadrops | דיקלופטיל 0.1 % · Dicloftil | לוקלין טיפות · Localin Drops | אנסטוסיל · Anestocil | אוקסיבופרוקאין אס.קיי. · Oxybuprocaine S.K. |
| נימוק / הערה | טיפות ושתלים של רופא/ת עיניים (נבנק, ברומסייט, אוזורדקס, מרחיבי אישונים). כמו בזריקות לעין: מעקב וניפוק מסודרים. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני במינון קבוע שנקבע ע"י מומחה/ית. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | מעקב מסודר — רופא/ת העיניים | יש ביקור (רופא/ת העיניים) בתקופה שנקבעה במעקב, ואין פער במעקב. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ניפוק מסודר בלי פערים | הטיפול נופק לפי ההוראה, בלי פערים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 10 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

11.16 **ציקלוספורין טיפות עיניים ליובש (רסטזיס, סיקווה)** · Ciclosporin eye drops (dry eye) לפי הנחיה, בתנאים

עיניים · מומחה

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (2)** | רסטזיס · Restasis | סיקווה · Cequa |
| **נימוק / הערה** | ציקלוספורין טיפות (רסטזיס, איקרוויס) ליובש עיניים קשה, נקבע ע"י רופא/ת עיניים. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני במינון קבוע שנקבע ע"י מומחה/ית. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | הנחיה עדכנית של רופא/ת העיניים | מכתב או סיכום של רופא/ת העיניים מ-12 החודשים האחרונים, עם אותה תרופה ומינון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **מקור** | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

# 12. חיסון, זיהומים ומומחים

15 תרופות · לפי הנחיה, בתנאים: 8 · הכנה לאישור רופא/ה: 5 · לפי הנחיה: 2 · גרסה 2 · חלוקה לפי מערכות · 2.11.2026

מקורות: הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020; ACOG 2023 (סיכום AFP). שאר התחומים: החלטה מקומית; עלון לצרכן לפונקס (עודכן 12/2020). שאר התרופות: החלטה מקומית

## 12.א כללים

- חידוש רגיל: 3 חודשים
- ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה פעם בשנה
- עד 3 חידושים רצופים, ואז ביקור רופא
- אין התווית נגד ← תמיד מחדשים לפחות לחודש אחד
- חסרה מדידה, בדיקה או ביקורת שנתית: חידוש לחודש אחד + זימון למרפאה
- חריגה מספי ההחזרה: חידוש לחודש אחד + הודעה לרופא/ה
- התווית נגד או ערך חמור: לא מחדשים, הודעה לרופא/ה (הסף של כל תרופה מופיע ברשימה שלה)
- רפואן לא משנה מינון ולא מחליף תרופה. "מעקב צמוד" = תרופה עם מעקב תכוף (מעבדה, אק"ג, עיניים או צילום) — לבדוק כל ערך בקפידה
- תרופות של מומחה: לפי הנחיה עדכנית. HIV ו-PrEP, מדכאי חיסון ותרופות אונקולוגיות — דגל אדום
- חום או זיהום בתרופה מדכאת חיסון ← הודעה דחופה
- דגל אדום: הרפואן מכין לפי רשימת הבדיקות, והרופא/ה בודק/ת שוב לפני האישור — גם כשהכול תקין

## 12.ג בדיקות משותפות

| שלב | נושא | מה בודקים | קריטריון | אם לא מתקיים | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| לפני כל חידוש | בדיקת מעקב | לפי התרופה | שומנים: LDL; לבותירוקסין: TSH; אלופורינול/פבוקוסוסטט: חומצה אורית — מ-12 החודשים האחרונים | אין ← חידוש לחודש + זימון לבדיקה | הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52; החלטה כללי-1 |
| לפני כל חידוש | ערך המעקב | לעומת הבדיקה הקודמת או היעד | LDL לא עלה ב-30% ומעלה; TSH בטווח המעבדה; חומצה אורית מתחת ל-6 | לא ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה | החלטות כללי-2-4 |
| לפני כל חידוש | רכישות | כיסוי ימים ב-6 החודשים האחרונים | 80% מהימים ומעלה | פחות ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה | כמו בי"ל |
| לפני כל חידוש | ביקורת שנתית | ביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה | ב-12 החודשים האחרונים | אין ← חידוש לחודש + זימון לביקורת | כמו בי"ל |
| לפני כל חידוש | רצף חידושים | כמה חידושים רצופים מאז ביקור רופא | פחות מ-3 | 3 ← ביקור רופא | כמו בי"ל |
| החזרה מיידית לרופא | פריחה | מופיע בפנייה או ברשומה (אלופורינול) | פריחה או תגובה עורית | הפסקה, דחוף | החלטה כללי-7 |

## 12.ד החלטות

| # | נושא | מה ההנחיה אומרת | ההחלטה לפרוטוקול | סוג | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| כללי-1 | בדיקות מעקב | שומנים: פרופיל 12-4 שבועות אחרי התחלה, אחר כך כל 12-6 חודשים (ההנחיה הישראלית 2020; ESC/EAS 2019). TSH בלבותירוקסין: שנתי כשמאוזן (NICE NG145). חומצה אורית בטיפול מוריד: יעד <6, בדיקה תקופתית (ACR 2020) | LDL, TSH וחומצה אורית מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש + זימון | החלטה מקומית (הצעה) | הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52; ESC/EAS 2019; NICE NG145; ACR 2020 |

| # | נושא | מה ההנחיה אומרת | ההחלטה לפרוטוקול | סוג | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| כללי-6 | מעכבי משאבת פרוטונים | טיפול ממושך דורש התוויה מתועדת; בלי התוויה — לנסות הפחתה או הפסקה | נדרשת התוויה מתועדת לטיפול ממושך. אין ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה לשקול הפחתה | החלטה מקומית (הצעה) | AGA 2022 |
| כללי-7 | אלופורינול ופבוקסוסטט | יעד חומצה אורית <6 mg/dL; התחלה במינון נמוך והתאמה לכליות; פריחה ← הפסקה מיידית (סיכון SJS/DRESS) | חומצה אורית ≥6 ← הודעה. אלופורינול: eGFR <30 ← הודעה (מינון). פריחה ← התווית נגד, דחוף | החלטה מקומית (הצעה) | ACR 2020; תווית FDA |
| כללי-11 | מעכבי PCSK9 (רפאטה, פראלואנט) | בסל באינדיקציות מצומצמות; רוב המטופלים דרך שב"ן או ביטוח. סבילות טובה, תגובה מקומית | בתנאים: אישור מימון בתוקף וטיפול כרוני; מעקב LDL כמו בסטטין. אין אישור ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה | החלטה מקומית (הצעה) | הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 (פרק מעכבי PCSK9) |
| כללי-12 | תרופות כרוניות נוספות (2) | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי). SSRI/SNRI: היפונתרמיה בקשישים | בזאפיברט, גבפנטין, פרגבלין, SSRI/SNRI (נתרן בגיל 65+), מעכבי ארומטאז, טמוקסיפן, רלוקסיפן, טרבינפין ואיטרקונזול (קורס): לפי הרשימה של כל תרופה | החלטה מקומית (הצעה) | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| כללי-15 | שלפוחית רגיזה ו-PDE5 | אנטי-כולינרגיים חזקים — להימנע בקשישים (Beers 2023). מירבגרון: אסור ב-ל"ד ≥180/110, זהירות מעל 160/100 (עלון). PDE5 + ניטרטים — התווית נגד (תווית) | אנטי-כולינרגיים: גיל 75+ ← אישור רופא/ה; אצירת שתן ← דחוף. מירבגרון: ל"ד מתחת ל-160/100. PDE5: ניטרטים = התווית נגד | החלטה מקומית (הצעה) | Beers 2023; עלונים |
| כללי-16 | ברזל, B12, חומצה פולית | ברזל: אחרי תיקון האנמיה ממשיכים כ-3 חודשים לחידוש המאגרים, ואז ספירה תקופתית (BSG 2021). B12 בטיפול שימורי: אין בדיקת רמה שגרתית אלא בתסמינים (NICE NG239, 2024) — הרמה השנתית בפרוטוקול מחמירה | ברזל: ספירת דם ופריטין מ-6 חודשים; טיפול מעל 6 חודשים בלי התוויה ← הודעה. B12: רמה שנתית | החלטה מקומית (הצעה) | BSG 2021; NICE NG239 |
| כללי-19 | תרופות מומחה | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי). הטיפול נקבע ומנוטר ע"י המומחה | אריתרופויאטין, קושרי זרחן ואשלגן, HIV, הפטיטיס B, ציקלוספורין/טקרולימוס, אפרמילסט ואציטרטין: הודעה בלבד, חידוש ע"י רופא/ה | החלטה מקומית | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| כללי-20 | השלמות מהמאגר (2.11.2026) | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) | טרזוסין, פינסטריד, אינקליסירן, ורדנאפיל, טיפות לגלאוקומה (ביקורת עיניים שנתית; טימולול: דופק ואסתמה), NSAID ממושך (כליות, אשלגן, ל"ד, דימום, הגנת קיבה), אנטיהיסטמינים, ציננריזין, דומפרידון, מבברין, סידן, מידודרין, פנטוקסיפילין, דיפירידמול, ולציקלוביר מונע, חומצה זולדרונית | החלטה מקומית (הצעה) | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| כללי-21 | תרופות מומחה נוספות | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי). הטיפול נקבע ומנוטר ע"י המומחה | מטוקלופרמיד ממושך, ממריצים/מודפיניל, טרשת נפוצה, אונקולוגיה, יל"ד ריאתי/IPF, סירולימוס, הורמון גדילה, המטולוגיה, CF, טפמידיס/מבקמטן: הודעה בלבד, חידוש ע"י רופא/ה. תרופות ביולוגיות בזריקה בקהילה: הרפואן מכין (אישור, מכתב מומחה, מרווח, בטיחות) והרופא/ה מאשר/ת (5.11.2026) | החלטה מקומית | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| כללי-22 | השלמות 2 מהמאגר (2.11.2026) | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) | ויטמין D, בטאהיסטין, חומצה במפדואית, אומגה 3/איקוזפנט, ציפרופיברט, וריסיגואט, ניטרוגליצרין תת-לשוני, פזולינטנט/אלינזנטנט (ALT), דואביב, אינטראروסה, סיאנה, אורליסטט, פרוקלופריד, משלשלים, טטרציקלינים ממושכים, מניעת זיהומי שתן, משככי כאב ממושכים, ביקרבונט. עודכן ב-7.11.2026: אין עוד "רופא/ה בלבד" בקבוצה זו — ראו החלטת הסקירה | החלטה מקומית (הצעה) | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |

| # | נושא | מה ההנחיה אומרת | ההחלטה לפרוטוקול | סוג | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| מעקב-7 | קרבמזפין וולפרואט | רמה שגרתית לא נדרשת — רק בחשד לרעילות או אי-היענות (הרמה השנתית בפרוטוקול מחמירה). ולפרואט באישה בגיל הפוריות: תוכנית מניעת היריון עם אמצעי מניעה יעיל (MHRA/EMA) | רמה, נתרן (קרבמזפין), ALT וספירת דם מ-12 החודשים האחרונים. ולפרואט באישה בגיל הפוריות: אמצעי מניעה מתועד. היריון ← הודעה דחופה, לא מפסיקים | החלטה מקומית (הצעה) | NICE NG217; MHRA 2023 |
| מעקב-12 | תרופות למעקב צמוד נוספות | DMARDs: ספירת דם, ALT וקריאטינין כל 3 חודשים בטיפול יציב (BSR 2017); שאר התרופות לפי התווית | מתימזול/PTU, לפלונומיד, אזתיופרין, סולפסלזין, מיקופנולט, מעכבי JAK, הידרוקסיאוריאה, הידרוקסיכלורוקווין, נוגדי פסיכוזה, טסטוסטרון, סטרואידים כרוניים, ניטרופורנטואין, קולכיצין, דנוסומאב, טריפרטייד: בדיקות לפי התרופה; חריגה ← חודש + הודעה; ערך חמור ← לא מחדשים | החלטה מקומית (הצעה) | BSR 2017; עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| סקירה-1 | סקירת פריטים חסומים (7.11.2026) | נושא תפעולי — הנחיות קליניות לא עוסקות בו; מבוסס על נוהל הרפואן | אף תרופה לא חסומה כברירת מחדל. 59 הפריטים שהיו "רופא/ה בלבד" נסקרו אחד-אחד: חלקם פתוחים עם רשימת בדיקות, חלקם בדגל אדום (בדיקה כפולה מול הרופא/ה). נשארים אצל הרופא/ה: רואקוטן, אנטיביוטיקה לתסמין חדש (מלבד מוקסיפן/רפאפן אחרי משטח גרון חיובי) ותרופות נגד שפעת. התראת האינטראקציות של המערכת היא שכבת ההגנה הבסיסית. | החלטה מקומית (7.11.2026) | - |

## 12.ה רשימת התרופות (לסימון)

| # | שם | גנרי | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | לטרוזול | Letrozole | מעכב ארומטאז | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 12.2 | אנסטרוזול | Anastrozole | מעכב ארומטאז | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 12.3 | אקסמסטן | Exemestane | מעכב ארומטאז | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 12.4 | טמוקסיפן | Tamoxifen | SERM (אונקולוגיה) | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 12.5 | תרופות נגד HIV | HIV antiretrovirals | אנטי-רטרו-ויראלי | דגל אדום | ☐ | |
| 12.6 | מעכבי קלצינאורין | Calcineurin inhibitors | מדכא חיסון | דגל אדום | ☐ | |
| 12.7 | ולציקלוביר / אציקלוביר (טיפול מונע) | Valaciclovir / aciclovir (suppression) | אנטי-ויראלי | לפי הנחיה | ☐ | |
| 12.8 | תרופות ביולוגיות | Biologic drugs | נוגדנים ותרופות ביולוגיות | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 12.9 | תרופות אונקולוגיות ובמעקב אונקולוגי | Oral oncology and hormonal cancer therapy | אונקולוגיה | דגל אדום | ☐ | |
| 12.10 | מדכאי חיסון להשתלה (mTOR) | Transplant immunosuppressants (mTOR) | מדכא חיסון | דגל אדום | ☐ | |
| 12.11 | תרופות למחלות נדירות | Rare metabolic / orphan drugs | מחלות מטבוליות ונדירות | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 12.12 | פילוקרפין בבליעה ליובש בפה (סלגן, סלבקל) | Oral pilocarpine (dry mouth) | ראומטולוגיה · מומחה | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |

| # | שם | גנרי | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.13 | תרופות אנטי-זיהומיות של מומחה (פטריות, CMV, שחפת, קלוסטרידיום) | Specialist anti-infectives | זיהומים · מומחה | לפי הנחיה | ☐ | |
| 12.14 | אזתיופרין | Azathioprine | מדכא חיסון | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |
| 12.15 | מיקופנולט | Mycophenolate | מדכא חיסון | לפי הנחיה, בתנאים ⚗ | ☐ | |

## 12.ו פירוט מלא

### 12.1 **לטרוזול** · Letrozole לפי הנחיה, בתנאים

מעכב ארומטאז

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (4) | פמרה · Femara \| לטרוזול דקסל · Letrozole Dexcel \| לטרוזול פרמוז · Letrozole Farmoz \| לטרוזול טבע · Letrozole Teva |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י אונקולוג/ית. צפיפות עצם |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | צפיפות עצם מתועדת | צפיפות עצם מ-24 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י אונקולוג/ית, במסגרת משך הטיפול שנקבע. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | צפיפות עצם כל שנתיים |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאבי פרקים קשים ← לרופא; שבר ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 12.2 אנסטרוזול · Anastrozole לפי הנחיה, בתנאים

מעכב ארומטאז

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | אנסטרוזול טבע · Anastrozole Teva \| Arimidex · ארימידקס |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י אונקולוג/ית. צפיפות עצם |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | צפיפות עצם מתועדת | צפיפות עצם מ-24 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י אונקולוג/ית, במסגרת משך הטיפול שנקבע. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | צפיפות עצם כל שנתיים |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאבי פרקים קשים ← לרופא; שבר ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 12.3 אקסמסטן · Exemestane

לפי הנחיה, בתנאים

מעכב ארומטאז

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | ארומזין · Aromasin \| אקסמזין-ויט · Exemasin-Vit |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י אונקולוג/ית. צפיפות עצם |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | צפיפות עצם מתועדת | צפיפות עצם מ-24 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י אונקולוג/ית, במסגרת משך הטיפול שנקבע. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | צפיפות עצם כל שנתיים |
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאבי פרקים קשים ← לרופא; שבר ← לרופא |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 12.4 **טמוקסיפן** · Tamoxifen לפי הנחיה, בתנאים

SERM (אונקולוגיה)

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (1)** | טמוקסיפן טבע · Tamoxifen Teva |
| **נימוק / הערה** | נקבע ע"י אונקולוג/ית. דימום וגינלי ← דחוף בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **אין דימום וגינלי חדש** | ברשומה או בפנייה אין דימום וגינלי לא סדיר (בעיקר אחרי גיל המעבר). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 2 | **רכישות** | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | **ביקורת שנתית במרפאה** | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 4 | **טיפול כרוני במינון קבוע** | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י אונקולוג/ית, במסגרת משך הטיפול שנקבע. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | **רצף חידושים** | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | **החידוש השלישי ברצף**<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | **אין התווית נגד** | פקקת ורידים או תסחיף ריאתי פעיל. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 10 | **בדיקה גינקולוגית שנתית** | בדיקה גינקולוגית בשנה האחרונה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | בדיקה גינקולוגית לפי תסמינים |
| **מצבים שמוציאים מהפרוטוקול** | פקקת ורידים או תסחיף ריאתי פעיל |
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | כאב ונפיחות ברגל או קוצר נשימה ← דחוף; דימום וגינלי ← דחוף |
| **מקור** | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 12.5 תרופות נגד HIV · HIV antiretrovirals דגל אדום

אנטי-רטרו-ויראלי

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (32) | ביקטארווי · Biktarvy · דסקובי · Descovy · טרובדה · Truvada · אודפסיי · Odefsey · ג'נדברה · Gendevra · סטריבילד · Stribild · טיויקיי · Tivicay · טריומק · Triumeq · דובאטו · Dovato · ג'ולוקה · Juluca · דלסטריגו · Delstrigo · אמטריציטבין/טנופוביר טבע · Emtricitabine/Tenofovir Teva · אמפוביר אס.קיי. · Emfovir S.K. · אבקויר לאמיבודין תרו · Abacavir Lamivudine Taro · זיאגן טבליות · Ziagen · אפיביר · Epivir · אפיביר תמיסה לשתיה · Epivir Oral Solution · רזולסטה · Rezolsta · אדוראנט · Edurant · רקמביס · Rekambys · ווקבריה זריקה · Vocabria Injection · ווקבריה טבליות · Vocabria · אייסנטרס · Isentress · פיפלטרו · Pifeltro · סאנלנקה טבליות מצופות · Sunlenca · סאנלנקה תמיסה להזרקה · Sunlenca Solution For Inection · אטאזנביר טבע · Atazanavir Teva · אינטלנס · Intelence · סלסנטרי · Celsentri · נורויר · Norvir · רטרוביר קפסולות · Retrovir · דולוטרמד 50 מ"ג · Dolutremed |
| נימוק / הערה | תרופות HIV ו-PrEP: HIV מנוהל במרכז האיידס; PrEP — בדיקת HIV כל 3 חודשים ותפקוד כליות, ורק רופא/ה מורשה רושם/ת. הרפואן מכין במקרו הייעודי, והרופא/ה מאשר/ת. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני במינון קבוע שנקבע ע"י מומחה/ית. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | הנחיה עדכנית של מרכז האיידס או מרפאת ה-PrEP | מכתב או סיכום של מרכז האיידס או מרפאת ה-PrEP מ-12 החודשים האחרונים, עם אותה תרופה ומינון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | PrEP: שימוש במקרו הייעודי | המרשם הוכן במקרו ה-PrEP שבמערכת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 6 | PrEP: הרופא/ה מורשה לרשום PrEP | לרופא/ה המאשר/ת יש הרשאה לרשום PrEP (רק לחלק מהרופאים). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | PrEP: בדיקת HIV ותפקוד כליות | בדיקת HIV מ-3 החודשים האחרונים, וקראטינין מהשנה האחרונה. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 10 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 11 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 12 | פינוי קריאטינין מספיק (טנופוביר) | בטנופוביר: ב-PrEP פינוי קריאטינין 60 ומעלה; בשילובים לטיפול 50 ומעלה. לא ← התווית נגד: לא מחדשים, הודעה דחופה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 13 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | PrEP: בדיקת HIV כל 3 חודשים; קראטינין |
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 12.6 מעכבי קלצינאורין · Calcineurin inhibitors דגל אדום

מדכא חיסון

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (7) | סנדאימון ניאורל · Sandimmun Neoral \| דקסימון · Deximune \| פרוגרף · Prograf \| אדבגרף · Advagraf \| טקרוסל · Tacrocel \| דייליפורט · Dailiport \| אקרולימוס פי.אר. · Acrolimus PR |
| נימוק / הערה | טקרולימוס וציקלוספורין: רמה בדם ותפקוד כליות מנוטרים ע"י מרכז ההשתלה או המומחה/ית. הרפואן מכין, והרופא/ה מאשר/ת. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני במינון קבוע שנקבע ע"י מומחה/ית. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | הנחיה עדכנית של מרכז ההשתלה או המומחה/ית | מכתב או סיכום של מרכז ההשתלה או המומחה/ית מ-12 החודשים האחרונים, עם אותה תרופה ומינון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | רמת התרופה בדם | רמה אחרונה בטווח שנקבע, לפי תדירות המעקב. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 6 | תפקוד כליות | קראטינין ו-eGFR מ-3 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | רמת התרופה, קראטינין ו-eGFR |
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: SPS · SPS Medicines Monitoring (NHS) · SPS Medicines Monitoring |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 12.7 ולציקלוביר / אציקלוביר (טיפול מונע) · Valaciclovir / aciclovir (suppression) לפי הנחיה

אנטי-ויראלי

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (6) | ולטרקס · Valtrex | זובירקס · Zovirax | אציקלו-וי · Acyclo-V | ציקלוביר · Cyclovir | אציקלובניר · Acyclovenir | אציקלוביר ויז'ן · Aciclovir Vision |
| נימוק / הערה | טיפול מונע בהרפס חוזר; הערכה מחדש פעם בשנה. מינון לפי כליות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | טיפול מונע שהוערך בשנה האחרונה | החלטת רופא/ה על טיפול מונע ב-12 החודשים האחרונים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | קריאטינין מתועד<br>שאלה: גיל 65 ומעלה או מחלת כליות? | קריאטינין/eGFR מ-12 החודשים האחרונים, eGFR 30 ומעלה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 3 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | קריאטינין שנתי בגיל 65+ |
| תלונות בפנייה או ברשומה | בלבול (בגיל מבוגר) ← דחוף |
| מקור | מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 12.8 תרופות ביולוגיות · Biologic drugs

הכנה לאישור רופא/ה

נוגדנים ותרופות ביולוגיות

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (77) | אדאלימומאב קמהדע · Adalimumab Kamada | אמג'ויטה · Amgevita | אמספאריטי · Amsparity | הוליו · Hulio | יומירה · Humira | היירימוז · Hyrimoz | היירימוז אייץ'. סי. אף · Hyrimoz Hcf | אידסיו · Idacio | יופלימה · Yuflyma | אנברל · Enbrel | אנברל אבקה וממס · Enbrel Powder And Solvent | ארלזי · Erelzi | נפקסטו · Nepexto | סימזיה · Cimzia | גולימומאב קמהדע · Golimumab Kamada | סימפוני · Simponi | אימולדוזה · Imuldosa | אימולדוזה מזרק מוכן לשימוש · Imuldosa Pre-Filled Syringe | סטלרה · Stelara | סטלרה עט מוכן לשימוש · Stelara Pre-Filled Pen | סטלרה מזרק מוכן לשימוש · Stelara Prefilled Syringe | סטקימה · Steqeyma | סטקימה מזרק מוכן לשימוש · Steqeyma Prefilled Syringe | אוסטקינומאב קמהדע · Ustekinumab Kamada | אוסטקינומאב קמהדע מזרק מוכן לשימוש · Ustekinumab Kamada Pre-Filled Syringe | וזלנה · Wezlana | וזלנה מזרק מוכן לשימוש · Wezlana Prefilled Syringe | יסינטק · Yesintek | יסינטק מזרק מוכן לשימוש · Yesintek Pre-Filled Syringe | קוסנטיקס תמיסה להזרקה · Cosentyx Solution For Injection | טאלץ · Taltz | טרמפיה · Tremfya | סקיריזי · Skyrizi | אילומיה · Ilumya | בימזלקס · Bimzelx | אומבו · Omvoh | דופיקסנט · Dupixent | אבגליס · Ebglyss | אומליקלו · Omlyclo | זולאייר פי.אף.אס · Xolair Pfs | זולאייר · Xolair | נוקלה אבקה להכנת תמיסה להזרקה · Nucala Powder For Solution For Injection | נוקלה תמיסה להזרקה · Nucala Solution For Injection | פסנרה · Fasenra | סינקאייר · Cinqair | טזספייר · Tezspire | אקטמרה · Actemra | אבטוזמה · Avtozma | קבזרה · Kevzara | אורנסיה · Orencia | אנטיביו תוך ורידי · Entyvio I.V | אנטיביו תת עורי · Entyvio S.C | סאפנלו · Saphnelo | בנליסטה תוך ורידי · Benlysta I.V | בנליסטה תת-עורי · Benlysta S.C | איימוביג · Aimovig | אמגליטי · Emgality | אג'ובי · Ajovy | איקסיפי · Ixifi | רמיקד · Remicade | רמסימה · Remsima | מבטרה · Mabthera | ריקסתון · Rixathon | רוקסיאנס · Ruxience | טרוקסימה · Truxima | סוליריס · Soliris | אולטומיריס · Ultomiris | ואייפטי · Vyepti | סוטיקטו · Sotyktu | סיבינקו · Cibinqo | ליטפולו · Litfulo | ולסיפיטי · Velsipity | קינרט · Kineret | אילאריס · Ilaris | ויוגרט · Vyvgart (מיאסטניה גרביס) | אנספרינג · Enspryng (NMOSD) | אימאווי · Imaavy (מיאסטניה גרביס) |
| נימוק / הערה | תרופות ביולוגיות בזריקה בקהילה (דופיקסנט, קסולייר, חומירה, סטלרה, קוזנטיקס ועוד): הרפואן מכין — אישור, מכתב, מרווח ובטיחות — והרופא/ה מאשר/ת. עירוי בבית חולים — לרופא/ה. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | ניתנת בקהילה | התרופה ניתנת במרפאה (אחות) או בהזרקה עצמית, ולא בעירוי ביחידת אשפוז יום. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | אישור תרופה בתוקף | אישור מימון (טופס 29ג או אישור תרופות) בתוקף לתאריך המנה, לאותה תרופה ומינון. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | מכתב מומחה/ית מ-12 החודשים האחרונים | מכתב של הרופא/ה המומחה/ית מהשנה האחרונה, עם אותה תרופה, מינון ומרווח. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | המנה בזמן | המרווח מהמנה הקודמת לפי ההוראה (לא מוקדם, לא באיחור של יותר משבוע). לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | אין זיהום פעיל או ניתוח מתוכנן | בפנייה וברשומה אין חום, זיהום, אנטיביוטיקה בשבועיים האחרונים, או ניתוח מתוכנן. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | אין היריון חדש | אין היריון חדש או תכנון היריון שלא נדון עם המומחה/ית. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 7 | אין חיסון חי מתוכנן | אין בקשה או תוכנית לחיסון חי (MMR, אבעבועות רוח, קדחת צהובה). לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 8 | תור לאחות או הדרכה להזרקה עצמית | תור במרפאת האחיות, או תיעוד שהמטופל/ת מוזרק/ת בבית. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 9 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 10 | בדיקת שחפת במהלך הטיפול | בדיקת שחפת (TB) לפי הנחיית המומחה, ואין תסמיני שחפת. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 11 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 12 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | חום או זיהום ← לרופא/ה לפני המנה; פריחה, קוצר נשימה או נפיחות אחרי הזרקה ← דחוף |
| **הוראות ואזהרות למטופל/ת** | הוראות לתרופה ביולוגית:<br>• להזריק (או להגיע לאחות) לפי המרווח שנקבע, בלי להקדים ובלי לדלג.<br>• לשמור את התרופה במקרר (לא במקפיא), ולהוציא חצי שעה לפני ההזרקה.<br>• לפני כל מנה: אם יש חום, זיהום, אנטיביוטיקה, ניתוח מתוכנן או היריון — לפנות קודם לרופא, ולא להזריק.<br>• לא לקבל חיסון חי (כמו MMR, אבעבועות רוח, קדחת צהובה) בלי לשאול את הרופא.<br>• פריחה, קוצר נשימה או נפיחות אחרי ההזרקה — לפנות מיד לטיפול רפואי. |
| **מקור** | -; מעקב: עלון ה-(DailyMed) FDA · עלון (DailyMed) FDA · עלון (DailyMed) FDA · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 12.9 תרופות אונקולוגיות ובמעקב אונקולוגי · Oral oncology and hormonal cancer therapy דגל אדום

אונקולוגיה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (167) | אבירטרון - תרימה · Abiraterone - Trima | אבירטרון מדומי · Abiraterone Medomie | אבירטרון אס.קיי · Abiraterone S.K | אבירטרון סנדוז · Abiraterone Sandoz | אבירטרון תרו · Abiraterone Taro | אבירטרון טבע · Abiraterone Teva | אביטאבניר · Abitavenir | אביבניר · Abivenir | אקיגה · Akeega | יונסה · Yonsa | זייטיגה · Zytiga | אנז-אבניר · Enz-Avenir | אנזלוטמיד דקסל · Enzalutamide Dexcel | אנזלוטמיד סנדוז · Enzalutamide Sandoz | אנזלוטמיד טבע · Enzalutamide Teva | אקסטנדי · Xtandi | ארלידה · Erleada | נובקה · Nubeqa | ביקאלוטמיד טבע · Bicalutamide Teva | קזודקס · Casodex | זולדקס · Zoladex | זולדקס אל.אי. · Zoladex La | קמסבי · Camcevi | אליגרד · Eligard | דקספטיל · Decapeptyl | דקספטיל · Decapeptyl C.R. | דקספטיל דפו · Decapeptyl Depot | פירמגון · Firmagon | אייברנס כמוסות · Ibrance | פלבו טבע כמוסות · Palbo Teva | קיסקלי · Kisqali | ריבוציקליב טבע · Ribociclib Teva | ורזניו · Verzenio | קפסיטבין אינובמד · Capecitabine Inovamed | קפסיטבין תרו · Capecitabine Taro | קפציטבין טבע · Capecitabine Teva | גליבק · Glivec | אימרם · Imarem | אימטיניב - תרימה · Imatinib - Trima | אימטיניב תרו · Imatinib Taro | אימטיניב טבע · Imatinib Teva | טסיגנה · Tasigna | דסטיניב אס.קיי · Dasatinib S.K. | דסטיניב סנדוז · Dasatinib Sandoz | דסטיניב תרו · Dasatinib Taro | דסטיניב טבע · Dasatinib Teva | טאגריסו · Tagrisso | לינפארזה · Lynparza | לנלידומיד אס.קיי. · Lenalidomide S.K. | לנלידומיד תרו · Lenalidomide Taro | לנלידומיד טבע · Lenalidomide Teva | אימברוביקה · Imbruvica | אימברוביקה תרחיף לבליעה · Imbruvica Oral Suspension | טמו · Temo | טמודאל · Temodal | פסלודקס · Faslodex | פולבניר · Fulvenir | פולבסטרנט · Fulvestrant | פולווסטרנט אוור · פולבסטרנט פארמה · Fulvestrant Ever Pharma | פולבסטרנט רומפארם · Fulvestrant Rompharm | פולבסטראנט טבע · Fulvestrant Teva | סנדוז · Fulvestrant Sandoz | פיקריי · Piqray | אפיניטור · Afinitor | סרטיקן · Certican | אוורולימוס תרו · Everolimus Taro | אברולימוס טבע · Everolimus Teva | אבטור · Evetor | קאלקוונס טבליות · Calquence | ג'יוטריף · Giotrif | אלצנזה · Alecensa | סמבליקס · Scemblix | אקסי-טבע · Axi-Teva | אקסיטיניב סנדוז · Axitinib Sandoz | אקסיטיניב טבע · Axitinib Teva | אינלייטה · Inlyta | אונורג · Onureg | ולירג · Welireg | מקטובי · Mektovi | בוסט · Bosset | בוסוליף · Bosulif | אלונבריג · Alunbrig | מילראן טבליות · Myleran | קבומטיקס · Cabometyx | טרוקאפ · Truqap | טברקטה · Tabrecta | קוטליק · Cotellic | קסאלקורי · Xalkori | טפינלר · Tafinlar | אורסרדו · Orserdu | ברפטובי · Braftovi | רוזליטרק · Rozlytrek | בלוורסה · Balversa | ארלוטיניב אס.קיי. · Erlotinib S.K. | ארלוטיניב תרו · Erlotinib Taro | ארלוטיניב טבע · Erlotinib Teva | אינרביק · Inrebic | פרוזקלה · Fruzaqla | גפטיניב ס.ק. · Gefitinib S.K. | גפיטיניב סנדוז · Gefitinib Sandoz | גפיטיניב טבע · Gefitinib Teva | זוספטה · Xospata | אייטובבי · Itovebi | טיבסובו · Tibsovo | נינלארו · Ninlaro | טייקרב · Tykerb | ויטראקבי · Vitrakvi | לזקלוז · Lazcluze | לנווימה · Lenvima | לורביקואה · Lorviqua | פורי-נתול טבליות · Puri-Nethol | רייידפט · Rydapt | ליזודרן · Lysodren | אומג'ארה · Omjjara | נרלינקס · Nerlynx | אוֹגְסִיבְיוֹ · Ogsiveo | פאזופניב טבע · Pazopanib Teva | ווטריינט · Votrient | פמאזיר · Pemazyre | ג'ייפירקה · Jaypirca | אימנוביד · Imnovid | פומה טבע · Poma Teva | פומלידומיד אס.קיי. · Pomalidomide S.K. | פומלידומיד טבע · Pomalidomide Teva | איקלוסיג · Iclusig | סטיוורגה · Stivarga | קינלוק · Qinlock | רובראקה · Rubraca | אקספוביו · Xpovio | רטבמו · Retevmo | קוסליוגו גרנולות בכמוסה · Koselugo Granules In | קוסליוגו כמוסות קשיחות · KOSELUGO Hard | אודומזו · Odomzo | נקסבר · Nexavar | סוראפניב אס.קיי. · Sorafenib S.K. | סורפניב טבע · Sorafenib Teva | לומיקראס · Lumykras | סוניטיניב פאדאגיס · Sunitinib Padagis | סוניטיניב אס.קיי. · Sunitinib S.K | סוניטיניב סנדוז · Sunitinib Sandoz | סוניטיניב תרו · Sunitinib Taro | סוניטיניב טבע · Sunitinib Teva | סוטנט · Sutent | טלזנה · Talzenna | טפמטקו · Tepmetko | תלידומיד בי אם אס · Thalidomide Bms | לונסורף · Lonsurf | מקיניסט · Mekinist | טוקייסה · Tukysa | קפרלסה · Caprelsa | זלבוראף · Zelboraf | ונקלקסטה · Venclexta | אריוודג' · Erivedge | וורניגו · Voranigo | ברוקינסה · Brukinsa | הרנואו · Hyrnuo | הרנקסיוס · Hernexeos | קסרמלו · Xermelo | איווילפין · Iwilfin | אימנד · Emend | סטרון · Setron | אקינזאו · Akynzeo | אקסג'יבה · Xgeva | היקמטין 0.25 מ"ג · Hycamtin | וסנואיד · Vesanoid | פאלוקסי כמוסות (דנוסומאב לגרורות בעצם) · Paloxi | נבלבין 20 מ"ג · Navelbine |
| נימוק / הערה | תרופות אונקולוגיות בבליעה: רעילות גבוהה, ומחזורי הטיפול נקבעים באונקולוגיה. הרפואן מכין עם המכתב העדכני וספירת דם, והרופא/ה מאשר/ת. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול שנקבע באונקולוגיה, לפי המחזור הנוכחי. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | הנחיה עדכנית של האונקולוג/ית | מכתב או סיכום של האונקולוג/ית מ-12 החודשים האחרונים, עם אותה תרופה ומינון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ספירת דם עדכנית | ספירת דם מהחודש האחרון (בטיפול הורמונלי — לפי ההנחיה). אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 8 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 9 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 10 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **מעקב מעבדה** | ספירת דם מהחודש האחרון |
| **מקור** | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: SPS · SPS Medicines Monitoring (NHS) Medicines Monitoring |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 12.10 מדכאי חיסון להשתלה (mTOR) · Transplant immunosuppressants (mTOR) דגל אדום

מדכא חיסון

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | רפמיון · Rapamune \| רפמיון תמיסה · Rapamune Solution |
| נימוק / הערה | סירולימוס (רפמיון) ואברולימוס (סרטיקן, אפיניטור): רמה בדם ותפקוד כליות. הרפואן מכין, והרופא/ה מאשר/ת. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני במינון קבוע שנקבע ע"י מומחה/ית. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | הנחיה עדכנית של מרכז ההשתלה או המומחה/ית | מכתב או סיכום של מרכז ההשתלה או המומחה/ית מ-12 החודשים האחרונים, עם אותה תרופה ומינון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | רמת התרופה בדם | רמה אחרונה בטווח שנקבע, לפי תדירות המעקב. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 6 | תפקוד כליות | קראטינין ו-eGFR מ-3 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 9 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 10 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 11 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | רמת התרופה, קראטינין ו-eGFR |
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 12.11 תרופות למחלות נדירות · Rare metabolic / orphan drugs לפי הנחיה, בתנאים

מחלות מטבוליות ונדירות

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (56) | טריאנטין הידרוכלוריד מדומי · Trientine Hcl Medomie · טריאנטין רז · Trientine Raz · ווילנטין · Willentine · ניטיזינון דיפארמה · Nitisinone Dipharma · אורפדין · Orfadin · קובן · Kuvan · סאפרופטרין אינובמד · Sapropterin Inovamed · סאפרופטרין אס.קיי · Sapropterin S.K · ספרופטרין טבע · Sapropterin Teva · ציסטגון · Cystagon · גאלאפולד · Galafold · סרדלגה · Cerdelga · מיגלוסטאט דיפארמה · Miglustat Dipharma · מיגלוסטט ג'י.אל. · Miglustat G.L. · זבסקה · Zavesca · לוג'וקסטה · Lojuxta · אבקיזה · Evkeeza · גאטקס · Gattex · אימסיברי · Imcivree · חומצה כנודאוקסיכולית לדיאנט · Chenodeoxycholic Acid Leadiant · פירדפסה · Firdapse · רקסון אידבנון · Raxone Idebenone · טרנסלרנה · Translarna · ציסטדן · Cystadane · כולבם · Cholbam · פבוראן · Pheburane · קרניטין תמיסה · Carnitine Solution · % · אורלאדיאו · Orladeyo · טבנאוס · Tavneos · רזורוק · Rezurock · ג'ואנג'ה · Joenja · ווידיאה · Voydeya · אווריסדי · Evrysdi · סקייקלריס · Skyclarys · אקנורסה · Aqneursa · זוקינבי · Zokinvy · בילווי · Bylvay · ספיאנס · Sephience · חומצה קרגלומית ווימד · Carglumic Acid Waymade · מטופירון · Metopirone · איסטוריסה · Isturisa · קטוקונזול אסטבה 200 מ"ג · Ketoconazole Esteve · נודקסטה · Nuedexta · פירזיר · Firazyr (אנגיואדמה תורשתית) · איקיטיבנט טבע · Icatibant Teva (אנגיואדמה תורשתית) · טאקזירו · Takhzyro (אנגיואדמה תורשתית) · ברינרט · Berinert (אנגיואדמה תורשתית) · אנדמברי · Andembry (אנגיואדמה תורשתית) · קריסויטה · Crysvita · ווקסוגו · Voxzogo · ליבמרלי · Livmarli · גיבלרי · Givlaari · יורביפאט · Yorvipath · אגאמרי · Agamree · סטרנסיק · Strensiq · אינקרלקס · Increlex |
| נימוק / הערה | תרופות למחלות מטבוליות נדירות: המינון נקבע ומנוטר במרפאה המטבולית. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני במינון קבוע שנקבע ע"י מומחה/ית. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | מעקב מסודר — המרפאה המטבולית | יש ביקור (המרפאה המטבולית) בתקופה שנקבעה במעקב, ואין פער במעקב. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 12.12 פילוקרפין בבליעה ליובש בפה (סלגן, סלבקל) · Oral pilocarpine (dry mouth) לפי הנחיה, בתנאים

ראומטולוגיה · מומחה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | סלגן · Salagen \| סלבקל · Salvakal |
| נימוק / הערה | פילוקרפין (סלגן) ליובש בפה (שיוגרן, אחרי הקרנות), נקבע ע"י ראומטולוג/ית או אונקולוג/ית. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 3 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשטיפול כרוני במינון קבוע שנקבע ע"י מומחה/ית. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | הנחיה עדכנית של המומחה/ית | מכתב או סיכום של המומחה/ית מ-12 החודשים האחרונים, עם אותה תרופה ומינון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 7 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 8 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 9 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 12.13 **תרופות אנטי-זיהומיות של מומחה (פטריות, CMV, שחפת, קלוסטרידיום)** · Specialist anti-infectives

לפי הנחיה

זיהומים · מומחה

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (20)** | ואלגנציקלוביר ג'נמדיקס · Valganciclovir Genmedix | ואלגנציקלוביר טבע · Valganciclovir Teva | נוקספיל · Noxafil | פוסקונזול · Posaconazole | פוסאקונאזול אינובמד · Posaconazole Inovamed | ויפנד · Vfend | ווריקונזול טבע חדש · Voriconazole Teva New | ווריקונזול-תרימה · Voriconazole-Trima | קרסמבה · Cresemba | דיפיקליר · Dificlir | לינזו - אבניר · Linezo - Avenir | זיבוקסיד · Zyvoxid | מיקובוטין · Mycobutin | סירטורו · Sirturo | גרנופס · Granupas | ליבטנסיטי · Livtencity | פרווימיס · Prevymis | קינין סולפאט · Quinine Sulfate | קינידין סולפט · Quinidine Sulfate | אימפבידו · Impavido |
| **נימוק / הערה** | תרופות אנטי-זיהומיות של מומחה (פטריות, CMV, שחפת, קלוסטרידיום): לפי משך הטיפול ומי שקבע אותו. בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | הנחיה עדכנית של רופא/ת המחלות הזיהומיות או המומחה/ית | מכתב או סיכום של רופא/ת המחלות הזיהומיות או המומחה/ית מ-12 החודשים האחרונים, עם אותה תרופה ומינון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | משך הטיפול וקובע/ת הטיפול ידועים | מתועדים מי קבע/ה את הטיפול, ותאריך הסיום (או שזו מניעה ממושכת), והמשך לא עבר. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | בדאקווילין: אק"ג | בבדאקווילין: אק"ג מהחודש האחרון עם QTc מתחת ל-500. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | בדיקות המעקב שבמכתב המומחה בוצעו | הבדיקות שהמומחה ביקש במכתב האחרון (דם, אק"ג, אקו, עיניים ועוד) בוצעו בזמן. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **מקור** | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026); מעקב: עלון ה-FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) · עלון FDA (DailyMed) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 12.14 אזתיופרין · Azathioprine

מעקב צמוד | לפי הנחיה, בתנאים

מדכא חיסון

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | אימוראן · Imuran |
| נימוק / הערה | נקבע ע"י רופא/ה מומחה/ית. אסור עם אלופורינול או פבוקסוסטט ללא התאמת מינון בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | בדיקות מ-3 החודשים האחרונים | ספירת דם ו-ALT מ-3 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה | בבדיקה האחרונה ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה. חריג: WBC מתחת ל-3,500, נויטרופילים מתחת ל-1,600, טסיות מתחת ל-140,000 או MCV מעל 105 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-100,000 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-100,000 ← לא מחדשים | |
| 3 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה מעל 30% או eGFR מתחת ל-60 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 4 | תפקודי כבד (ALT) תקין | בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT או AST מעל 100 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: ALT מעל פי 3 מהגבול העליון ← לא מחדשים | |
| 5 | ערכי מעבדה | בבדיקות האחרונות אין: אלבומין מתחת ל-30. יש ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 6 | אין חום או זיהום מתועד | ברשומה או בפנייה אין חום, כאב גרון, פצעים בפה או זיהום. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 7 | אין היריון | אין היריון או תכנון היריון. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 8 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 9 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 10 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י רופא/ה מומחה/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 11 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 12 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 13 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 14 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 15 | בדיקות בתדירות SPS | ספירה, תפקודי כבד, קריאטינין ואלבומין מ-3 החודשים האחרונים; אלבומין מתחת ל-30 ← לרופא/ה. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ספירת דם ו-ALT כל 3 חודשים |
| ספי החזרה לרופא/ה | WBC מתחת ל-3,500, נויטרופילים מתחת ל-1,600, טסיות מתחת ל-140,000 או MCV מעל 105; ALT או AST מעל 100; קריאטינין עלה מעל 30% או eGFR מתחת ל-60; אלבומין מתחת ל-30 |
| ערך חמור | WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-100,000; ALT מעל פי 3 מהגבול העליון |
| תלונות בפנייה או ברשומה | חום או זיהום ← דחוף; חבורות או דימומים ← דחוף |
| מקור | מעקב: SPS Medicines Monitoring (NHS) · SPS Medicines Monitoring |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 12.15 מיקופנולט · Mycophenolate

מעקב צמוד | לפי הנחיה, בתנאים

מדכא חיסון

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (5) | סלספט · CellCept \| מיקופנולט טבע · Mycophenolate Teva \| מיפורטיק · Myfortic \| מיקופנוליק אסיד אינובמד · Mycophenolic Acid Inovamed \| מיקופנוליק אסיד אופק · Mycophenolic Acid Ofek |
| נימוק / הערה | נקבע ומנוטר ע"י יחידת ההשתלות או הראומטולוג/ית. התווית נגד בהיריון בדיקות שנוספו לפי מקור (SPS / עלון FDA / עלון לרופא) — אושר 9.11.2026. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | ספירת דם מ-3 החודשים האחרונים | ספירת דם מ-3 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה | בבדיקה האחרונה ספירת דם (WBC / נויטרופילים) תקינה. חריג: WBC מתחת ל-3,500, נויטרופילים מתחת ל-1,600, טסיות מתחת ל-140,000 או MCV מעל 105 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-100,000 ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה.<br>חמור: WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-100,000 ← לא מחדשים | |
| 3 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה מעל 30% או eGFR מתחת ל-60 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 4 | תפקודי כבד (ALT) תקין | בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT או AST מעל 100 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 5 | ערכי מעבדה | בבדיקות האחרונות אין: אלבומין מתחת ל-30. יש ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 6 | אין חום או זיהום מתועד | ברשומה או בפנייה אין חום, כאב גרון, פצעים בפה או זיהום. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 7 | רכישות | התרופה נרכשה לפחות ל-80% מהימים ב-6 החודשים האחרונים. פחות ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 8 | ביקורת שנתית במרפאה | המטופל/ת היה/תה בביקור במרפאה אצל רופא/ת המשפחה ב-12 החודשים האחרונים. אם לא: חידוש לחודש אחד בלבד וזימון לביקורת במרפאה. | זימון |
| 9 | טיפול כרוני במינון קבוע | תרופה זו מחודשת ע"י רפואן רק כשנקבע ע"י יחידת ההשתלות או רופא/ה מומחה/ית, אותו מינון ב-3 החודשים האחרונים. אחרת ← חידוש לחודש אחד באותו מינון והודעה לרופא/ה. | |
| 10 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 11 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |
| 12 | רצף חידושים | מאז הביקור האחרון אצל רופא/ה בוצעו פחות מ-3 חידושים רצופים ע"י רפואן. 3 ומעלה ← ביקור רופא/ה לפני החידוש הבא. | |
| 13 | החידוש השלישי ברצף<br>שאלה: זה החידוש השלישי ברצף מאז ביקור אצל רופא/ה? | בחידוש השלישי ברצף: הודעה למטופל/ת "מומלצת ביקורת אצל רופא/ת משפחה לפחות פעם בשנה". | שאלה |
| 14 | אין התווית נגד | היריון או תכנון היריון. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 15 | בדיקות בתדירות SPS | ספירה, תפקודי כבד, קריאטינין ואלבומין מ-3 החודשים האחרונים; אלבומין מתחת ל-30 ← לרופא/ה. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ספירת דם כל 3 חודשים (לפי היחידה המטפלת) |
| ספי החזרה לרופא/ה | WBC מתחת ל-3,500, נויטרופילים מתחת ל-1,600, טסיות מתחת ל-140,000 או MCV מעל 105; ALT או AST מעל 100; קריאטינין עלה מעל 30% או eGFR מתחת ל-60; אלבומין מתחת ל-30 |
| ערך חמור | WBC מתחת ל-3,000 או טסיות מתחת ל-100,000 |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | היריון או תכנון היריון |
| תלונות בפנייה או ברשומה | חום או זיהום ← דחוף; שלשולים ← לרופא |
| מקור | מעקב: SPS Medicines Monitoring (NHS) · SPS Medicines Monitoring |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

# 13. תרופות שאינן כרוניות

82 תרופות · הכנה לאישור רופא/ה: 69 · רופא/ה בלבד: 2 · לפי הנחיה: 11 · גרסה 2 · חלוקה לפי מערכות · 2.11.2026

מקורות: הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020; ACOG 2023 (סיכום AFP). שאר התחומים: החלטה מקומית

## 13.א כללים

- כל בקשה בלשונית זו מוכנה ע"י הרפואן לאישור הרופא/ה, מלבד פריטים שמסומנים "ביצוע לפי הנחיית הרופא/ה"
- מתחת לגיל 18 ← לרופא/ה (מינון לפי משקל)
- הרפואן לא שואל שאלות רפואיות חדשות: בודק רשומה ופנייה. סימן אזהרה בפנייה ← הודעה דחופה לרופא/ה
- תכשיר עם ריכוז אחר, אריזה גדולה או בקשה חוזרת תכופה ← לרופא/ה
- בקשה להמרת מרשם שנכתב בכתב יד: מציגים לרופא/ה לפענוח. לא מפענחים ולא מקלידים לבד.
- הסיכום לרופא/ה: איפה תועד, תאריך, שם הרופא/ה ותפקידו/ה, האבחנה וההמלצה
- נוגדי דלקת חזקים: לבדוק כיב קיבה בעבר ותפקוד כליות. טרבינפין: ALT לפני ואחרי חודש
- משחה סטרואידלית: לא לשימוש כרוני; כשמאושרת — ההוראה הקבועה נכנסת להודעה למטופל/ת
- דגל אדום: הרפואן מכין לפי רשימת הבדיקות, והרופא/ה בודק/ת שוב לפני האישור — גם כשהכול תקין

## 13.ג בדיקות משותפות

| שלב | נושא | מה בודקים | קריטריון | אם לא מתקיים | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| לפני כל חידוש | בדיקת מעקב | לפי התרופה | שומנים: LDL; לבותירוקסין: TSH; אלופורינול/פבוקסוסטט: חומצה אורית — מ-12 החודשים האחרונים | אין ← חידוש לחודש + זימון לבדיקה | הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52; החלטה כללי-1 |
| לפני כל חידוש | ערך המעקב | לעומת הבדיקה הקודמת או היעד | LDL לא עלה ב-30% ומעלה; TSH בטווח המעבדה; חומצה אורית מתחת ל-6 | לא ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה | החלטות כללי-4-2 |
| החזרה מיידית לרופא | דימום | מופיע בפנייה או ברשומה (נוגדי טסיות) | צואה שחורה, דם בצואה, דימום משמעותי | דחוף - לרופא עכשיו | החלטה כללי-5 |
| החזרה מיידית לרופא | חולשת שרירים | מופיע בפנייה או ברשומה (סטטין) | חולשה או כאבי שרירים עם שתן כהה | דחוף - לרופא עכשיו | הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 51 |

## 13.ד החלטות

| # | נושא | מה ההנחיה אומרת | ההחלטה לפרוטוקול | סוג | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| כללי-1 | בדיקות מעקב | שומנים: פרופיל 4-12 שבועות אחרי התחלה, אחר כך כל 6-12 חודשים (ההנחיה הישראלית 2020; ESC/EAS 2019). TSH בלבותירוקסין: שנתי כשמאוזן (NICE NG145). חומצה אורית בטיפול מוריד: יעד <6, בדיקה תקופתית (ACR 2020) | LDL, TSH וחומצה אורית מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש + זימון | החלטה מקומית (הצעה) | הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52; ESC/EAS 2019; NICE NG145; ACR 2020 |
| כללי-2 | LDL לעומת הבדיקה הקודמת | עלייה לא מוסברת ← לברר היענות וסיבות שניוניות; היעד לפי דרגת הסיכון | עלייה של 30% ומעלה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. היעד האישי בידי הרופא/ה | החלטה מקומית (הצעה) | הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 עמ' 52 |
| כללי-5 | נוגדי טסיות | אספירין 75-100 מ"ג למניעה שניונית; משך DAPT לפי הקרדיולוג; שילוב עם נוגד קרישה מעלה דימום ומוגבל לתקופה מוגדרת | אספירין 75-100 מ"ג בלבד. נוגד קרישה במקביל ← הודעה. דימום ← התווית נגד. קלופידוגרל רק כטיפול כרוני לטווח ארוך | החלטה מקומית (הצעה) | ESC CCS 2024; ESC ACS 2023 |
| כללי-6 | מעכבי משאבת פרוטונים | טיפול ממושך דורש התוויה מתועדת; בלי התוויה — לנסות הפחתה או הפסקה | נדרשת התוויה מתועדת לטיפול ממושך. אין ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה לשקול הפחתה | החלטה מקומית (הצעה) | AGA 2022 |

| # | נושא | מה ההנחיה אומרת | ההחלטה לפרוטוקול | סוג | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| כללי-7 | אלופורינול ופבוקסוסטט | יעד חומצה אורית <6 mg/dL; התחלה במינון נמוך והתאמה לכליות; פריחה ← הפסקה מיידית (סיכון SJS/DRESS) | חומצה אורית ≥6 ← הודעה. אלופורינול: eGFR <30 ← הודעה (מינון). פריחה ← התווית נגד, דחוף | החלטה מקומית (הצעה) | ACR 2020; תווית FDA |
| כללי-9 | ביספוספונטים | להפסיק אחרי 5 שנים טיפול פומי בסיכון שאינו גבוה; עד 10 שנים בסיכון גבוה. אסור ב-eGFR ≤35 | 5 שנות טיפול ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. eGFR <35 ← ערך חמור | הנחיה | ACOG 2023 (סיכום AFP) עמ' 102-101 |
| כללי-11 | מעכבי PCSK9 (רפאטה, פראלואנט) | בסל באינדיקציות מצומצמות; רוב המטופלים דרך שב"ן או ביטוח. סבילות טובה, תגובה מקומית | בתנאים: אישור מימון בתוקף וטיפול כרוני; מעקב LDL כמו בסטטין. אין אישור ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה | החלטה מקומית (הצעה) | הנחיות ישראליות לטיפול בדיסליפידמיה 2020 (פרק מעכבי PCSK9) |
| כללי-12 | תרופות כרוניות נוספות (2) | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי). SSRI/SNRI: היפונתרמיה בקשישים | בזאפיברט, גבפנטין, פרגבלין, SSRI/SNRI (נתרן בגיל 65+), מעכבי ארומטאז, טמוקסיפן, רלוקסיפן, טרבינפין ואיטרקונזול (קורס): לפי הרשימה של כל תרופה | החלטה מקומית (הצעה) | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| כללי-13 | חידוש ע"י רופא/ה בלבד | רואקוטן: מרשם ע"י רופא/ת עור בלבד ותוכנית מניעת היריון (משרד הבריאות; EMA) | רואקוטן (רופא/ת עור בלבד), אנטיביוטיקה לתסמין חדש ותרופות נגד שפעת: הכלי מציג הודעה ולא רשימת בדיקות | החלטה מקומית | משרד הבריאות; EMA |
| כללי-14 | הורמונים לנשים | NAMS 2022: אסטרוגן מערכתי עם רחם ← פרוגסטוגן; דימום לא סדיר ← בירור; התוויות נגד: סרטן שד, פקקת, אוטם/שבץ, מחלת כבד | אסטרוגן בלי פרוגסטוגן כשיש רחם ← הודעה; דימום ← הודעה דחופה; ממוגרפיה לפי התוכנית; ל"ד שנתי. אמצעי מניעה משולב: ל"ד מתחת ל-140/90, עישון בגיל 35+, מיגרנה עם הילה ופקקת = התווית נגד | הנחיה + החלטה מקומית | NAMS 2022; נייר העמדה הישראלי לטיפול הורמונלי (בפרויקט) |
| כללי-15 | שלפוחית רגיזה ו-PDE5 | אנטי-כולינרגיים חזקים — להימנע בקשישים (Beers 2023). מירבגרון: אסור ב-ל"ד ≥180/110, זהירות מעל 160/100 (עלון). PDE5 + ניטרטים — התווית נגד (תווית) | אנטי-כולינרגיים: גיל 75+ ← אישור רופא/ה; אצירת שתן ← דחוף. מירבגרון: ל"ד מתחת ל-160/100. PDE5: ניטרטים = התווית נגד | החלטה מקומית (הצעה) | Beers 2023; עלונים |
| כללי-16 | ברזל, B12, חומצה פולית | ברזל: אחרי תיקון האנמיה ממשיכים כ-3 חודשים לחידוש המאגרים, ואז ספירה תקופתית (BSG 2021). B12 בטיפול שימורי: אין בדיקת רמה שגרתית אלא בתסמינים (NICE NG239, 2024) — הרמה השנתית בפרוטוקול מחמירה | ברזל: ספירת דם ופריטין מ-6 חודשים; טיפול מעל 6 חודשים בלי התוויה ← הודעה. B12: רמה שנתית | החלטה מקומית (הצעה) | BSG 2021; NICE NG239 |
| כללי-17 | קרדיולוגיה | טיקגרלור/פרסוגרל: DAPT כ-12 חודשים אחרי ACS (ESC 2023). פלקאיניד/פרופפנון: אסורים במחלה לבבית מבנית (ESC AF 2024). דרונדרון: תפקודי כבד בחודשים הראשונים (תווית) | טיקגרלור ופרסוגרל: לפי משך שנקבע; נוגד קרישה במקביל ← דחוף. פלקאיניד, פרופפנון, דרונדרון: אק"ג שנתי ושלילת מחלה מבנית. אנטרסטו: בפרוטוקול יל"ד | החלטה מקומית (הצעה) | ESC ACS 2023; ESC AF 2024; תווית |
| כללי-20 | השלמות מהמאגר (2.11.2026) | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) | טרזוסין, פינסטריד, אינקליסירן, ורדנאפיל, טיפות לגלאוקומה (ביקורת עיניים שנתית; טימולול: דופק ואסתמה), NSAID ממושך (כליות, אשלגן, ל"ד, דימום, הגנת קיבה), אנטיהיסטמינים, ציננריזין, דומפרידון, מבברין, סידן, מידודרין, פנטוקסיפילין, דיפירידמול, ולציקלוביר מונע, חומצה זולדרונית | החלטה מקומית (הצעה) | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| כללי-21 | תרופות מומחה נוספות | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי). הטיפול נקבע ומנוטר ע"י המומחה | מטוקלופרמיד ממושך, ממריצים/מודפיניל, טרשת נפוצה, אונקולוגיה, יל"ד ריאתי/IPF, סירולימוס, הורמון גדילה, המטולוגיה, CF, טפמידיס/מבקמטן: הודעה בלבד, חידוש ע"י רופא/ה. תרופות ביולוגיות בזריקה בקהילה: הרפואן מכין (אישור, מכתב מומחה, מרווח, בטיחות) והרופא/ה מאשר/ת (5.11.2026) | החלטה מקומית | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |

| # | נושא | מה ההנחיה אומרת | ההחלטה לפרוטוקול | סוג | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| כללי-22 | השלמות 2 מהמאגר (2.11.2026) | לפי עלון/תווית כל תרופה — הקישור למקור בכרטיס התרופה (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) | ויטמין D, בטאהיסטין, חומצה במפדואית, אומגה 3/איקוזפנט, ציפרופיברט, וריסיגואט, ניטרוגליצרין תת-לשוני, פזולינטנט/אלינזנטנט (ALT), דואביב, אינטראזוסה, סיאנה, אורליסטט, פרוקלופריד, משלשלים, טטרציקלינים ממושכים, מניעת זיהומי שתן, משככי כאב ממושכים, ביקרבונט. עודכן ב-7.11.2026: אין עוד "רופא/ה בלבד" בקבוצה זו — ראו החלטת הסקירה | החלטה מקומית (הצעה) | עלוני התרופות (SPS, DailyMed, עלון ישראלי) |
| סקירה-1 | סקירת פריטים חסומים (7.11.2026) | נושא תפעולי — הנחיות קליניות לא עוסקות בו; מבוסס על נוהל הרפואן | אף תרופה לא חסומה כברירת מחדל. 59 הפריטים שהיו "רופא/ה בלבד" נסקרו אחד-אחד: חלקם פתוחים עם רשימת בדיקות, חלקם בדגל אדום (בדיקה כפולה מול הרופא/ה). נשארים אצל הרופא/ה: רואקוטן, אנטיביוטיקה לתסמין חדש (מלבד מוקסיפן/רפאפן אחרי משטח גרון חיובי) ותרופות נגד שפעת. התראת האינטראקציות של המערכת היא שכבת ההגנה הבסיסית. | החלטה מקומית (7.11.2026) | - |

## 13.ה רשימת התרופות (לסימון)

| # | שם | גנרי | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.1 | טרבינפין (טבליות) | Terbinafine (oral) | נוגד פטרת (קורס) | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.2 | נוגדי דלקת חזקים (במרשם) | NSAIDs (strong, prescription) | NSAID | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.3 | תרופה שאינה ברשימה הקבועה | Drug not on the chronic list | כל תרופה שלא רשומה כתרופה קבועה | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.4 | טיפות עיניים עם סטרואיד | Steroid eye drops | סטרואיד מקומי לעין | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.5 | משחות וקרמים עם סטרואיד | Topical steroids | סטרואיד מקומי לעור | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.6 | תרסיס מכווץ כלי דם לאף | Nasal decongestant spray | קורס קצר · צינון ואף | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.7 | תרסיס סטרואידי לאף (עונתי) | Intranasal corticosteroid (seasonal) | קורס קצר · אלרגיה ואף | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.8 | אזלסטין — תרסיס אנטיהיסטמיני לאף | Azelastine nasal spray | קורס קצר · אלרגיה ואף | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.9 | אנטיהיסטמין מרדים (דור ראשון) | Sedating antihistamine | קורס קצר · אלרגיה וצינון | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.10 | תכשירים לשיעול (דקסטרומתורפן, גואיפנזין) | Cough preparations | קורס קצר · שיעול | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.11 | תכשירי צינון ושפעת משולבים (פסאודואפדרין, פנילאפרין) | Cold and flu combinations (decongestant) | קורס קצר · צינון ושפעת | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |

| # | שם | גנרי | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12 | תכשירים לכאב גרון (לכסניות ותרסיסים) | Throat lozenges and sprays | קורס קצר · גרון | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.13 | פרצטמול — קורס קצר | Paracetamol (short course) | קורס קצר · כאב וחום | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.14 | איבופרופן / נפרוקסן / אספירין — קורס קצר | Ibuprofen / naproxen (short course) | קורס קצר · כאב וחום | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.15 | דיפירון (אופטלגין) — קורס קצר | Dipyrone (short course) | קורס קצר · כאב וחום | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.16 | ג'ל נוגד דלקת (וולטרן ודומיו) | Topical NSAID gel | קורס קצר · כאב שרירים ומפרקים | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.17 | נוגדי חומצה ואלגינטים (גביסקון, מאלוקס) | Antacids and alginates | קורס קצר · עיכול | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.18 | מעכבי חומצה — קורס קצר (אומפרזול ודומיו, פמוטידין) | Acid suppression (short course) | קורס קצר · עיכול | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.19 | לופרמיד (אימודיום) | Loperamide | קורס קצר · שלשול | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.20 | ביסמות סובסליצילט (קלבטן, ביטני) | Bismuth subsalicylate | קורס קצר · שלשול וקלקול קיבה | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.21 | משלשלים אוסמוטיים (לקטולוז, PEG) | Osmotic laxatives | קורס קצר · עצירות | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.22 | משלשלים ממריצים ופתילות (ביסקודיל, סנה, גליצרין) | Stimulant laxatives and suppositories | קורס קצר · עצירות | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.23 | סימתיקון (גזים) | Simethicone | קורס קצר · עיכול | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.24 | נוגדי עוויתות למעי רגיש ידוע (קולוטאל, קולפרמין) | Mebeverine (known IBS) | קורס קצר · עיכול | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.25 | תכשירים לטחורים (פרוקטו-גליבנול, רקטוצורין) | Haemorrhoid preparations | קורס קצר · טחורים | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.26 | קרם נגד פטרת (קלוטרימזול, מיקונזול, טרבינפין) | Topical antifungals | קורס קצר · עור — פטרת | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.27 | שמפו נגד פטרת (קטוזול, אגיספור) | Antifungal shampoo | קורס קצר · עור — פטרת | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.28 | לכה נגד פטרת ציפורניים (לוסריל, פונגינייל) | Antifungal nail lacquer | קורס קצר · עור — פטרת | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |

| # | שם | גנרי | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.29 | משחה אנטיביוטית (פוסידין, בקטרובן) | Topical antibiotics | קורס קצר · עור — זיהום | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.30 | קרם אציקלוביר (זובירקס) — פצעי קור | Aciclovir cream | קורס קצר · עור — הרפס | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.31 | אציקלוביר / ולציקלוביר בטבליות — התקף של הרפס ידוע | Oral aciclovir / valaciclovir (known recurrent herpes) | קורס קצר · הרפס חוזר | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.32 | טיפול בגרדת (לייקליר) | Scabies treatment | קורס קצר · עור — טפילים | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.33 | משחות לכוויות ופצעים (סילברול, בפנטן פלוס) | Burn and wound creams | קורס קצר · עור — כוויות ופצעים | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.34 | חיטוי עור ופה (כלורהקסידין, פולידין) | Skin and mouth antiseptics | קורס קצר · עור — חיטוי | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.35 | תכשירים לגרד מקומי (קלמין, פניסטיל ג'ל, צינק) | Antipruritic lotion | קורס קצר · עור — גרד | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.36 | טיפול מקומי באקנה (בנזק, אפידו, דואק) | Topical acne treatment | קורס קצר · עור — אקנה | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.37 | טיפול ביבלות (סלאטק) | Wart treatment | קורס קצר · עור — יבלות | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.38 | הרדמה מקומית לפני פעולה (אמלה, LMX4, עזרקאין) | Local anaesthetic cream (before a procedure) | קורס קצר · עור — לפני פעולה | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.39 | דמעות מלאכותיות | Artificial tears | קורס קצר · עיניים | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.40 | טיפות עיניים נגד אלרגיה (אופטילסט, אולופטדין) | Antiallergic eye drops | קורס קצר · עיניים | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.41 | הכנה לקולונוסקופיה (מרוקן, מוביפרפ, פיקו סלקס) | Bowel preparation before colonoscopy | קורס קצר · לפני בדיקה | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.42 | פרה-מדיקציה לפני בדיקה עם חומר ניגוד (רגישות ידועה) | Premedication before contrast imaging | קורס קצר · לפני בדיקה | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.43 | אנטיביוטיקה מונעת לפני טיפול שיניים | Antibiotic prophylaxis before dental treatment | קורס קצר · לפני טיפול | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.44 | תחליפי ניקוטין (מדבקות, מסטיק, לכסניות, תרסיס) | Nicotine replacement therapy | קורס קצר · גמילה מעישון | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.45 | מניעת מלריה לטיול (מלרון, דוקסיציקלין) | Malaria prophylaxis (travel) | קורס קצר · לפני טיסה | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |

| # | שם | גנרי | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.46 | מניעת מחלת גבהים (אורמוקס) | Altitude sickness prevention | קורס קצר · לפני טיסה | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.47 | אנטיביוטיקה "למקרה הצורך" לשלשול מטיילים | Travellers' diarrhoea standby antibiotic | קורס קצר · לפני טיסה | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.48 | מחלת תנועה (טרבמין) | Motion sickness | קורס קצר · לפני טיסה | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.49 | אנטיביוטיקה לתסמין חדש | Antibiotics for a new symptom | רופא/ה בלבד · אנטיביוטיקה | רופא/ה בלבד | ☐ | |
| 13.50 | מוקסיפן או רפאפן אחרי משטח גרון חיובי | Penicillin for positive strep test | אנטיביוטיקה · דלקת גרון | לפי הנחיה | ☐ | |
| 13.51 | תרופות נגד שפעת (טמיפלו, קסופלוזה, רלנזה) | Oseltamivir | רופא/ה בלבד · נגד שפעת | רופא/ה בלבד | ☐ | |
| 13.52 | גלולה ליום שאחרי (פוסטינור, אלה) | Emergency contraception | דחוף באותו יום | דגל אדום | ☐ | |
| 13.53 | טיפול בפטרת או בזיהום נרתיקי (פלוקונזול, אגיסטן V, זידובל) | Vaginal and oral antifungals | נשים | לפי הנחיה | ☐ | |
| 13.54 | טיפול בפטרת בפה (דקטרין ג'ל, ניסטטין) | Oral thrush treatment | פה | לפי הנחיה | ☐ | |
| 13.55 | טיפות אנטיביוטיות לעיניים, וטיפות לאוזניים | Antibiotic eye and ear drops | עיניים ואוזניים | לפי הנחיה | ☐ | |
| 13.56 | קורס סטרואידים בבליעה (פרדניזון, מדרול) | Oral corticosteroid course | סטרואידים | דגל אדום | ☐ | |
| 13.57 | תרופות נגד בחילה (אונדנסטרון) | Anti-nausea drugs | בחילות | לפי הנחיה | ☐ | |
| 13.58 | מדללי ליחה (אצטילציסטאין, קרבוציסטאין, ברומהקסין) | Mucolytics | קורס קצר · שיעול | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.59 | תכשירי צמחים לשיעול ולסינוסים (ברונכיקליר, קלובה, סינוקליר) | Herbal cough and sinus preparations | קורס קצר · שיעול וסינוסים | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.60 | תכשירים לאפטות ולכאב בפה (אורקורט, טיג'ל) | Mouth ulcer and gum preparations | קורס קצר · פה | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.61 | טיפות עיניים נגד אודם (טטריזולין) | Decongestant eye drops | קורס קצר · עיניים | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.62 | עזרי שינה ללא מרשם (דוקסילמין, ולריאן) | Sleep aids (non-prescription) | קורס קצר · שינה | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.63 | תרופות נגד תולעים (ורמוקס, אסקזול) | Anthelmintics | קורס קצר · טפילים | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.64 | קרם קפסאיצין (זוסטריקס) | Capsaicin cream | קורס קצר · כאב מקומי | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |

| # | שם | גנרי | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.65 | משחות מחממות וצמחים לכאב שרירים (טראומפלנט, בנגיי, טייגר באלם) | Comfrey and herbal topical pain | קורס קצר · כאב מקומי | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.66 | תוספים לשחיקת סחוס (גלוקוזאמין, דיאצרין) | Osteoarthritis supplements | קורס קצר · מפרקים | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.67 | הזעת יתר (אנהידרול פורטה) | Hyperhidrosis | קורס קצר · עור | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.68 | טיפול בנשירת שיער (מינוקסידיל, פרופסיה) | Minoxidil (hair loss) | קורס קצר · עור | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.69 | תכשירי צמחים לגיל המעבר ולתסמונת קדם-וסתית | Menopause and PMS herbal products | קורס קצר · בריאות האישה | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.70 | תכשירי צמחים לערמונית ולדרכי השתן (פרמיקסון, קנפרון) | Herbal urology preparations | קורס קצר · דרכי שתן | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.71 | גינקו בילובה (צרבונין, טבוקן) | Ginkgo biloba | קורס קצר · תוספי צמחים | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.72 | תכשירים לאי-ספיקה ורידית (ונורוטון) | Venotonics | קורס קצר · כלי דם | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 13.73 | פקסלוביד (קורונה) | Paxlovid | קורונה | דגל אדום | ☐ | |
| 13.74 | פנזופירידין (סדורל) | Phenazopyridine | דרכי שתן | לפי הנחיה | ☐ | |
| 13.75 | חומצה טרנקסמית (הקסאקפרון) | Tranexamic acid | דימום | לפי הנחיה | ☐ | |
| 13.76 | מיזופרוסטול ומיפפריסטון (ציטוטק, מיפג'ין) | Misoprostol | הכנה לרופא/ה | דגל אדום | ☐ | |
| 13.77 | תרופות בהזרקה לטיפול מיידי במרפאה (כאב, בחילה, אלרגיה) | Clinic injections for immediate treatment | הזרקה במרפאה | דגל אדום | ☐ | |
| 13.78 | אימונוגלובולין לטטנוס (היפרטט) | Tetanus immunoglobulin | אימונוגלובולינים | לפי הנחיה | ☐ | |
| 13.79 | Anti-D בהיריון (רופילאק, Rho-D) | Anti-D immunoglobulin | אימונוגלובולינים | לפי הנחיה | ☐ | |
| 13.80 | היפריקום (רמוטיב) | St John's wort | צמחים | לפי הנחיה | ☐ | |
| 13.81 | טיפול בפיסורה (רקטוג'סיק, אנטרולין) | Anal fissure treatment | פיסורה | לפי הנחיה | ☐ | |
| 13.82 | תכשירי טרפנים לאבנים בדרכי השתן ובדרכי המרה (רווהטינקס, רווהכול) | Terpene preparations (urinary / biliary) | קורס קצר · כליות ודרכי מרה | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |

## 13.ו פירוט מלא

### 13.1 **טרבינפין (טבליות)** · Terbinafine (oral) הכנה לאישור רופא/ה

נוגד פטרת (קורס)

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (6) | טרבינאפין טבע · Terbinafine Teva | טרבינא טבע · Terbina Teva | דרמסיל · Dermasil | מדוסיל · Medosil | פטיר · Patir (לוודא טבליות) | טרקלרה · Terclara (לוודא טבליות) |
| נימוק / הערה | קורס בלבד: עד 12 שבועות בציפורני רגליים, 6 שבועות בציפורני ידיים. ALT לפני הטיפול ואחרי חודש. האישור בידי הרופא/ה. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | ALT לפני הטיפול ואחרי חודש | ALT לפני תחילת הקורס ואחרי חודש טיפול. חסר ← זימון לבדיקה. | זימון |
| 2 | תפקודי כבד (ALT) תקין | בבדיקה האחרונה תפקודי כבד (ALT) תקין. חריג: ALT מעל פי 2 מהגבול העליון ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 3 | בתוך משך הקורס | סך הטיפול עד 12 שבועות (ציפורני רגליים) או 6 שבועות (ידיים). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | אין התוויות נגד | מחלת כבד פעילה. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | ALT לפני הטיפול |
| ספי החזרה לרופא/ה | ALT מעל פי 2 מהגבול העליון |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | מחלת כבד פעילה |
| תלונות בפנייה או ברשומה | צהבת, שתן כהה או חולשה ← דחוף - הפסקה; אובדן טעם ← לרופא; פריחה ← לרופא |
| מקור | מעקב: תפקודי כבד לפני התחלה; הפסקה בתסמיני פגיעה כבדית (תווית FDA) · DailyMed (תווית FDA) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.2 נוגדי דלקת חזקים (במרשם) · NSAIDs (strong, prescription) הכנה לאישור רופא/ה

NSAID

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (21) | אביטרן טבע · Abitren Teva | בטרן SR · Betaren SR | קטאפלם · Cataflam | אולפן · Olfen | נקסין · Naxyn | נרוסין · Narocin | נפרוסן · Naprocen | פוינט · Point | ארקוקסיה · Arcoxia | ארקו-טבע · Arco-Teva | אטוריקוקסיב דקסל · Etoricoxib Dexcel | אטוריקוקסיב תרו · Etoricoxib Taro | אטוריקוקסיב סנדוז · Etoricoxib Sandoz | סלקוקס · Celcox | אתופן · Etopan | אתופן XL · Etopan XL | ברקסין טבליות · Brexin Tablets | ברקסין שקיות · Brexin Sachets | אקסיפן · Exipan | נוקסיקם · Noxicam | מסוליד 100 · Mesulid 100 |
| נימוק / הערה | לא תרופה כרונית: האישור בידי הרופא/ה. לפני ההצגה הרפואן בודק כיב קיבה בעבר ותפקוד כליות. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין כיב קיבה או דימום בעבר | ברשומה אין כיב פפטי או דימום ממערכת העיכול. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | קריאטינין מתועד | קריאטינין/eGFR ואשלגן מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 3 | אשלגן (K) תקין | בבדיקה האחרונה אשלגן (K) תקין. חריג: K מעל 5.0 ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. חמור: K 5.5 ומעלה ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. חמור: K 5.5 ומעלה ← לא מחדשים | |
| 4 | תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין | בבדיקה האחרונה תפקוד כליות (קריאטינין / eGFR) תקין. חריג: קריאטינין עלה ב-30% ומעלה ← חידוש לחודש + הודעה לרופא/ה. | |
| 5 | מדידת ל"ד מתועדת | מדידת ל"ד מ-12 החודשים האחרונים. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 6 | ל"ד מתחת ל-140/90 | מדידת ל"ד אחרונה מתחת ל-140/90. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 7 | אין נוגד קרישה במקביל | ברשימת התרופות אין נוגד קרישה (קומדין, אליקוויס, קסרלטו, פרדקסה). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 8 | אין דימום מתועד | ברשומה או בפנייה אין צואה שחורה, דם בצואה או דימום משמעותי. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה דחופה לרופא/ה. | |
| 9 | הגנה על הקיבה שאלה: גיל 65 ומעלה, כיב בעבר או אספירין/סטרואיד במקביל? | מעכב משאבת פרוטונים ברשימת התרופות. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | שאלה |
| 10 | אין התווית נגד | אי-ספיקת לב; כיב פעיל או דימום ממערכת העיכול; eGFR מתחת ל-30. התווית נגד ← לא מחדשים, הודעה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 11 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 12 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מעקב מעבדה | קריאטינין ואשלגן שנתי; ל"ד |
| ספי החזרה לרופא/ה | K מעל 5.0; קריאטינין עלה ב-30% ומעלה |
| ערך חמור | K 5.5 ומעלה |
| מצבים שמוציאים מהפרוטוקול | אי-ספיקת לב; כיב פעיל או דימום ממערכת העיכול; eGFR מתחת ל-30 |
| תלונות בפנייה או ברשומה | צואה שחורה או הקאה דמית ← דחוף; בצקות או קוצר נשימה ← לרופא; כאב בחזה ← דחוף |
| מקור | מעקב: אזהרה מודגשת לסיכון קרדיווסקולרי ודימום במערכת העיכול; בשימוש ממושך — כליות ול"ד (תווית FDA) · DailyMed (תווית FDA) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 13.3 תרופה שאינה ברשימה הקבועה · Drug not on the chronic list

הכנה לאישור רופא/ה

כל תרופה שלא רשומה כתרופה קבועה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (7) | תרופה נוספת \| תרופה לא קבועה \| המלצת יועץ \| מכתב שחרור \| המרת מרשם \| תכשיר גנרי \| החלפה לגנרי |
| נימוק / הערה | כל תרופה שאינה ברשימה הקבועה (כולל המלצת יועץ/ת, מכתב שחרור, המרת מרשם או מעבר לגנרי) מוצגת לרופא/ה לפני שמתחילים. הרפואן מכין סיכום: איפה תועד, תאריך, שם הרופא/ה ותפקידו/ה, האבחנה וההמלצה. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מקור מתועד להמלצה | ביקור, מכתב יועץ/ת או סיכום אשפוז שבו הומלצה התרופה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | פרטי המקור נרשמו | תאריך, שם הרופא/ה ותפקידו/ה, האבחנה וההמלצה — נרשמו בביקור. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | לא כמות גדולה של תרופות חדשות | הבקשה כוללת תרופה אחת או שתיים. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 4 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 5 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| תלונות בפנייה או ברשומה | בקשה לתרופה בלי מקור מתועד ← שיחה עם המטופל/ת או בקשה למסמך, ואז לרופא/ה |
| מקור | ספר חפיפה עוזרי רופא; החלטה מקומית (3.11.2026) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 13.4 טיפות עיניים עם סטרואיד · Steroid eye drops

הכנה לאישור רופא/ה

סטרואיד מקומי לעין

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (10) | פרד פורטה · Pred Forte \| אף-אם-אל ליקויפילם · FML Liquifilm \| לוטמקס · Lotemax \| מקסיטרול · Maxitrol (עם אנטיביוטיקה) \| סטרודקס · Sterodex \| דקסאקורט פורטה · Dexacort Forte \| דתאמיצין · Dethamycin (עם אנטיביוטיקה) \| זיילט · Zylet (עם אנטיביוטיקה) \| אפלומיצין · Aflumycin \| תריאולון · Threolone |
| נימוק / הערה | טיפול ממושך ללא השגחה מעלה לחץ תוך-עיני. רק כשרופא/ת עיניים קבע/ה טיפול לתקופה ארוכה; אחרת — המלצה חדשה מרופא/ת העיניים. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | קבוע ע"י רופא/ת עיניים לתקופה ארוכה | סיכום רופא/ת עיניים שקובע טיפול ממושך, ומשך הטיפול לא עבר. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | ביקורת עיניים מתועדת | ביקור אצל רופא/ת עיניים בתקופה שנקבעה במעקב. אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 3 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 4 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| תלונות בפנייה או ברשומה | כאב עין, ירידה בראייה או אודם ← דחוף - רופא/ת עיניים |
| מקור | ספר חפיפה עוזרי רופא; החלטה מקומית (3.11.2026) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.5 משחות וקרמים עם סטרואיד · Topical steroids

הכנה לאישור רופא/ה

סטרואיד מקומי לעור

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (26) | דרמובט · Dermovate \| קלובטאזול-תרימה · Clobetasol-Trima \| בטאקורטן · Betacorten \| בטנובט · Betnovate \| דיפרוג'נטה · Diprogenta (עם אנטיביוטיקה) \| דיפרוסאליק · Diprosalic \| אלוקום · Elocom \| אדוונטן · Advantan (לאימות) \| נרידרם · Neriderm \| טבעדרם · Tevaderm \| דקטקורט · Daktacort (עם נוגד פטרת) \| הידרואגיסטן · Hydroagisten \| דרמקומבין · Dermacombin \| ציקלודרם C · Cicloderm C \| דייבובט · Daivobet (עם קלציפוטריול) \| בטאקלציפ טבע · Betacalcip Teva \| טרידרם קרם · Triderm Cream \| קלוטריזון · Clotrisone \| פוסיקורט קרם · Fucicort Cream \| קומאגיס קרם · Comagis Cream \| בטריאן משחה · Betrien Ointment \| אנסטילר · Enstilar \| קסמיאול · Xamiol \| סורל קומבו ® · Sorel Combo \| היקומיצין · Hycomycin \| תריול · Tariol (קלציפוטריול, בלי סטרואיד) |
| נימוק / הערה | שימוש ממושך עלול לגרום לדילול ופגיעה בעור. לא לשימוש כרוני. כשמרשם מאושר — הוראה קבועה למטופל/ת. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | לא שימוש כרוני | לפי הרכישות: אין שימוש רצוף ממושך באותה משחה. לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 2 | אזור הטיפול ידוע | ידוע על איזה אזור מורחים (פנים או קפלי עור — זהירות מיוחדת). לא ← חידוש לחודש אחד והודעה לרופא/ה. | |
| 3 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 4 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| תלונות בפנייה או ברשומה | דילול עור, פצעים או החמרה ← לרופא |
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | הוראות שימוש במשחה או בקרם עם סטרואיד:<br>• למרוח שכבה דקה על האזור הפגוע בלבד, פעם או פעמיים ביום.<br>• לא יותר משבועיים ברציפות, אלא אם הרופא הנחה אחרת.<br>• לשטוף ידיים אחרי המריחה.<br>אזהרות:<br>• אין למרוח על הפנים, סביב העיניים, על איברי המין, בקפלי העור או מתחת לחבישה, אלא אם הרופא הנחה זאת.<br>• אין למרוח על עור פצוע או מזוהם (מוגלה, פטרת, הרפס).<br>• שימוש ממושך עלול לגרום לדילול העור, לסימני מתיחה, לכלי דם נראים, ולהחמרה כשמפסיקים בבת אחת.<br>• המשחה מיועדת רק לך: אין להעביר לאחרים, ובמיוחד לא לילדים.<br>• אם אין שיפור תוך שבוע, או שמופיעים גירוי, דילול עור, פצעים או החמרה, יש לפנות לרופא. |
| מקור | ספר חפיפה עוזרי רופא; החלטה מקומית (3.11.2026) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.6 תרסיס מכווץ כלי דם לאף · Nasal decongestant spray הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · צינון ואף

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (10) | אף-קאר · Af-Care | אלרין חדש · Alrin New | אוטריוין · Otrivin | אוטריוין קומפליט · Otrivin Complete | אוטריוין מנטול · Otrivin Menthol | אוטריוין ג'ל לאף · Otrivin Nasal Gel | קסילוויט % · Xylovit | אף טיפה · Af Tipa | אלרין AF טבע · Alrin Af Teva | ויברוסיל מיקרודוזר · Vibrocil Microdoser |
| נימוק / הערה | לגודש באף בצינון. שימוש מעבר ל-5–7 ימים גורם לגודש חוזר (ריניטיס מתרופות). |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | לא בהיריון ולא מניקה | אין היריון או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | אין גלאוקומה עם זווית סגורה | ברשומה אין גלאוקומה עם זווית סגורה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | משך וכמות בגבולות | עד 7 ימים, אריזה אחת. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין חום מעל 3 ימים, כאב חזק בפנים או בשיניים, נזלת מעל 10 ימים, דימום מהאף, קוצר נשימה או צפצופים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| תלונות בפנייה או ברשומה | שימוש רצוף מעל שבוע ← לרופא/ה: חשד לגודש מתרופה |
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | 2–1 התזות בכל נחיר עד 3 פעמים ביום, לא יותר מ-7 ימים ברציפות. שימוש ממושך גורם לגודש חוזר. אם יש חום מעל 3 ימים, כאב בפנים או דימום מהאף, יש לפנות לרופא. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 13.7 תרסיס סטרואידי לאף (עונתי) · Intranasal corticosteroid (seasonal) הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · אלרגיה ואף

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (6) | אלגרו תרסיס לאף · Allegro Nasal Spray \| אבאמיס · Avamys \| פליקסרג'י תרסיס לאף · Flixergy Nasal Spray \| פליקסונז תרסיס מימי לאף · Flixonase Aqueous Nasal Spray \| ריאלטריס · Ryaltris \| סטרונאז AQ תרסיס לאף · Steronase Aq Nasal Spray |
| נימוק / הערה | לנזלת אלרגית עונתית. ההשפעה מלאה אחרי כמה ימים. כשנלקח באופן קבוע כל השנה — זה טיפול כרוני (לשונית נשימה). |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | לא בהיריון ולא מניקה | אין היריון או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | נזלת אלרגית ידועה | אבחנה של נזלת אלרגית ברשומה או טיפול דומה בעונה קודמת. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | משך וכמות בגבולות | עונה אחת (עד 3 חודשים). לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין דימום מהאף חוזר, חום, כאב בפנים, צפצופים או קוצר נשימה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התארת אינטראקציה | כל התארת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | 1–2 התזות בכל נחיר פעם ביום, לכוון לצד החיצוני של הנחיר. ההשפעה המלאה מגיעה אחרי כמה ימים. אם מופיעים דימום חוזר מהאף, חום או קוצר נשימה, יש לפנות לרופא. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 13.8 אזלסטין — תרסיס אנטיהיסטמיני לאף · Azelastine nasal spray הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · אלרגיה ואף

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | אזל-אבניר · Azel-Avenir \| אזלסטין-פוס תרסיס לאף · Azelastin - Pos Nasal Spray \| רינולסט · Rhinolast |
| נימוק / הערה | אנטיהיסטמין מקומי לנזלת אלרגית. עלול לגרום לטעם מר ולישנוניות קלה. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | לא בהיריון ולא מניקה | אין היריון או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | נזלת אלרגית ידועה | אבחנה של נזלת אלרגית ברשומה או טיפול דומה בעונה קודמת. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | משך וכמות בגבולות | עונה אחת (עד 3 חודשים). לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין דימום מהאף, חום, כאב בפנים, צפצופים או קוצר נשימה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התארת אינטראקציה | כל התארת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | התזה אחת בכל נחיר פעמיים ביום. עלול לגרום לטעם מר או לישנוניות קלה. אם אין שיפור תוך שבועיים, יש לפנות לרופא. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.9 אנטיהיסטמין מרדים (דור ראשון) · Sedating antihistamine

הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · אלרגיה וצינון

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (8) | פנרגן · Phenergan \| פרומטאזין באזי · Promethazine Basi \| פרוטיאזין · Prothiazine \| פרוטיאזין סירופ · Prothiazine Syrup \| פניסטיל טיפות · Fenistil Drops \| ברונכו די · Broncho D \| מדי-דן טיפות · Medi-Dene Drops \| טינדן טיפות · Tinden Drops |
| נימוק / הערה | מרדים ואנטיכולינרגי. להימנע בגיל 65 ומעלה (נפילות, בלבול). לא עם אלכוהול או תרופות מרדימות. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | לא בהיריון ולא מניקה | אין היריון או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | מתחת לגיל 65 | גיל מתחת ל-65 (בגיל מבוגר יותר: נפילות ובלבול). לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | אין גלאוקומה או הגדלת ערמונית | ברשומה אין גלאוקומה עם זווית סגורה, הגדלת ערמונית או אצירת שתן. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | אין תרופות מרדימות קבועות | אין בנזודיאזפינים, אופיואידים, תרופות שינה או נוגדי פסיכוזה בתרופות הקבועות. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 7 | משך וכמות בגבולות | עד 7 ימים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 8 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין קוצר נשימה, נפיחות בשפתיים או בלשון, פריחה מתפשטת או חום. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 9 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 10 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | גורם לישנוניות: לא לנהוג ולא להפעיל מכונות אחרי הנטילה, ולא לשתות אלכוהול. אם מופיעים קושר נשימה, נפיחות בשפתיים או פריחה מתפשטת, יש לפנות מיד לטיפול רפואי. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.10 תכשירים לשיעול (דקסטרומתורפן, גואיפנזין) · Cough preparations

הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · שיעול

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (7) | אלצינל סירופ · Alcinal Syrup \| קאפקס · Kuffex \| קאפסירופ · Kufsyrup \| טוסופדרין · Tussophedrine \| היסטפד אקספקטורנט סירופ · Histafed Expectorant Syrup \| פרוטיאזין אקספקטורנט סירופ · Prothiazine Expectorant Syrup \| אוקסקטין · Oxacatin (לא בסל) |
| נימוק / הערה | לשיעול בצינון. דקסטרומתורפן: סיכון לתסמונת סרוטונין עם SSRI, SNRI, טרמדול ו-MAOI. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | לא בהיריון ולא מניקה | אין היריון או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | אין SSRI, SNRI, טרמדול או MAOI (בדקסטרומתורפן) | בתרופות הקבועות אין נוגדי דיכאון סרוטונרגיים, טרמדול או MAOI. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | משך וכמות בגבולות | עד 7 ימים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין שיעול מעל 3 שבועות, שיעול דמי, קוצר נשימה, כאב בחזה, חום מעל 3 ימים או ירידה במשקל. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | לפי ההוראות שבעלון, עד שבוע. לשתות הרבה. אם השיעול נמשך מעל 3 שבועות, יש דם בכיח, קוצר נשימה או חום מעל 3 ימים, יש לפנות לרופא. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.11 תכשירי צינון ושפעת משולבים (פסאודואפדרין, פנילאפרין) · Cold and flu combinations (decongestant)

הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · צינון ושפעת

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (30) | אקמול צינון ושפעת יום · Acamol Tsinun & Shapa'At Day (עם פרצטמול, דקסטרומתורפן) \| אקמול צינון ושפעת לילה · Acamol Tsinun & Shapa'At Night (עם פרצטמול, כלורפנירמין, דקסטרומתורפן) \| אקמול צינון ליקוויג'ל ליום · Acamol Tsinun Liquigel Day (עם פרצטמול) \| אקמול צינון ליקוויג'ל לילה · Acamol Tsinun Liquigel Night (עם פרצטמול, כלורפנירמין) \| אדויל קולד & סינוס · Advil Cold & Sinus (עם איבופרופן) \| ברונכולט פלוס · Broncholate Plus (עם פרצטמול, דיפנהידרמין) \| ברונכולט סירופ · Broncholate Syrup (עם דיפנהידרמין) \| קלארינז רפטאבס · Clarinase Repetabs (עם לורטדין) \| דקסמולקולד לטיפול ביום ולילה (30 + · 30) Dexamolcold Day + Night + (עם פרצטמול, דקסטרומתורפן, גואיפנזין) \| דקסמולקולד לטיפול ביום ולילה (48 + · 48) Dexamolcold Day + Night + (עם פרצטמול, דקסטרומתורפן, גואיפנזין) \| דקסמולקולד לטיפול ביום · Dexamolcold Day Care (עם פרצטמול, דקסטרומתורפן, גואיפנזין) \| דקסמולקולד לטיפול בלילה · Dexamolcold Night Care (עם פרצטמול, כלורפנירמין, דקסטרומתורפן) \| דקסמולסינוס לטיפול ביום ולילה (20 + · Dexamolsinus Day + Night ( (עם פרצטמול) \| דקסמולסינוס לטיפול ביום · Dexamolsinus Day Care (עם פרצטמול) \| דקסמולסינוס לטיפול בלילה · Dexamolsinus Night Care (עם פרצטמול, כלורפנירמין) \| היסטדקס · Histadex (עם דקסכלורפנירמין) \| היסטפד · Histafed (עם טריפרולידין) \| היסטפד אקספקטורנט סירופ · Histafed Expectorant Syrup (עם טריפרולידין, גואיפנזין) \| היסטפד סירופ · Histafed Syrup (עם טריפרולידין) \| קלסינוס · Kalsinus (פסאודואפדרין בלבד) \| נורופן צינון ושפעת · Nurofen Cold And Flu (עם איבופרופן) \| נוסידקס · Nussidex (עם דקסכלורפנירמין) \| פראמול אף ושיעול לטיפול ביום · Paramol Af & Shiul Day Care (עם פרצטמול, דקסטרומתורפן, גואיפנזין) \| פראמול אף ושיעול לטיפול בלילה · Paramol Af & Shiul Night Care (עם פרצטמול, כלורפנירמין, דקסטרומתורפן) \| פראמול אף לטיפול ביום · Paramol Af Day Care (עם פרצטמול) \| פראמול אף לטיפול בלילה · Paramol Af Night Care (עם פרצטמול, כלורפנירמין) \| סינופד סירופ · Sinufed Syrup (פסאודואפדרין בלבד) \| סינופד טבליות · Sinufed (פסאודואפדרין בלבד) \| טבע - קולד קפליות · Teva - Cold (עם פרצטמול, כלורפנירמין, פנילאפרין, קפאין) \| אקסדרין · Excedrin (פרצטמול, אספירין וקפאין — בלי מכווץ כלי דם) |
| נימוק / הערה | כולם מכילים מכווץ כלי דם (פסאודואפדרין), שמעלה לחץ דם ודופק. הרכיבים הנוספים משתנים: אקמול צינון, דקסמול ופראמול — עם פרצטמול; אדויל קולד ונורופן צינון — עם איבופרופן; קלרינז — עם לורטדין; היסטפד ונוסידקס — עם אנטיהיסטמין מרדים; סינופד וקלסינוס — פסאודואפדרין בלבד. הרכיבים של כל תכשיר מופיעים ליד שמו. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | לא בהיריון ולא מניקה | אין היריון או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | אין יתר ל"ד לא מאוזן או מחלת לב | ל"ד אחרון מאוזן; אין מחלת לב איסכמית, הפרעת קצב או אירוע מוחי. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | אין גלאוקומה, הגדלת ערמונית או יתר פעילות של בלוטת התריס | ברשומה אין גלאוקומה עם זווית סגורה, הגדלת ערמונית או יתר פעילות של בלוטת התריס. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | אין כפילות רכיבים | אם התכשיר מכיל פרצטמול — לא נלקח במקביל אקמול או תכשיר אחר עם פרצטמול; אם מכיל איבופרופן — לא נלקח נוגד דלקת אחר. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 7 | בתכשיר עם איבופרופן: אין כיב, מחלת כליות או נוגדי קרישה | אם התכשיר מכיל איבופרופן — ברשומה אין כיב או דימום, אי-ספיקת כליות, אי-ספיקת לב, ואין נוגדי קרישה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 8 | בתכשיר עם דקסטרומתורפן: אין SSRI, SNRI, טרמדול או MAOI | אם התכשיר מכיל דקסטרומתורפן — בתרופות הקבועות אין נוגדי דיכאון סרוטונרגיים, טרמדול או MAOI. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 9 | משך וכמות בגבולות | עד 5 ימים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 10 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין חום מעל 3 ימים, קוצר נשימה, כאב בחזה, נוקשות עורף, פריחה, בלבול או החמרה אחרי שיפור. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 11 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 12 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **הוראות ואזהרות למטופל/ת** | לפי ההוראות שבעלון, עד 5 ימים. אם התכשיר מכיל פרצטמול (אקמול צינון, דקסמול, פראמול) — לא לקחת במקביל אקמול; אם מכיל איבופרופן (אדויל, נורופן) — לא לקחת נוגד דלקת נוסף. אם מופיעים דפיקות לב, כאב ראש חזק, חום מעל 3 ימים או קוצר נשימה, יש לפנות לרופא. |
| **מקור** | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.12 **תכשירים לכאב גרון (לכסניות ותרסיסים)** · Throat lozenges and sprays

הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · גרון

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (15)** | סטרפן דבש ולימון · Strefen Honey And Lemon | סטרפן תפוז ללא סוכר · Strefen Orange - Sugar Free | סטרפן ספריי · Strefen Spray | אקסרופן תפוז ללא סוכר · Xrofen Orange Sugar Free | רוגרון לימון ללא סוכר · Rogaron Lemon Sugar Free | רוגרון תפוז - דבש ללא סוכר · Rogaron Orange - Honey Sugar Free | טנטום ורדה · Tantum Verde | קלגרון מנטה · Kalgaron Mint | קלגרון תפוז · Kalgaron Orange | קלגרון תות · Kalgaron Strawbery | סטרפסילס דבש ולימון · Strepsils Honey And Lemon | סטרפסילס לימון ללא סוכר · Strepsils Lemon Sugar Free | סטרפסילס ללא סוכר תות · Strepsils Strawberry Sugar Free | קלירוצין דובדבן · Clearocin Cherry | קלירוצין לימון · Clearocin Lemon |
| **נימוק / הערה** | לכאב גרון בצינון. פלורביפרופן (סטרפן) הוא נוגד דלקת: לא באסתמה רגישה לנוגדי דלקת. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | לא בהיריון ולא מניקה | אין היריון או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | אין רגישות לנוגדי דלקת (בסטרפן) | ברשומה אין רגישות לאספירין או לנוגדי דלקת. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | משך וכמות בגבולות | עד 5 ימים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין קושי לבלוע רוק, ריור, קושי לפתוח את הפה, קוצר נשימה, חום גבוה בלי שיעול או כאב מעל שבוע. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **הוראות ואזהרות למטופל/ת** | לפי ההוראות שבעלון, עד 5 ימים. אם יש קושי לבלוע, ריור, חום גבוה או שהכאב נמשך מעל שבוע, יש לפנות לרופא. |
| **מקור** | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.13 פרצטמול — קורס קצר · Paracetamol (short course) הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · כאב וחום

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (11) | אברול טבליות · Abrol \| אקמול · Acamol \| אקמול טבע קפליות · Acamol Teva \| אבקמול · Avcamol \| דקסמול · Dexamol \| אפרמול · Efferamol \| פנדול · Panadol \| פראמול · Paramol \| סופרמול 500 פתילות · Supramol \| רזמול 500 מ"ג פתילות · Razamol \| מוסקול · Muscol (עם אורפנדרין) |
| נימוק / הערה | לכאב ולחום. עד 4 גרם ביום (בגיל מבוגר, במשקל נמוך או בצריכת אלכוהול: עד 3 גרם). לבדוק כפילות עם תכשירי צינון. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אין מחלת כבד או צריכת אלכוהול מוגברת | ברשומה אין מחלת כבד או שימוש מוגבר באלכוהול. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | אין תכשיר נוסף עם פרצטמול | לא נלקח במקביל תכשיר צינון עם פרצטמול. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | משך וכמות בגבולות | עד 3 ימים לחום, עד 7 ימים לכאב. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין כאב חדש וחזק במיוחד, כאב ראש פתאומי או "הכי חזק שהיה", כאב בחזה או בבטן, חולשה או נימול, חבלה משמעותית או חום. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | 1–2 טבליות (500 מ"ג) עד 4 פעמים ביום, לפחות 4 שעות בין מנות, לא יותר מ-8 טבליות ביממה. לא לקחת במקביל תכשיר צינון שמכיל פרצטמול. אם החום נמשך מעל 3 ימים או הכאב מחמיר, יש לפנות לרופא. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.14 איבופרופן / נפרוקסן / אספירין — קורס קצר · Ibuprofen / naproxen (short course)

הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · כאב וחום

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (21) | אדקס · Adex | אדקס פורטה · Adex Forte | אדקס ליקווי-ג'לס · Adex Liqui-Gels | אדקס כמוסות ליקוויד ג'ל · Adex Liquid Gelcapsules | אדויל פורטה · Advil Forte | אדויל ליקווי-ג'לס · Advil Liqui-Gels | איבופן · Ibufen | איבופרו · Ibupro | איבופרו פורטה · Ibupro Forte | איבופרו ליקווי - ג'לס · Ibupro Liqui - Gels | איבופרופן פורבי · Ibuprofen Forbe | נורופן פורטה קפסולות נוזל · Nurofen Forte Liquid | נורופן קפסולות נוזל · Nurofen Liquid | נורופן קוויק · Nurofen Quick | נורופן טבליות · Nurofen | נפרוסן · Naprocen | נרוסין · Narocin | נקסין · Naxyn | קומבודקס · Combodex (עם פרצטמול) | אצטוסל 300 · Acetosal (אספירין) | אקסידול · Exidol (אספירין) |
| נימוק / הערה | נוגדי דלקת במינון רגיל. סיכון לקיבה, לכליות ולדימום. נוגדי דלקת חזקים במרשם (ארקוקסיה ודומיה) — בפריט נפרד. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | לא בהיריון ולא מניקה | אין היריון (בעיקר מהשבוע ה-20) או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | אין כיב קיבה או דימום בעבר | ברשומה אין כיב פפטי או דימום ממערכת העיכול. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | אין מחלת כליות, אי-ספיקת לב או נוגדי קרישה | ברשומה אין אי-ספיקת כליות (eGFR מתחת ל-60), אי-ספיקת לב, ואין טיפול בנוגדי קרישה או במעכבי טסיות. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | אין אסתמה שמחמירה מנוגדי דלקת | ברשומה אין רגישות לאספירין או לנוגדי דלקת. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 7 | משך וכמות בגבולות | עד 7 ימים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 8 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין כאב חדש וחזק במיוחד, כאב ראש פתאומי או "הכי חזק שהיה", כאב בחזה או בבטן, חולשה או נימול, חבלה משמעותית או חום. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 9 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 10 | אין התארת אינטראקציה | כל התארת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | לקחת עם אוכל, במינון הנמוך שמקל, עד 7 ימים. לא לשלב עם נוגד דלקת אחר. אם מופיעים כאב בטן, צואה שחורה, הקאה או נפיחות ברגליים, יש להפסיק ולפנות לרופא. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.15 דיפירון (אופטלגין) — קורס קצר · Dipyrone (short course)

הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · כאב וחום

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (7) | דיפירז טיפות לפה · Dipyraz Oral Drops | דולרגין · Dulergin | אופטלגין קפליות · Optalgin | אופטלגין טבע · Optalgin Teva | אופטלגין טיפות חדש · Optalgin Drops New | וי-דלגין סירופ מרוכז למבוגרים · V-Dalgin Concentrated Syrup For Adults | וי-דלגין טיפות · V-Dalgin Drops |
| נימוק / הערה | משכך כאב וחום. סיכון נדיר לירידה חמורה בכדוריות הלבנות (אגרנולוציטוזיס) ולירידת ל"ד. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | לא בהיריון ולא מניקה | אין היריון או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | אין ירידה בכדוריות הלבנות או תגובה לדיפירון בעבר | ברשומה אין אגרנולוציטוזיס, נויטרופניה או תגובה לדיפירון. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | משך וכמות בגבולות | עד 7 ימים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין כאב חדש וחזק במיוחד, כאב ראש פתאומי או "הכי חזק שהיה", כאב בחזה או בבטן, חולשה או נימול, חבלה משמעותית או חום; אין חום עם כאב גרון או פצעים בפה בזמן הטיפול. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | 1–2 טבליות (500 מ"ג) עד 4 פעמים ביום, עד שבוע. אם מופיעים חום, כאב גרון או פצעים בפה בזמן הטיפול, יש להפסיק ולפנות מיד לרופא. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.16 ג'ל נוגד דלקת (וולטרן ודומיו) · Topical NSAID gel

הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · כאב שרירים ומפרקים

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (11) | דיקלורן ג'ל · Dicloren Gel | אוסטאומין דיקלופנק · Osteomine Diclofenac Gel | פיזיקאר ג'ל · Physicare Gel | סוויס רליף ספרי ג'ל · Swiss Relief Spray Gel | וולטרן אמולג'ל · Voltaren Emulgel | וולטרן אמולג'ל פורטה % · Voltaren Emulgel Forte | נורופן ג'ל % · Nurofen Gel | פאסטום ג'ל · Fastum Gel (קטופרופן) | קטוספריי · Ketospray 10 % (קטופרופן) | דיקלוויט · Diclovit | דיקלופלסט · Dicloplast |
| נימוק / הערה | למריחה על כאב שרירים או מפרק. ספיגה מועטה; לא על עור פגוע. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | לא בהיריון ולא מניקה | אין היריון (בעיקר מהשבוע ה-20) או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | אין רגישות לנוגדי דלקת | ברשומה אין רגישות לאספירין או לנוגדי דלקת. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | משך וכמות בגבולות | עד 14 ימים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין נפיחות חמה ואדומה במפרק, חום, חבלה עם חשד לשבר או כאב שמחמיר. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | למרוח שכבה דקה על האזור הכואב 3–4 פעמים ביום, לא על עור פגוע, ולשטוף ידיים אחרי. עד שבועיים. אם יש נפיחות אדומה וחמה, חום או שהכאב מחמיר, יש לפנות לרופא. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.17 נוגדי חומצה ואלגינטים (גביסקון, מאלוקס) · Antacids and alginates הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · עיכול

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (12) | גביסקון פורטה מנטה · Gaviscon Forte Peppermint \| גביסקון נוזל מנטה · Gaviscon Liquid Peppermint \| גביסקון מנטה טבליות · Gaviscon Peppermint Tablets \| מאלוקס תרחיף · Maalox Suspension \| מאלוקס פלוס · Maalox Plus \| פרסקו טבליות · Fresco Tablets \| צרבת איקס מנטה · Tzarevet X Mint \| צרבת איקס מלון · Tzarevet X Melon Flavour \| רני אייס · Rennie Ice \| רני בטעם תפוז · Rennie Orange \| רני בטעם מנטה · Rennie Peppermint \| רני בטעם מנטה עדין · Rennie Spearmint |
| נימוק / הערה | לצרבת ולקלקול קיבה מזדמנים. מפריעים לספיגת תרופות אחרות (לבותירוקסין, ברזל, אנטיביוטיקה): להפריד בשעתיים. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אין אי-ספיקת כליות מתקדמת (במאלוקס) | eGFR אחרון 30 ומעלה (מגנזיום ואלומיניום מצטברים). לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | משך וכמות בגבולות | עד 14 ימים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין סימני אזהרה: ירידה במשקל, קושי או כאב בבליעה, הקאות חוזרות, צואה שחורה או דם, אנמיה, כאב בטן חזק, או תסמינים חדשים מגיל 55. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | לפי ההוראות שבעלון, אחרי ארוחות ולפני השינה. להפריד בשעתיים מתרופות אחרות. אם התסמינים נמשכים מעל שבועיים, או שיש ירידה במשקל, קושי בבליעה, הקאות או צואה שחורה, יש לפנות לרופא. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.18 **מעכבי חומצה — קורס קצר (אומפרזול ודומיו, פמוטידין)** · Acid suppression (short course)

הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · עיכול

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (14)** | אסומפראזול אינובמד · Esomeprazole Inovamed | אסופרים קונטרול · Esoprim Control | אסופרים אס.קיי. · Esoprim S.K | לוסק · Losec | נקסיום טבליות · Nexium | אומפרה · Omepra | אומפרדקס - Z · Omepradex - Z | אומפרדקס קפליות · Omepradex | לנסו טבע · Lanso Teva | לנטון · Lanton | קונטרולוק · Controloc | פאמו · Famo | פמוטידין טבע · Famotidine Teva | גאסטרו · Gastro |
| **נימוק / הערה** | קורס קצר לצרבת. טיפול קבוע ומתמשך — בלשונית מערכת העיכול. בגיל 55 ומעלה עם תסמין חדש, או עם סימן אזהרה — לרופא/ה. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **גיל 18 ומעלה** | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | **אין רגישות לתרופה** | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | **לא קורס חוזר תכוף** | לא ניתן קורס דומה ב-3 החודשים האחרונים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | **משך וכמות בגבולות** | עד 4 שבועות, פעם ביום. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | **לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה** | אין סימני אזהרה: ירידה במשקל, קושי או כאב בבליעה, הקאות חוזרות, צואה שחורה או דם, אנמיה, כאב בטן חזק, או תסמינים חדשים מגיל 55. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 6 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | **אין התארת אינטראקציה** | כל התארת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **הוראות ואזהרות למטופל/ת** | כמוסה אחת ביום, חצי שעה לפני ארוחת הבוקר, עד 4 שבועות. אם התסמינים חוזרים אחרי הפסקה, או שיש ירידה במשקל, קושי בבליעה, הקאות או צואה שחורה, יש לפנות לרופא. |
| **מקור** | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.19 לופרמיד (אימודיום) · Loperamide הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · שלשול

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (6) | אימודיום כמוסות · Imodium \| לופמיד · Lopamide \| לופריד כמוסות · Loperid \| לופי-קאר טבליות · Lopi-Care \| רקמיד · Rekamide \| סטופיט · Stopit |
| נימוק / הערה | לשלשול חד בלי סימני אזהרה. לא בשלשול דמי, בחום או אחרי אנטיביוטיקה (חשד לזיהום חיידקי או קלוסטרידיום). |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | לא בהיריון ולא מניקה | אין היריון או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | אין מחלת מעי דלקתית | ברשומה אין קרוהן או קוליטיס כיבית. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | משך וכמות בגבולות | עד יומיים; לא יותר מ-8 מ"ג ביממה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין דם או ריר בצואה, חום מעל 38, כאב בטן חזק, סימני התייבשות (סחרחורת, מיעוט שתן), שלשול מעל 3 ימים, אנטיביוטיקה או אשפוז בחודשים האחרונים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | 2 כמוסות בהתחלה, ואחר כך כמוסה אחרי כל יציאה רכה, לא יותר מ-4 כמוסות ביממה ולא יותר מיומיים. לשתות הרבה. אם יש דם בצואה, חום, כאב בטן חזק או סימני התייבשות, יש להפסיק ולפנות לרופא. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.20 ביסמות סובסליצילט (קלבטן, ביטני) · Bismuth subsalicylate הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · שלשול וקלקול קיבה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (6) | קלבטן פורטה · Kalbeten Forte Caplets | קלבטן תרחיף · Kalbeten Suspension | ביטני טבליות · Bitni Tablets | ביטני תרחיף · Bitni Suspension | ביסמו-קל · Bismu-Cal | ביסמורז · Bismuraz |
| נימוק / הערה | מכיל סליצילט: כמו אספירין לעניין רגישות ונוגדי קרישה. צואה ולשון שחורות — צפוי ולא מסוכן. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | לא בהיריון ולא מניקה | אין היריון או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | אין רגישות לאספירין ואין נוגדי קרישה | ברשומה אין רגישות לאספירין, ואין טיפול בנוגדי קרישה, באספירין או במתוטרקסט. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | משך וכמות בגבולות | עד יומיים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין דם או ריר בצואה, חום מעל 38, כאב בטן חזק, סימני התייבשות (סחרחורת, מיעוט שתן), שלשול מעל 3 ימים, אנטיביוטיקה או אשפוז בחודשים האחרונים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | לפי ההוראות שבעלון, עד יומיים. צבע שחור של הלשון או הצואה צפוי ואינו מסוכן. אם יש דם בצואה, חום, כאב בטן חזק או סימני התייבשות, יש לפנות לרופא. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.21 משלשלים אוסמוטיים (לקטולוז, PEG) · Osmotic laxatives

הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · עצירות

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (7) | אבילק סירופ · Avilac Syrup \| לקטורז · Lacturaz \| לבולק · Laevolac \| נורמלקס · Normalax \| פגלקס נוטראל · Peglax Neutral \| פגלקס תפוז · Peglax Orange \| רגולקס · Regulax |
| נימוק / הערה | לעצירות חדשה או מזדמנת. טיפול קבוע — בלשונית מערכת העיכול (משלשלים). עצירות חדשה מגיל 50 — לרופא/ה. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | משך וכמות בגבולות | עד 14 ימים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין דם בצואה, ירידה במשקל, כאב בטן חזק, הקאות, בטן נפוחה בלי גזים, או שינוי חדש ביציאות מגיל 50. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התארת אינטראקציה | כל התארת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | לפי ההוראות שבעלון, עם הרבה שתייה. ההשפעה מגיעה אחרי יום–יומיים. אם אין יציאה 3 ימים, או שיש דם בצואה, כאב בטן חזק, הקאות או בטן נפוחה, יש לפנות לרופא. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.22 משלשלים ממריצים ופתילות (ביסקודיל, סנה, גליצרין) · Stimulant laxatives and suppositories

הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · עצירות

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (11) | לקסעדין · Laxadin | עצירות איקס · Atzirut X | קונטלקס · Contalax | מידרו תה · Midro Tea | אגיולקס · Agiolax | גליצרין פתילות למבוגרים · Glycerin Suppositories For Adults | גליצרין פורטה פתילות · Glycerin Forte Suppositories | מיקרולט · Microlet | איזילקס טבליות · Easylax Tablets | פליט חוקן 133 · Fleet Enema 133 | רזלקס מבוגרים · Razalax Adult |
| נימוק / הערה | לעצירות מזדמנת בלבד. שימוש ממושך בממריצים גורם לתלות ולהפרעות מלחים. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | לא בהיריון ולא מניקה | אין היריון או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | משך וכמות בגבולות | עד 7 ימים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין דם בצואה, ירידה במשקל, כאב בטן חזק, הקאות, בטן נפוחה בלי גזים, או שינוי חדש ביציאות מגיל 50. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | טבליות: בערב לפני השינה. פתילה: לפי הצורך. לא יותר משבוע ברציפות. אם אין יציאה 3 ימים, או שיש דם בצואה, כאב בטן חזק, הקאות או בטן נפוחה, יש לפנות לרופא. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.23 סימתיקון (גזים) · Simethicone

הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · עיכול

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (5) | גזים איקס · Gazim X | סימיקול טבליות · Simicol Tablets | קרבוסילן · Carbosylane | גספן · Gaspan | טיפטיפות סימיקול · Tiptipot Simicol (טיפות לתינוקות) |
| נימוק / הערה | לגזים ולנפיחות. בטוח, כמעט אינו נספג. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | משך וכמות בגבולות | עד 14 ימים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין דם בצואה, ירידה במשקל, כאב בטן חזק, הקאות, בטן נפוחה בלי גזים, או שינוי חדש ביציאות מגיל 50. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | לפי ההוראות שבעלון, אחרי ארוחות. אם הנפיחות נמשכת, או שיש כאב בטן חזק, הקאות או ירידה במשקל, יש לפנות לרופא. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.24 נוגדי עוויתות למעי רגיש ידוע (קולוטאל, קולפרמין) · Mebeverine (known IBS) הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · עיכול

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | קולוטאל טבליות · Colotal Tablets \| קולפרמין · Colpermin (שמן מנטה) \| נוטנסיל טבליות · Notensyl Tablets (דיציקלומין) |
| נימוק / הערה | נוגד עוויתות לכאבי בטן במעי רגיש. רק כשיש אבחנה של מעי רגיש; כאב בטן חדש — לרופא/ה. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | לא בהיריון ולא מניקה | אין היריון או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | אבחנה של מעי רגיש ברשומה | אבחנה מתועדת של מעי רגיש (IBS). לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | משך וכמות בגבולות | עד חודש. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין דם בצואה, ירידה במשקל, כאב בטן חזק, הקאות, בטן נפוחה בלי גזים, או שינוי חדש ביציאות מגיל 50. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | טבליה אחת 3 פעמים ביום, 20 דקות לפני הארוחה. אם הכאב משתנה או מחמיר, או שיש דם בצואה או ירידה במשקל, יש לפנות לרופא. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.25 תכשירים לטחורים (פרוקטו-גליבנול, רקטוצורין) · Haemorrhoid preparations

הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · טחורים

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (4) | פרוקטו-גליבנול קרם · Procto-Glyvenol Cream | פרוקטו-גליבנול פתילות · Procto-Glyvenol Suppositories | רקטוצורין משחה · Rectozorin Ointment | רקטוצורין פתילות · Rectozorin Suppositories |
| נימוק / הערה | לטחורים ידועים. דימום מהרקטום שלא הוערך, בעיקר מגיל 50, או כאב חזק — לרופא/ה. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | לא בהיריון ולא מניקה | אין היריון או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | טחורים ידועים | אבחנה של טחורים ברשומה או בביקור קודם. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | משך וכמות בגבולות | עד 7 ימים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין דימום מהרקטום שלא הוערך קודם (בעיקר מגיל 50), כאב חזק, גוש קשה וכואב, חום, או שינוי ביציאות. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | למרוח או להחדיר פעמיים ביום ואחרי יציאה, עד שבוע. אם יש דימום, כאב חזק, גוש קשה וכואב או חום, או שאין שיפור תוך שבוע, יש לפנות לרופא. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.26 קרם נגד פטרת (קלוטרימזול, מיקונזול, טרבינפין) · Topical antifungals

הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · עור — פטרת

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (31) | אגיסטן אלוורה קרם · Agisten Aloevera Cream \| אגיסטן קרם · Agisten Cream \| אגיסטן פסטה · Agisten Paste \| אגיסטן תמיסה · Agisten Solution \| קנסטן קרם · Canesten Cream \| קלוטריויט · Clotrivit \| פונגיקאר · Fungicare \| פונגיוורה קרם · Fungivera Cream \| דקטרין קרם · Daktarin Cream \| פונגידרם · Fungiderm \| פטריון · Pitrion \| דרמסיל · Dermasil \| למיסיל קרם · Lamisil Cream \| למיסיל · ONCE Lamisil Once \| למיסיל ספריי · Lamisil Spray \| פטיר · Patir \| פטרייה-תי · Pitriya-T \| אגיספור ג'ל · Agispor Gel \| אגיספור תמיסה · Agispor Solution \| ביפוויט · Bifovit \| ציקלודרם · Cicloderm \| ציקלודרם תמיסה · Cicloderm Solution \| פיטרקס · Pitrex (טולנפטט) \| אונדציל משחה · Undecyl Ointment \| אונדציל אבקה · Undecyl Powder \| פונגימון · Fungimon \| מנטקס קרם · Mentax Cream (בוטנפין) \| פוליקוטן · Polycutan \| טבעקוטן · Tevacutan \| ניזורל קרם · Nizoral Cream \| ספירט ויטפילד פלוריש · Spirit Whitfield Floris |
| נימוק / הערה | לפטרת בעור (רגל אתלט, מפשעה, גוף). פטרת בציפורניים או בקרקפת, או נגעים נרחבים — לרופא/ה. דקטרין ג'ל לפה — לא כאן (אינטראקציה עם וורפרין). |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | פטרת בעור בלבד | לא בציפורניים, לא בקרקפת ולא בפה או בנרתיק. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | משך וכמות בגבולות | עד 4 שבועות. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין אודם מתפשט, פס אדום, חום, מוגלה או מורסה, כאב שמחמיר, נגע ליד העין או פצע ברגל של חולה סוכרת; אין נגעים נרחבים או בקרקפת. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | למרוח על האזור הפגוע ומעט סביבו, פעם–פעמיים ביום, אחרי ניקוי וייבוש. להמשיך שבועיים אחרי שהעור נראה תקין. אם אין שיפור תוך 4 שבועות, או שמופיעים אודם מתפשט, חום או מוגלה, יש לפנות לרופא. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 13.27 **שמפו נגד פטרת (קטוזול, אגיספור)** · Antifungal shampoo הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · עור — פטרת

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (3)** | קטוזול שמפו · Ketozol Shampoo | אגיספור שמפו · Agispor Shampoo | סבוסל · Sebosel |
| **נימוק / הערה** | לקשקשים סבוריאיים ולפטרת עור (פיטיריאזיס). פטרת בקרקפת עם נשירה — לרופא/ה. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | משך וכמות בגבולות | עד 4 שבועות. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין אזורי קרחת, מוגלה, נפיחות בקרקפת או פריחה נרחבת. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **הוראות ואזהרות למטופל/ת** | לחפוף, להשאיר 3–5 דקות ולשטוף. פעמיים בשבוע במשך 2–4 שבועות. אם יש נשירה באזור מוגדר, מוגלה או אין שיפור, יש לפנות לרופא. |
| **מקור** | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 13.28 **לכה נגד פטרת ציפורניים (לוסריל, פונגינייל)** · Antifungal nail lacquer הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · עור — פטרת

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (4)** | לוסריל · Loceryl | פונגופין · Fungofin | פונגינייל · Funginail | מיקוניל · Myconail |
| **נימוק / הערה** | לפטרת ציפורניים קלה (עד חצי ציפורן, בלי שורש הציפורן). טיפול ארוך: 6 חודשים בידיים, 9–12 ברגליים. טבליות טרבינפין — בפריט נפרד. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | פטרת קלה | פחות מחצי ציפורן, לא שורש הציפורן ולא ציפורניים רבות. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | משך וכמות בגבולות | עד 12 חודשים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין פצע, אודם או נפיחות סביב הציפורן, ואין סוכרת עם פצע ברגל. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **הוראות ואזהרות למטופל/ת** | למרוח על הציפורן הפגועה לפי ההוראות שבעלון (פעם בשבוע או פעם ביום, לפי התכשיר), אחרי שיוף קל. הטיפול נמשך חודשים רבים. אם מופיעים אודם, נפיחות או כאב סביב הציפורן, יש לפנות לרופא. |
| **מקור** | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.29 משחה אנטיביוטית (פוסידין, בקטרובן) · Topical antibiotics

הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · עור — זיהום

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (9) | פוסידין קרם · Fucidin Cream \| סטאפידרם קרם · Staphiderm Cream \| בקטרובן לעור · Bactroban Dermal \| מופירוסין אס.קיי. · Mupirocin S.K \| מופירוצין טבע · Mupirocin Teva \| פוסידין משחה · Fucidin Ointment \| גנטתרים קרם · Gentatrim Cream \| גנטתרים משחה · Gentatrim Ointment \| כלורפניקול משחת עור · Chlorphenicol Skin Ointment |
| נימוק / הערה | לזיהום שטחי קטן בעור (אימפטיגו מקומי). זיהום נרחב, חום או אודם מתפשט — לרופא/ה (ייתכן צורך באנטיביוטיקה בבליעה). שימוש ממושך מעודד עמידות. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אזור קטן | נגע אחד או כמה נגעים באזור מוגבל. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | משך וכמות בגבולות | עד 7 ימים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין אודם מתפשט, פס אדום, חום, מוגלה או מורסה, כאב שמחמיר, נגע ליד העין או פצע ברגל של חולה סוכרת. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | למרוח 3 פעמים ביום על הנגע בלבד, עד 7 ימים. לשטוף ידיים לפני ואחרי. אם האודם מתפשט, מופיעים חום או מוגלה, או שאין שיפור תוך 3 ימים, יש לפנות לרופא. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.30 קרם אציקלוביר (זובירקס) — פצעי קור · Aciclovir cream

הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · עור — הרפס

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (4) | ציקלוביר · Cyclovir \| זובירקס · Zovirax \| פנליפס · Fenlips (פנציקלוביר) \| פנליפס קולור · Fenlips Color (פנציקלוביר) |
| נימוק / הערה | לפצעי קור (הרפס בשפתיים) חוזרים. יעיל בעיקר כשמתחילים בתחושת העקצוץ. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | משך וכמות בגבולות | עד 5 ימים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין נגע ליד העין, נגעים נרחבים, חום, דיכוי חיסוני או יותר מ-6 התקפים בשנה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | למרוח 5 פעמים ביום, מהעקצוץ הראשון, 5 ימים. לא לגעת בעיניים אחרי המריחה. אם יש נגע ליד העין, נגעים נרחבים או חום, יש לפנות לרופא. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.31 אציקלוביר / ולציקלוביר בטבליות — התקף של הרפס ידוע · Oral aciclovir / valaciclovir (known recurrent herpes)

הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · הרפס חוזר

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (3)** | ולטרקס טבליות · Valtrex \| אציקלו-וי · Acyclo-V \| זובירקס טבליות · Zovirax |
| **נימוק / הערה** | רק להתקף חוזר של הרפס שאובחן בעבר (שפתיים או איברי מין). התקף ראשון, שלבקת חוגרת, עין או דיכוי חיסוני — לרופא/ה. טיפול מונע קבוע — בלשונית חיסון וזיהומים. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **גיל 18 ומעלה** | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | **לא בהיריון ולא מניקה** | אין היריון או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | **אין רגישות לתרופה** | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | **הרפס חוזר שאובחן בעבר** | אבחנה ברשומה של הרפס חוזר באותו מקום. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | **תפקוד כליות תקין** | eGFR אחרון 30 ומעלה (מתחת — התאמת מינון). לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | **משך וכמות בגבולות** | התקף אחד: 1–5 ימים לפי התכשיר. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 7 | **לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה** | אין התקף ראשון, נגע ליד העין, שלבקת חוגרת (פריחה בפס בצד אחד), חום או דיכוי חיסוני. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 8 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **הוראות ואזהרות למטופל/ת** | להתחיל בסימן הראשון (עקצוץ או שלפוחית), לפי ההוראות שעל האריזה. לשתות הרבה. אם הנגעים מתפשטים, מופיעים ליד העין, או שיש חום או פריחה בפס בצד אחד של הגוף, יש לפנות לרופא. |
| **מקור** | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.32 טיפול בגרדת (לייקליר) · Scabies treatment

הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · עור — טפילים

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | לייקליר קרם לעור · Lyclear Dermal Cream \| יורקס · Eurax |
| נימוק / הערה | פרמתרין לגרדת. מטפלים בכל בני הבית באותו יום, וחוזרים אחרי שבוע. הגרד יכול להימשך 2–4 שבועות אחרי טיפול מוצלח. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | לא בהיריון ולא מניקה | אין היריון או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | אבחנה או חשיפה ידועה | אבחנה של גרדת ברשומה, או בן בית שאובחן. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | משך וכמות בגבולות | 2 טיפולים בהפרש שבוע; אריזה לכל בן בית. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין קרומים עבים בעור (גרדת קרומית), זיהום בעור (מוגלה, חום) או מגורים במוסד. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | למרוח על כל הגוף מהצוואר ומטה, כולל בין האצבעות ומתחת לציפורניים, ולשטוף אחרי 8–12 שעות. לחזור על הטיפול אחרי 7 ימים. לטפל בכל בני הבית באותו יום, ולכבס מצעים, מגבות ובגדים ב-60 מעלות. גרד יכול להימשך כמה שבועות; אם מופיעים מוגלה, חום או החמרה, יש לפנות לרופא. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.33 משחות לכוויות ופצעים (סילברול, בפנטן פלוס) · Burn and wound creams

הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · עור — כוויות ופצעים

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (5) | סלברול קרם · Silverol Cream \| סילברול קר · Silverol Care \| בפנטן פלוס · Bepanthen Plus \| ביאפין · Biafine \| איכטמול משחה · Ichthammol Ointment |
| נימוק / הערה | לכוויה שטחית קטנה או לפצע קטן. סלברול מכיל סולפה: לא ברגישות לסולפה ולא בהיריון מתקדם. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | לא בהיריון ולא מניקה | אין היריון או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | אין רגישות לסולפה (בסלברול) | ברשומה אין רגישות לסולפונאמידים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | משך וכמות בגבולות | עד 14 ימים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | הכוויה קטנה מכף יד, לא בפנים, בידיים, באיברי המין או על מפרק, לא כוויה חשמלית או כימית, אין שלפוחיות גדולות, ואין סימני זיהום (אודם מתפשט, מוגלה, חום). לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | לקרר במים זורמים (לא קרח), לנקות בעדינות ולמרוח שכבה דקה פעם–פעמיים ביום, עם חבישה נקייה. אם מופיעים אודם מתפשט, מוגלה, חום או כאב שמחמיר, או שהפצע לא משתפר תוך שבוע, יש לפנות לרופא. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.34 חיטוי עור ופה (כלורהקסידין, פולידין) · Skin and mouth antiseptics

הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · עור — חיטוי

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (26) | אלכוספט · Alcosept | אלכוקסידין · Alcoxidine | פולידין תמיסה · Polydine Solution | פולידין משחה · Polydine Ointment | יודיפלור תמיסה · Iodiflor Solution | בטאדין תרסיס · Betadine Topical Spray | קורסודיל מי פה · Corsodyl Mouthwash | הקסידיל מי פה · Hexidyl Mouthwash | מי חמצן 3% פלוריס · Hydrogen Peroxide 3 % Floris | מי חמצן 3% לייף · Hydrogen Peroxide 3% Life | ספטדין · Septadine | ספטדין תרחיץ · Septadine Tarhitz | אלכוהול כלורהקסידין טבע · Alcohol Chlorhexidine Teva | יודיקאר משחה · Iodicare Ointment | יודו-ויט משחה · Iodo-Vit Ointment | יודו-ויט תמיסה · Iodo-Vit Solution | פוליסקין תמיסה · Polyskin Solution | סביעור · Savior | מרפן ספריי לעזרה ראשונה · Merfen Spray First Aid | ספטול · Septol | אלכוהול 70 % ויטאמד · Alcohol | סולודנט ללא אלכוהול שטיפת פה · Solodent Alcohol Free Mouthwash | סולודנט שטיפת פה · Solodent Mouthwash | תרודנט שטיפת פה · Tarodent Mouthwash | דרמקס · Dermax | ספטל סקרב · Septal Scrub |
| נימוק / הערה | לחיטוי פצע קטן או לשטיפת פה. יוד: לא במחלת בלוטת התריס, בהיריון או על שטח נרחב. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | לא בהיריון ולא מניקה | אין היריון או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | אין מחלת בלוטת התריס (ביוד) | ברשומה אין מחלה של בלוטת התריס. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | משך וכמות בגבולות | עד 14 ימים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | הפצע לא עמוק, לא נשיכה של אדם או בעל חיים, אין סימני זיהום ואין חשד לגוף זר. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | לחטא את הפצע פעם–פעמיים ביום. מי פה: לשטוף ולירוק, לא לבלוע, עד שבועיים (עלולים להכתים שיניים). פצע עמוק, נשיכה, אודם מתפשט או מוגלה — יש לפנות לרופא. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 13.35 תכשירים לגרד מקומי (קלמין, פניסטיל ג'ל, צינק) · Antipruritic lotion הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · עור — גרד

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (10) | קלמין תרחיץ פלוריש · Calamine Lotion Floris \| תרחיץ קלמין ויטאמד · Calamine Lotion Vitamed \| פניסטיל ג'ל · Fenistil Gel \| דרמוסטמין ג'ל · Dermostamin Gel \| דימטינדן אינובמד ג'ל · Dimetindene Inovamed Gel \| תיו ג'ל · Thio Gel \| מדי-דן ג'ל · Medi-Dene Gel \| טינדן ג'ל · Tinden Gel \| צינק תרחיץ ויטאמד · Zinc Lotion Vitamed \| בלנאום פלוס · Balneum Plus |
| נימוק / הערה | לגרד מקומי (עקיצות, פריחה קלה). גרד בכל הגוף בלי פריחה, או עם צהבת — לרופא/ה. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | משך וכמות בגבולות | עד 14 ימים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין נפיחות בשפתיים או בלשון, קוצר נשימה, פריחה מתפשטת עם חום, או גרד בכל הגוף בלי פריחה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | למרוח על אזור הגרד 2–3 פעמים ביום. לא על עור פצוע. אם מופיעים נפיחות בשפתיים, קוצר נשימה או פריחה מתפשטת עם חום, יש לפנות מיד לטיפול רפואי. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.36 טיפול מקומי באקנה (בנזק, אפידו, דואק) · Topical acne treatment

הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · עור — אקנה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (16) | בנזק · Benzac 5 % | אדאפרין קרם · Adaferin Cream | אדטאר · Adatar | אפידו · Epiduo | אפידו פורטה · Epiduo Forte | דואק · Duac | אקטידו ג'ל · Actidu Gel | אקנטרים · Acnetrim | אקנמיצין · Aknemycin | רט-אוויט קרם · Ret-Avit Cream | רט-אוויט ג'ל · Ret-Avit Gel | אקליף · Aklief | טווינאו · Twyneo | לינדק · Lindac | תרוקלינדין ג'ל · Taroclindin Gel | זינדקלין 1 % ג'ל · Zindaclin |
| נימוק / הערה | לאקנה קלה עד בינונית. אדפלן (אפידו, אדאפרין) — אסור בהיריון. אקנה קשה עם צלקות — רופא/ת עור. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | לא בהיריון ולא מניקה | אין היריון, תכנון היריון או הנקה (אדפלן אסור בהיריון). לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | משך וכמות בגבולות | עד 3 חודשים, ואז הערכה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין קשריות כואבות, צלקות, אקנה שהופיעה פתאום בגיל מבוגר או עם סימני הורמונים (שיעור יתר, מחזור לא סדיר). לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התארת אינטראקציה | כל התארת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | למרוח שכבה דקה על כל האזור (לא רק על הפצעים) פעם ביום בערב, על עור נקי ויבש. בהתחלה ייתכנו יובש וגירוי; בנזואיל פרוקסיד מלבין בדים. ההשפעה מגיעה אחרי 6–8 שבועות. אם יש גירוי חזק או אין שיפור תוך 3 חודשים, יש לפנות לרופא. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.37 טיפול ביבלות (סלאטק) · Wart treatment הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · עור — יבלות

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (5) | סלאטק ג'ל · Salatac Gel \| ורומאל תמיסה · Verrumal Solution \| טופיסלן · Topisalen \| סאליקרן · Salikaren \| ספירט סליציל 2 % · Spirit Salicyl |
| נימוק / הערה | חומצה סליצילית ליבלות בידיים וברגליים. לא בפנים, באיברי המין או בחולי סוכרת או מחלת כלי דם היקפית. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אין סוכרת או מחלת כלי דם היקפית | ברשומה אין סוכרת ואין מחלת כלי דם היקפית (סיכון לפצע). לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | משך וכמות בגבולות | עד 12 שבועות. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין יבלת בפנים או באיברי המין, נגע שמשנה צבע, מדמם או גדל מהר. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | למרוח על היבלת בלבד פעם ביום, ולשייף בעדינות לפני המריחה הבאה. עד 12 שבועות. לא על עור תקין, לא בפנים ולא על שומות. אם הנגע מדמם, משנה צבע או כואב, יש לפנות לרופא. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.38 הרדמה מקומית לפני פעולה (אמלה, LMX4, עזרקאין) · Local anaesthetic cream (before a procedure)

הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · עור — לפני פעולה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (9) | אמלה · Emla | לידופרי-אבניר · Lidopri-Avenir | לואנה · Loana | פרילידן · Prilidan | אל אם איקס 4 · Lmx4 | עזרקאין קרם 5 % · Esracain Cream | עזרקאין ג'ל · Esracain Gel | קסילוקאין משאבת ספריי 10 % · Xylocaine Pump Spray | פליאגליס · Pliaglis |
| נימוק / הערה | לפני דקירה, לייזר או פעולה קטנה, לפי הנחיית המטפל/ת. כמות גדולה על שטח נרחב — סיכון למתהמוגלובינמיה. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | פעולה מתוכננת | יש תור או הנחיה לפעולה (דקירה, לייזר, פעולה קטנה). לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | משך וכמות בגבולות | לפעולה אחת, כמות קטנה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין עור פצוע באזור, ואין פעולה על שטח נרחב. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התארת אינטראקציה | כל התארת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | למרוח שכבה עבה על האזור שעה לפני הפעולה ולכסות בניילון נצמד או בחבישה שקופה, ולהסיר לפני הפעולה. לא על עור פצוע ולא על שטח נרחב. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.39 דמעות מלאכותיות · Artificial tears הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · עיניים

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (10) | טירס נטורל Tears Natural II · II | טירס נטורל פרי · Tears Natural Free | איקון · Eyecon | לקרימול · Lacrimol Eye Drops | לייטירס · Lyteers Eye Drops | וי-טירס · V-Tears | וי-קרימה · V-Crima | צלוספן · Celluspan | דורהטירס · Duratears | אופטאסטריל 50 מ"ג/מ"ל · Oftasteril |
| נימוק / הערה | ליובש בעיניים. בטוחות. שימוש יותר מ-4–6 פעמים ביום — תכשיר ללא חומר משמר. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | משך וכמות בגבולות | עד 3 חודשים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין כאב בעין, ירידה בראייה, רגישות חזקה לאור, הפרשה מוגלתית, אודם בעין אחת בלבד, חבלה או גוף זר, או שימוש בעדשות מגע עם אודם. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | טיפה בכל עין לפי הצורך, עד 4–6 פעמים ביום. לא לגעת בקצה הבקבוק. אם מופיעים כאב, ירידה בראייה, רגישות חזקה לאור או הפרשה מוגלתית, יש לפנות לרופא. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.40 טיפות עיניים נגד אלרגיה (אופטילסט, אולופטדין) · Antiallergic eye drops הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · עיניים

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (7) | אופטילסט · Optilast | אזלסטין-קומוד טיפות עיניים · Azelastin-Comod Eye Drops | אולופטדין אס.קיי · Olopatadine S.K. | רלסטט · Relestat | קרומופטיק · Cromoptic | כרומו קומוד טיפות עיניים · Cromo-Comod Eye Drops | ליווסטין · Livostine |
| נימוק / הערה | לדלקת לחמית אלרגית: גרד, דמעות ואודם בשתי העיניים. אודם בעין אחת, כאב או הפרשה — לרופא/ה. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | לא בהיריון ולא מניקה | אין היריון או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | תסמינים בשתי העיניים עם גרד | גרד ודמעות בשתי העיניים, בלי הפרשה מוגלתית. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | משך וכמות בגבולות | עונה אחת (עד 3 חודשים). לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין כאב בעין, ירידה בראייה, רגישות חזקה לאור, הפרשה מוגלתית, אודם בעין אחת בלבד, חבלה או גוף זר, או שימוש בעדשות מגע עם אודם. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | טיפה בכל עין פעמיים ביום (קרומופטיק: 4 פעמים). להוציא עדשות מגע לפני הטפטוף ולהחזיר אחרי 15 דקות. אם מופיעים כאב, ירידה בראייה או הפרשה, יש לפנות לרופא. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.41 הכנה לקולונוסקופיה (מרוקן, מוביפרפ, פיקו סלקס) · Bowel preparation before colonoscopy

הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · לפני בדיקה

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (4)** | מרוקן · Meroken \| מוביפרפ · Moviprep \| פיקו - סלקס אורנג' · Pico - Salax Orange \| פיקו סלקס קרנברי · Pico Salax Cranberry |
| **נימוק / הערה** | לפי ההפניה והתור לקולונוסקופיה. פיקו סלקס — לא באי-ספיקת כליות או לב. סוכרת עם אינסולין — הנחיה לגבי האינסולין מהרופא/ה. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **גיל 18 ומעלה** | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | **אין רגישות לתרופה** | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | **תור לקולונוסקופיה** | יש הפניה ותור (תאריך ומכון), וההכנה שהמכון ביקש ידועה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | **אין אי-ספיקת כליות או לב (בפיקו סלקס)** | eGFR אחרון 30 ומעלה, ואין אי-ספיקת לב. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | **אין טיפול באינסולין או SGLT2** | בתרופות הקבועות אין אינסולין ואין SGLT2 (צריך הנחיה מיוחדת לפני הבדיקה). לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | **נוגדי קרישה: ההנחיה ידועה** | אם יש נוגד קרישה או קלופידוגרל — הנחיה של המכון או הרופא/ה לגבי הפסקה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 7 | **משך וכמות בגבולות** | הכנה אחת לבדיקה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 8 | **לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה** | אין כאב בטן חזק, הקאות, חסימת מעיים או דימום פעיל. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 9 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 10 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **הוראות ואזהרות למטופל/ת** | לפי דף ההכנה של המכון: דיאטה דלת סיבים לפני הבדיקה, ושתיית התמיסה במועדים שנקבעו, עם הרבה שתייה צלולה. התרופות הקבועות — לפי ההנחיה שקיבלת. אם מופיעים הקאות חוזרות, כאב בטן חזק או סחרחורת, יש לפנות לרופא. |
| **מקור** | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.42 פרה-מדיקציה לפני בדיקה עם חומר ניגוד (רגישות ידועה) · Premedication before contrast imaging

הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · לפני בדיקה

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (2)** | פרדניזון רקח 20 מ"ג · Prednisone Rekah 20MG \| פרדניזון רקח 5 מ"ג · Prednisone Rekah 5 MG |
| **נימוק / הערה** | רק לפי הפרוטוקול הכתוב של מכון הדימות, למטופל/ת עם רגישות ידועה לחומר ניגוד (בדרך כלל פרדניזון ואנטיהיסטמין לפני הבדיקה). |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **גיל 18 ומעלה** | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | **לא בהיריון ולא מניקה** | אין היריון או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | **אין רגישות לתרופה** | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | **מכתב או הנחיה כתובה** | מכתב מהגורם המפנה (תאריך, שם ותפקיד, ההנחיה) מ-3 החודשים האחרונים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | **אין סוכרת לא מאוזנת** | אם יש סוכרת — HbA1c אחרון מתחת ל-9% (סטרואיד מעלה סוכר). לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | **משך וכמות בגבולות** | לבדיקה אחת. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 7 | **לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה** | אין תגובה קשה בעבר (קוצר נשימה, הלם), אין חום או זיהום פעיל. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 8 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **הוראות ואזהרות למטופל/ת** | לקחת לפי השעות שבהנחיית מכון הדימות, לפני הבדיקה. חולי סוכרת: לבדוק סוכר בתדירות גבוהה יותר ביום הטיפול. להגיע לבדיקה עם מלווה אם ניתן אנטיהיסטמין מרדים. |
| **מקור** | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.43 אנטיביוטיקה מונעת לפני טיפול שיניים · Antibiotic prophylaxis before dental treatment

הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · לפני טיפול

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (11) | אמוקסיצילין מדו · Amoxicillin Medo | אמוקסי קאר פורטה · Amoxy Care Forte | מוקסיפן חדש כמוסות · Moxypen New | מוקסיפן פורטה · Moxypen Forte | מוקסיויט · Moxyvit | מוקסיויט פורטה · Moxyvit Forte | ויטאמוקס פורטה · Vitamox Forte | דאלאצין סי כמוסות · Dalacin C | אזניל כמוסות · Azenil | אזיתרומיצין אינובמד · Azithromycin Inovamed | זטו · Zeto |
| נימוק / הערה | רק לפי מכתב קרדיולוג/ית (מסתם תותב, אנדוקרדיטיס בעבר, מומי לב מסוימים). מנה אחת לפני הטיפול. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | לא בהיריון ולא מניקה | אין היריון או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | מכתב או הנחיה כתובה | מכתב מהגורם המפנה (תאריך, שם ותפקיד, ההנחיה) מ-3 החודשים האחרונים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | משך וכמות בגבולות | מנה אחת לפני כל טיפול. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין חום, נפיחות בפנים או כאב שיניים חזק עם נפיחות (זה זיהום — לא מניעה). לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | מנה אחת, 30–60 דקות לפני טיפול השיניים, לפי ההוראה שעל המרשם. אם מופיעים פריחה, נפיחות או קוצר נשימה, יש לפנות מיד לטיפול רפואי. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.44 תחליפי ניקוטין (מדבקות, מסטיק, לכסניות, תרסיס) · Nicotine replacement therapy

הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · גמילה מעישון

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (4) | ניקורט קוויק מיסט ספריי · Nicorette Quick Mist Spray | ניקוטינל מדבקה · Nicotinell | ניקוטינל מסטיק · Nicotinell Gum | ניקוטינל לכסניות · Nicotinell Lozenges |
| נימוק / הערה | לגמילה מעישון, כ-8–12 שבועות. מדבקה + תכשיר קצר-טווח יחד יעילים יותר. ורניקלין — בלשונית בריאות הנפש. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | לא בהיריון ולא מניקה | אין היריון או הנקה (בהיריון — רק בהנחיית רופא/ה). לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | אין אירוע לבבי או מוחי בשבועיים האחרונים | אין התקף לב, תעוקה לא יציבה, הפרעת קצב חמורה או שבץ בשבועיים האחרונים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | משך וכמות בגבולות | עד 12 שבועות. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין כאב בחזה, דפיקות לב או אירוע לבבי או מוחי בשבועות האחרונים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | מדבקה: להדביק כל בוקר על עור נקי ושעיר מעט, ולהחליף מקום כל יום. מסטיק או לכסנית: כשיש דחף לעשן, ללעוס לאט ולהניח בין הלחי לחניכיים. לא לעשן בזמן הטיפול. אם מופיעים כאב בחזה, דפיקות לב או בחילה חזקה, יש להפסיק ולפנות לרופא. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.45 מניעת מלריה לטיול (מלרון, דוקסיציקלין) · Malaria prophylaxis (travel) הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · לפני טיסה

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (3)** | מלרון טבליות למבוגרים · Malarone Tablets For Adults | דוקסי · Doxy | דוקסילין · Doxylin |
| **נימוק / הערה** | רק לפי מכתב של מרפאת מטיילים: יעד, תאריכים, תכשיר ומשך. דוקסיציקלין — רגישות לשמש ולא בהיריון. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **גיל 18 ומעלה** | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | **לא בהיריון ולא מניקה** | אין היריון או הנקה (דוקסיציקלין אסור בהיריון). לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | **אין רגישות לתרופה** | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | **מכתב או הנחיה כתובה** | מכתב מהגורם המפנה (תאריך, שם ותפקיד, ההנחיה) מ-3 החודשים האחרונים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | **תפקוד כליות תקין (במלרון)** | eGFR אחרון 30 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | **משך וכמות בגבולות** | לפי מכתב מרפאת המטיילים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 7 | **לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה** | אין חום או מחלה פעילה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 8 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **הוראות ואזהרות למטופל/ת** | לפי מכתב מרפאת המטיילים: להתחיל לפני הנסיעה ולהמשיך אחרי החזרה כפי שנקבע, עם אוכל ועם כוס מים מלאה. דוקסיציקלין: לא לשכב חצי שעה אחרי הנטילה, ולהגן מהשמש. חום בזמן הטיול או בחודשים שאחריו — יש לפנות מיד לרופא ולספר על הטיול. |
| **מקור** | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 13.46 מניעת מחלת גבהים (אורמוקס) · Altitude sickness prevention

הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · לפני טיסה

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (1)** | אורמוקס · Uramox |
| **נימוק / הערה** | אצטזולמיד לטרקים בגובה רב. סולפונאמיד: לא ברגישות לסולפה, באבנים בכליות או באי-ספיקת כליות. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **גיל 18 ומעלה** | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | **לא בהיריון ולא מניקה** | אין היריון או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | **אין רגישות לתרופה** | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | **מכתב או הנחיה כתובה** | מכתב מהגורם המפנה (תאריך, שם ותפקיד, ההנחיה) מ-3 החודשים האחרונים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | **אין רגישות לסולפה, אבנים בכליות או אי-ספיקת כליות** | ברשומה אין רגישות לסולפונאמידים, אבנים בכליות, eGFR מתחת ל-30 או מחלת כבד קשה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | **משך וכמות בגבולות** | לפי משך הטרק. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 7 | **לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה** | אין מחלה פעילה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 8 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | **אין התארת אינטראקציה** | כל התארת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **הוראות ואזהרות למטופל/ת** | לפי מכתב מרפאת המטיילים: להתחיל יום לפני העלייה לגובה. נימול באצבעות ושינוי בטעם משקאות מוגזים — צפויים. כאב ראש חזק, הקאות, קוצר נשימה במנוחה או בלבול בגובה — לרדת מיד ולפנות לטיפול רפואי. |
| **מקור** | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.47 **אנטיביוטיקה "למקרה הצורך" לשלשול מטיילים** · Travellers' diarrhoea standby antibiotic

הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · לפני טיסה

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (3)** | אזניל כמוסות · Azenil \| אזיתרומיצין אינובמד · Azithromycin Inovamed \| זטו · Zeto |
| **נימוק / הערה** | רק לפי מכתב של מרפאת מטיילים, ליעדים שבהם מומלץ. מנה או קורס קצר כשמופיע שלשול קשה בטיול. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **גיל 18 ומעלה** | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | **לא בהיריון ולא מניקה** | אין היריון או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | **אין רגישות לתרופה** | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | **מכתב או הנחיה כתובה** | מכתב מהגורם המפנה (תאריך, שם ותפקיד, ההנחיה) מ-3 החודשים האחרונים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | **אין הארכת QT או תרופות שמאריכות QT** | ברשומה אין QT ארוך, ואין תרופות קבועות שמאריכות QT. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | **משך וכמות בגבולות** | קורס אחד. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 7 | **לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה** | אין מחלה פעילה עכשיו. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 8 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **הוראות ואזהרות למטופל/ת** | לקחת רק אם מופיע בטיול שלשול קשה (יותר מ-3 יציאות ביום עם חום או דם, או שמפריע לתפקוד), לפי ההוראה שעל המרשם. לשתות הרבה. אם יש חום גבוה, דם רב או התייבשות, יש לפנות לטיפול רפואי במקום. |
| **מקור** | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.48 מחלת תנועה (טרבמין) · Motion sickness הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · לפני טיסה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | טרבמין טבליות · Travamin Tablets \| סטונרון טבליות · Stunarone Tablets |
| נימוק / הערה | לבחילה בנסיעה. מרדים; להימנע בגיל 65 ומעלה, בגלאוקומה ובהגדלת ערמונית. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | לא בהיריון ולא מניקה | אין היריון או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | מתחת לגיל 65 | גיל מתחת ל-65. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | אין גלאוקומה או הגדלת ערמונית | ברשומה אין גלאוקומה עם זווית סגורה או אצירת שתן. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | משך וכמות בגבולות | לנסיעה אחת או לטיול. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 7 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין סחרחורת חדשה שלא בזמן נסיעה, כאב ראש חזק או הקאות שלא קשורות לנסיעה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | טבליה אחת חצי שעה עד שעה לפני הנסיעה, ולפי הצורך כל 6–8 שעות לפי העלון. גורם לישנוניות: לא לנהוג ולא לשתות אלכוהול. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 13.49 **אנטיביוטיקה לתסמין חדש** · Antibiotics for a new symptom רופא/ה בלבד

רופא/ה בלבד · אנטיביוטיקה

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (38)** | אמוקסיצילין מדו · Amoxicillin Medo | אמוקסי קאר פורטה · Amoxy Care Forte | מוקסיפן חדש כמוסות · Moxypen New | מוקסיפן פורטה · Moxypen Forte | מוקסיויט · Moxyvit | מוקסיויט פורטה · Moxyvit Forte | ויטאמוקס פורטה · Vitamox Forte | אמוקסיקלב טבע · Amoxiclav Teva | אוגמנטין · Augmentin | מאקליבן · Maclivan | פן-רפא וי-ק · Pen-Rafa Vk | צפואבניר · Cefuavenir | זינט טבליות · Zinnat | צפוויט · Cefovit | צפוויט פורטה · Cefovit Forte | אזניל כמוסות · Azenil | אזיתרומיצין אינובמד · Azithromycin Inovamed | זטו · Zeto | קארין · Karin | קלאסיד SR טבליות · Klacid Sr | ניטרופורנטואין רז · Nitrofurantoin Raz | פוספומיצין ד.ק.ל. · Fosfomycin D.K.L. | מונורול · Monurol | ציפרודקס · Ciprodex | לבו · Levo | טאבניק טבליות · Tavanic | פלאג'יל · Flagyl | רוקסו 150 · Roxo 150 | מגקסין טבליות · Megaxin Tablets | ספקטרצף 200 מ"ג · Spectracef 200 MG | ספקטרצף 400 מ"ג · Spectracef 400 MG | פרוטוסייד · Protocide (טינידזול) | צפטריאקסון מדו 1 גרם · Ceftriaxone Medo 1 GR (בהזרקה) | צפטריאקסון אס.קיי. · Ceftriaxone S.K. (בהזרקה) | צפטריאקסון-ויט · Ceftriaxone-Vit (בהזרקה) | מאקרוביד · Macrobid | אופלודקס · Oflodex | אופלוקסצין טבע 200 מ"ג · Ofloxacin Teva |
| **נימוק / הערה** | בקשה לאנטיביוטיקה בגלל תסמין (גרון, אוזן, סינוסים, שיעול, שתן, עור): צריך הערכה של רופא/ה. הרפואן לא מכין מרשם. להעביר לרופא/ה את הפנייה: התסמינים, מתי התחילו, חום, ותרביות קודמות. אנטיביוטיקה מונעת לפי מכתב (שיניים, טיול) — בפריט נפרד. חריג: מוקסיפן או רפאפן אחרי משטח גרון חיובי — בפריט נפרד. |
| **הנחיה** | **בקשה לאנטיביוטיקה בגלל תסמין (גרון, אוזן, סינוסים, שיעול, שתן, עור): צריך הערכה של רופא/ה. הרפואן לא מכין מרשם. להעביר לרופא/ה את הפנייה: התסמינים, מתי התחילו, חום, ותרביות קודמות. אנטיביוטיקה מונעת לפי מכתב (שיניים, טיול) — בפריט נפרד.** |

| | |
|---|---|
| **מקור** | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 13.50 **מוקסיפן או רפאפן אחרי משטח גרון חיובי** · Penicillin for positive strep test לפי הנחיה

אנטיביוטיקה · דלקת גרון

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (3)** | מוקסיפן חדש כמוסות · Moxypen New | מוקסיפן פורטה · Moxypen Forte | פן-רפא וי-ק · Pen-Rafa Vk |
| **נימוק / הערה** | חריג לאנטיביוטיקה לתסמין חדש: מוקסיפן או רפאפן אחרי משטח גרון חיובי. הצהרת המטופל/ת על בדיקה ביתית חיובית מספיקה. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | משטח גרון חיובי | תוצאה חיובית במרפאה, או הצהרת המטופל/ת שבדיקה ביתית יצאה חיובית. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | אין רגישות לפניצילין | ברשומה אין רגישות לפניצילין או לצפלוספורינים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 4 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | קושי בנשימה או בבליעה, ריור ← דחוף |
| **מקור** | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 13.51 תרופות נגד שפעת (טמיפלו, קסופלוזה, רלנזה) · Oseltamivir רופא/ה בלבד

רופא/ה בלבד · נגד שפעת

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | טמיפלו · Tamiflu | קסופלוזה 40 מ"ג · Xofluza 40 MG (בלוקסביר) | רלנזה · Relenza (זנמיביר) |
| נימוק / הערה | טיפול או מניעה של שפעת: החלטה של רופא/ה לפי זמן מהופעת התסמינים וגורמי סיכון. להעביר לרופא/ה באותו יום. |
| הנחיה | **טיפול או מניעה של שפעת: החלטה של רופא/ה לפי זמן מהופעת התסמינים וגורמי סיכון. להעביר לרופא/ה באותו יום.** |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 13.52 גלולה ליום שאחרי (פוסטינור, אלה) · Emergency contraception דגל אדום

דחוף באותו יום

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | פוסטינור · Postinor | נורלבו · Norlevo | אלה · Ella |
| נימוק / הערה | גלולה ליום שאחרי: דחוף, באותו יום. הרפואן מכין ומציג לרופא/ה מיד. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | בתוך חלון הזמן | עברו עד 72 שעות (פוסטינור) או עד 120 שעות (אלה) מקיום יחסי מין לא מוגנים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | טופל באותו יום | הבקשה הוצגה לרופא/ה באותו יום. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 3 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 5 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 13.53 **טיפול בפטרת או בזיהום נרתיקי (פלוקונזול, אגיסטן V, זידובל)** · Vaginal and oral antifungals

לפי הנחיה

נשים

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (9)** | פלוקנול · Flucanol | פלוקונאזול טבע · Fluconazole Teva | טריקאן · Trican | אגיסטן וי · Agisten V | קנסטן וי · Canesten V | קלוטרי · Clothree | גינו פבאריל 150 מ"ג · Gyno Pevaryl 150 MG | זידובל 7.5 מ"ג/ג' ג'ל וגינלי · Zidoval (מטרונידזול נרתיקי) | קלינדה · Calinda (קלינדמיצין נרתיקי) |
| **נימוק / הערה** | פטרת נרתיקית: טיפול מקומי או פלוקונזול. פלוקונזול — לא בהיריון; אינטראקציות נבדקות במערכת. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | לא בהיריון ולא מניקה | אין היריון או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | משך וכמות בגבולות | טיפול אחד; לא יותר מ-3 פניות בשנה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין חום, כאב בטן, הפרשה עם ריח רע, דימום, או פצעים באיברי המין. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2OP = 2 אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **מקור** | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 13.54 **טיפול בפטרת בפה (דקטרין ג'ל, ניסטטין)** · Oral thrush treatment

לפי הנחיה

פה

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (4)** | דקטרין אורל ג'ל · Daktarin Oral Gel | אגיסטן לכסניות · Agisten Lozenges | ניסטטין רדי מיקס · Nystatin Ready Mix | ניסטטין תרו · Nystatin Taro |
| **נימוק / הערה** | פטרת בפה (דקטרין ג'ל, ניסטטין). דקטרין ג'ל — אינטראקציה עם וורפרין, נבדקת במערכת. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | משך וכמות בגבולות | טיפול אחד עד שבועיים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין קושי או כאב בבליעה, חום, או פטרת חוזרת בלי סיבה ידועה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2OP = 2 אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **מקור** | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.55 טיפות אנטיביוטיות לעיניים, וטיפות לאוזניים · Antibiotic eye and ear drops

לפי הנחיה

עיניים ואוזניים

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (25) | כלורמפניקול פיזיופארמה · Chloramphenicol Fisiopharma \| כלורמפניקול וואב · Chloramphenicol Vuab \| פניקול · Phenicol \| סינטומיצין % · Synthomycine \| פוסיתלמיק טיפות עיניים צמיגות · Fucithalmic Viscous Eye Drops \| אוטומיצין · Otomycin \| סילוקסן · Ciloxan \| פלוקסל · Floxal \| אייטוברין · Eyetobrin \| טוברקס משחת עיניים · Tobrex Ophthalmic Ointment \| ויגמוקס · Vigamox \| סולפאסיד · Sulfacid \| בסיוונס · Besivance 0.6 % \| אוטידין טבע · Otidin Teva (טיפות הרדמה לאוזן) \| אנאסתטיק · Anaesthetic (טיפות הרדמה לאוזן) \| אופלוקס · Oflox \| אופלוקסצין אדול · Ofloxacin Edol \| ציפלוקס · Ciplox \| לקרומיצין טיפות עינים · Lacromycin Eye Drops \| אופטי גנטה · Opti Genta \| לבוקורט · Levocort \| לוודסה · Levodesa \| מוקסיפלוקסן אס.קיי. · Moxifloxan S.K. \| דזורן טפות אזניים · Desoren Ear Drops \| סטרקסל · Cetraxal (טיפות אוזניים: ציפרופלוקסצין + פלואוצינולון) |
| נימוק / הערה | טיפות אנטיביוטיות לעין או לאוזן, לטיפול קצר. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | משך וכמות בגבולות | טיפול אחד עד שבוע. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | בעין: אין כאב, ירידה בראייה, רגישות לאור או עדשות מגע; באוזן: אין חום גבוה, נפיחות מאחורי האוזן או ירידה בשמיעה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.56 קורס סטרואידים בבליעה (פרדניזון, מדרול) · Oral corticosteroid course

דגל אדום

סטרואידים

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (4) | פרדניזון רקח · Prednisone Rekah \| מדרול 4 מ"ג · Medrol 4 MG \| בטנזול · Betnesol \| סטרוקורט 4 מ"ג · Sterocort |
| נימוק / הערה | קורס סטרואידים בבליעה (פרדניזון, מדרול) אינו רגיל: הרפואן מכין, והרופא/ה בודק/ת שוב לפני האישור. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | סיבה ומינון מתועדים | ההתוויה (אסתמה, אלרגיה, אחר), המינון ומשך הקורס מתועדים בבקשה או בהמלצה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | סוכרת ידועה | בסיכום לרופא/ה צוין אם יש סוכרת (סטרואיד מעלה סוכר). לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | לא קורסים חוזרים | לא ניתן קורס סטרואידים ב-3 החודשים האחרונים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 5 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 13.57 תרופות נגד בחילה (אונדנסטרון) · Anti-nausea drugs לפי הנחיה

בחילות

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | אונדנסטרון אינובמד · Ondansetron Inovamed \| זופרן טבליות · Zofran |
| נימוק / הערה | אונדנסטרון (זופרן) לבחילות: הארכת QT; בהיריון — לפי ההנחיה. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | לא בהיריון ולא מניקה | אין היריון או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | משך וכמות בגבולות | טיפול קצר, עד שבוע. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין הקאות מתמשכות, התייבשות, כאב בטן או כאב ראש חזק. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 13.58 מדללי ליחה (אצטילציסטאין, קרבוציסטאין, ברומהקסין) · Mucolytics הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · שיעול

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (11) | ראולין טבליות תוססות · Reolin Effervescent \| סירן · Siran \| מיקל טבליות · Mical \| מוקוליט · Mucolit \| מוקוליט תמיסה למתן דרך הפה · Mucolit Oral Solution \| טיפטיפות מוקוליט · Tiptipot Mucolit \| מווקס תמיסה · Movex Solution \| מווקס טבליות · Movex \| מוקולס תמיסה · Mucoless Solution \| מוקולס טבליות · Mucoless \| ארדוטין · Erdotin |
| נימוק / הערה | לשיעול עם ליחה סמיכה. קרבוציסטאין וברומהקסין — לא בכיב קיבה פעיל. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | לא בהיריון ולא מניקה | אין היריון או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | אין כיב קיבה פעיל | ברשומה אין כיב פפטי פעיל. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | משך וכמות בגבולות | עד 10 ימים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין שיעול מעל 3 שבועות, שיעול דמי, קוצר נשימה, צפצופים, כאב בחזה, חום מעל 3 ימים או ירידה במשקל. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | לפי ההוראות שבעלון, עם הרבה שתייה, עד 10 ימים. אם השיעול נמשך מעל 3 שבועות, יש דם בכיח, קוצר נשימה או חום מעל 3 ימים, יש לפנות לרופא. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.59 תכשירי צמחים לשיעול ולסינוסים (ברונכיקליר, קלובה, סינוקליר) · Herbal cough and sinus preparations

הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · שיעול וסינוסים

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (8)** | ברונכיקליר נוזל לשתייה · Bronchiclear Oral Liquid | ברונכיקליר טבליות · Bronchiclear | קלובה טבליות · Kaloba Tablets | קלובה סירופ · Kaloba Syrup | סינוקליר אקסטרקט טבליות · Sinuclear Extract | סינוקליר סירופ · Sinuclear Syrup | סינוקליר טבליות · Sinuclear | טסלין · Tesalin (פטסיטס, לנזלת אלרגית) |
| **נימוק / הערה** | תכשירי צמחים. קלובה (פלרגוניום) — לא במחלת כבד ולא עם נוגדי קרישה. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **גיל 18 ומעלה** | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | **לא בהיריון ולא מניקה** | אין היריון או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | **אין רגישות לתרופה** | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | **אין מחלת כבד ואין נוגדי קרישה (בקלובה)** | ברשומה אין מחלת כבד ואין טיפול בנוגדי קרישה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | **משך וכמות בגבולות** | עד 10 ימים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | **לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה** | אין שיעול מעל 3 שבועות, שיעול דמי, קוצר נשימה, צפצופים, כאב בחזה, חום מעל 3 ימים או ירידה במשקל; אין כאב חזק בפנים או בשיניים, או נזלת מעל 10 ימים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 7 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **הוראות ואזהרות למטופל/ת** | לפי ההוראות שבעלון, עד 10 ימים. אם מופיעים חום מעל 3 ימים, כאב חזק בפנים, קוצר נשימה או שיעול מעל 3 שבועות, יש לפנות לרופא. |
| **מקור** | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.60 תכשירים לאפטות ולכאב בפה (אורקורט, טיג'ל) · Mouth ulcer and gum preparations

הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · פה

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (2)** | אורקורט · Oracort \| טיג'ל ג'ל · Teejel Gel |
| **נימוק / הערה** | לאפטה קטנה או לכאב מקומי בפה. פצע בפה מעל 3 שבועות — לרופא/ה (חשד לגידול). טיג'ל מכיל סליצילט. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **גיל 18 ומעלה** | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | **לא בהיריון ולא מניקה** | אין היריון או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | **אין רגישות לתרופה** | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | **אין רגישות לאספירין (בטיג'ל)** | ברשומה אין רגישות לאספירין. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | **משך וכמות בגבולות** | עד 7 ימים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | **לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה** | אין פצע בפה מעל 3 שבועות, פצעים רבים, חום, נפיחות בפנים, קושי לבלוע או נגע לבן שלא יורד. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 7 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **הוראות ואזהרות למטופל/ת** | למרוח כמות קטנה על הפצע עד 3–4 פעמים ביום, אחרי האוכל. אם הפצע לא נרפא תוך שבועיים, או שיש חום או פצעים רבים, יש לפנות לרופא. |
| **מקור** | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.61 טיפות עיניים נגד אודם (טטריזולין) · Decongestant eye drops הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · עיניים

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (8) | אזולין · Azolin \| איי רליף · Eye Relief \| סטילה סינגלס · Stilla Singles \| וי-זולין · V-Zoline \| וייזין אוריגינל טיפות עיניים · Visine Original Eye Drops \| ויזין רליף · Visine Relief \| וויו · View \| דקספרין טיפות · Dexefrin Eye Drops |
| נימוק / הערה | מכווצות כלי דם בעין: לשימוש קצר בלבד (עד 3 ימים), אחרת אודם חוזר. לא בגלאוקומה עם זווית סגורה. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אין גלאוקומה | ברשומה אין גלאוקומה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | משך וכמות בגבולות | עד 3 ימים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין כאב בעין, ירידה בראייה, רגישות לאור, הפרשה מוגלתית, אודם בעין אחת או חבלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | טיפה בכל עין עד 3 פעמים ביום, לא יותר מ-3 ימים. אם האודם נמשך, או שיש כאב, ירידה בראייה או הפרשה, יש לפנות לרופא. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.62 עזרי שינה ללא מרשם (דוקסילמין, ולריאן) · Sleep aids (non-prescription) הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · שינה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (12) | סליפ אייד · Sleep Aid (דוקסילמין) \| טונייט · Tonight (דוקסילמין) \| קלמנרבין אס אליקסיר · Calmanervin S Elixir \| קלמנרבין טבליות · Calmanervin \| דורמינול לילה · Dorminol Night \| דורמינול לילה פורטה · Dorminol Night Forte \| נרבן · Nerven \| רלקסין · Relaxine \| ולריאן טינקטורה כצט · Valerian Tincture Cts \| ואלטון טיפות · Valeton Drops \| לסאה · Lasea (שמן לבנדר) \| לבקאלם · Lavecalm (שמן לבנדר) |
| נימוק / הערה | לקשיי שינה זמניים. דוקסילמין — אנטיהיסטמין מרדים: לא בגיל 65 ומעלה, בגלאוקומה, בהגדלת ערמונית או עם תרופות מרדימות. נדודי שינה מתמשכים — הערכה (דיכאון, חרדה, דום נשימה בשינה). |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | לא בהיריון ולא מניקה | אין היריון או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | מתחת לגיל 65 (בדוקסילמין) | גיל מתחת ל-65. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | אין גלאוקומה או הגדלת ערמונית (בדוקסילמין) | ברשומה אין גלאוקומה עם זווית סגורה או אצירת שתן. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | אין תרופות מרדימות קבועות | אין בנזודיאזפינים, אופיואידים, תרופות שינה או נוגדי פסיכוזה בתרופות הקבועות. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 7 | משך וכמות בגבולות | עד שבועיים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 8 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין מחשבות על מוות או פגיעה עצמית, מצב רוח ירוד או חרדה קשה, נחירות עם הפסקות נשימה, או נדודי שינה מעל חודש. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 9 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 10 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | לקחת חצי שעה לפני השינה, רק בלילות שצריך, עד שבועיים. לא לנהוג בבוקר אם יש ישנוניות, ולא לשתות אלכוהול. אם נדודי השינה נמשכים, או שיש מצב רוח ירוד או מחשבות קשות, יש לפנות לרופא. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.63 תרופות נגד תולעים (ורמוקס, אסקזול) · Anthelmintics

הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · טפילים

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | ורמוקס טבליות · Vermox Tablets \| אסקזול · Eskazole |
| נימוק / הערה | לתולעי סיכה (אוקסיאורים). מטפלים בכל בני הבית, וחוזרים אחרי שבועיים. לא בהיריון. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | לא בהיריון ולא מניקה | אין היריון או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | אבחנה או חשיפה ידועה | תולעים שנראו, או בן בית שאובחן. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | משך וכמות בגבולות | מנה אחת, וחזרה אחרי שבועיים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין כאב בטן חזק, דם בצואה, ירידה במשקל, או תולעים שנראו אחרי טיול בחו"ל. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 7 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | טבליה אחת, ולחזור אחרי שבועיים. לטפל בכל בני הבית באותו יום, לכבס מצעים ומגבות, לגזור ציפורניים ולשטוף ידיים היטב. אם מופיעים כאב בטן חזק או דם בצואה, יש לפנות לרופא. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.64 קרם קפסאיצין (זוסטריקס) · Capsaicin cream

הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · כאב מקומי

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | זוסטריקס · Zostrix \| זוסטריקס HP · Zostrix-HP |
| נימוק / הערה | לכאב נוירופתי מקומי ולכאב מפרקים. צריבה בהתחלה — צפויה. לא על עור פצוע או ליד העיניים. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | משך וכמות בגבולות | עד 3 חודשים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין פצע או זיהום באזור, ואין כאב חדש שלא הוערך. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | למרוח שכבה דקה 3–4 פעמים ביום ולשטוף ידיים מיד אחרי. צריבה בשבועות הראשונים צפויה ויורדת. לא לגעת בעיניים ולא על עור פצוע. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.65 משחות מחממות וצמחים לכאב שרירים (טראומפלנט, בנגיי, טייגר באלם) · Comfrey and herbal topical pain

הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · כאב מקומי

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (6)** | טראומפלנט · Traumaplant | בנגיי אולטרא חזק · Bengay Ultra Strength | טייגר באלם אדום · Tiger Balm Red | טייגר באלם לבן · Tiger Balm White | רדיאן B מאסז' · Radian B Muscle Rub | רדיאן בי ספריי · Radian B Spray |
| **נימוק / הערה** | לחבלות קלות ולנקעים. לא על עור פצוע, ולא יותר מ-10 ימים. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **גיל 18 ומעלה** | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | **אין רגישות לתרופה** | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | **משך וכמות בגבולות** | עד 10 ימים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | **לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה** | אין חבלה עם חשד לשבר, נפיחות גדולה, מפרק לא יציב או כאב שמחמיר. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 5 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **הוראות ואזהרות למטופל/ת** | למרוח 2–4 פעמים ביום על עור שלם בלבד, עד 10 ימים. אם יש כאב חזק, נפיחות גדולה או קושי לדרוך, יש לפנות לרופא. |
| **מקור** | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 13.66 תוספים לשחיקת סחוס (גלוקוזאמין, דיאצרין) · Osteoarthritis supplements

הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · מפרקים

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (3) | ארתריל · Arthryl \| ארתריל גו · Arthryl Go \| דיאטרים · Diatrim (דיאצרין) |
| נימוק / הערה | תועלת מוגבלת. גלוקוזאמין — זהירות עם וורפרין. דיאצרין — שלשולים; לא בגיל 65 ומעלה ולא במחלת כבד. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | לא בהיריון ולא מניקה | אין היריון או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | אין וורפרין (בגלוקוזאמין) | בתרופות הקבועות אין וורפרין. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | אין מחלת כבד (בדיאצרין) | ברשומה אין מחלת כבד. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | משך וכמות בגבולות | עד 3 חודשים, ואז הערכה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 7 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין מפרק חם, אדום ונפוח, חום, או כאב חדש וחזק. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 8 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | לפי ההוראות שבעלון. ההשפעה, אם יש, מגיעה אחרי כמה שבועות. דיאצרין עלול לגרום לשלשול ולשינוי צבע השתן. אם אין שיפור תוך 3 חודשים, אין טעם להמשיך. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 13.67 הזעת יתר (אנהידרול פורטה) · Hyperhidrosis

הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · עור

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | אנהידרול פורטה · Anhydrol Forte |
| נימוק / הערה | אלומיניום כלוריד להזעת יתר מקומית. הזעה כללית, בלילה או עם ירידה במשקל — לרופא/ה. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | משך וכמות בגבולות | עד 3 חודשים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין הזעות לילה, חום, ירידה במשקל, דפיקות לב או הזעה בכל הגוף שהופיעה לאחרונה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | למרוח בלילה על עור יבש לגמרי ולשטוף בבוקר, כל לילה עד שיפור ואז פעם–פעמיים בשבוע. לא על עור מגולח טרי או פצוע. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.68 טיפול בנשירת שיער (מינוקסידיל, פרופסיה) · Minoxidil (hair loss)

הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · עור

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (6) | הרגיין % · Hairgain | הרגיין קצף · Hairgain Foam | מינוקסי · Minoxi | נוקסידיל % · Noxidil | נוקסידיל קצף · Noxidil Foam | פרופסיה · Propecia (פינסטריד 1 מ"ג, לגברים) |
| נימוק / הערה | לנשירה תורשתית. נשירה פתאומית, במוקדים או עם סימנים נוספים — לרופא/ה. אסור בהיריון. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | לא בהיריון ולא מניקה | אין היריון או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | משך וכמות בגבולות | עד 6 חודשים, ואז הערכה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין נשירה פתאומית, מוקדי קרחת, קרקפת אדומה או מקשקשת, או סימנים נוספים (עייפות, מחזור לא סדיר). לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | למרוח על קרקפת יבשה פעמיים ביום (קצף: פעם ביום), ולשטוף ידיים. בחודשים הראשונים ייתכן שהנשירה תתגבר לפני השיפור; התוצאה נשמרת רק בזמן הטיפול. אם מופיעים סחרחורת, דפיקות לב או נפיחות, יש להפסיק ולפנות לרופא. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.69 **תכשירי צמחים לגיל המעבר ולתסמונת קדם-וסתית** · Menopause and PMS herbal products

הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · בריאות האישה

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (5)** | מנופרט · Menopret \| צימידונה 6.5 מ"ג · Cimidona 6.5 MG \| צימידונה פורטה 13 מ"ג · Cimidona Forte 13 MG \| פרפמין · Prefemin \| אגנוקסטון · Agnucaston |
| **נימוק / הערה** | צימיציפוגה (מנופרט, צימידונה) — דיווחים על פגיעה כבדית. אגנוס קסטוס (פרפמין) — לא עם טיפול הורמונלי. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **גיל 18 ומעלה** | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | **לא בהיריון ולא מניקה** | אין היריון או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | **אין רגישות לתרופה** | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | **אין מחלת כבד** | ברשומה אין מחלת כבד. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | **אין סרטן תלוי הורמונים** | ברשומה אין סרטן שד או רחם. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | **משך וכמות בגבולות** | עד 3 חודשים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 7 | **לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה** | אין דימום לא סדיר, דימום אחרי גיל המעבר, צהבת או שתן כהה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 8 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **הוראות ואזהרות למטופל/ת** | לפי ההוראות שבעלון. דימום לא סדיר, דימום אחרי גיל המעבר, צהבת או שתן כהה — יש להפסיק ולפנות לרופא. |
| **מקור** | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.70 תכשירי צמחים לערמונית ולדרכי השתן (פרמיקסון, קנפרון) · Herbal urology preparations

הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · דרכי שתן

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (2)** | פרמיקסון 160 מ"ג · Permixon 160 MG \| קנפרון · Canephron |
| **נימוק / הערה** | לתסמיני ערמונית ידועים או לתמיכה בדרכי השתן. דם בשתן, צריבה עם חום או תסמינים חדשים — לרופא/ה. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **גיל 18 ומעלה** | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | **אין רגישות לתרופה** | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | **אבחנה ידועה** | הגדלת ערמונית מאובחנת או תסמינים שהוערכו בעבר. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | **משך וכמות בגבולות** | עד 3 חודשים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | **לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה** | אין דם בשתן, חום, כאב בגב או במותן, אצירת שתן או קושי חדש להטיל שתן. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 6 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **הוראות ואזהרות למטופל/ת** | לפי ההוראות שבעלון. אם מופיעים דם בשתן, חום, כאב במותן או קושי להטיל שתן, יש לפנות לרופא. |
| **מקור** | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.71 גינקו בילובה (צרבונין, טבוקן) · Ginkgo biloba הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · תוספי צמחים

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (3)** | צרבונין 120 מ"ג · Cerebonin 120 MG \| צרבונין פורטה 240 מ"ג · Cerebonin Forte 240 MG \| טבוקן · Tebokan |
| **נימוק / הערה** | תועלת לא מוכחת בזיכרון. מגביר דימום: לא עם נוגדי קרישה, מעכבי טסיות או לפני ניתוח. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **גיל 18 ומעלה** | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | **לא בהיריון ולא מניקה** | אין היריון או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | **אין רגישות לתרופה** | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | **אין נוגדי קרישה או מעכבי טסיות** | בתרופות הקבועות אין נוגדי קרישה, אספירין או קלופידוגרל. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | **אין ניתוח מתוכנן** | אין ניתוח או פעולה פולשנית בשבועיים הקרובים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | **משך וכמות בגבולות** | עד 3 חודשים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 7 | **לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה** | אין ירידה חדשה בזיכרון או בתפקוד שלא הוערכה, סחרחורת חדשה או חולשה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 8 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 9 | **אין התארת אינטראקציה** | כל התארת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **הוראות ואזהרות למטופל/ת** | לפי ההוראות שבעלון. להפסיק שבועיים לפני ניתוח או טיפול שיניים. דימום חריג או חבורות — להפסיק ולפנות לרופא. |
| **מקור** | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 13.72 תכשירים לאי-ספיקה ורידית (ונורוטון) · Venotonics הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · כלי דם

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | ונורוטון כמוסות 300 מ"ג · Venoruton Capsules 300 MG |
| נימוק / הערה | לנפיחות וכבדות ברגליים באי-ספיקה ורידית. נפיחות ברגל אחת, כאב או אודם — לרופא/ה (חשד לקריש דם). |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | לא בהיריון ולא מניקה | אין היריון בשליש הראשון או הנקה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | משך וכמות בגבולות | עד 3 חודשים. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין נפיחות ברגל אחת, כאב בשוק, אודם וחום ברגל, קוצר נשימה או פצע ברגל. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| הוראות ואזהרות למטופל/ת | כמוסה 2–3 פעמים ביום עם אוכל. אם מופיעים נפיחות ברגל אחת, כאב בשוק, אודם או קוצר נשימה, יש לפנות מיד לרופא. |
| מקור | החלטה מקומית (5.11.2026); עלון לצרכן של התכשירים |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 13.73 פקסלוביד (קורונה) · Paxlovid דגל אדום

קורונה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | פקסלוביד · Paxlovid |
| נימוק / הערה | פקסלוביד: אינטראקציות רבות וחובה להתחיל תוך 5 ימים מהתסמינים. הרפואן מכין עם תפקוד כליות, והרופא/ה מאשר/ת. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | בדיקת קורונה חיובית | בדיקה חיובית (ביתית או במרפאה) מדווחת או מתועדת. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | עד 5 ימים מתחילת התסמינים | תחילת התסמינים לפני 5 ימים לכל היותר. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | תפקוד כליות | eGFR מהשנה האחרונה (מתחת ל-60 — מינון מופחת). אין ← חידוש לחודש אחד וזימון לבדיקה. | זימון |
| 4 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 5 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 13.74 פנזופירידין (סדורל) · Phenazopyridine לפי הנחיה

דרכי שתן

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | סדורל · Sedural |
| נימוק / הערה | פנזופירידין (סדורל) משכך צריבה בשתן ואינו מטפל בזיהום. צובע את השתן בכתום. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | לא בהיריון ולא מניקה | אין היריון או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | משך וכמות בגבולות | עד יומיים-שלושה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין חום, כאב גב או צד, דם בשתן, או היריון. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 13.75 חומצה טרנקסמית (הקסאקפרון) · Tranexamic acid לפי הנחיה

דימום

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | הקסאקפרון טבליות · Hexakapron Tablets |
| נימוק / הערה | חומצה טרנקסמית (הקסאקפרון), לרוב לדימום וסתי מוגבר. אסורה עם קרישי דם בעבר. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | לא בהיריון ולא מניקה | אין היריון או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | משך וכמות בגבולות | לימי הדימום בלבד. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין קרישי דם בעבר (פקקת ורידים, תסחיף, שבץ), ואין דימום חריג או חדש. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 13.76 מיזופרוסטול ומיפפריסטון (ציטוטק, מיפג'ין) · Misoprostol דגל אדום

הכנה לרופא/ה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | ציטוטק 200 מק"ג טבליות · Cytotec 200 MCG Tablets \| מיפג'ין · Mifegyne |
| נימוק / הערה | מיזופרוסטול (ציטוטק): אסור בהיריון, אלא לסיום היריון או לפעולה גינקולוגית. הרפואן מכין, והרופא/ה מאשר/ת. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | התוויה מתועדת | המלצה של רופא/ה עם ההתוויה (הגנה על הקיבה, פעולה גינקולוגית, סיום היריון). לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | היריון נבדק | בסיכום לרופא/ה צוין אם יש היריון או אפשרות להיריון. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 4 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 13.77 תרופות בהזרקה לטיפול מיידי במרפאה (כאב, בחילה, אלרגיה) · Clinic injections for immediate treatment דגל אדום

הזרקה במרפאה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (6) | קטורולק רומפארם 30 מ"ג/מ"ל · Ketorolac Trometamol Rompharm 30 MG/ML \| פרמין להזרקה · Pramin Injection \| פנרגן 50 מ"ג/2 מ"ל · Phenergan 50 MG/2 ML \| דקסמתזון רומפארם 4 מ"ג/מ"ל · Dexamethasone Rompharm 4 MG/ML \| אדרנלין 1 מ"ג/מ"ל · Adrenaline S.A.L.F 1 MG/ML \| קונקיון 10 מ"ג/מ"ל · Konakion MM 10 MG/ML (ויטמין K) |
| נימוק / הערה | תרופות בהזרקה לטיפול מיידי במרפאה (קטורולק, פרמין, פנרגן, דקסמתזון, אדרנלין, קונקיון). הרפואן מכין, והרופא/ה מאשר/ת לפני ההזרקה. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | הוראה וסיבה | יש הוראה של רופא/ה עם הסיבה, התרופה והמינון. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 4 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| תלונות בפנייה או ברשומה | תגובה אלרגית קשה או קוצר נשימה ← דחוף: רופא/ה מיד או מד"א 101 |
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 13.78 אימונוגלובולין לטטנוס (היפרטט) · Tetanus immunoglobulin לפי הנחיה

אימונוגלובולינים

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | היפרטט · Hypertet S/D |
| נימוק / הערה | אימונוגלובולין לטטנוס אחרי פצע מזוהם, כשהחיסון לא מלא. לבדוק את היסטוריית החיסונים ברשומה. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | היסטוריית חיסונים | לפי הרשומה: פחות מ-3 מנות חיסון לטטנוס, או היסטוריה לא ידועה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | פצע מזוהם | פצע מזוהם, דקירה או פצע עם רקמה פגועה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 4 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 13.79 Anti-D בהיריון (רופילאק, Rho-D) · Anti-D immunoglobulin לפי הנחיה

אימונוגלובולינים

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | רופילאק 300 · Rho-D \| Rhophylac 300 (Anti-D) קמהדע · Rho-D Kamada (Anti-D) |
| נימוק / הערה | Anti-D לאישה בהיריון עם Rh שלילי: בשבוע 28 או אחרי דימום, חבלה או פעולה (עדיף תוך 72 שעות). |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | סוג דם Rh שלילי | סוג הדם של האם Rh שלילי, מתועד. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | קומבס עקיף שלילי | קומבס עקיף עדכני ללא נוגדני anti-D. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | סיבה ותזמון | שגרה בסביבות שבוע 28, או אחרי דימום, חבלה או פעולה — עדיף תוך 72 שעות. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | הוראה של הרופא/ה המטפל/ת בהיריון | הוראה של הגינקולוג/ית או מי שעוקב/ת אחרי ההיריון. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 6 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 13.80 היפריקום (רמוטיב) · St John's wort לפי הנחיה

צמחים

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (1) | רמוטיב 250 · Remotiv |
| נימוק / הערה | היפריקום (רמוטיב): האינטראקציות נבדקות במערכת המרשמים. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | גיל 18 ומעלה | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | לא בהיריון ולא מניקה | אין היריון או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | אין רגישות לתרופה | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | משך וכמות בגבולות | טיפול לחודש. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | אין החמרה במצב הרוח או מחשבות פגיעה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 6 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 7 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 13.81 טיפול בפיסורה (רקטוג'סיק, אנטרולין) · Anal fissure treatment לפי הנחיה

פיסורה

| | |
|---|---|
| שמות מסחריים (2) | רקטוג'סיק ® · Rectogesic \| אנטרולין · Antrolin |
| נימוק / הערה | רקטוג'סיק או אנטרולין לפיסורה חוזרת. אסור עם סילדנפיל או טדלפיל. תרופה לא כרונית: הרופא/ה מקבל/ת הודעה. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אבחנה או מרשמים קודמים | ברשומה אבחנה של פיסורה או מרשמים קודמים לאותו טיפול. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | אין סילדנפיל או טדלפיל | אין ויאגרה, סיאליס או דומיהן בתרופות. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה | בפנייה לא מתוארים דימום רב, כאב חזק, חום או שינוי ביציאות. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 4 | כמות, יחידות ותדירות | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 5 | אין התראת אינטראקציה | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| מקור | סקירת פריטים חסומים, החלטה מקומית (7.11.2026) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 13.82 תכשירי טרפנים לאבנים בדרכי השתן ובדרכי המרה (רווהטינקס, רווהכול) · Terpene preparations (urinary / biliary)

הכנה לאישור רופא/ה

קורס קצר · כליות ודרכי מרה

| | |
|---|---|
| **שמות מסחריים (2)** | רווהטינקס · Rowatinex (דרכי השתן) \| רווהכול · Rowachol (דרכי המרה) |
| **נימוק / הערה** | תכשירי צמחים (טרפנים) כתוספת בטיפול באבנים. לא מחליפים בירור של כאב, חום או דם בשתן. |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **גיל 18 ומעלה** | המטופל/ת בן/בת 18 ומעלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 2 | **לא בהיריון ולא מניקה** | אין היריון או הנקה ברשומה או בפנייה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 3 | **אין רגישות לתרופה** | ברשומה אין רגישות לתרופה או לקבוצה שלה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 4 | **אבחנה מתועדת של אבנים** | ברשומה יש אבחנה של אבנים בדרכי השתן או המרה. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 5 | **משך וכמות בגבולות** | עד חודש. לא ← לרופא/ה עם הבקשה. | |
| 6 | **לא מתוארים סימני אזהרה בפנייה** | אין חום, כאב חזק בצד או בבטן, צהבת או הקאות. לא ← לרופא/ה עם הבקשה, בדחיפות. | |
| 7 | **כמות, יחידות ותדירות** | לוודא כמות (2 = 2OP אריזות), יחידות (mg מול mcg) ותדירות (מתוטרקסט, אוזמפיק ואלנדרונט — פעם בשבוע). אי-התאמה ← לא מחדשים עד תשובת הרופא/ה. | |
| 8 | **אין התראת אינטראקציה** | כל התראת אינטראקציה, גם בין תרופות שניתנות זמן רב ← החידוש ממתין לתשובת הרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | חום עם כאב בצד או צמרמורות ← דחוף — מוקד או מיון; צהבת או כאב בטן חזק ← דחוף |
| **הוראות ואזהרות למטופל/ת** | לפי ההוראות שבעלון. חום, כאב חזק בצד או בבטן, צהבת או הקאות — לפנות לרופא/ה או למוקד. |
| **מקור** | פער מול הרג'יסטרי, החלטה מקומית (8.11.2026) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

# 14. אישורים

17 פריטים · לפי הנחיה: 7 · לפי הנחיה, בתנאים: 2 · הכנה לאישור רופא/ה: 2 · רופא/ה בלבד: 6 · גרסה 1.1 · 10.11.2026

מקורות: חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 07/2024 "מתן תעודות מחלה" (16.7.2024, בתוקף מ-1.9.2024); חוק זכויות החולה. שאר הערכים: החלטה מקומית; הנחיית מכבי לרופאי המשפחה – אישורים רפואיים (אוקטובר 2021)

## 14.א כללים

- הרפואן מפיק רק את סוגי האישורים שמסומנים "ביצוע לפי הנחיית הרופא/ה", בשם הרופא/ה המטפל/ת ובהנחייתו/ה
- כל אישור מתועד ברשומה: סוג, תאריכים, מה נבדק ומי הפיק
- אישור מחלה: בלי אבחנה. נוסח: "עקב בעיה רפואית הרשומה בתיק הרפואי"
- לא מפיקים אישור שמתחיל בעתיד. ההתחלה: היום, או מחר אם הפנייה הגיעה היום
- אישור קצר (בלי ביקור רופא): עד 4 ימים. בודקים כל יום מחלה בנפרד: ב-7 הימים שמסתיימים בו (כולל) לא יותר מ-4 ימים בתעודות קצרות (חוזר משרד הבריאות 7/2024, סעיף 8.1)
- היעדרות ילד/ה מגן או מבית ספר עד 4 ימים: לא נדרש אישור רופא — מספיק אישור בכתב מההורים (חוזר 7/2024, סעיף 9)
- רטרואקטיבי: רק לימים שמתועדים ברשומה. בלי תיעוד: רופא/ה בלבד
- מעל 4 ימים: רק לפי המלצה כתובה ברשומה. מעל 30 ימים לאותה מחלה: רופא/ה בלבד
- מידע לצד שלישי ומחלת בן/בת זוג או הורה: רק בהסכמת המטופל/ת
- כשירות, נפגע בעבודה: הרפואן מכין, הרופא/ה מאשר/ת. נשק (הצהרה), נהיגה, פטורים: רופא/ה בלבד
- סימן אזהרה בפנייה: לא מסתפקים באישור, העברה מיידית לרופא/ה
- לפני כל אישור: לבדוק את הפניות מ-5 הימים האחרונים (בקשה כפולה או חריגה ← לרופא/ה)
- אישור בריאות: נדרש ביקור במרפאה בשנה האחרונה; אחרת זימון
- קנאביס: לא מטופל ע"י רפואן, לרופא/ה
- אישור שאינו נדרש בחוק ואינו לצורך טיפול (אירוע ספורט, טיפול קוסמטי, התנדבות, תוכנית טלוויזיה), כשירות לפעילות או לעבודה, וכשירות לפרוצדורה שביקש רופא/ה אחר/ת (שיניים, קטרקט): מפיקים סיכום מידע רפואי בלבד, בלי קביעת כשירות (הנחיית מכבי 10/2021)
- סיכום מידע רפואי: טופס "אישור רפואי" בקליקס — מחלות כרוניות, תרופות קבועות, רגישויות, וגובה, משקל, דופק ולחץ דם אחרונים
- חברות ביטוח: סיכום מידע רפואי; מה שידוע רק מפי המטופל/ת נכתב "לפי דיווחו/ה". מטופל/ת שנפטר/ה ← משרד המרכז הרפואי (נדרש צו ירושה)
- מוסדות חינוך: לא חותמים על הצהרת הבריאות השנתית של ההורים (אלא אם הוצהר על מחלה — סיכום עם המגבלות). אין אישור לתלמיד/ה בריא/ה לחוגים, טיולים, מסע לפולין או גדנ"ע. אישור הגעה למרפאה: מנהלי, בלי חתימה רפואית
- חדר כושר: אין אישור לאדם בריא — מספיקה הצהרת הבריאות. מגבלות בהצהרה ← טופס חדר כושר בקליקס, רופא/ה בלבד
- טופס ירוק (נהיגה): מכבי ממליצה שהרופא/ה לא יחתום/תחתום על סעיף הכשירות לנהיגה ולא יחווה/תחווה דעה

## 14.ג בדיקות משותפות

| שלב | נושא | מה בודקים | קריטריון | אם לא מתקיים | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| לפני כל אישור | זהות המבקש/ת | מטופל/ת, הורה של קטין או מי שיש לו הסכמה | המבקש/ת מורשה לקבל את המסמך | לא ← לא מופק | חוק זכויות החולה סעיף 20 |
| לפני כל אישור | סימני אזהרה | קריאת הפנייה | אין כאב בחזה, קוצר נשימה, סימן נוירולוגי, מחשבות אובדניות ועוד | יש ← העברה מיידית לרופא/ה | החלטה מקומית |
| לפני כל אישור | סוג האישור | לפי הטבלה בלשונית "חיפוש" | מתאים לרפואן או בתנאים שמתקיימים | לא ← הכנה והעברה לרופא/ה | נוהל רפואן |
| אישורי מחלה | תאריך התחלה | יום הפנייה | היום או קודם; לא עתידי | עתידי ← לא מופק | חוזר משרד הבריאות 7/2024 |
| אישורי מחלה | אורך וחלון 7 ימים | אישורים קודמים ברשומה | עד 4 ימים; לא יותר מ-4 ימים קצרים ב-7 ימים | לא ← מפגש עם רופא/ה (גם מרחוק) | חוזר משרד הבריאות 7/2024 |
| אישורי מחלה | ימים רטרואקטיביים | תיעוד לאותם ימים | כל יום מכוסה בתיעוד | לא ← רופא/ה בלבד | חוזר משרד הבריאות 7/2024 |
| אישורי מחלה | נוסח | גוף האישור | בלי אבחנה | תיקון לפני ההפקה | חוזר משרד הבריאות 7/2024 |
| אחרי ההפקה | תיעוד והודעה | רשומה והודעה למטופל/ת | נרשם ברשומה; הודעה נשלחה | — | חוזר משרד הבריאות 7/2024 (חובת תיעוד) |

## 14.ד החלטות

| # | נושא | מה ההנחיה אומרת | ההחלטה לפרוטוקול | סוג | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אישור קצר ללא מפגש | רופא/ה רשאי/ת לחתום על אישור עד 4 ימים לאחר פנייה דיגיטלית, ללא מפגש | הרפואן מפיק אישור קצר בשם הרופא/ה ובהנחייתו/ה, כשכל התנאים מתקיימים | החלטה מקומית (הצעה) — לאישור משפטי | חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 07/2024 "מתן תעודות מחלה" (16.7.2024, בתוקף מ-1.9.2024) |
| 2 | חלון 7 ימים | לא יותר מ-4 ימי מחלה באישורים קצרים בכל 7 ימים | חריגה ← מפגש עם רופא/ה (גם מרחוק) | הנחיה | חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 07/2024 "מתן תעודות מחלה" (16.7.2024, בתוקף מ-1.9.2024) |
| 3 | רטרואקטיבי | עם תיעוד: לימים שהרשומה תומכת בהם. בלי תיעוד: לפי שיקול רפואי ולחודש הקלנדרי הקודם בלבד | הרפואן: רק עם תיעוד. בלי תיעוד: רופא/ה בלבד | הכרעה | חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 07/2024 "מתן תעודות מחלה" (16.7.2024, בתוקף מ-1.9.2024) |
| 4 | אישור עתידי | אסור לתת אישור שמתחיל בעתיד; מותר מהיום שאחרי הפנייה | כמו בהנחיה | הנחיה | חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 07/2024 "מתן תעודות מחלה" (16.7.2024, בתוקף מ-1.9.2024) |
| 5 | מעל 4 ימים | רופא/ה רשאי/ת בלי מפגש כשהרשומה מראה צורך (למשל אחרי ניתוח); קבוצות חריגות מוגדרות | הרפואן רק לפי המלצה כתובה ובמספר הימים שבה; אחרת רופא/ה | החלטה מקומית (הצעה) | חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 07/2024 "מתן תעודות מחלה" (16.7.2024, בתוקף מ-1.9.2024) |
| 6 | מעל 30 ימים | נדרשת המלצת מומחה/ית בכתב או חתימת מנהל/ת רפואי/ת | רופא/ה בלבד | הנחיה | חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 07/2024 "מתן תעודות מחלה" (16.7.2024, בתוקף מ-1.9.2024) |
| 7 | אבחנה באישור | אסור לציין אבחנה; נוסח ניטרלי | כמו בהנחיה | הנחיה | חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 07/2024 "מתן תעודות מחלה" (16.7.2024, בתוקף מ-1.9.2024) |
| 8 | אישור מנהלי עצמי בקופה | לקופה מותר להפיק אישור קצר בלי חתימת רופא: עד 4 פעמים ו-10 ימים בשנה, עד שבוע אחורה, למחלת העובד/ת בלבד | הרפואן לא מפנה לשירות במקום אישור שעומד בתנאים. אפשר לציין אותו בהודעה למטופל/ת — לדיון | החלטה מקומית (לדיון) | חוזר מנכ"ל משרד הבריאות 07/2024 "מתן תעודות מחלה" (16.7.2024, בתוקף מ-1.9.2024); תקנות דמי מחלה (נוהל לתשלום), תיקון 2024 |
| 9 | אישורים חוזרים | חוזר 7/2024 לא עוסק בכך | 3 אישורים ומעלה ב-3 חודשים ← הודעה לרופא/ה לפני הנפקה | החלטה מקומית (הצעה) | — |
| 10 | מחלת בן/בת זוג או הורה | החוזר עוסק במחלת העובד/ת; מחלת בן משפחה לפי תקנות דמי מחלה | רק בהסכמת החולה הבגיר/ה; בתיק החולה; בלי אבחנה | החלטה מקומית (הצעה) | חוק זכויות החולה סעיף 20 |
| 11 | אישור בריאות | הנחיית מכבי 10/2021: לכשירות לפעילות, עבודה או פרוצדורה מפיקים סיכום מידע רפואי, בלי קביעת כשירות | הרפואן מכין; הרופא/ה מאשר/ת. בדיקה גופנית ב-6 חודשים. ספורט תחרותי מחוץ לפרוטוקול | החלטה מקומית (מכלי הרפואן) | כלי רפואן; הנחיית מכבי – אישורים רפואיים (10/2021) |
| 12 | רשומה ריקה | נושא תפעולי — הנחיות קליניות לא עוסקות בו; מבוסס על נוהל הרפואן | נוסח: "ללא מחלות רקע וללא טיפול תרופתי קבוע הידועים ברשומה" | החלטה מקומית (הצעה) | — |
| 13 | נשק, נהיגה, פטורים | הנחיית מכבי 10/2021: חידוש רישיון נהיגה ונשק — בסל בתשלום; בטופס הירוק מומלץ לא לחתום על סעיף הכשירות לנהיגה | הצהרת נשק: פנים אל פנים. נהיגה ופטורים: רופא/ה בלבד | החלטה מקומית | כלי רפואן; הנחיית מכבי – אישורים רפואיים (10/2021) |
| 14 | היסטוריית בקשות | נושא תפעולי — הנחיות קליניות לא עוסקות בו; מבוסס על נוהל הרפואן | בקשה זהה או חריגה ב-5 הימים האחרונים ← לרופא/ה | החלטה מקומית (3.11.2026) | ספר חפיפה עוזרי רופא |
| 15 | אישור מחלה ממושך | חוזר 7/2024: מעל 4 ימים — רופא/ה רשאי/ת בלי מפגש כשהרשומה מראה צורך | רק לפי ביקור אחרון או מכתב יועץ/ת שתואמים את התלונה ואת מספר הימים | החלטה מקומית (3.11.2026) | ספר חפיפה עוזרי רופא; חוזר 7/2024 |

| # | נושא | מה ההנחיה אומרת | ההחלטה לפרוטוקול | סוג | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | קנאביס | רישיון קנאביס ניתן ע"י רופא/ה מומחה/ית מורשה לפי נוהל היק"ר; רופא/ת המשפחה מוסר/ת סיכום בלבד | לא מטופל ע"י רפואן | החלטה מקומית (3.11.2026) | ספר חפיפה עוזרי רופא; נוהל היק"ר |
| 17 | אישור בריאות | הנחיית מכבי 10/2021: לכשירות לפעילות, עבודה או פרוצדורה מפיקים סיכום מידע רפואי, בלי קביעת כשירות | ביקור במרפאה בשנה האחרונה (במקום בדיקה גופנית ב-6 חודשים) | החלטה מקומית (3.11.2026) | ספר חפיפה עוזרי רופא; הנחיית מכבי – אישורים רפואיים (10/2021) |
| 18 | אישורים שלא בחוק ולא לטיפול | אירוע ספורט, קוסמטיקה, התנדבות, ריאליטי: סיכום מידע רפואי | סיכום מידע רפואי בלבד | הנחיה | הנחיית מכבי לרופאי המשפחה – אישורים רפואיים (אוקטובר 2021) |
| 19 | כשירות לפעילות, לעבודה או לפרוצדורה | רופא/ת המשפחה לא קובע/ת כשירות; סיכום. כשירות לעבודה: רופא/ה תעסוקתי/ת | סיכום מידע רפואי; לא מכינים "אישור כשירות" כשסיכום מספיק | הנחיה | הנחיית מכבי לרופאי המשפחה – אישורים רפואיים (אוקטובר 2021) |
| 20 | חברות ביטוח | סיכום + מצב לפי דיווח המטופל/ת; נפטר/ת ← משרד המרכז הרפואי; אימות חתימה לא חובה | כמו בהנחיה | הנחיה | הנחיית מכבי לרופאי המשפחה – אישורים רפואיים (אוקטובר 2021) |
| 21 | מוסדות חינוך | אין חתימה על הצהרת הורים; אין אישור לתלמיד בריא; מעל 4 ימי מחלה: רופא/ה; פנימייה: סיכום מ-3 חודשים | כמו בהנחיה | הנחיה | הנחיית מכבי לרופאי המשפחה – אישורים רפואיים (אוקטובר 2021) |
| 22 | חדר כושר | אין אישור לבריא; מגבלות בהצהרה ← טופס בקליקס לשיקול הרופא/ה | הרפואן משיב שאין צורך; מגבלות ← רופא/ה | הנחיה | הנחיית מכבי לרופאי המשפחה – אישורים רפואיים (אוקטובר 2021) |
| 23 | טופס ירוק | מומלץ לא לחתום על סעיף הכשירות לנהיגה | רופא/ה בלבד (ללא שינוי) | הנחיה | הנחיית מכבי לרופאי המשפחה – אישורים רפואיים (אוקטובר 2021) |

## 14.ה רשימת סוגי אישורים (לסימון)

| # | שם | | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | אישור מחלה קצר (עד 4 ימים) | | אישורי מחלה · מחלת המטופל/ת | לפי הנחיה | ☐ | |
| 14.2 | אישור מחלה ממושך או המשך (מעל 4 ימים) | | אישורי מחלה · מחלת המטופל/ת | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 14.3 | מחלת ילד/ה (היעדרות הורה) | | אישורי מחלה · בן/בת משפחה | לפי הנחיה | ☐ | |
| 14.4 | מחלת בן/בת זוג או הורה | | אישורי מחלה · בן/בת משפחה | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 14.5 | אישור בריאות (כשירות) | | אישורי כשירות | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 14.6 | סיכום מידע רפואי | | סיכומים ומידע לצד שלישי | לפי הנחיה | ☐ | |
| 14.7 | אישור רפואי לגורם שלישי | | סיכומים ומידע לצד שלישי | לפי הנחיה | ☐ | |
| 14.8 | תעודה לנפגע בעבודה (ב.ל. 250) | | מסמכים משפטיים | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 14.9 | רישיון נשק: סיכום מידע רפואי | | מסמכים משפטיים | לפי הנחיה | ☐ | |
| 14.10 | רישיון נשק: הצהרת רופא/ה מטפל/ת | | מסמכים משפטיים | רופא/ה בלבד | ☐ | |
| 14.11 | רישיון נהיגה (טופס ירוק, חידוש, דיווח) | | מסמכים משפטיים | רופא/ה בלבד | ☐ | |
| 14.12 | פטור או התאמות (ספורט, עבודה, צבא, לימודים) | | אישורי כשירות | רופא/ה בלבד | ☐ | |
| 14.13 | קנאביס (אישור, סיכום או רישיון) | | אישורים · רופא/ה בלבד | רופא/ה בלבד | ☐ | |

| # | שם | | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.14 | אישור לחדר כושר | | אישורי כשירות | לפי הנחיה | ☐ | |
| 14.15 | אישורים למוסדות חינוך | | אישורי כשירות | לפי הנחיה | ☐ | |
| 14.16 | אישור העסקת נוער | | מסמכים משפטיים | רופא/ה בלבד | ☐ | |
| 14.17 | רישיון שייט, טיס או צלילה | | מסמכים משפטיים | רופא/ה בלבד | ☐ | |

## 14.ו פירוט מלא

### 14.1 אישור מחלה קצר (עד 4 ימים) לפי הנחיה

אישורי מחלה · מחלת המטופל/ת

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | אישור מחלה \| ימי מחלה \| תעודת מחלה \| יום מחלה |
| **נימוק / הערה** | אישור קצר מותר ללא מפגש עם רופא/ה; הרפואן מפיק בשם הרופא/ה ובהנחייתו/ה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **לא מתחיל בעתיד** | אישור שמתחיל בתאריך עתידי אסור. אפשר שהאישור יתחיל ביום שאחרי הפנייה. לא מתקיים ← לא מופקים, הודעה למטופל/ת לפנות ביום ההיעדרות. | התוויית נגד |
| 2 | **אין בקשה כפולה** | בקשה כפולה, בקשה שכבר טופלה או דפוס חריג ← לא מפיקים; לבדיקת הרופא/ה. | התוויית נגד |
| 3 | **עד 4 ימים** | אישור קצר: עד 4 ימים רצופים. מעל 4 ← לפי "אישור מחלה ממושך" או לרופא/ה. | |
| 4 | **חלון 7 ימים** | מעל 4 ימים באישורים קצרים בתוך 7 ימים ← לא מופקים, נדרש מפגש עם רופא/ה (גם בווידאו, בטלפון או בהתכתבות). | זימון |
| 5 | **ימים רטרואקטיביים מתועדים**<br>שאלה: האם האישור כולל ימים שלפני יום הפנייה? | רטרואקטיבי רק למספר הימים שהרשומה תומכת בו. בלי תיעוד ← לרופא/ה: רק רופא/ה רשאי/ת, מנימוק רפואי ורק לחודש הקלנדרי הקודם. | שאלה |
| 6 | **אין סימני אזהרה בפנייה** | יש סימן אזהרה ← לא מסתפקים באישור: העברה מיידית לרופא/ה. | התוויית נגד |
| 7 | **אין דפוס חוזר** | 3 אישורים ומעלה ב-3 חודשים ← הודעה לרופא/ה לפני הנפקה. | |
| 8 | **נוסח ללא אבחנה** | האישור לא כולל אבחנה או פרט רפואי. האבחנה והאישור נרשמים ברשומה הרפואית. | |

| | |
|---|---|
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | כאב בחזה, קוצר נשימה, חולשה או הפרעת דיבור חדשה ← דחוף: לרופא/ה מיד או מוקד/מיון; מחשבות אובדניות או מצוקה נפשית קשה ← דחוף: לרופא/ה מיד; חום מעל 3 ימים או החמרה למרות טיפול ← לרופא/ה לפני הנפקה |
| **מקור** | חוזר חטיבת הרפואה 7/2024 (משרד הבריאות) סעיפים: אישור קצר, חלון 7 ימים, רטרואקטיבי, תוכן האישור; תקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה) (תיקון), התשפ"ד-2024 |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 14.2 אישור מחלה ממושך או המשך (מעל 4 ימים) לפי הנחיה, בתנאים

אישורי מחלה · מחלת המטופל/ת

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | המשך אישור מחלה \| הארכת אישור מחלה \| אחרי ניתוח \| מכתב שחרור |
| **נימוק / הערה** | רק כשביקור אחרון או מכתב יועץ/ת תואמים את התלונה ואת אורך ההיעדרות; אחרת לרופא/ה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **לא מתחיל בעתיד** | אישור שמתחיל בתאריך עתידי אסור. אפשר שהאישור יתחיל ביום שאחרי הפנייה. לא מתקיים ← לא מופקים, הודעה למטופל/ת לפנות ביום ההיעדרות. | התוויית נגד |
| 2 | **אין בקשה כפולה** | בקשה כפולה, בקשה שכבר טופלה או דפוס חריג ← לא מפיקים; לבדיקת הרופא/ה. | התוויית נגד |
| 3 | **ביקור או מכתב יועץ/ת תואמים** | לחפש ברישומי הביקורים, בביקורי יועצים, במידע הכרונולוגי ובפורטל. יש ← מפיקים לפיו. אין ← לרופא/ה (אפשר לבקש מהמטופל/ת מסמך). | |
| 4 | **תואם להמלצה** | האישור לא חורג מההמלצה. חריגה ← לרופא/ה. | |
| 5 | **עד 30 ימים לאותה מחלה** | מעל 30 ימים ← רופא/ה בלבד: נדרשת המלצת מומחה/ית בכתב או חתימת מנהל/ת רפואי/ת. | התוויית נגד |
| 6 | **ימים רטרואקטיביים מתועדים**<br>שאלה: האם האישור כולל ימים שלפני יום הפנייה? | רטרואקטיבי רק למספר הימים שהרשומה תומכת בו. בלי תיעוד ← לרופא/ה: רק רופא/ה רשאי/ת, מנימוק רפואי ורק לחודש הקלנדרי הקודם. | שאלה |
| 7 | **אין סימני אזהרה בפנייה** | יש סימן אזהרה ← לא מסתפקים באישור: העברה מיידית לרופא/ה. | התוויית נגד |
| 8 | **נוסח ללא אבחנה** | האישור לא כולל אבחנה או פרט רפואי. האבחנה והאישור נרשמים ברשומה הרפואית. | |

| | |
|---|---|
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | כאב בחזה, קוצר נשימה, חולשה או הפרעת דיבור חדשה ← דחוף: לרופא/ה מיד או מוקד/מיון; מחשבות אובדניות או מצוקה נפשית קשה ← דחוף: לרופא/ה מיד; חום מעל 3 ימים או החמרה למרות טיפול ← לרופא/ה לפני הנפקה |
| **מקור** | חוזר חטיבת הרפואה 7/2024 (משרד הבריאות) סעיפים: אישור ממושך, אוכלוסיות חריגות, 30 ימים; תקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה) (תיקון), התשפ"ד-2024 |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 14.3 מחלת ילד/ה (היעדרות הורה) לפי הנחיה

אישורי מחלה · בן/בת משפחה

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | ילד חולה \| מחלת ילד \| הבן שלי חולה \| הבת שלי חולה \| היעדרות מהגן |
| **נימוק / הערה** | אותם כללים כמו אישור קצר; האישור מופק בתיק הילד/ה. אין חלופה של אישור מנהלי עצמי |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | בתיק הילד/ה, ע"י הורה | המבקש/ת אינו/ה הורה רשום/ה ← לא מופק, לבירור במזכירות. | התווית נגד |
| 2 | אין בקשה כפולה | בקשה כפולה, בקשה שכבר טופלה או דפוס חריג ← לא מפיקים; לבדיקת הרופא/ה. | התווית נגד |
| 3 | לא מתחיל בעתיד | אישור שמתחיל בתאריך עתידי אסור. אפשר שהאישור יתחיל ביום שאחרי הפנייה. לא מתקיים ← לא מופקים, הודעה למטופל/ת לפנות ביום ההיעדרות. | התווית נגד |
| 4 | עד 4 ימים | אישור קצר: עד 4 ימים רצופים. מעל 4 ← לפי "אישור מחלה ממושך" או לרופא/ה. | |
| 5 | חלון 7 ימים | מעל 4 ימים באישורים קצרים בתוך 7 ימים ← לא מופקים, נדרש מפגש עם רופא/ה (גם בווידאו, בטלפון או בהתכתבות). | זימון |
| 6 | ימים רטרואקטיביים מתועדים<br>שאלה: האם האישור כולל ימים שלפני יום הפנייה? | רטרואקטיבי רק למספר הימים שהרשומה תומכת בו. בלי תיעוד ← לרופא/ה: רק רופא/ה רשאי/ת, מנימוק רפואי ורק לחודש הקלנדרי הקודם. | שאלה |
| 7 | אין סימני אזהרה אצל הילד/ה | יש סימן אזהרה ← העברה מיידית לרופא/ה. | התווית נגד |
| 8 | נוסח ללא אבחנה | האישור לא כולל אבחנה או פרט רפואי. האבחנה והאישור נרשמים ברשומה הרפואית. | |

| | |
|---|---|
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | תינוק/ת מתחת לגיל 3 חודשים עם חום ← דחוף: לרופא/ה מיד או מיון; ישנוניות, קוצר נשימה, התייבשות או פריחה שלא מחווירה ← דחוף: לרופא/ה מיד |
| **מקור** | חוזר חטיבת הרפואה 7/2024 (משרד הבריאות) (כללי אישור קצר ורטרואקטיבי); תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993; תקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה) (תיקון), התשפ"ד-2024 |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 14.4 מחלת בן/בת זוג או הורה לפי הנחיה, בתנאים

אישורי מחלה · בן/בת משפחה

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | מחלת בן זוג \| מחלת בת זוג \| מחלת הורה \| ליווי הורה |
| **נימוק / הערה** | מותר רק בהסכמת החולה הבגיר/ה; האישור מופק בתיק החולה, בלי אבחנה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | הסכמת החולה | מידע על מחלת בגיר/ה נמסר לבן משפחה רק בהסכמתו/ה. אין ← לא מופק. | התווית נגד |
| 2 | אין בקשה כפולה | בקשה כפולה, בקשה שכבר טופלה או דפוס חריג ← לא מפיקים; לבדיקת הרופא/ה. | התווית נגד |
| 3 | לא מתחיל בעתיד | אישור שמתחיל בתאריך עתידי אסור. אפשר שהאישור יתחיל ביום שאחרי הפנייה. לא מתקיים ← לא מופקים, הודעה למטופל/ת לפנות ביום ההיעדרות. | התווית נגד |
| 4 | עד 4 ימים | אישור קצר: עד 4 ימים רצופים. מעל 4 ← לפי "אישור מחלה ממושך" או לרופא/ה. | |
| 5 | ימים רטרואקטיביים מתועדים<br>שאלה: האם האישור כולל ימים שלפני יום הפנייה? | רטרואקטיבי רק למספר הימים שהרשומה תומכת בו. בלי תיעוד ← לרופא/ה: רק רופא/ה רשאי/ת, מנימוק רפואי ורק לחודש הקלנדרי הקודם. | שאלה |
| 6 | אין סימני אזהרה בפנייה | יש סימן אזהרה ← לא מסתפקים באישור: העברה מיידית לרופא/ה. | התווית נגד |
| 7 | נוסח ללא אבחנה | האישור לא כולל אבחנה או פרט רפואי. האבחנה והאישור נרשמים ברשומה הרפואית. | |

| | |
|---|---|
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | כאב בחזה, קוצר נשימה, חולשה או הפרעת דיבור חדשה ← דחוף: לרופא/ה מיד או מוקד/מיון; מחשבות אובדניות או מצוקה נפשית קשה ← דחוף: לרופא/ה מיד; חום מעל 3 ימים או החמרה למרות טיפול ← לרופא/ה לפני הנפקה |
| **מקור** | חוזר חטיבת הרפואה 7/2024 (משרד הבריאות); חוק זכויות החולה סעיף 20. התנאי של הסכמה: החלטה מקומית |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 14.5 אישור בריאות (כשירות) הכנה לאישור רופא/ה

אישורי כשירות

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | אישור כשירות \| כשיר \| מילואים \| אישור לעבודה |
| **נימוק / הערה** | קביעת כשירות היא החלטה רפואית: הרפואן מכין, הרופא/ה מאשר/ת וחותם/ת. נדרש ביקור במרפאה בשנה האחרונה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | סיכום לא מספיק | הגורם מקבל סיכום ← מפיקים "סיכום מידע רפואי" במקום אישור כשירות. כשירות לעבודה ← רופא/ה תעסוקתי/ת. | |
| 2 | מטרה וטופס | חסר ← לבקש מהמטופל/ת את הטופס לפני ההכנה. | |
| 3 | ביקור במרפאה בשנה האחרונה | אין ← זימון לביקור לפני הכנת האישור. | זימון |
| 4 | אין בקשה כפולה | בקשה כפולה, בקשה שכבר טופלה או דפוס חריג ← לא מפיקים; לבדיקת הרופא/ה. | התווית נגד |
| 5 | אין בירור או אירוע פתוח | יש ← לציין בהעברה לרופא/ה. | |
| 6 | לא ספורט תחרותי | ספורט תחרותי ← מחוץ לפרוטוקול, לרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| **מקור** | נוהל רפואן (כלי רפואן: בדיקה גופנית ב-6 חודשים). שאר התנאים: החלטה מקומית (הצעה); הנחיית מכבי לרופאי המשפחה – אישורים רפואיים (אוקטובר 2021) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 14.6 סיכום מידע רפואי לפי הנחיה

סיכומים ומידע לצד שלישי

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | סיכום רפואי \| סיכום מידע \| תמצית רשומה \| אירוע ספורט (מרוץ, מרתון — סיכום בלבד) \| התנדבות \| טיפול קוסמטי \| כשירות לטיפול שיניים (סיכום בלבד; לא קובעים כשירות) \| קטרקט (כשירות לניתוח: סיכום בלבד) \| לימודי ספורט (לא קובעים כשירות למאמץ — סיכום) \| פנימייה (סיכום מ-3 החודשים האחרונים; תוצאת מנטו לא חובה) \| ביטוח נסיעות (כשירות לטיסה: סיכום; "מצב יציב" רק בהחלטת הרופא/ה) |
| **נימוק / הערה** | טופס "אישור רפואי" בקליקס: מחלות כרוניות, תרופות קבועות, רגישויות ומדדים אחרונים, בלי חוות דעת |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **המבקש/ת מורשה** | מידע רפואי נמסר לצד שלישי רק בהסכמת המטופל/ת (חוק זכויות החולה, סעיף 20). אין הסכמה ← לא מופק. | התוויית נגד |
| 2 | **אין בקשה כפולה** | בקשה כפולה, בקשה שכבר טופלה או דפוס חריג ← לא מפיקים; לבדיקת הרופא/ה. | התוויית נגד |
| 3 | **תמצית בלבד** | הגורם מבקש חוות דעת או קביעת כשירות ← מסבירים שלפי הנחיית מכבי ניתן סיכום מידע רפואי בלבד; עומד/ת על כך ← לרופא/ה. | התוויית נגד |
| 4 | **הרשומה עדכנית** | סתירה בולטת (תרופה שהופסקה, אבחנה שגויה) ← לרופא/ה לתיקון לפני ההפקה. | |
| 5 | **קנאביס: נוסח ניטרלי**<br>שאלה: האם הסיכום מיועד לבקשת רישיון קנאביס? | רק כשהבקשה לקנאביס. אין המלצה, הערכה או מילוי טופס רישיון. | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מקור** | חוק זכויות החולה סעיפים 18, 20; נוהל רפואן. נוסח הקנאביס: כלי רפואן; הנחיית מכבי לרופאי המשפחה – אישורים רפואיים (אוקטובר 2021) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 14.7 אישור רפואי לגורם שלישי לפי הנחיה

סיכומים ומידע לצד שלישי

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | ביטוח לאומי \| חברת ביטוח \| רופא שיניים \| אישור רפואי \| אימות חתימה (לא חובה לחתום) |
| **נימוק / הערה** | כשהגורם מבקש מידע מהרשומה בלבד; שאלון או חוות דעת עוברים לרופא/ה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **המבקש/ת מורשה** | מידע רפואי נמסר לצד שלישי רק בהסכמת המטופל/ת (חוק זכויות החולה, סעיף 20). אין הסכמה ← לא מופק. | התוויית נגד |
| 2 | **אין בקשה כפולה** | בקשה כפולה, בקשה שכבר טופלה או דפוס חריג ← לא מפיקים; לבדיקת הרופא/ה. | התוויית נגד |
| 3 | **לא שאלון ולא חוות דעת** | שאלון, הצהרה או חוות דעת ← לרופא/ה. | התוויית נגד |
| 4 | **רשומה ריקה: נוסח זהיר**<br>שאלה: האם הרשומה ריקה מאבחנות ותרופות? | לא לכתוב "בריא/ה" או "ללא מחלות" בלי הסייג "הידועים ברשומה". | שאלה |
| 5 | **המטופל/ת בחיים** | נפטר/ה ← מפנים את המבקש/ת למשרד המרכז הרפואי (נדרש צו ירושה). | התוויית נגד |
| 6 | **דיווח עצמי בנוסח מתאים**<br>שאלה: האם יש בבקשה מידע שמבוסס רק על דיווח המטופל/ת? | לא כותבים כעובדה מה שלא מתועד. | שאלה |

| | |
|---|---|
| **מקור** | חוק זכויות החולה סעיף 20; נוהל רפואן. הסייג "הידועים ברשומה": החלטה מקומית (הצעה); הנחיית מכבי לרופאי המשפחה – אישורים רפואיים (אוקטובר 2021) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 14.8 תעודה לנפגע בעבודה (ב.ל. 250) הכנה לאישור רופא/ה

מסמכים משפטיים

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | תאונת עבודה \| נפגעתי בעבודה \| תעודה רפואית לנפגע |
| **נימוק / הערה** | מסמך משפטי: הרפואן מכין, הרופא/ה מאשר/ת לפני ההפקה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | הפגיעה מתועדת | אין תיעוד ← זימון לבדיקה במרפאה. | זימון |
| 2 | אין בקשה כפולה | בקשה כפולה, בקשה שכבר טופלה או דפוס חריג ← לא מפיקים; לבדיקת הרופא/ה. | התוויות נגד |
| 3 | ימים לפי המלצה | אין המלצה ← הרופא/ה קובע/ת. | |
| 4 | לא מתחיל בעתיד | אישור שמתחיל בתאריך עתידי אסור. אפשר שהאישור יתחיל ביום שאחרי הפנייה. לא מתקיים ← לא מופקים, הודעה למטופל/ת לפנות ביום ההיעדרות. | התוויות נגד |

| | |
|---|---|
| **מקור** | כלי רפואן ("דורש אישור מקדים של הרופא/ה"). החלטה מקומית |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 14.9 רישיון נשק: סיכום מידע רפואי לפי הנחיה

מסמכים משפטיים

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | נשק \| רישיון נשק |
| **נימוק / הערה** | השלב הראשון הוא סיכום מידע רפואי בלבד |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | המבקש/ת מורשה | מידע רפואי נמסר לצד שלישי רק בהסכמת המטופל/ת (חוק זכויות החולה, סעיף 20). אין הסכמה ← לא מופק. | התוויות נגד |
| 2 | אין בקשה כפולה | בקשה כפולה, בקשה שכבר טופלה או דפוס חריג ← לא מפיקים; לבדיקת הרופא/ה. | התוויות נגד |
| 3 | סיכום בלבד | הצהרת רופא/ה ← רופא/ה בלבד, במפגש פנים אל פנים. | התוויות נגד |

| | |
|---|---|
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | אמירה על פגיעה בעצמו/ה או באחרים ← דחוף: לרופא/ה מיד |
| **מקור** | כלי רפואן (אישור לנשק). החלטה מקומית |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 14.10 רישיון נשק: הצהרת רופא/ה מטפל/ת רופא/ה בלבד

מסמכים משפטיים

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | הצהרת בריאות לנשק |
| **נימוק / הערה** | מחייבת מעבר על כל התיק במפגש פנים אל פנים |
| **הנחיה** | **רופא/ה בלבד, במפגש פנים אל פנים. הרפואן מודיע/ה למטופל/ת לקבוע תור ומפיק/ה רק סיכום מידע אם התבקש.** |
| **מקור** | כלי רפואן. החלטה מקומית |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 14.11 רישיון נהיגה (טופס ירוק, חידוש, דיווח) רופא/ה בלבד

מסמכים משפטיים

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | טופס ירוק \| רישיון נהיגה \| רשות הרישוי |
| **נימוק / הערה** | קביעת כשירות לנהיגה היא החלטה רפואית. מכבי ממליצה לא לחתום על סעיף הכשירות לנהיגה בטופס הירוק |
| **הנחיה** | **רופא/ה בלבד. הרפואן מעביר/ה את הבקשה לרופא/ה ומודיע/ה למטופל/ת שייתכן שיידרש ביקור.** |
| **מקור** | החלטה מקומית; הנחיית מכבי לרופאי המשפחה – אישורים רפואיים (אוקטובר 2021) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 14.12 פטור או התאמות (ספורט, עבודה, צבא, לימודים) רופא/ה בלבד

אישורי כשירות

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | פטור מספורט \| התאמות \| פטור \| הקלות בעבודה |
| **נימוק / הערה** | פטור או התאמה הם המלצה רפואית שהרופא/ה קובע/ת |
| **הנחיה** | **רופא/ה בלבד. אם יש המלצת יועץ/ת ברשומה, לצרף אותה להעברה לרופא/ה.** |
| **מקור** | החלטה מקומית |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 14.13 קנאביס (אישור, סיכום או רישיון) רופא/ה בלבד

אישורים · רופא/ה בלבד

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | קנאביס \| קנאביס רפואי \| רישיון קנאביס |
| **נימוק / הערה** | החלטה 3.11.2026: הרפואן לא מטפל בבקשות קנאביס |
| **הנחיה** | **בקשות לקנאביס (אישור, סיכום מידע, חידוש רישיון) — לא מטופלות ע"י רפואן. להעביר לרופא/ה.** |
| **מקור** | החלטה מקומית (3.11.2026) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 14.14 אישור לחדר כושר לפי הנחיה

אישורי כשירות

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | חדר כושר \| מכון כושר \| הצהרת בריאות לחדר כושר |
| **נימוק / הערה** | לאדם בריא לא נותנים אישור — מספיקה הצהרת הבריאות. הרפואן משיב למטופל/ת |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **אין מגבלות בהצהרה** | סומנו ← לרופא/ה (טופס חדר כושר בקליקס, לשיקול הרופא/ה). | התוויית נגד |
| 2 | **אין בקשה כפולה** | בקשה כפולה, בקשה שכבר טופלה או דפוס חריג ← לא מפיקים; לבדיקת הרופא/ה. | התוויית נגד |

| | |
|---|---|
| **מקור** | הנחיית מכבי לרופאי המשפחה – אישורים רפואיים (אוקטובר 2021) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 14.15 אישורים למוסדות חינוך לפי הנחיה

אישורי כשירות

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | הצהרת בריאות \| בית ספר \| טיול שנתי \| מסע לפולין \| גדנ"ע \| חוג \| אישור הגעה למרפאה |
| **נימוק / הערה** | לתלמיד/ה בריא/ה אין אישור: לא חותמים על הצהרת ההורים, טיולים, פולין, גדנ"ע וחוגים. אישור הגעה למרפאה — מנהלי |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **לא הוצהר על מחלה** | צוינה ← סיכום מידע רפואי עם המגבלות, הכנה לרופא/ה. | התווית נגד |
| 2 | **לא אישור מחלה** | היעדרות עד 4 ימים: אישור הורים; מעל 4 ימים ← רופא/ה (חוזר 7/2024 סעיף 9). | התווית נגד |
| 3 | **אין בקשה כפולה** | בקשה כפולה, בקשה שכבר טופלה או דפוס חריג ← לא מפיקים; לבדיקת הרופא/ה. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| **מקור** | הנחיית מכבי לרופאי המשפחה – אישורים רפואיים (אוקטובר 2021) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 14.16 אישור העסקת נוער רופא/ה בלבד

מסמכים משפטיים

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | העסקת נוער \| עבודת נוער |
| **נימוק / הערה** | אישור לפי חוק |
| **הנחיה** | **רופא/ה בלבד.** |

| | |
|---|---|
| **מקור** | הנחיית מכבי לרופאי המשפחה – אישורים רפואיים (אוקטובר 2021) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 14.17 רישיון שייט, טיס או צלילה רופא/ה בלבד

מסמכים משפטיים

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | שייט \| סקיפר \| טייס \| צלילה |
| **נימוק / הערה** | חידוש רישיון שייט: רופא/ה (בתשלום). טיס וצלילה: רופא/ה מוסמך/ת בלבד |
| **הנחיה** | **רופא/ה בלבד. טיס וצלילה: הפניה לרופא/ה מוסמך/ת.** |

| | |
|---|---|
| **מקור** | הנחיית מכבי לרופאי המשפחה – אישורים רפואיים (אוקטובר 2021) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

# 15. פניות דיגיטליות

13 פריטים · לפי הנחיה: 2 · לפי הנחיה, בתנאים: 2 · הכנה לאישור רופא/ה: 1 · רופא/ה בלבד: 8 · גרסה 1 · 2.11.2026

מקורות: המדריך למדריך ברפואת המשפחה, מכבי (2017), עמ' 32-34: "כיצד נלמד מתמחים לקיים ביקורים וירטואליים איכותיים", ד"ר גליה מאירי וד"ר תמי ברמן (ינואר 2016)

## 15.א כללים

- ביקור וירטואלי הוא ביקור לכל דבר: מתעדים, מציינים שזו פנייה מקוונת, רושמים אבחנה
- לפני המענה: קוראים את הרשומה — ביקורים אחרונים, גורמי סיכון, בדיקות ורפואה מונעת
- פנייה מקוונת איננה רק "הוצאת מרשמים כי זה מה שביקשו"
- מתאים: חידוש תרופות כרוניות למאוזן/ת, הפניה לבדיקות מעקב, סיכום מידע, אישורים לפי הפרוטוקול
- מסרבים: דחוף, תסמין חדש, ממצא גופני, מטופל/ת לא מוכר/ת או לא מאוזן/ת, סוגיה נפשית, בקשה מורכבת או טופס מורכב, מרשם לא מנומק
- סירוב: מנומק ומנומס, מציע חלופה (ביקור, שיחה טלפונית, וידאו). אפשר לאשר עם הסתייגות ("בעתיד...")
- תשובה: מלאה, ברורה, תמציתית, בעברית תקנית; בלי ראשי תיבות (סונר, US, ת"ל); הנחיות מפורשות — מה לעשות ומתי
- מענה רק בערוץ הרשמי (מערכת הפניות של מכבי), לא ב-WhatsApp או SMS אישי
- דחוף: לא מחכים — הנחיה מיידית למוקד/מיון והודעה מיידית לרופא/ה

## 15.ב תוצאות אפשריות

| תוצאה | נוסח בתיעוד |
|---|---|
| בוצע לפי הנחיית הרופא/ה ונענה | תוצאה: הפנייה טופלה לפי הנחיית הרופא/ה והפרוטוקול, ונענתה. |
| הוכן והועבר לרופא/ה | תוצאה: הפנייה הוכנה והועברה להחלטת הרופא/ה. |
| סירוב מנומק: זימון לביקור או לשיחה | תוצאה: לא מתאים למענה מקוון. נשלח סירוב מנומק והזמנה לביקור או לשיחה. |
| דחוף: מוקד/מיון והודעה מיידית לרופא/ה | תוצאה: פנייה דחופה. המטופל/ת הונחה לפנות למוקד/מיון; הרופא/ה עודכן/ה מיד. |

## 15.ג בדיקות משותפות

| שלב | נושא | מה בודקים | קריטריון | אם לא מתקיים | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| לפני כל מענה | דחיפות | קריאת הפנייה | אין חשד לאירוע לבבי/מוחי, קוצר נשימה, חום גבוה במיוחד, מחשבות אובדניות | יש ← מוקד/מיון + הודעה מיידית לרופא/ה | המדריך למדריך עמ' 32-34 |
| לפני כל מענה | מי פונה | החשבון השולח | המטופל/ת או הורה של קטין/ה | אחר ← לפנות מהחשבון של המטופל/ת | המדריך למדריך עמ' 32-34 |
| לפני כל מענה | סוג הפנייה | לפי הלשונית "חיפוש" | מתאים למענה מקוון | לא ← סירוב מנומק + זימון | המדריך למדריך עמ' 32-34 |
| לפני כל מענה | הרשומה | ביקורים, גורמי סיכון, בדיקות, רפואה מונעת | נקראה; חוסרים בולטים צוינו לרופא/ה | — | המדריך למדריך עמ' 32-34 |
| המענה | נוסח | ההודעה למטופל/ת | מלא, מנומס, תמציתי, עברית תקנית, בלי קיצורים | תיקון לפני שליחה | המדריך למדריך עמ' 32-34 |
| המענה | ערוץ | מערכת הפניות | רק בערוץ הרשמי | — | המדריך למדריך עמ' 32-34 (שיקולי WhatsApp/SMS); החלטה מקומית |
| אחרי המענה | תיעוד | רשומה | פנייה מקוונת; מידע מערוצים אחרים; אבחנה | — | המדריך למדריך עמ' 32-34 |

## 15.ד החלטות

| # | נושא | מה ההנחיה אומרת | ההחלטה לפרוטוקול | סוג | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מי עונה | המדריך נכתב למתמחים: מענה מקוון רק אחרי 3 חודשים במרפאה ובאישור המדריך | הרפואן עונה רק על סוגי הפניות שמסומנים "מתאים", בשם הרופא/ה ובהנחייתו/ה | החלטה מקומית (הצעה) | המדריך למדריך עמ' 32-34 |

| # | נושא | מה ההנחיה אומרת | ההחלטה לפרוטוקול | סוג | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | משוב על תוצאות | מסומן בסימן שאלה | רפואן משיב רק כשכל הערכים תקינים ואין שאלה קלינית; אחרת רופא/ה | החלטה מקומית (לדיון) | המדריך למדריך עמ' 32-34 |
| 3 | אישור מחלה | מסומן בסימן שאלה (2016) | לפי לשונית האישורים (חוזר 07/2024) | הכרעה | המדריך למדריך עמ' 32-34; חוזר 07/2024 |
| 4 | הפניה לבדיקות | "הפנייה לבדיקות מעקב (סוכר, ליפידים, ממצא בהדמיה)" | מעבדה למעקב: רפואן. הדמיה: מכין, הרופא/ה מאשר/ת | הכרעה | המדריך למדריך עמ' 32-34 |
| 5 | סירוב | לא כל סירוב אבסולוטי; אפשר לאשר עם הסתייגות; טקסט אוטומטי | הודעות סירוב מוכנות לכל סוג פנייה | הנחיה | המדריך למדריך עמ' 32-34 |
| 6 | WhatsApp/SMS | שיקולים בעד ונגד, בלי הכרעה | מענה רק בערוץ הרשמי | החלטה מקומית (הצעה) | המדריך למדריך עמ' 32-34 |
| 7 | זמן מענה | הנחיה למטופלים: "הרופא נדרש לענות תוך 5 ימי עבודה" | לבדוק מול הנוהל הנוכחי של מכבי | לבדיקה | המדריך למדריך עמ' 32-34 |
| 8 | מענה לפנייה נפשית | מצוקה נפשית: ער"ן 1201; סכנה מיידית — מד"א 101 או מיון | בהודעה: ער"ן 1201 ופנייה מיידית במצוקה קשה | החלטה מקומית (הצעה) | משרד הבריאות |

## 15.ה רשימת סוגי פניות (לסימון)

| # | שם | | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | חידוש מרשם כרוני | | פניות מתאימות למענה מקוון | לפי הנחיה | ☐ | |
| 15.2 | הפניה לבדיקות מעקב | | פניות מתאימות למענה מקוון | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 15.3 | הפניה להדמיה למעקב אחרי ממצא | | פניות מתאימות למענה מקוון | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 15.4 | משוב על תוצאות בדיקות | | פניות מתאימות למענה מקוון | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 15.5 | אישורים וסיכום מידע רפואי | | פניות מתאימות למענה מקוון | לפי הנחיה | ☐ | |
| 15.6 | בקשות חוזרות לאישורי מחלה | | פניות שמסרבים להן | רופא/ה בלבד | ☐ | |
| 15.7 | מרשם חדש שאינו תרופה קבועה | | פניות שמסרבים להן | רופא/ה בלבד | ☐ | |
| 15.8 | תסמין או תלונה חדשים | | פניות שמסרבים להן | רופא/ה בלבד | ☐ | |
| 15.9 | ממצא גופני או תמונה (פריחה, נגע) | | פניות שמסרבים להן | רופא/ה בלבד | ☐ | |
| 15.10 | אישור או טופס רפואי מורכב | | פניות שמסרבים להן | רופא/ה בלבד | ☐ | |
| 15.11 | פנייה רגשית או חברתית | | פניות שמסרבים להן | רופא/ה בלבד | ☐ | |
| 15.12 | פנייה בשם מטופל/ת אחר/ת | | פניות שמסרבים להן | רופא/ה בלבד | ☐ | |
| 15.13 | פנייה דחופה | | פניות שמסרבים להן | רופא/ה בלבד | ☐ | |

## 15.ו פירוט מלא

### 15.1 חידוש מרשם כרוני לפי הנחיה

פניות מתאימות למענה מקוון

| | |
|---|---|
| נקרא גם | חידוש מרשם \| חידוש תרופות \| מרשם קבוע \| נגמרו הכדורים |
| נימוק / הערה | פנייה מתאימה כשהמטופל/ת מאוזן/ת. הבדיקות לכל תרופה: בלשוניות התרופות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין סימני דחיפות | יש ← לא עונים במקוון: הנחיה מיידית למוקד/מיון (101 בחירום) והודעה מיידית לרופא/ה. | התוויית נגד |
| 2 | הפנייה על המטופל/ת עצמו/ה | פנייה על בן/בת זוג או בן משפחה בוגר מהחשבון שלך ← לא עונים לגופה; מבקשים לפנות מהחשבון של המטופל/ת. | התוויית נגד |
| 3 | מאוזן/ת ומבצע/ת מעקב | לא מאוזן/ת, לא ביצע/ה מעקב או חוסר היענות ← לפי פרוטוקול התרופה: חידוש לחודש וזימון. | זימון |
| 4 | עברתי על הרשומה | המדריך: מצפים לקרוא ולהתייחס לביקורים אחרונים, גורמי סיכון, רפואה מונעת ובדיקות. חוסר בולט ← לציין בהודעה לרופא/ה. | |
| 5 | תיעוד כביקור | ביקור וירטואלי הוא ביקור לכל דבר: מתעדים, רושמים SOAP כשרלוונטי ומכניסים אבחנה. | |

| | |
|---|---|
| הודעה למטופל/ת | שלום,<br>המרשם חודש וזמין לרכישה בבית המרקחת. ___ |
| מקור | המדריך למדריך עמ' 32-34 |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 15.2 הפניה לבדיקות מעקב לפי הנחיה, בתנאים

פניות מתאימות למענה מקוון

| | |
|---|---|
| נקרא גם | הפניה לבדיקת דם \| בדיקות דם \| בדיקות מעקב \| הפניה לבדיקות |
| נימוק / הערה | בדיקות מעקב של מחלה ידועה (סוכר, שומנים, תפקודי כליות) לפי פרוטוקול; בירור תלונה חדשה — לא |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין סימני דחיפות | יש ← לא עונים במקוון: הנחיה מיידית למוקד/מיון (101 בחירום) והודעה מיידית לרופא/ה. | התוויית נגד |
| 2 | הפנייה על המטופל/ת עצמו/ה | פנייה על בן/בת זוג או בן משפחה בוגר מהחשבון שלך ← לא עונים לגופה; מבקשים לפנות מהחשבון של המטופל/ת. | התוויית נגד |
| 3 | מעקב של מצב ידוע | בדיקה לבירור תלונה חדשה ← לא במקוון ע"י רפואן: לרופא/ה או לביקור. | |
| 4 | הגיע הזמן | מוקדם מהמקובל ← לרופא/ה. | |
| 5 | עברתי על הרשומה | המדריך: מצפים לקרוא ולהתייחס לביקורים אחרונים, גורמי סיכון, רפואה מונעת ובדיקות. חוסר בולט ← לציין בהודעה לרופא/ה. | |
| 6 | תיעוד כביקור | ביקור וירטואלי הוא ביקור לכל דבר: מתעדים, רושמים SOAP כשרלוונטי ומכניסים אבחנה. | |

| | |
|---|---|
| הודעה למטופל/ת | שלום,<br>ההפניה לבדיקות ___ הופקה ונמצאת באפליקציה. ניתן לקבוע תור למעבדה דרך האפליקציה. |
| מקור | המדריך למדריך עמ' 32-34 |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 15.3 הפניה להדמיה למעקב אחרי ממצא הכנה לאישור רופא/ה

פניות מתאימות למענה מקוון

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | הפניה לאולטרסאונד \| הפניה ל-CT \| מעקב ממצא \| צילום חוזר |
| **נימוק / הערה** | המדריך מונה מעקב ממצא בהדמיה כפנייה מתאימה; ההפניה עצמה בהחלטת הרופא/ה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין סימני דחיפות | יש ← לא עונים במקוון: הנחיה מיידית למוקד/מיון (101 בחירום) והודעה מיידית לרופא/ה. | התוויות נגד |
| 2 | הפנייה על המטופל/ת עצמו/ה | פנייה על בן/בת זוג או בן משפחה בוגר מהחשבון שלך ← לא עונים לגופה; מבקשים לפנות מהחשבון של המטופל/ת. | התוויות נגד |
| 3 | המלצה כתובה למעקב | אין המלצה כתובה ← לרופא/ה. | |
| 4 | עברתי על הרשומה | המדריך: מצפים לקרוא ולהתייחס לביקורים אחרונים, גורמי סיכון, רפואה מונעת ובדיקות. חוסר בולט ← לציין בהודעה לרופא/ה. | |
| 5 | תיעוד כביקור | ביקור וירטואלי הוא ביקור לכל דבר: מתעדים, רושמים SOAP כשרלוונטי ומכניסים אבחנה. | |

| | |
|---|---|
| **מקור** | המדריך למדריך עמ' 32-34 |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 15.4 משוב על תוצאות בדיקות לפי הנחיה, בתנאים

פניות מתאימות למענה מקוון

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | תוצאות בדיקות \| תוצאות דם \| מה יצא בבדיקות \| פענוח בדיקות |
| **נימוק / הערה** | החלטה 8.11.2026: הרפואן לא מפרש תוצאות. מסתכל/ת בתוצאות, משווה לבדיקות קודמות ומדווח/ת לרופא/ה. מסר מהרופא/ה מועבר למטופל/ת, בציון שמי שמעביר/ה הוא/היא סטודנט/ית לרפואה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | מסר מהרופא/ה | אין מסר מהרופא/ה ← לא עונים על התוצאות; מסכמים ומעבירים לרופא/ה. | התוויות נגד |

| | |
|---|---|
| **הודעה למטופל/ת** | שלום,<br>ד"ר ____ עבר/ה על תוצאות הבדיקות שלך ומבקש/ת למסור: ____<br>ההודעה נמסרת ע"י ____, סטודנט/ית לרפואה המסייע/ת לרופא/ה. |
| **מקור** | החלטה 8.11.2026 (נוהל רפואן) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 15.5 אישורים וסיכום מידע רפואי לפי הנחיה

פניות מתאימות למענה מקוון

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | אישור \| סיכום מידע \| אישור מחלה \| טופס |
| **נימוק / הערה** | סיכום מידע לצרכים מנהלתיים מתאים; אישור מחלה ואחרים — לפי לשונית האישורים |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין סימני דחיפות | יש ← לא עונים במקוון: הנחיה מיידית למוקד/מיון (101 בחירום) והודעה מיידית לרופא/ה. | התוויות נגד |
| 2 | הפנייה על המטופל/ת עצמו/ה | פנייה על בן/בת זוג או בן משפחה בוגר מהחשבון שלך ← לא עונים לגופה; מבקשים לפנות מהחשבון של המטופל/ת. | התוויות נגד |
| 3 | תיעוד כביקור | ביקור וירטואלי הוא ביקור לכל דבר: מתעדים, רושמים SOAP כשרלוונטי ומכניסים אבחנה. | |

| | |
|---|---|
| **מקור** | המדריך למדריך עמ' 32-34; חוזר 07/2024 (בלשונית האישורים) |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 15.6 בקשות חוזרות לאישורי מחלה רופא/ה בלבד

פניות שמסרבים להן

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | אישורי מחלה חוזרים \| שוב אישור מחלה |
| **נימוק / הערה** | המדריך: פניות חוזרות ונשנות לאישורי מחלה (מעבר לסביר) — מסרבים ומזמינים לביקור |
| **הנחיה** | **לא מפיקים במקוון. סירוב מנומק והזמנה לביקור; עדכון הרופא/ה.** |

| | |
|---|---|
| **הודעה למטופל/ת** | שלום,<br>בשל פניות חוזרות בנושא, נדרש ביקור במרפאה כדי שהרופא/ה יוכל/תוכל להעריך את המצב ולתת את האישור המתאים. ניתן לקבוע תור דרך האפליקציה או מזכירות המרפאה. |
| **מקור** | המדריך למדריך עמ' 32-34 |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 15.7 מרשם חדש שאינו תרופה קבועה רופא/ה בלבד

פניות שמסרבים להן

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | מרשם חדש \| אנטיביוטיקה \| תרופה חדשה \| מרשם ל |
| **נימוק / הערה** | המדריך: בקשה לא מנומקת למרשם שאינו תרופה קבועה — מסרבים |
| **הנחיה** | **הרפואן לא מפיק. מעבירים לרופא/ה; אם אין נימוק ברור — סירוב מנומק והזמנה לביקור.** |

| | |
|---|---|
| **הודעה למטופל/ת** | שלום,<br>כדי לתת מרשם לתרופה חדשה הרופא/ה צריך/ה להכיר את הסיבה ולעיתים גם לבדוק. ניתן לקבוע תור (גם טלפוני או בווידאו) דרך האפליקציה או מזכירות המרפאה. |
| **מקור** | המדריך למדריך עמ' 32-34 |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 15.8 תסמין או תלונה חדשים רופא/ה בלבד

פניות שמסרבים להן

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | חום \| כאב \| שיעול \| לא מרגיש טוב \| תסמין |
| **נימוק / הערה** | המדריך: תסמינים שמחייבים אנמנזה ובדיקה (חום, כאבים, שיעול) — לא במענה מקוון |
| **הנחיה** | **קודם בודקים סימני דחיפות. אין ← סירוב מנומק והזמנה לביקור או לשיחה עם הרופא/ה. יש ← הנחיה מיידית למוקד/מיון והודעה לרופא/ה.** |

| | |
|---|---|
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | חשד לאירוע לבבי או מוחי, קוצר נשימה, חום גבוה במיוחד ← דחוף: מוקד/מיון, 101 בחירום, הודעה מיידית לרופא/ה |
| **הודעה למטופל/ת** | שלום,<br>כדי לטפל בתלונה כראוי נדרשים שיחה ובדיקה, ולכן לא ניתן לענות עליה במלואה בפנייה מקוונת. ניתן לקבוע תור (גם טלפוני או בווידאו) דרך האפליקציה או מזכירות המרפאה. אם מופיעים קוצר נשימה, כאב בחזה, חולשה בצד אחד של הגוף או החמרה משמעותית — יש לפנות מיד למוקד או לחדר מיון, ובחירום להתקשר ל-101. |
| **מקור** | המדריך למדריך עמ' 32-34 |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 15.9 ממצא גופני או תמונה (פריחה, נגע) רופא/ה בלבד

פניות שמסרבים להן

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | פריחה \| תמונה \| נגע בעור \| נפיחות \| שומה |
| **נימוק / הערה** | המדריך: פנייה בנוגע לממצאים גופניים (פריחה) — מסרבים |
| **הנחיה** | **הרפואן לא מעריך ממצא. מעבירים לרופא/ה (שמחליט/ה אם התמונה מספיקה) או מזמינים לביקור.** |

| | |
|---|---|
| **הודעה למטופל/ת** | שלום,<br>הערכת הממצא שתיארת דורשת בדיקה של רופא/ה. ניתן לקבוע תור דרך האפליקציה או מזכירות המרפאה.<br>אם הממצא מתפשט במהירות, מלווה בחום גבוה או בקושי בנשימה — יש לפנות מיד למוקד או לחדר מיון. |
| **מקור** | המדריך למדריך עמ' 32-34 |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 15.10 אישור או טופס רפואי מורכב רופא/ה בלבד

פניות שמסרבים להן

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | ביטוח לאומי \| חברת ביטוח \| טופס \| נכות \| חוות דעת |
| **נימוק / הערה** | המדריך: בקשה לאישור רפואי מורכב (מכתב לביטוח לאומי) — מסרבים |
| **הנחיה** | **רופא/ה בלבד, לרוב בביקור. הרפואן יכול להפיק סיכום מידע רפואי אם זה מה שנדרש (לשונית האישורים).** |

| | |
|---|---|
| **הודעה למטופל/ת** | שלום,<br>מילוי הטופס דורש מעבר מעמיק על התיק עם הרופא/ה, ולכן נדרש ביקור. ניתן לקבוע תור דרך האפליקציה או מזכירות המרפאה, ולהביא את הטופס לביקור. |
| **מקור** | המדריך למדריך עמ' 32-34 |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 15.11 פנייה רגשית או חברתית רופא/ה בלבד

פניות שמסרבים להן

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | לחץ \| דיכאון \| חרדה \| קשיים \| מצוקה |
| **נימוק / הערה** | המדריך: סוגיות פסיכוסוציאליות פתוחות או חדשות — לא במענה מקוון |
| **הנחיה** | **לרופא/ה באותו יום. מחשבות אובדניות או סכנה לאחר ← דחוף: הודעה מיידית לרופא/ה.** |

| | |
|---|---|
| **תלונות בפנייה או ברשומה** | מחשבות לפגוע בעצמו/ה או באחרים ← דחוף: הודעה מיידית לרופא/ה; בחירום 101 |
| **הודעה למטופל/ת** | שלום,<br>תודה ששיתפת. חשוב לנו לשוחח על כך באופן אישי ולא בהודעה, ולכן הרופא/ה יחזור/תחזור אלייך או תתואם לך שיחה בהקדם. אם יש מחשבות לפגוע בעצמך או מצוקה קשה עכשיו — יש לפנות מיד למוקד, לחדר מיון או לער"ן 1201. |
| **מקור** | המדריך למדריך עמ' 32-34 |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 15.12 פנייה בשם מטופל/ת אחר/ת רופא/ה בלבד

פניות שמסרבים להן

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | בשם אשתי \| בשם בעלי \| בשביל אמא \| עבור |
| **נימוק / הערה** | המדריך: אין לפנות בנוגע למטופל אחר מהחשבון שלך. הורה של קטין — מותר |
| **הנחיה** | **לא עונים לגופה. מבקשים לשלוח מהחשבון של המטופל/ת (או בהרשאה מתועדת).** |

| | |
|---|---|
| **הודעה למטופל/ת** | שלום,<br>מטעמי סודיות רפואית, פנייה בעניין מטופל/ת אחר/ת צריכה להישלח מהחשבון של המטופל/ת עצמו/ה.<br>נשמח לטפל בה משם. |
| **מקור** | המדריך למדריך עמ' 32-34 |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 15.13 פנייה דחופה רופא/ה בלבד

פניות שמסרבים להן

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | כאב בחזה \| קוצר נשימה \| חולשה פתאומית \| דחוף |
| **נימוק / הערה** | המדריך: מקרים דחופים — לא במענה מקוון |
| **הנחיה** | **מיד: הודעה למטופל/ת לפנות למוקד או למיון (101 בחירום), והודעה מיידית לרופא/ה. מתעדים את השעה.** |

| | |
|---|---|
| **הודעה למטופל/ת** | שלום,<br>התיאור בפנייתך מחייב הערכה רפואית מיידית. יש לפנות עכשיו למוקד או לחדר מיון, ובמקרה חירום להתקשר למד"א 101. הרופא/ה עודכן/ה. |
| **מקור** | המדריך למדריך עמ' 32-34 |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

# 16. חיסונים

13 פריטים · לפי הנחיה: 6 · לפי הנחיה, בתנאים: 6 · רופא/ה בלבד: 1 · גרסה 2 · 5.11.2026

מקורות: ספר חפיפה עוזרי רופא; לאימות מול הנחיות משרד הבריאות ומכבי

## 16.א כללים

- בודקים זכאות לפי גיל וקבוצת סיכון, את המרווח מהמנות הקודמות (לשונית חיסונים בתיק) ואת המימון (סל או תשלום מלא)
- מטופל/ת שאינו/ה זכאי/ת בסל: אפשר לתת מרשם לרכישה פרטית, עם הסבר
- הפניה לאחיות נדרשת לחיסונים בזריקה — מלבד שינגריקס ושפעת, שבהם קובעים תור לאחיות ישירות
- קבוצת סיכון לא ברורה או לא מתועדת: לרופא/ה
- תסמין חדש או סימן אזהרה בפנייה: לא מטפלים כבקשת חיסון, לרופא/ה

## 16.ב תוצאות אפשריות

| תוצאה | נוסח בתיעוד |
|---|---|
| הופקו מרשם או הפניה לפי הפרוטוקול | תוצאה: הופקו מרשם או הפניה לחיסון לפי הפרוטוקול. |
| הוכן והועבר לרופא/ה | תוצאה: הבקשה הוכנה והועברה להחלטת הרופא/ה. |
| לא זכאי/ת או לא מתאים — הוסבר למטופל/ת | תוצאה: לא הופק. הוסבר למטופל/ת (זכאות, מרווח או אפשרות רכישה פרטית). |
| תסמין או סימן אזהרה — לרופא/ה מיד | תוצאה: לא טופל כבקשת חיסון. הועבר מיד לרופא/ה. |

## 16.ג בדיקות משותפות

| שלב | נושא | מה בודקים | קריטריון | אם לא מתקיים | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| לפני כל חיסון | זכאות | גיל וקבוצת סיכון מתועדת | לפי החיסון | לא זכאי/ת בסל ← מרשם לרכישה פרטית, או לרופא/ה אם לא ברור | ספר חפיפה |
| לפני כל חיסון | מנות קודמות | לשונית חיסונים בתיק | מרווח מתאים מהמנה הקודמת | לא מתאים ← לרופא/ה | ספר חפיפה |
| לפני כל חיסון | הפניה לאחיות | האם נדרשת | בזריקה — כן; שינגריקס ושפעת — לא | — | ספר חפיפה |

## 16.ד החלטות

| # | נושא | מה ההנחיה אומרת | ההחלטה לפרוטוקול | סוג | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | לשונית חיסונים | נושא תפעולי — הנחיות קליניות לא עוסקות בו; מבוסס על נוהל הרפואן | הרפואן בודק זכאות, מרווח ומימון ומפיק מרשם או הפניה לפי החיסון | החלטה מקומית (3.11.2026) | ספר חפיפה |
| 2 | פרבנר | תדריך החיסונים: פרבנר 20 מחליף את פרבנר 13 במבוגרים (ההנחיה הישראלית לרפואה מונעת שבפרויקט עדיין מתארת פרבנר 13 + פנאומווקס — ישנה) | פרבנר 20 בלבד (מחליף את פרבנר 13 במבוגרים) | החלטה מקומית (3.11.2026) | ספר חפיפה; תדריך החיסונים, משרד הבריאות |
| 3 | חיסונים נוספים | לפי תדריך החיסונים של משרד הבריאות; חיסוני טיול — במרפאת מטיילים | בוסטריקס, צהבת A ו-B, RSV, קורונה, מנינגוקוק, MMR ואבעבועות רוח, וחיסונים לטיול (הפניה למרפאת מטיילים) | החלטה מקומית (5.11.2026) | עמודי הזכאות של מכבי; תדריך החיסונים, משרד הבריאות |

## 16.ה רשימת חיסונים (לסימון)

| # | שם | | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.1 | שינגריקס (שלבקת חוגרת) | | חיסונים | לפי הנחיה | ☐ | |
| 16.2 | גרדסיל 9 (HPV) | | חיסונים | לפי הנחיה | ☐ | |
| 16.3 | פרבנר 20 (דלקת ריאות) | | חיסונים | לפי הנחיה | ☐ | |

| # | שם | | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.4 | פנאומווקס 23 | | חיסונים | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 16.5 | חיסון שפעת | | חיסונים | לפי הנחיה | ☐ | |
| 16.6 | בוסטריקס / אדסל (שעלת, טטנוס, דיפתריה) | | חיסונים | לפי הנחיה | ☐ | |
| 16.7 | חיסון צהבת A (הווריקס, וקטה) | | חיסונים | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 16.8 | חיסון צהבת B (אנג'ריקס B) | | חיסונים | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 16.9 | חיסון RSV למבוגרים (אברסיבו, ארקסווי) | | חיסונים | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 16.10 | חיסון קורונה | | חיסונים | לפי הנחיה | ☐ | |
| 16.11 | חיסון מנינגוקוק (מנוויאו, נימנריקס, בקסרו) | | חיסונים | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 16.12 | חצבת-חזרת-אדמת ואבעבועות רוח למבוגרים (פריוריקס, וריליקס) | | חיסונים | לפי הנחיה, בתנאים | ☐ | |
| 16.13 | חיסונים לטיול (טיפוס, קדחת צהובה, דלקת מוח, דנגי) | | חיסונים | רופא/ה בלבד | ☐ | |

## ו.16 פירוט מלא

### 16.1 שינגריקס (שלבקת חוגרת) לפי הנחיה

חיסונים

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | שינגריקס \| חיסון שלבקת חוגרת \| הרפס זוסטר |
| **נימוק / הערה** | 2 מנות בהפרש 2-6 חודשים. מרשם למנה הראשונה בלבד; למנה השנייה — מרשם נוסף. לא צריך הפניה לאחיות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין סימני דחיפות או תסמין חדש | תסמין חדש או סימן אזהרה ← לרופא/ה. | התוויות נגד |
| 2 | זכאות בסל | לא זכאי/ת בסל: אפשר מרשם לרכישה פרטית (בריאים מגיל 50, או מגיל 18 בסיכון אחר) — להסביר שבתשלום מלא. | |
| 3 | בדיקת פנקס החיסונים | נמצאה מנה קודמת שלא מתאימה למרווח ← לרופא/ה. | |
| 4 | מנה ראשונה או שנייה בזמן | מרווח לא מתאים ← לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **הודעה למטופל/ת** | שלום,<br>הופק עבורך מרשם לחיסון שינגריקס (מנה ___). יש לקנות את החיסון סמוך למועד ההתחסנות ולקבוע בעצמך תור במרפאת האחיות (לא צריך הפניה). את המנה השנייה מקבלים 2-6 חודשים אחרי הראשונה — לפני כן יש לבקש מרשם נוסף. |
| **מקור** | ספר חפיפה עוזרי רופא (המרפאה לבריאות המשפחה, קרית אונו); לאימות מול הנחיות משרד הבריאות ומכבי העדכניות |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 16.2 גרדסיל 9 (HPV) לפי הנחיה

חיסונים

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | גרדסיל 9 \| חיסון פפילומה \| HPV |
| **נימוק / הערה** | בנים ובנות בגיל 9-26. מרשם והפניה לאחיות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין סימני דחיפות או תסמין חדש | תסמין חדש או סימן אזהרה ← לרופא/ה. | התוויות נגד |
| 2 | גיל 9-26 | מחוץ לטווח הגיל ← לרופא/ה. | |
| 3 | בדיקת פנקס החיסונים | נמצאה מנה קודמת שלא מתאימה למרווח ← לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **הודעה למטופל/ת** | שלום,<br>הופקו עבורך מרשם לחיסון גרדסיל 9 והפניה לאחיות. ניתן לקבוע תור במרפאת האחיות. |
| **מקור** | ספר חפיפה עוזרי רופא (המרפאה לבריאות המשפחה, קרית אונו); לאימות מול הנחיות משרד הבריאות ומכבי העדכניות |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 16.3 פרבנר 20 (דלקת ריאות) לפי הנחיה

חיסונים

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | פרבנר 20 \| חיסון דלקת ריאות \| פנאומוקוק |
| **נימוק / הערה** | גיל 65 ומעלה, או מגיל 18 בקבוצת סיכון גבוה. חד-פעמי, לפחות שנה אחרי חיסון פנאומוקוק קודם (פנאומווקס או פרבנר 13). מרשם והפניה לאחיות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **אין סימני דחיפות או תסמין חדש** | תסמין חדש או סימן אזהרה ← לרופא/ה. | התווית נגד |
| 2 | **גיל או קבוצת סיכון** | קבוצת סיכון לא מתועדת או לא ברורה ← לרופא/ה. | |
| 3 | **בדיקת פנקס החיסונים** | נמצאה מנה קודמת שלא מתאימה למרווח ← לרופא/ה. | |
| 4 | **לא קיבל/ה פרבנר 20, ועברה שנה מחיסון קודם** | כבר קיבל/ה, או לא עברה שנה ← לא מפיקים. | התווית נגד |

| | |
|---|---|
| **הודעה למטופל/ת** | שלום,<br>הופקו עבורך מרשם לחיסון פרבנר 20 והפניה לאחיות. ניתן לקבוע תור במרפאת האחיות. |
| **מקור** | ספר חפיפה עוזרי רופא (המרפאה לבריאות המשפחה, קרית אונו); לאימות מול הנחיות משרד הבריאות ומכבי העדכניות |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 16.4 פנאומווקס 23 לפי הנחיה, בתנאים

חיסונים

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | פנאומווקס \| חיסון דלקת ריאות 23 |
| **נימוק / הערה** | לקבוצות סיכון גבוה מגיל שנתיים. במבוגרים שקיבלו או זכאים לפרבנר 20 — לרופא/ה |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **אין סימני דחיפות או תסמין חדש** | תסמין חדש או סימן אזהרה ← לרופא/ה. | התווית נגד |
| 2 | **קבוצת סיכון גבוה מתועדת** | אין ← לרופא/ה. | |
| 3 | **בדיקת פנקס החיסונים** | נמצאה מנה קודמת שלא מתאימה למרווח ← לרופא/ה. | |
| 4 | **לא מבוגר/ת שזכאי/ת לפרבנר 20** | מבוגר/ת שזכאי/ת לפרבנר 20 ← לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **הודעה למטופל/ת** | שלום,<br>הופקו עבורך מרשם לחיסון פנאומווקס והפניה לאחיות. ניתן לקבוע תור במרפאת האחיות. |
| **מקור** | ספר חפיפה עוזרי רופא (המרפאה לבריאות המשפחה, קרית אונו); לאימות מול הנחיות משרד הבריאות ומכבי העדכניות |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 16.5 חיסון שפעת לפי הנחיה

חיסונים

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | שפעת \| חיסון שפעת |
| **נימוק / הערה** | מומלץ לכל מגיל 6 חודשים, ובמיוחד מגיל 50 ובקבוצות סיכון. לא צריך הפניה: המטופל/ת קובע/ת תור לאחיות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **אין סימני דחיפות או תסמין חדש** | תסמין חדש או סימן אזהרה ← לרופא/ה. | התוויית נגד |

| | |
|---|---|
| **הודעה למטופל/ת** | שלום,<br>לחיסון שפעת לא צריך הפניה. ניתן לקבוע תור במרפאת האחיות דרך האפליקציה או מזכירות המרפאה. |
| **מקור** | ספר חפיפה עוזרי רופא (המרפאה לבריאות המשפחה, קרית אונו); לאימות מול הנחיות משרד הבריאות ומכבי העדכניות |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

## 16.6 בוסטריקס / אדסל (שעלת, טטנוס, דיפתריה) לפי הנחיה

חיסונים

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | בוסטריקס \| בוסטריקס פוליו \| אדסל \| אדסל פוליו \| חיסון שעלת \| טטנוס |
| **נימוק / הערה** | מנה אחת למבוגרים, ובכל היריון בשבועות 27–36. לא צריך הפניה: המטופל/ת קובע/ת תור לאחיות (*3555). פצע או נשיכה עכשיו — לא בקשת חיסון שגרתית |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **אין סימני דחיפות או תסמין חדש** | תסמין חדש או סימן אזהרה ← לרופא/ה. | התוויית נגד |
| 2 | **לא בגלל פצע או נשיכה עכשיו** | פצע או נשיכה ← לרופא/ה היום (טטנוס ותכשירים נוספים לפי הצורך) | התוויית נגד |
| 3 | **היריון: שבוע 27–36** | היריון מחוץ לשבועות 27–36 ← להסביר מתי, או לרופא/ה | |
| 4 | **בדיקת פנקס החיסונים** | נמצאה מנה קודמת שלא מתאימה למרווח ← לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **הודעה למטופל/ת** | שלום,<br>לחיסון נגד שעלת (בוסטריקס) לא צריך הפניה. ניתן לקבוע תור במרפאת האחיות במוקד *3555 או דרך האפליקציה. בהיריון — בשבועות 27–36, עם כרטיס מעקב היריון. |
| **מקור** | ספר חפיפה עוזרי רופא (המרפאה לבריאות המשפחה, קרית אונו); לאימות מול הנחיות משרד הבריאות ומכבי העדכניות |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 16.7 חיסון צהבת A (הווריקס, וקטה) לפי הנחיה, בתנאים

חיסונים

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | הווריקס 1440 \| וקטה 50 \| צהבת A \| הפטיטיס A |
| **נימוק / הערה** | 2 מנות בהפרש 6–12 חודשים. לקבוצות סיכון (מחלת כבד כרונית, גברים המקיימים יחסים עם גברים, חשיפה תעסוקתית) או לפני טיול. מרשם והפניה לאחיות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **אין סימני דחיפות או תסמין חדש** | תסמין חדש או סימן אזהרה ← לרופא/ה. | התוויות נגד |
| 2 | **קבוצת סיכון מתועדת או טיול** | אין קבוצת סיכון: אפשר מרשם לרכישה פרטית עם הסבר; טיול — מרפאת מטיילים או מרשם | |
| 3 | **בדיקת פנקס החיסונים** | נמצאה מנה קודמת שלא מתאימה למרווח ← לרופא/ה. | |
| 4 | **מנה ראשונה או שנייה בזמן** | מרווח לא מתאים ← לרופא/ה | |

| | |
|---|---|
| **הודעה למטופל/ת** | שלום,<br>הופקו עבורך מרשם לחיסון נגד צהבת A והפניה לאחיות. ניתן לקבוע תור במרפאת האחיות. |
| **מקור** | ספר חפיפה עוזרי רופא (המרפאה לבריאות המשפחה, קרית אונו); לאימות מול הנחיות משרד הבריאות ומכבי העדכניות |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 16.8 חיסון צהבת B (אנג'ריקס B) לפי הנחיה, בתנאים

חיסונים

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | אנג'ריקס B 20 \| צהבת B \| הפטיטיס B |
| **נימוק / הערה** | 3 מנות (0, 1 ו-6 חודשים). לקבוצות סיכון: צוות רפואי וסטודנטים לרפואה, דיאליזה או אי-ספיקת כליות, מחלת כבד, HIV או הפטיטיס C, בני זוג ובני בית של נשאים. מרשם והפניה לאחיות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **אין סימני דחיפות או תסמין חדש** | תסמין חדש או סימן אזהרה ← לרופא/ה. | התוויות נגד |
| 2 | **קבוצת סיכון מתועדת** | אין קבוצת סיכון מתועדת ← לרופא/ה | |
| 3 | **בדיקת פנקס החיסונים** | נמצאה מנה קודמת שלא מתאימה למרווח ← לרופא/ה. | |
| 4 | **מנה בזמן** | מרווח לא מתאים, או סדרה שלמה בעבר ← לרופא/ה (אולי בדיקת נוגדנים) | |

| | |
|---|---|
| **הודעה למטופל/ת** | שלום,<br>הופקו עבורך מרשם לחיסון נגד צהבת B והפניה לאחיות. ניתן לקבוע תור במרפאת האחיות. |
| **מקור** | ספר חפיפה עוזרי רופא (המרפאה לבריאות המשפחה, קרית אונו); לאימות מול הנחיות משרד הבריאות ומכבי העדכניות |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 16.9 חיסון RSV למבוגרים (אברסיבו, ארקסווי) לפי הנחיה, בתנאים

חיסונים

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | אברסיבו \| ארקסווי \| אמרסוויה \| RSV |
| **נימוק / הערה** | למבוגרים בסיכון לפי ההנחיה העדכנית (גיל מבוגר ומחלות כרוניות). בדרך כלל לא בסל: מרשם לרכישה פרטית. בהיריון — לרופא/ה. מנה אחת |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **אין סימני דחיפות או תסמין חדש** | תסמין חדש או סימן אזהרה ← לרופא/ה. | התוויות נגד |
| 2 | **גיל וקבוצת סיכון לפי ההנחיה** | לא ברור ← לרופא/ה | |
| 3 | **לא בהיריון** | היריון ← לרופא/ה (חיסון בהיריון לפי החלטה) | |
| 4 | **בדיקת פנקס החיסונים** | נמצאה מנה קודמת שלא מתאימה למרווח ← לרופא/ה. | |
| 5 | **לא קיבל/ה חיסון RSV בעבר** | כבר חוסן/ה ← לרופא/ה | |

| | |
|---|---|
| **הודעה למטופל/ת** | שלום,<br>הופק עבורך מרשם לחיסון RSV לרכישה בבית המרקחת (בתשלום), והפניה לאחיות למתן החיסון. ניתן לקבוע תור במרפאת האחיות. |
| **מקור** | ספר חפיפה עוזרי רופא (המרפאה לבריאות המשפחה, קרית אונו); לאימות מול הנחיות משרד הבריאות ומכבי העדכניות |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 16.10 חיסון קורונה לפי הנחיה

חיסונים

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | קומירנטי \| ספייקוואקס \| נובווקסוביד \| קורונה |
| **נימוק / הערה** | לפי ההמלצה העונתית של משרד הבריאות (בעיקר גיל מבוגר וקבוצות סיכון). לא צריך הפניה: המטופל/ת קובע/ת תור לאחיות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **אין סימני דחיפות או תסמין חדש** | תסמין חדש או סימן אזהרה ← לרופא/ה. | התוויות נגד |

| | |
|---|---|
| **הודעה למטופל/ת** | שלום,<br>לחיסון קורונה לא צריך הפניה. ניתן לקבוע תור במרפאת האחיות דרך האפליקציה או מוקד *3555. |
| **מקור** | ספר חפיפה עוזרי רופא (המרפאה לבריאות המשפחה, קרית אונו); לאימות מול הנחיות משרד הבריאות ומכבי העדכניות |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 16.11 חיסון מנינגוקוק (מנוויאו, נימנריקס, בקסרו) לפי הנחיה, בתנאים

חיסונים

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | מנוויאו \| מנקטרה \| נימנריקס \| מנקוודפי \| בקסרו \| מנינגוקוק \| קרום המוח |
| **נימוק / הערה** | לקבוצות סיכון (כריתת טחול, חסר משלים, טיפול באקוליזומאב), לפני טיול ליעד מומלץ (חג' ועומרה), ולסטודנטים לפני לימודים בחו"ל. מרשם והפניה לאחיות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **אין סימני דחיפות או תסמין חדש** | תסמין חדש או סימן אזהרה ← לרופא/ה. | התווית נגד |
| 2 | **קבוצת סיכון, טיול או דרישת לימודים** | אין ← לרופא/ה | |
| 3 | **בדיקת פנקס החיסונים** | נמצאה מנה קודמת שלא מתאימה למרווח ← לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **הודעה למטופל/ת** | שלום,<br>הופקו עבורך מרשם לחיסון מנינגוקוק והפניה לאחיות. ניתן לקבוע תור במרפאת האחיות. |
| **מקור** | ספר חפיפה עוזרי רופא (המרפאה לבריאות המשפחה, קרית אונו); לאימות מול הנחיות משרד הבריאות ומכבי העדכניות |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 16.12 חצבת-חזרת-אדמת ואבעבועות רוח למבוגרים (פריוריקס, וריליקס) לפי הנחיה, בתנאים

חיסונים

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | פריוריקס \| פריוריקס טטרה \| פרוקווד \| וריליקס \| MMR \| חצבת \| אבעבועות רוח |
| **נימוק / הערה** | למבוגרים ללא חיסון מתועד או ללא נוגדנים (למשל לפני היריון). חיסון חי: לא בהיריון (ולהימנע מהיריון חודש אחרי), לא בדיכוי חיסוני. מרשם והפניה לאחיות |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | **אין סימני דחיפות או תסמין חדש** | תסמין חדש או סימן אזהרה ← לרופא/ה. | התווית נגד |
| 2 | **אין חיסון מתועד או נוגדנים** | כבר מחוסן/ת ← להסביר, לא מפיקים | |
| 3 | **אין היריון ואין דיכוי חיסוני (חיסון חי)** | היריון או דיכוי חיסוני ← לרופא/ה (חיסון חי אסור) | התווית נגד |
| 4 | **בדיקת פנקס החיסונים** | נמצאה מנה קודמת שלא מתאימה למרווח ← לרופא/ה. | |

| | |
|---|---|
| **הודעה למטופל/ת** | שלום,<br>הופקו עבורך מרשם לחיסון והפניה לאחיות. זה חיסון חי: אין להיכנס להיריון בחודש שאחרי החיסון. ניתן לקבוע תור במרפאת האחיות. |
| **מקור** | ספר חפיפה עוזרי רופא (המרפאה לבריאות המשפחה, קרית אונו); לאימות מול הנחיות משרד הבריאות ומכבי העדכניות |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 16.13 חיסונים לטיול (טיפוס, קדחת צהובה, דלקת מוח, דנגי) רופא/ה בלבד

חיסונים

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | טיפים VI \| ויווטיף \| סטמריל \| איקסיארו \| טיקובק \| קדנגה \| אימובקס פוליו \| חיסונים לטיול \| מרפאת מטיילים |
| **נימוק / הערה** | חיסונים לטיול נקבעים ונותנים במרפאת מטיילים, לפי היעד ומשך הטיול. הרפואן מפנה את המטופל/ת לקבוע תור במרפאת מטיילים של מכבי. |
| הנחיה | **חיסונים לטיול ניתנים במרפאת מטיילים לפי היעד. להפנות את המטופל/ת לקבוע תור במרפאת מטיילים.** |

| # | בדיקה | קריטריון ופעולה | סוג |
|---|---|---|---|
| 1 | אין סימני דחיפות או תסמין חדש | תסמין חדש או סימן אזהרה ← לרופא/ה. | התוויות נגד |

| | |
|---|---|
| **הודעה למטופל/ת** | שלום,<br>חיסונים לטיול ניתנים במרפאת מטיילים לפי היעד. מומלץ לקבוע תור 4–6 שבועות לפני הנסיעה, דרך האפליקציה או מוקד *3555. |
| **מקור** | ספר חפיפה עוזרי רופא (המרפאה לבריאות המשפחה, קרית אונו); לאימות מול הנחיות משרד הבריאות ומכבי העדכניות |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

# 17. סיכום רפואי

19 פריטים · הכנה לאישור רופא/ה: 19 · גרסה 8.11.2026

מקורות: חוברת עוזרי רופא — הנחיות לכתיבת סיכום רפואי

## 17.א כללים

- הרפואן מכין את הסיכום; הרופא/ה עובר/ת ומאשר/ת לפני שהוא נשלח או מצורף להפניה.
- סיכום הוא תמצית — לא מעתיקים את כל הפרטים מהתיק ולא מקבצים ביקורים. בלי תאריכי ביקורים, פרטים אישיים (נשוי/ה, ילדים, מקצוע), מחלות לא רלוונטיות (זיהום חולף) ומשפטים כמו "הפקת תרופות קבועות" או "מעבדה תקינה לחלוטין".
- המקור העיקרי: הביקור המסודר האחרון (Periodic comprehensive health assessment). לבדוק גם מה התחדש מאז: ביקורים אצל מומחים, בדיקות חדשות, אשפוזים.
- לרשום את כל המידע שרלוונטי לגורם שאליו מפנים — ולא יותר. לדוגמה: בהפניה לאק"ג חשוב לרשום אבחנות קרדיאליות, פחות חשוב אם המטופלת נוטלת HRT.
- הפניה לגורם שאינו רופא (פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת): בלי פירוט מחלות הרקע כמו בהפניה לרופא/ה מומחה/ית.
- לכל מחלת רקע: שנת האבחנה, הטיפול התרופתי, והאם במעקב מומחה (שם הרופא/ה או המרפאה, אם ידוע).
- סדר וארגון: מחלות מרכזיות ורלוונטיות ראשונות; בתוך כל מחלה לפי סדר כרונולוגי; פסקה עם כותרת לכל מחלה — לא פסקה אחת מבולגנת.
- אשפוזים: רק משמעותיים ורלוונטיים (למשל זיהום שתן עם חיידק עמיד, אשפוזים חוזרים בגלל אספירציה).
- כל בדיקה עם תאריך (אק"ג מלפני חמש שנים אינו כמו אק"ג משבוע שעבר). לוודא שערכי המעבדה בסיכום הם העדכניים.
- הפניה לרופא/ה בבית חולים ולא במסגרת מכבי: לציין למה (למשל "המטופל/ת במעקבו/ה של ד"ר ____ מזה שנים", "לבקשת המטופל/ת", "לאור מורכבות המצב").

## 17.ג בדיקות משותפות

| שלב | נושא | מה בודקים | קריטריון | אם לא מתקיים | מקור |
|---|---|---|---|---|---|
| פתיח | בן/בת ____ | | | | |
| הרגלים | עישון, שתיית אלכוהול, צריכת סמים, פעילות גופנית, שינה | | | | |
| מחלות רקע | המרכזיות והרלוונטיות ראשונות; לכל מחלה שנת אבחנה, טיפול ומעקב מומחה — לפי הלשונית "חיפוש מחלה" | | | | |
| ניתוחים בעבר | | | | | |
| אשפוזים אחרונים | רק אם יש משהו רלוונטי ומשמעותי | | | | |

## 17.ה רשימת התרופות (לסימון)

| # | שם | | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.1 | פתיח הסיכום | | מבנה | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 17.2 | מחלת לב איסכמית | | מחלות רקע | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 17.3 | סוכרת | | מחלות רקע | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 17.4 | יתר לחץ דם | | מחלות רקע | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 17.5 | דיסליפידמיה | | מחלות רקע | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 17.6 | פרפור פרוזדורים | | מחלות רקע | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 17.7 | אי ספיקת לב | | מחלות רקע | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 17.8 | מחלת ריאות | | מחלות רקע | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 17.9 | מחלת כליות כרונית | | מחלות רקע | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 17.10 | מחלה אונקולוגית | | מחלות רקע | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 17.11 | CVA / TIA | | מחלות רקע | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 17.12 | מפרצת אבי העורקים הבטני | | מחלות רקע | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |

| # | שם | | קבוצה | התאמה | אושר | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.13 | אנמיה | | מחלות רקע | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 17.14 | מחלות בלוטת התריס | | מחלות רקע | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 17.15 | דיכאון וחרדה | | מחלות רקע | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 17.16 | אוסטאופורוזיס | | מחלות רקע | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 17.17 | דמנציה | | מחלות רקע | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 17.18 | פרקינסון | | מחלות רקע | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |
| 17.19 | מחלת רקע אחרת | | מחלות רקע | הכנה לאישור רופא/ה | ☐ | |

## ו.17 פירוט מלא

### 17.1 פתיח הסיכום הכנה לאישור רופא/ה

מבנה

| | |
|---|---|
| נקרא גם | פתיח \| מבנה הסיכום \| הרגלים \| ניתוחים \| אשפוזים \| גיל |
| נימוק / הערה | הרפואן מכין את הסיכום מהתיק; הרופא/ה מאשר/ת לפני השליחה |
| מקור | חוברת עוזרי רופא — הנחיות לכתיבת סיכום רפואי |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 17.2 מחלת לב איסכמית הכנה לאישור רופא/ה

מחלות רקע

| | |
|---|---|
| נקרא גם | IHD \| לב איסכמי \| מחלת לב כלילית \| צנתור \| סטנט \| MI \| CABG \| אוטם |
| נימוק / הערה | הרפואן מכין את הסיכום מהתיק; הרופא/ה מאשר/ת לפני השליחה |
| מקור | חוברת עוזרי רופא — הנחיות לכתיבת סיכום רפואי |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 17.3 סוכרת הכנה לאישור רופא/ה

מחלות רקע

| | |
|---|---|
| נקרא גם | diabetes \| DM \| סכרת \| סוכרתי |
| נימוק / הערה | הרפואן מכין את הסיכום מהתיק; הרופא/ה מאשר/ת לפני השליחה |
| מקור | חוברת עוזרי רופא — הנחיות לכתיבת סיכום רפואי |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 17.4 יתר לחץ דם הכנה לאישור רופא/ה

מחלות רקע

| | |
|---|---|
| נקרא גם | יל"ד \| HTN \| לחץ דם גבוה \| hypertension |
| נימוק / הערה | הרפואן מכין את הסיכום מהתיק; הרופא/ה מאשר/ת לפני השליחה |
| מקור | חוברת עוזרי רופא — הנחיות לכתיבת סיכום רפואי |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 17.5 דיסליפידמיה הכנה לאישור רופא/ה

מחלות רקע

| | |
|---|---|
| נקרא גם | שומנים \| כולסטרול \| היפרליפידמיה \| dyslipidemia |
| נימוק / הערה | הרפואן מכין את הסיכום מהתיק; הרופא/ה מאשר/ת לפני השליחה |
| מקור | חוברת עוזרי רופא — הנחיות לכתיבת סיכום רפואי |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 17.6 פרפור פרוזדורים הכנה לאישור רופא/ה

מחלות רקע

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | AF \| פרפור \| atrial fibrillation |
| **נימוק / הערה** | הרפואן מכין את הסיכום מהתיק; הרופא/ה מאשר/ת לפני השליחה |
| **מקור** | חוברת עוזרי רופא — הנחיות לכתיבת סיכום רפואי |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 17.7 אי ספיקת לב הכנה לאישור רופא/ה

מחלות רקע

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | HF \| CHF \| אס"ל \| heart failure |
| **נימוק / הערה** | הרפואן מכין את הסיכום מהתיק; הרופא/ה מאשר/ת לפני השליחה |
| **מקור** | חוברת עוזרי רופא — הנחיות לכתיבת סיכום רפואי |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 17.8 מחלת ריאות הכנה לאישור רופא/ה

מחלות רקע

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | COPD \| אסתמה \| ריאות \| פיברוזיס |
| **נימוק / הערה** | הרפואן מכין את הסיכום מהתיק; הרופא/ה מאשר/ת לפני השליחה |
| **מקור** | חוברת עוזרי רופא — הנחיות לכתיבת סיכום רפואי |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 17.9 מחלת כליות כרונית הכנה לאישור רופא/ה

מחלות רקע

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | CKD \| אי ספיקת כליות \| כליות |
| **נימוק / הערה** | הרפואן מכין את הסיכום מהתיק; הרופא/ה מאשר/ת לפני השליחה |
| **מקור** | חוברת עוזרי רופא — הנחיות לכתיבת סיכום רפואי |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 17.10 מחלה אונקולוגית הכנה לאישור רופא/ה

מחלות רקע

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | סרטן \| גידול \| אונקולוגיה \| ממאירות \| cancer |
| **נימוק / הערה** | הרפואן מכין את הסיכום מהתיק; הרופא/ה מאשר/ת לפני השליחה |
| **מקור** | חוברת עוזרי רופא — הנחיות לכתיבת סיכום רפואי |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 17.11 CVA / TIA הכנה לאישור רופא/ה

מחלות רקע

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | שבץ | אירוע מוחי | stroke | TIA | CVA |
| **נימוק / הערה** | הרפואן מכין את הסיכום מהתיק; הרופא/ה מאשר/ת לפני השליחה |
| **מקור** | חוברת עוזרי רופא — הנחיות לכתיבת סיכום רפואי |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 17.12 מפרצת אבי העורקים הבטני הכנה לאישור רופא/ה

מחלות רקע

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | AAA | מפרצת | aortic aneurysm |
| **נימוק / הערה** | הרפואן מכין את הסיכום מהתיק; הרופא/ה מאשר/ת לפני השליחה |
| **מקור** | חוברת עוזרי רופא — הנחיות לכתיבת סיכום רפואי |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 17.13 אנמיה הכנה לאישור רופא/ה

מחלות רקע

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | אנמיה | חוסר ברזל | המוגלובין נמוך |
| **נימוק / הערה** | הרפואן מכין את הסיכום מהתיק; הרופא/ה מאשר/ת לפני השליחה |
| **מקור** | חוברת עוזרי רופא — הנחיות לכתיבת סיכום רפואי |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 17.14 מחלות בלוטת התריס הכנה לאישור רופא/ה

מחלות רקע

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | תריס | תת פעילות | יתר פעילות | TSH | hypothyroidism |
| **נימוק / הערה** | הרפואן מכין את הסיכום מהתיק; הרופא/ה מאשר/ת לפני השליחה |
| **מקור** | חוברת עוזרי רופא — הנחיות לכתיבת סיכום רפואי |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 17.15 דיכאון וחרדה הכנה לאישור רופא/ה

מחלות רקע

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | דיכאון | חרדה | פסיכיאטרי |
| **נימוק / הערה** | הרפואן מכין את הסיכום מהתיק; הרופא/ה מאשר/ת לפני השליחה |
| **מקור** | חוברת עוזרי רופא — הנחיות לכתיבת סיכום רפואי |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 17.16 אוסטאופורוזיס הכנה לאישור רופא/ה

מחלות רקע

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | אוסטאופורוזיס \| צפיפות עצם \| דלדול עצם |
| **נימוק / הערה** | הרפואן מכין את הסיכום מהתיק; הרופא/ה מאשר/ת לפני השליחה |
| **מקור** | חוברת עוזרי רופא — הנחיות לכתיבת סיכום רפואי |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 17.17 דמנציה הכנה לאישור רופא/ה

מחלות רקע

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | דמנציה \| שטיון \| אלצהיימר \| ירידה קוגניטיבית |
| **נימוק / הערה** | הרפואן מכין את הסיכום מהתיק; הרופא/ה מאשר/ת לפני השליחה |
| **מקור** | חוברת עוזרי רופא — הנחיות לכתיבת סיכום רפואי |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 17.18 פרקינסון הכנה לאישור רופא/ה

מחלות רקע

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | פרקינסון \| parkinson |
| **נימוק / הערה** | הרפואן מכין את הסיכום מהתיק; הרופא/ה מאשר/ת לפני השליחה |
| **מקור** | חוברת עוזרי רופא — הנחיות לכתיבת סיכום רפואי |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____

### 17.19 מחלת רקע אחרת הכנה לאישור רופא/ה

מחלות רקע

| | |
|---|---|
| **נקרא גם** | מחלה אחרת \| אחר |
| **נימוק / הערה** | הרפואן מכין את הסיכום מהתיק; הרופא/ה מאשר/ת לפני השליחה |
| **מקור** | חוברת עוזרי רופא — הנחיות לכתיבת סיכום רפואי |

אושר ☐ לתיקון ☐ הערות: _____